

针灸集锦

(修訂本)

郑魁山 编著

甘肃科学技术出版社

R245
ZKS

80227

针 灸 集 锦

(修订本)

郑 魁 山 编 著

甘 肃 科 学 技 术 出 版 社

责任编辑：王季瑜
陈景明
封面设计：王占国
版式设计：陈安庆

针 灸 集 锦
(修订本)

郑 魁 山 编著

甘肃科学技术出版社出版
(兰州第一新村81号)

甘肃省新华书店发行 兰州新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米1/32 印张16.5 插页5 字数394,000
1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷
印数：1——7,000

ISBN 7-5424-0126-2/R·38 定价：6.35元



作者生平简介

郑魁山教授（公元1918年），河北省安国县人，出生于针灸世家，幼年随父郑毓琳学习针灸于故里，20岁学成后行医于安国、保定、北京等地。1943年迁居北平，1947年考取中医师，独立开业。1951年与栾志仁等创办了北京市广安门联合诊所，同年应专家高凤桐邀请创办了北京中医学会针灸研究班，1952年又创办了针灸门诊部。1954年被聘为华北中医实验所主治医师。1955年在卫生部中医研究院针灸研究所任第三研究室负责人，从事针法研究。在此期间，并在中医研究院针灸高师班、国际班、苏联、印度、朝鲜等外国专家班，及中华医学会、北京中医学会等学术团体和北京大学、北京中医学院任教。1970年下放到甘肃省成县医院，任中医科主任。1979年任甘肃省首届针灸学会副会长。1982年调入甘肃中医学院，并积极筹建甘肃中医学院针灸系，任名誉系主任，教授。现任中国针灸学会理事，中国针灸学会针法灸

法研究会顾问，甘肃省针灸学会学术指导委员会主任，兰州中医药学会、光明中医函授大学甘肃省分校等单位顾问。先后在公开杂志上发表40余篇学术论文，《针灸集锦》第一版已流传于日本，并在1984年5月由京都中医研究会翻译出版。其它著作有《子午流注与灵龟八法》、点校《针灸大全》，编导了针灸取穴法和针刺手法电教片演示的《针刺手法一百种幻灯片》，已由中国医药科技出版社出版。

自序

针灸疗法，是祖国医学宝贵遗产，具有两千多年的悠久历史。它不但治疗范围广，收效快，而且经济、简便，容易掌握。因此，极受广大人民群众欢迎。

为了发掘、总结祖国针灸遗产，使较多的医务工作者掌握针灸医术，以便更好地为广大患者服务。本人根据家传和从事针灸临床四十余年的经验，在不断实践中，勤求前人针灸各家手法，博采各方同道的先进经验，编写成《针灸集锦》一书。

全书共三篇。第一篇经络腧穴，主要论述经络腧穴在人体的生理功能、病理变化及其在诊断、治疗上的作用。为了临床辨证施治，对每个腧穴概括性地阐明了穴性功能，在常用及重要穴后根据个人实践体会和前人经验加了按语，以便读者加深印象。第二篇针灸方法，重点介绍了烧山火、透天凉等各种针刺手法操作和适应症，并对灸法、新医疗法、针麻作了扼要介绍。第三篇临床治疗，介绍了临床配穴原则和规律，以及汗、吐、下、和、温、清、补、消“八法”在针灸治疗上的应用，并附有二十三种中医病名的辨证配穴、三十五种西医病名的临床治疗总结摘要和三十一例医案。

本书内容力求理论联系实际，注重临床实践，取材有所侧重，文字浅显易懂，并附插图。可供医务工作者和广大乡村医生在针灸工作中参考。

在编写过程中，得到傅继纲、刘云腾、金马等同志的热情帮助，在此致以诚挚的谢意。

由于实践不足，知识有限，书中缺点和错误在所难免，尚希读者批评指正。

郑魁山

1977年8月19日

EU78/01

《针灸集锦》修订再版序

对针灸这门学科，我没有进行过系统的学习和研究，但我和我的家庭却是针灸医疗的受益者，因此对针灸疗疾深信无疑。我在甘肃省出版局任局长时，看到了《针灸集锦》的书稿，如获至宝。我让责任编辑同志抓紧审稿，力争尽快出版，造福社会。在审稿过程中我荣幸的结识了郑魁山大夫，得知他“文革”中被“四人帮”赶出北京，下放甘肃成县时，深表同情。《针灸集锦》一书，经过作者精心修改后，于1978年9月正式出版。这本书不仅继承和发扬了祖国针灸疗法的宝贵经验，而且颇有创新。全书内容新颖、结构严谨，文字深入浅出，通俗易懂，疗法简便、实用，令人爱不释手。出版后得到广大读者好评，荣获省优秀图书奖，在北京书展中是深受欢迎的图书之一。

1982年郑魁山大夫调甘肃省中医学院任教，后来被评为教授，我们接触的机会更多了，通过郑魁山大夫对我的针疗疾病和平时交谈，使我学到了许多针灸和保健方面的知识。时间已过了十年，我对郑教授在针灸研究，医德医风等方面有了进一步的了解。听说《针灸集锦》要修订再版，我很高兴，表示祝贺。借此机会对郑教授针灸经验，医疗医风等方面，作简要介绍，供读者参考。

郑魁山教授是我国著名的针灸专家，也是新中国针灸研究的开创人之一。他不仅在针灸理论研究方面有较高的造诣，而且有很丰富的针灸实践经验，《针灸集锦》就是他对针灸理论研究和长期针灸实践的结晶。由他编著的《子午流注与灵龟八法》荣获甘肃省卫生厅优秀著作奖。他还在全国家医疗报刊上公开发表40多

篇论文，对针灸理论的研究起了积极作用。

郑魁山教授出生于针灸世家，幼年随父郑毓林学习针灸于故里（河北安国县），二十岁学成开始针灸研究。五十多年以来，他致力于针灸研究、临床、教学工作，对针灸典籍研究精深。早在五十年代，就和高凤桐等专家创办了北京中医学会针灸研究班，先后共办六班，培养学员180多人。以后又分别为中医研究院针灸高师班，国际针灸班，北京中医学院等单位主讲针灸学，为我国针灸事业做出了积极的贡献。

郑魁山教授在长期针灸实践中，总结出一套汗、吐、下、和、温、清、补、消的针灸配穴和手法。他十分注重针刺各个环节，善用左手，其要点是：①左手揣穴，右手辅助，以揣摸穴位处肌肉厚薄，孔窍大小，确定进针方向和深浅，并创新了旋转、滚摇、压按、升降等法；②右手进针，左手候气，随时感触针下冲动，候其气至，及时应用手法；③左手关闭，一旦触到针下冲动，则按住针穴下方，右手持针向上推进，使气至病所，及时守气，持续针感。

郑魁山教授用针手法精练实用，他采用提插、搓捻、关闭、搜刮、飞推、拨动、弹震、盘摇、循摄、搬垫、停留、压按等行针法。在传统“烧山火”、“透天凉”基础上，去繁就简，创新了“热补”、“凉泻”法，用捻按守气，使针下沉紧，产生热感；捻提守气，使针下轻滑，产生凉感。他撰写的《对热补、凉泻针刺手法的初步实验观察》论文，获得甘肃省卫生厅科技成果奖。

郑魁山教授很重视子午流注与灵龟八法的应用，把“纳子法”、“纳甲法”、“六十花甲子”融合在一起，研制成多功能临床应用盘，兼用三种优选取穴用途，可以迅速找到六十年每日每时的“花甲子”及当日当时的开穴。

郑魁山教授在临床实践中不断探索疑难疾病，提高疗效，对

视网膜出血用烧山火手法，使热感传到眼区，观察91例，有效率90.2%，获卫生部1958年科研成果奖。对小儿麻痹后遗症，创用穴位埋线新方法，提高了疗效，观察113例，有效率99.5%，获甘肃省武都地区科学大会奖。类似病症治验甚多，充分体现了郑魁山教授不拘于常，善用手法，因病施术，务求实效的学术特点，值得学习与推广。

郑魁山教授是我国爱国知识分子的典范。早在抗日战争时期，他以针灸疗疾的身份，为八路军传递消息，日伪军以为他是共产党，无辜被捕。百般恐吓威胁，他不畏强暴，坚贞不屈。全国解放后，他一心扑在祖国针灸医疗事业的研究与临床实践之中。在担任国务院卫生部中医研究院针灸研究室负责人工作期间，经常给一些中央领导同志和国内外专家进行针疗，效果显著，博得好评。“文革”期间以莫须有罪名强行批判斗争，他毫无怨言，坚信党组织一定能够澄清他的问题，因而从未中断过对祖国针疗事业的一片热忱。即就是被“四人帮”赶出北京，下放到甘肃成县，他依然相信党，相信组织，相信人民，充分发挥自己的针灸才能，全心全意地为山区人民防病治病，精心为山区人民培养针灸工作者，认真研究针灸医术，一点一滴的总结自己几十年的针灸实践经验，《针灸集锦》一书就是在这样艰苦的逆境中编撰出来的。由于他对人民针灸事业忠心耿耿，对患者无私奉献，得到成县广大人民的崇敬，得到党政领导的信任，于1981年经县委批准，吸收为中国共产党党员，他的夙愿终于实现了，他更加热爱自己的事业。

医德高尚，关心患者，平易近人，这是郑魁山教授的一贯风格。不论在农村还是到城市，不论对领导干部还是一般干部，不论是工人还是农民，只要有求于他，他都是一视同仁，认真诊断，精心治疗。在成县工作时，他的家里几乎成了临时家庭病院，对病人随到随医，不收分文。到兰州后他一如既往，很多患者

由农村或远地来求他看病，他总是热情接待。即使是节假日，他还是忙个不停，对患者关心备至。我是深有其感的，“文革”中我被歹使用钢鞭击伤头部和腰部，经抢救幸存，但留下了严重的后遗症。经中西医长期治疗，收效甚微。经郑魁山大夫一段针灸治疗后，完全恢复了健康。我到郑大夫家里进行针灸时，经常碰见一些病人在他家留针疗疾，床上凳子上到处是病人，他都是不厌其烦一一耐心治疗，这种高贵的医德，实在令人钦佩。还有一件事，也是十分感人的。我的一个孩子在“文革”中受株连，由于惊恐过度，连冻带饿，脑子受到严重刺激，产生了急性脑痉挛。因未能及时进行有效的治疗，留下了严重的后遗症。一受到外界刺激，就即刻发作，严重的影响孩子的健康成长与学习，曾经多方治疗，总是不能根治，时好时犯。经郑大夫针灸治疗后，再没发作，孩子大学毕业后，一直坚持工作，这真是一个奇迹，我们全家无比的高兴与感谢。

郑魁山教授在他五十多年的针灸生涯中，碰到了不少逆境和不愉快的事，但他对人民的针灸事业始终坚持不懈，精益求精；工作中任劳任怨，从不计较个人得失。《针灸集锦》的修订再版，也是他辛勤劳动的成果，又增添一些新的成就，这对他的事业也是一个很大的鼓舞，对广大读者和患者定有裨益，对针灸科学的研究与推广，必将起积极的推动作用。在郑魁山教授行医五十周年的时候，我曾留句表示祝贺，现摘抄如下，作为本文结语：

精湛针艺， 造福人类。
诚挚丹心， 志在兴华。

邓品珊

1987年9月

修订再版自序

针灸医学，是祖国医学宝贵遗产之一，具有悠久历史。早在原始社会、石器时代有了取火法之后，发明了砭石和灸熨。在三千多年前，我国医家把针灸的临床经验进行了初步总结。从长沙马王堆汉墓中出土的医学帛书“足臂十一脉灸经”和“阴阳十一脉灸经”中，除记有经脉循行路线的症状外，还有一些全身症状，都用灸法治疗。1963年在我国内蒙多伦旗头道洼，新石器时代遗址出土一根古代石针，长4.5厘米，一端有锋，呈四棱锥形，可以作针刺；另一端扁平，有弧刃，刃宽0.4厘米，中身有四棱，略扁，能容纳拇食二指挟持，可用来切开脓肿。1978年在内蒙达拉特旗树林召乡出土文物中发现一根古代青铜砭针，长4.6厘米，形状大小与头道洼砭石相似。1968年在河北省满城县西汉刘胜墓（葬于公元前113年）出土的金制银制医针九根，即古代九针中的一部分实物。证明我国随着生产的发展，针具也不断随之发展，早在三千多年前的石针、骨针、竹针逐渐发展到铜针、铁针、金针、银针；灸熨也从木炭、草皮、油捻、硫黄等烧烤，不断发展为艾灸。战国时代（公元前475～公元前206年）著《黄帝内经》，在总结前人医疗实践经验的基础上，进行了第一次大总结，它以阴阳、五行、脏腑、精神、气血、津液、五志、六淫等学说为主要内容，用无神论、整体、人与自然相应、发展变化的观点，论述了人体的生理病理以及诊断要领和防病治病的原则。记载了九种针具的形状、功用和用途，对经络、腧穴、针灸的适应症、禁忌症及其治疗原则等，都作了比较详细的论述。给中国医药学，特别是针灸学奠定了独特的理论体系。《黄帝八十一难经》提出

脉诊独取寸口、脏腑经络、奇经八脉、针法要双手操作重用左手等论述，颇有独到之处。晋朝皇甫谧（公元215～公元282年），著《针灸甲乙经》是第二次针灸大总结，提出头、面、耳、颈、背、肩、胸、胁、腹等分部、分经取穴法，对常见病证的针灸治疗方法，作了全面的论述。它不但对我国针灸医学的发展起着巨大作用，而且对针灸医学向国外传播、推广也有深远影响。唐朝孙思邈于公元650～682年撰成《千金要方》和《千金翼方》，绘《明堂三人图》，首次提出“阿是穴”，对唐朝以后“经外奇穴”的发展，起了启发作用。宋朝王唯一（公元1023～1063年）铸两座铜人，为我国最早的针灸模型，1026年撰《铜人腧穴针灸图经》，这部书当时曾刻在两块石碑上，树立在汴京，对于统一各家有关腧穴的位置有很大贡献。金代何若愚撰《子午流注针经》和《流注指微赋》，提出子午流注纳甲法按时取穴。金元时代窦汉卿（公元1190～1280年）著《针经指南》、《通玄指要赋》、《标幽赋》创用下针十四法，提倡按时取穴。滑伯仁1341年将十二经和任督二脉合成十四经，撰《十四经发挥》，对考究经络、腧穴很有贡献。明朝徐风，1439年撰《针灸大全》、《金针赋》，将《子午流注》“纳甲法”原先的十二个图缩改为十图。提倡“灵龟八法”、“飞腾八法”等按时取穴，对接时取穴的发展起了一定作用。杨继洲公元1601年撰《针灸大成》，很有独到之处，可以说是明朝以前针灸的又一次大总结。对后世针灸的取穴、针刺手法、治疗各科病证，有很大的指导价值。

1822年清朝政府因拘于封建礼教，竟以“针刺火灸，究非奉君所宜”的荒谬理由，下令停止太医院使用针灸，废止针灸科。1929年2月26日，国民党政府中央卫生委员会通过余云岫“废止旧医……”的提案，规定消灭中医的措施，医界春秋社通告全国中医界，于3月17日在上海召开全国中医中药团体代表会议，派出请愿代表团到南京，请愿罢工，因为中医中药有群众基础，得

到了社会各界的支持，使其提案未能实施。

中华人民共和国成立后，针灸事业又获得新生，成立针灸医疗、科研、教学机构和国际班，不但在国内培养针灸人才，而且为世界各国培养了大批针灸医生。使我国独特的针灸医学进入了一个新阶段，也逐渐发展成为世界人民的共同财富。

针灸著作如雨后春笋，蓬勃发展。拙著《针灸集锦》于1978年9月出版后，受到国内外读者的好评，六年内连续三次印刷75,600册。1984年在北京召开的中国针灸学会第二届全国针灸针麻学术讨论会展销时，引起了国内、外专家学者的重视。为了满足海内外读者的要求，承出版部门的帮助及敦促，特此修订再版。

全书共三篇。第一篇经络腧穴，主要论述经络腧穴在人体的生理功能、病理变化，及其在诊断、治疗上的作用。为了临床取穴准确和辨证施治，对每个腧穴，概括性地阐明了穴名解释和穴性功能，在常用及重要穴后根据个人实践体会和前人经验加了按语，以便读者加深印象。第二篇针灸方法，重点地介绍了烧山火、透天凉等各种针刺手法操作和适应症，并对灸法、新医疗法和针麻作了扼要介绍。第三篇临床治疗，介绍了临床配穴原则、规律、和汗、吐、下、和、温、清、补、消“八法”在针灸治疗上的应用，以及治症总要和脏腑经络证治；并附有二十三种中医病名的辨证配穴、四十一種西医病名的临床治疗总结摘要，附病案八十二例和六十四例医案，其中：这次修订再版增加了穴名解释，部分传统手法，对手法补泻的探讨，对热补、凉泻针刺手法的实验观察，治疗总要，脏腑经络证治以及病种和医案多则等，约十万字。增补内容，大部分是郑俊江、郑俊明整理的，附以说明。

本书内容力求理论联系实际，注重临床实践，取材有所侧重，文字浅显易懂，并附插图。可供中医师、西学中医师及广大针灸工作者参考。由于实践不足，知识有限，书中缺点错误在所

难免，尚希读者批评指正。

郑 魁 山

1988年元月于甘肃中医学院

目 录

第一篇 经络腧穴

第一章 经络腧穴总论	(1)
第一节 经络	(1)
一、经络系统的结构	(1)
二、经络的作用	(5)
第二节 腧穴	(8)
一、腧穴的分类	(8)
二、腧穴的作用	(9)
三、取穴法	(13)
第二章 经络腧穴各论	(20)
第一节 手太阴肺经	(20)
中府 (22) 云门 (22) 天府 (23) 侠白 (23)	
尺泽 (24) 孔最 (24) 列缺 (25) 经渠 (26)	
太渊 (27) 鱼际 (28) 少商 (29)	
第二节 手阳明大肠经	(27)
商阳 (29) 二间 (30) 三间 (30) 合谷 (30)	
阳溪 (32) 偏历 (32) 温溜 (33) 下廉 (33)	
上廉 (43) 手三里 (43) 曲池 (35) 肘髎 (35)	
五里 (36) 臂臑 (36) 肩髃 (36) 巨骨 (37)	
天鼎 (37) 扶突 (38) 禾髎 (38) 迎香 (38)	
第三节 足阳明胃经	(39)
承泣 (41) 四白 (41) 巨髎 (42) 地仓 (42)	
大迎 (42) 颊车 (43) 下关 (43) 头维 (44)	
人迎 (44) 水突 (45) 气舍 (45) 缺盆 (45)	
气户 (46) 库房 (46) 屋翳 (46) 膺窗 (47)	

乳中(47)	乳根(47)	不容(48)	承满(48)
梁门(49)	关门(49)	太乙(49)	滑肉门(50)
天枢(50)	外陵(51)	大巨(51)	水道(51)
归来(52)	气冲(52)	髀关(53)	伏兔(53)
阴市(53)	梁丘(54)	犊鼻(54)	足三里(54)
上巨虚(55)	条口(56)	下巨虚(56)	丰隆(57)
解溪(57)	冲阳(57)	陷谷(58)	内庭(58)
厉兑(59)			

第四节 足太阴脾经..... (59)

隐白(61)	大都(61)	太白(62)	公孙(63)
商丘(63)	三阴交(63)	漏谷(64)	地机(64)
阴陵泉(65)	血海(65)	箕门(66)	冲门(66)
府舍(67)	腹结(67)	大横(68)	腹哀(68)
食窦(69)	天溪(69)	胸乡(69)	周荣(70)
大包(70)			

第五节 手少阴心经..... (70)

极泉(72)	青灵(73)	少海(73)	灵道(73)
通里(74)	阴郄(74)	神门(75)	少府(75)
少冲(76)			

第六节 手太阳小肠经..... (76)

少泽(77)	前谷(79)	后溪(79)	腕骨(80)
阳谷(80)	养老(81)	支正(81)	小海(82)
肩贞(82)	臑俞(82)	天宗(83)	秉风(83)
曲垣(84)	肩外俞(84)	肩中俞(84)	天窗(85)
天容(85)	颧髻(85)	听宫(86)	

第七节 足太阳膀胱经..... (86)

睛明(88)	攒竹(89)	眉冲(90)	曲差(90)
五处(90)	承光(91)	通天(91)	络却(91)
玉枕(92)	天柱(92)	大杼(90)	风门(93)
肺俞(93)	厥阴俞(94)	心俞(94)	督俞(95)

膈俞(95)	肝俞(96)	胆俞(97)	脾俞(97)
胃俞(98)	三焦俞(98)	肾俞(99)	气海俞(99)
大肠俞(100)	关元俞(100)	小肠俞(101)	膀胱俞(101)
中膻俞(102)	白环俞(102)	上髎(102)	次髎(103)
中髎(103)	下髎(104)	会阳(104)	附分(104)
魄户(105)	膏肓(105)	神堂(106)	谿谿(106)
膈关(106)	魂门(107)	阳纲(107)	意舍(107)
胃仓(108)	育门(108)	志室(108)	胞肓(109)
秩边(109)	承扶(109)	殷门(110)	浮郤(110)
委阳(110)	委中(111)	合阳(111)	承筋(111)
承山(112)	飞扬(112)	跗阳(113)	昆仑(113)
仆参(113)	申脉(114)	金门(114)	京骨(115)
束骨(115)	足通谷(116)	至阴(116)	

第八节 足少阴肾经..... (116)

涌泉(117)	然谷(119)	太溪(119)	大钟(120)
水泉(120)	照海(121)	复溜(121)	交信(122)
筑宾(122)	阴谷(122)	横骨(122)	大赫(122)
气穴(124)	四满(124)	中注(125)	育俞(125)
商曲(125)	石关(126)	阴都(126)	通谷(127)
幽门(127)	步廊(128)	神封(128)	灵墟(128)
神藏(129)	臑中(129)	俞府(129)	

第九节 手厥阴心包络经..... (130)

天池(130)	天泉(132)	曲泽(132)	郄门(132)
间使(133)	内关(133)	大陵(134)	劳宫(134)
中冲(135)			

第十节 手少阳三焦经..... (135)

关冲(137)	液门(137)	中渚(138)	阳池(138)
外关(139)	支沟(139)	会宗(140)	三阳络(140)
四渎(141)	天井(141)	清冷渊(141)	消泺(142)
臑会(142)	肩髃(142)		

天髎(143)	天牖(143)	翳风(143)	瘛脉(144)
颊息(144)	角孙(145)	耳门(145)	和髎(145)
丝竹空(146)			

第十一节 足少阳胆经 (146)

瞳子髎(147)	听会(149)	上关(149)	颌厌(150)
悬颅(150)	悬厘(150)	曲鬓(151)	率谷(151)
天冲(152)	浮白(152)	头窍阴(152)	完骨(153)
本神(153)	阳白(154)	头临泣(154)	目窗(155)
正营(155)	承灵(155)	脑空(156)	风池(156)
肩井(157)	渊液(157)	辄筋(158)	日月(158)
京门(159)	带脉(159)	五枢(159)	维道(160)
居髎(160)	环跳(161)	风市(161)	中渎(162)
膝阳关(162)	阳陵泉(162)	阳交(163)	外丘(163)
光明(164)	阳辅(164)	悬钟(165)	丘墟(165)
足临泣(165)	地五会(166)	侠溪(166)	足窍阴(167)

第十二节 足厥阴肝经 (167)

大敦(168)	行间(170)	太冲(170)	中封(171)
蠡沟(171)	中都(172)	膝关(172)	曲泉(172)
阴包(173)	足五里(173)	阴廉(174)	急脉(174)
章门(174)	期门(175)		

第十三节 任脉 (175)

会阴(177)	曲骨(177)	中极(178)	关元(178)
石门(179)	气海(179)	阴交(180)	神阙(180)
水分(180)	下脘(181)	建里(181)	中脘(182)
上脘(182)	巨阙(183)	鸠尾(183)	中庭(183)
膻中(184)	玉堂(184)	紫宫(184)	华盖(185)
璇玑(185)	天突(185)	廉泉(186)	承浆(186)

第十四节 督脉 (187)

长强(188)	腰俞(188)	腰阳关(189)	命门(189)
悬枢(190)	脊中(190)	中枢(190)	筋缩(190)

至阳 (191)	灵台 (191)	神道 (191)	身柱 (192)
陶道 (192)	大椎 (193)	哑门 (193)	风府 (194)
脑户 (194)	强间 (194)	后顶 (195)	百会 (195)
前顶 (195)	囟会 (196)	上星 (196)	神庭 (196)
素髻 (197)	人中 (197)	兑端 (197)	龈交 (198)
第十五节 其它经脉 (198)			
冲脉 (198)	带脉 (199)	阴跷脉 (201)	阳跷脉 (201)
阴维脉 (201)	阳维脉 (203)		
第十六节 经外奇穴 (204)			
印堂 (204)	鱼腰 (204)	太阳 (204)	球后 (205)
上迎香 (205)	金津 (205)	玉液 (205)	旁廉泉 (205)
上廉泉 (206)	百劳 (206)	喘息 (206)	定喘 (206)
腰眼 (207)	华佗夹脊 (207)	提托 (207)	
子宫 (207)	肩缝 (208)	抬肩 (208)	疟门 (208)
手小节 (208)	落枕 (209)	八邪 (209)	十王 (209)
三关 (209)	四缝 (210)	十宣 (210)	四强 (210)
鹤顶 (211)	上阳关 (211)	膝眼 (211)	陵下 (211)
阑尾 (212)	纠下垂 (212)	纠内翻 (212)	纠外翻 (212)
八风 (212)	足小节 (213)		
第十七节 经络的分布与临床应用 (213)			
一、根结标本与气街 (213)			
二、四海 (218)			
三、三阳三阴与关、阖、枢 (220)			

第二篇 针灸方法

第一章 针 法 (223)	
第一节 古代九针简介 (223)	
一、毫针的规格 (225)	
二、选针与藏针 (225)	
第二节 内经刺法 (226)	

一、属于不同浅深的刺法	(226)
二、属于取穴原则的刺法	(229)
三、其它刺法	(230)
第三节 针治的作用及注意事项	(231)
一、针治的作用	(232)
二、针治注意事项	(233)
第四节 禁针与异常现象的处理	(236)
一、禁针	(236)
二、针刺异常现象及处理	(237)
第五节 其它针及疗法	(238)
一、三棱针	(238)
二、挑治	(239)
三、火针	(241)
四、皮下埋针	(241)
五、丛针	(242)
六、拔罐与捏脊	(243)
第六节 新医疗法与针刺麻醉	(246)
一、穴位注射	(246)
二、强刺激结扎	(247)
三、穴位埋线	(248)
四、耳针	(249)
五、针刺麻醉	(253)
第二章 手 法	(258)
第一节 练针法	(258)
一、关节练习法	(258)
二、左右手练习法	(259)
第二节 揣穴(定穴)法	(260)
一、指切法	(261)
二、按压法	(261)
三、分拨法	(261)

四、旋转法	(262)
五、滚摇法	(262)
六、升降法	(263)
七、滚摇升降法	(263)
第三节 进针法	(264)
一、指切速刺法	(264)
二、缓慢捻进法	(265)
三、刺入捻进法	(265)
四、管针打入法	(265)
五、指切压入法	(266)
六、压针缓进法	(266)
第四节 行针候气法	(266)
一、候气催气法	(268)
二、行气法	(269)
三、守气法	(271)
四、留针与出针	(273)
第五节 补泻手法	(273)
一、迎随补泻法	(273)
二、呼吸补泻法	(273)
三、徐疾补泻法	(274)
四、捻转补泻法	(275)
五、荣卫补泻法	(276)
六、开合补泻法	(276)
七、虚实补泻法	(276)
第六节 混合补泻法	(277)
一、烧山火(补法)	(277)
二、透天凉(泻法)	(278)
三、阳中隐阴(先补后泻法)	(279)
四、阴中隐阳(先泻后补法)	(280)
五、苍龟探穴(平补平泻、行气法)	(280)

六、赤凤迎源(平补平泻、行气法)	(281)
七、进火补法	(281)
八、进水泻法	(282)
九、苍龙摆尾	(283)
十、赤凤摇头	(283)
十一、热补法	(284)
十二、凉泻法	(285)
十三、针刺热补(烧山火)凉泻(透天凉)手法对皮肤温度影响的实验观察	(285)
十四、对热补(烧山火)凉泻(透天凉)针刺手法的实验观察	(293)
十五、对手法、补泻的探讨	(298)
第三章 灸 法	(302)
第一节 施灸的原料	(302)
第二节 艾灸的常用方法	(303)
一、艾炷灸法	(303)
二、艾条灸法	(305)
第三节 施灸的作用与注意事项	(306)
一、施灸的作用	(306)
二、施灸注意事项	(307)

第三篇 临床治疗

第一章 临床治疗总论	(309)
第一节 针灸治病总则	(309)
一、补虚泻实	(309)
二、标本缓急	(309)
三、主次先后	(310)
第二节 特定穴的应用	(310)
一、五腧穴	(311)
二、原络穴	(313)

三、俞募穴	(314)
四、八会穴	(316)
五、八脉交会穴	(317)
六、郄穴	(317)
七、六腑下合穴	(318)
八、四总穴	(319)
九、回阳九针穴	(319)
第三节 配穴法	(320)
一、远隔配穴法	(320)
二、局部配穴法	(321)
三、远近配穴法	(321)
第四节 治症总要(杨氏治症总要)	(322)
第五节 “八法”在针灸治疗上的应用	(339)
一、汗法	(339)
二、吐法	(340)
三、下法	(342)
四、和法	(343)
五、温法	(344)
六、清法	(345)
七、补法	(346)
八、消法	(347)
第二章 临床治疗各论	(349)
第一节 脏腑经络证治	(349)
一、肺和大肠	(349)
二、脾和胃	(351)
三、心和小肠	(352)
四、肾和膀胱	(353)
五、心包和三焦	(354)
六、肝和胆	(355)
第二节 辨证配穴	(357)

一、昏迷不醒	(357)
二、恶心呕吐	(358)
三、便秘	(358)
四、脱肛	(358)
五、遗尿	(359)
六、尿闭	(359)
七、遗精	(360)
八、疝气	(361)
九、头痛	(361)
十、胸痛	(362)
十一、胁痛	(362)
十二、胃脘痛	(363)
十三、腹痛	(363)
十四、腰痛	(364)
十五、妇女月经病	(364)
十六、带下	(365)
十七、乳汁不足	(366)
十八、小儿抽风	(367)
十九、耳鸣、耳聋	(367)
二十、牙痛	(367)
二十一、冻疮	(368)
二十二、鹅掌风	(368)
二十三、聋哑	(369)
第三节 临床治疗总结摘要	(369)
一、感冒	(369)
二、支气管炎	(370)
三、支气管哮喘	(372)
四、急性胃肠炎	(373)
五、胃及十二指肠溃疡	(375)
六、胃下垂	(379)
七、胆囊炎	(383)

八、急性阑尾炎	(385)
九、痢疾	(386)
十、疟疾	(387)
十一、神经衰弱	(389)
十二、瘧病	(392)
十三、癲癇	(398)
十四、脑血管意外	(399)
十五、脑血管意外后遗偏瘫	(406)
十六、面神经麻痹	(409)
十七、小儿麻痹及后遗症	(410)
十八、传染性多发性神经炎	(413)
十九、风湿性关节炎	(417)
二十、脊椎炎	(420)
二十一、坐骨神经痛	(422)
二十二、腰肌劳损	(425)
二十三、肩关节周围炎	(427)
二十四、单纯性甲状腺肿	(429)
二十五、腱鞘炎	(431)
二十六、腱鞘囊肿	(432)
二十七、创伤性肿痛(软组织损伤)	(433)
二十八、颈淋巴结结核	(435)
二十九、急性淋巴管炎	(436)
三十、腮腺炎(痄腮)	(437)
三十一、闭经	(438)
三十二、小儿营养不良症	(440)
三十三、百日咳	(442)
三十四、急性结膜炎	(443)
三十五、近视	(444)
三十六、视网膜出血	(445)
三十七、视神经萎缩	(449)
三十八、内耳眩晕症	(451)

三十九、链霉素中毒性耳聋	(452)
四十、鼻炎	(456)
四十一、急性扁桃体炎	(457)
第四节 医 案	(459)
一、上呼吸道感染	(459)
二、支气管哮喘合并肺炎	(459)
三、流行性胸痛	(461)
四、风湿热(关节型)	(462)
五、风湿性心脏病	(463)
六、膈肌痉挛(呃逆)	(464)
七、慢性萎缩性胃炎	(464)
八、贲门癌	(465)
九、糖尿病	(466)
十、肠麻痹	(467)
十一、慢性肠炎	(467)
十二、结肠炎伴肠痉挛	(468)
十三、五更泻	(469)
十四、消化不良	(469)
十五、急性肾炎	(470)
十六、急性膀胱炎	(471)
十七、慢性前列腺炎	(472)
十八、偏头痛并低血压症	(472)
十九、病毒性感染性头痛	(473)
二十、乙型脑炎后遗症	(474)
二十一、脑震荡	(474)
二十二、腰麻后遗症	(475)
二十三、多发性神经根炎	(475)
二十四、三叉神经痛	(476)
二十五、眶上神经痛	(476)
二十六、尺神经麻痹	(477)
二十七、正中神经麻痹	(478)

二十八、巴比妥中毒后遗症	(479)
二十九、植物神经功能紊乱	(481)
三十、两手震颤	(482)
三十一、功能性震颤	(482)
三十二、一氧化碳中毒	(483)
三十三、椎间盘脱出	(483)
三十四、骶椎腰化伴坐骨神经痛	(484)
三十五、荐肠关节结核(骶髂关节结核)	(485)
三十六、大骨节病	(486)
三十七、腰椎压缩性粉碎性骨折	(487)
三十八、下肢静脉曲张并发血栓性静脉炎	(488)
三十九、面肌痉挛	(489)
四十、腓肠肌痉挛	(489)
四十一、进行性肌营养不良症	(490)
四十二、慢性盆腔炎	(490)
四十三、功能性子宫出血	(491)
四十四、产后感染	(492)
四十五、产后无乳	(493)
四十六、慢性毛囊炎	(493)
四十七、酒皲鼻	(494)
四十八、带状疱疹	(494)
四十九、顽固性荨麻疹	(495)
五十、过敏性紫癜	(495)
五十一、翼状赘肉	(496)
五十二、青光眼	(496)
五十三、视网膜脉络膜炎	(497)
五十四、电光性眼炎	(497)
五十五、麻痹性外斜视	(498)
五十六、麻痹性内斜视	(499)
五十七、鼻衄	(498)
五十八、慢性上颌窦炎	(499)

五十九、化脓性中耳炎	(500)
六十、慢性唇炎	(501)
六十一、口腔溃疡	(501)
六十二、急性牙周炎	(502)
六十三、急性喉头炎	(503)
六十四、下颌关节炎	(503)

第一篇 经络腧穴

第一章 经络腧穴总论

经络是人体运行气血，联络脏腑，沟通内外，贯穿上下的径路；腧穴是经气输注交会于皮、肉、筋、骨间的部位。经络和腧穴同属一个系统，在生理、病理、诊断和治疗等方面都有密切的联系。

第一节 经 络

经系经脉，“直行者为经”，是主干，比较大；络是络脉，“支而横者为络”，是旁支，比较小。脉行络连，通称经络。经络贯穿于人体，从脏腑、肌肉、筋骨以至皮肤等一切组织，形成纵横交叉的罗网，就象自然界的河流渠道一样。气血就是通过经络昼夜运行，如环无端、周流不息的传注，使人体各部的机能活动和整个机体都保持了共济和协调。

一、经络系统的结构

经络系统是由十二经脉、奇经八脉、十五络脉、十二经别、十二经筋、十二经水和十二皮部的紧密联系所构成的。

1. 十二经脉：因阴阳属性不同，分为三阴三阳，即手足三阴和手足三阳共十二条经脉，称为十二正经。每经都归属和联络一

脏（阴）一腑（阳），形成脏腑的络属和阴阳配偶关系。十二经在体内，六阴经分别归属于肝、心、脾、肺、肾五脏（加心包络为六脏）。六阳经分别归属于胆、小肠、胃、大肠、膀胱、三焦六腑。十二经在体表分别于头面、躯干、四肢以阴升阳降的单向循行规律，逐经相传，如环无端、周而复始的构成气血运行的通路。

经脉阴升阳降的单向循行规律，可概括为手之三阴从胸走手，手之三阳从手走头，足之三阳从头走足，足之三阴从足走胸。

古人在长期的临床实践中观察认识到，脏腑生理的阴阳消长关系，犹如天时之六气。如心、肾二经似阴气之初生，应六气的少阴；脾、肺二经似阴气之大盛，应六气的太阴；心包络、肝二经似阴气之消尽，应六气的厥阴；三焦、胆二经似阳气之初生，应六气的少阳；小肠、膀胱二经似阳气之大盛，应六气的太阳；大肠、胃二经似阳气之最盛，应六气的阳明。从而又比类作象地为十二经订出了名称。如手太阴肺经、手少阴心经、手厥阴心包络经等。说明了人体与自然界是息息相关的。同时根据各脏腑之间在生理功能上的联系，找出了互为表里的配偶关系。如肺与大肠、脾与胃、心与小肠、肾与膀胱、肝与胆、心包络与三焦相表里。其所属的经脉亦自然成为一阴一阳的配偶关系；如手太阴肺经与手阳明大肠经，手少阴心经与手太阳小肠经……互为表里。

并以金、水、木、火、土五种物质属性和生克制化喻配于五脏六腑。如肺和大肠属金、肾和膀胱属水、肝和胆属木、心和小肠属火、脾和胃属土、心包络和三焦属相火。来阐明人体是一个统一的整体和十二经所属脏腑在生理功能、病理变化上存在着相互依存、相互制约、相互联系、相互影响的关系。五行的相生比喻脏腑的相互依存，相克比喻脏腑的相互制约，在人体生理正常时，阴阳平衡，脏腑协调；病理变化时，则出现阴阳偏胜或偏衰，脏腑失调。也就是说十二经和所属脏腑，必须保持阴阳的平

衡统一和脏腑的协调，才能维持机体正常的生理活动（表1）。

表1 十二经脉脏腑表里衔接走向

阴		脏（里）		腑（表）		阳	
		胸中衔接		四肢衔接			
太阴	手	肺 ↓ 脾 ↓ 心 ↓ 肾 ↓ 心包 ↓ 肝	手次指内端（商阳）→ 大肠 ↓ 鼻孔傍（迎香）		手	阳明	
	足		足大趾内端（隐白）←				足
少阴	手	胸中 ↓ 肾 ↓ 心包	手小指端（少冲、少泽）→ 小肠 ↓ 内眼角（睛明）		手	太阳	
	足		足小趾端（至阴）← 膀胱				足
厥阴	手	胸中 ↓ 肝	手无名指端（关冲）→ 三焦 ↓ 外眼角（瞳子髎）		手	少阳	
	足		足大趾外端（大敦）← 胆				足

2. 奇经八脉：无脏腑络属和阴升阳降规律，亦无配偶，而别道奇行，但与“奇恒之腑”（脑、髓、骨、脉、胆、女子胞）有密切联系，故称奇经。奇经有八脉，任脉行于胸腹，总任一身之阴经；督脉行于脊背，总督一身之阳经；冲脉与足少阴并行；带脉在季肋下，绕身一周；阳跷为足太阳之别，由足跟外侧上行；阴跷为足少阴之别，由足跟内侧上行；阳维起于足跟，出外踝并足少阳等经上行；阴维起于小腿内侧，并足太阴经等上行；总之

阳脉从外侧面，阴脉从内侧面，由下向上循行，阴阳相维，诸脉乃调。八脉中唯督、任有专穴，由元代滑伯仁著《十四经发挥》，将任督二脉合十二经为十四经，其余六脉皆附于十二经中。

3.十五络脉：十四经脉各别出一络，加脾之大络，共称十五络。十五络脉皆有自己的分布部位，其中十二经之络脉各由肘膝以下分出，在体表构成表里经相互联络的通路。任脉之络分布在腹部，督脉之络分布在背部，脾之大络分布在侧身部，加强了人体的统一和联系。《灵枢·经脉篇》已有详载，兹不赘述。由于《素问·平人氣象论篇》又有“胃之大络名曰虚里”的记载，故又有十六络之称。关于十五络穴的作用和应用参见《特定穴的应用》原络穴一节。

4.十二经别：是十二正经的别行部分。它的循行是由四肢走入内脏，复出头颈，比较络脉则为深长。它是在互为表里配偶的阴阳经之间出入离合，作为中途加强联系的通路。但阴经与阳经之间有一区别，六阳经别行后仍能合到本经，六阴经别行后不再返回本经，而和其互为表里的阳经相合。由于它是正经所别出的支脉，所以称为别行的正经。

5.十二经筋：是十二经别以外的另一个循行系统，起于四肢末端，行于关节部分，上至颈项头面，但不入内脏。十二经筋，是十二经脉之气输注、积聚、散布于筋、肉、关节的体系，也是十二经脉的附属部分。其循行和十二经脉的体表通路基本是一致的。但与十二经阴升阳降的规律不同。

6.十二经水：主要是古人借助于当时十二条有名的河流，比喻人体十二经脉之大小、深浅、气血之多少和十二经脉交叉离合的联系及输注、濡养的作用。在临床治疗上实用意义不大，故从略。

7.十二皮部：是经络机能活动反映于体表的部位。皮为一身之躯壳，在内包括脏腑，在外则司毫毛腠理之开合，而为诸邪出

入之门户，也就是由于它居于人体最外层，所以是机体卫外的屏障，在病理上，邪气可以通过皮部而深入络脉、经脉以至脏腑；而内脏有病，也可通过经脉、络脉反映于皮部。

二、经络的作用

《灵枢·经脉》篇说：“人始生，先成精，精成而脑髓生，骨为干，脉为营，筋为刚，肉为墙，皮肤坚而毛发长，谷入于胃，脉道以通，血气乃行……经脉者，所以能决死生，处百病，调虚实，不可不通。”这就是说成形始于精，养形在于谷，都必须依靠经络运行气血，营养周身，才能进行复杂的生命活动。当人体得了病，往往会反映到经络上来，在进行治疗时，也应当根据经络显现之虚实症候进行施治。所以针灸治病更须首先熟悉经络。两千多年来，经络学说一直是中医指导临床、分析生理、病理、诊断和治疗方面的主要依据，因此，“不懂经络，动手开口便错”的说法是有道理的。

1. 在生理上的作用：《灵枢·本脏》篇说：“经脉者，所以行血气而营阴阳，濡筋骨，利关节者也”。说明气血必须依靠经络循环不息的运行、输注，才能供给人体五脏、六腑、四肢、百骸、组织器官的营养，从而使机体得到正常活动的物质基础。人体各脏腑器官进行有规律的活动时，经常受天时气候的影响，因此经络还有调节机体内在活动适应外界环境变化的作用。正如《素问·生气通天论篇》所载的“其气九州、九窍、五脏、十二节，皆通乎天气”的学说。就是说明，经络在运行气血、营养周身、适应自然环境等方面，都起着很重要的作用。

2. 在病理上的作用：当机体处于病理状态时，经络有传递病邪和反映症候的作用。在传递病邪方面：正如《素问·缪刺论篇》说的：“邪之客于形也，必先舍于皮毛……入舍于孙脉……入舍于络脉……入舍于经脉，内连五脏，散于肠胃”。说明外邪

在机体卫外功能减弱，或失常时，即会由表传里。例如外感风寒，往往会引起头痛、鼻塞，甚或出现腹痛、下泻。就是病邪由表传里的表现。在反映病理症候方面：经络运行失常，气血受阻，就会在所过部位的某处发生疼痛、肿胀或功能障碍；如因经气不足，可能在病变部位出现肌肤麻木、萎弱无力、功能减退等症候。脏腑有病也往往会在所属和有关的经络线上或所辖部位显现异常。如《素问·藏气法时论篇》说的“肝病者，两胁下痛”。在某种情况下脏腑有病也会在本经脏腑所司的组织发生病理改变。如《灵枢·经脉》篇说的“手太阴气绝，则皮毛焦”。就是脏腑有病通过经络反映到体表来的现象。由此可见，经络在使病邪传递和反映病理症候上都起着重要作用。

3. 在诊断上的作用：《素问·三部九候论篇》说“有下部，有中部，有上部；部各有三候……中部天，手太阴也；中部地，手阳明也；中部人，手少阴也；下部天，足厥阴也；下部地，足少阴也；下部人，足太阴也。故下部之天以候肝，地以候肾，人以候脾胃之气”。就是在人体相应的部位来诊察人体经络的异常和症候的方法。

近代根据古人触经按穴的诊察方法，发展地运用了经络传导刺激和反映症候的临床特性，来察知脏腑经络的病变。如望诊，有的患者当脏腑发生病变时，在皮肤上循经出现红线、白线和丘疹、湿疹、色素痣、扁平苔癣等带状分布，医者以此为线索，结合辨证施治和其它诊查方法，诊断疾病。问诊，在临床上询问时，有许多病人都是因局部不知缘故的疼痛、痠困等自觉症状来就诊，检查后，结果都与脏腑经络有关。触诊，针灸临床工作者，常沿问诊所得的线索，循经摸揣，按压穴位，如背俞及腹募穴，看是否有结节、过敏、压痛等异常，帮助诊断，并为针灸治疗提示重要部位。仪器，用经络测定仪，尤其是用耳针测定仪进行诊查，为进一步诊断，提示很有意义的线索。所以经络在诊断

上也是很重要的。

4.在治疗上的作用：前已叙述，经络有内连脏腑，外络支节，运行气血，协调阴阳，传导感应，调整虚实的功能。故针灸治病，多按病位症状归经，采用循经取穴的方法进行治疗。不但有五腧取穴、原络配穴、俞募配穴、异经取穴、巨刺、缪刺、刺络和上病取下，下病取上的治疗方法。而且还有按照经络循行的方向，进行迎随补泻的针刺手法。所以经络在治疗上也有它的特殊价值。

5.感觉传导与经络有密切关系：针灸临床诊疗，基本依经络的传导来完成，故研究经络的传导，对进一步理解和探索经络的实质，有很重要的意义。根据1964年3月在中医研究院针灸研究所1980例患者，全身58个穴位，针6439次的结果，循经的占69.7%，穴位周围的占24.03%，不循经的仅占6.27%。临床上有些典型例子基本上是与经脉循行部位相符合的。例如针陷谷穴的感觉沿胃经上至头维，下至内庭穴；针内关的感觉沿心包络经上至天池，下至中冲穴；针命门的感覺沿督脉上至大椎，下至长强穴。足以证明经络的传导，是有一定径线的。

针刺部位的不同也影响着感传径线的变化：头项、胸腹和背部穴位，感觉常为片状放散，传导近而不循经的较多。如针天枢穴感觉多为片状放散或斜行传导，以不循经的和传到一侧腹部的较多，肺俞、心俞感传常沿肋骨放散，有时并放散到胸腔或腹腔；这说明背部“俞穴”、腹部“募穴”确实与脏腑有关系。四肢穴位，尤其是肘膝以下的穴位，感觉多为循经传导，并且传导波较远。如针足三里的感传上至头维，下至足次趾……等。也说明了“五腧穴”与经脉确有密切的关系。

第二节 腧 穴

腧穴是人体脏腑经络之气输注，聚结于体表的部位，也是施行针灸治病的处所。腧穴是经穴、奇穴、阿是穴等的总称。在《内经》里腧、输、俞三字通用。腧通输，有转输流注之意，俞为简写。穴有空隙的含义，象隐藏之土室与空洞。腧穴在《内经》里称为气穴、骨空，在晋初皇甫谧《甲乙经》自序中称为孔穴，到元代《金兰循经》中称为经穴。

一、腧穴的分类

腧穴的种类很多，但总括起来不外三类：

1. 经穴：是《内经》、《铜人经》里有记载属于十四经系统内的腧穴。经穴这个名称，可能是因为这些穴位分别联属在一定的经络通路上，和经络脏腑有着密切关系而命名的。但在文字记载上，到元代《金兰循经》中始有称腧穴为经穴的记载。

穴数的记载：《内经》中有 365 个穴数，但因年代古远，有所遗缺，现在《内经》原文中只有单穴 25 个，双穴 135 个，共 295 个穴数；《甲乙经》中有单穴 49 个，双穴 300 个，共 649 个穴数；《铜人腧穴针灸图经》中有单穴 51 个，双穴 303 个，共 657 个穴数；《针灸大成》中有单穴 51 个，双穴 308 个，共 667 个穴数。根据各家腧穴数目的记载来看，历代腧穴数目随历史的进程是逐渐发展的。

2. 经外奇穴：是不属于十四经系统内的穴位。也是历代针灸工作者在临床治疗中逐渐发现积累起来的经验穴位。如太阳部的太阳穴治头痛、眼病；眉中的鱼腰治眼病等都有一定的疗效。所谓经外奇穴，并不是说它与经络循行道路绝对无关，而仅是表示它不属于原来的三百六十多个经穴而已。如古人将《内经》未载

的穴称奇穴，《铜人经》未载的穴称别穴，现在习惯上称《内经》、《铜人经》未载的穴皆为经外奇穴。

2.阿是穴：是在患处或过敏点上或患处附近施行针灸的部位。它没有固定的位置，是在患处选择适当的部位进针，也就是《内经》所说的“以痛为腧”的取穴法。阿是穴在唐代《千金方》中就有记载，后世《针方六集》的“不定穴”、《医学纲目》的“天应穴”等，名称虽然不同，但仍属一类。

二、腧穴的作用

腧穴分布在一定的经络循行路线上，它的作用和经络是密切相关的，在生理上，腧穴是脏腑经气运行输注、积聚出入之处所。在病理上，某经脏腑发病时，往往在某经的穴位上出现疼痛、麻痹或过敏等。在诊断上，常用手指压按各经的穴位和“俞穴”、“募穴”寻找压痛点，诊查疾病。针灸治疗就是根据这些特点施行补虚泻实、扶正驱邪来调整经络、脏腑之功能，而治愈疾病。所以腧穴几千年来一直是针灸、按摩治病的专用部位。但每个腧穴的主治范围很广，全身腧穴又很多，为了便于记忆，根据古代和现代文献的记载及临床治疗经验，将所有腧穴的按部归类分别将主治重点的共同性简述如下：

1.头、面、颈、项部腧穴：主治局部病和腧穴邻近器官及神志病（图1）。

2.胸、腹、背、腰部腧穴：主治局部病和腧穴部位的脏腑器官病。后背上部的腧穴兼治发热和上肢病；腰部以下的腧穴兼治虚寒症和下肢病（图2~4）。

3.肘、膝以上腧穴：主治局部病和腧穴邻近病。

4.肘、膝以下腧穴：主治局部病和腧穴邻近病，主要治疗本经的经络病和络属脏腑器官的疾病。如肺经腧穴能治喉、胸、肺的病；大肠经腧穴能治头、面、口、眼、喉和发热病；胃经腧

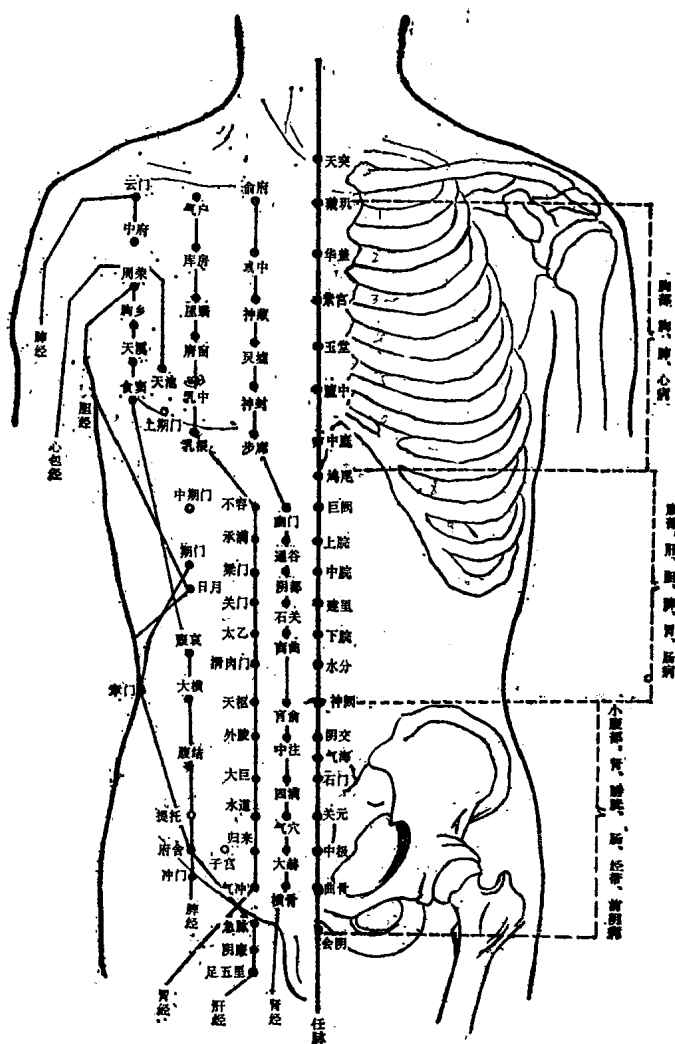


图3 胸腹部腧穴和主治

穴能治头、面、鼻、齿、胃、肠和发热病；脾经膻穴能治脾、胃病；心经膻穴能治胸、心和神志病；小肠经膻穴能治头、项、眼、耳和发热病；膀胱经膻穴能治头、项、腰、背、膀胱和发热病；肾经膻穴能治生殖、泌尿系和咽喉病；心包络经膻穴能治胸、心、胃、和神志病；三焦经膻穴能治头、耳、眼、胸、肋和发热病；胆经膻穴能治头、眼、耳、肋和发热病；肝经膻穴能治胸、肋、肝的病。总之头面躯干的穴位主治是以分部为主，四肢，尤其是肘膝以下的以分经为主（图5—9）。

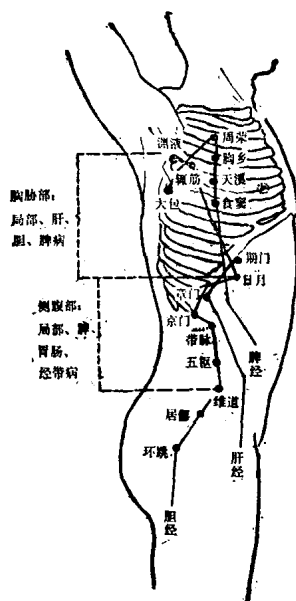


图4 胸胁侧腹部膻穴和主治

三、取穴法

寻找膻穴的位置，称为取穴。取穴准确与否直接影响治疗效果。为了取穴准确，必须掌握骨度折量分寸和体表天然标志。在取穴时首先要根据各部膻穴的具体情况，医生、患者用一定的姿势、动作（如患者的坐、卧、屈肘、张口和医生的推、拉、翻、转等）将体位姿势摆好，再采用骨度分寸折量取穴法、天然标志取穴法和手指同身寸取穴法。确定穴位的部位后，还要用手指在取穴部位行按压、分拨等手法，避开筋骨血管，寻到孔隙凹陷或压之出现痠、麻、胀感觉时，才能取得准确穴位。

1. 骨度分寸折量取穴法：是将病人身体某一部位的距离，折作一定的寸数，按规定寸数取穴。《灵枢·骨度》篇说的“众人之度，人长七尺五寸”。是说不论男女老少，高矮、肥瘦都是一

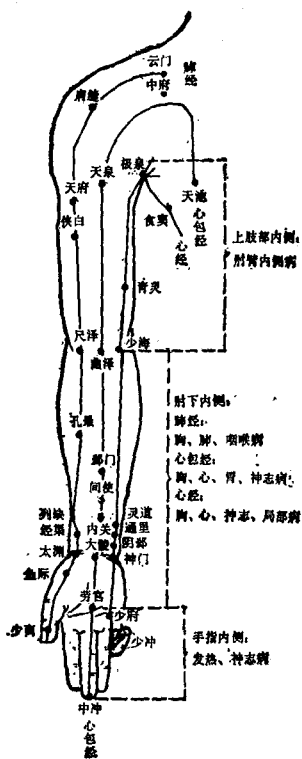


图5 上部内侧面腧穴和主治

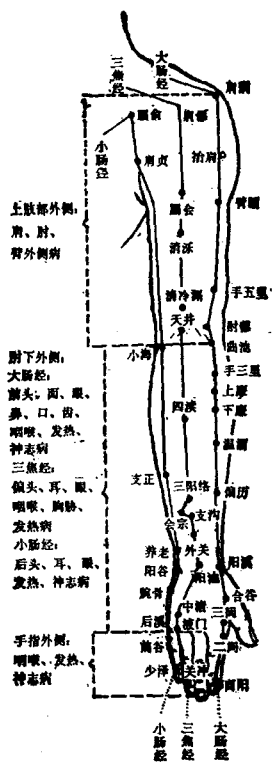


图6 上部外侧面腧穴和主治

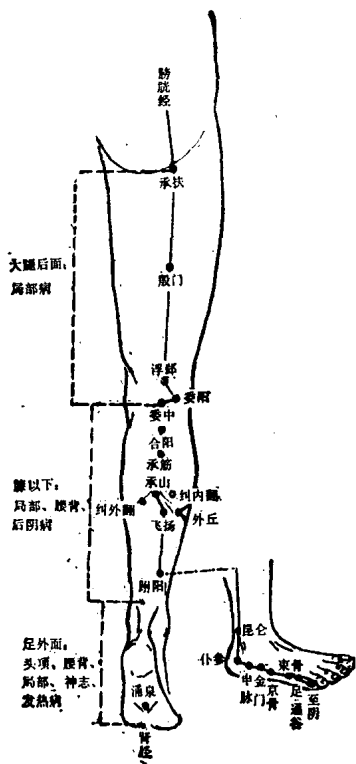


图7 下肢部背面腧穴和主治

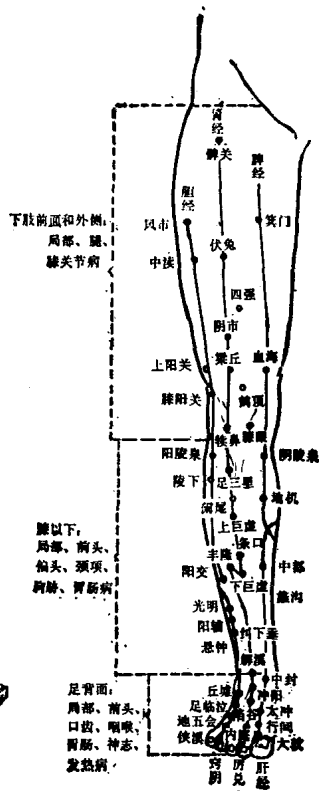


图8 下肢部前面腧穴和主治

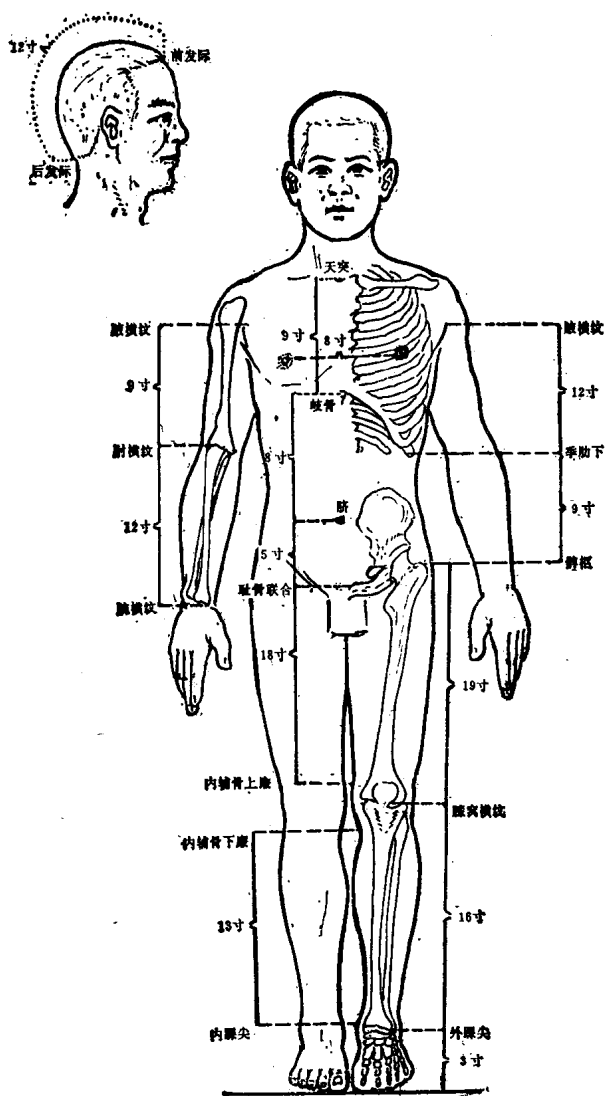


图10 骨度分寸折量法

表 2 常用骨度分寸折量法

部位	起 止 部 位	骨度分寸	度量法	说 明
头面颈项部	眉心至前发际	3寸	直寸	1.前后发际不明者,从眉心至大椎折作18寸。
	前发际至后发际	12寸	直寸	2.头维穴至神庭穴折作4.5寸。
	后发际至大椎	3寸	直寸	3.完骨指耳后乳突骨。
	前发际至颐	1尺	直寸	
	两头维之间	9寸	横寸	
	耳后两完骨之间	9寸	横寸	
	结喉至缺盆	4寸	直寸	
胸部	天突至岐骨	9寸	直寸	4.岐骨指剑突。
	岐骨至肚脐	8寸	直寸	5.横骨上廉指耻骨联合上缘。
	肚脐至横骨上廉	5寸	直寸	6.胸肋部的直寸按肋骨计算,一肋骨折作1.6寸。
	两乳头之间	8寸	横寸	7.季肋指十一肋端。
	腋下至季肋	12寸	直寸	8.脾枢指环跳处。
	季肋下至脾枢	9寸	直寸	
背部	大椎下至尾骶	21椎 3尺	直寸	9.大椎以下按脊椎数计算。
上肢部	腋前纹至肘横纹	9寸	直寸	10.腋前纹至腕横纹用于手三阴、三阳经的直寸。
	肘横纹至腕横纹	12寸	直寸	
	腕横纹至中指本节	4寸	直寸	
	中指本节至其末	4.5寸	直寸	
下肢部	横骨上廉至内辅骨上廉	18寸	直寸	11.内辅骨上廉指股骨内上髁。
	内辅骨下廉至内踝尖	13寸	直寸	12.臀横纹至膝中折作14寸。

续表

部位	起 止 部 位	骨度 分寸	度量法	说 明
下 肢 部	髌枢至膝中	19寸	直寸	13. 膝中指膝盖中央或膝窝横纹。
	膝中至外踝尖	16寸	直寸	14. 膝内侧用于足三阴经的直寸。
	外踝尖至足底	3寸	直寸	15. 膝外侧用于足三阳经的直寸。
	足 长	12寸	长度	



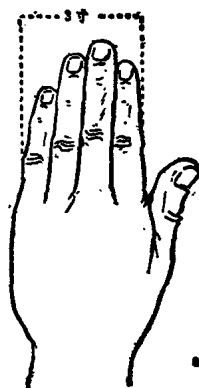
图11 中指同身寸



(1)



(2)



(3)

图12 横指寸

第二章 经络腧穴各论

经络和腧穴，是不可分割的完整系统，在临床治疗中，除个别奇穴和新穴外，都要循经取穴，因为针刺和艾灸的感应是靠经络传递，取得疗效的。许多针灸医籍中，把经络和腧穴分开论述，是为了叙述的方便。笔者为实际应用，将两者一并介绍，按照每条经络的循行路线、生理功能和病理症候，及该经腧穴的部位、穴释、功能、主治和针灸方法，分别叙述。并对某些穴位根据前人经验和个人临床体会加了按语，使读者对每条经络和它的腧穴有一个比较系统的概念，并能抓住重点，以便临床运用。

第一节 手太阴肺经

起于中府终于少商，左右共22穴。取少商、鱼际、太渊、经渠、尺泽为井、荣、俞、经、合。本穴经渠，络穴列缺，俞穴肺俞，募穴中府，郄穴孔最。

循行概述：起于中焦，横行出于中府，沿着胸上外侧及上肢内侧上缘下行，过肘、腕桡侧，至拇指内侧端的少商穴。腕后的支脉，从列缺走向食指内侧端和手阳明经相接。中焦的支脉，向下联络大肠，上行归属肺脏（图13）。

生理功能：肺位于胸中，上连气道，和大肠互为表里，外合皮毛，开窍于鼻。主行气调节呼吸，为气机出入升降之枢纽，“肺朝百脉”，而能煦泽皮毛肌肤，抵御外邪。

病理症候：经络症：伤风自汗，缺盆和肩臂内侧前缘至拇指内侧肺经循行线之肿痛、麻痹、厥冷。

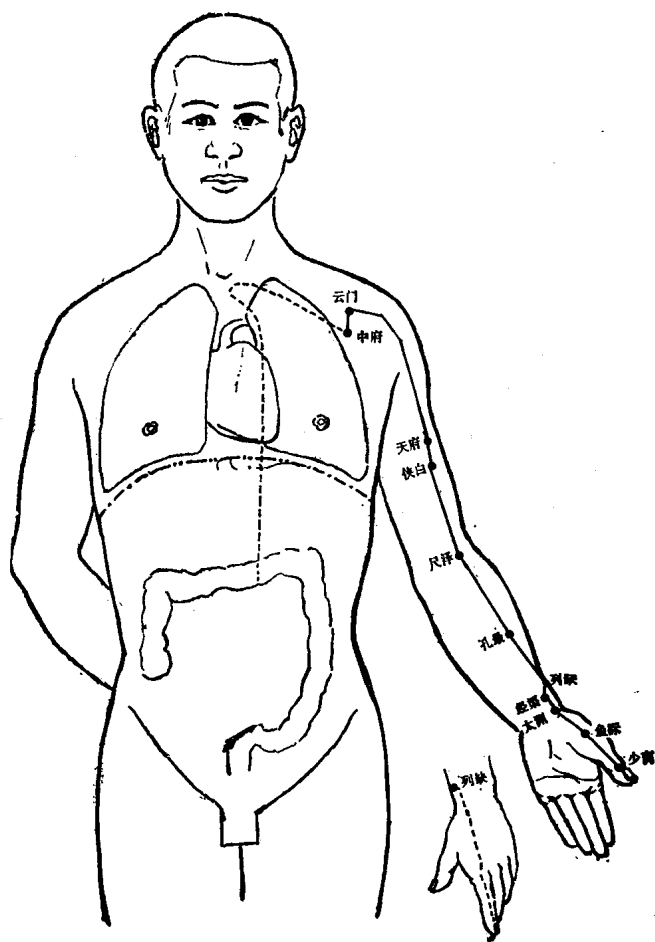


图13 手太阴肺经循行示意图和腧穴

脏腑症：咳嗽哮喘，胸中满闷，咽肿口渴，咳吐脓痰，气郁气短。肺气竭绝，则不能行气布津，温养皮毛，而见指（趾）甲干枯，毫毛脱落。

肺经穴歌：

手太阴肺十一穴，中府云门天府诀；
侠白尺泽孔最存，列缺经渠太渊涉；
鱼际拇指白肉际，少商甲角如韭叶。

中 府

部位：仰卧取穴。在任脉旁六寸，云门下约一寸，第一肋间隙外侧（图13）。

穴释：中，胸中；府，府库。此穴在胸部，为肺气聚集贮藏之府，故名中府。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：调理肺气，养阴清热。

主治：胸痛，烦满，咳嗽，哮喘，腹胀，支气管炎，肺炎，肺结核，肩背酸痛等。

按语：中府系肺之募穴。手太阴肺经和足太阴脾经之会穴。除能治疗本经咳嗽、气喘，胸部胀满，尚可治疗脾经病症，如脾失运化纳差、腹胀。该穴也是肺脏病变出现经络反映的压痛点，近代用来诊断肺结核，有一定参考价值，故亦为治疗肺结核的主穴。配肺俞、百劳、定喘、膻中治疗慢性气管炎。痰盛加丰隆。

云 门

部位：仰卧用手叉腰取穴。在任脉旁六寸，锁骨外下方凹陷中（图13）。

穴释：云，云雾；门，门户。“肺开窍于鼻，五气入鼻，藏于心肺”，再由此穴如云雾样的温润全身，故名云门。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：调理肺气。

主治：胸痛烦满，咳嗽，哮喘，肩臂疼痛、麻木等。

按语：云门与中府仅一肋之隔，虽在治疗肺经病症的作用上略同，但无肺募的特殊性。因其感应能理想的沿本经传到上肢远端，故常作为治疗肩臂疼痛及上肢麻木等症的主穴。配天府、尺泽、列缺治疗臂内前缘的疼痛和麻木。

天 府

部位：垂臂或举臂取穴。在上臂内侧，腋前纹头下三寸筋骨间。垂臂与乳头平齐（图13）。

穴释：天，高上为天，“府”，府库。“天食人以五气”，此穴为肺气聚会与输布之处，故名天府。

针灸：直刺5～8分。

功能：调理肺气，清热凉血。

主治：咳嗽，哮喘，吐血，鼻衄，喉肿，精神病，肩臂痛等。

侠 白

部位：垂臂取穴。在天府下一寸筋骨间（图13）。

穴释：侠，同挟；白，肺色白。两臂下垂，此穴挟在肺脏两旁白肉间，故名侠白。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：调理肺气。

主治：胸痛，胸中烦满，咳嗽，气短，心悸，心痛等。

按语：侠白系手太阴肺经之经别，散于胸中。故可治疗胸痛、胸中烦满、心悸、心痛等症。配心俞、膈俞、内关治疗心脏病。

尺 泽

部位：取穴法有三种。

1. 屈肘拱手，在大肠经曲池内一寸横纹端。

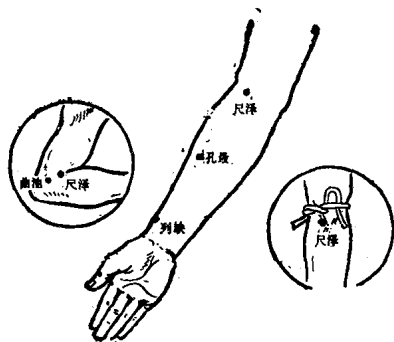


图14 尺泽取穴法

2. 屈肘仰掌，在肘窝横纹中央，大筋（肱二头肌腱）外侧凹陷中。

3. 伸臂使肘窝静脉暴露，用于三棱针放血（图14）。

穴释：尺，从此处至寸口一尺；“泽”湖泽。此穴在屈肘肘横纹似湖的凹陷中，故名尺泽。

针灸：直刺1～1.5寸；灸5～10分钟。

功能：调理肺气，清热和中。

主治：胸胁胀满，咳嗽，哮喘，咯血，鼻衄，咽喉肿痛，腹痛，吐泻，小儿惊风，上肢瘫痪，肘臂挛痛等。

按语：尺泽系肺经之合穴。上述三种不同取穴法，其治疗作用有别。第一种取穴，常配肩髃、列缺、三间治疗上肢瘫痪和肘臂痛。第二种取穴，常配膻中、定喘治疗胸满、哮喘。第三种取穴，属点刺放血，常配少商、合谷治疗咽喉肿痛。配委中治疗急性腹痛，吐泻等。

孔 最

部位：伸肘握拳取穴。在前臂掌面桡侧，太渊上七寸凹陷中，伸肘手虎口向上握拳时凹陷最明显，并且有压痛（图14）。

穴释：孔，孔隙；最，甚大也。掌心向上握拳，此穴在腕上

七寸最大的凹陷处，故名孔最。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：调理肺气，清热利咽。

主治：咳嗽，咯血，咽喉肿痛，身热无汗，肺炎，肘臂冷痛等。

按语：孔最系肺经之郄穴。配肺俞、风门、大椎治疗肺炎、发烧；加配合谷治疗高热、无汗。前人配膈俞、肺俞、曲池等穴医治咯血。日人泽田健氏谓孔最是灸治肛痔的名穴。

列 缺

部位：取穴法有两种。

1. 两手虎口交叉，食指尖端到达的凹陷就是本穴。

2. 手虎口向上，在大肠经阳溪后一寸五分（二横指）凹陷中（图15）。

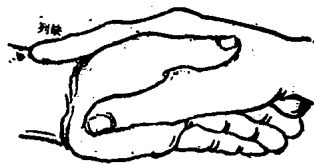


图15 列缺取穴法

穴释：列，排列；缺，缺陷。此穴在腕上寸半，肺经经气运行到此裂缝、缺陷之处，故名列缺。

针灸：向前、后斜刺5~8分；灸5~10分钟。

功能：调理肺气，疏通经络。

主治：咳嗽，哮喘，头痛，颈项强痛，牙痛，咽喉肿痛，口眼歪斜，腕部腱鞘炎，腕痛、无力，上肢瘫痪等。

按语：列缺系肺经之络穴，别走手阳明大肠经。又是八脉交会穴之一，通任脉。历代针灸家对该穴的临床应用，积累了丰富的经验，将它列入四总要穴。该穴除能治疗本经的咳嗽等症外，长于治疗外感引起的偏正头痛、颈项强痛、口眼歪斜等症。配合谷、鱼际、少商治疗咽喉肿痛，气逆咳嗽。配照海治疗肾阴虚损

之咽喉干痛。

经 渠

部位：仰掌避开动脉取穴。在太渊后一寸，桡动脉桡侧凹陷中（图13）。

穴释：经，经气；渠，水沟。肺经经气象水在此穴处流注，故名经渠。

针灸：直刺2～5分。

功能：调理肺气。

主治：咳嗽，哮喘，咽喉肿痛，腕痛、无力等。

按语：经渠系肺经之经穴。配合谷、少商治疗咽喉肿痛。

太 渊

部位：仰掌避开动脉取穴。在手腕掌面桡侧横纹上，桡动脉桡侧凹陷中（见图13）。

穴释：太，大之甚；渊，深潭。肺经经气运行、聚集到此穴，为凹陷最深之处，故名太渊。

针灸：直刺2～5分；灸1～3分钟。

功能：调理肺气，止咳化痰。

主治：胸满，咳嗽，哮喘，肺癆咳血，无脉症等。

按语：太渊系肺经之俞穴，原穴，又是八会穴中之脉会。常用于治疗哮喘、无脉症等。配内关、神门治疗胸痛、心痛、心悸。

鱼 际

部位：仰掌取穴。在拇指掌指关节后内侧，太渊前一寸赤白肉际凹陷中（图13）。

穴释：鱼，鱼际肌；际，边际。此穴在拇指本节后赤白肉

际，故名鱼际。

针灸：直刺5～8分，灸3～5分钟。

功能：调理肺气，清热利咽。

主治：咳嗽吐血，身热，头痛，咽喉肿痛，肺炎，乳房肿痛，肘痛，指挛等。

按语：鱼际系肺经之荥穴，多用于外感风寒引起的头痛、身热、咳嗽等症。配少泽、乳根、足三里治疗乳房肿痛。配少商、肺俞、中府治疗肺炎。

少 商

部位：伸指取穴。在拇指内侧（桡侧）指甲角外约一分（图13）。

穴释：少，幼小为少；商，肺属金，在五音为商。此穴为肺经脉气初出之井，故名少商。

针灸：斜刺1～2分或点刺出血。

功能：清肺利咽，清热醒神。

主治：中风，中暑，昏迷，休克，癰病，癫狂，伤风，发热，咽喉肿痛，鼻衄，腮肿，乳蛾，手指挛痛等。

按语：少商系肺经之井穴。是治疗中风、晕厥、昏迷、休克的重要急救穴之一。因有清肺利咽的功能，用点刺出血的方法配十宣、翳风治疗乳蛾、发热、咽肿、喉闭等症，加配人中治疗中暑昏迷。

第二节 手阳明大肠经

本经起于商阳终于迎香，左右共40穴。取商阳、二间、三间、合谷、阳溪、曲池为井、荥、俞、原、经、合。本穴商阳，络穴偏历，俞穴大肠俞，募穴天枢，郄穴温溜。

循行概述：起于商阳，沿着食指内侧及上肢外侧上缘上行，过腕、肘、肩端、曲颊、口角至鼻孔旁边迎香和足阳明经相接。肩部的支脉，从巨骨交会督脉大椎。过颊部的支脉，入下齿，绕口环唇交会人中。肩部缺盆的支脉，入里联络肺脏，向下归属大肠（图16）。

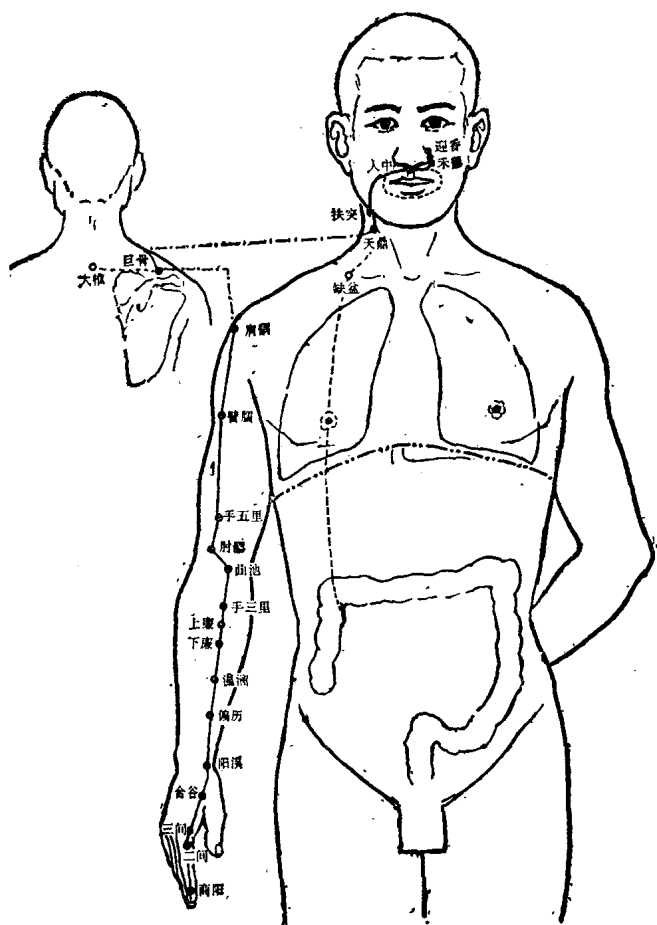


图16 手阳明大肠经循行示意图和腧穴

生理功能：大肠包括回肠和广肠。大肠上接阑门，下接直肠和肛门。和肺互为表里。大肠司传送、排泄糟粕。

病理症候：经络症：牙痛颈肿，口干喉痹，咽梗不通，鼻塞流涕，鼻衄，目黄，肩臂上缘至食指等大肠经循行线之肿痛、麻痹、厥冷。

脏腑症：腹痛、肠鸣、便秘、泄泻、下血、脱肛。大肠气竭绝，则泄利无度。

大肠经穴歌：

二十大肠起商阳，二间三间合谷藏；
阳溪偏历温溜济，下廉上廉三里长；
曲池肘髎五里近，臂臑肩髃巨骨当；
天鼎扶突禾髎接，鼻旁五分号迎香。

商 阳

部位：伸指取穴。在食指内侧（桡侧）指甲角外约一分（图16）。

穴释：商，大肠属金，在五音为商；阳，阳经。此穴在手阳明大肠经，故名商阳。

针灸：斜刺1～2分或点刺出血；灸3～5分钟。

功能：清热醒神，疏泻阳明。

主治：中风，昏迷，耳鸣，耳聋，目赤，咽喉肿痛，齿痛，腮肿，热病汗不出，腹痛吐泻，乳蛾等。

按语：商阳系大肠经之井穴。有泻阳明热的作用。配少商、合谷、翳风治疗乳蛾、疟腮。配大椎、合谷、风门治发热汗不出。配人中、百会、内关治疗中风、昏迷、休克，有清热醒神作用。

二 间

部位：握拳取穴。在食指内侧（桡侧）第二掌指关节前横纹头赤白分肉间凹陷中（图16）。

穴释：二，二数；间，间隔。此穴在食指内侧第二骨节后，故名二间。

针灸：斜刺1～3分；灸5～10分钟。

功能：清阳明热。

主治：鼻衄，口眼歪斜，咽喉肿痛，腮肿，食积等。

按语：二间系大肠经之荣穴。配少商、合谷治疗咽喉肿痛，加配天府、膈俞治疗鼻出血。

三 间

部位：屈指或握拳取穴。在食指内侧（桡侧）第二掌指关节后，赤白分肉间凹陷中（图16）。

穴释：三，三数；间，间隔。此穴在食指内侧第三骨节后，故名三间。

针灸：直刺0.5～1.5寸；灸3～5分钟。

功能：清热止痛，疏经利节。

主治：咽喉肿痛，梗塞，肠鸣，下泻，牙痛，齿齦肿痛，手背红肿，手指拘挛，上肢瘫痪等。

按语：三间系大肠经之俞穴。与二间仅一节之隔，但二间穴长于治疗鼻衄，三间则长于本经的肠鸣亢进，急性下泄。此外尚有疏筋利节作用，对于手指拘急，握拳不开，用此穴深刺透后溪，常获显效。配天枢、气海、会阳、长强治疗洞泻。

合 谷

部位：取穴法有三种。

1. 拇食二指并拢，在拇食二指之间虎口纹头上。针沿食指侧直刺。

2. 拇食二指张开，在虎口上赤白肉际凹陷中。针向两掌骨间近端斜刺。

3. 握拳在第二掌指关节与第一掌骨腕端连线中点，直刺透劳宫（图17）。

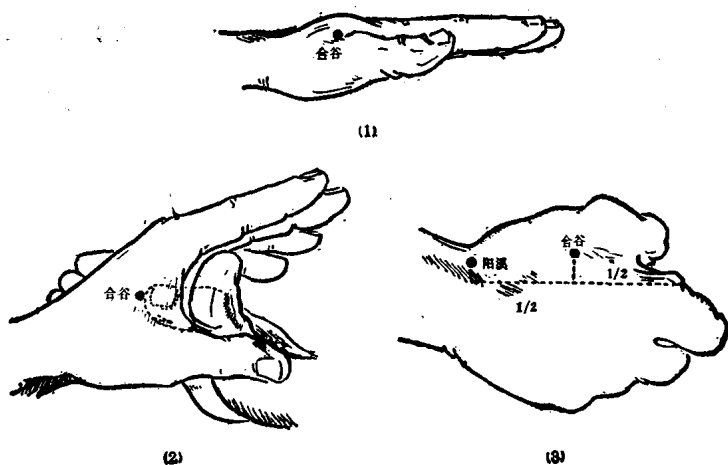


图17 合谷取穴法

穴释：合，开合；谷，山谷空洞也。此穴在拇食二指歧骨间似谷的凹陷处，故名合谷。

针灸：直刺0.5~1.5寸；灸5~20分钟。

功能：清泻阳明，疏风镇痛，通经开窍。

主治：头痛，面肿，目赤生翳，聋哑，鼻衄，鼻塞，牙痛，口噤不开，口眼歪斜，咽喉肿痛，疔腮，中风，瘫痪，荨麻疹，丹毒，瘰病，精神病，癫痫，吐泻，消渴，惊风，热病汗不出，三叉神经痛，扁桃体炎，臂痛，手挛，上肢麻痹，鹅掌风，滞产、难产，胎衣不下，闭经等。孕妇禁针灸。

按语：合谷系大肠经之原穴。是极为常用的名穴之一。有较好的解表退热和通经镇痛作用。治疗相当广泛，但由于取穴和刺法不同，其适应症亦随之有别。上述第一种针法，属于常规用穴法，正如《四总穴歌》中“面口合谷收”之句，为后世治疗头面部疾病的依据。配风池治疗发热汗不出。配下关治疗上牙痛。配太冲古称“四关穴”，有开窍醒神之功，故可治疗手足抽搐、小儿惊风、中风昏迷、口噤不开等。第二种针法，是笔者治疗狂躁型精神病的经验用穴法。进针后施以赤凤摇头手法，可立即使患者出现抑制状态，起到较理想的镇静作用。第三种针法常用于治疗鹅掌风。

阳 溪

部位：手虎口向上取穴。在手腕上侧腕横纹两筋间凹陷中。翘起拇指凹陷更明显（图18）。

穴释：阳，阳经；溪，水沟。此穴在手阳明经，腕部两筋间似溪的凹陷处，故名阳溪。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：清泻阳明，疏筋利节。

主治：头痛，耳鸣，耳聋，目痛生翳，咽喉肿痛，食道痉挛，腕部腱鞘炎，臂痛，腕痛、无力等。

按语：阳溪系大肠经之经穴。配合谷、阳池、外关对手指拘挛和腕痛疗效迅速。配三间、天突、间使治疗食道痉挛和咽喉气梗。

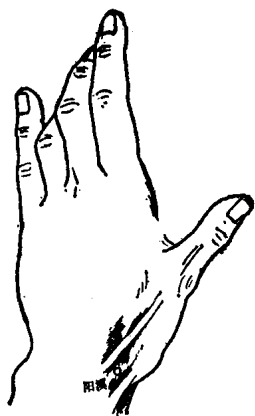


图18 阳溪穴

偏 历

部位：手虎口向上取穴。在阳溪后三寸桡骨外侧凹陷中（图

16)。

穴释：偏，偏侧；历，经历。手阳明经经历手臂至此偏侧，别走太阴，故名偏历。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：疏经活络。

主治：耳鸣，牙痛，口眼歪斜，腕部腱鞘炎，上肢痠痛，瘫痪等。

按语：偏历系大肠经之络穴，别走手太阴肺经。有疏经活络的功能，可用于两经产生的腕、臂、肘、肩疼痛及麻木不仁等。

配阳溪、列缺治疗腕部腱鞘炎。

温 溜

部位：屈肘手虎口向上取穴。在阳溪（上六寸）与曲池之间，桡骨外侧凹陷中（图16）。

穴释：温，温暖；溜，流注。手阳明经之阳气流注至此，能温经散寒，故名温溜。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：清泻阳明，疏经活络。

主治：头痛，面肿，癫狂症，扁桃体炎，上肢痠痛、瘫痪等。

按语：温溜系大肠经之郄穴。多用于治疗腹痛、肠潴等大肠之急性病。又有疏风通络、清上焦热的作用，用于癫狂、语无伦次等症。配合谷、少商、颊车治疗急性扁桃体炎。

下 廉

部位：屈肘手虎口向上取穴。在曲池下四寸肌肉之间（图16）。

穴释：下，下端；廉，边缘，又与棱通。手阳明经循行于上

肢外侧前缘，此穴在曲池下四寸，肌肉棱起的下端，故名下廉。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：疏经活络。

主治：消化不良，腹痛，上肢痠痛、麻痹、瘫痪等。

上 廉

部位：屈肘手虎口向上取穴。在曲池下三寸筋肉之间（图16）。

穴释：上，上端；廉，边缘，又与棱通。此穴在曲池下三寸，肌肉棱起的上端，故名上廉。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：疏经活络。

主治：胸满，腹痛，腹胀，半身不遂，上肢痠痛、瘫痪等。

手 三 里

部位：屈肘拱手，手虎口向上取穴。在曲池下二寸筋肉之间（图16）。

穴释：手与臂通；里，里程也，一里为一寸。此穴在肘髁下三寸，故名手三里。

针灸：直刺1～1.5寸；灸5～10分钟。

功能：清泻阳明、疏风活络。

主治：牙痛，颌痛，炸腮，胃痛，腹痛，腹泻，高血压，上肢麻痹、痠痛、瘫痪等。

按语：手三里长于经络病的治疗，因为它的针刺感应相当强烈，胜于曲池，是治疗小儿麻痹、瘫痪或肌肉萎缩、知觉迟钝的首选穴。配臂臑作“穴位埋线”，治疗上肢麻痹和肌肉萎缩等。近代已将其作为治疗高血压、淋巴结核等病的常用穴。

曲 池

部位：屈肘拱手、手虎口向上取穴。在肘窝横纹头（桡侧）筋骨间凹陷中（图16）。

穴释：曲，曲角；池，水池。曲肘，此穴在肘骨内缘曲角似池的凹陷处，故名曲池。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：调理肠胃，行气活血，疏筋利节。

主治：瘰癧，喉痹，咳嗽，哮喘，腹痛，吐泻，便秘，肠痛，水肿，湿疹，荨麻疹，皮肤搔痒症，丹毒，高血压，月经不调，上肢肿痛、麻痹、瘫痪等。

按语：曲池系大肠经之合穴。有疏风清热、行气和血、利节通络的功效。它不但是上肢筋缓臂细或拘急挛痛、半身不遂等经络症的常用穴，还对本腑的上吐下泻、大便秘结、痢疾、肠痛等病症及肺经的咳嗽、哮喘、咽痛、喉痹也有一定的疗效。常用曲池透臂臑治疗淋巴结核。配合谷、风市、血海、足三里、三阴交治疗湿疹和皮肤搔痒。

肘 髻

部位：屈肘取穴。在曲池外上方一寸，肱骨边缘凹陷中（图16）。

穴释：肘，肘骨；髻同窞，骨之空隙。此穴在曲池上，肘大骨外缘凹陷中，故名肘髻。

针灸：直刺5~8分；灸5~10分钟。

功能：疏筋利节。

主治：臂肘痠痛、麻痹、痉挛，上肢瘫痪等。

五里（手五里）

部位：屈肘取穴。在曲池上三寸，筋骨间凹陷中（图16）。

穴释：五，五数；里，里程。一里为一寸，此穴在天府下五寸，故名五里。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：行气散瘀。

主治：瘰癧，瘰气，咳嗽，吐血，肘臂痠痛等。

臂 臑

部位：垂臂屈肘取穴。在曲池上七寸，三角肌下端凹陷中（图16）。

穴释：臂同膊、膀；臑，肩膊下脰肉。此穴在肩膊下脰肉端。故名臂臑。

针灸：直刺1～1.5寸；灸5～10分钟。

功能：疏经散风。

主治：颈项强痛，瘰癧，瘰气，癰疽，上肢瘫痪，肩臂痛等。

按语：臂臑系手阳明大肠经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经和阳维脉之会穴。有疏风、散寒通络的作用，治疗外感风寒所致的头项强痛。又可治疗肩背痛和胸痛。对瘫痪、小儿麻痹、肌肉萎缩的病人，疗效胜于肩髃。配合谷、臑中埋线治疗癰疽。

肩 髃

部位：正坐将胳膊举与肩平取穴。在肩头前面正中凹陷中（图16）。

穴释：肩，肩骨；髃，髃骨。举臂此穴在肩前两骨间凹陷中，故名肩髃。

针灸：向腋窝直刺1~2寸；灸5~10分钟。

功能：理气化痰，疏筋利节。

主治：颈项强痛，瘰癧，瘰气，麻痹，半身不遂，瘫痪，肩关节周围炎，肩臂痠痛，手臂拘急等。

按语：肩髃系手阳明大肠经和阳跷脉之会穴。能治疗本经病症和上肢挛痛及瘫痪。配肩髃、臑会、条口治疗肩关节周围炎。配曲池、外关、合谷、环跳、阳陵泉、悬钟治疗偏瘫。

巨 骨

部位：正坐垂肩取穴。在肩头之上，锁骨肩峰与肩胛岗之间的凹陷中（图16）。

穴释：巨，形似巨字；骨，锁骨，谓之巨骨。此穴在肩上两叉骨间，似“巨”字形的凹陷中，故名巨骨。

针灸：直刺5~8分；灸5~10分钟。

功能：宽胸理气，疏经利节。

主治：胸中满闷，瘰癧，瘰气，半身不遂，屈伸困难，颈项强痛，肩臂痠痛等。

按语：巨骨系手阳明大肠经和阳跷脉之会穴。配风池、悬钟治疗颈项强痛。

天 鼎

部位：正坐直颈取穴。在颈侧部扶突下一寸，胸锁乳突肌后缘（图16）。

穴释：天，头颈在上为天；鼎，三足两耳煮茶、焚香之古鼎。此穴在颈旁似鼎状的三条肌腱顶部，故名天鼎。

针灸：向前斜刺0.5~1寸；灸3~5分钟。

功能：理气化痰，清利咽膈。

主治：咽喉肿痛，气梗，瘰癧，瘰气，胸、背胀痛等。

扶 突

部位：：正坐直颈取穴。在颈侧部结喉旁三寸，胸锁乳突肌后缘（见图1）。

穴释：扶，辅四指曰扶，为三寸；突，突起。此穴在结喉突起旁三寸肌肉隆起处，故名扶突。

针灸：向前或向后斜刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：理气化痰，清利咽膈。

主治：咳嗽，哮喘，咽喉肿痛，瘰癧，瘰气等。

禾 髃

部位：正坐或仰卧取穴。在鼻翼直下，督脉人中旁五分（图16）。

穴释：禾，五谷也；髃同窞，骨之空隙。此穴在鼻翼下凹陷中，可嗅到五谷气味之处，故名禾髃。

针灸：直刺2～3分。

功能：散风清热。

主治：鼻塞，流涕，鼻衄，嗅觉不灵，昏厥，口噤不开，口眼歪斜等。

迎 香

部位：正坐或仰卧取穴。在鼻唇沟上端，鼻侧凹陷中（图16）。

穴释：迎，迎接；香，芳香。此穴在鼻唇沟中，能迎、嗅芳香气味之处，故名迎香。

针灸：直刺或向鼻孔斜刺2～5分。

功能：清热散风，通利鼻窍。

主治：面痒，面痛，浮肿，口眼歪斜，鼻塞，鼻衄，嗅觉失

灵，鼻炎等。

按语：迎香系手阳明大肠经和足阳明胃经之会穴。顾名思义其穴为治疗鼻病的主穴。有散面风，清肺热的作用，治鼻塞、鼻衄、面部肿痛、搔痒、麻木及蚁走感。配上星、攒竹、上迎香、合谷治疗急、慢性鼻炎和嗅觉失灵。

第三节 足阳明胃经

本经起于承泣终于厉兑，左右共90穴。取厉兑、内庭、陷谷、冲阳、解溪、足三里为井、荣、俞、原、经、合。本穴足三里，络穴丰隆，郄穴梁丘，俞穴胃俞，募穴中脘。

循行概述：起于承泣，沿着口角绕口唇、耳前，从下颌、咽喉、缺盆、乳线、脐旁及下肢外侧前缘下行，过膝、胫前面、足跗至二趾外侧端厉兑。胫部的支脉，从丰隆至中趾外侧。足跗部的支脉，从冲阳至大趾内侧端和足太阴经相接。缺盆的支脉，入里下行归属胃腑，联络脾脏（图19）。

生理功能：胃在膈下，上接食道，下通小肠，胃上口为贲门，又名上脘，下口为幽门又名下脘，统称胃脘。和脾互为表里，胃主受纳腐熟，消化水谷，司升清降浊，为后天之本，化气生血之源泉。

病理症候：经络症：身热阵寒，高热谵语，口唇生疮，牙痛喉肿，口喎眼斜，鼻痛流血，鼻塞流涕和胸、腹、股、膝、胫至次趾等胃经循行线之肿痛、麻痹、厥冷。

脏腑症：胃脘胀痛，消谷善饥，呕吐吞酸，水肿，肠鸣，腹部膨胀，食难消化。胃气竭绝，则不能纳谷。

胃经穴歌：

四十五穴足阳明，承泣四白巨髎经。

头维下关颊车穴，地仓大迎对人迎。

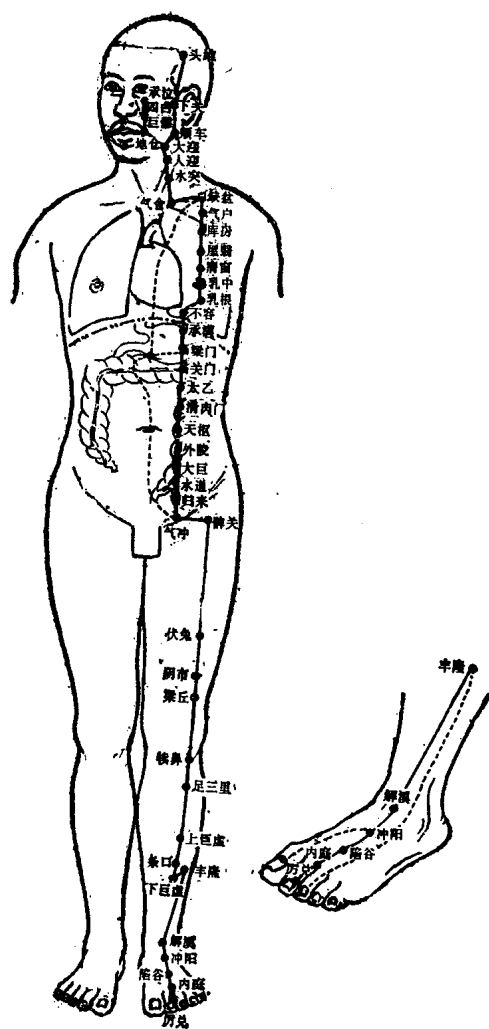


图19 足阳明胃经循行示意图和腧穴

水突气舍连缺盆，气户库房屋翳屯。
膺窗乳中接乳根，不容承满与梁门。
关门太乙滑肉门，天枢外陵大巨存。
水道归来气冲次，髀关伏兔走阴市。
梁丘犊鼻足三里，上巨虚连条口行。
下巨虚跳上丰隆，解溪冲阳陷谷中。
内庭穴在二趾缝，次趾甲角厉兑停。

承 泣

部位：正坐或仰卧取穴。在瞳孔下七分，下眼眶上缘凹陷中（图19）。

穴释：承，承受，泣，泪下曰泣。此穴在下眼眶上缘陷中，能承受眼泪之处，故名承泣。

针灸：直刺2～3分或沿皮刺透睛明。

功能：清头明目，疏风活络。

主治：目赤肿痛，青盲，近视，口眼歪斜，视神经萎缩，泪囊炎等。

按语：承泣系足阳明胃经、阳跷脉和任脉之会穴。是治眼病的主穴。透睛明治疗近视眼，加配合谷、风池治疗泪囊炎。

四 白

部位：正坐或仰卧取穴。在瞳孔下一寸，眶下孔凹陷中（图19）。

穴释：四，四方；白，光明洁白。此穴在目下，针后使眼睛明亮，观看四方万物，故名四白。

针灸：直刺2～3分或沿皮刺透睛明。

功能：清头明目，疏风活络。

主治：头痛，眩晕，目痛，目赤生翳，夜盲，青盲，近视，

口眼歪斜，三叉神经痛，鼻炎等。

巨 髎

部位：正坐或仰面取穴。在瞳孔直下，平齐人中穴的凹陷中（图19）。

穴释：巨，大也；髎，通窳，骨之空隙。此穴在颧骨下，空隙最大之处，故名巨髎。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：清热散风，疏经镇痛。

主治：目痛，鼻塞，唇颊肿痛，牙痛，面神经麻痹，三叉神经痛等。

按语：巨髎系足阳明胃经、手阳明大肠经和阳跷脉之会穴。是治疗牙痛和颜面神经麻痹的主穴。配下关、合谷治疗上牙痛。

地 仓

部位：正坐或仰卧取穴。在口角外边，直对瞳孔（图19）。

穴释：地，口为地，“地食人以五味”；仓，仓廩。此穴在口角旁，闭口凹陷似仓之处，故名地仓。

针灸：直刺2～3分或横刺透颊车；灸5～10分钟。

功能：清热散风，疏经镇痛。

主治：面肿，口眼歪斜，口疮流涎，失音不语，惊风等。

按语：地仓系足阳明胃经、手阳明大肠经和阳跷脉之会穴。《玉龙歌》、《杂病穴法歌》等许多古著皆有“地仓连颊车治疗口眼歪斜”之句。近代也常以此穴透颊车，治疗颜面神经麻痹和痉挛。

大 迎（瞳孔）

部位：仰卧取穴。在下颌角前一寸三分，下颌底上方，咬肌

前缘凹陷中（图19）。

穴释：大，先后天之大气；迎，迎接。此穴在口角旁骨隙中动脉处，能迎接谷气，输转气血，故名大迎。

针灸：直刺2～5分；灸3～5分钟。

功能：清头散风，通利牙关。

主治：面肿，口眼歪斜，口噤不开，牙痛，颊肿等。

颊 车

部位：正坐或仰卧闭口取穴。在下颌角前上方约一横指凹陷中。牙齿咬紧时凹陷处有一块肌肉凸起来（图19）。

穴释：颊，曲颊；车，牙车。此穴在颊部，张口合口活动如车轮之转动处，故名颊车。

针灸：直刺3～5分或横刺透地仓；灸5～10分钟。

功能：祛风清热，通利牙关，疏经止痛。

主治：牙关紧闭，口眼歪斜，疟腮，中风，舌强不语，牙痛，颊肿，下颌关节炎，失音，口疮流涎，惊风，三叉神经痛，扁桃体炎等。

按语：颊车具有祛风活络的作用。配承浆、合谷治疗下牙痛和口眼歪斜。加配人中治疗小儿惊风、口噤不开。

下 关

部位：正坐闭口取穴。在耳屏（小耳朵）前约二横指，颧骨弓下凹陷中。张嘴时凹陷就会凸起来（图19）。

释穴：下，下方；关，机关。此穴在颧骨弓下，张口合口如机关样的上下活动，故名下关。

针灸：直刺0.5～1.5寸。

功能：清热止痛，通利牙关，疏风开窍。

主治：牙痛，颞肿，习惯性颞下颌关节脱臼，口眼歪斜，耳鸣，耳聋，耳痛，口噤不开，下颌关节炎，三叉神经痛等。

按语：下关系足阳明胃经和足少阳胆经之会穴。功同颊车，唯治耳疾及下颌关节病胜于颊车。配合谷治疗上牙痛和三叉神经痛。配听宫治疗耳聋。

头 维

部位：正坐咬牙取穴。在额角头发边，入发际五分肌缝中。咬牙时穴位处有一块肌肉凸起来（图19）。

穴释：头，头部；维，四角为维。此穴在头部额角入发际之处，故名头维。

针灸：向耳朵斜刺0.5～1寸或横刺透率谷。

功能：祛风止痛，清头明目。

主治：偏正头痛，眩晕，口眼歪斜，面肿，目痛，眼跳，视物不清等。

按语：头维系足阳明胃经、足少阳胆经和阳维脉之会穴。是治疗偏正头痛的主穴。对颜面神经麻痹所见的前额无纹、上眼睑无力疗效显著。配百会、风池、太阳、合谷治疗头痛。配阳白治疗面神经麻痹所见的前额无纹和眼睑无力。

人 迎

部位：直颈避开动脉取穴。在结喉旁一寸五分，胸锁乳突肌前缘（图19）。

穴释：人，有生命的人；迎，迎接。此穴在结喉旁，能迎接呼吸来的氧气、饮食来的五谷，维持人之生命，故名人迎。颈动脉，古称人迎脉。

针灸：直刺2～5分或横刺透扶突。

功能：清肺利咽，理气化痰。

主治：胸满，咳嗽，哮喘，咽喉肿痛，瘰疬，瘕气，高血压等。

按语：人迎系足阳明胃经和足少阳胆经之会穴。配曲池、内关、阳陵泉、足三里治疗高血压。

水 突

部位：直颈避开血管取穴。人迎与气舍穴之间，胸锁乳突肌前缘（图19）。

穴释：水，水谷；突，突起。此穴在咽喉旁，水谷下咽时，该突起上下活动，故名水突。

针灸：直刺2～4分或向外横刺1～1.5寸。

功能：清肺利咽，理气化痰。

主治：咳嗽，哮喘，气短，咽喉肿痛，甲状腺肿等。

气 舍

部位：直颈避开血管取穴。在任脉天突旁一寸五分，锁骨上窝凹陷中（图19）。

穴释：气，肺气；舍，居室。此穴在肺上部，是呼吸之气入舍之处，故名气舍。

针灸：直刺或向后背横刺3～5分。

功能：清肺利咽，理气化痰。

主治：咳嗽，哮喘，呃逆，咽喉肿痛，颈项强痛，瘰癧，瘰气等。

缺 盆

部位：正坐取穴。在任脉天突旁四寸，乳头直上，锁骨上窝凹陷中（图19）。

穴释：缺，残缺凹陷；盆，无盖之盆。此穴在锁骨上窝盆状凹陷处，故名缺盆。

针灸：向后背横刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清肺利咽，理气化痰。

主治：胸满，咳嗽，哮喘，咽喉肿痛，瘰癧，瘰气，颈肿，缺盆中肿痛等。

气 户

部位：仰卧取穴。在任脉旁四寸，乳头直上，锁骨下缘凹陷中（图19）。

穴释：气，肺气；户，门户。此穴在肺尖部，是呼吸之气出入的门户，故名气户。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸理气，疏经止痛。

主治：咳嗽，哮喘，呃逆，胸胁支满，胸背痛等。

库 房

部位：仰卧取穴。在任脉旁四寸，乳头直上，第一肋间隙中（图19）。

穴释：库，仓库；房，房屋。此穴在胸部，似库房样的贮藏肺气，故名库房。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：理肺化痰。

主治：胸胁胀痛，咳吐浊痰等。

屋 翳

部位：仰卧取穴。在任脉旁四寸，乳头直上，第二肋间隙中（图19）。

穴释：屋，房舍；翳，雉尾扇，蔽也。此穴在胸部，似屋舍羽扇遮盖保护心肺，故名屋翳。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宣肺理气，安神定志，活络通乳。

主治：胸满，肋痛，咳嗽，哮喘，心动过速，心律不齐，乳肿，乳少等。

按语：屋翳为胸部常用穴之一，配膻中、内关治疗心动过速或心律不齐。配大椎、肺俞、膻中、尺泽治疗咳嗽。

膺 窗

部位：仰卧取穴。在任脉旁四寸，乳头直上，第三肋间隙中（图19）。

穴释：膺，胸膺；窗，窗牖通孔。此穴在乳上是肺气出入之处，故名膺窗。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宣肺理气，安神定志，活络通乳。

主治：胸满，肋痛，咳逆，哮喘，心区痛，心动过速，心律不齐，乳痛，乳少等。

按语：膺窗是治疗乳房肿痛的主穴，有清热消肿的作用。配乳根、膻中、少泽治疗乳腺炎，发烧加配大椎、合谷。配膻中、内关治疗心动过速、心律不齐和心区痛。

乳 中

部位：在乳头中央，仅为取穴之标志（图19）。禁忌针灸。

穴释：乳，乳头；中，正中。此穴在乳头正中，故名乳中。

乳 根

部位：仰卧取穴。在任脉旁四寸，乳头直下，第五肋间隙中（图19）。

穴释：乳，乳房；根，根本、基底也。此穴在乳房下缘根底部，故名乳根。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宣肺理气，活络通乳。

主治：胸满，肋痛，咳嗽，哮喘，呃逆，心区痛，乳痛，乳少等。

按语：乳根以其穴所居位置故名，为治疗乳房一些疾患及心区疼痛的主穴。配膻中、内关治疗心前区疼痛。配膻中、少泽治疗乳房肿痛及产后突然乳汁不通或乳汁不足。

不 容

部位：仰卧取穴。在肚脐上六寸，任脉巨阙旁二寸(图19)。

穴释：不，夫不鸟名，小鸠也；容，容纳。此穴在鸠尾旁接近胃府，能容纳盛受水谷，故名不容。

附注：胃经由不容至滑肉门的横寸，有几种不同的记载：《甲乙经》、《针灸大成》为去任脉三寸，《类经图翼》、《医宗金鉴》为去中行二寸，本书为任脉旁二寸。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃气。

主治：胸满，胁痛，咳嗽，哮喘，吐血，胃痛，呕吐等。

承 满

部位：仰卧取穴。在任脉上脘旁二寸，不容下一寸(图19)。

穴释：承，承受；满，饱满。此穴接近胃腑，能承满饮食，故名承满。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃气。

主治：胃痛，腹胀，胁下肿痛，饮食不下，胃溃疡等。

梁 门

部位：仰卧取穴。在任脉中脘旁二寸，承满下一寸(图19)。

穴释：梁同粱，谷也；门，门户。此穴在胃脘部，是谷气出入之门，故名梁门。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃气。

主治：胃痛，腹胀，食欲不振，肠鸣，泄泻，完谷不化，胃炎，胃和十二指肠溃疡等。

按语：梁门为治疗胃病的常用主穴。配中脘、足三里、内关、公孙治疗胃痛和胃溃疡。

关 门

部位：仰卧取穴。在任脉建里旁二寸，梁门下一寸(图19)。

穴释：关，机关；门，门户。此穴在胃底部，是纳谷、消谷、胃气出入之门，故名关门。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃肠。

主治：腹痛，泄痢，食欲不振，水肿，腹胀，便秘等。

太 乙

部位：仰卧取穴。在任脉下脘旁二寸，关门下一寸(图19)。

穴释：太，大也；乙，一也，盘曲之象。此穴在盘曲的大小肠之上，故名太乙。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃肠。

主治：胸满，心烦，腹痛，泻痢，食欲不振，胃肠炎等。

滑 肉 门

部位：仰卧取穴。在任脉水分旁二寸，太乙下一寸(图19)。

穴释：滑，光滑；肉，肌肉；门，门户。此穴在腹部滑肉处，是调理胃肠之门，故名滑肉门。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃肠。

主治：胃痛，呕吐，腹痛，腹胀，消化不良等。

天 枢

部位：仰卧取穴。在肚脐中心旁二寸，滑肉门下一寸(图19)。

附注：胃经由天枢至气冲的直寸，有几种不同的记载：《千金翼方》天枢下半寸为外陵，《针灸大全》陵下二寸名大巨，《甲乙经》水道穴在大巨下三寸，归来穴在水道下二寸，本书为一寸一穴。

穴释：天，高上为天；枢，枢纽。《素问至真要大论》说：“身半以上天之分也，天气主之；身半以下地之分也，地气主之。半，所谓天枢也”。此穴在脐旁，居天地二气之间，通于中焦；为水谷之气升清降浊之枢纽，故名天枢。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～20分钟。

功能：调理肠胃，行气活血。

主治：腹痛、胀满，便秘，泄泻，肠鸣，痢疾，水肿，症瘕，消化不良，阑尾炎，急、慢性肠炎，月经不调，痛经等。

按语：天枢系大肠之募穴。是治疗肠道疾病的常用穴之一。配中脘、气海、足三里治疗急、慢性肠炎、腹痛、痢疾和肠麻痹。配外陵、上巨虚治疗阑尾炎。

外 陵

部位：仰卧取穴。在任脉阴交旁二寸，天枢下一寸(图19)。

穴释：外，外侧；陵，丘陵。此穴在脐旁腹肌隆起如丘的外缘，故名外陵。

针灸：直刺0.5~1寸；灸5~20分钟。

功能：理气活血。

主治：腹胀，腹痛，疝气，阑尾炎，月经不调等。

按语：外陵配关元治疗下焦虚寒引起的腹胀，腹痛。配天枢、上巨虚治疗肠痈。

大 巨

部位：仰卧取穴。在任脉石门旁二寸，外陵下一寸(图19)。

穴释：大，高大，大盛；巨，巨大。此穴在脐旁腹肌隆起最高大丰满而有光泽之处，故名大巨。

针灸：直刺0.5~1寸；灸5~20分钟。

功能：理气活血。

主治：肠痈，腹痛，便秘，小便不利，遗精等。

水 道

部位：仰卧取穴。在任脉关元旁二寸，大巨下一寸(图19)。

穴释：水，水液；道，道路。此穴接近膀胱，有通调水道利尿之功能，故名水道。

针灸：直刺0.5~1寸；灸5~20分钟。

功能：通调水道。

主治：小腹胀痛，小便不利，水肿，腹水，疝气，肾炎，膀胱炎，月经不调等。

按语：水道顾名思义能通调水道，有利尿作用。配命门、膀

胱俞、中极、水分、复溜治疗膀胱气化失调、小便不利、乳肿、口渴不欲饮水等。配中极、三阴交治疗尿路感染、尿急、尿频。配中脘、水分、气海、足三里、复溜治疗腹水。

归 来

部位：仰卧取穴。在任脉中极旁二寸，水道下一寸(图19)。

穴释：归，回归；来，还也。此穴在少腹部，有使不归之气血复来之功，故名归来。

针灸：直刺0.5~1寸；灸5~20分钟。

功能：调气活血，培补冲任。

主治：小腹胀痛，遗精，疝气，阴部肿痛，经闭，白带，月经不调等。

按语：归来有温经活血的作用。配关元、三阴交用于寒凝血瘀的经闭和盆腔及外生殖器的疾患，虚症加肾俞、关元俞；实证加气穴、中极。

气 冲（气街）

部位：仰卧避开动脉取穴。在任脉曲骨旁二寸，归来下一寸，耻骨上缘(图19)。

穴释：气，原气、逆气；冲，冲要、冲动。此穴在少腹气街动脉处，是经气通行的重要道路，能治疗疝气、逆气上冲等症，故名气冲。

针灸：直刺0.5~1寸；灸5~10分钟。

功能：行气活血，调肝补肾。

主治：腹痛，疝气，阳萎，阴茎痛，阴部肿痛，月经不调等。

按语：气冲系足阳明胃经和冲脉之会穴。配关元、三阴交治疗月经不调。

髌 关

部位：仰卧屈膝取穴。在大腿根前面，平齐耻骨的横纹中央，两筋间凹陷中（图19）。

穴释：髌，股骨；关，关节。此穴在股骨关节处，下肢运动亦随之活动，故名髌关。

针灸：直刺1～2寸；灸3～5分钟。

功能：疏筋活络。

主治：腿膝肿痛，不得屈伸，下肢麻痹、痿痹等。

伏 兔

部位：仰卧或正坐屈膝取穴。在髌骨（膝盖）外上缘上六寸起肉处（图19）。

穴释：伏，潜伏；兔，动物。此穴在膝上，腿膝伸直绷紧，肌肉隆起，形如兔伏，故名伏兔。

针灸：直刺1～2寸；灸3～5分钟。

功能：疏经活络。

主治：荨麻疹，脚气，腿膝冷痛，下肢麻痹等。

阴 市

部位：仰卧或正坐屈膝取穴。在髌骨（膝盖）外上缘上三寸（图19）。

穴释：阴，阴寒；市，集市。此穴在足阳明经，是寒湿阴气聚集与治疗之处，故名阴市。

针灸：直刺1～1.5寸；灸3～5分钟。

功能：疏经利节。

主治：消渴，腿膝肿痛，下肢麻痹，脚气等。

梁 丘

部位：垂足取穴。在髌骨（膝盖）外上缘上二寸（图19）。

穴释：梁同梁；丘，丘陵。此穴在膝上，腿膝伸直绷紧，肌肉隆起状如梁丘之处，故名梁丘。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：疏肝和胃，通经活络。

主治：胃痛，腹胀，胃酸过多，腿膝肿痛，下肢麻痹等。

按语：梁丘系足阳明胃经之郄穴。与足三里同是治胃病的常用穴，但梁丘擅长治疗胃酸过多，足三里擅长治疗胃酸缺乏。配中脘、内关、公孙治疗胃酸过多和胃溃疡。

犊 鼻

部位：屈膝垂足取穴。在髌骨（膝盖）前外侧凹陷中（图20）。

穴释：犊，小牛；鼻，鼻子。此穴在膝下外膝眼状如牛鼻之处，故名犊鼻。

针灸：向血海斜刺1~1.5寸；灸10~15分钟。

功能：通利关节。

主治：脚气，膝关节肿痛、麻木、屈伸不利等。

按语：犊鼻因于髌骨韧带外侧之深陷中，形似牛犊鼻孔故名。亦称外膝眼。为治疗膝关节疾患的主穴。配鹤顶、梁丘、血海、阴陵泉、阳陵泉、足三里治疗膝关节炎。

足 三 里

部位：屈膝垂足取穴。在犊鼻下三寸，大骨（胫骨脊）外缘凹陷中（图20）。

穴释：足，下肢；里，里程。一里为一寸。此穴在膝下三

寸，故名足三里。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~15分钟。

功能：调理脾胃，疏通经络，镇痉止痛。

主治：胃痛，腹胀，胃酸缺乏，呕吐，泻痢，肠鸣，便秘，消化不良，水肿，神经衰弱，急、慢性胃肠炎，下肢肿痛、麻痹，痹症，瘫痪等。

按语：足三里系胃经之合穴。主治范围很广，为四总要穴之一。是治疗胃肠疾患的常用穴。配中脘治疗急、慢性胃痛，常获显效。配中脘、天枢、气海治疗急、慢性胃肠炎、消化不良等

病。配环跳、阳陵泉、悬钟治疗下肢瘫痪，小儿麻痹后遗症，风湿痹症等。30岁以上的人，常灸此穴，可以保健。

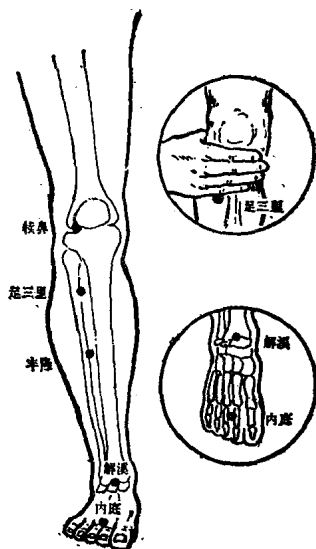


图20 足三里取穴法

上 巨 虚

部位：屈膝垂足取穴。在足三里下三寸，筋骨之间凹陷中（图19）。

穴释：上，上端；巨虚，巨大空虚。屈膝垂足，此穴在胫骨外缘，长条肌肉巨大空隙上方，故名上巨虚。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：调理肠道，疏经活络。

主治：胃痛，腹痛，腹胀，便秘，痢疾，肠痛，消化不良，结肠炎，下肢肿痛、麻痹、瘫痪等。

按语：上巨虚又名上廉，系大肠之下合穴。是治疗肠道疾病的主穴。配天枢治疗结肠炎引起之急性腹痛。配天枢、内关、曲池、公孙治疗痢疾、腹胀、腹痛。

条 口

部位：垂足取穴。在上巨虚下二寸，筋骨之间凹陷中（图19）。

穴释：条，狭长为条；口，缺口。屈膝垂足，此穴在胫骨外缘，长条肌肉如口状的凹陷中间，故名条口。

针灸：直刺1~1.5寸或透承山；灸5~10分钟。

功能：疏经活络。

主治：腹痛，肩关节周围炎，下肢肿痛、麻痹等。

按语：条口常用于小腿部外经病，其远距离治疗的特点是：能缓解肩关节周围的肌肤挛痛。配肩髃、肩髃，天宗治疗肩关节周围炎。

下 巨 虚

部位：垂足取穴。在上巨虚下三寸，筋骨之间凹陷中（图19）。

穴释：下，下端；巨虚，巨大空隙。屈膝垂足，此穴在胫骨外缘，长条肌肉巨大空隙下方，故名下巨虚。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：疏经活络，调理胃肠。

主治：胸胁胀痛，泻痢，急、慢性肠炎，下肢肿痛、瘫痪等。

按语：下巨虚又名下廉，系小肠之下合穴。是治疗下腹部疼痛的主穴。配中脘、关元能增强小肠的分清降浊作用，治疗消化不良的水泻。配天枢治疗急性肠炎。

丰 隆

部位：仰卧或垂足取穴。在外踝尖（上八寸）与膝窝外面横纹之间，大骨（胫骨）外约二横指两筋间隙中（图20）。

穴释：丰，丰满；隆，隆起。此穴在胫骨外侧肌肉丰满隆起之处，故名丰隆。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：祛痰降逆，疏经活络。

主治：头痛，目眩，瘧病，精神病，癲病，咳嗽，哮喘，腹痛，痢疾，便秘，下肢肿痛，中风，瘫痪等。

按语：丰隆系胃经之络穴，别走足太阴脾经。长于降逆祛痰，凡呼吸系统疾患痰多者必加丰隆。配曲池、内关治疗高血压。配膻中治疗癲病。

解 溪

部位：仰卧取穴。在脚腕前面（脚背与小腿交界处）横纹正中，两筋间凹陷处（图20）。

穴释：解，解脱；溪，水沟。此穴在足腕关节两筋间似溪的凹陷中，系，解鞋带处，故名解溪。

针灸：直刺5~8分；灸5~15分钟。

功能：通调肠胃，疏筋利节。

主治：头痛，面肿，腹胀，便秘，踝关节炎，足腕下垂、肿痛，下肢麻痹等。

按语：解溪系胃经之经穴。主要用于踝关节疾患。配丘墟、商丘治疗踝关节痛。

冲 阳

部位：垂足避开动脉取穴。在解溪前一寸，足背动脉凹陷中

(图19)。

穴释：冲，冲动、冲要；“阳”，阳经。此穴在足背高骨动脉处，是胃气运行的重要通道，故名冲阳。

针灸：直刺2~3分；灸3~5分钟。

功能：健脾利湿，疏风通络。

主治：头面浮肿，牙痛，口眼歪斜，水肿，胃痛，腹胀，不思食，精神病，足背肿痛，足麻、无力等。

按语：冲阳系胃经之原穴。配中脘、足三里治疗胃痛。

陷 谷

部位：垂足取穴。在足背内庭后约二横指，第二、三跖趾关节凹陷中(图19)。

穴释：陷，凹陷；谷，山谷、空洞。此穴在第二、三跖趾关节后凹陷处，故名陷谷。

针灸：直刺3~5分；灸5~10分钟。

功能：健脾利湿，疏风通络。

主治：头面浮肿，水肿，腹痛，脚背肿痛，足麻、无力等。

按语：陷谷系胃经之俞穴。配下关、颧髻治疗面部浮肿。

内 庭

部位：仰卧或垂足取穴。在足背，二趾三趾的趾缝纹头后凹陷中(图20)。

穴释：内，里边；庭，庭室。此穴在二、三趾间如内室的凹陷处，故名内庭。

针灸：直刺3~5分；灸5~10分钟。

功能：调理胃肠，祛风活络，清热镇痛。

主治：胃痛，腹胀，痢疾，便秘，肠痛，牙痛，龈肿，口眼歪斜，鼻衄，喉痹，脚背红肿疼痛等。

按语：内庭系胃经之荥穴。配颊车、地仓，下关治疗口眼歪斜。

厉 兑

部位：伸趾取穴。在足二趾外侧趾甲角外约一分（图19）。

穴释：厉，月在戌为厉，胃属戊土；兑，为正西属金。此穴是足阳明经之井属金，故名厉兑。

针灸：斜刺1～2分或点刺出血；灸3～5分钟。

功能：清热利湿，通调肠胃。

主治：胸满，胃痛，腹胀，水肿，便秘，鼻衄，喉肿，尸厥，口噤，晕厥，热病汗不出，黄疸，足痛，趾肿等。

按语：厉兑系胃经之井穴。配合谷、风池治疗热病汗不出。配十宣、人中治疗昏厥。

第四节 足太阴脾经

本经起于隐白终于大包，左右共42穴。取隐白、大都、太白、商丘、阴陵泉为井、荥、俞、经、合。本穴太白，络穴公孙和大包，俞穴脾俞，募穴章门，郄穴地机。

循行概述：起于隐白，沿着大趾内侧赤白肉际及下肢内侧前缘上行，过内踝、胫骨内侧、腹股沟、腹部至胸外侧大包。腹部入胃的支脉，穿过横膈和手少阴经相接。腹部从冲门进入腹腔的支脉，过中极、关元、下脘、期门、横膈，挟咽喉，连舌本，并归属脾脏，联络胃腑（图21）。

生理功能：脾在腹中，和胃互为表里。脾主肌肉，开窍于口，连系舌本。脾司运化，把食物中的精华输布到全身，为生化之源，且有益气统血，营养五脏、六腑、四肢、百骸和肌肉的功能。

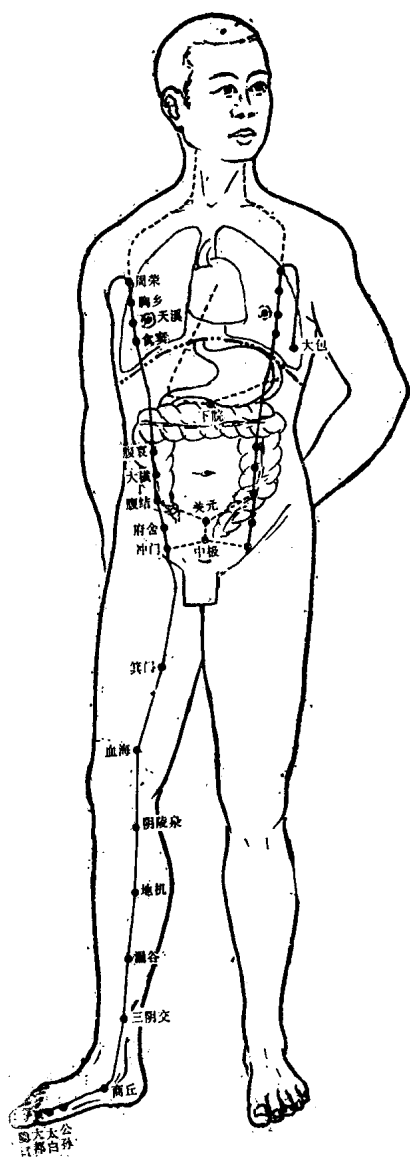


图21 足太阴脾经循行示意图和腧穴

病理症候：经络症：舌根强痛，股、膝内侧至大趾等脾经循行线之肿痛、麻痹、厥冷。

脏腑症：胃痛痞满，腹胀呕吐，消化不良，噎气，便溏，黄疸，痰饮，肢体沉重无力。脾气竭绝，则肌肉得不到脉的营养，而见肌肉松软，舌萎缩，人中部肿满，口唇外翻。

脾经穴歌：

二十一穴脾中州，隐白在足大趾头。
大都太白公孙盛，商丘三阴交可求。
漏谷地机阴陵泉，血海箕门冲门投。
府舍腹结大横排，腹哀食窦天溪候。
胸乡周荣大包上，从足经腹向胸走。

隐 白

部位：伸趾取穴。在足大趾内侧趾甲角外约一分（图21）。

穴释：隐，隐伏；白，白色。此穴在大趾内侧隐伏不见的白肉际，故名隐白。

针灸：斜刺2～3分或点刺出血；灸3～5分钟。

功能：开窍醒神，益气统血。

主治：昏厥，癫狂，呕吐，腹胀，食不下，泄泻，小儿抽搐，鼻衄，崩漏，带下，月经不调等。

按语：隐白系脾经之井穴。脾为统血之脏，脾失健运，统摄无权，则血不归经，经水过期不止，甚或崩漏，常以隐白为主穴。配关元治疗经漏，加配行间治疗血崩。配人中治疗失血之昏迷。近代配关元、血海、三阴交为主穴治疗功能性子宫出血。

大 都

部位：仰卧或盘膝取穴。在足大趾内侧，第一跖趾关节前横纹头陷中（图22）。

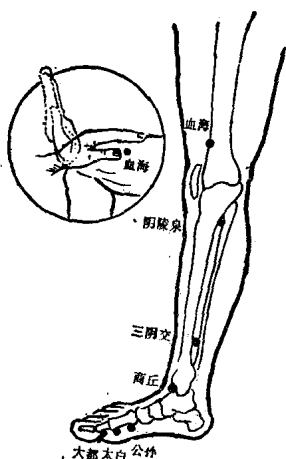


图22 大都、血海取穴法

风。《甲乙经》说：“热病汗不出且厥……大都主之。”可见该穴有清泄里热、疏散表邪、畅达气机、镇惊熄风的作用。配人中、合谷治疗小儿惊风。

穴释：大，高大；都，城邑、丰满。此穴在大趾内侧本节前白肉丰满处，故名大都。

针灸：向下斜刺1～3分；灸2～5分钟。

功能：健脾利湿，镇惊熄风。

主治：热病汗不出，胃痛，腹胀，呕吐，暴泻，小儿惊风，足痛，厥冷，足趾肿痛等。

按语：大都系脾经之荣穴。常用于热病表实无汗，胃肠实热，疼痛拒按，热邪内闭，四肢厥逆及小儿惊

太 白

部位：仰卧或盘膝取穴。在足内侧，第一跖趾关节后，骨下凹陷中（图22）。

穴释：太，大之甚；白，白色。此穴在高大的第一跖骨小头后白肉际，故名太白。

针灸：直刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：健脾利湿，通调肠胃。

主治：胃痛，胸满，腹胀，肠鸣，腹痛，呕吐，泻痢，便秘，消化不良，肢体沉重，脚气等。

按语：太白系脾经之俞穴，又是原穴。有清热化湿的作用，可治疗时病所致之身热烦满、吐利、腹痛等胃肠疾患。配内关、足三里、大椎、天枢、合谷治疗发热身重、腹痛胀满、上吐下泻。

公 孙

部位：仰卧或垂足取穴。在足内侧，第一跖趾关节后一寸骨下凹陷中（图22）。

穴释：公，正经为公；孙，旁支为孙。此穴是足太阴沟通足阳明经之络，故名公孙。

针灸：直刺0.5～1寸，灸5～10分钟。

功能：健脾利湿，通调肠胃。

主治：胃痛，腹胀，呕吐，泻痢，痞积，消化不良，热病，黄疸，疟疾，水肿，癰病，癰痛，足痛无力等。

按语：公孙系脾经之络穴，别走足阳明胃经。也是八脉交会穴之一，通冲脉。有理气宽膈、降痰除烦之功。配内关治疗太息胸闷、心烦喜呕、胃痛吐酸、疟疾等。

商 丘

部位：垂足取穴。在内踝前下方凹陷中（图22）。

穴释：商，在五行为金；丘，丘陵。此穴在似丘陵的内踝前，为脾经之经属金，故名商丘。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：健脾利湿。

主治：呃逆，呕吐，肠鸣，腹胀，消化不良，痢疾，泻泄，便秘，舌强、肿痛，足踝关节红肿、痠痛、麻痹等。

按语：商丘系脾经之经穴。主要用于健脾利湿。配天枢、气海、足三里治疗急性腹痛泻泄，加配关元、脾俞、三焦俞治疗因脾阳运化失调所致的慢性腹泄。

三 阴 交

部位：仰卧或垂足取穴。在内踝尖上三寸，胫骨后缘凹陷中

(图22)。

穴释：三阴，三阴经；交，交会。此穴在内踝上三寸，是足三阴经交会处，故名三阴交。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~15分钟。

功能：健脾益气，调补肝肾。

主治：胃痛，腹胀，消化不良，肠鸣，溏泻，黄疸，消渴，眩晕，失眠，阳萎，滑精，疝气，遗尿，尿血，小便不利，水肿，荨麻疹，阴部肿痛，神经衰弱，高血压，症瘕，痛经，闭经，崩漏，带下，月经不调，子宫脱垂，胎衣不下，下肢肿痛、瘫痪、脚气等。孕妇禁针。

按语：三阴交系足太阴脾经、足厥阴肝经和足少阴肾经之会穴。统治足三阴经所主治的病症。应用极为广泛，为治疗肠胃、生殖、泌尿系统和妇产科疾病的主穴。亦为下肢病症的常用穴。配关元治疗痛经。配中极、膀胱俞治疗尿闭、遗尿。

漏 谷

部位：垂足取穴。在内踝尖上六寸，胫骨后缘凹陷中（图21）。

穴释：漏，渗漏；谷，山谷、空洞。此穴在胫骨内侧后缘凹陷处，主治淋漓水肿，故名漏谷。

针灸：直刺5~8分；灸3~5分钟。

功能：健脾利湿。

主治：肠鸣，腹胀，下肢肿痛、麻痹，脚气等。

地 机

部位：垂足取穴。在阴陵泉下三寸，胫骨后缘凹陷中（图21）。

穴释：地，土地；机，枢机。脾属土，此穴在膝下五寸，为膝关节和脾气转输之处，故名地机。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：健脾利湿，调补肝肾。

主治：胁满，腹胀，水肿，溏泻，小便不利，遗精，遗尿，症瘕，痛经，白带，月经不调，下肢冷痛、麻痹等。

按语：地机系脾经之郄穴。有健脾利湿、通经活血的作用。配肾俞、期门、中脘、中极、水道、复溜治疗肝脾不利，脾失健运所致之纳差、便溏、胁满腹胀、小便不利、水肿等症。配关元、归来、三阴交治疗气滞血凝之痛经、经闭及症瘕等症。

阴 陵 泉

部位：仰卧或垂足取穴。在膝窝里面横纹头下二寸，胫骨头下缘凹陷中（图22）。

穴释：阴陵，内侧丘陵；泉，水泉。此穴在膝关节隆起的内侧，如泉的凹陷中，故名阴陵泉。

针灸：直刺1～2寸；灸5～15分钟。

功能：健脾利湿，调补肝肾。

主治：腹痛、胀满，水肿，泄泻，小便不利，遗精，遗尿，尿闭，月经不调，带下，阴痛，腿膝肿痛、麻痹等。

按语：阴陵泉系脾经之合穴。也是下肢腧穴中较常用的经穴之一。主治脾肾二经症候。有温运中焦，清利下焦之功。故凡由中焦虚寒与下焦湿热所致的病症皆可选用此穴施治。配水道、中极、复溜治疗水肿。

血 海

部位：垂足取穴。在髌骨（膝盖）内上缘上二寸，右掌心按左膝，左掌心按右膝时拇指尖尽处是穴（图22）。

穴释：血，血液；海，水归聚之处。脾统血、摄血，此穴属脾经，有祛瘀血、生新血，调治一切血病的功能，故名血海。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~15分钟。

功能：调和气血，祛风利湿。

主治：腹胀，湿疹，荨麻疹，贫血，经闭，崩漏，痛经，月经不调，阴部痒痛，脚气，腿膝肿痛、麻痹等。

按语：血海又名百虫窝，有调和气血的作用。血分杂病，常选用此穴。擅治妇科经血诸症。亦用于阴部搔痒、湿疹、荨麻疹等皮肤风湿侵袭之症，古有“治风先治血，血和风自灭”之说，就是这个道理。配三阴交、隐白、归来治疗脾失统摄的崩漏。配气穴、关元、三阴交治疗痛经、经闭。配曲池、合谷、足三里、三阴交治疗荨麻疹和皮肤搔痒等症。



图23 箕门穴

箕 门

部位：外展屈膝取穴。在髌骨（膝盖）内上缘上八寸，两筋间凹陷中。外展屈膝时凹陷最明显（图23）。

穴释：箕，簸箕；门，门户。此穴在膝髌内缘上八寸，外展屈膝两筋间似簸箕口的凹陷处，故名箕门。

针灸：直刺1~1.5寸；灸3~5分钟。

功能：健脾利湿。

主治：小便不通，遗尿，阴囊湿疹，大腿肿痛、麻痹等。

冲 门

部位：仰卧避开动脉取穴。在任脉曲骨旁四寸，腹股沟外端纹头中（图21）。

附注：脾经由冲门至腹哀的横寸，有几种不同的记载：《针灸大成》为

去中行四寸五分，《类经图翼》、《医宗金鉴》为去中行三寸五分，本书为任脉旁四寸。

穴释：冲，冲动，上冲；门，门户。此穴在腹股沟外端动脉处，脉气由此上冲，是脾、肝、阴维脉交会之门，故名冲门。

针灸：直刺0.5～1寸，灸5～10分钟。

功能：调中益气，温经活血。

主治：小腹胀痛，小便不利，疝气，睾丸炎，子宫脱垂等。

按语：冲门系足太阴脾经、足厥阴肝经、阴维脉之会穴。一般用于少腹寒凉、胀痛、坠痛和尿闭等症。配中脘、气海、三阴交治疗子宫脱垂。配大敦、三阴交治疗疝气。

府 舍

部位：仰卧取穴。在冲门上七分，任脉旁四寸（图21）。

穴释：府，脏腑；舍，居室。此穴在腹部，是脏腑之气聚集入舍之处，故名府舍。

针灸：直刺0.5～1寸，灸5～10分钟。

功能：调中益气，温经活血。

主治：小腹胀痛，症瘕，疝气，睾丸炎，子宫脱垂等。

按语：府舍系足太阴脾经、足厥阴肝经和阴维脉之会穴。是治疗小腹症瘕、积聚引起急痛的常用穴。配中脘、气海、三阴交治疗子宫脱垂，加配大敦治疗睾丸炎。

腹 结

部位：仰卧取穴。在大横下一寸三分，任脉旁四寸（图21）。

附注：腹结的直寸有几种不同的记载：《甲乙经》、《千金方》、《外台秘要》、《十四经发挥》、《针灸大成》、《类经图翼》等书为大横下一寸三分，《铜人腧穴图经》为大横下三寸，《针灸大全》为大横下三分，本书为大横下一寸三分。

穴释：腹，肚腹；结，聚结。此穴在腹部，是腹气结聚及治疗气结腹痛之处，故名腹结。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：理气活血。

主治：绕脐腹痛，腹胀，疝气，泻痢，阑尾炎等。

大 横

部位：仰卧取穴。在肚脐中心旁四寸（图21）。

穴释：大，大肠；横，平线为横。此穴在脐外四寸，横平大肠之募天枢，故名大横。

针灸：直刺0.5~1寸；灸5~10分钟。

功能：通调肠胃。

主治：绕脐腹痛，泄泻，痢疾，便秘，脏躁症等。

按语：大横系足太阴脾经和阴维脉之会穴。为治疗腹痛、泻痢的常用穴。亦可治疗妇女脏躁症。配天枢、上巨虚治疗绕脐腹痛。配人中、合谷治疗癰病。

腹 哀

部位：仰卧取穴。在大横上一寸半，任脉旁四寸（图21）。

穴释：腹，肚腹；哀，哭啼，哀鸣。此穴在上腹部，常有肠鸣之声，故名腹哀。

针灸：直刺0.5~1寸；灸3~5分钟。

功能：调理脾胃。

主治：胸腹胀痛，消化不良等。

按语：腹哀系足太阴脾经和阴维脉之会穴。主要治疗胃肠疾病。配中脘、足三里治疗消化不良。

食 窠

部位：仰卧或举臂取穴。在任脉旁六寸，天溪下一肋，第五肋间隙中（图21）。

穴释：食，饮食；窠，空洞。此穴在侧胸肋间，饮食通过之处，故名食窠。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸理气。

主治：胸胁胀痛等。

天 溪

部位：仰卧取穴。在乳头旁二寸，第四肋间隙中（图21）。

穴释：天，胸属上焦为天；溪，水沟。此穴在乳旁，乳汁流溢之处，故名天溪。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：舒肝理气。

主治：胸肋胀痛，呃逆，咳嗽，哮喘，乳痛，乳汁不足等。

胸 乡

部位：仰卧取穴。在任脉旁六寸，天溪上一肋，第三肋间隙中（图21）。

穴释：胸，胸腔；乡，家乡居处。此穴在侧胸部，内居肺脏，故名胸乡。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸理气。

主治：胸肋胀痛，支气管炎等。

周 荣

部位：仰卧取穴。在任脉旁六寸，胸乡上一肋，第二肋间隙中（图21）。

穴释：周，周身；荣，荣养。此穴内应肺脏，是肺气、脾气转输荣养全身之处，故名周荣。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸理气。

主治：胸胁胀痛，咳嗽，哮喘等。

大 包

部位：仰卧或正坐举臂取穴。在任脉中庭旁八寸，腋窝直下六寸，第六肋间隙中。手虎口张开，拇指尖按中庭，中指指尖尽处就是本穴（图21）。

穴释：大，大络；包，包罗，包揽。此穴为脾之大络，“总统阴阳诸络”，“灌溉五脏”，无所不包，故名大包。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：理气活络。

主治：胸胁胀痛，咳嗽，哮喘，气短，全身痛等。

按语：大包系足太阴脾经之大络。总管阴阳诸经之络，能治疗全身络脉病症，但后世多用于治疗胸胁痛和脾胃疾患。配肝俞、期门治疗胸胁痛。

第五节 手少阴心经

本经起于极泉终于少冲，左右共18穴。取少冲、少府、神门、灵道、少海为井、荣、俞、经、合。本穴少府，络穴通里，俞穴心俞，募穴巨阙，郄穴阴郄。

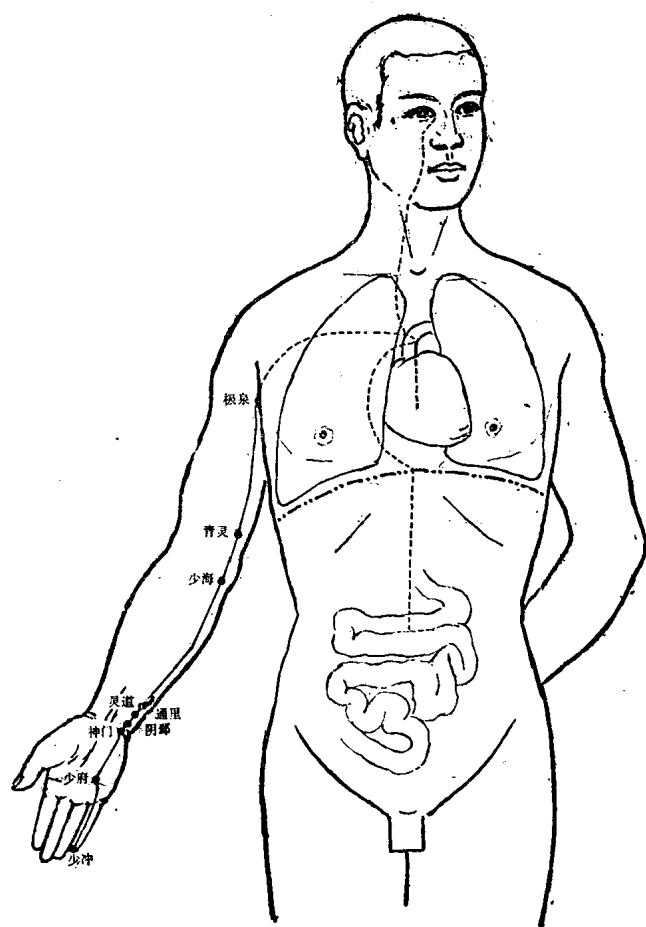


图24 手少阴心经循行示意图和腧穴

循行概述：起于心中，上肺横出腋窝部的极泉，沿着上肢内侧下缘下行，过肘、腕尺侧至小指内侧端少冲和手太阳经相接。从心中出来的支脉，连“心系”挟咽喉连“目系”，并归属心脏，向下联络小肠（图24）。

生理功能：心居胸中，被心包围护，和小肠互为表里，开窍于舌。心主血脉，主宰血脉之运行，濡养全身，为生命活动之中心，又主神明，是情志思维活动之中枢。

病理症候：经络症：手心热痛，上臂内侧后缘心经循行线之肿痛、麻痹、厥冷。

脏腑症：心痛，不眠，咽干，目黄，口渴欲饮，心悸，健忘，惊恐烦乱，哭笑无常。心气竭绝，则脉道不通，血不流行，而见头发颜色不润泽，面色黑瘦如柴。

心经穴歌：

九穴心经手少阴，极泉青灵少海深，
灵道通里阴郄穴，神门少府少冲寻。

极 泉

部位：举臂手掌向内避开动脉取穴。在腋窝正中，两筋间凹陷中（图25）。

穴释：极，尽处，高也；泉，水之源。此穴在心经最高处，气血由此流出，故名极泉。

针灸：直刺3～5分。

功能：行气活血。

主治：心痛，胁痛，乳汁不足，臂肘冷痛等。

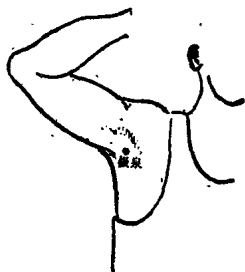


图25 极泉取穴法

青 灵

部位：伸肘仰掌或手掌按头取穴。在少海上三寸，大筋（肱二头肌）内侧沟中（图24）。

穴释：青，少也，生发之象；灵，神灵。此穴属少阴心经，是藏神通灵之处，故名青灵。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：行气活血。

主治：头痛，胁痛，肩臂红肿、痠痛、麻痹等。

少 海

部位：屈肘成直角取穴。在肘关节内侧（尺侧）横纹头凹陷中（图26）。

穴释：少，少阴；海，水归聚之处。此穴属手少阴之合水，经气似百川汇合入海之处，故名少海。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：行气活血，化痰宁心。

主治：头痛，目眩，健忘，癫痫，瘧病，心痛，呕吐，瘰癧，腋下肿痛，手颤，肘挛，上肢不能抬举等。

按语：少海系心经之合穴。可用于癫狂等症，手臂肘挛痛功能障碍，也常选用此穴。近年来主要用于手颤动和瘰癧的治疗。配曲池、内关透外关、合谷治疗手臂震颤，配阿是、巨骨治疗颈淋巴结核。

灵 道

部位：伸肘仰掌取穴。在神门后一寸五分，两筋间凹陷中（图26）。

穴释：灵，心灵；道，道路。此穴属手少阴经之经，是心灵

出入的道路，故名灵道。

针灸：直刺 5～8 分；灸 3～5 分钟。

功能：行气活血，宁心醒神。

主治：心痛，干呕，暴暗不语，神昏，失眠，悲恐，瘧病，尺神经麻痹，手痒，臂肘挛痛等。

按语：灵道系心经之经穴。是治疗心脏病和瘧病的主穴。配内关、心俞、厥阴俞、膻中治疗心脏病。配人中、合谷、巨阙治疗瘧病。

通 里

部位：伸肘仰掌取穴。在神门后一寸，两筋间凹陷中（图 26）。

穴释：通，通达；里，家乡邻里。此穴属心经之络，能通达表经，返还故里，故名通里。

针灸：直刺 5～8 分；灸 3～5 分钟。

功能：行气活血，宁心醒神。

主治：心悸，心痛，怔忡，失眠，瘧病，癰痛，目眩，暴哑，神昏，舌强，咽喉肿痛，臂腕痠痛，指挛等。

按语：通里系心经之络穴，别走手太阳小肠经。是治疗心血瘀阻，心阳不通之心痛的主穴。配内关、膻窗、乳根治疗心绞痛。

阴 郄

部位：伸肘仰掌取穴。在神门后五分，两筋间凹陷中（图 26）。

穴释：阴，少阴；郄，孔隙，裂缝。此穴属手少阴经之郄，故名阴郄。

针灸：直刺 5～8 分；灸 3～5 分钟。

功能：行气活血，养阴安神。

主治：心痛，惊悸，心动过速，失眠，盗汗，干咳，吐血等。

按语：阴郤系心经之郤穴。常用于阴虚盗汗、心悸失眠、午后烦热、干咳无痰等症。配百会、印堂、风池治疗神经衰弱。配百劳、肺俞，定喘治疗肺结核。



神 门

部位：仰掌取穴。在手掌面尺侧第一道腕横纹的两筋间凹陷中(图26)。

图26 神门等穴

穴释：神，心藏神；门，门户。此穴属心经，为心神出入之门，故名神门。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：行气活血，宁心安神。

主治：心痛，烦满，心悸，怔忡，健忘，失眠，无脉症，瘧病癲狂，吐血，惊风，神经衰弱等。

按语：神门系心经之俞穴，也是本经的原穴。为治疗心血管、脑神经系统病症的常用穴。配内关、心俞、膻中、乳根治疗心绞痛、阵发性心动过速、心律不齐等症。配百会、印堂、风池，三阴交治疗神经衰弱。配人中、百会、合谷治疗瘧病。

少 府

部位：仰掌屈指取穴。在无名指和小指之间，掌心内第一道横纹尺侧凹陷中(图24)。

穴释：少，少阴；府，府库、聚也。此穴在掌心，为手少阴脉气汇聚之处，故名少府。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：行气活血，清心导火。

主治：心痛、烦满、胸中痛，心悸，心律不齐，失眠，阴痒，小便赤短，手指拘挛，手掌多汗等。

按语：少府系心经之荥穴。功同神门，都有治疗心病的作用，但少府主要用于风湿性心脏病、心律不齐及心绞痛的治疗；而神门有治疗精神病、癔病及神经衰弱的作用。另外本穴尚有治阴痒、小便不利的功能。配三阴交、关元治疗遗尿。配关元、会阴治疗阴部湿疹搔痒。

少 冲

部位：伸指取穴。在小指内侧（桡侧）指甲角外约一分（图24）。

穴释：少，少阴；冲，冲要、冲出。此穴在小指内侧端，是手少阴经脉气所出之井，故名少冲。

针灸：斜刺1～2分或点刺出血。

功能：行气活血，清热醒神。

主治：心悸，心痛，胸胁胀满，目黄，癔病，癫狂，中风，中暑，惊风，昏厥等。

按语：少冲系心经之井穴。长于高热惊厥和中风昏迷的治疗。配合谷、太冲、人中治疗小儿惊风。配风府、十宣、合谷治疗中风昏迷。

第六节 手太阳小肠经

本经起于少泽终于听宫，左右共38穴。取少泽、前谷、后溪、腕骨、阳谷、小海为井、荥、俞、原、经、合。本穴阳谷，络穴支正，俞穴小肠俞，募穴关元，郄穴养老。

循行概述：起于少泽，沿着小指外侧及上肢外侧下缘上行，

过腕、肘、肩胛、颈、颞骨至耳前听官。肩上的支脉，交会督脉大椎。耳前的支脉，从颞髻至内眼角和足太阳经相接。肩上入缺盆的支脉，下行联络心脏、归属小肠（图27）。

生理功能：小肠上接胃的幽门，下连大肠的阑门。和心互为表里。小肠受盛胃中水谷，分利清浊，亦即吸收营养、传递糟粕。

病理症候：经络症：颊肿，口糜，咽喉肿痛，耳聋，目黄，肩，肘、臂外侧后缘小肠经循行线之肿痛、麻痹。

脏腑症：小腹痛，腰脊痛引睾丸，疝气，小便赤涩，尿闭，尿血。小肠气竭绝，则发直焦脆如干麻，自汗不止。

小肠经穴歌：

小肠经穴一十九，少泽前谷后溪走。

腕骨阳谷养老穴，支正小海外辅肘。

肩贞臑俞接天宗，髃外乘风曲垣首。

肩外俞连肩中俞，天窗乃与天容偶。

颞骨弓下是颞髻，听官耳屏前面求。

少 泽

部位：伸指取穴。在小指外侧（尺侧）指甲角外约一分（图27）。

穴释：少，小也；泽，润泽。此穴属手太阳经之井，小肠主液，有润泽全身之功能，故名少泽。

针灸：斜刺1～2分或点刺出血；灸3～5分钟。

功能：清热醒神，活络通乳。

主治：中风昏迷，头痛，项强，目翳，鼻衄，咽喉肿痛，疟疾，热病，乳汁不足，乳腺炎等。

按语：少泽系小肠经之井穴。因有散风解表的作用，故可用于表证头痛、寒热无汗等症。能通络清热，为治疗乳痈肿痛和乳

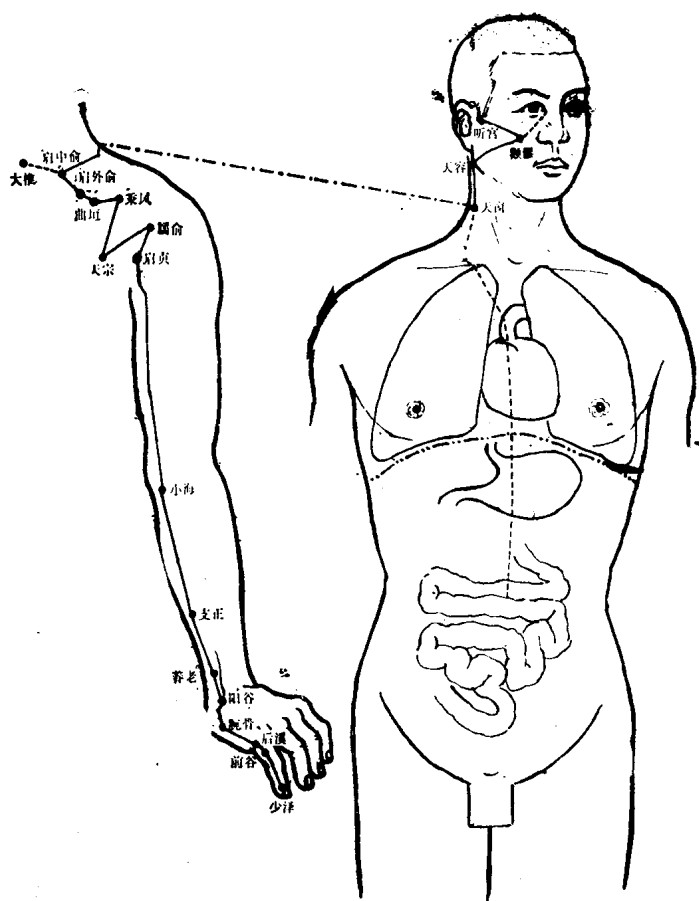


图27 手太阳小肠经循行示意图和腧穴

汁不通的主穴。配乳根、阿是治疗乳腺炎。配膻中、膺窗、乳根、中脘治疗乳汁分泌不足。

前 谷

部位：握拳取穴。在小指外侧（尺侧）第五掌指关节前横纹头赤白肉际凹陷中（图27）。

穴释：前，前方；谷，山谷、空洞。此穴在手小指外侧本节前凹陷处，故名前谷。

针灸：斜刺2～3分；灸3～5分钟。

功能：清热疏风。

主治：头项强痛，耳鸣，耳聋，目痛，鼻衄，颊肿，疟疾，疟疾，热病，乳汁不足，手指麻木等。

按语：前谷系小肠经之荣穴。局部应用主要治疗掌、指的一些疾患。远端用该穴治疗面颊和咽喉的病症。配外关、阳谷治疗手小指麻木。

后 溪

部位：握拳取穴。在小指外侧（尺侧）第五掌指关节后横纹头上方的赤白肉际凹陷中（图27）。

穴释：后，后方；溪，水沟。此穴在手小指外侧本节后凹陷处，故名后溪。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：散风清热，疏经活络。

主治：头项强痛，目翳，耳聋，癫痫，瘧病，疟疾，感冒，热病，臂痛，小儿麻痹后遗症，指挛，鹅掌风，瘫痪等。

按语：后溪系小肠经之俞穴，又是八脉交会穴之一，通督脉。主要功用：清心宁志，治疗瘧病，癫痫，精神病，清心导火，治疗小便短赤，心移热于小肠的见症，清热解表，治疗外感发

热，疟疾。配风池、阿是治疗颈项强痛。配大椎、陶道、申脉治疗感冒及疟疾。

腕 骨

部位：握拳取穴。在手腕外侧（尺侧）腕横纹前约一横指，赤白肉际凹陷中（图27）。

穴释：腕骨，手腕前外侧高骨，谓之腕骨。此穴在手腕前外侧高骨下陷中，故名腕骨。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：清热散风，疏经活络。

主治：头痛，耳鸣，目痛生翳，颈项强痛，尺神经麻痹，臂痛，指挛，手肿，瘫痪，消渴等。

按语：腕骨系小肠经之原穴。有清热散风，舒筋活络的作用。治胆火上浮，耳鸣，耳聋；肝火上攻，目赤生翳；湿热黄疸；指、腕、臂、肘挛痛不得屈伸。配外关、阳池治疗腕关节炎和小指、四指麻木。

阳 谷

部位：屈腕取穴。在手背腕横纹外侧（尺侧），尺骨小头之前凹陷中（图27）。

穴释：阳，外为阳；谷，山谷、空洞。此穴在腕关节外侧似山谷的凹陷处，故名阳谷。

针灸：直刺2～3分；灸5～10分钟。

功能：清热泻火，疏筋利节。

主治：耳鸣，目眩，颈、颌肿痛，臂痛，手腕痠痛等。

按语：阳谷系小肠经之经穴。配合谷、人中、内关治疗心肝火盛之癫狂诸症。配液门、侠溪、听宫治疗肝胆火邪所致之耳聋、耳鸣及两胁疼痛。

养 老

部位：屈肘手掌向肩取穴。在阳谷上一寸，尺骨小头最高点桡侧骨缝中。屈肘掌心朝面，小指侧内旋，尺骨小头桡侧显出的陷窝就是本穴（图27）。

穴释：养，供养；老，元老。此穴有治疗老年人眼目昏花，肩臂痠痛的功效，故名养老。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：清热利湿，疏筋活络。

主治：口舌生疮，小便短赤，麻痹无力，落枕，肩臂痠痛，手腕痠痛等。

按语：养老系小肠经之郄穴。有清热利湿的作用，是治疗指、腕、肘关节红肿疼痛症的主穴。配外关、阳池治疗手腕下垂和腕关节痛。

支 正

部位：屈肘手掌向肩取穴。在阳谷上五寸，筋骨之间（图27）。

穴释：支，别走为支；正，本经为正。此穴为小肠经之络穴，别走手少阴经，故名支正。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：清热养阴，疏经活络。

主治：头痛，项强，颈肿，目眩，消渴，癫狂，精神病，尺神经麻痹，臂痛，肘挛，手指痠痛等。

按语：支正系小肠经之络穴，别走手少阴心经。与腕骨穴同有养阴清热作用，能治疗消渴，癫狂，臂痛等症。配中脘、足三里、脾俞治糖尿病。

小 海

部位：屈肘取穴。在肘尖（尺骨鹰嘴）与肘内高骨（肱骨内上髁）之间的沟中（图27）。

穴释：小，小肠经，海，水归聚之处，此穴在肘内大骨外似海的凹陷中，故名小海。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：清心导火，疏筋利节。

主治：耳聋，目眩，牙痛，颊肿，颈项强痛，小便短赤，癰痛，精神病，尺神经麻痹，臂痛，震颤，瘫痪等。

按语：小海系小肠经之合穴。主要用于本经所过部位及器官的病症。如肩、臂、肘、颈的疼痛和耳、目、颞、颊的疾患。配支正、阳谷、腕骨治疗尺神经麻痹。

肩 贞

部位：垂臂取穴。在腋窝后面竖纹头上约一寸凹陷中（图28）。

穴释：肩，肩胛；贞，正也。此穴在肩胛外，腋窝后缘竖纹正中，为操作努力之本，故名肩贞。

针灸：直刺1～2寸；灸5～10分钟。

功能：疏筋利节。

主治：肩胛痠痛，上肢肿痛、麻痹、瘫痪等。

臑 俞

部位：垂臂取穴。在肩贞直上，肩胛岗下缘凹陷中（图28）。

穴释：臑，肩膊下脰肉；俞，输注。此穴在肩胛骨下缘，经气输注之软组织处，故名臑俞。

针灸：直刺1～2寸；灸5～10分钟。

功能：疏筋利节。

主治：肩胛痠痛，颈项强痛，臂痛、无力等。

按语：臑俞系手太阳小肠经、阳维脉和阳跷脉之会穴。主要治疗肩胛疼痛。配肩髃、肩髃、肩贞、外关治疗肩关节周围炎。

天 宗

部位：正坐垂臂取穴。在腋窝后面竖纹头下端向内约四横指，大筋外凹陷中，约与第五胸椎平齐（图28）。

穴释：天宗，日月星也。

《书·尧典》：“禋于六宗”。

疏：“六宗者，天宗三，日月星也；地宗三，江河岱也”。此穴在肩胛骨中央，与曲垣、秉风诸穴排列有天宗之象，故名天宗。

针灸：向内斜刺3～5分；

灸5～10分钟。

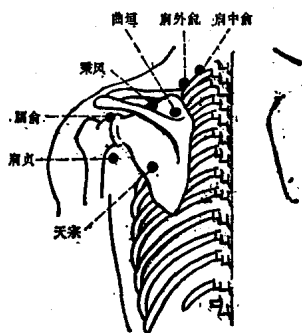


图28 天宗等穴

功能：疏筋利节。

主治：肩胛痠痛，上肢肿痛、麻痹、痿痹等。

按语：天宗和秉风均能治疗肩胛痠痛。但天宗的感应相当强烈，能穿过肩胛传到手指。故能治疗臂痛和麻痹。配臑俞、肩髃、臑会、曲池治疗臂丛神经损伤。

秉 风

部位：垂臂取穴。在天宗直上，肩胛岗上缘凹陷中（图28）。

穴释：秉，主持；风，风邪。此穴在肩胛骨上缘，有主治诸风病的功能，故名秉风。

针灸：向前斜刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：疏筋利节。

主治：颈项强痛，麻痹，肩胛痠痛，臂痛等。

按语：秉风系手三阳经和足少阳胆经之会穴。主要治疗肩胛部的疼痛。配肩井、臑俞、肩髃治疗肩胛部肿痛。

曲 垣

部位：垂臂取穴。在胆经肩井后下方约二寸，肩胛骨上凹陷中（图28）。

穴释：曲，弯曲；垣，矮墙。此穴在肩中央曲胛陷中，四旁骨起如垣，故名曲垣。

针灸：向前斜刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：疏筋利节。

主治：肩胛痠痛，肩臂拘急，臂痛、麻痹等。

肩 外 俞

部位：正坐伏俯取穴。在督脉陶道旁三寸，肩胛骨边缘（图28）。

穴释：肩，肩胛；外俞，外缘俞穴。此穴在肩胛骨外缘，去脊三寸，故名肩外俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：疏经活络。

主治：颈项强痛，肩背痠痛，肘臂冷痛等。

肩 中 俞

部位：正坐伏俯取穴。在督脉大椎旁二寸凹陷中（图28）。

穴释：肩，肩胛；中俞，中间俞穴。此穴去脊二寸，在肩胛骨外缘与督脉之间，故名肩中俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：宣肺解表，疏经活络。

主治：咳嗽，哮喘，吐血，感冒，目视不明，肩臂痠痛等。

天 窗

部位：正坐取穴。在大肠经扶突后约一寸，胸锁乳突肌后缘（图27）。

穴释：天，高上为天；窗，窗牖。此穴在颈外侧，有开窍通气治耳聋喉痹之功能，故名天窗。

针灸：直刺或向结喉斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：颈项强痛，咽喉肿痛，口噤，耳鸣，聋哑等。

天 容

部位：正坐取穴。在耳垂下约一寸，胸锁乳突肌与下颌角之间凹陷中（图27）。

穴释：天，高上为天；容，面容、容身。此穴在耳下曲颊后，古人之头盔弯曲下垂，防护头颈，穴当其下，头颈象天，故名天容。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：清热化痰。

主治：耳鸣，耳聋，咽喉肿痛，牙痛，颊肿，瘰癧，瘰气等。

颧 髅

部位：合口取穴。在外眼角直下，颧骨下缘凹陷中（图27）。

穴释：颧，颧骨；髅，同窌，骨之空隙。此穴在颧骨下缘凹陷中，故名颧髅。

针灸：直刺1～1.5寸。

功能：清热散风，疏经止痛。

主治：口眼歪斜，牙痛，面肿，眼睑痉挛，三叉神经痛等。

按语：颧髎系手太阳小肠经和手少阳三焦经之会穴。主要用于三叉神经痛和面神经麻痹的治疗。配太阳、下关、颊车、合谷治疗三叉神经痛。

听 官

部位：张口取穴。在耳屏（小耳朵）前边凹陷中。张口时凹陷最明显（图27）。

穴释：听，听力；官，五音之首，又为宫室。此穴在耳屏前，张口凹陷处，主听力，故名听官。

针灸：直刺1~1.5寸。

功能：清头聪耳。

主治：耳鸣，耳聋，耳中肿痛，头痛，聋哑，眩晕，牙痛，下颌关节炎等。

按语：听官系手太阳小肠经、手少阳三焦经和足少阳胆经之会穴。有活络通窍的作用。是治疗耳部诸疾的主穴。配听会、率谷、侠溪治疗耳鸣、耳聋。配耳门、听会、前谷治疗中耳炎。

第七节 足太阳膀胱经

本经起于睛明终于至阴，左右共134穴。取至阴、通谷、束骨、京骨、昆仑、委中为井、荣、俞、原、经、合。本穴通谷，络穴飞扬，俞穴膀胱俞，募穴中极，郄穴金门。

循行概述：起于睛明，沿着眉头、前额、头顶、项、背及下肢后面下行，过腰、臀、膝窝、腿肚、外踝后至小趾外侧端至阴和足少阴经相接。头部的支脉，交百会入里络脑。头顶的支脉，横行为耳上角。臀部的支脉，从秩边交环跳而下行。背脊的支脉、

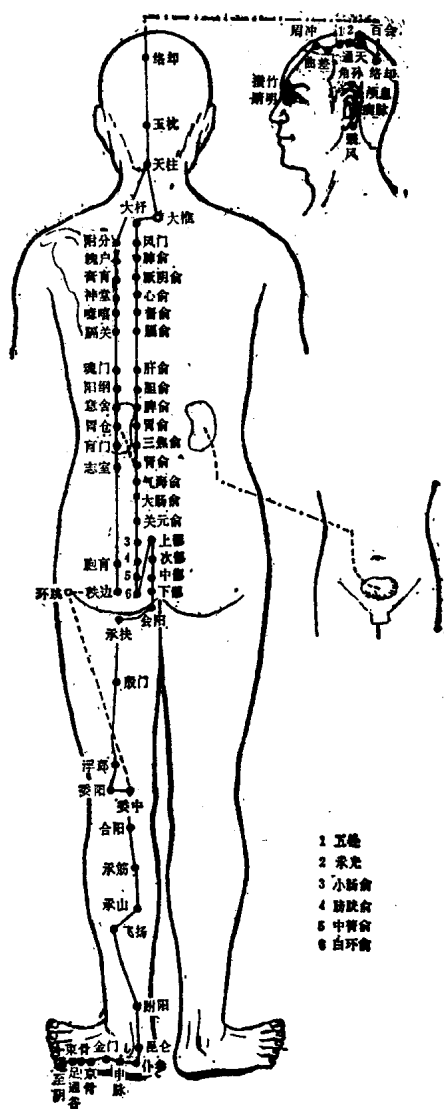


图29 足太阳膀胱经循行示意图和腧穴

入里联络肾脏，归属膀胱（图29）。

生理功能：膀胱位于小腹，和肾互为表里。膀胱藏津液，司气化，主汗，尿之排泄。

病理症候：经络症：发热恶寒，头痛，鼻衄，鼻塞流涕，目痛流泪，项、背、腰、臀和膝后面至足等膀胱经循行线之肿痛、麻痹、厥冷。

脏腑症：小便不利，遗尿，尿赤，尿浊，尿血，蓄血发狂。膀胱气绝，则遗尿狂言，目反直视。

膀胱经穴歌：

六十七穴足太阳，睛明目内红肉藏。
攒竹眉冲与曲差，五处二寸上承光。
通天络却下玉枕，天柱发际大筋上。
大杼风门肺厥阴，心俞督俞膈俞当。
肝胆脾胃具挨次，三焦肾气海大肠。
关元小肠到膀胱，中膂白环寸半量。
上次中下四髎穴，一空二空骶孔藏。
会阳尾骨外边取，附分背脊第二行。
魄户膏肓神堂寓，億譔膈关魂门详。
阳纲意舍胃仓随，肓门志室至胞育。
二十一椎秩边是，承扶臀股纹中央。
殷门浮郄委阳至，委中合阳承筋量。
承山飞扬跗阳继，昆仑仆参申脉堂。
金门京骨束骨跟，通谷至阴小趾旁。

睛 明

部位：取穴法有三种。

1. 睛明：仰卧合目取穴，在内眼角外约一分凹陷中。
2. 内睛明：仰卧分开上下眼睑，目向外视取穴，在内眼角内

泪阜边缘。

3.上睛明：仰卧合目取穴，在内眼角上一分凹陷中(图30)。

穴释：睛，眼睛；明，光明。此穴在目内眦靠近眼球，有使眼睛明亮之功，故名睛明。

针灸：直刺1~3分；内、上睛明直刺1~1.5寸。

功能：疏风清热，活血明目。

主治：目赤肿痛，内眦赘肉侵

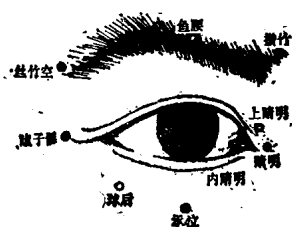


图30 睛明等穴

睛，目痒，流泪，近视，青盲，色盲，夜盲，视网膜炎，视网膜出血，视神经炎，视神经萎缩，早期白内障等一切眼病。

按语：睛明系足太阳膀胱经、手太阳小肠经、足阳明胃经和阴、阳跷脉之会穴。有疏风清热，通络明目的作用。为治疗眼病的主穴，尤其内睛明是内眼病的首选穴。对青光眼、视网膜出血、视网膜炎和视神经萎缩等病有较好的疗效。配风池、颅息、角孙、太阳、攒竹治疗视网膜炎和眼底出血。配风池、球后、瞳子髎、攒竹治疗视神经萎缩，加配合谷、光明可降眼压治疗青光眼。

攒竹

部位：正坐或仰卧取穴。在睛明直上，眉头陷中(图30)。

穴释：攒，簇聚；竹，竹叶。此穴在眉头凹陷处，眉毛似簇聚之竹丛，故名攒竹。

针灸：向下斜刺3~5分或透鱼腰或点刺出血。

功能：疏风清热，通络明目。

主治：头痛，面肿，眉棱骨痛，目赤肿痛，目翳，眼球痒痛，流泪，青盲，口眼歪斜，眼睑痉挛，近视，视网膜出血，视神经萎缩，鼻炎等。

按语：攒竹有疏风泄热、通络明目的作用。功同睛明，治疗一切眼病。但内睛明长于内眼病，而本穴则长于外眼疾患和头痛等。配鱼腰、太阳治疗急性结膜炎。配承泣透睛明治疗泪囊炎。配上星、合谷治疗前头痛。

眉 冲

部位：正坐或仰卧取穴。在眉头直上，入发际五分，督脉神庭与曲差之间（图29）。

穴释：眉，眼眉；冲，冲要。此穴在眉头直上，经气冲入发际之处，故名眉冲。

针灸：沿皮刺3～5分。

功能：清头散风。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，目赤肿痛等。

曲 差

部位：正坐或仰卧取穴。在督脉神庭旁一寸五分（图29）。

穴释：曲，弯曲；差，参差不齐。此穴在眉冲外，发际弯曲不齐之处，故名曲差。

针灸：沿皮刺3～5分。

功能：清头散风。

主治：头顶肿痛，鼻衄，鼻塞流涕，目视不明等。

五 处

部位：正坐取穴。在曲差后五分，督脉上星旁一寸五分（图29）。

穴释：五，五数；处，处所。此穴在曲差后五分，又是足太阳经的第五穴，故名五处。

针灸：沿皮刺3～5分。

功能：清头散风。

主治：头痛，眩晕，目视不明等。

承 光

部位：正坐取穴。在五处后约二寸，督脉前顶旁一寸五分（图29）。

穴释：承，承受；光，光明。此穴在头部，有承受眼病，使之恢复光明的功能，故名承光。

针灸：沿皮刺3～5分。

功能：清头散风。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，口眼歪斜等。

通 天

部位：正坐取穴。在承光后一寸五分，督脉百会旁一寸五分（图29）。

穴释：通，通达；天，高上为天。此穴是足太阳经上交督脉百会之处，为一身之天顶，故名通天。

针灸：沿皮刺3～5分。

功能：清头散风。

主治：头痛，眩晕，偏瘫，鼻衄，鼻塞流涕，尸厥等。

络 却

部位：正坐取穴。在通天后一寸五分，督脉旁一寸五分（图29）。

穴释：络，联络；却，退却。此穴在通天之后，经脉从巅顶入里络脑，还出却向后下行，故名络却。

针灸：沿皮刺3～5分。

功能：清头散风。

主治：头痛，眩晕，耳鸣，青盲，目视不明等。

玉 枕

部位：正坐取穴。在督脉脑户旁一寸五分凹陷中（图29）。

穴释：玉枕，相士称枕骨为玉枕骨。此穴在脑后枕骨两旁仰卧着枕之处，故名玉枕。

针灸：沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清头散风。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，目视不明，近视等。

天 柱

部位：正坐取穴。在项后发际，督脉哑门旁大筋外缘（图29）。

穴释：天，高上为天；柱，支柱。此穴在项后发际大筋外缘，项筋柱骨支持头部有擎天之象，故名天柱。

针灸：向内斜刺0.5～1寸。

功能：清头散风，通经活络。

主治：头痛，眩晕，目视不明，鼻塞流涕，感冒，颈项强痛，落枕，失眠，健忘，肩臂痠痛等。

按语：天柱有通经活络之功，为治疗颈项病的主穴。又有升清降浊的作用，可清头明目。配大杼、风门、巨骨治疗项背疼痛。配内关、阳陵泉治疗高血压。

大 杼

部位：俯伏取穴。在第一胸椎下，督脉陶道旁一寸五分（图29）。

穴释：大，盛大；杼，织布之梭。第一胸椎谓之杼骨，此穴在杼骨两旁，故名大杼。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：祛风解表，疏调筋骨。

主治：头痛，项强，目眩，咳嗽，哮喘，发热汗不出，咽喉肿痛，肩胛痠痛，脊背痠痛等。

按语：大杼系足太阳膀胱经，手太阳小肠经、手少阳三焦经和足少阳胆经之会穴。又是八会中的骨会。有解表退热、疏筋壮骨之功。配大椎、陶道、后溪治疗伤寒脉浮、头项强痛、恶寒发热无汗等症。配大椎、华佗夹脊、委中治疗项背筋急痠痛不得屈伸等症。

风 门

部位：俯伏取穴。在第二胸椎下，督脉旁一寸五分(图29)。

穴释：风，风邪；门，门户。此穴在第二胸椎旁，是风邪侵入与驱出的门，故名风门。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：祛风解表，清热宣肺。

主治：头痛，项强，感冒，咳嗽，哮喘，胸背疼痛，荨麻疹，支气管炎，肺炎等。

按语：风门亦称热府，系足太阳膀胱经和督脉之会穴。因风邪多由此为门户侵入故名。有理肺宣散之功，擅长祛风，凡外感表症皆可取此穴施治。配大椎、肺俞、鱼际、少商治疗寒邪外束，内热郁闭之肺炎等症。

肺 俞

部位：俯伏取穴。在第三胸椎下，督脉身柱旁一寸五分(图29)。

穴释：肺，肺脏；俞，同输。此穴内应肺脏，是肺气转输之处，故名肺俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：疏散风热，养阴清肺。

主治：肺癆，咳嗽，哮喘，吐血，盗汗，感冒，发热，荨麻疹，肩背强痛，气管炎，肺炎等。

按语：肺俞系肺在背之俞穴。有调补肺气之功，通治肺经内伤、外感病症。配风门、喘息、列缺治疗外感咳嗽，胸膈满闷等症。配大椎、身柱、中府、列缺、照海治疗内伤咳嗽，盗汗、午后潮热等症。

厥 阴 俞

部位：俯伏取穴。在第四胸椎下，督脉旁一寸五分(图29)。

穴释：厥阴，心包络；俞，同输。此穴内应心包络，是心包络之气转输之处，故名厥阴俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：理气活血，疏通心脉。

主治：心痛，呕吐，胸痛，肋痛，烦闷，咳嗽，冠心病等。

按语：厥阴俞系心包络在背之俞穴。有通经活络之功。配心俞、膻中、内关缓解冠状动脉痉挛，扩张血管，改善心脏供血障碍，治疗心绞痛。

心 俞

部位：俯伏取穴。在第五胸椎下，督脉神道旁一寸五分(图29)。

穴释：心，心脏；俞，同输。此穴内应心脏，是心气转输之处，故名心俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：理气活血，化痰宁心。

主治：胸闷，心痛，心烦，心悸，心脏病，咳嗽，哮喘，呕

吐，吐血，遗精，健忘，瘧病，癲痛，肩臂痠痛等。

按语：心俞系心在背之俞穴。有行气活血、清热化痰、镇惊安神之功。治疗癲痛、狂躁、精神病等。近代临床为治疗心绞痛和冠心病的主穴。另外对于心肾不交之遗精、洩浊、神经衰弱亦有疗效。配厥阴俞、膻中、内关治疗心绞痛和冠心病。

督 俞

部位：俯伏取穴。在第六胸椎下，督脉旁一寸五分(图29)。

穴释：督，督脉；俞，同输。此穴在第六胸椎旁，是督脉之气转输之处，故名督俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：宽胸理气。

主治：胸膈满闷，心痛，气逆，腹胀，肠鸣，脊背痛等。

膈 俞

部位：俯伏取穴。在第七胸椎下，督脉至阳旁一寸五分。正坐时与肩胛骨下缘平齐(图31)。

穴释：膈，横膈；俞，同输。此穴内应横膈，有开胸通膈治疗气滞血瘀的功能，故名膈俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：宽胸降逆，调补气血。

主治：胸胁胀痛，胃痛，呕吐，噎膈，呃逆，饮食不下，咳嗽，哮喘，吐血，瘀血，便血，贫血，肩臂痠痛等。

按语：膈俞系八会穴中之血会。与胆俞合称“四花穴”主要有补血化瘀作用。并可治疗咳嗽、哮喘、胸满气逆和虚劳诸疾。配肝俞、脾俞、曲池、血海、三阴交治疗慢性出血、贫血和紫癜等症。配肝俞、期门、中脘、合谷、内关治疗膈肌痉挛。

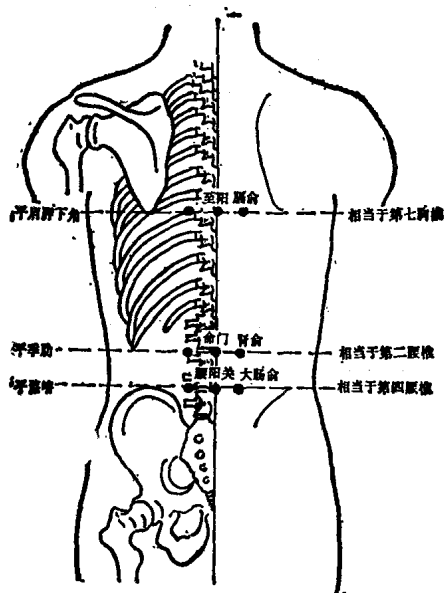


图31 肝俞大肠俞等取穴法

肝 俞

部位：俯伏取穴。在第九胸椎下，督脉筋缩旁一寸五分（图29）。

穴释：肝，肝脏；俞，同输。此穴内应肝脏，是肝气转输之处，故名肝俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～15分钟。

功能：清泄肝胆，养血明目。

主治：胸胁胀痛，胃痛，黄疸，鼻衄，吐血，瘰病，癰病，眩晕，青盲，夜盲，肝炎，胆囊炎，视网膜出血，视神经萎缩，乳少，脊背痠痛等。

按语：肝俞系肝在背之俞穴。既可泄肝胆之火，又能养肝肾之阴。凡肝肾阴虚、肝阳上亢和肝胆经湿热之见症，皆可选用此

穴施治，此外对肝胆经所司两胁痛和目疾等症，也常选用此穴。配胆俞、期门、中脘、足三里、三阴交治疗肝炎。配大椎、风池、肾俞、颅息、角孙、太阳治疗因血小板减少引起的紫癜和视网膜反复出血。

胆 俞

部位：俯伏取穴。在第十胸椎下，督脉中樞旁一寸五分（图29）。

穴释：胆，胆腑；俞，同输。此穴内应胆腑，是胆气转输之处，故名胆俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～15分钟。

功能：清泄肝胆，理气解郁。

主治：胸胁胀痛，黄疸，口苦，感冒，恶寒汗不出，胃痛，呕吐，胆囊炎，肝炎等。

按语：胆俞系胆在背之俞穴。功同肝俞。而肝俞偏养阴潜阳，此穴则长于利胆解郁；二穴常同时使用治疗肝胆所见诸症。配肝俞、期门、中脘、阳陵泉、足三里、三阴交治疗急性黄疸性肝炎，加配日月治疗胆囊炎。

脾 俞

部位：俯伏或俯卧取穴。在第十一胸椎下，督脉脊中旁一寸五分（图29）。

穴释：脾，脾脏；俞，同输。此穴内应脾脏，是脾气转输之处，故名脾俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～15分钟。

功能：健脾利湿，益气统血。

主治：胃痛，腹胀，呕吐，泄泻，黄疸，水肿，肠鸣，痢疾，症瘕，积聚，出血性病症，崩漏等。

按语：脾俞系脾在背之俞穴。有健脾利湿、益气统摄之功。凡脾阳不振出现水湿内停、纳差、便溏、脘腹胀满、疼痛喜按、四肢困乏、水肿等中焦虚寒，以及脾不统血之出血见症，皆可取此穴施治。配胃俞、中脘、足三里治疗脾胃虚寒症。配关元、归来、三阴交、隐白治疗经水崩漏症等。

胃 俞

部位：俯伏或俯卧取穴。在十二胸椎下，督脉旁一寸五分（图29）。

穴释：胃，胃腑；俞，同输。此穴内应胃腑，是胃气转输之处，故名胃俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～15分钟。

功能：滋养胃阴，健脾助运。

主治：胃痛，胃下垂，腹胀，饥不思食，渴思冷饮，虚烦干呕，泄泻，小儿疳积，营养不良，腰背痠痛等。

按语：胃俞系胃在背之俞穴。与脾俞有治疗消化系统病症的协同作用。脾俞健运脾阳，胃俞滋养胃阴，凡见渴思冷饮、干呕嘈杂、饥不思食、脉数舌红等胃阴不足之症，均以此穴为主。配中脘、内关、足三里治疗胃脘痛。配脾俞、中脘、建里、下脘、足三里、四缝治疗消化不良。配中脘、内关、三阴交治疗胃阴不足。

三 焦 俞

部位：俯伏或俯卧取穴。在第一腰椎下，督脉悬枢旁一寸五分（图29）。

穴释：三焦，三焦腑；俞，同输。此穴内应三焦，是三焦之气转输之处，故名三焦俞。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～15分钟。

功能：温阳化气，通调水道。

主治：腹胀，呕吐，泻痢，水肿，消化不良，腰背痠痛等。

按语：三焦俞系三焦在背之俞穴。此穴统管三焦之火，有通调水道之功。故凡三焦寒凝、水湿内停皆可取用此穴，温阳化气，行水利湿。配脾俞、胃俞、中脘治疗消化不良。配肾俞、水分、水道、中极、阴陵泉、复溜治疗水肿。

肾 俞

部位：俯伏或俯卧取穴。在第二腰椎下，督脉命门旁一寸五分（图31）。

穴释：肾，肾脏；俞，同输。此穴内应肾脏，是肾气转输之处，故名肾俞。

针灸：直刺5～8分；灸10～20分钟。

功能：益肾固精，清热利湿。

主治：阳萎，遗精，遗尿，尿血，尿闭，水肿，耳鸣，目昏，腰背酸痛，肾炎，神经衰弱，视网膜出血，视神经萎缩，赤白带下，月经不调，盆腔炎，下肢麻痹等。

按语：肾俞系肾在背之俞穴。有滋阴补肾之功。泌尿生殖系统疾病，多用此穴。配关元俞、关元、三阴交治疗遗尿、遗精、阳萎等症。配内关、中脘、水分、气海、阴陵泉、足三里、复溜治疗肾炎。

气 海 俞

部位：俯伏或俯卧取穴。在第三腰椎下，督脉旁一寸五分（图29）。

穴释：气海，原气之海；俞，同输。此穴与脐下气海相对，有输调元气之功，故名气海俞。

针灸：直刺5～8分；灸10～20分钟。

功能：培补元气。

主治：下焦虚寒，腰痠腿软，阳萎，遗精，腹胀，便秘，腰背强痛，崩漏，带下，下肢瘫痪等。

大 肠 俞

部位：俯伏或俯卧取穴。在第四腰椎下，督脉阳关旁一寸五分。约与髂嵴平齐（图31）。

穴释：大肠，大肠腑；俞，同输。此穴内应大肠，是大肠之气转输之处，故名大肠俞。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：通调大肠。

主治：腹痛，便秘，泻泄，痢疾，肠痛，痔漏，腰背痠痛，坐骨神经痛，肠炎等。

按语：大肠俞系大肠在背之俞穴。有调理大肠气机的作用。可用于燥热伤津、大便秘结，或水湿偏渗、大便溏泻等症。配中脘、天枢、气海、足三里治疗痢疾、肠炎。配支沟、次髎、天枢、照海治疗便秘。

关 元 俞

部位：俯卧或俯伏取穴。在第五腰椎下，督脉旁一寸五分。骶髂关节上缘凹陷中（图29）。

穴释：关元，元气之机关；俞，同输。此穴与脐下关元相对，有输调元气之功，故名关元俞。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：温肾壮阳。

主治：腹痛，泄泻，遗精，遗尿，尿闭，腰腿痠痛，坐骨神经痛，赤白带下，症瘕，月经不调，盆腔炎，下肢麻痹等。

按语：关元俞有统理下焦气血的功能，尤可调补丹田原气。凡下焦虚寒诸症，皆可选用此穴。配肾俞、上髎、关元治疗少腹

寒痛。配秩边、环跳、承扶、委中、承山治疗腰膝冷痛、下肢痿软和坐骨神经痛。

小 肠 俞

部位：俯卧取穴。在第一骶椎下，督脉旁一寸五分（图29）。

穴释：小肠，小肠腑，俞，转输。此穴内应小肠，是小肠之气转输之处，故名小肠俞。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：清热利湿。

主治：小腹胀痛，小便淋沥，遗尿，尿闭，遗精，消渴，痢疾，赤白带下，盆腔炎等。

按语：小肠俞系小肠在背之俞穴。有调理小肠、分清降浊的作用。配关元、中极、三阴交。复溜治疗尿浊、尿赤、遗尿、尿闭、茎中痛等症。

膀 胱 俞

部位：俯卧取穴。在第二骶椎下，督脉旁一寸五分。骶髂关节下缘凹陷中（图29）。

穴释：膀胱，膀胱腑，俞，转输。此穴内应膀胱，是膀胱之气转输之处，故名膀胱俞。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：疏调膀胱，清热化湿。

主治：尿赤，遗尿，小便不利，遗精，阳萎，泄泻，便秘，会阴部湿痒、肿痛，腰脊痠痛，坐骨神经痛，下肢麻痹等。

按语：膀胱俞系膀胱在背之俞穴。凡由寒热诸因致成膀胱气化失司，证见小便不利、癃闭、频数、失禁，湿热下注之阴部搔痒、肿痛、肾气虚弱之遗精、阳萎等症，皆可取本穴治疗。配关元、中极、三阴交治疗遗尿、尿闭、阳萎、遗精等症。配肾俞、

关元俞、腰眼、阿是治疗腰肌劳损，加配环跳、委中、承山治疗坐骨神经痛、下肢麻痹、瘫痪等。

中 膂 俞

部位：俯卧取穴。在第三骶椎下，督脉旁一寸五分（图29）。

穴释：中膂，脊背中隆起之肌肉；俞，转输。此穴在骶部、脊椎两旁隆起的肌肉之中，有输调腰膂及下焦经气之功能，故名中膂俞。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：清利下焦。

主治：腹痛，泻痢，腰脊强痛，腿痛、麻痹等。

白 环 俞

部位：俯卧取穴。在第四骶椎下，督脉腰俞旁一寸五分凹陷中（图29）。

穴释：白环，白色玉环；俞，转输。此穴在臀部脊椎两旁白肉处，经脉由此回绕如环，上至上髎，有输调白浊、白带之功，故名白环俞。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：疏调下焦。

主治：遗精，疝气，二便不利，腰背痠痛，月经不调，下肢麻痹等。

上 髎

部位：俯卧取穴。在督脉和小肠俞之间，第一骶骨孔凹陷中（图29）。

穴释：上，上端；髎，同窌，骨之空隙。骶骨左右各四孔，此穴在上，故名上髎。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：壮腰补肾，清热利湿。

主治：二便不利，阳萎，遗精，腰腿疼痛，阴门瘙痒，月经不调，赤白带下，子宫脱垂，盆腔炎，下肢麻痹等。

按语：上髎系足太阳膀胱经和足少阳胆经之会穴。与次髎、中髎、下髎合称八髎穴。是治疗妇科和二阴疾患、腰痛 的 常用穴。配关元俞、次髎、中髎、下髎、关元、三阴交治疗遗精、阳萎、盆腔炎，加配中脘治疗子宫脱垂。

次 髎

部位：俯卧取穴。在督脉和膀胱俞之间，第二骶骨孔凹陷中（图29）。

穴释：次，次位，髎，同窠、骨之空隙。此穴在骶骨第二孔中，故名次髎。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：壮腰补肾，清热利湿。

主治：二便不利，肠鸣，泄泻，遗精，阳萎，疝气，腰背疼痛，月经不调，白带，经痛，下肢麻痹等。

中 髎

部位：俯卧取穴。在督脉和中膂俞之间，第三骶骨孔凹陷中（图29）。

穴释：中，中间；髎，同窠、骨之空隙。此穴在骶骨第三孔中，故名中髎。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：壮腰补肾，清热利湿。

主治：二便不利，腹胀，痢疾，泄泻，遗精，阳萎，腰腿疼痛，赤白带下，月经不调，下肢麻痹等。

按语：中髎系足太阳膀胱经和足少阳胆经之会穴。配关元俞、上髎、次髎、归来、三阴交治疗月经不调和赤白带下。

下 髎

部位：俯卧取穴。在督脉腰俞和白环俞之间，第四骶骨孔凹陷中（图29）。

穴释：下，下端；髎，同窌、骨之空隙。此穴在骶骨第四孔为下，故名下髎。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：壮腰补肾，清热利湿。

主治：小腹胀痛，二便不利，肠鸣，泻痢，腰腿痠痛，赤白带下，痛经，盆腔炎，下肢麻痹等。

会 阳

部位：俯卧取穴。在尾骨尖旁约五分凹陷中（图29）。

穴释：会，交会；阳，阳经。此穴在尾骨两旁，足太阳经与督脉交会之处，故名会阳。

针灸：向上直刺1~1.5寸；灸10~20分钟。

功能：壮腰补肾，清热利湿。

主治：泻痢，脱肛，痔漏，便血，阴部汗湿搔痒，白带等。

附 分

部位：俯伏开腠取穴。在第二胸椎下，督脉旁三寸，肩胛边缘（图29）。

穴释：附，附属、附近；分，分支、分界。此穴在第二椎下旁开三寸，膀胱经第二行，即第一行的附属分支，故名附分。

针灸：向下斜刺3~5分；灸5~10分钟。

功能：清热散风，疏经活络。

主治：颈项强痛，肩背挛痛、拘急，上肢麻痹等。

按语：附分系足太阳膀胱经和手太阳小肠经之会穴。功同风门。偏于疏经活络，治疗肩背疼痛、麻木等。配风门、大椎、身柱治疗脊背痠痛，加配肩井、肩髃、肩髃、曲池治疗肘臂麻木。

魄 户

部位：俯伏开腠取穴。在第三胸椎下，督脉身柱旁三寸，肩胛骨边缘（图29）。

穴释：魄，肺藏魄；户，门户。此穴内应肺脏，是肺气出入之门户，故名魄户。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：疏散风热，养阴清肺。

主治：肺癆，咳嗽，哮喘，项强，胸满，肩背痛等。

膏 肓

部位：俯伏开腠取穴。在第四胸椎下，督脉旁三寸，肩胛骨边缘（图29）。

穴释：膏，心下为膏；肓，心下膈上为肓。此穴在心膈之间，故名膏肓。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：清肺养阴，补虚益损。

主治：肺癆，咳嗽，哮喘，吐血，咳血，盗汗，健忘，遗精，肩背痛，支气管炎等。

按语：膏肓有补益气血的作用。对于体弱、虚癯的病人，常作为扶助正气的主穴。配百劳、肺俞、膈俞、肾俞、中府、太渊治疗骨蒸盗汗、咳吐痰血。配定喘、喘息、膻中治疗哮喘。配足三里、关元常灸能健壮身体。

神 堂

部位：俯伏开胛取穴。在第五胸椎下，督脉神道旁三寸，肩胛骨边缘（图29）。

穴释：神，心藏神；堂，官室。此穴内应心脏，是心神朝会之堂，故名神堂。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：清肺宁心，理气安神。

主治：胸满，咳嗽，哮喘，心慌，心痛，脊背强痛等。

谿 謔

部位：俯伏取穴。在第六胸椎下，督脉灵台旁三寸，肩胛骨边缘（图29）。

穴释：谿，伤痛之声；謔，悲欢之声。此穴在第六胸椎旁三寸，压之令人呼“谿謔”，谿謔应手震动，故名谿謔。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：宣肺解表，和胃降逆。

主治：咳嗽，哮喘，热病汗不出，呃逆，呕吐，胸背痛等。

膈 关

部位：俯伏取穴。在第七胸椎下，督脉至阳旁三寸，肩胛骨边缘（图29）。

穴释：膈，横膈；关，关界。此穴内应横膈，是上焦中焦的关界，故名膈关。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：宽胸利膈，和胃降逆。

主治：胸闷，噎膈，呕吐，呃逆，背痛，脊强等。

魂 门

部位：俯伏取穴。在第九胸椎下，督脉筋缩旁三寸（图29）。

穴释：魂，肝藏魂；门，门户。此穴内应肝脏，是肝气出入之门，故名魂门。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：疏肝理气。

主治：胸胁胀痛，腰背痛，饮食不下，尸厥等。

阳 纲

部位：俯伏取穴。在第十胸椎下，督脉中枢旁三寸（图29）。

穴释：阳，腑为阳；纲，纲纪。此穴内应胆腑，为诸阳之纲纪，故名阳纲。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：清肝胆热。

主治：腹痛，腹胀，背痛，黄疸，泄泻，饮食不下等。

按语：阳纲有清利肝胆湿热的作用，配至阳、膈俞、肝俞、脾俞、期门、中脘、足三里治疗黄疸性肝炎。

意 舍

部位：俯伏取穴。在第十一胸椎下，督脉脊中旁三寸（图29）。

穴释：意，脾藏意；舍，居室。此穴内应脾脏，是脾气居留之舍，故名意舍。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：调和脾胃。

主治：腹满，呕吐，肠鸣，泄泻，食欲不振，背痛等。

胃 仓

部位：俯卧取穴。在第十二胸椎下，督脉旁三寸（图29）。

穴释：胃，胃腑；仓，胃为仓廩之官。此穴内应胃腑，是胃气之仓，故名胃仓。

针灸：向下斜刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：和中理气。

主治：胃痛，腹满，水肿，食积，便秘，背痛等。

按语：胃仓有理气和中的作用。长于胃痛、腹胀的治疗。配脾俞、育门、中脘、三关治疗小儿食积。

育 门（痞根）

部位：俯卧取穴。在第一腰椎下，督脉悬枢旁三寸（图29）。

穴释：育，膜也；门，门户。此穴内应三焦，上有膏育、下有胞育、前有育俞，是三焦之气通向诸育之门，故名育门。

针灸：向下斜刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：通调肠胃，化滞消痞。

主治：胃痛，痞块，食积，腹胀，便秘，消化不良等。

志 室（精宫）

部位：俯卧取穴。在第二腰椎下，督脉命门旁三寸（图29）。

穴释：志，肾藏志；室，居处。此穴内应肾脏，是肾之精气储藏之室，故名志室。

针灸：直刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：补肾培元。

主治：阳萎，遗精，小便淋沥，阴肿，阴痛，水肿，腹胀，遗尿，尿闭，腰背强痛，腰肌劳损，肾炎等。

按语：志室功同肾俞。长于壮腰补肾。配肾俞、关元俞、腰

眼、阿是治疗腰肌劳损。

胞 育

部位：俯卧取穴。在第二骶椎下，督脉旁三寸凹陷中（图29）。

穴释：胞，膀胱；育，膜也。此穴内应膀胱，是膀胱之气转输之处，故名胞育。

针灸：直刺1～2寸；灸5～10分钟。

功能：疏调下焦。

主治：腹胀，阴肿，遗尿，二便不利，腰脊强痛，坐骨神经痛，下肢麻痹等。

秩 边

部位：俯卧取穴。在第四骶椎下，督脉腰俞旁三寸（图29）。

穴释：秩，秩序；边，边际。此穴在背部膀胱经，依次序排列到最下边际之处，故名秩边。

针灸：直刺1～3寸；灸10～20分钟。

功能：壮腰补肾，疏通经络。

主治：腰脊痠痛，二便不利，坐骨神经痛，下肢瘫痪等。

按语：秩边有疏经通络之功。配关元、俞、胞育、环跳、承扶、委中、承山治疗坐骨神经痛和下肢麻痹。

承 扶

部位：俯卧屈膝取穴。在臀下横纹中央，大筋外侧凹陷中（图29）。

穴释：承，承受；扶，扶护。此穴在臀下横纹中，有承受上身扶护下肢之功，故名承扶。

针灸：直刺1～2寸；灸5～10分钟。

功能：疏经活络。

主治：腰臀痠痛，二便不利，痔疮，坐骨神经痛，下肢酸痛、麻痹等。

殷 门

部位：俯卧屈膝取穴。在承扶下六寸两筋之间（图29）。

穴释：殷，丰厚；门，门户。此穴在大腿后面肌肉丰满肥厚处，是膀胱经脉气通行之门，故名殷门。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：疏通经络。

主治：腰脊强痛，坐骨神经痛，下肢痠痛、麻痹等。

浮 郄

部位：微屈膝取穴。在委阳内上方一寸，两筋之间凹陷中（图29）。

穴释：浮，浅浮；郄，孔隙。此穴在委阳上一寸，经气从承扶顺流直下，至此而浅浮，故名浮郄。

针灸：直刺1~1.5寸；灸3~5分钟。

功能：疏筋利节。

主治：腹痛，吐泻，腿膝挛痛，下肢麻痹等。

委 阳

部位：屈膝取穴。在膝窝横纹外侧端，两筋间凹陷中（图29）。

穴释：委，曲也；阳，阳经、外侧。此穴曲膝在委中之外侧，故名委阳。

针灸：直刺1~1.5寸；灸3~5分钟。

功能：疏筋利节。

主治：腰痛，小便不利，腹痛，下肢挛痛、麻痹等。

按语：委阳系三焦下合穴。配中脘、天枢、阿是治疗腹痛。
配秩边、承山、三阴交治疗腓肠肌痉挛。

委 中

部位：俯卧避开动脉取穴。在膝窝横纹中央。动脉侧凹陷中（图29）。

穴释：委，曲也；中，正中。此穴曲膝在腘窝横纹中央，故名委中。

针灸：直刺1~1.5寸或点刺出血。

功能：清热散邪，疏筋利节。

主治：腰背痛，膝肿痛，腹痛吐泻，下肢挛痛、麻痹等。

按语：委中系膀胱经之合穴。是有名的“四总”穴之一，为治疗腰背病症的主穴。配肾俞、关元俞治疗腰痛。配尺泽点刺出血治疗暑热和腹痛吐泻。

合 阳

部位：俯卧取穴。在委中下二寸，分肉间凹陷中（图29）。

穴释：合，会合，阳，太阳。足太阳经两条支脉会于腘中，至此合行向下，故名合阳。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：疏筋利节。

主治：腰脊强痛，功能性子宫出血，下肢痠痛、麻痹等。

承 筋

部位：俯卧取穴。在委中下五寸，小腿肚中央（图29）。

穴释：承，承受；筋，经筋。此穴在腓肠足太阳经筋所结之处，能承受全身重力，故名承筋。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：疏筋利节。

主治：腰痛，便秘，下肢痠痛、麻痹、转筋、抽筋等。

承 山

部位：俯卧取穴。在委中（下八寸）与外踝尖之间凹陷中。

用力提脚跟，向后翘脚尖，人字形凹陷最明显（图32）。



穴释：承，承受；山，高山。此穴在丰肉似山的腓肠下，能承受全身重力，故名承山。

针灸：直刺1~2寸；灸5~10分钟。

功能：疏筋利节。

主治：腰痛、痔疮、脱肛、便秘，脚气，足跟肿痛，坐骨神经痛，

下肢肿痛、麻痹、瘫痪、转筋、抽筋等。

按语：承山功同委中。而偏于治疗小腿转筋及肛门病症。配会阳、长强、大肠俞治疗脱肛、痔疮等。配关元俞、阿是、手小指治疗腰背扭伤之疼痛。

飞 扬

部位：俯卧卷足取穴。在承山外下方约一寸，昆仑上七寸，两筋间凹陷中（图29）。

穴释：飞，飞翔；扬，举也。此穴为足太阳之络，可沟通少阴与阳跷，有助跑跳捷步如飞之功，故名飞扬。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：疏经活络。

主治：腰痛，痔疮，膀胱炎，下肢麻痹、肿痛、抽筋等。

按语：飞扬系膀胱经之络穴，别走足少阴肾经。配秩边、环跳、承山治疗下肢麻木和坐骨神经痛。

跗 阳

部位：俯卧或垂足取穴。在昆仑上三寸，筋骨之间（图29）。

穴释：跗，跗骨；阳，外侧、阳经。此穴在跗骨上方之外侧，故名跗阳。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：疏筋利节。

主治：腰痛，下肢痠痛、瘫痪，外踝肿痛，脚气等。

按语：跗阳系阳跷脉之郄穴。配秩边、环跳、飞扬治疗下肢外侧疼痛、麻木等症。

昆 仑

部位：垂足取穴。在外踝尖后，脚跟上的大筋（跟腱）前凹陷中（图29）。

穴释：昆仑，高山名。此穴在似高山的外踝尖后，故名昆仑。

针灸：直刺0.5~1寸；灸5~10分钟。

功能：疏筋利节，解表散寒。

主治：头痛，项强，腰背强痛，坐骨神经痛，阴部肿痛，难产，胎衣不下，足跟肿痛，脚气，下肢瘫痪、麻痹等。

按语：昆仑系膀胱经之经穴。有疏通经络的作用。配肾俞、关元俞、阿是治疗腰背痛。配次髎、会阳、曲骨治疗阴部肿痛。

仆 参

部位：垂足取穴。在昆仑直下约二寸，跟骨下赤白肉际凹陷中（图29）。

穴释：仆，侍从；参，参见。此穴在跟骨外侧，仆人参见下跪时显露之处，故名仆参。

针灸：直刺3～5分，灸3～5分钟。

功能：疏经活络，开窍醒神。

主治：晕厥，癫痫，精神病，脚气，足跟肿痛，下肢麻痹等。

按语：仆参系阳跷脉之本。功同昆仑。但有治疗癫痫、晕厥、精神病等的作用。配承山、飞扬、昆仑、太溪治疗足跟肿痛不得着地。配人中、合谷、太冲治疗癫狂症。

申 脉

部位：垂足取穴。在外踝直下，赤白肉际凹陷中（图29）。

穴释：申，申时；脉，经脉。此穴在足太阳膀胱经，气血申时流注于本脉，故名申脉。

针灸：直刺0.5～1寸，灸5～10分钟。

功能：祛散风寒，疏经活络。

主治：头痛，眩晕，热病恶寒，癫痫，瘧病，精神病，腰腿痠痛，下肢麻木、无力、瘫痪等。

按语：申脉系阳跷脉之所生，为八脉交会穴之一，通阳跷脉。配后溪治疗感冒、眩晕、癫痫等病。配悬钟、环跳治疗半身不遂之腿、脚不收和足内翻。

金 门

部位：垂足取穴。在第五跖骨粗隆后方，赤白肉际凹陷中（图29）。

穴释：金，申支属金；门，门户。此穴在膀胱经，申时气血注此，为经气通行之门，故名金门。

针灸：直刺3～5分，灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：昏厥，癫痫，惊风，腿痛，转筋，麻痹等。

按语：金门系膀胱经之郄穴，阳维脉之所生。配人中、合谷、中冲治疗昏厥和小儿惊风。

京 骨

部位：伸趾取穴。在第五跖骨粗隆前下方，赤白肉际凹陷中（图29）。

穴释：京骨，小趾外侧本节后大骨，谓之京骨。此穴在京骨后，故名京骨。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风，疏经活络。

主治：头痛，项强，目痛，眩晕，心痛，腰膝痠痛，腿脚挛痛等。

按语：京骨系膀胱经之原穴。有疏经络，通心脉的作用。配风池、后溪、阿是治疗头痛、项背强痛。配心俞、内关、膻中治疗心痛。

束 骨

部位：垂足取穴。在第五跖骨小头后下方，赤白肉际凹陷中（图29）。

穴释：束骨，小趾外侧本节，谓之束骨。此穴在束骨后，故名束骨。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风，疏经活络。

主治：头痛，项强，目赤，目眩，目黄，耳聋，腰痛，小腿痠痛、抽筋等。

按语：束骨系膀胱经之俞穴。有清热利湿之功。配肝俞、胆

俞、期门、中脘、阳陵泉治疗身热、目黄。

足 通 谷

部位：屈趾取穴。在第五跖趾关节前下方，横纹头凹陷中（图29）。

穴释：通，通行；谷，山谷。此穴在小趾本节前陷中，足太阳所溜之荣，故名通谷。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风，疏经活络。

主治：头痛，目眩，颈项强痛，足趾肿痛等。

按语：足通谷系膀胱经之荣穴。可疏风清热。配申脉、天柱、攒竹、太阳治疗头痛目眩。

至 阴

部位：伸趾取穴。在足小趾外侧，趾甲角外约一分（图29）。

穴释：至，到也；阴，阴经。此穴在小趾外侧端，足太阳经终止而交至少阴经，故名至阴。

针灸：向下斜刺1～2分或点刺出血；灸3～5分钟。

功能：清热散风，通利下焦。

主治：头痛，眩晕，目痛，鼻塞，遗精，尿闭，滞产，难产，胞衣不下，胎位不正等。孕妇禁针。

按语：至阴系膀胱经之井穴。是远距离取穴（上病取下）的常用穴，对于头、面诸疾均可选配此穴。灸本穴尚有矫正胎位的作用。配风池、瞳子髎、攒竹治疗头痛、目痛。

第八节 足少阴肾经

本经起于涌泉终于俞府，左右共54穴。取涌泉、然谷、太太

溪、复溜、阴谷为井、荣、俞、经、合。本穴阴谷，络穴大钟，俞穴肾俞，募穴京门，郄穴水泉。

循行概述：起于涌泉，沿着脚心及下肢内侧后缘上行，过脚跟、内踝后、膝股内侧、会阴、脐旁至胸部俞府。从胸部入肺的支脉，联络心脏，注于胸中，和手厥阴经相接。入肺的支脉，沿喉咙至舌根两侧。会阴部的支脉，从长强入里归属肾脏，联络膀胱（图33）。

生理功能：肾居下焦，内藏元阴元阳，为水火之脏，和膀胱互为表里，开窍于耳。主藏精，为生殖发育之源，先天之本。主骨，生髓，司听力和体内津液之平衡，有润养五脏之功能。

病理症候：经络症：咽喉肿痛，下肢内侧后缘肾经循行线之肿痛、麻痹、厥冷，足心热痛。

脏腑症：咳血，气喘，水肿，便秘，或泄泻，遗精，阳痿，心悸，恐惧，腰痠，腿软，耳鸣，眼花，口干舌燥，目视不清。肾气竭绝，则不能营养骨髓而骨枯，肌肉无所附着而退缩，可见齿松无华，发枯不润。

肾经穴歌：

少阴肾经二十七，涌泉然谷与太溪。
大钟水泉通照海，复溜交信筑宾抵。
阴谷膝内辅骨后，以上从足走至膝。
横骨大赫连气穴，四满中注育俞脐。
商曲石关阴都密，通谷幽门一寸取。
步廊神封膺灵墟，神藏或中俞府毕。

涌泉

部位：仰卧屈足卷趾取穴。在足心前凹陷中（图33）。

穴释：涌，涌出；泉，喷水之泉。此穴在足心，肾经脉气如泉水自此涌出，故名涌泉。

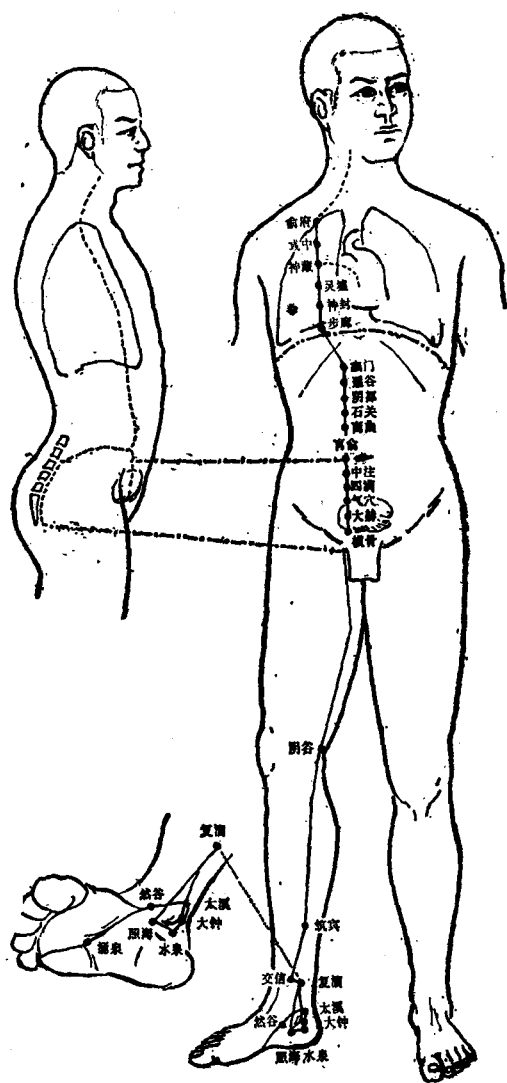


图33 足少阴肾经循行示意图和腧穴

针灸：直刺5～8分，灸3～5分钟。

功能：清热醒神，交济心肾。

主治：头痛，目眩，中风，昏迷，休克，身热，咽喉肿痛，小便不利，水肿，黄疸，小儿惊风，瘧病，足趾痛不能履地等。

按语：涌泉系肾经之井穴。有开窍醒神、交济水火的作用。虚火上炎可壮水制火，实火炽盛能釜底抽薪。刺灸按摩的效果可直达颠顶。配百会、人中、合谷治疗瘧病。配颊车、翳风、合谷治疗咽喉肿痛。配人中、十宣、合谷治疗小儿惊风和休克。

然 谷

部位：仰卧取穴。在内踝前舟骨下凹陷中（图33）。

穴释：然，然骨，今称舟骨；谷，山谷空洞。此穴在然骨下凹陷处，故名然谷。

针灸：直刺5～8分，灸3～5分钟。

功能：滋阴补肾，清热利湿。

主治：咽喉肿痛，咳血，心痛，遗精，阳萎，泻痢，自汗，盗汗，消渴，小儿脐风，阴痒，月经不调，足跗肿痛，脚气等。

按语：然谷系肾经之荥穴。既可滋阴清热，又可益火祛寒。配人中、合谷治疗小儿脐风。配肾俞、关元俞、关元治疗遗精、阳萎。

太 溪

部位：垂足取穴。在内踝尖后、脚跟上的大筋（跟腱）前凹陷中（图33）。

穴释：太，大之甚也；溪，水沟。此穴在内踝后如溪的凹陷中，故名太溪。

针灸：直刺5～8分，灸3～5分钟。

功能：滋阴补肾，清热利湿。

主治：咽喉肿痛，心痛，咳嗽，遗尿，尿频，浮肿，阳萎，遗精，耳聋，牙痛，失眠，膀胱炎，肾炎，神经衰弱，月经不调，下肢麻痹，足跟肿痛等。

按语：太溪系肾经之俞穴，又是原穴。可调治三焦，滋阴补肾。配水分、气海、水道治疗水湿泛滥，周身浮肿。配膀胱俞、中极、水道治疗尿路感染和膀胱炎。

大 钟

部位：垂足取穴。在太溪下五分，跟腱内侧缘凹陷中（图33）。

穴释：大，高大；钟，同鍾、踵。此穴在足踵部，是肾藏精气之处，故名大钟。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：滋肾清肺。

主治：咽喉肿痛，哮喘，咳血，尿闭，遗尿，痴呆嗜卧，足跟肿痛等。

按语：大钟系肾经之络穴，别走足太阳膀胱经。配关元、中极、三阴交治疗遗尿、尿闭。

水 泉

部位：垂足取穴。在太溪下一寸陷中（图33）。

穴释：水，肾属水；泉，喷泉。此穴在足跟，肾之经气如泉水由此上行，故名水泉。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：调补肝肾。

主治：目视不明，小便不利，月经不调，经闭，痛经，子宫脱垂等。

按语：水泉系肾经之郄穴。配提托、归来、关元、三阴交治

疗子宫脱垂、经闭和痛经。

照 海

部位：仰卧或垂足取穴。在内踝直下约一寸，距骨下凹陷中（图33）。

穴释：照，明照；海，水归聚之处。此穴在肾经属水，内寓真阳，明照周身，故名照海

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：滋阴补肾，清热利湿。

主治：遗尿，疝气，便秘，癰痛，瘰病，眩晕，失眠，咽喉肿痛，神经衰弱，阴痒，阴痛，子宫脱垂，白带，月经不调，半身不遂，瘫痪引起的足外翻等。

按语：照海系阴跷脉之所生，八脉交会穴之一，通阴跷脉。有清心神、利咽喉、泄湿热的作用。配翳风、列缺、合谷治疗咽喉肿痛。配纠正外翻、三阴交治疗瘫痪引起的足外翻。

复 溜

部位：垂足取穴。在太溪上二寸，跟腱前缘（图33）。

穴释：复，复返；溜，同流。此穴在内踝上，肾经在内踝往复返还溜行之处，故名复溜。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：滋阴补肾，清热利湿。

主治：水肿，腹水，腹胀，泻痢，尿道感染，消渴，淋病，尿闭，舌干，视力减退，盗汗，自汗，肾炎，小儿麻痹后遗症，月经不调，足萎，小腿寒冷，下肢浮肿等。

按语：复溜系肾经之经穴。有培补肾气之作用。治疗肾阴亏损，或水道不通，寒湿停滞或湿热下注。配水分、水道、中极治疗腹水和下肢浮肿。配合谷可止汗。

交 信

部位：垂足取穴。在内踝尖上二寸，复溜前五分 胫骨后缘（图33）。

穴释：交，交会；信，信息。此穴与复溜相并、相交，并与三阴交互通信息，故名交信。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：调补肝肾。

主治：睾丸肿痛，淋病，二便不利，痢疾，胫骨内侧痛，月经不调，经闭，崩漏，白带，子宫脱垂等。

按语：交信系阴跷脉之郄穴。配中脘、归来、关元治疗子宫脱垂。

筑 宾

部位：垂足取穴。在内踝尖上五寸，胫骨后约二横指（图33）。

穴释：筑，建筑；宾，客也。此穴属肾经为主，又是阴维脉之郄为客，似在肾经上筑一宾馆，迎接阴维脉之来临，故名筑宾。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：调补肝肾，清热利湿。

主治：癫痫，瘰病，疝气，腹痛，遗尿，肾炎，膀胱炎，小腿痠痛、无力等。

按语：筑宾系阴维脉之郄穴，又是足少阴肾经和阴维脉之会穴。配肾俞、膀胱俞、中极治疗膀胱炎。

阴 谷

部位：外展微屈膝取穴。在膝窝内侧横纹头，两筋（半腱肌腱与半膜肌腱）之间凹陷中（图34）。

穴释：阴，阴经；谷，山谷空洞。此穴在足少阴经腠横纹内

侧两筋间空陷处，故名阴谷。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：调补肝肾，清热利湿。

主治：阳萎，疝气，阴囊湿痒，小便频急，遗尿，尿闭，腹胀，崩漏，赤白带下，膝内侧痛等。

按语：阴谷系肾经之合穴。有升举下焦、清利湿热之功。配水道、中极、复溜治疗小便短赤涩痛，加配关元、肾俞、上髂治疗白带过多、阴痒和阴囊湿疹。



图34 阴谷穴

横 骨

部位：仰卧取穴。在任脉曲骨旁一寸，耻骨上缘（图33）。

附注：肾经由横骨至育俞的横寸，有几种不同的记载：《内经》、《甲乙经》、《千金方》、《外台》、《铜人》、《十四经发挥》、《类经图翼》、《医宗金鉴》等书为去中行五分；《针灸大成》为去中行一寸。根据临床应用，本书为任脉旁一寸。

穴释：横骨，耻骨谓之横骨。此穴在横骨上缘，故名横骨。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：调补肝肾，清热利湿。

主治：小腹胀痛，遗精，阳萎，小便不利，阴肿，偏坠，淋病，遗尿，盆腔炎，经闭，月经不调等。

按语：横骨系足少阴肾经和冲脉之会穴。配中极、三阴交治疗遗尿。

大 赫

部位：仰卧取穴。在横骨上一寸，任脉中极旁一寸（图33）。

穴释：大，高大；赫，显赫。此穴在小腹，是足少阴、冲脉之会，妇女妊娠后，此处突起高大，显而易见，故名大赫。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：调补肝肾，清热利湿。

主治：阳萎，遗精，阴茎痛，月经不调，赤白带下，子宫脱垂等。

按语：大赫系足少阴肾经和冲脉之会穴。配气海、关元、三阴交治疗月经不调及阴茎痛。

气 穴

部位：仰卧取穴。在大赫上一寸，任脉关元旁一寸(图33)。

穴释：气，原气；穴，孔穴。此穴是足少阴与冲脉之会，下焦元气归聚之处，故名气穴。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：调补肝肾，温经散寒。

主治：遗精，遗尿，小便不通，腹痛，泄泻，月经不调，经闭，痛经，子宫寒冷，不孕症等。

按语：气穴系足少阴肾经和冲脉之会穴。配中脘、天枢、关元、三阴交、合谷治疗经闭和不孕症。

四 满

部位：仰卧取穴。在气穴上一寸，任脉石门旁一寸(图33)。

穴释：四，四方精神气血；“满”，充满。此穴在丹田旁，精气充满之处，故名四满。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：调补肝肾。

主治：遗精，疝气，脐下积聚，腹痛，月经不调，功能性子宫出血等。

按语：四满系足少阴肾经和冲脉之会穴。配膈俞、肝俞、关元、三阴交、隐白治疗功能性子宫出血。

中 注

部位：仰卧取穴。在四满上一寸，任脉阴交旁一寸(图33)。

穴释：中，中间；注，灌注。此穴在人身中部，是肾气注入冲脉之处，故名中注。

针灸：直刺0.5~1寸；灸5~10分钟。

功能：调补肝肾。

主治：疝气，腹痛，便秘，小便淋沥，月经不调等。

按语：中注系足少阴肾经和冲脉之会穴。配关元俞、上髎、关元、三阴交治疗月经不调。

育 俞

部位：仰卧取穴。在中注上一寸，任脉神阙（肚脐）旁一寸，腹直肌内缘（图33）。

穴释：育，育膜；俞，同输。此穴在脐旁，是肾气深入输注育膜之处，故名育俞。

针灸：直刺0.5~1寸；灸5~10分钟。

功能：调肠理气。

主治：腹痛，便秘，疝气痛，肠炎，月经不调等。

按语：育俞系足少阴肾经和冲脉之会穴。配横骨、大敦治疗疝气痛。

商 曲

部位：仰卧取穴。在育俞上二寸，任脉下脘旁一寸，腹直肌内缘（图33）。

附注：肾经由商曲至幽门的横寸，有几种不同的记载：《内经》、《甲

乙经》、《千金方》、《外台秘要》、《铜人腧穴图经》、《十四经发挥》、《医宗金鉴》等书为去任脉中行五分，《针灸大成》、《针灸大全》等书为去任脉中行一寸五分；根据临床应用，本书为任脉旁一寸，腹直肌内缘。

穴释：商，大肠属金，其音为商；曲，弯曲。此穴在腹部，内应大肠曲折之处，故名商曲。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃肠。

主治：消化不良，腹痛，腹中积聚，泄泻，便秘等。

按语：商曲系足少阴肾经和冲脉之会穴。配中脘、阿是、足三里、三阴交治疗气滞血瘀之腹痛拒按。

石 关

部位：仰卧取穴。在商曲上一寸，任脉建里旁一寸，腹直肌内缘（图33）。

穴释：石，同食；关，关口。此穴在腹部，内应胃脘，是受纳饮食之关，故名石关。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃肠。

主治：胃痛，呃逆，呕吐，食欲不振，腹痛，消化不良等。

按语：石关系足少阴肾经和冲脉之会穴。配内关、中脘、足三里治疗腑气不通、胃痛、呕吐。

阴 都

部位：仰卧取穴。在石关上一寸，任脉中脘旁一寸，腹直肌内缘（图33）。

穴释：阴，阴经；都，都邑。此穴在腹部，是胃、脾、肾、冲脉之都会，故名阴都。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃肠。

主治：胃痛，胁痛，腹痛，腹胀，消化不良等。

按语：阴都系足少阴肾经和冲脉之会穴。配中脘、下脘、足三里治疗腹痛和消化不良。

通 谷

部位：仰卧取穴。在阴都上一寸，任脉上脘旁一寸，腹直肌内缘（图33）。

穴释：通，通过；谷，同穀。此穴内应胃腑，是水谷通过之处，故名通谷。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：调理胃肠。

主治：胃痛，呕吐，腹痛，消化不良，急、慢性胃炎等。

按语：通谷系足少阴肾经和冲脉之会穴。配上脘、建里、天枢、足三里治疗消化不良。

幽 门

部位：仰卧取穴，在通谷上一寸，任脉巨阙旁一寸，肋骨边缘（图33）。

穴释：幽，两阴交尽曰幽；门，门户。此穴在上腹部，是冲脉与肾经交会的尽处，又是胃气出入之门，故名幽门。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：调理胃肠。

主治：胸痛，胃痛，腹胀，呃逆，呕吐，食积，消化不良，胃溃疡等。

按语：幽门系足少阴肾经和冲脉之会穴。配上脘、中脘、梁丘、足三里治疗胃脘痛。

步 廊

部位：仰卧取穴。在任脉中庭旁二寸，第五肋间隙中(图33)。

穴释：步，度量；廊，庭外长廊。此穴在中庭外，肾经各穴从步廊至俞府，均等距离按顺序排列，如庭廊相对，故名步廊。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宣肺理气。

主治：胸胁胀痛，咳嗽，哮喘，气短，呃逆，呕吐，心悸等。

按语：步廊配心俞、内关治疗心悸。

神 封

部位：仰卧取穴。在任脉膻中与乳头之间，第四肋间隙中(图33)。

穴释：神，心藏神；封，封藏。此穴在胸部，内应心脏，是心神封藏之处，故名神封。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宣肺理气，宁心安神。

主治：胸胁胀痛，咳嗽，哮喘，呕吐，肋间神经痛，心动过速，支气管炎，乳痛，乳汁不足等。

按语：神封与步廊皆有通经活络、宽胸利膈的作用。为治疗肋间神经痛和心脏病的常用配穴。配膈俞、肝俞、膻中、支沟治疗肋间神经痛。

灵 墟

部位：仰卧取穴。在任脉玉堂旁二寸，第三肋间隙中(图33)。

穴释：灵，心灵；墟，居处。此穴内应心脏，是心灵隐居之处，故名灵墟。

针灸：向下斜刺 3～5 分；灸 3～5 分钟。

功能：宣肺理气。

主治：咳嗽，哮喘，呕吐，胸肋胀痛，乳痈，乳汁不足等。

神 藏

部位：仰卧取穴。在任脉紫宫旁二寸，第二肋间隙中（图 33）。

穴释：神，心神；藏，隐藏。此穴内近心脏，是心神隐藏之处，故名神藏。

针灸：向下斜刺 3～5 分；灸 3～5 分钟。

功能：宣肺理气。

主治：咳嗽，哮喘，胸肋胀痛，心慌，气短，支气管炎等。

按语：神藏有平喘降逆、通经活络之功。配百劳、定喘、肺俞、膻中、太渊治疗咳嗽哮喘。

彧 中

部位：仰卧取穴。在任脉华盖旁二寸，第一肋间隙中（图 33）。

穴释：彧，繁华茂盛；中，胸中。此穴在胸部，是心神肺气聚集与输布之处，故名彧中。

针灸：向下斜刺 3～5 分；灸 3～5 分钟。

功能：宣肺理气。

主治：咳嗽，哮喘，痰壅，胸肋胀痛，支气管炎等。

俞 府

部位：仰卧取穴。在任脉璇玑旁二寸，锁骨下缘凹陷中（图 33）。

穴释：俞，同输；府，府库。此穴在胸部，是肾经、心包络

经、心血、肺气会聚、转输之处，故名俞府。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宣肺理气。

主治：咳嗽，哮喘，胸肋胀痛，呕吐，支气管炎等。

第九节 手厥阴心包络经

本经起于天池终于中冲，左右共18穴。取中冲、劳宫、大陵、间使、曲泽为井、荣、俞、经、合。本穴劳宫，络穴内关，俞穴厥阴俞，募穴膻中，郄穴郄门。

循行概述：起于胸部天池，沿着腋窝及上肢内侧心、肺二经之间下行，过肘、腕、掌心至中指端中冲。掌心的支脉，从劳宫走向无名指外侧端和手少阳经相接。胸部的支脉，入里归属心包络，向下联络上、中、下三焦（图35）。

生理功能：心包居于胸中，护于心脏之外，和三焦互为表里，代心行事。

病理症候：经络症：腋下肿，肘、臂拘急或痉挛，掌心发热。

脏腑症：心痛，胸闷，心悸，烦躁，喜笑无常，癫狂。心包络气竭绝，则阳反独留，形体如烟熏，目直视、摇头。

心包络经穴歌：

九穴心包手厥阴，天池天泉曲泽深；

郄门间使内关对，大陵劳官中冲寻。

天 池

部位：仰卧取穴。在乳头外约一寸，第四肋间隙中（图35）。

穴释：天，胸居上焦为天；池，水池。此穴在乳旁凹陷中，是乳汁贮存之处，故名天池。

和足厥阴肝经之会穴。有清热除烦，宽胸理气之功。配心俞、厥阴俞、内关治疗胸满，心烦和心痛。

天 泉

部位：垂臂取穴。在臂前面腋横纹下二寸，两筋之间（图35）。

穴释：天，高上为天；泉，水源。此穴在上肢腋下，经气如瀑布自上而下，故名天泉。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：疏经活络。

主治：心痛，咳嗽，胸胁胀痛，臂内侧痛等。

曲 泽

部位：屈肘取穴。在肘窝横纹中央，大筋（肱二头肌腱）内侧凹陷中（图35）。

穴释：曲，屈曲；泽，湖泽。此穴屈肘在肘窝横纹凹陷正中，与尺泽相平，故名曲泽。

针灸：直刺5～8分或点刺出血。

功能：清热除烦，疏筋活血。

主治：心痛，心悸，胃痛，腹痛，腹泻，呕吐，身热，烦渴，臂肘挛痛等。

按语：曲泽系心包络经之合穴。有通心络、除烦热、利暑湿的作用。配心俞、膻中、内关治疗心胸疼痛、胸满烦热。配委中点刺放血治疗暑温高热，上吐下泻。

郄 门

部位：仰掌取穴。在大陵后五寸，两筋之间（图35）。

穴释：郄，孔隙；门，门户。此穴在腕后五寸两筋如门的凹

陷中，又是郄穴，故名郄门。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：宁心安神，调理气血。

主治：胸满，心痛，心悸，呕血，鼻衄，癰疽，瘰癧等。

按语：郄门系心包络经之郄穴。有降逆除烦，通经活络的作用。配天池、心俞治疗心痛。

间 使

部位：仰掌取穴。在大陵后三寸，两筋之间（图35）。

穴释：间，间隙；使，臣使。此穴在腕后三寸两筋间，心包为臣使之官，故名间使。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：清热化痰，宁心安神。

主治：心痛，心悸，胃痛，呕吐，中风，昏迷，癰疽，瘰癧，精神病，疟疾，热病，小儿惊风，肘臂挛痛等。

按语：间使系心包络经之经穴。有祛痰开窍，养心安神之功。配人中、合谷、丰隆治疗痰蒙心窍之癰狂、瘰癧等症。配心俞、膻中、乳根、神封治疗心动过速、心律不齐。

内 关

部位：仰掌取穴。在大陵后二寸，两筋之间，仰掌握拳两筋显出之浅沟凹陷处（图35）。

穴释：内，内侧；关，关口，此穴在腕后内侧，是心主通三焦与阴维脉之关，故名内关。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：理气降逆，宁心安神，镇痉止痛。

主治：心绞痛，心悸，怔忡，无脉症，胃痛，呃逆，呕吐，胸胁胀痛，昏迷，眩晕，失眠，疟疾，热病，中暑，癰疽，瘰癧，

精神病，心动过速，急性胃肠炎，神经衰弱，小儿惊风，肘臂挛痛、麻痹等。

按语：内关系心包络经之络穴。别走手少阳三焦经，又是八脉交会穴之一，通阴维脉。有宁心安神、疏肝降逆、调和脾胃、活血通络之功。是治疗胸满胁痛、呃逆呕吐、胃脘胀痛等症的常用穴。古书有“治心痛、胸胁诸疾”及“胸胁内关谋”等句。足证该穴是治疗上、中二焦疾病的重要穴位，尤其对上实中满的实证见长。临床配厥阴俞、心俞、膻中、乳根治疗心悸不安和心绞痛。配膈俞、肝俞、中脘、公孙治疗恶心呕吐。配曲池、百会、丰隆治疗高血压。配膻中、期门、肝俞、膈俞治疗胸胁痛。

大 陵

部位：仰掌取穴。在手掌面的腕横纹正中，两筋之间凹陷中（图35）。

穴释：大，高大；陵，丘陵。此穴在掌后似丘陵的隆起之下，故名大陵。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：理气活血，宁心安神，清热散邪。

主治：心痛，心悸，癫痫，癰病，胃痛，中暑，头痛，热病汗不出，咽喉肿痛，呕吐，胸胁痛，神经衰弱，肘、臂、手挛痛等。

按语：大陵系心包络经之俞穴，也是本经原穴。功同内关。但偏于安神定志，疏通心络。配人中、内关、合谷治疗癰病。

劳 宫

部位：仰掌屈指取穴。在中指和无名指之间，掌心内第一道横纹的凹陷中（图35）。

穴释：劳，劳作；宫，宫室。此穴在掌心凹陷中，用手劳作

时握物之处，故名劳宫。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：活血开窍，清热散邪。

主治：心痛，呕吐，胸胁痛，胃痛，大小便带血，鼻衄，黄疸，癰疽，瘰癧，热病汗不出，中风，昏迷，手掌多汗，鹅掌风等。

按语：劳宫系心包络经之荣穴。有开窍醒神的作用。配人中、神门、合谷治疗瘰癧、哭笑无常。

中 冲

部位：伸指取穴。在中指尖正中，指甲前约一分（图35）。

穴释：中，中指；冲，冲出。此穴在中指尖端，是心包络经所出之井，故名中冲。

针灸：斜刺1～2分或点刺出血。

功能：活血开窍，清热散邪。

主治：心痛，心烦，热病汗不出，中风，中暑，昏迷，晕厥，休克，吐泻，癰疽，瘰癧，急、慢性惊风等。

按语：中冲系心包络经之井穴。有醒神救脱之功。常用于中风昏迷，晕厥、休克等神志不清诸症。配人中、内关、合谷治疗小儿惊风，配十宣、人中治疗中暑、中风之昏迷。

第十节 手少阳三焦经

本经起于关冲终于丝竹空，左右共46穴。取关冲、液门、中渚、阳池、支沟、天井为井、荣、俞、原、经、合。本穴支沟，络穴外关，俞穴三焦俞，募穴石门，郄穴会宗。

循行概述：起于关冲，沿着无名指及上肢外侧大、小肠二经之间上行，过腕、肘、肩、颈、耳后、耳前至眉外丝竹空和足少

阳经相接。肩上的支脉，由天髎交会肩井与大椎。然后从缺盆入里联络心包络，向下归属上、中、下三焦（图36）。

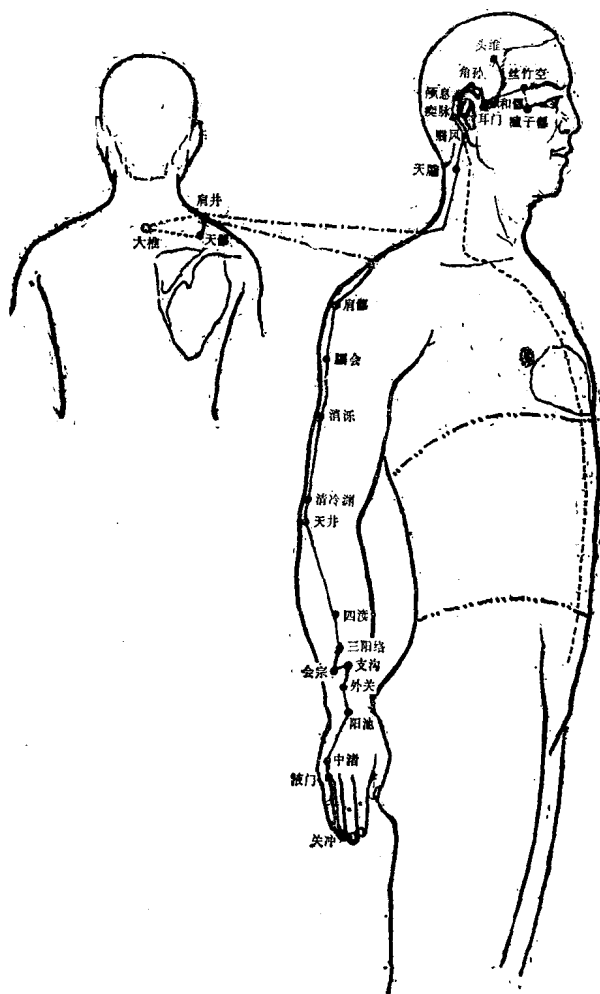


图36 手少阳三焦经循行示意图和腧穴

生理功能：三焦有上、中、下之分，和心包络互为表里。主通调水道。

病理症候：经络症：耳聋，耳鸣，外眼角痛，咽喉肿痛，咽梗，颊肿，耳后和肩、臂、肘外侧至无名指等三焦经循行线之肿痛、麻痹。

脏腑症：腹胀，水肿，遗尿，小便不利。三焦气竭绝：上焦竭则善噫，中焦竭则不能消谷，下焦竭则遗尿失便。

三焦经穴歌：

二十三穴手少阳，关冲液门中渚旁。

阳池外关支沟正，会宗三阳四渎长。

天井清冷渊消泅，臑会肩髃天髎堂。

天膷翳风瘰脉青，颊息角孙耳门当。

和髎耳前发际边，丝竹空在眉外藏。

关 冲

部位：伸指取穴。在无名指外侧（尺侧）指甲角外约一分（图36）。

穴释：关，关口；冲，冲出。此穴是三焦经所出之井，脉气与外关相通，故名关冲。

针灸：斜刺1～2分或点刺出血；灸3～5分钟。

功能：清三焦热，醒神开窍。

主治：头痛，目赤，目翳，目视不明，热病，口干，腹痛。吐泻，心烦，咽喉肿痛，疟腮，中暑，中风，昏迷等。

按语：关冲系三焦经之井穴。有清热醒神的作用。配颊车、翳风、合谷治疗口干咽痛和疟腮。

液 门

部位：握拳取穴。在小指和无名指的指缝纹头后凹陷中（图

36)。

穴释：液，津液；门，门户。三焦为决渎之官，水道出焉，此穴在小指与无名指之间，是津液、水气出入之门，故名液门。

针灸：直刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：清三焦热，开窍聪耳，疏筋利节。

主治：头痛，眩晕，目赤、肿痛，咽喉肿痛，疟疾，耳鸣，耳聋，牙痛，手背红肿、痒痛，手指拘挛等。

按语：液门系三焦经之荥穴。有清热泻火、安神定痛的作用。配太阳、下关、颊车、合谷治疗目赤肿痛、牙痛、咽肿、眩晕、耳鸣等虚火上炎之症。

中 渚

部位：俯掌或握拳取穴。在液门后一寸半掌骨间（图36）。

穴释：中，中间；渚，水流之处。此穴在手背三阳经中间，是三焦经所注之俞，故名中渚。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清三焦热，开窍聪耳，疏筋利节。

主治：头痛，眩晕，目赤，耳聋，聋哑，耳鸣，咽喉肿痛，疟疾，热病汗不出，前臂痛，手肿痒痛，指难屈伸等。

按语：中渚系三焦经之俞穴。有清热开窍、疏筋活血的作用。配耳门、听宫、率谷治疗耳鸣、耳聋。配合谷治疗指难屈伸。

阳 池

部位：俯掌取穴。在手背面腕横纹正中凹陷处（图36）。

穴释：阳，背为阳；池，水池。此穴在手腕背面似池的凹陷中，故名阳池。

针灸：直刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：清三焦热，疏筋利节。

主治：感冒，疟疾，耳聋，口干，消渴，虚癆，上肢肿痛、麻痹，手腕肿痛、无力、下垂等。

按语：阳池系三焦经之原穴。是调理上、中、下三焦气机的重要穴位。有宣肺解表，滋阴除烦，清热利湿之功。为很多慢性病之整体疗法中不可缺少的穴位。日人泽田健氏常以左阳池灸治子宫曲屈（如左、右屈，前、后倾）。临床常配风池、大椎、曲池、合谷治疗感冒、发热头痛等症。配脾俞、肾俞、三阴交、照海治疗消渴。配膏肓、百劳、肺俞、肾俞、关元、足三里治疗虚癆。配中脘、气海、足三里治疗脘腹胀满。配曲池、四渎、外关治疗手腕无力及下垂。

外 关

部位：俯掌取穴。在阳池后二寸，两骨之间凹陷中(图36)。

穴释：外，外为阳；关，关口。此穴在腕后外侧，是三焦通阳维与心包经之关，故名外关。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：清三焦热，镇惊熄风，疏经活络。

主治：头痛，胸胁痛，耳聋，耳鸣，聋哑，鼻衄，感冒，热病，中暑，牙痛，疟疾，颊肿，落枕，高血压，小儿惊风，上肢挛痛、麻痹，瘫痪，腕痛、无力，手指肿痛、麻痹等。

按语：外关系三焦经之络穴，别走手厥阴心包络经。也是八脉交会穴之一，通阳维脉。有通经活络的作用。配膻中、肝俞、足临泣治疗胸胁痛。配曲池、手三里、四渎、阳池、中渚治疗上肢瘫痪、腕下垂和手指麻痹。

支 沟

部位：俯掌取穴。在阳池后三寸，两骨之间凹陷中(图36)。

穴释：支，同肢；沟，水沟。此穴在上肢外侧腕后三寸两骨间之沟中，故名支沟。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：清三焦热，通关开窍，疏经活络。

主治：耳鸣，耳聋，热病汗不出，暴哑不语，口噤不开，胸胁胀痛，浮肿，呕吐，便秘，经闭，上肢痠痛、瘫痪等。

按语：支沟系三焦经之经穴。配阳陵泉、膈俞、肝俞、膻中治疗胸胁胀痛。配次髎，照海治疗习惯性便秘。

会 宗

部位：俯掌取穴。在支沟外侧（尺侧）约五分，尺骨边缘（图36）。

穴释：会，交会；宗，聚也，流派之本源为宗。此穴在三焦经，为手三阳经脉气宗会之处，故名会宗。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：疏经活络。

主治：耳聋，哮喘，癰疽，上肢痠痛，瘫痪等。

按语：会宗系三焦经之郄穴。配曲池、四渎、外关、合谷治疗上肢疼痛和瘫痪。

三 阳 络

部位：俯掌取穴。在支沟后一寸，两骨之间（图36）。

穴释：三阳，三阳经；络，联络。此穴在手三阳经之间，经气互有联络，故名三阳络。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：疏经活络，通关开窍。

主治：耳聋，暴喑不语，牙痛，上肢痠痛，麻痹等。

四 渎

部位：手掌按头取穴。在肘尖下五寸，阳池上七寸，两骨之间（图36）。

穴释：四，四肢；渎，水之大川。三焦为决渎之官，手足少阳上有四渎、下有中渎，四肢经气相通，故名四渎。

针灸：直刺1～1.5寸；灸3～5分钟。

功能：疏经活络。

主治：头痛，耳鸣，牙痛，聋哑，上肢肿痛、麻痹等。

天 井

部位：屈肘或手掌按头取穴。在肘尖上一寸凹陷中（图36）。

穴释：天，高上为天；井，水井。此穴在上肢肘后，四周高中间似井的凹陷处，故名天井。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：清热化痰，疏经利节。

主治：头痛，项强，耳鸣，耳聋，瘰癧，颈肿，颊肿，咽喉肿痛，胸胁胀痛，咳嗽，癫痫，肘臂痠痛、麻痹等。

按语：天井系三焦经之合穴。配肘髎、曲池、手三里治疗肘关节炎。

清 冷 渊

部位：屈肘取穴。在天井上一寸（图36）。

穴释：清冷，寒冷；渊，深水。此穴在肘尖上二寸，有清热泻火之功，是古人种痘、流水浆预防天花之处，故名清冷渊。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：清三焦热，疏经活络。

主治：头痛，颈项强痛，胁痛，目黄，上肢痠痛、麻痹等。

消 冻

部位：屈肘取穴。在肘尖上六寸（图36）。

穴释：消，消散；冻，水泽。此穴在臂外侧腓肉下，有清热泻火之功，也是古人种痘、流水浆预防天花之处，故名消冻。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：清三焦热，疏经活络。

主治：头痛，眩晕，颈项强痛，上肢痠痛、瘫痪等。

臑 会

部位：垂臂取穴。在肩髃下约三寸，三角肌后缘，与腋后纹头平齐（图36）。

穴释：臑，肩膊下之腓肉；会，交会。此穴在臑部，是三焦经与阳维脉之会，故名臑会。

针灸：直刺1～1.5寸；灸3～5分钟。

功能：疏经活络。

主治：项强，瘰气，肩背痛，臂肿痛、无力、瘫痪等。

按语：臑会配天宗、肩髃、肩髃治疗肩关节周围炎。

肩 髃

部位：举臂取穴。在大肠经肩髃后外方约一寸凹陷中（图36）。

穴释：肩，肩膊；髃同窞，骨之空隙。此穴在肩外端空隙处，故名肩髃。

针灸：直刺1～1.5寸；灸3～5分钟。

功能：疏经利节。

主治：肩关节炎，臂痛不得举，中风、瘫痪等。

按语：肩髃有祛风通络的作用。配肩髃、曲池、外关治疗上

肢疼痛和麻痹。

天 髎

部位：垂臂取穴。在胆经肩井后下方约一寸凹陷中(图36)。

穴释：天，高上为天；髎，同窵，骨之空隙，此穴在肩脾上方空隙处，故名天髎。

针灸：向前斜刺5～8分或透肩井；灸3～5分钟。

功能：疏经利节。

主治：颈项强痛，胸中烦满，肩臂痠痛等。

按语：天髎系手少阳三焦经、足少阳胆经和阳维脉之会穴。作用同肩髎。配肩井、风门、膈俞治疗肩背痛。

天 牖

部位：正坐取穴。在胆经完骨下约一寸，胸锁乳突肌后缘，约与下颌角平齐(图36)。

穴释：天，高上为天；牖，窗牖。此穴在耳后，有开窍通气治疗耳聋之功，故名天牖。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清头散风。

主治：头晕，面肿，耳鸣，耳聋，目痛，喉痛，颈项强痛，肩背痛等。

翳 风

部位：正坐张口取穴。在耳朵根下，耳垂后凹陷中。张口时凹陷最明显(图37)。

穴释：翳，雉尾扇；风，风气。此穴在似羽扇的耳垂后，蔽风收声之处，故名翳风。

针灸：向鼻尖斜刺5～8分；灸3～5分钟。

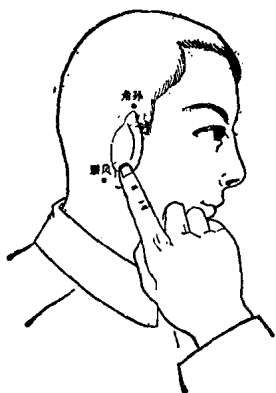


图37 翳风取穴法

功能：清热化痰，通关开窍。

主治：耳鸣，耳聋，耳内湿痒，聋哑，口眼歪斜，牙痛，龈肿，牙关紧闭，瘰癧，瘰气，口吃，腮腺炎，三叉神经痛，乳蛾等。

按语：翳风系手少阳三焦经和足少阳胆经之会穴。有清热散邪，通关开窍之功。配颊车、合谷、少商治疗扁桃体炎和疳腮。配颊车、下关、合谷治疗牙痛和口噤不开。

瘰 脉

部位：正坐取穴。在耳廓后平齐耳屏的青脉中（图36）。

穴释：瘰，瘰纵；脉，络脉。此穴在耳后青络脉处，高热证则脉赤而跳动，肾元亏则脉黑而干枯，主治抽掣瘰纵之证，故名瘰脉。

针灸：斜刺3～5分或点刺出血。

功能：清热散风。

主治：头痛，目赤，目视不明，耳鸣，耳聋，小儿惊风等。

颞 息

部位：正坐取穴。在耳廓后，瘰脉上约一寸青脉中（图36）。

穴释：颞，头颅；息，安息。此穴在头颅侧面，睡卧休息时着枕之处，故名颞息。

针灸：斜刺3～5分或点刺出血。

功能：清热散风。

主治：头痛，耳鸣，耳聋，耳中肿痛，身热，目视不明，小儿惊风，中耳炎，视网膜出血等。

角 孙

部位：正坐取穴。在耳尖上直对耳孔的发际边，张口有凹陷（图37）。

穴释：角，头角，拐角；孙，幼小细络。此穴在耳廓上角细络发际处，故名角孙。

针灸：斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：耳中肿痛，耳廓红肿，牙痛，龈肿，头痛，项强，目赤生翳，视网膜出血，视神经萎缩等。

按语：角孙系手少阳三焦经、手太阳小肠经和足少阳胆经之会穴。有清头明目的作用。配风池、颊息、太阳、内睛明治疗视网膜出血和视神经萎缩。

耳 门

部位：张口取穴。在耳屏上缺口处之前方凹陷中（图36）。

穴释：耳，耳屏；门，门户。此穴在耳屏上缺口似门的凹陷中，能司听力，故名耳门。

针灸：直刺0.5～1寸或向下斜刺透听会。

功能：清热散风，通关开窍。

主治：耳鸣，耳聋，耳中肿痛，头痛，眩晕，牙痛，颌肿，聋哑等。

按语：耳门具有通络聪耳之功，为耳疾常用穴。配听宫、听会、翳风、中渚治疗耳鸣，耳聋，耳中肿痛。

和 髻

部位：正坐避开动脉取穴。在耳门前上方鬓发边缘动脉处（图36）。

穴释：和，调和；髎，同窌，骨之空隙。此穴在耳前鬓发边缘空隙中，耳和能闻五音，故名和髎。

针灸：斜刺3～5分。

功能：清热散风。

主治：头痛，耳鸣，牙痛，颌肿，口眼歪斜等。

按语：和髎系手少阳三焦经、足少阳胆经和手太阳小肠经之会穴。配头窍阴治疗耳鸣。

丝 竹 空

部位：正坐取穴。在眉毛外边凹陷中（图36）。

穴释：丝竹，细长如丝的竹叶；空，空隙。此穴在似竹叶的眉毛外端空隙中，故名丝竹空。

针灸：直刺3～5分。

功能：清热散风。

主治：头痛，眩晕，目赤肿痛，迎风流泪，青盲，眼睑震颤，口眼歪斜，近视，视网膜出血，视神经萎缩等。

按语：丝竹空系手少阳三焦经和足少阳胆经之会穴。配鱼腰、攒竹治疗目赤肿痛。配风池、攒竹、合谷治疗头痛。

第十一节 足少阳胆经

本经起于瞳子髎终于窍阴，左右共88穴。取窍阴、侠溪、临泣、丘墟、阳辅、阳陵泉为井、荣、俞、原、经、合。本穴临泣，络穴光明，俞穴胆俞，募穴日月，郄穴外丘。

循行概述：起于瞳子髎，绕额角、前额、耳前、耳后、偏头部，沿着肩、侧胸、胁下、小腹外侧、胯骨及下肢外侧下行，过膝、胫外侧、外踝前面、足跗至四趾外侧端窍阴。足跗部的支脉，从足临泣入大趾和足厥阴经相接。肩部的支脉，从肩井交会

大椎。肩部入缺盆的支脉，穿过横膈联络肝脏，归属胆腑（图38）。

生理功能：胆附于肝，主贮藏与输出胆汁，和肝互为表里。古人认为胆性刚直，豪壮，果断，说明与精神活动有密切关系。

病理症候：经络症：往来寒热，头额痛，外眼角痛，缺盆和腋下肿痛，胸、胁和股、膝外侧至足四趾等胆经循行线之肿痛、麻痹。

脏腑症：胸、腕烦满，胁痛，口苦，呕吐，胆怯易惊，善太息，皮肤不润。胆气竭绝，则骨节弛缓、耳聋、眉必倾。

胆经穴歌：

足少阳起瞳子髻，四十四穴行召召。
听会上关颌厌集，悬颅悬厘曲鬓翹。
率谷天冲浮白次，窍阴完骨本神交。
阳白临泣目窗皮，正营承灵脑空朝。
风池肩井与渊液，辄筋日月京门标。
带脉五枢维道连，居髃环跳风市到。
中渚阳关阳陵泉，阳交外丘光明照。
阳辅悬钟丘墟外，临泣当在足背找。
地五会过是侠溪，窍阴穴在四趾稍。

瞳 子 髻

部位：正坐或仰卧取穴。在外眼角外约一横指，眶骨外侧凹陷中（图38）。

穴释：瞳子，瞳孔；髻，同窠，骨之空隙。此穴在眼眶外缘空隙中，横平瞳子，故名瞳子髻。

针灸：直刺3～5分或向下斜刺透颧髻。

功能：清热散风，活络明目。

主治：头痛，眩晕，目翳，目痒，迎风流泪，口眼歪斜，夜

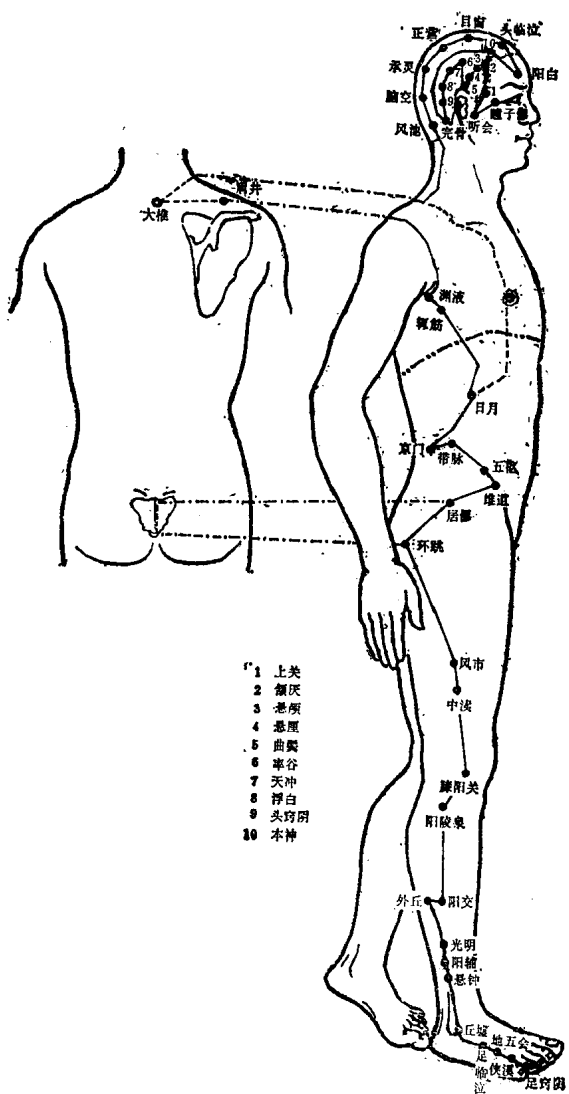


图38 足少阳胆经循行示意图和腧穴

盲，近视，视网膜出血，视神经萎缩，角膜炎，结膜炎，三叉神经痛等。

按语：瞳子髎系足少阳胆经、手太阳小肠经和手少阳三焦经之会穴。有散风活络、清头明目的作用。也是眼科疾患常用穴。配肝俞、肾俞、风池、颅息、角孙、攒竹治疗眼底出血和视神经萎缩。配风池、悬颅、头维、中渚治疗偏头痛。

听 会

部位：张口取穴。在耳屏下缺口处之前方凹陷中（图38）。

穴释：听，听力；会，会聚。此穴在耳屏下缺口前凹陷中，能使听觉会聚之处，故名听会。

针灸：直刺1~1.5寸。

功能：清热散风，通关开窍。

主治：耳鸣，耳聋，聋哑，耳中肿痛，牙痛，腮肿，下颌脱臼，口眼歪斜，下颌关节炎等。

按语：听会是耳疾的常用主穴，通窍聪耳是此穴之长。配听宫、耳门、液门治疗耳鸣、耳聋、中耳炎。配听宫、神庭、风池、合谷、内关治疗耳源性眩晕。

上 关

部位：正坐取穴。在耳屏前约二横指，颧骨弓上缘凹陷中（图38）。

穴释：上，上方；关，机关。此穴在颧骨弓上缘，与颧骨弓下之下关相对，故名上关。

针灸：直刺1~3分；灸2~3分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，耳鸣，耳聋，口眼歪斜，下颌关节炎，牙痛等。

按语：上关系足少阳胆经、手少阳三焦经和足阳明胃经之会穴。有活络止痛，清热祛风之效。配太阳、下关、颧髎、合谷治疗上牙痛。

颌 厌

部位：正坐取穴。在胃经头维下后方约一寸鬓发内(图38)。

穴释：颌，下颌骨；厌，合也。此穴在颌角发际头维之下，咀嚼食物时下颌骨动，此处亦应合而动，故名颌厌。

针灸：斜刺3～5分；灸2～3分钟。

功能：清热散风。

主治：偏头痛，耳鸣，头风，口眼歪斜，目眩，目痛等。

按语：颌厌系足少阳胆经、手少阳三焦经和足阳明胃经之会穴。有疏风止痛之功。配头维、百会、听宫、风池、合谷治疗偏、正头痛和眩晕。

悬 颅

部位：正坐取穴。在颌厌下后方约一寸鬓发内(图38)。

穴释：悬，悬挂；颅，头颅。此穴在颌厌后下方，上不及顶，下不及耳，如悬在头颅之状，故名悬颅。

针灸：斜刺3～5分；灸2～3分钟。

功能：清热散风。

主治：偏头痛，鼻衄，面肿，目眩，目赤肿痛等。

按语：悬颅系足少阳胆经、手少阳三焦经和足阳明胃经之会穴。有散风止痛的作用。配头维、风池、太阳、下关、颊车、合谷治疗头面肿痛。

悬 厘

部位：正坐取穴。在悬颅下后方约一寸，曲鬓前上方约一

寸，鬓发内（图38）。

穴释：悬，悬挂；厘，同麓，毛之强屈者曰麓。此穴在悬厘下，只差毫麓，故名悬厘。

针灸：斜刺3～5分；灸2～3分钟。

功能：清热散风。

主治：偏头痛，面红肿，耳鸣，目眩，目赤肿痛，三叉神经痛等。

按语：悬厘系足少阳胆经、手少阳三焦经和足阳明胃经之会穴。有清热泻火的作用。配瞳子髎、攒竹、四白、合谷治疗面目红肿、内热心烦。

曲 鬓

部位：正坐取穴。在悬厘下后方约一寸，三焦经耳门直上、鬓发边凹陷中（图38）。

穴释：曲，弯曲；鬓，鬓发。此穴在耳上鬓发弯曲之处，故名曲鬓。

针灸：斜刺3～5分。

功能：清热散风，通关开窍。

主治：偏头痛，耳鸣，颌颊肿痛，口眼歪斜，牙关紧闭，青光眼，视网膜出血，视神经萎缩等。

按语：曲鬓系足少阳胆经和足太阳膀胱经之会穴。配风池、颞息、角孙、太阳、攒竹、肝俞、肾俞治疗视网膜出血和视神经萎缩。

率 谷

部位：正坐取穴。在耳孔直上入发际一寸五分（图38）。

穴释：率，率领；谷，山谷，空洞。此穴在耳上发际内凹陷处，咀嚼时此处率领运动，故名率谷。

针灸：斜刺 3～5 分；灸 2～3 分钟。

功能：清热散风。

主治：偏正头痛，眩晕，耳鸣，耳聋，偏瘫等。

按语：率谷系足少阳胆经和足太阳膀胱经之会穴。配耳门、听宫、听会、中渚治疗耳鸣、耳聋。

天 冲

部位：正坐取穴。在率谷后约五分（图38）。

穴释：天，高上为天；冲，冲动。此穴在率谷后与足太阳经交会直上通天，故名天冲。

针灸：斜刺 3～5 分。

功能：清热散风。

主治：头痛，眩晕，牙痛，齿龈肿痛，癫痫等。

按语：天冲系足少阳胆经和足太阳膀胱经之会穴。配风池、百会、神庭、听宫、合谷治疗眩晕。

浮 白

部位：正坐取穴。在天冲后下方约一寸凹陷中（图38）。

穴释：浮，漂浮；白，白色。此穴在胆经耳后发际内，肝胆相表里，血不养肝，肝阳上浮，鬓发颁白，故名浮白。

针灸：斜刺 3～5 分；灸 3～5 分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，颈项肿痛，耳鸣，耳聋，瘰气，偏瘫等。

按语：浮白系足少阳胆经和足太阳膀胱经之会穴。配耳门、听宫、听会、中渚治疗耳鸣、耳聋。

头 窍 阴

部位：正坐取穴。在浮白下后方约一寸，完骨上凹陷中（图

38)。

穴释：头窍，头上空窍；阴，后为阴。此穴在耳后枕骨下，动摇有空之处，是通脑髓之窍，故名头窍阴。

针灸：斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，项强，目痛，耳鸣，耳聋，咽喉肿痛，中耳炎等。

按语：头窍阴系足少阳胆经、足太阳膀胱经和手少阳三焦经之会穴。有通络清热的作用。配风池、脑空、后顶、后溪治疗后头痛。

完 骨

部位：正坐取穴。在乳突后缘凹陷中，与督脉风府平齐（图38）。

穴释：完骨，耳后高骨，谓之完骨。此穴在完骨下，能完备的维护脑髓，故名完骨。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，耳后痛，面肿，咽喉肿痛，口眼歪斜，颈项强痛，失眠，视网膜出血，视神经萎缩等。

按语：完骨系足少阳胆经和足太阳膀胱经之会穴。有疏风活络、清热明目的作用。配风池、角孙、太阳、攒竹、肝俞治疗视网膜出血和视神经萎缩。

本 神

部位：正坐取穴。在外眼角直上入发际约五分，督脉神庭旁约三寸（图38）。

穴释：本，根本；神，神志。此穴在前发际，内应脑髓，脑

为人之本，主神志，故名本神。

针灸：沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，目眩，视物不明，癫痫，中风昏迷，小儿惊风等。

按语：本神系足少阳胆经和阳维脉之会穴。配神庭、攒竹、合谷治疗前额痛。

阳 白

部位：正坐或仰卧取穴。在眉毛上一寸，直对瞳孔(图38)。

穴释：阳，阳经；白，光明洁白。此穴在眼眉之上肌肉洁白处，有使患眼光明之功，故名阳白。

针灸：沿皮刺5～8分；灸2～3分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，目眩，目赤肿痛，流泪，角膜痒痛，青盲，夜盲，口眼歪斜，近视，眼睑痉挛，三叉神经痛，视网膜出血等。

按语：阳白系足少阳胆经和阳维脉之会穴。为疏风明目的常用穴。配头维、丝竹空、攒竹治疗口眼歪斜，前额肌麻痹。

头 临 泣

部位：正坐取穴。在阳白直上入发际约五分，督脉神庭与胃经头维之间(图38)。

穴释：头，头颅；临，临近；泣，泪下曰泣。此穴在目上入发际，泣出于目，穴临头上，故名头临泣。

针灸：沿皮刺3～5分；灸2～3分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，癫痫，目眩，目痛，目翳，鼻塞流涕，中风昏迷等。

按语：头临泣系足少阳胆经、足太阳膀胱经和阳维脉之会穴。长于目、鼻之疾。配攒竹、瞳子髎、承泣透睛明治疗目痛及泪囊炎。

目 窗

部位：正坐取穴。在头临泣后一寸（图38）。

穴释：“目”，眼目；“窗”，窗牖。此穴在目上入发际，有通气透光治目疾之功，故名目窗。

针灸：沿皮刺3～5分；灸2～3分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，眩晕，面肿，目赤痒痛，鼻塞，暴盲，青盲，近视等。

按语：目窗系足少阳胆经和阳维脉之会穴。为头部通络明目的主要配穴之一。配攒竹、鱼腰、瞳子髎、风池、合谷治疗暴盲、目赤痒痛。

正 营

部位：正坐取穴。在目窗后一寸（图38）。

穴释：正，正中；营，营气。此穴在头顶正中百会旁，为少阳、阳维脉之会，给脑输送营气，故名正营。

针灸：沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，项强，眩晕，呕吐，牙痛，唇挛等。

按语：正营系足少阳胆经和阳维脉之会穴。配百会、太阳、内关治疗头痛、呕吐。

承 灵

部位：正坐取穴。在正营后一寸五分（图38）。

穴释：承，承受；灵，神灵。此穴在头部，为承受脑髓元神之处，故名承灵。

针灸：沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，眩晕，鼻衄，鼻塞流涕，伤风，感冒，目痛等。

按语：承灵系足少阳胆经和阳维脉之会穴。配风池、百会、合谷治疗外感头痛。

脑 空

部位：正坐取穴。在风池直上一寸五分，督脉脑户旁约三横指凹陷中（图38）。

穴释：脑，头脑；空，空隙。此穴在后脑枕骨下凹陷空软处，故名脑空。

针灸：直刺2～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：头痛，眩晕，颈项强痛，癫痫、青盲等。

按语：脑空系足少阳胆经和阳维脉之会穴。配听宫、百会、神庭、合谷治疗眩晕。

风 池

部位：正坐取穴。在督脉风府旁大筋（斜方肌）外，后头骨下凹陷中（图38）。

穴释：风，风邪；池，水池。此穴在项后大筋外似池的凹陷中，是感受与主治风邪之处，故名风池。

针灸：向对侧太阳斜刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：祛风解表，清头明目，健脑安神。

主治：头痛，项强，耳鸣，耳聋，目痛，青盲，鼻塞，鼻

蛆，中风不语，外感风寒，热病汗不出，失眠，健忘，精神病，近视，视网膜出血，视神经萎缩，神经衰弱，半身不遂等。

按语：风池系足少阳胆经、手少阳三焦经和阳维脉之会穴。是祛风清热、通达脑、目脉络之重要腧穴。可治疗头脑、五官、颈项诸疾。配大椎、曲池、合谷治疗外感风寒。配肝俞、肾俞、颞息、角孙、曲鬓、太阳、攒竹、内睛明治疗视网膜出血和视神经萎缩。

肩 井

部位：正坐垂臂取穴。在肩膀头与督脉大椎之间，两筋中央凹陷中（图38）。

穴释：肩，肩胛；井，水井。此穴在肩部正中似井的凹陷处，故名肩井。

针灸：向前斜刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：理气降痰，疏经活络。

主治：中风不语，颈项强痛，落枕，肩背痠痛，上肢痠痛、瘫痪，胸满，瘰癧，肩关节周围炎，滞产，难产，胎衣不下，乳痈等。

按语：肩井系足少阳胆经、手少阳三焦经、足阳明胃经和阳维脉之会穴。有疏通经络、行痰降痰的作用。配肩髃、肩髃、天宗、臑会治疗肩关节周围炎。配百会、风府、风池、人中、合谷、中冲治疗中风不语。

渊 液

部位：举臂取穴。在腋下三寸，第四肋间隙中，约与乳头平齐（图38）。

穴释：渊，深渊；液，腋窝。此穴在腋窝下深藏之处，常有汗液从腋窝流下，故名渊液。

针灸：向下斜刺3～5分。

功能：理气活血。

主治：胸满，胁痛，腋下肿痛，肋间神经痛等。

輶 筋

部位：举臂取穴。在渊液前一寸第四肋间隙中，约与乳头平齐（图38）。

穴释：輶，车两轱也；筋，筋脉。此穴在似两轱的筋骨之间，即第四肋间隙中，故名輶筋。

针灸：向下斜刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：理气活血，平喘降逆。

主治：胸满，胁痛，气喘，呕吐，肋间神经痛等。

按语：輶筋系足少阳胆经和足太阳膀胱经之会穴。有宽胸理气之功。配膈俞、肝俞、膻中、期门、支沟治疗肋间神经痛。

日 月

部位：仰卧取穴。在乳头直下第九肋端下五分（图38）。

穴释：日，左目为日；月，右目为月。此穴在肝募期门下，肝胆之精气上注于目，犹如日月之光明，故名日月。

针灸：直刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：疏调肝胆，和中降逆。

主治：胁肋胀痛，肋间神经痛，呃逆，膈肌痉挛，呕吐，吞酸，腹痛，黄疸，胆囊炎，肝炎等。

按语：日月系胆之募穴，足少阳胆经和足太阴脾经之会穴。有疏肝和胃、通利胆道的作用。配期门、中脘、足三里、阳陵泉、三阴交、行间、肝俞、胆俞治疗胆囊炎和肝炎。

京 门

部位：侧卧取穴。在第十二肋前端（图38）。

穴释：京，京城；门，门户。此穴在似京城的十二肋端，是通肾脏与原气之门，故名京门。

针灸：直刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：温补肾阳。

主治：腹胀，腹痛，肠鸣，泄泻，小便不利，肾炎，腰膝冷痛等。

按语：京门系肾之募穴。有温肾壮阳，通利下焦的作用。配肾俞、命门、关元、委中治疗腰膝冷痛。配中脘、天枢、气海、足三里治疗腹痛、肠鸣、泄泻。配肾俞、关元、复溜治疗肾炎。

带 脉

部位：侧卧取穴。在第十一肋前端下约一寸八分，与肚脐平齐（图38）。

穴释：带，腰带；脉，经脉。此穴在肚脐外侧，如束腰带的带脉循行处，故名带脉。

针灸：直刺5～8分，灸5～10分钟。

功能：温补下焦。

主治：腰腹冷痛、疝气，赤白带下，月经不调，子宫脱垂等。

按语：带脉系足少阳胆经和带脉之会穴。有调经止带的作用。配肾俞、关元俞、上髎、关元、阴陵泉、三阴交治疗月经不调，赤白带下和子宫脱垂。

五 枢

部位：侧卧取穴。在带脉下三寸，髂前上棘之上凹陷中（图

78)。

穴释：五，五数；枢，枢纽。“天数五，地数五”。五为中数，此穴在人身之中，是任、督、冲、带、足少阳五脉通行之枢纽，故名五枢。

针灸：直刺 5～8 分；灸 5～10 分钟。

功能：温补下焦。

主治：疝气，腹痛，便秘，腰胯痠痛，赤白带下等。

按语：五枢系足少阳胆经和带脉之会穴。配关元俞、上髎、次髎、关元、三阴交治疗慢性盆腔炎和附件炎。

维 道

部位：仰卧取穴。在髂前上棘（五枢）下五分凹陷中（图 38）。

穴释：维，维系；道，道路。此穴是足少阳、带脉之会，也是维系连接下肢的道路，故名维道。

针灸：直刺 5～8 分；灸 5～10 分钟。

功能：温阳利湿，疏经活络。

主治：腰胯痠痛，疝气，水肿，腿痛、麻痹等。

按语：维道系足少阳胆经和带脉之会穴。有温经散寒之功。配冲门、关元、三阴交、大敦治疗疝气。

居 髎

部位：侧卧取穴。在髂前上棘与胯骨头（大转子最高点）之间凹陷中（图 38）。

穴释：居，蹲也；髎，同窌，骨之空隙。此穴在胯骨上，蹲坐时软组织凹陷处，故名居髎。

针灸：直刺 1～2 寸；灸 5～10 分钟。

功能：清利湿热，疏筋利节。

主治：腰胯痠痛，髋关节炎，膀胱炎，下肢肿痛、瘫痪等。

按语：居髎系足少阳胆经和阳跷脉之会穴。配关元俞、腰眼、环跳、风市治疗腰胯肿痛。

环 跳

部位：侧卧下腿伸直，上腿弯曲取穴。在胯骨头（大转子最高点）后上方约二寸凹陷中（图38）。

穴释：环，同环；跳，跳跃。此穴在股骨大转子后上方，侧卧伸下足，屈上足环形凹陷处，人的下肢屈伸跳跃，全仗此骨为枢纽，故名环跳。

针灸：直刺2~3寸，灸5~10分钟。

功能：祛风利湿，疏筋利节。

主治：腰胯痠痛，荨麻疹，风寒湿痹，髋关节炎，坐骨神经痛，下肢肿痛，麻痹、瘫痪，半身不遂等。

按语：环跳系足少阳胆经和足太阳膀胱经之会穴。能通经活络、除湿散寒，为治疗下肢、腰背痛常用穴。配胞育、秩边、承山治疗坐骨神经痛。

风 市

部位：仰卧取穴。在大腿外侧正中线，膝窝外面横纹头（上七寸）与臀下横纹头之间，两筋间（图38）。

穴释：风，风邪；市，聚集之处。此穴在股外侧，是风邪侵袭与治疗之处，故名风市。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：祛风利湿，疏经活络。

主治：风寒湿痹，荨麻疹，全身搔痒，神经性皮炎，下肢肿痛、麻痹、瘫痪，半身不遂，脚气等。

按语：风市有驱风湿、壮筋骨的作用。配环跳、阳陵泉、足

三里、三阴交、申脉治疗风寒湿所致之下肢肿痛和麻痹。配曲池、合谷、血海、足三里、三阴交治疗荨麻疹和皮肤搔痒症。

中 渎

部位：仰卧取穴。在大腿外侧，膝窝外面横纹头上五寸，两筋间（图38）。

穴释：中，中间；渎，水之大川。此穴在足太阳、阳明两经中间，经气由此流注，故名中渎。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：疏经活络。

主治：腿膝痠痛，下肢瘫痪，半身不遂等。

膝 阳 关

部位：屈膝取穴。在髌骨（膝盖）外侧，膝窝外面横纹头之上凹陷中（图38）。

穴释：阳，外为阳；关，关节。此穴在膝关节外侧，主治膝关节屈伸不利，故名阳关。

针灸：直刺1~2寸或透曲泉。

功能：疏筋利节，温经散寒。

主治：膝部红肿、疼痛、拘挛，下肢冷痛、麻痹，半身不遂等。

按语：膝阳关又名寒府。长于驱下肢寒湿，是治疗膝部肿痛的常用穴。配梁丘、膝眼、足三里治疗膝关节炎。

阳 陵 泉

部位：屈膝或垂足取穴。在膝窝外面横纹头下二寸，腓骨小头前下方凹陷中（图38）。

穴释：阳陵，外侧丘陵；泉，水泉。此穴在膝关节外侧，如

丘的腓骨小头下方，似泉的凹陷中，故名阳陵泉。

针灸：直刺1~1.5寸；灸10~15分钟。

功能：清泄肝胆，疏筋利节。

主治：胸满，胁痛，黄疸，呕吐，全身拘挛，腰痛，坐骨神经痛，肋间神经痛，肝炎，胆囊炎，高血压，膝部红肿，下肢肿痛、瘫痪，半身不遂，小儿麻痹后遗症等。

按语：阳陵泉系胆经之合穴，也是八会穴中之筋会。有疏肝胆、清湿热、疏筋利节的作用。是临床极为常用的腧穴。配肝俞、胆俞、期门、日月、中脘、内关、足三里治疗胆囊炎。配曲池、外关、合谷、环跳、三阴交治疗四肢痉挛。

阳 交

部位：垂足或屈膝取穴。在外踝尖上七寸，腓骨前缘两筋间（图38）。

穴释：阳，阳经；交，交会。此穴在外踝上七寸，胆经与阳维脉之交会处，故名阳交。

针灸：直刺1~1.5寸；灸3~5分钟。

功能：疏经活络。

主治：胸满，胁痛，面肿，坐骨神经痛，下肢痠痛、瘫痪等。

按语：阳交系阳维脉之郄穴。配阳陵泉、悬钟、丘墟治疗下肢外侧痠痛。

外 丘

部位：垂足取穴。在外踝尖上七寸腓骨后缘，阳交（后约一横指）与膀胱经飞扬之间（图38）。

穴释：外，外侧；丘，丘陵。此穴在阳交后外方，健步用力此处丰肉隆起如丘，故名外丘。

针灸：直刺1~1.5寸；灸3~5分钟。

功能：疏经活络。

主治：颈项强痛，胸胁胀痛，坐骨神经痛，腿痛、麻痹、瘫痪，脚气等。

按语：外丘系胆经之郄穴。配风池，风门、肩井治疗颈项强痛。

光 明

部位：垂足取穴。在外踝尖上五寸，腓骨前缘两筋间（图38）。

穴释：光，光亮；明，光明。此穴为胆经之络，肝胆相表里，肝开窍于目，有使患眼恢复光明之功，故名光明。

针灸：直刺1~1.5寸；灸3~5分钟。

功能：清热散风，疏经活络。

主治：目痛不明，热病汗不出，头痛，青光眼，视神经萎缩，下肢肿痛、麻痹等。

按语：光明系胆经之络穴，别走足厥阴肝经。有清肝明目之功。配风池，瞳子髎、攒竹、内睛明、球后、合谷治疗青光眼。

阳 辅

部位：垂足取穴。在外踝尖上四寸，腓骨前缘两筋间（图38）。

穴释：阳，外为阳；辅，辅助、辅骨。此穴在小腿外侧腓骨前方，腓为胫之辅，故名阳辅。

针灸：直刺1~1.5寸；灸3~5分钟。

功能：清肝胆热，疏经活络。

主治：头痛，目痛，胸满，胁痛，腋下肿痛，坐骨神经痛，下肢挛痛、麻痹、瘫痪、半身不遂等。

按语：阳辅系胆经之经穴。配环跳，风市、阳陵泉、足三里治疗下肢偏瘫。

悬 钟

部位：垂足取穴。在外踝尖上三寸，腓骨前缘凹陷中（图38）。

穴释：悬，悬挂；钟，钟鼓乐器。此穴在外踝上绝骨之端，似钟的凹陷处，故名悬钟。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~15分钟。

功能：清肝胆热，疏经活络。

主治：颈项强痛，落枕，胸胁胀痛，伤寒热不退，咽喉肿痛，腹痛，腰痛，下肢肿痛、瘫痪，脚气，肩凝症等。

按语：悬钟又名绝骨，系八会穴中之髓会。配风池、风门、巨骨治疗颈项强痛，配环跳、风市、梁丘、足三里治疗下肢疼痛、麻痹和瘫痪。

丘 墟

部位：垂足取穴。在外踝前下方凹陷中（图38）。

穴释：丘，丘陵；墟，同虚。此穴在如丘陵的外踝前下方，空虚的凹陷处，故名丘墟。

针灸：直刺3~8分；灸3~5分钟。

功能：清肝胆热，疏筋利节。

主治：颈项强痛，胸胁胀痛，腋下肿痛，胆囊炎，半身不遂，腿痛、转筋、麻痹，外踝和足跟肿痛等。

按语：丘墟系胆经之原穴。有清泻肝胆的作用。配肝俞、胆俞、期门、日月、中脘、阳陵泉治疗胆囊炎。配悬钟、解溪治疗外踝肿痛。

足 临 泣

部位：垂足取穴。在足背小趾四趾的趾缝纹头后一寸五分，

小筋后骨缝中（图39）。

穴释：足，足背，临，居高临下；“泣”，泪下曰泣。此穴在足背，主治郁闷不舒哭泣之证，故名足临泣。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清肝胆热，疏经止痛。

主治：头痛，耳鸣，目痛，目眩，胸满，胁肋胀痛，瘰癧，疟疾，热病，往来寒热，乳痛，月经不调，足背肿痛等。



图39 足临泣等穴

按语：足临泣系胆经之俞穴，八脉交会穴之一，通带脉。有疏肝解郁、理气止痛之功。配肝俞、期门、外关治疗两胁疼痛。配大椎、陶道、外关治疗疟疾。

地 五 会

部位：垂足取穴。在足背小趾四趾的趾缝纹头后约一寸，小筋前骨缝中（图39）。

穴释：地，地下；五会，五经交会。此穴在足部为地，胆经之气与其它五经之气在足部交会相通之处，故名地五会。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清肝胆热。

主治：目赤肿痛，腋下肿痛，吐血，足背肿痛、麻木等。

侠 溪

部位：垂足取穴。在小趾四趾的趾缝纹头后凹陷中（图38）。

穴释：侠，同挟；溪，水沟。此穴在小趾次趾挟缝如溪的中间，故名侠溪。

针灸：向下斜刺3～5分，灸3～5分钟。

功能：清肝胆热，疏经活络。

主治：头痛，眩晕，目痛不明，颊肿，耳鸣，耳聋，胸胁胀痛，浮肿，疟疾，热病，全身串痛，足背肿痛、麻木，足趾挛痛等。

按语：侠溪系胆经之荣穴。有疏肝清热的作用。配听官、听会、翳风治疗耳鸣、耳聋。

足 窍 阴

部位：伸趾取穴。在足四趾外侧，趾甲角外约一分（图38）。

穴释：足窍，足下空窍；阴，阴经。此穴在足趾，是足少阳交于足厥阴经之处，和头窍阴上下相应，主治目痛、耳聋等证，两穴基本相同，故名足窍阴。

针灸：斜刺1～2分，灸3～5分钟。

功能：清肝胆热。

主治：头痛，失眠，目痛，心烦，咳逆，哮喘，咽喉肿痛，舌强，胸胁胀痛，热病，耳聋，手足烦热等。

按语：足窍阴系胆经之井穴。有清热养阴之功。配颊车、翳风、合谷、少商治疗咽喉肿痛。

第十二节 足厥阴肝经

本经起于大敦终于期门，左右共28穴。取大敦、行间、太冲、中封、曲泉为井、荣、俞、经、合。本穴大敦，络穴蠡沟，俞穴肝俞，募穴期门，郄穴中都。

循行概述：起于大敦，沿着足背及下肢内侧脾、肾二经之间

（内踝骨上八寸以下在脾经之前）上行，过内踝前、膝内侧，会阴部至胸前期门穴，进入中焦和手太阴经相接。胸前的支脉，穿横膈布胁肋，过喉咙后面，入鼻咽部连“目系”。目系的支脉，环绕口唇里面。会阴部入里的支脉，夹胃上行归属肝脏，联络胆腑（图40）。

生理功能：肝在胁下，和胆互为表里。肝主筋，开窍于目，司血液之贮藏调节，主全身筋、骨、关节之屈伸。肝性刚强，喜条达恶抑郁，说明精神情志之变化与肝有密切关系。

病理症候：经络症：腰痛，疝气，小腹肿痛，遗尿，尿闭。

脏腑症：胸满，胁痛，口苦，呕吐，呃逆、症瘕、积聚，月经不调，头晕，目眩，急、慢惊风，手、足拘挛。肝气竭绝，则不能生血养筋，而见拘急痉挛，唇青，舌卷，睾丸上缩。

肝经穴歌：

一十四穴足厥阴，大敦行间太冲寻；
中封蠡沟中都近，膝关曲泉阴包临；
五里阴廉急脉穴，章门仰望见期门。

大 敦

部位：伸趾取穴。在足大趾外侧趾甲角外约一分（图40）。

穴释：大，盛大；敦，厚、高也。此穴在足大趾外端，肌肉丰厚之处，故名大敦。

针灸：向上斜刺2～3分；灸5～10分钟。

功能：清热醒神，固冲止崩，升举下陷。

主治：小便频数，遗尿，腹胀，肿痛，失血，昏厥，疝气，茎中痛，阴部搔痒，淋病，崩漏，子宫脱垂等。

按语：大敦系肝经之井穴。功长调肝和血，并有清热利湿作用。配关元、归来、三阴交治疗月经过多和功能性子宫出血。配

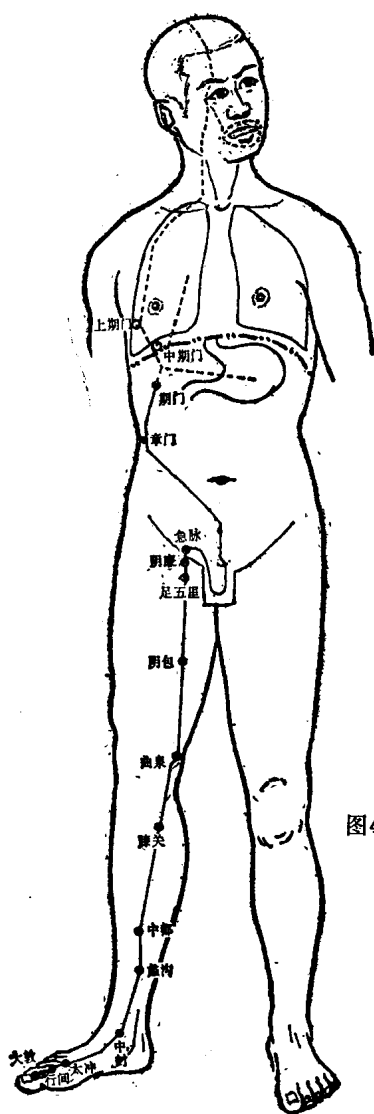


图40 足厥阴肝经循行示意图和腧穴

中注、四满、关元、三阴交治疗外阴湿疹搔痒、淋病和疝气。

行 间

部位：垂足取穴。在足大趾二趾趾缝纹头后凹陷中（图40）。

穴释：行，通行；间，中间。此穴在大趾次趾挟缝中间，是肝经所溜之荣，故名行间。

针灸：直刺3～5分，灸5～10分钟。

功能：舒肝理气，调经和血，镇惊止痛。

主治：胸满、胁痛，善怒，目肿流泪，心痛，咳逆，呕血，胃痛、腹痛，瘕病，癰病，惊风，疝气，遗尿、尿血，尿闭，头痛，失眠，目眩，消渴，黄疸，神经衰弱，阴肿，崩漏，白带，痛经，月经不调，脚气等。

按语：行间系肝经之荣穴。有理气活血、舒肝解郁的作用。配中脘、天枢、关元、足三里、三阴交治脘腹胀痛。配人中、合谷、三阴交治疗肝郁不舒，瘕病和精神病。

太 冲

部位：垂足避开动脉取穴。在行间后一寸五分骨缝中（图40）。

穴释：太，大之甚也；冲，冲动。此穴在足背太冲脉搏动处，“女子太冲脉盛，月事以时下，故有子”。肝经与冲脉有关，故名太冲。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：舒肝理气，调经和血，镇惊熄风。

主治：胸满，胁痛，瘕病，惊风，头痛，失眠，目眩，口眼歪斜，溇泄，疝气，遗尿，尿闭，黄疸，高血压，淋病，阴肿，崩漏，赤白带下，月经不调，足痛、无力，足趾挛痛等。

按语：太冲系肝经之俞穴，亦是原穴。用以治疗寒滞厥阴，阴囊收缩、痛引少腹或肝失藏血及肝经风热诸症。配关元、三阴交、隐白治疗功能性子宫出血。配中注、四满、关元治疗疝气和小腹痛。配人中、合谷治疗小儿惊风。

中 封

部位：翘足屈趾取穴。在内踝尖前大筋（胫骨前肌腱）后凹陷中（图40）。

穴释：中，中间；封，封藏。足尖上跷，此穴在内踝与大筋中间，筋肉封藏处，故名中封。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：舒肝理气，清利下焦。

主治：小腹胀痛，疝气，遗精，小便不利、淋病，疟疾，肝炎，踝关节肿痛等。

按语：中封系肝经之经穴。常用于治疗肝经湿热下注。配关元、曲骨、三阴交治疗湿热淋病和小腹痛。配解溪、丘墟治疗踝关节炎。

蠡 沟

部位：垂足取穴。在内踝尖上五寸，胫骨内侧缘（图40）。

穴释：蠡，盛水之瓢；沟，水沟。此穴在胫骨内侧，似瓢杓的沟渠处，故名蠡沟。

针灸：斜刺5～8分；灸3～5分钟。

功能：舒肝理气，清利下焦。

主治：疝气，小便肿痛，小便不利，会阴部湿痒，月经不调，赤白带下，子宫出血，下肢肿痛、麻痹等。

按语：蠡沟系肝经之络穴。有疏肝解郁的作用。可治疗肝脾不和诸症。配关元、归来、三阴交、隐白治疗月经不调、功能性

子宫出血和赤白带下。

中都

部位：垂足取穴。在内踝尖上七寸，胫骨内侧缘（图40）。

穴释：中，中间；都，都会、丰满。此穴在内踝与膝胫中间，肌肉丰满处，故名中都。

针灸：斜刺5～8分；灸3～5分钟。

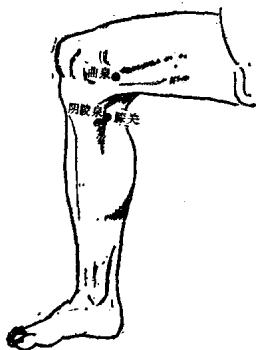
功能：舒肝理气，固冲止崩。

主治：小腹胀痛，痢疾，疝气，崩漏，赤白带下，月经不调等。

按语：中都系肝经之郄穴。配中注、关元、三阴交、大敦治疗疝气和小腹胀痛。

膝关

部位：屈膝取穴。在膝下二寸，脾经阴陵泉后一寸之沟中。



左手虎口按住左侧胫骨嵴（右手按右侧）食指尽处是阴陵泉，中指尽处就是该穴（图41）。

穴释：膝，膝关节；关，机关。此穴在膝内辅骨后，靠近膝关节，故名膝关。

针灸：直刺1～1.5寸；灸3～5分钟。

图41 膝关等穴

功能：通利关节。

主治：腹痛，胀满，膝内痛，下肢肿痛、麻痹等。

曲泉

部位：屈膝取穴。在髌骨（膝盖）内侧，膝窝里面横纹头之

上凹陷中（图41）。

穴释：曲，屈曲；泉，水泉。此穴曲膝在膝内腘窝横纹上似泉的凹陷处，故名曲泉。

针灸：直刺1~1.5寸或透阳关；灸3~5分钟。

功能：理气活血，清热除湿，疏筋利节。

主治：小腹肿痛，疝气，阴股痛，遗精，阳萎，阴茎痛，小便不利，尿闭，阴部痒痛，症瘕，月经不调，子宫脱垂，腿膝肿痛等。

按语：曲泉系肝经之合穴。常用于治疗湿热下注之阴痒、洩难、小腹肿痛等病症。尚有升举下陷治疗阴挺的作用。配中脘、关元、足三里、三阴交治疗子宫脱垂。配中极、足五里、血海、足三里治疗外阴搔痒和湿疹。

阴 包

部位：腿伸直或卷足取穴。在膝内高骨（股骨内上髁）上四寸两筋（股内肌与缝匠肌）间（图40）。

穴释：阴，阴经；包，包揽。此穴在股内廉，居足三阴经之间，能包揽三阴经和胞宫病候，故名阴包。

针灸：直刺1~1.5寸；灸3~5分钟。

功能：理气活血，通调下焦。

主治：小便不利，遗尿，月经不调，下肢肿痛、麻痹等。

足 五 里

部位：仰卧避开动脉取穴。在胃经气冲下三寸，大腿根内侧股动脉中（图40）。

穴释：足，下肢，五，五数，里，里程。此穴在股内廉，居足厥阴经尽处前的第五位，故名足五里。

针灸：直刺5~8分；灸3~5分钟。

功能：通调下焦。

主治：小腹胀满，遗尿，小便不通，阴囊湿痒等。

阴 廉

部位：仰卧避开动脉取穴。在胃经气冲下二寸，大腿根内侧动脉中（图40）。

穴释：阴，会阴部；廉，边缘。此穴在股内廉，会阴部的外缘，故名阴廉。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：调经活血。

主治：股内侧痛，月经不调等。

急 脉

部位：仰卧取穴。在胃经气冲下约一寸任脉旁二寸。平齐阴茎根上缘腹股沟处（图40）。

穴释：急，急促；脉，动脉。此穴在阴茎旁，动脉冲动甚急之处，故名急脉。

针灸：灸5～10分钟。

功能：舒肝理气。

主治：阴茎痛，疝气，小腹胀痛，股内侧痛，阴部肿痛，子宫脱垂等。

章 门

部位：侧卧取穴。在第十一肋前端（见图4）。

穴释：章，同障，蔽也；门，门户。此穴在第十一肋端，两肋为遮蔽五脏和脏气出入之门，故名章门。

针灸：直刺0.5～1寸；灸3～5分钟。

功能：疏调肝脾，清热利湿，活血化瘀。

主治：黄疸，呃逆，呕吐，水肿，腹胀如鼓，肠鸣，腹泻，

二便不利，胁痛，肝脾肿大，胃痛，消化不良等。

按语：章门系脾之募穴，足厥阴肝经和足少阳胆经之会穴，又是八会穴中之脏会。有疏肝理气、通络化痰的作用。配膈俞、肝俞、脾俞、期门、中脘、足三里、三阴交治疗肝脾肿大。

期 门

部位：仰卧取穴。部位有三个。

1.期门：在乳头直下肋弓边缘第九肋端。

2.上期门：在乳旁一寸半，再下一寸半。

3.中期门：在乳头下二肋，第六肋间隙中（图40）。

穴释：期，周期；门，门户。十二经运行气血，始于肺经，终于肝经，周而复始，气血至此穴为归入肺经之门，故名期门。

针灸：直刺4~6分，上、中期门斜刺3~5分；灸3~5分钟。

功能：疏调肝脾，理气活血。

主治：胸满，胁痛，肋间神经痛，咳逆，哮喘，胃痛，呃逆，呕吐，饮食不下，黄疸，肝脾肿大，肝炎，妇女热入血室，乳痛，乳汁不足等。

按语：期门系肝之募穴，足厥阴肝经、足太阴脾经和阴维脉之会穴。功用同章门。而章门偏于脾经病症，此穴则长于肝经见症。配膈俞、肝俞、胆俞、日月、中脘、阳陵泉、足三里、中封治疗肝炎和胆囊炎。上期门、中期门配膈俞、肝俞、膻中、支沟治疗肋间神经痛。

第十三节 任 脉

本脉起于会阴终于承浆，共24穴。络穴会阴，列缺通任脉。

循行概述：起于会阴，沿着腹内中线上行，过脐、喉至唇下承浆，沿面部进入目内（图42）。

病理症候：疝气，赤白带下和聚结肿块。

任脉穴歌：

任脉二四起会阴，曲骨中极关元逢。

石门气海阴交并，神阙水分下脘临。

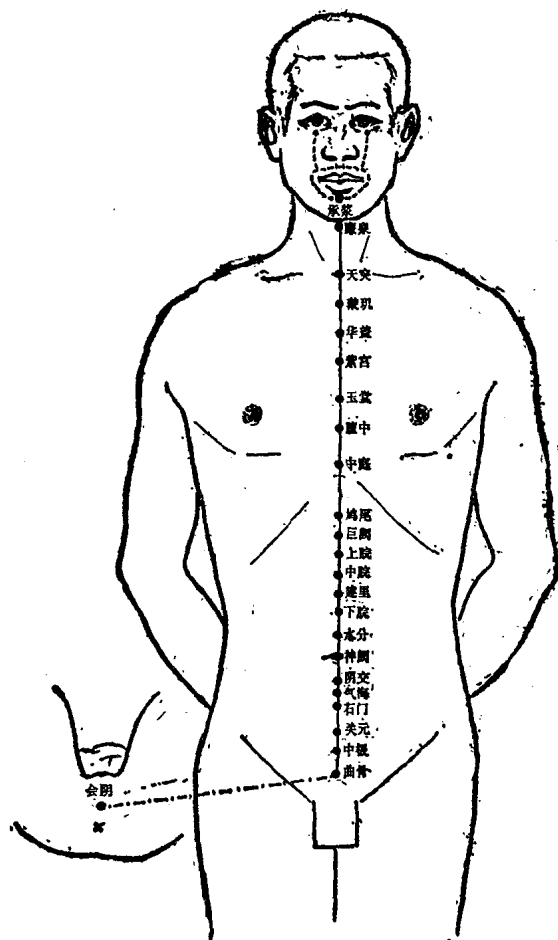


图42 任脉循行示意图和腧穴

建里中脘连上脘，巨阙鸠尾剑突迎。

中庭膻中连玉堂，紫宫华盖璇玑扞。

天突廉泉结喉上，唇下宛窝承浆寻。

会 阴

部位：仰卧屈膝取穴。在阴囊（女子阴道后联合）与肛门之间，会阴部正中（图42）。

穴释：会，聚会；阴，阴部。此穴在前后二阴之间，任、督、冲三脉之会，故名会阴。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：补肾培元，清热利湿。

主治：阴部痒痛，多汗，肛门搔痒、肿痛，遗精，遗尿，尿闭，溺水昏迷，淋病，子宫脱垂，月经不调等。

按语：会阴又名屏翳，系任、督、冲三脉之会穴，任脉之络穴，别走督脉。是治疗二阴和盆腔疾患的有效穴。但由于取用不便，一般回避不用。配人中，百会治疗溺水昏迷。配中脘、关元、三阴交治疗子宫脱垂。

曲 骨

部位：仰卧取穴。在肚脐中心下五寸，耻骨联合上缘（图42）。

穴释：曲，屈曲；骨，横骨。此穴在横骨（耻骨）中央屈曲处之上缘，故名曲骨。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～20分钟。

功能：补肾培元，清热利湿。

主治：阳萎，遗精，尿闭，遗尿，疝气，小腹胀痛，淋病，阴部湿痒，赤白带下，月经不调，痛经等。

按语：曲骨系任脉和足厥阴肝经之会穴。为治疗盆腔和外阴

部病症的常用穴。配中极、三阴交治疗遗尿和尿频。加配血海、风市治疗外阴湿痒。

中 极

部位：仰卧取穴。在肚脐中心下四寸（图42）。

穴释：中，中间；极，极端、尽处。此穴在横骨之上，人体上下左右的中间，任脉行于腹部中线的尽端，故名中极。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～20分钟。

功能：补肾培元，清热利湿。

主治：阳萎，遗精，疝气，遗尿，尿闭，小腹胀痛，阴部肿痛、搔痒，症瘕，经闭，崩漏，赤白带下，月经不调，胎衣不下，子宫脱垂等。

按语：中极系膀胱之募穴，任脉和足三阴经之会穴。有培补肾气、清热利湿之功。配肾俞、关元俞、膀胱俞、水道、三阴交，治疗遗尿、遗精、外阴肿痛和膀胱炎。

关 元

部位：仰卧取穴。在肚脐中心下三寸（图42）。

穴释：关，关界、闭藏；元，元气。此穴在脐下，是人身元阴元阳交关之所，故名关元。

针灸：直刺0.5～1寸；灸10～20分钟。

功能：补肾培元，清热利湿。

主治：阳萎，遗精，遗尿，尿闭，尿血，泄泻，痢疾，脱肛，腹痛，胃下垂，疝气，虚脱，尿道炎，膀胱炎，神经衰弱，会阴部湿痒，崩漏，赤白带下，症瘕，经闭，痛经，子宫脱垂，胎衣不下，不孕，月经不调等。

按语：关元系小肠之募穴，任脉和足三阴经之会穴。为培元固本之要穴，治疗极为广泛。凡胃肠、盆腔、泌尿、生殖等器官

之见症，皆可取用此穴施治。配印堂、中脘、神门、三阴交治疗神经衰弱。配肾俞、关元俞、上髎治疗盆腔炎。

石 门

部位：仰卧取穴。在肚脐中心下二寸（图42）。

穴释：石，坚石；门，门户。此穴在脐下丹田之门，内气下沉少腹坚硬之处，故名石门。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～20分钟。

功能：补肾培元，清热利湿。

主治：疝气，小腹痛，泄泻，痢疾，水肿，遗尿，尿闭，消化不良，症瘕，经闭，滞产，崩漏，赤白带下等。

按语：石门系三焦之募穴。配关元、气穴、合谷、三阴交治疗经闭。

气 海

部位：仰卧取穴。在肚脐中心下一寸五分（图42）。

穴释：气，元气；海，水归聚之处。此穴在脐下，是人身元气生发与会聚之处，故名气海。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～20分钟。

功能：补肾培元，益气和血。

主治：胃痛，腹痛，绕脐绞痛，便秘，泄泻，痢疾，脱肛，水肿，遗尿，尿血，尿闭，阳痿，遗精，胃下垂，疝气，虚癆，虚脱，神经衰弱，崩漏，赤白带下，症瘕，经闭，痛经，月经不调，胎衣不下，子宫脱垂，四肢无力等。

按语：气海意为元气之海。偏于补气，常用于脏器功能低下之见症。擅治肠胃虚弱。配中脘、天枢、足三里治疗胃下垂和慢性胃肠炎。配关元、三阴交、行间治疗尿血和崩漏。

阴 交

部位：仰卧取穴。在肚脐中心下一寸（图42）。

穴释：阴，阴脉；交，交会。此穴在脐下，为任脉、冲脉、足少阴交会之处，故名阴交。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～20分钟。

功能：补肾培元，清热利湿。

主治：小腹痛，绕脐冷痛，疝气，阴部湿痒，崩漏，赤白带下，月经不调等。

按语：阴交系任脉、足少阴肾经和冲脉之会穴。配下脘、天枢、足三里治疗绕脐冷痛和慢性肠炎。

神 阙

部位：仰卧取穴。在肚脐中心（图42）。

穴释：神，元神；阙，帝王之宫庭。此穴在脐中心，为元神出入之阙庭，故名神阙。

针灸：禁针；隔盐灸10～20分钟。严禁起泡。

功能：培元固本。

主治：肠鸣、腹痛、泄泻，痢疾，水肿，脱肛，腹中冷痛，中风，尸阙，虚脱等。

按语：神阙为回阳救逆之主要灸穴。配人中、足三里治疗中风、昏迷、尸阙和虚脱。

水 分

部位：仰卧取穴。在肚脐中心上一寸（图42）。

穴释：水，水液；分，分离。此穴内应小肠，能分利水气之清浊，主水病，故名水分。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：和中理气，分利水湿。

主治：胃胀，腹胀如鼓，腹水，腹胀痛，绕脐痛，小便不利，泄泻等。

按语：水分分为分利水道的常用穴。配天枢、气海、会阳治疗洞泻。配脾俞、肾俞、足三里、复溜治疗肾炎、水肿。

下 脘

部位：仰卧取穴。在肚脐中心上二寸（图42）。

穴释：下，下方；脘，胃腑。此穴内应胃之下口，故名下脘。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：和中理气，消积化滞。

主治：胃痛，呕吐，肠鸣，腹胀，腹痛，痞块，消化不良等。

按语：下脘系任脉和足太阴脾经之会穴。为治疗胃肠道疾患的常用穴。配上脘、中脘、内关、足三里治疗胃痛、腹胀和胃十二指肠溃疡。

建 里

部位：仰卧取穴。在肚脐中心上三寸（图42）。

穴释：建，建立；里，邻里。此穴内应胃部中下之间，建立中焦之邻里，故名建里。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：和中理气，消积化滞。

主治：胃痛，呃逆，呕吐，腹胀痛，身肿，消化不良等。

按语：建里为治疗胃肠疾患的配穴。配上脘、天枢、足三里治疗腹胀、肠鸣和消化不良。

中 脘

部位：仰卧取穴。在肚脐中心（上四寸）与中庭之间（图42）。

穴释：中，中间；脘，胃腑。此穴内应胃腑之中，中焦营卫气血化生之源，故名中脘。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：调理肠胃，行气活血，清热化滞。

主治：胃痛，胃下垂，呕吐，呃逆，吞酸，食积，痞疾，肠鸣，腹痛、胀满，痞块，便秘，泄泻，痢疾，黄疸，咳嗽，哮喘，瘰病，癰病，失眠，神经衰弱，胃溃疡，胃炎，消化不良，肠炎，肝炎，胆囊炎等。

按语：中脘系胃之募穴，八会穴中之腑会，又是任脉、手太阳小肠经、手少阳三焦经和足阳明胃经之会穴。有健脾和胃的作用，临床极为常用。配巨阙、下脘、内关、足三里、公孙治疗急、慢性胃肠炎和胃及十二指肠溃疡。

上 脘

部位：仰卧取穴。在肚脐中心上五寸（图42）。

穴释：上，上方；脘，胃腑。此穴内应胃之上口，故名上脘。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：和中降逆，清热化痰。

主治：胃痛，呃逆，呕吐，腹泻，腹胀痛，黄疸，痞块，水肿，瘰病，癰病，吐血，消化不良等。

按语：上脘系任脉、足阳明胃经和手太阳小肠经之会穴。上、中、下三脘的作用基本相同，都有治疗胃肠疾患的作用。但上脘偏于降逆和胃，治疗胃气上逆之呕吐；中脘则长于健脾助运，治疗脾失运化之纳差、疲乏、浮肿等症；下脘则偏于肠道疾患，治

疗腹痛、腹胀、肠鸣、泄泻等。配巨阙、内关治疗呃逆、呕吐和急性胃痛。

巨 阙

部位：仰卧取穴。在肚脐中心上六寸（图42）。

穴释：巨，大也；阙，帝王之宫庭。此穴在蔽骨下，为心神经气会聚之阙庭，故名巨阙。

针灸：直刺0.5～1寸；灸5～10分钟。

功能：和中降逆，清心化痰。

主治：胸满、胀痛，呃逆，呕吐，胃痛，吞酸，黄疸，腹泻，噎膈，瘧病，癰病，心痛，心慌，心悸，急性胃肠炎等。

按语：巨阙系心之募穴。配心俞、神门治疗心悸。配天突、膻中、中脘、内关、阳溪治疗噎膈和瘧病。

鸠 尾

部位：仰卧举臂取穴。在剑突下五分，肚脐中心上七寸（图42）。

穴释：鸠，鸠鸟；尾，尾巴。此穴在胸前似鸠鸟尾巴的鸠尾骨下，故名鸠尾。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：和中降逆，清心化痰。

主治：胸满、胀痛，胃痛，呃逆，呕吐，瘧病，癰病，心悸等。

中 庭

部位：仰卧取穴。在胸骨体与剑突之间凹陷中（图42）。

穴释：中，中间；庭，宫庭。此穴在胸前鸠尾骨上端，胸腹中心之前庭，故名中庭。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸理气。

主治：胸胁胀痛，食不下，呕吐，小儿吐乳，噎膈等。

膻 中

部位：仰卧取穴。在中庭上一寸六分，两乳头之间凹陷中（图42）。

穴释：膻，胸中两乳间曰膻；中，中间。此穴为八会之气会，在两乳间陷中，故名膻中。

针灸：向下沿皮刺3～8分；灸5～10分钟。

功能：宽胸理气，宁心化痰。

主治：胸痛，咳嗽，哮喘，肺病，咯血，噎膈，呃逆，心悸，心慌，痰迷心窍，心动过速，乳汁不足，乳痈等。

按语：膻中系心包络之募穴，任脉、足太阴脾经、足少阴肾经、手太阳小肠经和手少阳三焦经之会穴，也是八会穴中之气会。有理肺气、通乳络之功。配百劳、定喘、肺俞、太渊治疗咳嗽、胸满、不得卧。

玉 堂

部位：仰卧取穴。在膻中上一寸六分凹陷中（图42）。

穴释：玉，白色；堂，宫室。此穴居心之上，为五脏六腑经络精气来朝之堂，故名玉堂。

针灸：向下沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸理气。

主治：胸痛，呕吐，咳嗽，哮喘，咽喉肿痛等。

紫 宫

部位：仰卧取穴。在玉堂上一寸六分凹陷中（图42）。

穴释：紫，赤色；宫，宫室。心为君主之官，此穴内应心脏，为君主所居，故名紫宫。

针灸：向下沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸理气。

主治：胸痛，呃逆，呕吐，咳嗽，哮喘，咽喉肿痛等。

华 盖

部位：仰卧取穴。在紫宫上一寸六分凹陷中（图42）。

穴释：华，精华；盖，篷盖。肺之藏，有称五藏之华盖，此穴内应肺脏，故名华盖。

针灸：向下沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸理气。

主治：胸肋胀痛，咳嗽，哮喘，咽喉肿痛，咳逆等。

璇 玑

部位：仰卧取穴。在华盖上一寸六分，天突下约一寸凹陷中（图42）。

穴释：璇，旋转；玑，枢机。此穴内应肺脏，肺气、宗气流通犹如璇玑运转，故名璇玑。

针灸：向下沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸理气。

主治：胸肋胀痛，呃逆，咳嗽，哮喘，咽喉肿痛等。

天 突

部位：仰靠取穴。在胸骨上窝正中（图43）。

穴释：天，天气通肺；突，



图43 天突穴

突出。此穴在胸骨上窝正中，犹如肺气出入之灶突，故名天突。

针灸：向下沿胸骨后直刺0.5～1寸。

功能：宽胸理气，清热化痰。

主治：胸痛，咳嗽，哮喘，肺病，咯血，呃逆，呕吐，噎膈，咽喉肿痛，瘰气，瘰病，暴暗，中风痰壅，食道炎等。

按语：天突系任脉和阴维脉之会穴。有降气平喘之效。配膻中、百劳、肺俞、列缺治疗咳嗽哮喘。

廉 泉

部位：仰靠取穴。在结喉上方凹陷中（图43）。

穴释：廉，棱也；泉，水泉。此穴在棱形的结喉上，犹如通金津玉液之清泉，故名廉泉。

针灸：直刺3～5分；灸2～3分钟。

功能：通利咽膈，清热化痰。

主治：舌下肿痛，舌强，舌弛缓，口疮，流涎，瘰气，暴哑，咳嗽，哮喘，咽喉肿痛，吞咽困难等。

按语：廉泉系任脉和阴维脉之会穴。有清热利咽的功能。配翳风、合谷、少商治疗咽喉肿痛。

承 浆

部位：仰卧取穴。在下嘴唇之下，唇沟正中凹陷处（图42）。

穴释：承，承受；浆，浆水。浆水入口，此穴在下唇之下，能够承受，故名承浆。

针灸：向下斜刺2～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风，开窍醒神。

主治：下牙痛，齿龈肿，口噤不开，口疮，面肿，口眼歪斜，中风昏迷，休克，惊风，癲病，瘰病，口腔溃疡，半身不遂等。

按语：承浆系任脉、督脉、手阳明大肠经和足阳明胃经之会

穴。配地仓透颊车、下关、合谷治疗面神经麻痹。配人中、廉泉、哑门、合谷治疗癔病失音。配人中、内关、合谷、太冲治疗精神病。

第十四节 督 脉

本脉起于长强终于龈交，共28穴。络穴长强，后溪通督脉。

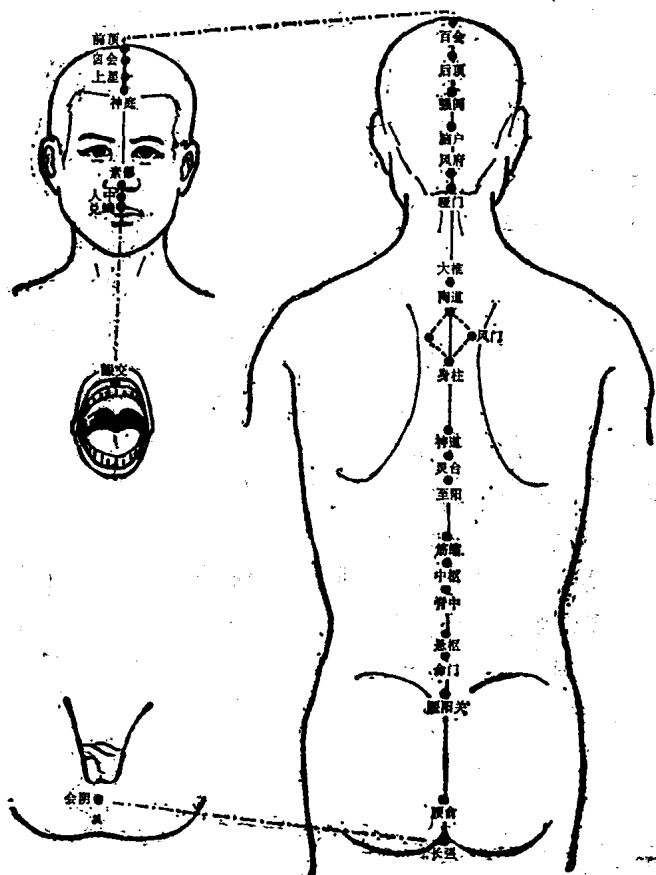


图44 督脉循行示意图和腧穴

循行概述：起于会阴部，由长强沿脊柱正中上行，过项后、头顶、前额至鼻柱下人中（图44）。

生理功能：督脉总督一身之阳脉，为“阳脉之海”，和脊髓、大脑有密切关系。

病理症候：脊柱强痛，角弓反张，头重，眩晕。

督脉穴歌：

督脉中行二十八，长强腰俞阳关达。

命门悬枢脊中穴，中枢筋缩至阳发。

灵台神道身柱位，陶道大椎颈七下。

哑门风府上脑户，强间后顶百会查。

前顶囟会连上星，神庭素髎人中扎。

兑端口上唇中央，龈交唇内靠上牙。

长 强

部位：俯卧取穴。在尾骨与肛门之间（图44）。

穴释：长，端长；强，强盛。此穴在尾骨下，督脉为诸阳之会，脉长而气盛，故名长强。

针灸：向上直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：培补下焦，清热利湿。

主治：痔疮，泄泻，痢疾，脱肛，便血，阳萎，遗精，癫痫，惊风，腰骶强痛，阴部搔痒，阴囊湿疹，子宫脱垂等。

按语：长强系督脉、足少阴肾经和足少阳胆经之会穴。督脉之络穴，别走任脉。配天枢、气海、会阳治疗里急后重。

腰 俞

部位：俯卧取穴。在第四骶骨下（屁股沟上边）凹陷中（图44）。

穴释：腰，腰背；俞，同输。此穴在骶骨下，是腰背部经气

输注之外，故名腰俞。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：培补下焦，清热利湿。

主治：泄泻，痢疾，脱肛，痔疮，遗尿，遗精，腰骶强痛，月经不调，下肢瘫痪等。

腰 阳 关

部位：俯卧取穴。在第四腰椎下凹陷中。约与髂嵴平齐(图44)。

穴释：腰，腰背，阳，背为阳；关，关界。此穴在第四腰椎下，其阳气通腹部关元而为阴阳交关之处，故名腰阳关。

针灸：直刺5～8分；灸5～10分钟。

功能：壮腰补肾，疏筋利节。

主治：遗精，阳萎，腰骶强痛，月经不调，赤白带下，下肢麻痹等。

按语：腰阳关功可补肾祛寒。配关元俞、上髎、关元、三阴交治疗遗精、阳萎，赤白带下。

命 门

部位：俯卧取穴。在第二腰椎下凹陷中。直立时与肚脐相对(图44)。

穴释：命，生命；门，门户。此穴在两肾之间，为精气之海，生命之门，故名命门。

针灸：直刺5～8分；灸10～20分钟。

功能：温肾壮阳。

主治：遗精，阳萎，水肿，遗尿，耳鸣，头痛，腰脊强痛，神经衰弱，月经不调，赤白带下，痛经，手足冷痹，下肢麻痹等。

按语：命门有培补肾阳的功能。是治疗命门火衰之腰膝冷痛、阳萎、遗精等症的常用穴。配肾俞、关元俞、上髎、次髎治

疗腰脊强痛和遗精、阳痿。

悬 枢

部位：俯卧取穴。在第一腰椎下凹陷中（图44）。

穴释：悬，悬挂；枢，枢纽。此穴在腰部，晃腰时以腰脐为枢纽，太极悬于腰中；仰卧时此处悬起不能平直，故名悬枢。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：温补脾肾。

主治：腰脊强痛，腹痛，泄泻，食积，水谷不化等。

脊 中

部位：俯卧或俯伏取穴。在第十一胸椎下凹陷中（图44）。

穴释：脊，脊骨；中，中间。此穴在第十一节脊椎下，居脊椎之中间，故名脊中。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：温补脾肾。

主治：腰脊强痛，癫痫，胃痛，腹胀，泄泻，食积，脱肛等。

中 枢

部位：俯卧或俯伏取穴。在第十胸椎下凹陷中（图44）。

穴释：中，中间；枢，枢纽。此穴在第十节脊椎下居中，为督脉之枢纽，故名中枢。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：温补脾肾。

主治：腰脊强痛，胃痛，腹胀，食积，消化不良等。

筋 缩

部位：俯伏取穴。在第九胸椎下陷中（图44）。

穴释：筋，肝主筋；缩，挛缩。此穴在肝俞之间，联筋络肝，主筋肉挛缩，故名筋缩。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：镇惊熄风。

主治：脊背强痛，癰瘤，瘰病，胃痛，小儿惊风等。

至 阳

部位：俯伏取穴。在第七胸椎下陷中。约与肩胛骨下角平齐（图44）。

穴释：至，到也；阳，背为阳。此穴在七椎下，近心处，心与七为阳中之阳，故名至阳。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：宽胸利膈，清热化痰。

主治：脊背强痛，胸胁胀痛，咳嗽，哮喘，疟疾，热病，黄疸，胃痛等。

灵 台

部位：俯伏取穴。在第六胸椎下陷中（图44）。

穴释：灵，心灵；台，楼台。此穴在六椎下，内应心脏，为心灵所居之台，故名灵台。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热化痰。

主治：脊背强痛，咳嗽，哮喘，热病，红丝疔等。

神 道

部位：俯伏取穴。在第五胸椎下陷中（图44）。

穴释：神，心神；道，道路。此穴在五椎下，内应心脏，为心神所通之道路，故名神道。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热熄风，宁心化痰。

主治：脊背强痛，心悸，咳嗽，哮喘，疟疾，热病，神经衰弱，小儿惊风等。

身 柱

部位：俯伏取穴。在第三胸椎下陷中（图44）。

穴释：身，身体；柱，支柱。此穴在三椎下，上连巅顶，下贯脊髓，横平两膊，为一身之支柱，故名身柱。

针灸：直刺3～5分；灸5～10分钟。

功能：清热散风，扶正祛邪。

主治：外感，身热，咳嗽，哮喘，疟疾，脊背强痛，癫痫，瘵病，神经衰弱，小儿惊风等。

按语：身柱有清肺平喘的作用。配大椎、风门、肺俞、膻中、列缺治疗胸膈满闷、喘息不得卧。

陶 道

部位：俯伏取穴。在第一胸椎下陷中（图44）。

穴释：陶，丘形上有两丘相重累曰陶；道，道路。此穴在第七颈椎第一胸椎似两丘相重累的下方，是督脉之气通行的道路，故名陶道。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风，扶正祛邪。

主治：外感，身热汗不出，咳嗽，哮喘，疟疾，脊背强痛，癫痫，小儿惊风等。

按语：陶道系督脉和足太阳膀胱经之会穴。功长疏风解表、清热截疟。配天柱、风门、身柱、至阳治疗项背强痛。配风池、大椎、合谷、后溪治疗发热汗不出、头痛、头重。配大椎、内

关、公孙治疗疟疾。

大 椎

部位：俯伏取穴。在第七颈椎与第一胸椎之间 凹陷 中（图44）。

穴释：大，高大；椎，脊椎。此穴在最高大的第七颈椎与第一胸椎之间，故名大椎。

针灸：直刺3～5分；灸5～15分钟。

功能：清热散风，扶正祛邪。

主治：疟疾，外感，热病汗不出，咽痛，咳嗽，哮喘，头痛，项强，胸痛，呕吐，脊背拘急，癰病，瘰病，黄疸，暑病，软骨病，贫血，神经衰弱，毛囊炎，视网膜出血，小儿惊风，小儿麻痹后遗症等。

按语：大椎系督脉和手足三阳经之会穴。有解表退热、发散风寒的作用。是临床常用穴。配风池、曲池、合谷治疗外感发热汗不出。配风池、人中、后溪、申脉治疗小儿惊风。

哑 门

部位：俯伏取穴。在项后正中，风府下五分，入发际凹陷中（图44）。

穴释：哑，哑疾；门，门户。此穴在项后发际，通舌根，为致哑与治哑之门，故名哑门。

针灸：向下颏直刺0.5～1寸。

功能：清热散风，化痰开窍。

主治：头痛，颈项强痛，角弓反张，中风不语，聋哑，癰病，瘰病等。

按语：哑门系督脉和阳维脉之会穴。有通经开窍之功。是治疗聋哑、失语的常用穴。配人中、百会、合谷治疗瘰病失语。

风 府

部位：俯伏取穴，在项后正中，枕骨粗隆（后脑勺）下两筋（两侧斜方肌）之间凹陷中（图44）。

穴释：风，风气；府，府库。此穴在项后发际正中如府的凹陷中，是感受与主治风邪之处，故名风府。

针灸：向下颌直刺3～5分。

功能：清热散风，化痰开窍。

主治：中风不语，头痛，颈项强痛，眩晕，鼻塞，鼻衄，咽喉肿痛，聋哑，癫痫，瘧病，小儿惊风，半身不遂等。

按语：风府系督脉、足太阳膀胱经和阳维脉之会穴。为治疗风邪侵犯脑府之要穴。配风池、人中、合谷、太冲治疗小儿惊风。

脑 户

部位：正坐取穴。在枕骨粗隆（后脑勺）上缘凹陷中（图44）。

穴释：脑，头脑；户，门户。此穴在枕骨部，为督脉入脑之门户，故名脑户。

针灸：沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清头散风。

主治：头痛，项强，癫痫，眩晕等。

按语：脑户系督脉和足太阳膀胱经之会穴。配命门、腰俞治疗癫痫。

强 间

部位：正坐取穴。在脑户前一寸五分（图44）。

穴释：强，强硬；间，间隙，中间。此穴在顶骨与枕骨缝之间，骨质强硬，故名强间。

针灸：沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清头散风。

主治：头痛，项强，癫痫，眩晕等。

后 顶

部位：正坐取穴。在强间前一寸五分（图44）。

穴释：后，后方；顶，巅顶。此穴在巅顶之后，故名后顶。

针灸：沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清头散风。

主治：癫痫，瘧病，头痛，眩晕等。

百 会

部位：正坐取穴。在头顶正中。前发际边与枕骨粗隆（后脑勺尖）之间凹陷中（图44）。

穴释：百，百脉；会，会合，交会。此穴在巅顶中央，为诸阳、百脉之会，故名百会。

针灸：沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清头散风，开窍醒神，回阳固脱。

主治：中风昏迷，口噤不开，尸厥，角弓反张，头痛，眩晕，鼻塞，耳鸣，耳聋，健忘，失眠，癫痫，瘧病，惊风，脱肛，遗尿，神经衰弱，半身不遂等。

按语：百会系督脉和手足三阳经之会穴。有清热开窍、镇惊熄风的作用。配风池、神庭、人中、合谷治疗癫痫、瘧病和尸厥。

前 顶

部位：正坐取穴。在百会前一寸五分（图44）。

穴释：前，前方；顶，巅顶。此穴在巅顶之前，故名前顶。

针灸：沿皮刺3～5分；灸1～3分钟。

功能：清头散风。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，癫痫，瘧病，神经衰弱等。

囟 会

部位：正坐取穴。在前顶前一寸五分骨隙中（图44）。

穴释：囟，囟门；会，会合。此穴在婴儿头顶软骨跳动、八岁后而合的囟门处，故名囟会。

针灸：沿皮刺3～5分；灸3～5分钟。婴儿禁针灸。

功能：清头散风。

主治：头痛，眩晕，鼻塞流涕，嗅觉失灵，小儿惊风等。

上 星

部位：正坐取穴。在鼻梁直上入前发际边一寸（图44）。

穴释：上，上方；星，光亮的星。此穴在前发际，如星之居上，使目光明，故名上星。

针灸：沿皮刺1～3分或点刺出血。

功能：清头散风。

主治：头痛，前顶痛，眩晕，目痛，目赤，热病汗不出，鼻塞，鼻衄，神经衰弱，小儿惊风等。

按语：上星有解表清热的作用，是治疗鼻病的主要配穴。配风池、上迎香、迎香、合谷治疗外感风邪、鼻塞流涕和鼻炎。

神 庭

部位：正坐取穴。在鼻梁直上入前发际边五分（图44）。

穴释：神，元神；庭，官庭。脑为元神之府，此穴在前发际，为元神之庭，故名神庭。

针灸：沿皮刺2～5分或点刺出血。

功能：清头散风。

主治：头痛，前顶痛，眩晕，目痛流泪，鼻塞流涕，头痛，失眠，神经衰弱，癔病，小儿急、慢惊风等。

按语：神庭故名思意为藏神之庭。系督脉、足阳明胃经和足太阳膀胱经之会穴。配风池、百会、人中、合谷、太冲治疗小儿惊风。配印堂、神门、三阴交治疗神经衰弱、失眠。

素 髻

部位：仰卧取穴。在鼻尖正中（图44）。

穴释：“素”，素白；“髻”，同窍，骨之空隙。此穴在鼻尖陷中，肺色白素、开窍于鼻，故名素髻。

针灸：直刺1～5分或点刺出血。

功能：清热开窍。

主治：鼻塞，鼻衄，鼻中疳肉，酒齄鼻，一氧化碳中毒等。

人 中（水沟）

部位：仰卧取穴。在鼻尖与上嘴唇尖之间，人中沟当中（图44）。

穴释：水，水液；沟，沟渠。此穴在鼻柱下人中沟流水液之处，故名水沟、人中。

针灸：向上斜刺5～8分，以有眼泪为度。

功能：清热熄风，苏厥醒神。

主治：中风，中暑，昏迷，急惊风，休克，癫痫，癔病，精神病，口眼歪斜，面肿，牙痛，腰脊强痛，崩漏，产后血晕等。

按语：人中又名水沟，系督脉、手阳明大肠经和足阳明胃经之会穴。有醒神开窍之长，为急救穴之一。凡见中风、昏迷、休克都可取此穴救治。配合谷、十二井治疗中风、中暑昏迷和癔病晕厥。配大敦、行间、隐白治疗血崩昏迷。

兑 端

部位：张口取穴。在上嘴唇尖正中，赤白肉际（图44）。

穴释：兑，兑上缺（≡）；端，端正。此穴在上唇端，口上之缺口似≡之处，故名兑端。

针灸：直刺2～3分或点刺出血。

功能：清热利湿。

主治：唇吻抽痛，牙痛，牙龈肿痛，口噤，癫痫，遗尿，尿闭等。

龈 交

部位：掀起上唇取穴。在上唇内，上唇系带与上齿龈之连接处（图44）。

穴释：龈，齿龈；交，交会。此穴在唇内上齿龈缝中，为任、督、手足阳明之交会处，故名龈交。

针灸：向上斜刺2～5分或点刺出血。

功能：清热利湿。

主治：牙龈肿痛，牙疳，口疮，鼻塞，癫痫，瘧病等。

第十五节 其它经脉

冲 脉

本脉起于横骨终于幽门，左右共22穴。公孙通冲脉。

循行概述：起于小腹内胞中，沿脊柱上行，出于气街，并于少阴，从横骨沿肾经挟脐上行，过咽喉，绕络口唇（图45）。

生理功能：“冲为血海”，司生育，胎产，月经，营养十二经脉、五脏六腑。

病理症候：气从小腹上冲，疝气，腹中胀满、拘急疼痛，症瘕，崩漏下血，月经不调。

交会穴位：横骨、大赫、气穴、四满、中注、育俞、商曲、

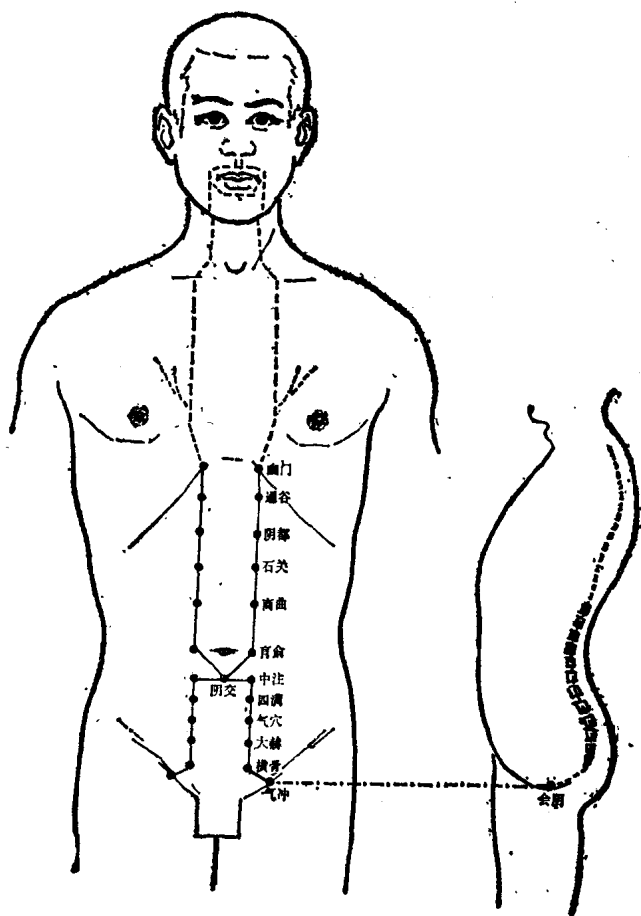


图45 冲脉循行示意图和腧穴

石关、阴都、通谷、幽门。会阴、气冲、阴交，公孙通冲脉。

带 脉

本脉起于带脉终于维道，左右共六穴。足临泣通带脉。

循行概述：起于季肋，横行绕腰一周（图46）。

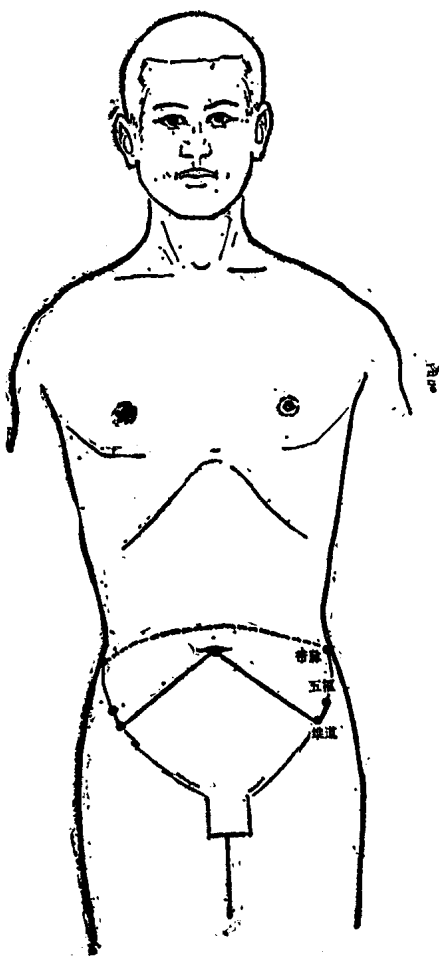


图46 带脉循行示意图和膻穴

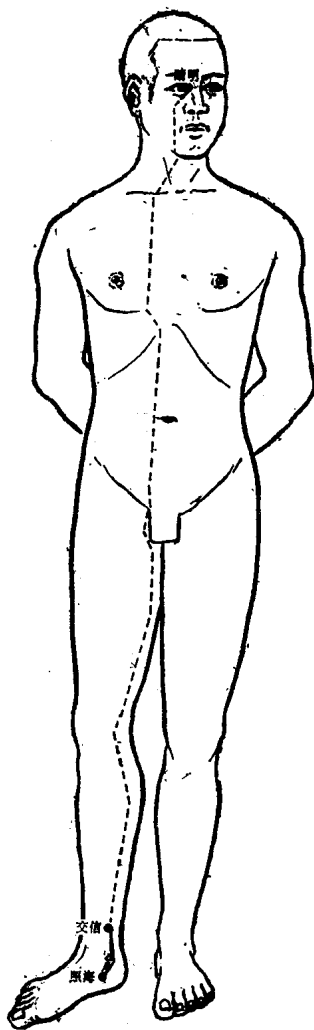


图47 阴跷脉循行示意图和膻穴

生理功能：带脉如束腰带，约束阴阳诸经，与任、督、冲三脉关系更为密切。

病理症候：腹部胀痛，赤白带下，腰困、痠痛，下肢痿软。

交会穴位：带脉、五枢、维道。足临泣通带脉。

阴 跷 脉

本脉起于照海终于睛明，左右共六穴。郄穴交信。

循行概述：起于照海，沿下肢肾经上行，过会阴、结喉至内眼角睛明（图47）。

生理功能：阴跷主阴气，司下肢运动。

病理症候：下肢阳经弛缓或阴经拘急的足内翻，阳气不足，阴气偏盛的嗜睡。

交会穴位：照海、交信、睛明。

阳 跷 脉

本脉起于申脉终于睛明，左右共22穴。郄穴跗阳。

循行概述：起于申脉，沿下肢膀胱经上行，过外踝、股外侧、腋窝后、肩上、口角至内眼角睛明（图48）。

生理功能：阳跷主阳气，司下肢运动。

病理症候：下肢阴经弛缓或阳经拘急的足外翻，阴气不足，阳气偏盛的失眠。

交会穴位：申脉、仆参、跗阳、居髎、臑俞、肩髃、巨骨、地仓、巨髎、承泣、睛明。

阴 维 脉

本脉起于筑宾终于廉泉，左右共14穴。郄穴筑宾，内关通阴维脉。

循行概述：起于筑宾，沿下肢肾经上行，过腹、胸至颈部廉泉（图49）。

生理功能：阴维有维系全身阴经的作用。

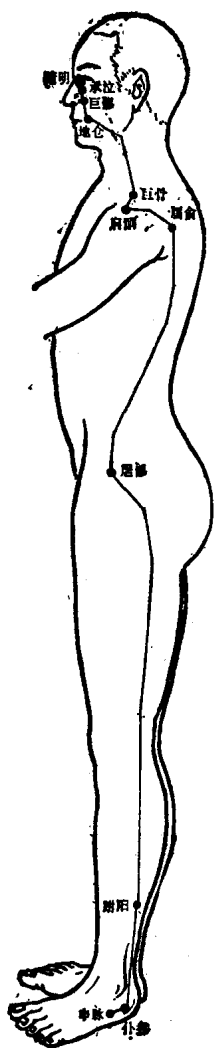


图48 阳跷脉循行示意图和腧穴

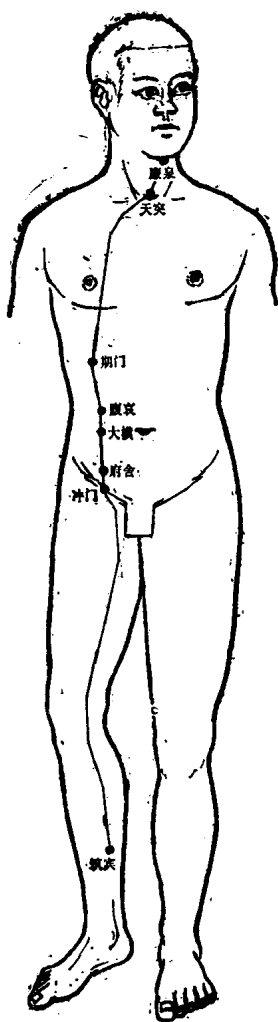


图49 阴维脉循行示意图和腧穴

病理症候：

主里，属阴，症见胸腹痛，
胃心痛。

交会穴位：

筑宾、冲门、府舍、大横、
腹哀、期门、天突、廉泉。内
关、通阴维脉。

阳 维 脉

本脉起于金门终于哑门，左
右共30穴。郄穴阳交，外关通阳
维脉。

循行概述：

起于金门，沿下肢胆经上
行，过外踝、胯、腋窝后、肩
上、前额至项后哑门（图50）。

生理功能：

阳维有维系全身阳经的作
用。

病理症候：

主表，属阳，症见恶寒发
热，头目眩晕。

交会穴位：

金门、阳交、臑俞、天髎、
肩井、头维、本神、阳白、头临
泣、目窗、正营、承灵、脑空、
风池、风府、哑门。外关通阳维
脉。



图50 阳维脉循行示
意图和腧穴

第十六节 经外奇穴

经外奇穴，指内、难二经未记载的穴位，是后世医家在医疗实践中逐渐发现的，并非和经络没有联系。兹根据临床常用的分述如下。

印 堂

部位：仰卧取穴。在两眉头之间（见图1）。

针灸：向下沿皮刺3～5分。

功能：清热散风。

主治：头痛，眉棱骨痛，口眼歪斜，眩晕，惊风，神经衰弱等。

鱼 腰

部位：仰卧取穴。在眉毛中间凹陷中。直对瞳孔（见图30）。

针灸：向上、向内或向外斜刺2～5分。

功能：清头明目。

主治：目翳，目赤，青盲，口眼歪斜，上眼眶痛，近视，结膜炎，视网膜出血，视神经萎缩等。

太 阳

部位：正坐或仰卧取穴。在眉尖与外眼角之间，再向外移一寸凹陷中（见图1）。

针灸：直刺3～5分或点刺出血。

功能：清头明目。

主治：目赤肿痛，迎风流泪，头痛，眩晕，口眼歪斜，青盲，近视，视网膜出血，视神经萎缩，三叉神经痛等。

球 后

部位：仰卧睁眼，目向内上方视取穴。在承泣与外眼角之间，下眼眶上缘凹陷中（图30）。

针灸：拇指或食指托住眼球，沿眼球下，向瞳孔后斜刺1～1.5寸。

功能：活血明目。

主治：青盲，青光眼，近视，视神经炎，视神经萎缩等一切眼病。

上 迎 香

部位：正坐取穴。在鼻翼软骨与鼻的骨性部之交点处（见图1）。

针灸：点刺2～3分，有时打喷嚏。

功能：清热散风，宣通鼻窍。

主治：伤风，鼻塞，头痛，目赤暴痛，鼻炎等。

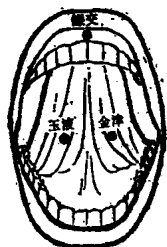
金 津（左）玉 液（右）

部位：张口翘舌取穴。在舌下系带两侧静脉中（图51）。

针灸：直刺2～3分或点刺出血。

功能：清热开窍。

主治：舌肿痛，口疮，音哑，咽喉肿痛，消渴，呕吐，泄泻等。



旁 廉 泉

部位：仰头取穴。在结喉旁约一横指（见图43）。

针灸：斜刺1～3分。

图51 金津（左）
玉液（右）

功能：清热导痰。

主治：中风昏迷，痰涎壅盛，咽喉肿痛，甲状腺肿，音哑等。

上廉泉

部位：正坐仰头取穴。在结喉上一寸，舌骨上方凹陷中（见图43）。

针灸：向舌根部斜刺1~1.5寸。

功能：利咽开窍。

主治：喑哑，聋哑，舌痛，流涎，吞咽困难，咽炎等。

百劳

部位：俯伏取穴。在督脉大椎上二寸旁约一寸（见图2）。

针灸：向下斜刺3~5分；灸3~5分钟。

功能：清肺化痰。

主治：瘰癧，颈肿，咳嗽，哮喘，肺癆，项、背强痛，支气管炎等。

喘患

部位：俯伏取穴。在第七颈椎旁一寸（见图2）。

针灸：向下斜刺5~8分；灸3~5分钟。

功能：宣肺定喘。

主治：咳嗽，哮喘，感冒，项背痛，支气管炎等。

定喘

部位：正坐取穴。在大椎旁约一横指（见图2）。

针灸：向下斜刺5~8分；灸3~5分钟。

功能：宣肺定喘。

主治：咳嗽，哮喘，喉痛，头项强痛，气管炎等。

腰 眼

部位：俯卧取穴。在第四腰椎旁约二寸凹陷中（见图2）。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：壮腰补肾。

主治：腰腿痛，遗精，阳萎，腰肌劳损，坐骨神经痛，月经不调，赤白带下，盆腔炎，下肢瘫痪等。

华佗夹脊

部位：俯伏或俯卧取穴。在第一胸椎至第五腰椎，每椎旁约五分一穴。共17对穴（图52）。

针灸：向脊椎斜刺5~8分；灸5~10分钟。

功能：通利关节，调理脏腑。

主治：脊背痠痛，腰肌扭伤，下肢麻痹，邻近部位的脏腑病等。

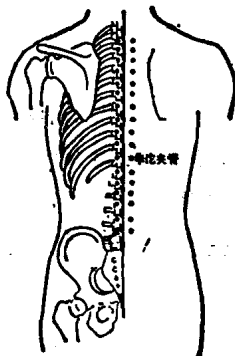


图52 华佗夹脊

提 托

部位：仰卧取穴。在任脉关元旁四寸（见图3）。

针灸：直刺0.5~1寸；灸10~20分钟。孕妇禁针。

功能：升提下陷，理气活血。

主治：小腹痛，疝气，子宫脱垂等。

子 宫

部位：仰卧取穴。在任脉中极旁三寸（见图3）。

针灸：直刺0.5~1寸。孕妇禁针灸。

功能：升提下陷，调经和血。

主治：子宫脱垂，月经不调，痛经，不孕症，盆腔炎等。

肩 缝

部位：举臂取穴。在大肠经肩髃内侧约一寸凹陷中（见图5）。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：疏筋利节。

主治：肩关节周围炎，上肢肿痛、麻痹等。

抬 肩

部位：正坐取穴。在肩峰前下方约一寸五分（图6）。

针灸：直刺1~2寸；灸5~10分钟。

功能：疏经活络。

主治：小儿麻痹后遗症，臂痛等。

疔 门

部位：手掌向下取穴。在手背面，第三、四指缝间赤白肉际（图53）。

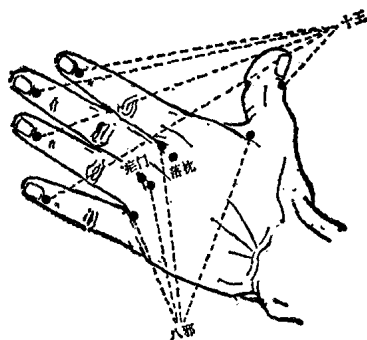


图53 疔门等穴

针灸：向上斜刺0.5~1寸。

功能：清热截疔。

主治：疔疾，手指痛等。

手 小 节

部位：屈指取穴。在手四指（无名指）中节外侧中间赤白肉际（图54）。

针灸：直刺2～5分。

功能：疏经止痛。

主治：扭伤、挫伤、创伤性疼痛等。

落 枕

部位：手掌向下取穴。在手背面，第二、三掌骨间，掌指关节后五分（图53）。

针灸：直刺0.5～1寸。

功能：疏通经络。

主治：落枕，肩臂痛，手指挛痛等。

八 邪

部位：握拳取穴。在手背面，五指的指缝纹头后凹陷中。左右共8穴（图53）。

针灸：直刺3～5分；灸3～5分钟。

功能：清热散风。

主治：手背红肿，手指挛痛，鹅掌风，蛇咬伤等。

十 王

部位：伸指取穴。在手指背面指甲根外约一分。左右共10穴（图53）。

针灸：直刺一分或点刺出血。

功能：清热苏厥。

主治：中风，中暑，昏迷，休克，瘧病，指甲青紫等。

三 关

部位：伸指取穴。在食指掌面第一、第二、第三道横纹上，每纹一穴，左右共6穴（图54）。

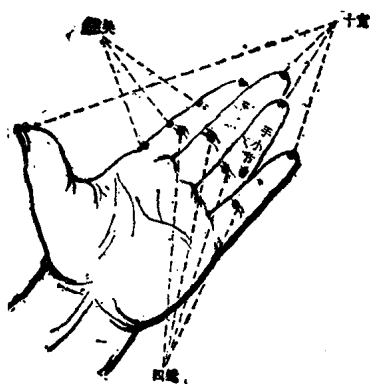


图54 三关等穴

针灸：点刺出血或挤出黄白色透明液体。

功能：清热消积。

主治：食积，疳疾，吐乳，消化不良，小儿惊风等。

四 缝

部位：手掌向上取穴。

在第二、三、四、五指掌面的中节横纹中，左右共8穴（图54）。

针灸：点刺出血或挤出黄白色透明液体。

功能：清热消积。

主治：腹泻，百日咳，消化不良，小儿疳积等。

十 宣

部位：伸指取穴。在手指尖正中，指甲前约一分，左右共10穴（图54）。

针灸：点刺出血。

功能：清热苏厥。

主治：中风，中暑，昏迷不醒，高烧，休克，瘧病，咽喉肿痛等。

四 强

部位：仰卧取穴。在髌骨（膝盖）上缘中点直上四寸五分（见图8）。

针灸：直刺1.5～2寸。

功能：疏经活络。

主治：小儿麻痹后遗症，瘫痪，腿痛，下肢无力等。

鹤 顶

部位：屈膝取穴。在髌骨（膝盖）上缘正中凹陷中（见图8）。

针灸：直刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：通利关节。

主治：膝关节肿痛，下肢瘫痪等。

上 阳 关

部位：仰卧屈膝取穴。在膝窝外面横纹头上一寸（见图8）。

针灸：直刺1~2寸。

功能：疏经活络。

主治：小儿麻痹后遗症，瘫痪，腿痛，膝关节肿痛等。

膝 眼

部位：垂足屈膝取穴。在髌骨（膝盖）下左右两个凹陷中（见图8）。

针灸：向上斜刺1~1.5寸；灸5~10分钟。

功能：通利关节。

主治：膝关节肿痛，下肢麻痹等。

陵 下

部位：仰卧取穴。在胆经阳陵泉下二寸（见图8）。

针灸：直刺1~2寸；灸5~10分钟。

功能：清泻胆火，疏经活络。

主治：耳聋，胆囊炎，腿痛，下肢瘫痪、麻痹等。

阑 尾

部位：仰卧取穴。在膝眼下约五寸，胫骨外找压痛点（见图8）。

针灸：直刺1~2寸。

功能：清热散瘀，通调肠道。

主治：阑尾炎，吐泻，腹痛，下肢瘫痪、麻痹等。

纠 下 垂

部位：仰卧取穴。在胃经解溪上二寸，胫骨外缘（见图8）。

针灸：直刺0.5~1寸。

功能：疏经活络。

主治：小儿麻痹后遗症，足下垂，下肢瘫痪等。

纠 内 翻

部位：俯卧取穴。在膀胱经承山外约一寸（见图7）。

针灸：直刺1~1.5寸。

功能：疏经活络。

主治：小儿麻痹后遗症，足内翻，下肢瘫痪等。

纠 外 翻

部位：俯卧取穴。在膀胱经承山内约一寸（见图7）。

针灸：直刺1~1.5寸。

功能：疏经活络。

主治：小儿麻痹后遗症，足外翻，下肢瘫痪等。

八 风

部位：垂足取穴。在足背面五趾的趾缝间。左右共8穴（图

55)。

针灸：直刺3~5分或点刺出血。

功能：清热散风。

主治：蛇虫咬伤，脚背红肿，足趾挛痛，脚气等。

足 小 节

部位：屈趾取穴。在足四趾中节·
外侧中间赤白肉际(图55)。

针灸：直刺2~3分。

功能：疏经止痛。

主治：扭伤，挫伤，创伤性疼痛等。



图55 八风等穴

第十七节 经络的分布与临床应用

经络分布到全身各部，有根结、标本、气街、四海、关、闾、枢等理论，对于理解特定穴有重要意义。兹分述如下。

一、根结标本与气街

四肢部为根为本，头身为结为标。气街是指经气通行的道路。对腧穴分类与辨证取穴有指导意义。

1. 根结：根为根本、根源；结有终结、归结的含义。脉气所起为根，所归为结。以四肢为“根”，故称“四根”，以头、胸、腹为“结”，故称“三结”。“根”，指四肢末端的井穴，“结”，指头面躯干的有关部位(表3)。

2. 根、溜、注、入：“根”，指井穴，即脉气所发出之处，“溜”，指原穴，即脉气所通过之处；“注”，指经穴，即脉气

表3 六经根结证治

类别		根	结	证候	治疗
经脉					
太阳	关	至阴	睛明	皮肉消瘦、干枯缓弱、邪易入之、而多暴急之病	暴病者，取之太阳
阳明	闾	厉兑	大迎	真气阻滞不行，邪气居留不去，筋脉失养，而至痿疾	痿疾者，取之阳明
少阳	枢	窍阴	听宫 (听会)	筋骨失养，骨节弛缓摇动、不能安稳站立于地	骨摇者，取之少阳
太阴	关	隐白	中脘	脾失健运，则水谷精微不能转输，水湿运化失常，膈气闭塞，洞泄不禁	膈洞者，取之太阴
厥阴	闾	大敦	玉堂	肝气弛缓而善悲，（肺气乘之，则为悲）	悲者，取之厥阴
少阴	枢	涌泉	廉泉	肾脉之气结滞，而下焦不通	不通者，取之少阴

所灌注之处；“入”，指脉气汇入两处：即上部的汇入颈项部膈穴，下部的汇入络穴（表4）。

3. 标本：“标”，指末端，“本”，指根本。标本与根结在词义上差不多，十二经在四肢的为“根”、为“本”，在头面躯干的为“结”、为“标”。十二经之“本”在四肢，其位较低；

表4 六阳经根流注入腧穴

类 别 经 脉	根	流	注	入	
				上	下
足太阳	至阴	京骨	昆仑	天柱	飞扬
足少阳	窍阴	丘墟	阳辅	天容	光明
足阳明	厉兑	冲阳	三里 (解溪)	人迎	丰隆
手太阳	少泽	阳谷 (腕骨)	小海 (阳谷)	天窗	支正
手少阳	关冲	阳池	支沟	天膈	外关
手阳明	商阳	合谷	阳溪	扶突	偏历

“标”在头身，其位较高。这说明，经脉分布有上下、内外的区别，经气有集中与扩散的联系。十二经标本部位（表5）。

根结、标本的关系：因为根上有本，结外有标，它们着重阐明经气散布于周身。根结主要说明经气循行两极（上下两头）相连的关系；标本则说明经气的弥漫散布；它们是互相贯通、共同阐明脉气上下、内外相应的关系。

4. 气街：“气”，指正气与邪气；“街”，指径路。也就是气所通行的道路。《甲乙经》说：“知六经之气街者，能知解结纽于门户”。是说能知道六经之气通行的径路，就可以知道邪气积结的所在，和怎样解除邪气的方法，促使气血通行的要道畅通。十二经的脉气密布于周身、躯干与四肢，而头、胸、腹、背，是经气所集中与通行的部位和道路。而这也就是经络学中所称的气街。故《灵枢·卫气》篇说：“胸气有街，腹气有街，头气有街，胫气有街，四街者，气之径路也”。就是说经气在头面、躯干有横向性分段联系的通路（表6）。

表 5 十二经标本部位腧穴

类 别 经 脉	标		本
	头	胸 背	四 肢
足阳明	人 迎		厉 兑
足少阳	听官 听会		窍 阴
足太阳	睛 明		附 阳
足太阴	舌本 廉泉	脾 俞	三 阴 交
足厥阴		肝 俞	中 封
足少阴	舌下两脉	肾 俞	内踝上下三寸中，交信 照海
手阳明	大 迎		臂臑 曲池
手少阳	角孙 丝竹空		液门（中渚）
手 阳	睛明上一寸		养 老
手太阴		中 府	太 渊
手厥阴		天 池	内 关
手少阴		心 俞	神 门

5. 根结、标本与气街的临床应用：

（1）《灵枢·邪气藏府病形》篇说：“十二经脉，三百六十五络，其气血皆上于面而走空窍”。《灵枢·卫气》篇说：“气在头者，止之于脑”。就是手足十二经脉之经气到头部的都联系头脑五官等部位，邪气在头部的，取百会穴治疗。因为手足三阳经的标、结都分部于头面、耳目等部位，所以手足阳经远端的腧穴，也都能治疗本经头面、耳目等部位的病症。

（2）《灵枢·卫气》篇说：“气在胸者，止之膺与背俞，

表6 气街部位经脉腧穴

类别 四街	经脉	止于部位	腧穴
头	手足三阳	脑	前 人迎(胃)
			侧 天容、天窗(小肠)天冲(胆) 天牖(三焦)扶突(大肠)
			后 天柱(膀胱)
胸	手三阴	膺	前 中府(肺)天池(心包)
		背俞	后 肺俞、厥阴俞、心俞(足太阳)
腹	足三阴	冲脉于脐 左右之动脉	前 盲俞(肾)天枢(胃)
		背俞	后 肝俞、脾俞、肾俞(足太阳)
胫	足阳明	气街	前 气冲(胃)
	足太阳	踝之上下	后 承山(膀胱)及踝周诸穴

气在腹者，止于背俞与冲脉，于脐左右之动脉者”。就是手三阴经之经气到胸部的都联系胸前的膺部有关穴位和背部俞穴；足三阴经之经气到腹部的都联系背部俞穴和腹部的冲脉。十二经脉、脏腑，在背部从上到下，依次有五脏六腑的俞穴，胸腹部有募穴。所以手三阴之标都在胸膺和背部，足三阴之标都在背部。邪气在胸膺前面的，取胸部两旁的穴位、在背后面的，取背部俞穴；邪气在腹部的，取背部的俞穴和天枢、盲俞治疗。

(3)《灵枢·卫气》篇说：“气在胫者，止之于气街，与承山踝上以下”。就是下肢部的经脉，其经气都联系或汇集于少腹气冲穴等处。所以邪气在胫部的，取气冲和承山及踝骨上下处的穴位治疗。

(4)根结、标本的部位，是指躯体大致上的一定区域范

围，由于各经的根结、标本各有不同的部位，因此，腧穴的主治也各有其特性。凡刺以上穴位，针前先用手指压按，以候其反应，或有疼痛或有动脉应手，乃刺之，可以治疗很多种病症。

基于上述理论，所以分布在头项、胸腹部的腧穴，既能治疗局部的病和有关脏腑病症，又能治疗四肢的部分病症，而四肢的腧穴，既可治疗局部的病和有关头项、胸腹部的病症，又能治疗有关的脏腑病症。这和《灵枢·终始》篇说的：“病在上者，下取之，病在下者，高取之；病在头者，取之足，病在腰者，取之膕”的方法是一致的。《灵枢·卫气》篇说：“下虚则厥，下盛则热；上虚则眩，上盛则热痛”。故实者，“绝而止之”，虚者，“引而起之”。是在下者为本，下虚则元阳衰于下，而为厥逆；下盛则阳气盛于下，而为热。在上者为标，上虚则清阳不升，而为眩晕；上盛则阳气盛于上，而为热痛，这是邪火上炽的缘故。治疗这种病，实证用泻法，以驱邪气绝其病根；虚证用引气的补法，以扶正气使其康复。《标幽赋》说：“更穷四根三结，依标本而刺无不痊”。就指出了根结、标本与气街理论的重要性。到现在这个理论对指导临床仍有它的一定作用。

二、四 海

四海比喻自然界的渤海、东海、黄海、南海。海有容纳聚集的涵义。人有髓海、血海、气海、水谷之海，四海为人体精神气血之源泉。也是营卫气血、十二经脉汇合之处（表7）。

1.胃是受纳饮食物的，称为“水谷之海”。胃居中焦，产生水谷之气（谷气），化为营气和卫气，营气流于脉中，卫气散布脉外，行于周身。其气输注出入的重要穴位，上在气冲，下在足三里。水谷之海有余的实证，则腹部胀满；不足的虚证，则在饥饿时也吃不下饮食。

2.冲脉上循脊里，与十二经脉会聚而贯通全身，称为“五脏

表7 四海及所通腧穴与证候

类别 海四	所通 腧穴		证 候	
	上	下	有 余	不 足
脑为髓海	百会	风府	轻劲多力，自 过其度	脑转耳鸣，胫痠眩冒 目无所见，倦怠安卧
冲脉为血海 (十二经之海)	大杼	巨虚之 上下廉	常想其身大，怫 然不知其所病	常想其身小，狭然不 知其所病
膻中为气海	哑门 大椎	人迎	气满胸中，惋 息面赤	少气，不足以言
胃为水谷之 海	气冲	三里	腹 满	饥不受谷食

六腑之海”、“十二经之海”、“血海”。冲脉起于胞中，居脐下，属下焦。《难经》说：“脐下、肾间动气”，为十二经之根本，为原气，动而上下行，渗灌气血于全身。其气输注出入的重要穴位，上在大杼，下在上巨虚和下巨虚。血海有余的实证，则经常感觉身体重滞高大，郁怒不舒，但一般看不出有病的样子；不足的虚证，则经常感觉身体轻瘦短小，胸闷不舒，但外表上亦看不出有病的样子。

3. 膻中，即胸中，是宗气会聚之处，称为“气海”。胸中属上焦，贯心肺而行呼吸，为宗气，推动气血运行不息。其气输注出入的重要穴位，上在柱骨上下（哑门、大椎），前在人迎。气海有余，则邪气盛，发生气满胸中，胸中满闷、喘息、气上逆而面赤；不足，则正气虚，就会因元气衰少而语言轻怯无力。

4. 脑是脑髓聚集之处，称为“髓海”。气血津液的精华主补

益脑髓而濡空窍，髓者以脑为主，故称脑为髓海。脑髓来源于“先天之精”和“后天之精”，杨上善说：“胃流津液渗入骨空，变而为髓，头中最多，故为海也”。其气输注出入的重要穴位，上在百会，下在风府。髓海充足，则身轻劲足，体力强盛，能享有超过一般人的高寿；不足，就会发生头象旋转样的昏晕、耳鸣，小腿发痠，头目眩晕而恍恍惚惚，看不清东西，四肢乏力，只想嗜睡等病证。

要调治上述病证，必须审查其病证的虚实，取“四海”经气输注的腧穴，虚证用补法，实证用泻法，不要违背这个法则，就是能顺从这个治疗法则治疗的，就能使病人恢复健康；否则治疗就会失败，或有害于健康。

上焦宗气，中焦谷气，下焦原气，共同构成人体的真气（正气）。《灵枢·刺节真邪》篇说：“真气者，所受于天，与谷气并，以充身者也”。真气行于经络则称为“经气”或脉气，各经的穴位称为“脉气所发”，又是“神气之所游行出入”的部位。神气的本源在脑，故称脑为“元神之府”。谷气，宗气，原气，神气，漫布全身。这一理论，对指导临床有重要意义。

三、三阳三阴与关、阖、枢

三阳三阴的气机变化，古人概括为“关”、“阖”、“枢”。关指门闩，其位在后，主关闭；阖指门扇，其位在前，主闭阖；枢指门轴，其位在侧，主转动。三者各有其方位和作用，阴阳之起始为“关”，阳之盛或阴之衰为“阖”，阴阳之转纽为“枢”。现结合皮部命名、六经辨证分述如下（表3）：

1. 太阳居三阳之表，为关，在皮部为“关枢”。“关”，固卫也，使营卫流于外者固，即太阳能约束而固卫其输布之阳，亦即太阳在人身如门之关，能维护其外，以固表御邪。如太阳关的

功能失调或减弱，皮肉就会消瘦、干枯、松弛；如风寒侵犯太阳，常见发热恶寒、头痛鼻塞、身痛无汗；如太阳卫外失固，感受外邪，即《灵枢·根结》篇说的“关折”，就会发生暴急之病；都可取太阳经穴治疗。

2. 阳明居三阳之里，为阖，在皮部为“害蜚”。“蜚”，古飞字，飞扬也，阳盛而浮也，必损，阳明、阳之损也。阳明在人身如门之阖，使营卫守于内者固，即阳明阖的功能、通调水谷、化生气血、运行全身，收藏阳气充养脏腑，主润肌肉宗筋。如阳明阖的功能失调、感受热邪，就会发生烦躁、恶热、谵语、腹痛、大便干燥等症状；如外邪侵犯，肢节筋肉失养，即《灵枢·根结》篇说的“阖折”，就会发生痿躄之病；都可取阳明经穴治疗。

3. 少阳居三阳表里之间，为枢，在皮部为“枢持”。“枢”，机也，“持”，主持。少阳在人身如门之枢，转动由之，使营卫出入内外也常。即少阳如机之枢纽，有转输内外、可出可入的功能。如少阳枢的功能失调或邪犯少阳，就会发生往来寒热、胸胁苦满、心烦喜呕等证；如少阳转输内外之经气失常，即《灵枢·根结》篇说的“枢折”，就会发生骨节弛缓不收、动摇不安、站立不稳等证；都可取少阳经穴治疗。

4. 太阴居三阴之表，为关，在皮部为“关蛰”，“关”者，固外也，“蛰”即阴盛阳伏。即太阴在人身如门之关，能约束闭藏之阴气，不使外泄。如太阴“关”的机能失调，脾失运化，谷气不能转输，即《灵枢·根结》篇说的“关折”，上则膈气痞塞不通，不能容纳水谷；下则洞泻不止；都可取太阴经穴治疗。

5. 厥阴居三阴之里，为阖，在皮部为“害肩”。“肩”，任也，载也，阳主运，阴主载，阴盛之极，其气必伤，此言阴极对万物的损害。即厥阴在人身如门之阖，使血气、精神、情志内守，充养脏腑、濡润宗筋。如厥阴“阖”的机能失调，情志所

伤，肝气郁结不舒，即《灵枢·根结》篇说的“阖折”，则可见胁肋窜痛，胸闷不舒、易怒、善悲、食欲不振、干呕等证，可取厥阴经穴治疗。

6.少阴居三阴表里之间，为枢，在皮部为“枢儒”。“儒”，文柔也，阴气柔顺。即少阴在人身如门之枢，使营卫内外出入。如少阴枢的机能失调，阴气盛则欲寐，虚阳上亢则心烦不得眠；《灵枢·根结》篇说的“枢折”，“则脉有所结而不通”，脉气滞结不通等证，都可取少阴经穴治疗。

上述六经病，邪气有余的实证用泻法，正气不足的虚证用补法。

第二篇 针灸方法

第一章 针 法

《灵枢·九针十二原》篇载述：“凡用针者，虚则实之，满则泻之，宛陈则除之，邪胜则虚之”。说明当人体的生理功能发生异常而反映出病理现象时，应根据病症的需要，选用不同形式的针，在人体腧穴或皮肤表面，刺入皮内或肌肉、筋骨间的经络通行之处，施予适合病情的针法，使患者产生痠、麻、困、重、胀、热、凉等感觉，或在局部放血排脓，达到气血调和，经络通畅，补虚泻实，祛邪扶正，治疗疾病，恢复健康的目的。

第一节 古代九针简介

《灵枢·官针》篇说：“九针之宜，各有所为，长、短、大、小，各有所施”。现将九针的名称、形状、用途分别介绍如下（图56）。

镵针：又名箭头针。针体宽0.5寸，长1.6寸，头大，末端一分锋锐。用于浅刺皮肤放血、排脓，治疗头身热证和痈肿等。

铍针：长1.6寸，针身圆柱形，针尖卵圆形。用于按摩体表，顶压穴位，治疗分肉间气血瘀滞病。

铤针：长3.5寸，针头如黍粟状，圆而微尖。用于按压经脉，不能深刺。治疗脉气虚少者。

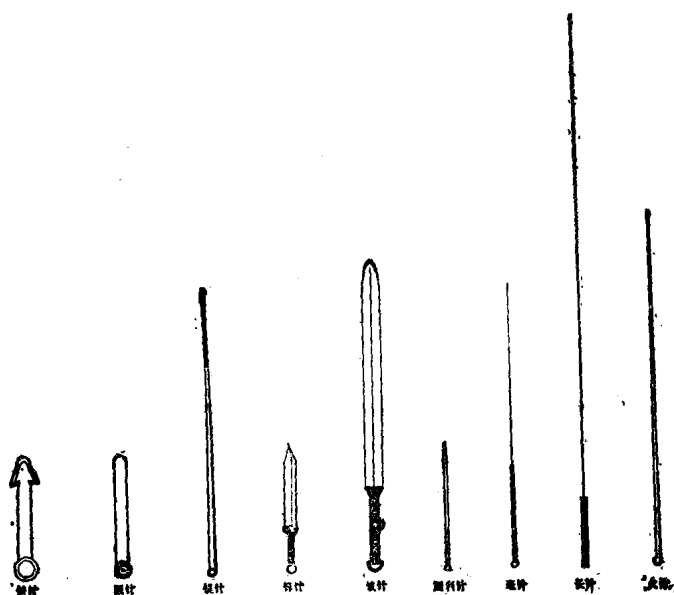


图56 古代九针

锋针：又名三棱针。长1.6寸，针身圆柱形、针头锋利、三棱形。用于放血、排脓，治疗热病、痈肿。

铍针：又名铍针。长4寸，宽2.5分，形如剑，末如剑锋。用于割治、排脓，治疗痈肿。

圆利针：长1.6寸，针头微大，比毫针略粗，圆而且利。用于体壮者、深刺，治疗痹症和痈肿。

毫针：长3.6寸，针细如毫毛。即现代临床常用的针灸针。用于深刺、浅刺，治疗各种病症。

长针：又名环跳针。长7寸。用于肌肉较厚处穴位的深刺，治疗深部痛痹。

大针：又名火针。长4寸，针身粗圆形。烧红后，速刺速退，排脓，常用于治疗颈部淋巴结核。

一、毫针的规格

目前毫针多为不锈钢制成,针体长度有0.5寸、1寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸等数种。针体粗细分26号、28号、30号、32号等数种。针体有弹性、滑利、针尖锐度适宜者为好。其中以1.5~3寸长和28~30号粗细的毫针,临床应用最广泛(图57)。

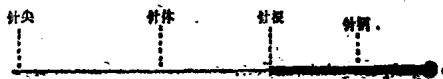


图57 毫针规格

二、选针与藏针

1.选针:毫针有长短、粗细之分,目的在于适应医者按病情选择应用。选择的得当与否和疗效有密切关系。选择针之长短,应根据针刺穴位局部肌肉之厚薄,患者身体的胖瘦、强弱、年龄的大小、穴位的深浅以及病之在表在里、病情的虚实不同而定。穴位处肌肉厚、病在里、胖人,应刺深些,当选长针;反之则刺浅些,当选短针。选择毫针的粗细,应根据患者的体质强弱、病情的虚实和对针感的适应性,以及医者手法操作的熟练程度而定。体质强壮,病属实热,穴位局部肌肉丰满者选用粗针,反之则选用细针。但针体越粗针感越大,反之则小。针体过粗,容易引起疼痛,并且有损伤脏腑器官的危险;针体过细,技术不熟练不易进针。所以选针必须根据术者和患者的具体情况而定。

2.藏针:藏针的目的是防止生锈,避免针体弯曲和针尖受损。藏针的方法是:在煮沸消毒时,应用纱布包裹,以防针尖与消毒锅壁碰撞,引起针尖损伤。毫针使用完毕,必须用棉花擦净,放在针盒、针管或针夹内,并须垫以棉花、纱布,以保护针尖。

第二节 内经刺法

《灵枢·官针》篇说：“凡刺之要，官针最妙。九针之宜，各有所为，长、短、大、小，各有所施也。不得其用，病弗能移。疾浅针深，内伤良肉，皮肤为痛；病深针浅，病气不泻，皮为大脓。病小针大，气泻太甚，疾必为害；病大针小，气不泄泻，亦复为败”。其内容不但丰富，而且在今天的临床上仍有十分重要的实用意义。兹将九刺、十二刺及五刺的方法，综合介绍如下：

一、属于不同浅深的刺法

（一）刺皮

1.毛刺：“毛刺者，刺浮痹皮肤也”。这是《素问·刺要论》说的“刺毫毛腠理无伤皮”的刺法。由于针刺浅浮的毫毛腠理，故称毛刺。临床上常用各种皮肤针、梅花针轻叩、不仅治疗皮肤麻木不仁的“浮痹”、皮肤病，而且还可治疗脏腑病。

2.半刺：“半刺者，浅内而疾发针，无针伤肉，如拔毛状，以取皮气，此肺之应也”。由于针不全入，象拔毛样的浅刺皮肤，不伤肌肉，故称半刺。因为肺主皮毛，刺皮可消散肺邪，所以和肺脏相应。这种针法比毛刺略深，临床上常用各种皮肤针、梅花针叩打、皮内埋针，宣泻表邪，治疗风寒束表、发热咳嗽及某些皮肤病症等。

3.直针刺：“直针刺者，引皮乃刺之，以治寒气之浅者也”。由于沿皮进针，上下垂直或向左右平刺，故称直针刺。临床上这种针法，是将穴位上的皮肤捏起，然后将针从捏起处沿皮刺入，不伤肌肉，常取瞳子髎透颧髎、地仓透颊车，治疗风寒客邪侵入较浅的面神经麻痹、拘急、抽搐等证。

（二）刺脉

1.经刺：“经刺者，刺大经之结络经分也”。由于针刺经脉所过部位、气血瘀滞结聚不通之处，故称经刺。临床上这种针法，是在患病的本经脉循行线上，循摩压按，发现压痛、硬结、条索等闭结不通之处，用针刺之，以通其经气，治疗经络瘀滞、气血不通所致之局部红肿、疼痛和经络、脏腑的其它病证。

2.络刺：“络刺者，刺小络之血脉也”。这是《素问·调经论》说的：“病在血，调之络”的刺法。由于浅刺小络出血，故称络刺，亦称刺络。临床上常取十宣、十二井、尺泽、委中、“三关纹”，用点刺法放血，疏泻热邪，治疗暑热高烧、惊风、中风、急性胃肠炎、小儿食积内热等证。

3.赞刺：“赞刺者，直入直出，数发针而浅之出血，是为治痈肿也”。赞有赞助、帮助的含意，由于在患处用三棱针速刺速出、浅而多刺，放血排脓，帮助痈肿消散，故称赞刺。临床上常用这种方法，放出粘液治疗腱鞘囊肿。

4.豹文刺：“豹文刺者，左右、前后针之，中脉为故，以取经络之血者，此心之应也”。由于在经络患处散刺多针，出血点似豹皮的斑纹，故称豹文刺。因为心主血脉，所以和心脏相应。临床上常用这种针法，在病痛的局部前后、左右散刺多针，或用梅花针重叩，使之出血，消散经络中的瘀滞，治疗局部血肿、静脉曲张、静脉炎和热邪亢盛的急性结膜炎等证。

（三）刺肉

1.浮刺：“浮刺者，傍入而浮之，以治肌急而寒者也”。由于从穴位傍边斜针刺入而浅浮，故称浮刺。临床上常用毫针斜刺肌肉和皮下埋针，治疗感受寒邪所致的肌肉拘急、面肌痉挛等证。

2.分刺：“分刺者，刺分肉之间也”。由于针刺分肉之间的缝隙，故称分刺。《素问·调经论》说的“病在肉，调之分肉”，就属此法。临床上常用这种针法，治疗肌肉松软、麻痹、

萎缩、痉挛、震颤和痠痛等证。

3.合谷刺：“合谷刺者，左右鸡足，针于分肉之间，以取肌痹，此脾之应也”。由于“肉之大会为谷”，一针三向成“个”字形刺于肌肉会合之处，故称合谷刺。因为脾主肌肉，所以和脾脏相应。临床上常用这种针法，将针刺至一定深度后，将针提至皮下，再分别向左右两侧各斜刺一针，象鸡爪的分叉针于分肉之间，治疗肌肉麻痹、痠痛和痉挛。有时用于搜寻感觉。

（四）刺筋

1.关刺：“关刺者，直刺左右尽筋上，以取筋痹，慎无出血，此肝之应也”。由于针刺四肢筋的尽端关节附近，故称关刺。因为肝主筋，所以和肝脏相应。临床上常用这种针法，治疗关节炎、关节痛、筋肉拘急、痉挛和筋痹等证。但施针时要慎重，不要刺伤脉管、关节囊和软骨，以防出血、出液，引起关节不得屈伸、肿胀、疼痛等症。

2.恢刺：“恢刺者，直刺傍之、举之，前后恢筋急，以治筋痹也”。由于针刺筋的附近，使拘急的筋恢复正常，故称恢刺。临床上这种针法，是在筋的旁边直刺、斜刺、横刺、多向透刺，结合提插搓捻，促其气至，以通其经气，缓解筋急，治疗拘急、痉挛、疼痛、腰肌劳损等证。

（五）刺骨

1.短刺：“短刺者，刺骨痹，稍摇而深之，致针骨所，以上下摩骨也”。由于针接近骨部，在距离骨很近的地方，短促而快速的操作，故称短刺。临床上这种针法，是将针进到一定深度，边摇动、边渐渐深入，使针尖直达骨的附近，上下轻微的提插、搓捻，以摩擦刺激骨膜，治疗关节炎、骨痹等深部病证。

2.输刺：“输刺者，直入直出，深内之至骨，以取骨痹，此肾之应也”。输有内外输通的含意，由于直进直出，深刺至骨，输泻深居骨节间的病邪，故称输刺。因为肾主骨，所以和肾脏相

应。临床上常用这种针法，治疗肩、肘、膝关节炎和骨痹等深部病证。

二、属于取穴原则的刺法

（一）取五俞和背俞穴

输刺：“输刺者，刺诸经荣输、脏输也”。由于取特定穴中的五俞和背俞治病，故称输刺。临床上常取十二经的井、荣、俞、经、合及背部脏腑俞穴为主，治疗有关的脏腑、经络各种病证。

（二）局部取穴

“以痛为输”。这种针法，是在病痛的局部取穴治病的方法。后世的“阿是穴”、“不定穴”、“天应穴”，就是按此法发展而来的。

（三）远隔取穴

远道刺：“远道刺者，病在上，取之下，刺腑输也”。由于上病取下，所针之穴距离病位较远，故称远道刺。临床上常取百会治疗脱肛、足三里治疗胃病、委中治疗腰痛……。

（四）前后配穴

偶刺：“偶刺者，以手直心若背、直痛所，一刺前，一刺后，以治心痹。刺此者，傍针之也”。由于前后、俞募、阴阳同时刺，似配偶，故称偶刺。这种针法，是在针刺之前，先以手指循按前胸募穴和后背俞穴，或在痛点上一针刺前胸，一针刺后背，治疗心痹和心气不舒的心胸疼痛证。但针时必须斜刺，以防刺伤内脏。临床上称这种针法，为俞募配穴，常取肺俞、中府治疗咳嗽，中脘、胃俞治疗胃病……。

（五）左右取穴

1. 阴刺：“阴刺者，左右率刺之，以治寒厥，中寒厥，足踝后少阴也”。由于取刺足少阴经的两侧太溪穴，治疗阴寒内盛的寒厥证，故称阴刺。临床上常取太溪治疗足心冷痛，十二原穴

治疗四肢厥冷和疼痛等证。

2. 巨刺、缪刺：“巨刺者，左取右、右取左”。《素问·调经论》说的：“身形有痛，九候莫病，则缪刺之；痛在于左而右脉病者，巨刺之”和《素问·缪刺论》说的：“邪客于经，左盛则右病，右盛则左病，亦有移易者，左痛未已而右脉先病，如此者，必巨刺之，必中其经，非络脉也，故络病者，其痛与经脉缪处，故名缪刺。就是左病取右、右病取左，深刺经为巨刺、浅刺络为缪刺的区别。由于巨与距相通，缪与误同意，取穴与病位的距离不但远隔，而且缪误，故称巨刺、缪刺。临床上常取左合谷治疗热在阳明的右侧龈肿牙痛，取右偏历治疗风寒袭络的左侧面瘫。

三、其它刺法

（一）多针

1. 齐刺：“齐刺者，直入一，傍入二，以治寒气小深者；或曰三刺，三刺者，治痹气小深者也”。由于在病位正中和左右两侧各刺一针、三针齐下，故称齐刺、三刺。临床上常用这种针法，治疗局限性疼痛、麻木、痠困和寒气稽留范围较小而又较深的痹证。

2. 扬刺：“扬刺者，正内一，傍内四而浮之，以治寒气之搏大者也”。由于五针齐下，浅刺速出，轻而扬之，故称扬刺。临床上这种针法，是将五根针捆在一起，用手指捏持，刺入皮肉后迅速将针抖出，以扩大针孔，或用梅花针重叩，捏挤出血，治疗疼痛、麻痹、热毒、疮疖和风寒湿侵及范围较广而浅的痹证。

3. 傍针刺：“傍针刺者，直刺傍刺各一，以治留痹久居者也”。由于在病位正中和傍边各刺一针、两针邻近，正傍配合，故称傍针刺。临床上常用这种针法，治疗压痛明显、固定不移、久治不愈、寒气较深的痛痹。

4. 报刺：“报刺者，刺痛无常处也。上下行者，直内无拔针，以左手随病所按之，乃出针复刺也”。报有复之含意，由于

出针后又复刺，故称报刺。临床上这种针法，是先在痛处直刺一针，不立即出针，再以左手在痛处上下循按，并询问患者有否压痛，找到新痛点后，将前针拔出，再复刺新痛点，发现一个新痛点，就复刺一针，根据痛点多少，决定复刺的针数，常用于治疗游走性串痛、痛无定处的“行痹”。

（二）燔针

燔刺：“燔刺者，刺燔针则取痹也”。由于将针烧红而刺，故称燔刺。《灵枢·经筋》篇说的：“燔刺者，刺寒急也；热则筋纵不收，无用燔针”，就是燔刺的适应症和禁忌症。临床上是将烧红的针，对准病变的局部，迅速刺入一定的深度，当即迅速将针拔出，常用于治疗寒痹、瘰癧等证。

（三）排脓

大泻刺：“大泻刺者，刺大脓以铍针也”。由于用铍针切开脓疡，排脓放血，祛邪外出，故称大泻刺。临床上常用三棱针，放出粘液，治疗腱鞘囊肿。

（四）输刺

“输刺者，直入直出，稀发针而深之，以治气盛而热者也”。输有输通的含意，直入直出，能输泻热邪，故称输刺。《灵枢·官针》篇中有三种输刺，这一种和前两种不同。这种是垂直进针，得气后垂直退出，取穴少，刺入较深，用泻法，治疗气盛有热的病证。临床上常用提插补泻中的泻法，深刺天枢、丰隆、支沟等穴治疗气盛有热的大便秘结。

第三节 针治的作用及注意事项

针治的作用很多，能治疗很多种疾病，但用之不当，也会给患者造成痛苦，甚至发生事故。所以采用针法时也应注意。

一、针治的作用

《灵枢·经脉》篇说：“盛则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之……不盛不虚，以经取之”。《刺节真邪》篇说：“用针之类，在于调气”。说明在穴位上用不同针刺手法，有补虚、泻实、调整机体平衡、治疗很多病症的作用。

1.扶正补虚：凡属脾肾阳虚引起的久泻、脱肛、阳萎、遗尿、神衰乏力或气血不足引起的麻痹、痿软等病症，取一定的穴位用补法，有扶正补虚、益气培元的作用。

2.祛邪泻实：凡属脏腑实热引起的腹满、便秘、尿闭、尿赤或感受外邪引起的烦躁、神昏和疼痛、痉挛等病症，取一定穴位用泻法，有祛邪泻实、清热导滞的作用。

3.调和阴阳：凡属气血失调引起的胸满、胁痛、气郁不舒、眩晕、失眠或阴阳偏盛偏衰引起的功能失调性病症，取一定的穴位用平补平泻法，有调和阴阳、疏通气血，调整机体平衡的作用。

4.调通经络：凡属经络阻塞引起的麻木、痠痛、肿胀等症，针刺一定的穴位，有疏通经络、通调气血的作用。

5.清热解毒：凡属风、寒、暑、湿、燥、火等外邪引起的发热无汗，咽喉肿痛和急性腹痛、吐泻等症，取一定穴位用点刺法放血，有清热除烦、泻火解毒的作用。

6.镇痉止痛：凡属内夹实热或感受外邪引起的惊风、痉挛、剧烈疼痛等症，取一定穴位用泻法，有清热熄火、镇痉止痛的作用。

7.消坚散结：腱鞘囊肿，用三棱针在囊肿顶端点刺，将胶状粘液挤净；瘰疬用火针；瘰气在局部用围刺法留针，有消坚散结的作用。

二、针治注意事项

1.体位：在进针前，患者应采取舒适、能持久而又便于医者操作的体位。配穴治疗时，应尽量少变换体位。现将临床常用的体位分述如下（图58）：

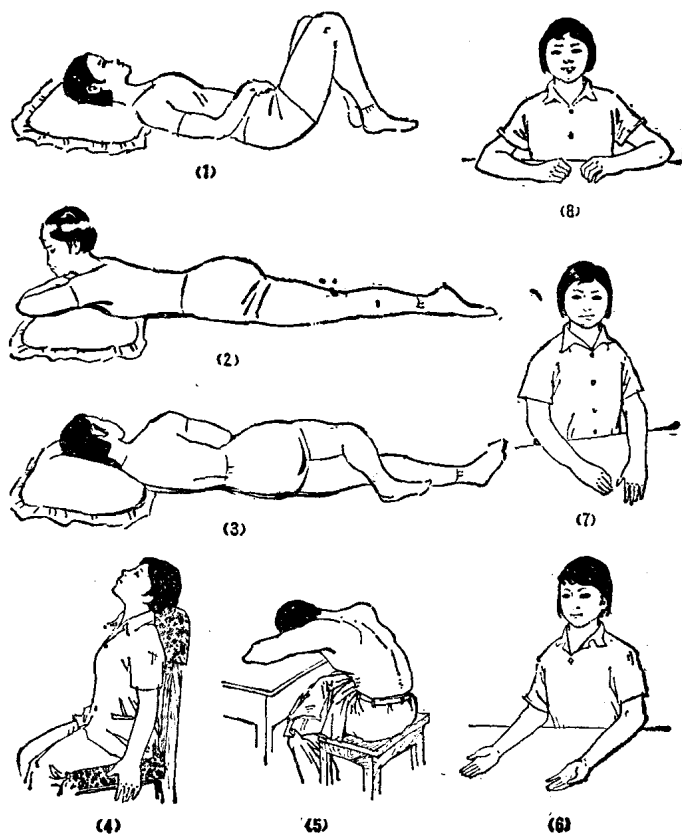


图58 体位

仰卧位：用于取头面、胸腹和下肢前面等穴位（1）。

俯卧位：用于取背腰、臀和下肢后面等穴位（2）。

侧卧位：用于取章门、环跳等人体侧面穴位(3)。

仰靠位：用于取头面和颈部等穴位(4)。

俯伏位：用于取头项和背腰部等穴位(5)。

屈肘仰掌位：用于取上肢手掌面等穴位(6)。

屈肘俯掌位：用于取手背面等穴位(7)。

屈肘拱手位：用于取上肢外侧面等穴位(8)。

2.进针角度：取穴局部解剖部位不同，针感传导方向临床需要不同，进针的角度亦不一致(图59)。

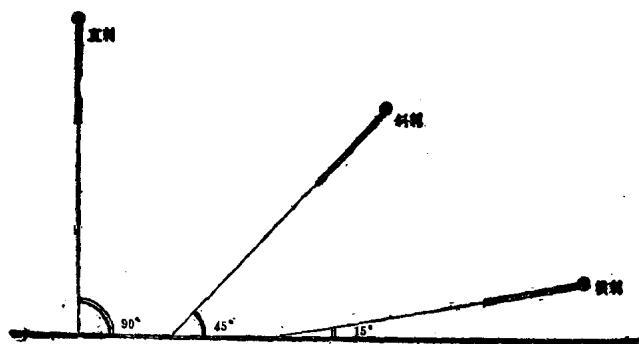


图59 针刺角度

(1)直刺：是针体与皮肤呈90°角垂直刺入。这种方法适用于全身大多数穴位。有时为使针感向四周扩散，常采取直刺盘摇法。

(2)斜刺：是针体倾斜与皮肤呈45°角刺入。这种方法多用于内有主要内脏的部位。如胸、背的中府、肺俞等穴。有时为使针感向需要的方向传导，常以针尖指向病所。

(3)横刺(沿皮刺)：是针体与皮肤呈15°角刺入。这种方法多用于肌肉较薄的部位。如头部的百会、上星等穴。此外为了加强刺激量，或联络经络，在一针透数穴时也用此法。如地仓透颊车等。

3. 针刺深度：每个穴位的针刺深度，在经络腧穴篇中已有详细论述，但在实际施针时，还要根据病人的年岁，胖瘦和感应大小，病之深浅酌情增减。

(1) 年岁：全身穴位的针刺深度，是按正常中年人制定的，老人和儿童气血不足，针刺应当浅些。

(2) 胖瘦：体壮的胖人，针刺应当深些；体弱的瘦人，针刺应当浅些。

(3) 感应：施针时痠胀或触电感大的或感应出现快的，以及精神紧张、怕针的患者，针刺应当浅些；感应迟钝或感应小的针刺应当深些。

(4) 病位：病在表的，应刺浅些；病在里的，应刺深些。正如《素问·刺要论篇》说的“病有浮沉，刺有浅深，各至其理，无过其道；过之则内伤，不及则生外壅……浅深不得，反为大贼……”。

4. 取穴顺序：一般先取上部的穴位，由上而下的按顺序往下针；双侧取穴，应针了一侧，再针另一侧；因病情需要，先取下部穴位时，应由下而上的按顺序往上针。拔针亦应如此。也就是应按顺序施针和起针。不应上肢扎一针，下肢扎一针，反过来又在上肢扎一针，下肢扎一针，打乱取穴顺序。

5. 消毒：棉花、纱布、镊子、针和藏针器具以及与针直接接触的用品，均应消毒，一般针和镊子用75%酒精浸泡30分钟或煮沸消毒。每针只针一穴，用后再消毒。术者在治疗前应先将手洗净，然后再用酒精棉球在穴位上由内向外涂擦消毒；放血时应应用碘酒消毒，再用酒精棉球擦净。

6. 工作细致：医生态度要和蔼，对患者要有同情心和责任感，仔细耐心地检查和了解病情，作好思想工作，使患者树立战胜疾病的信心和决心。施术时应采用平稳、舒适、能持久的体位，再行进针。施针时要避开大血管和瘢痕组织。初诊或精神紧张的患者，要进行解释，使其解除精神上不必要的负担。要告诉病人

施针时不要乱动,如有感应,要及时告诉医生,并随时询问和观察病人进针后的感应。在留针时间不得远离患者,以防发生事故。对疗效差或疗效不巩固的疾病,不要有“万病一针”的错误思想,应当配合其它方法进行治疗,以提高疗效。

第四节 禁针与异常现象的处理

一、禁 针

《灵枢·终始》篇说:“凡刺之禁,新内勿刺,新刺勿内;已醉勿刺,已刺勿醉;新怒勿刺,已刺勿怒;新劳勿刺,已刺勿劳;已饱勿刺,已刺勿饱;已饥勿刺,已刺勿饥;已渴勿刺,已刺勿渴。大惊、大恐,必定其气乃刺之。乘车来者,卧而休之,如食顷乃刺之;出行来者,坐而休之,如行十里顷乃刺之”。指出过劳、过饱、过饥、过渴、大惊、大恐、酒醉时等,应当解除这些情况以后,再给施针。急诊者应当例外。

《针灸大成》禁针穴歌中提出的禁针穴位:脑户、囟会、神庭、玉枕、络却、承灵、颅息、角孙、承泣、神道、灵台、膻中、水分、神阙、会阴、横骨、气冲、箕门、承筋、手五里、三阳络、青灵、乳中。孕妇不宜针合谷、三阴交、石门。云门、鸠尾、缺盆、肩井、深刺则晕针……。这是前人根据腧穴部位在重要器官或由于针刺不当发生事故的教训记载。近代临床实践证明,可分三种情况:第一种是绝对禁针穴,如乳中、神阙。第二种是慎用针穴,如孕妇小腹部及妊娠三个月以上不宜轻易针腰尻部及合谷、三阴交等反映较强的穴位,以防造成流产。若病情需要也可使用,但需慎重。第三种禁针穴位,只要医生认真负责,掌握针刺方向、深度及手法操作的轻重,是可以针刺的。如接近内脏,重要器官和大血管处的穴位,可用斜刺、浅刺法以避免发生事故。

二、针刺异常现象及处理

1. 滞针：针下特别沉紧，针体无法转动，进退困难的叫滞针。如是向一个方向捻转过度致使组织缠绕针体的滞针，需向相反的方向将针捻回；肌肉过度紧张引起的滞针，需将针留在原处，在滞针的周围循按或在附近再进一针，等待气散，滞针处出现松弛后，再行拔针。

2. 弯针：由于进针时用力过猛，指力不匀或进针后病人移动体位等，均可使针体弯曲。弯度轻的可以缓慢的将针拔出；弯度大或弯曲多的，应顺着弯针的方向，轻微摇动，顺着向针柄倾斜的方向，分段、缓慢的将针退出；如病人移动了体位，则需矫正到原来的体位，再拔针。

3. 折针：多因针的质料不好，保存不当，针根锈蚀，针体损伤或发生死弯，最常见的是针根部折断。发生折针后，医者和患者必须保持镇静，不可惊慌，不要乱动患者体位，以防针体陷入深部。针体露在皮外的，可用镊子轻轻钳出；针体在皮内的，可用手指在穴位周围挤压，使针体露出，再用镊子钳取；针下有骨骼可由外面向下轻压，用骨骼将针顶出；折针在两骨之间的，可用手指将针顶进，使针尖穿过软组织从对侧露出，再用镊子钳取；针体已陷入深部，当用手术取出；因此，进针后针体露在皮外五分以上为宜，不能进到针根部，并且要经常检查针体有无缺损和死弯，能修理的修理，不能修理者挑出不用，以防发生折针事故。

4. 晕针：多由病人体质虚弱，失血过多，饥饿疲劳，精神过度紧张，或医者针刺手法过重造成的。晕针轻的出现面色苍白、头晕目眩，恶心呕吐，心烦胸闷，四肢发冷等症，严重的有神志昏迷，肢冷脉微，冷汗淋漓，二便失禁等虚脱症状。如发现坐着晕针的，应立即停针，扶病人平卧，头部略低，并用指掐或针刺人中、中冲等穴，即可恢复。严重的可喂白开水或糖水，多

数患者即可苏醒。

5. 出血及血肿：多因施术时粗心大意，误伤血管所致。出针后出血少的或慢的，用消毒棉球按住即可；出血多的或急的，则需在针孔四周按住出血的血管施加压力，始能止血。皮肤出现青紫色或肿起的，应在局部涂碘酒或酒精，再作轻揉或热敷即可消散。

第五节 其它针及疗法

其它针和疗法，近年来发展的很多，仅将常用，有效而又容易掌握的几种介绍如下，以供参考。

一、三棱针

三棱针为不锈钢制成。针长约二寸，针体圆柱形，针体末端三棱形，尖端三面有刃，针尖锋利，专用于点刺放血。古人对刺络放血非常重视。如《素问·血气行志篇》说：“凡治病必先去其血”。《针解篇》又说：“菀陈则除之者，出恶血也”。就是刺络放血法。但刺时宜浅，出血不要过多，主要治疗发热、昏厥、咽喉肿痛，局部充血，急性腹痛、吐泻和神志病等，操作方法主要有三种（图60）：

1. 点刺（速刺）放血法：局部消毒后，左手拇食中三指握紧被针穴位，右手持针迅速刺入半分深左右，即将针退出，然后捏挤局部使之出血，排粘液。常用于十二井、十宣放血，治疗昏厥、发热、咽喉肿痛，局部放粘液，治疗腱鞘囊肿等（图61）。

2. 结扎放血法：先用带子或橡皮带一根，结扎在被针部位上端，局部用碘酒消毒，酒精棉球擦净后，左手拇指压在被针部位下端，右手持三棱针对准被针部位的静脉刺入脉中（0.5~1分深左右），即将针退出，使其流出少量血液，出血停止后，将带子解开，再用消毒棉球揉按针孔，不使出血过多。常用于尺泽、



图60 三棱针

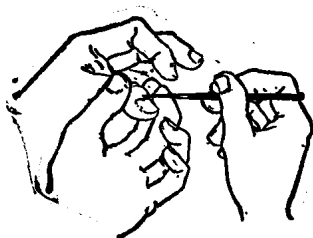


图61 点刺放血法

委中放血，治疗吐泻，急性腹痛等。对于有瘀血的络脉部位，刺过之后，使其恶血自流，待恶血流尽后，再用消毒棉球按压针孔；当出血时，也可轻轻按摩经脉上端，以帮助邪毒外出(图62)。

3. 捏起放血法：左手拇食二指捏起被针穴位的肌肉，右手持针刺入0.5~1分深左右，即将针退出，然后捏挤局部，使之出血，常用于攒竹、上星放血治疗目赤肿痛和头痛等(图63)。

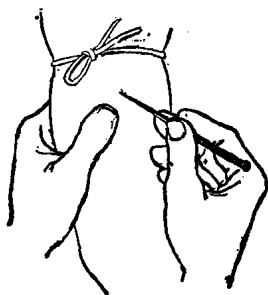


图62 结扎放血法

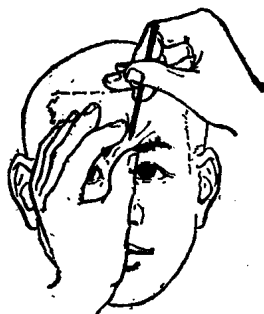


图63 捏起放血法

二、挑 治

本法是在病人的一定部位皮肤上，用粗针或三棱针挑断皮下白色纤维样物，治疗疾病的一种方法。

1. 挑治痔疮：要寻找痔点。让患者反坐于靠背椅上，两手扶在椅架上，暴露背部，在光线充足的条件下寻找痔点，痔点多在

第一腰椎至尾椎两侧。痔点要与毛囊炎、色素斑等鉴别。找点困难时，可用两手在患者背部摩擦，注意痔点出现。如出现三个痔点，应选择明显的1~2个进行挑治。痔点越接近中线，近于尾椎，效果越好。如找不到痔点，挑大肠俞、次髎亦可。

(1)痔点的特点：痔点似丘疹稍突出于表皮，针帽大小，多为灰白、暗红、棕褐、浅红色等，压之不退色，有的点上还有一根毫毛。

(2)挑治的方法：痔点确定后，用碘酒、酒精消毒皮肤，用消过毒的三棱针或粗针挑破痔点表皮，然后向内深入，可挑出白色纤维样物数十条，将其逐一挑断，挑尽为止，然后用酒精消毒贴盖消毒纱布。痔疮在炎症期效果好，无炎症时效果差。挑治后局部不要沾水，不要吃刺激性食物，避免体力劳动。如果一次不愈，隔十日再选点挑治。对治疗内痔、外痔、混合痔、肛门痒都有良好效果。

2.挑治颈淋巴结核：让患者反坐于靠背椅上，两手扶在椅架上，暴露脊背，在患者背部两肩胛下角以上，脊椎两侧，可见到红色、略高于皮肤、小米粒大、指压不退色的“结核点”。右侧颈部患病在左侧找点；左侧患病在右侧找点；两侧患病在两侧找点。常规消毒后，用消过毒的三棱针刺破“结核点”表皮，挑断皮下浅层白色纤维数根。酒精消毒后贴盖消毒纱布。治疗颈部淋巴结核有效。

3.截根颈淋巴结核：让患者反坐于靠背椅上，两手扶在椅架上，暴露脊背，在患者背部的膈俞、肝俞、胆俞、胃俞、肾俞常规消毒和局麻后，用消过毒的三棱针刺入穴位的肌膜部位，用针尖划3~5次，找到感觉，出针后贴盖消毒纱布。一般一天截根一次，五对穴位，一次一对，轮换使用，十次一个疗程。治疗未化脓颈部淋巴结核有效。

4.挑治羊毛疔：让患者仰卧，在患者腹部巨阙穴附近和后背及

疼痛周围找到象疹子似的红点，常规消毒后，用消过毒的三棱针挑破红点表皮，然后向内深入，可挑出一种黄白色象羊毛样的细丝数条，将其逐一挑断，然后用酒精消毒贴盖消毒纱布。治疗羊毛疔（上腹部剧痛、胃痛、干呕等）有效。

三、火 针

治疗淋巴结核：让患者正坐或仰卧，局部常规消毒后，以1～2%普鲁卡因局麻，再用烧红的不锈钢特制粗针刺患处。

1. 液化淋巴结：刺液化中心，排尽脓液。

2. 溃疡：沿其边火针，针距0.5～1厘米围刺，对溃疡面的渗出物、增生肉芽须以平烙。

3. 漏管：沿漏管腔，以火针破坏管腔及表皮使成溃疡面，继以火针。

4. 未液化淋巴结：在硬结上火针，深达硬结三分之二，勿刺透，速刺速退。5～6天火针一次，针后涂龙胆紫，敷无菌纱布，禁用油纱布和药膏等。如有感染可用消炎药物，炎症消退后再针。治疗颈部淋巴结核有效。

四、皮下埋针

让患者暴露受针部位，选好穴位，局部消毒后，选一寸长新毫针，由上向下沿皮横刺5～7分，用胶布或消过毒的干绵丝一束，在针根部缠绕一周，再用宽二厘米，长五厘米之胶布贴在针体的外面将针固定。然后让患者随意活动，如不刺痛，即将针留于皮下，一般可留5～7天。每次埋针不超过两穴，一般只取一个对称双穴。常取膈俞、阿是穴治疗胃痛；膻中、肺俞治疗哮喘等

五、丛 针

《灵枢·官针》篇说：“凡刺有九，以应九变”。说明古人治病是根据病情和病位的不同，而选用针具的。丛针种类很多，常用的丛针有三种：一种是用线将五枚一寸长小针捆在一起，用手指直接捏持使用的称为丛针扬刺法。另一种是四根针在病变的四周向中间斜刺的称为围刺法。再一种是用5~7枚一寸长小针捆在一起，安装在筷子的一端，用手持筷柄叩打皮肤的称为皮肤针叩打法。由于安装之针数不同，故有梅花针（五枚针）和七星针（七枚针）的名称。由于此法仅用于叩打皮肤，故又称为皮肤针。丛针的针尖不要太尖，也不要参差不齐，以防发生刺痛。

1. 丛针扬刺法：是右手拇食中三指捏持捆在一起的针，缓慢将针压入穴内2~5分深，再迅速将针拔出，然后捏挤针穴局部使之出血。常用于大椎、身柱治疗疟疾；大椎、身柱、灵台、筋缩、脊中、命门、腰阳关、腰俞治疗项部疔肿；大椎、身柱、肺俞等穴治疗外感发热等症（图64）。

2. 围刺法：是用四根针在病变的四周向中间斜刺，得气后留针20~30分钟，治疗痹病、痿气、腱鞘炎、腱鞘囊肿等（图65）。

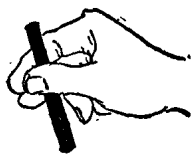


图64 丛针扬刺法

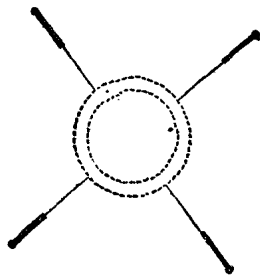


图65 围刺法

3. 皮肤针叩打法：是右手持针柄（筷子），无名指和小指将针柄末端固定在手掌小鱼际处，拇中二指固定针柄，食指压在针

柄中段，运用手腕弹力，使针尖垂直，在皮肤上连续叩打。当针尖触及皮肤后，立即迅速弹起。可发出短促的“哒 哒”弹刺声音。叩打手法的轻重和次数多少，要根据患者的身体强弱及病症的需要而定。轻叩以不出血为度，重叩以微出血为度。主要治疗头痛、失眠、神经麻痹、肠胃病、咳嗽、哮喘、月经不调、神经性皮炎和儿童疾患等（图66）。

（1）常规叩打部位：脊柱两侧和病变的局部，任何疾病都要叩打这些部位（图67）。

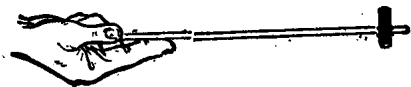


图66 皮肤针

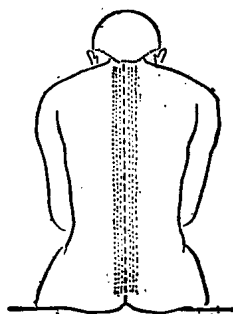


图67 常规叩打部位

（2）重点叩打部位：在脊柱两侧，根据病人所述的病区，或医生指压发现的痠、麻、痛等异常感觉，或局部出现的结节状及条索状硬物等处，或脏腑器官病变的皮表相应区进行重点叩打。如治疗近视眼，先叩打脊柱两侧，再叩打眼睛周围。如治疗下肢静脉曲张，除沿下肢静脉由下而上的叩打外，尚需在腰部压痛点上进行叩打（图68）。

六、拔罐与捏脊

1. 拔罐：是用大小不等的竹罐、陶罐或玻璃瓶，在患处或穴位上扣拔，致使瓶、罐吸住皮肤，造成瘀血现象，达到治病的一

种方法（图69）。

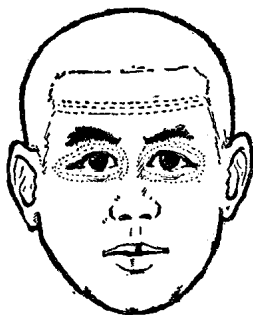


图68 近视眼叩打部位

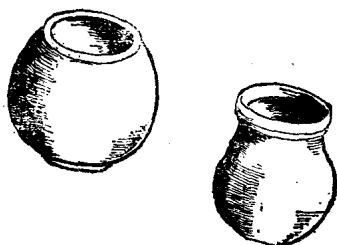


图69 大小不同的火罐

（1）火罐：选择大小适宜的罐子，将油纸或酒精棉球点燃送入罐内，在火旺时立即扣在患处，或用一青霉素瓶橡皮盖，放在拔罐部位中央，凹面向上，放进酒精棉球点燃，待火旺时，立即将罐扣上。此法的优点是拔的紧，而不易烫伤。10~15分钟起罐。起罐时用手指压迫火罐一侧边缘皮肤，使罐内进入空气，即可取下，并用棉球擦净皮肤（图70）。

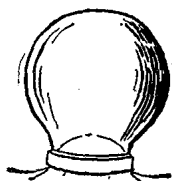


图70 火罐

（2）推罐：在需拔罐的部位和玻璃罐口上涂拭润滑油脂，将95%酒精棉球点燃放于罐中，乘热将罐扣在患处。待罐吸紧后，术者用双手将罐向上、下或左、右推移滑动几次，使局部出现红紫色为度（图71）。

（3）水罐：在选用的青霉素瓶（瓶口加盖橡皮塞，将瓶底切去，边缘磨平）内装生理盐水或热水半瓶，（不装水的为抽气罐），紧扣于被拔部位，用10~20毫升注射器，将针头从橡皮塞刺入瓶内，抽出部分空气，使瓶内产生负压，吸紧皮肤，10~15分钟起罐（瓶）（图72）。

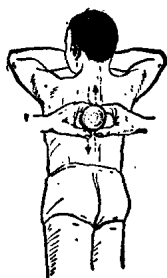


图71 推罐



图72 水罐

(4)适应症：火罐治疗腰、背痠痛、腹痛、肌肉劳损、四肢痠痛、麻木、咳喘。水罐（抽气罐）治疗面神经麻痹（拔面部）、声音嘶哑（拔结喉部）、百日咳（拔大杼、身柱）等。

(5)拔罐注意事项：①选择肌肉丰满、毛发少的部位拔罐。并且病人体位要舒适。②根据病情拔罐、推罐，按所拔部位范围的大小，选用合适口径的罐或瓶。③如点火过程中发现罐口发烫时，应当换罐，以防烫伤。如拔罐处发生水泡或烫伤，可涂龙胆紫。④凡骨骼凹凸不平、有皮肤病、大血管通过之处，毛发多的部位、心力衰竭、水肿、恶性肿瘤、活动性肺结核、孕妇均不应用此法。

2.捏脊：是在病人脊椎两侧进行推、捏治病的一种方法。属于推拿按摩疗法。

(1)操作方法：让病人俯卧在床上，两臂上举放在头的两边，使背部肌肉松弛，医生站在病人旁边，从尾椎部开始，用两手的拇指和食指掀起脊椎两侧的皮肤，一推一捏，沿脊椎两侧向上推捏（食指推、拇指捏提，操作时两手同时推捏），直到颈部为止（图73）。这样从下到上推捏3~5次。在第二、三次推捏过程中，每捏两下，将皮肤掀起向斜上方提一提，如果推捏得

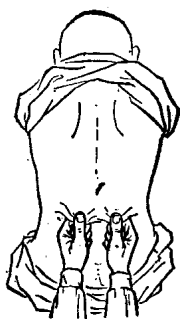


图73 捏脊

法，在第2～5腰椎之间的两侧可听到一种特有的响声。推捏完毕后，再用两手拇指在肾俞穴上揉按3～4下。每天一次，六天一个疗程。病情重的可连做两个疗程。

(2)适应症：能疏经活血，调理肠胃。对小儿营养不良、食积、奶积、消化不良、慢性胃肠炎等都有良好的效果。

第六节 新医疗法与针刺麻醉

一、穴位注射

本法是采用西医的注射器，在人体针灸的“阳性”经穴上注射药物，进行治疗的一种新方法。

(一)小剂量穴位注射

1.工具和药物：使用5～10毫升的注射器和4～5号针头。常用药液有维生素B₁、B₁₂、蒸馏水、当归液、阿托品等。

2.选择穴位：在人体背部俞穴，胸、腹部募穴和四肢合穴上用手指压按寻找结节、条索、敏感点和压痛点，定为主治穴位。

3.操作方法：皮肤用75%的酒精消毒，根据病情选好主治穴位，用注射器吸入应选用的药液，右手以笔式持注射器（图74），进针得气后，推进药液0.3～0.5毫升。

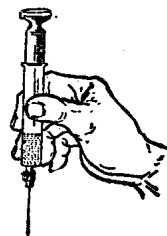


图74 执笔式持注射器

4.疗程：每日或隔日注射一次，每7～12次为一疗程，每疗

程结束休息3~5天。

5.适应症和选穴：支气管炎选肺俞，神经衰弱选内关，遗精选志室，遗尿选三阴交，月经不调选关元、三阴交等。

6.注意事项：（1）出血性疾病和孕妇不宜注射。（2）防止感染和药物反应。（3）胸背部穴位要斜刺，不可深刺，以防刺伤内脏。（4）病人体位要适宜，针头要检查，以防折针事故。

（二）水针

1.工具和药物：使用5~20毫升注射器和5号注射针头，牙科5号针头或封闭长针头。常用药液有5~10%葡萄糖注射液，4%碳酸氢钠或0.5~1%盐酸普鲁卡因注射液（用前做皮试）等。

2.操作方法：痛点选定后，用注射器吸入注射液并准确的注入疼痛部位。用量及注射深度，根据腧穴的不同，深浅而定。一般一穴局部注射不超过20毫升。如果痛点消失遗留痠、胀感觉，可在葡萄糖液内加二分之一或三分之一量的4%碳酸氢钠或维生素B₁，再次注射。

3.适应症：腰腿痛，坐骨神经痛等。

4.注意事项：有少数病例，首次注射后夜晚发烧，无须处理，次晨即退。孕妇腰、股部、急性传染病、感冒、发烧禁用此法。首次治疗或年老、体弱的一次注射部位和用量不宜过多。药液不可注入关节腔。

二、强刺激结扎

本法是中西医结合，采用穴位按摩和直接刺激神经干相结合的一种新疗法。它具有粗针透穴，带线结扎等综合作用，羊肠线在未被吸收前，可以起到一种机械性刺激，在被吸收的过程中又能起到一种生物性（异物蛋白）刺激，以延长刺激时间，加强刺激强度，使经络疏通，气血调和，改善血管神经的营养状态，而

达到治疗疾病的目的。

1.工具：需准备00号、1号、2号铬制羊肠线和外科用的大圆缝皮针，持针钳、洞巾、医用手套，5—10毫升注射器，5～6号针头，0.25～1%普鲁卡因注射液、弯盘、消毒纱布等小手术用具。

2.操作方法：按一般无菌操作，在穴位两旁与经络走向呈垂直约1.5厘米处，消毒皮肤，在进、出针的两端作局麻。盖洞巾。一端用手术刀尖切口约3～5毫米，用血管钳由切口插入穴位处进行按摩刺激，使其产生痠、麻、胀、热等感觉。取出血管钳，用大圆缝皮针，带铬制羊肠线从切口刺入，经穴位下方深处穿过，于穴位对侧1.5厘米处穿出皮肤，用消毒钳钳住羊肠线两端，呈拉锯状来回抽拉刺激，然后再经出针孔进针，经穴位皮下（浅处）穿回，于原入针孔出针，结扎羊肠线，剪去余线，将线头埋入切口内，局部消毒包扎。每次结扎2～4穴，25～30天结扎一次。

3.适应症：小儿麻痹后遗症，瘫痪等。

4.注意事项：对重要神经、血管走行处，避免取穴结扎。结扎松紧以病情而定：发病时间短，体质好的要穿的浅些，结扎的紧些；发病时间长，体质弱的线要穿的深些，结扎的要松些。线头不可外露，以免感染。

三、穴 位 埋 线

穴位埋线，是根据病症的不同，将铬制羊肠线埋藏于选好的穴位中，它不但有粗针深刺、得气感时间延长的作用，而且还能发挥羊肠线对穴位的持续性刺激，使经络疏通，气血调和，改善血管神经的营养状态，而达到治疗疾病的目的。

1.工具：准备000号、00号、0号、1号铬制羊肠线，6号、9号、18号腰椎穿刺针（将针芯尖端的斜面磨齐，以便将线顶入

穴内，防止带出体外），盛75%酒精的广口瓶、镊子、胶布、碘酒棉球、酒精棉球。将上述型号的羊肠线剪成长一厘米左右的碎段与穿刺针分别浸泡于酒精瓶中，消毒30~60分钟备用（图75）。

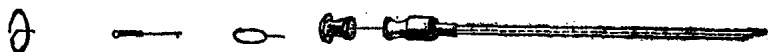


图75 腰椎穿刺针

2.操作方法：先将羊肠线由穿刺针尖端插入针内，穴位皮肤常规消毒，手持酒精棉球挟捏针体，对准穴位进针，得气（找到痠、困、麻、胀、触电样感觉）后，用穿刺针芯缓慢的将羊肠线顶入穴内，出针后用胶布垫消毒棉贴盖针眼。每次埋线2~4穴，7~10天埋线一次。5~7次为一疗程，休息5~10天，再继续埋线。

3.适应症：小儿麻痹后遗症、瘫痪、腰腿痛、坐骨神经痛、关节炎、哮喘、胃溃疡等。

4.注意事项：埋线2~3天内，局部产生胀痛感，无须处理，日后自行消失。妊娠期，发热病避免埋线。线头不可外露，埋线后3~4天不要洗澡，以防感染。

四、耳 针

耳针是在耳壳上选穴进行针刺治疗疾病的一种方法。耳穴是人体内脏或躯干有病时在耳壳一定部位上出现反应之处。如压痛点，敏感点，电阻变低，局部变色、变形等。这些反应部位就是用耳针治病的刺激点，故称耳穴。耳穴分布有一定的规律，耳壳好象子宫内一个倒置的胎儿，头在下，脚在上（图76）。兹概述如下：

（一）耳壳表面解剖名称（图77）

1.耳垂：即耳壳下部、无软骨的耳垂。

2.对耳屏：与耳屏相对的隆起处。

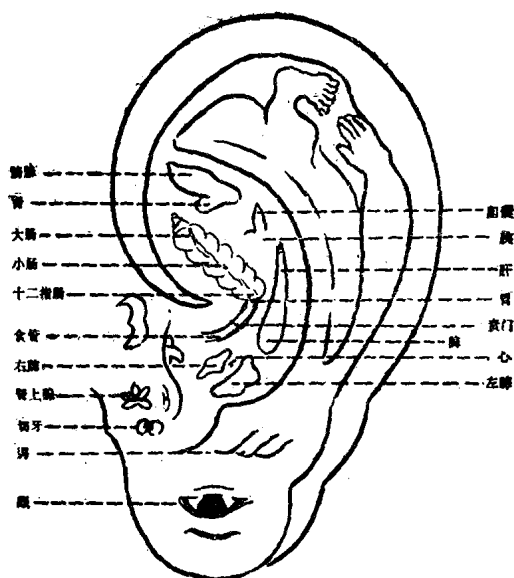


图76 耳穴分布规律

3. 耳轮：耳壳最外圈卷曲的部分。
4. 耳轮结节：指耳轮后上方稍突起处。
5. 耳轮脚：耳轮深入到耳腔的横行突起部。
6. 对耳轮：与耳轮相对。
7. 对耳轮上脚：对耳轮向上分叉的一枝。
8. 对耳轮下脚：对耳轮向下分叉的一枝。
9. 三角窝：对耳轮上、下之间的三角形凹窝。
10. 耳舟：耳轮和对耳轮之间的凹沟。
11. 耳屏（耳珠）：耳壳前面的瓣状突起处。
12. 屏上切迹：耳上缘和耳屏脚之间的凹陷。
13. 屏间切迹：耳屏与对耳屏之间的凹陷。
14. 耳甲窝（耳甲艇）：耳轮脚以上的耳腔部分。
15. 耳甲腔：耳轮脚以下的耳腔部分。

(二) 耳针穴位 (图78)

1.耳垂相当于面部。包括上、下颌，上、下颞，眼、耳，扁桃体等穴位。

2.对耳屏相当于头部。包括皮质下,枕额、平喘等穴位。

3. 耳轮脚相当于膈肌。

4.对耳轮相当于脊椎。内侧面包括颈椎、胸椎、腰椎。突面包括颈、胸、腹等穴位。



图77 耳壳表面解剖名称

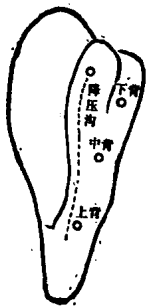
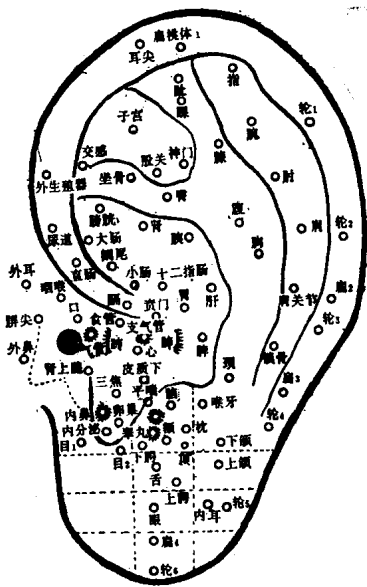


图78 耳针穴位

5.对耳轮上脚相当于下肢。包括趾、踝、膝等穴位。

6.对耳轮下脚相当于臀部。包括坐骨、臀、交感神经等穴位。

7.三角窝相当于生殖器官。包括子宫、神门、股关节等穴位。

8.耳舟相当于上肢。包括锁骨、肩、肘、腕、指等穴位。

9.耳屏相当于内鼻部、咽喉、屏尖、肾上腺等穴位。

10.耳上切迹相当于外耳。

11.耳间切迹相当于内分泌，卵巢等穴位。

12.耳甲窝相当于腹部。包括膀胱、肾、胰、胆、肝、脾等穴位。

13.耳甲腔相当于胸部。包括心、肺、三焦等穴位。

14.耳轮脚周围相当于消化管。包括口、食道、贲门、胃、十二指肠、小肠、阑尾、大肠等穴位。

15.耳壳背面相当于背部。包括上背、下背、降压沟等穴位。

(三) 耳针操作

1.针具：28~30号、0.5~1寸
不锈钢毫针和特制的揸钉样或蝌蚪样
皮内针(图79)。

图79 耳针

2.取穴：取穴要少而精，多数取同侧、少数取对侧或双侧穴位。

3.找穴：以针柄用力按压或用探针探寻反应点或用耳穴探测器探查“良导点”，然后将针刺部位和针具用酒精消毒。

4.进针：左手固定耳壳、右手持针垂直(或斜刺透穴)进针，以不刺透耳壳软骨为原则，找到痛、胀、痠、麻、灼热等感觉。埋针则用皮内针刺入耳穴，贴盖胶布固定。

5.留针：一般留针15~30分钟，有的留1~2小时。也可用皮内针埋针3~7天，以延长刺激时间，并让病人自己定期按压加强刺激，增强疗效。到一定时间起针。

(四) 耳针配穴

1.头痛：针额、枕、神门。顽固者埋针。

2.失眠：针额、枕、神门、皮质下、心、肾或埋针。睡前按压2~3分钟。

3.哮喘：针平喘、肺、肾上腺。在喘时针。

4.呃逆：膈、交感埋针。留针3~5天。

5.胸胁痛：针胸、肝、胆或埋针。

6.胃痛：胃、交感埋针。

7.腹痛腹泻：针大肠、小肠、交感或埋针。

8.便秘：针直肠、大肠、皮质下。

9.阑尾炎：针阑尾、交感、大肠、神门。

10.坐骨神经痛：针坐骨、臀、神门或埋针。

11.带状疱疹：相应部位、肺、神门埋针。

12.荨麻疹：相应部位、肺、神门、肝、脾埋针。

13.神经性皮炎：针相应部位、肺、神门连续10次。

14.痛经：针子宫、皮质下、内分泌、交感或埋针。

15.牙痛：针屏尖、上、下颌。留针常捻。

(五)耳针注意事项

1.应用耳针应按经络、脏象理论辨证取穴。

2.取穴和压痛点探查准确是疗效的关键。

3.耳针有一定的局限性。虽然适应症广，但也有些病疗效不明显，或疗效不巩固，必要时合理的配合体针、中药、西药等其它方法进行治疗，才能提高疗效。

4.妊娠期最好不针，以防流产。

5.过度疲劳、饥饿和衰弱的病人，针刺时最好平卧，以防晕针。

6.耳壳冻伤或有炎症，应当不针，以防感染和炎症扩散。

五、针刺麻醉

针刺麻醉，是用几根针，在病人身体、耳朵的穴位上，进行

针刺，并经过一定时间的诱导和刺激，使病人痛觉显著迟钝或消失，而在神志完全清醒的状态下，进行手术的一种新的麻醉方法。它是在发掘祖国医学宝库中的针刺止痛和针刺治病的基础上创造成功的。

（一）针刺麻醉的适应范围

针刺麻醉具有广泛的适应症，适用于不同性别、年龄的患者和全身多部位外科手术病种。并且针刺麻醉使用安全、没有副作用，术后恢复快，也不会发生过敏、过量等意外。

针刺麻醉对某些病灶复杂、粘连面广以及需要作广泛探查和病灶清除的病例，手术中还存在着“镇痛不全”、“内脏牵拉反应”、“肌肉松弛不全”的困难。但是，目前存在的这些问题，通过进一步选择穴位和改进刺激方法等，是会得到解决的。

（二）手术前的准备

解除患者的思想顾虑。并在手术前选择病人身上的1~3个穴位进行试针。通过试针，可以了解病人对针刺的反应和“得气”（痠、麻、胀和针下冲动）以及病人对针的耐受力，便于手术时选用适当的穴位和刺激强度。急性病人不试针也可。

（三）选取穴位

针刺麻醉是用针刺某些穴位，达到镇痛而进行手术的。因此，选取穴位是针刺麻醉手术中的一个重要环节。

1. 体针麻醉取穴法：根据手术切口部位通过的经络和涉及的脏腑，选择有主治功能的穴位。大致可分三类：①循经取穴：如胸腔、上腹部手术取内关，胃切除术取足三里，头面部手术取合谷等。②局部取穴：如甲状腺手术取扶突等。③唇针取穴：取人中、承浆施行颈、胸、腹、会阴、妇科等手术。所取穴位，应是不易出血，不易产生痛感，还必须考虑不影响病人舒适的体位和不影响手术操作。

2. 耳针麻醉取穴法：根据耳针麻醉的需要，耳穴大致可分三

- 类：①取基本穴：神门、交感各科手术几乎都采用或取其中一个；肺，大部分需行切开皮肤的手术都采用。因此叫基本穴。②选手术部位穴：手术切口部位和手术所涉及的脏腑在耳廓上的代表点。如阑尾切除术的针麻选穴是阑尾、腹。患病部位在耳廓上相应的反应点（敏感点、压痛点、变形、变色、电阻变小）。③耳针配穴：参考脏象学说取1~2个穴位，以加强针麻效果。如眼科手术配肝等。

（四）操作和刺激方法

在针刺麻醉手术中，给予某些穴位以恰当的刺激，是手术走向不痛的转化条件。因此体针和耳针的进针深浅，应根据病人的体质和穴位的具体情况而定。但进针后须使病人获得痠、胀、麻等感觉（耳针多为热、痛感）。

1. 刺激方法：常用的有三种：

（1）手法运针：体针以每分钟几十次至二百次的频率进行捻转、提插。捻转的幅度一般是10~30度左右，提插幅度多在一分范围以内。给以中等度刺激，使病人获得并保持“得气”感应。耳针只捻转不提插，并且在捻转时不可改变针尖方向，以免产生疼痛。

（2）电脉冲刺激法：扎针后在针上通以微弱的电流，这种电流通常是由电脉冲发生器（电针机）输出的。电针机的每对输出都有两个接头，在使用时只要把两个接头分别用导线联结在两根毫针的针柄上即可。一般电针机输出的波型多数是锯齿波，频率一般每分钟几十次至几千次，可进行调节，刺激强度也可进行调节。电刺激强度因人而异，一般控制在使病人有较强但能忍受的感应为度。使用体针时，电刺激强度，逐渐加大到使局部肌肉微微抽动为止。一次通电的时间不宜过长，否则病人容易产生“适应性”，“得气”感应会减弱甚至消失。如果需要长时间进行电针麻醉，则应采用断续通电的方法，如在通电十几分钟后，停电

几分钟，然后再通电。通电或断电时要注意逐渐加大或减小电流，以免给病人造成突然刺激。

(3)得气留针：按照循经取穴的原则，选用体针穴位，在规定的穴位上进针，使病人有痠、胀、重、麻感觉和术者有“得气”感即可留针。一般留针30分钟后开始手术。在手术过程中，医务人员随时检查针刺“得气”感，如无“得气”感则随时加以校正。使之重新有“得气”感。

以上三种常用的方法，不论那一种，最后都必须使病人得到和保持“得气”感应，是获得针刺麻醉的关键。

(4)诱导：在手术开始前，在穴位上预先进行一段时间的刺激称为诱导。诱导时间一般在10~20分钟左右。耳针麻醉若取穴较多，则有普遍诱导（普诱）和重点诱导（重诱）之分。在诱导期间，起初以一定的顺序将所有穴位逐一捻转，称为普诱，到手术前几分钟，再重点捻转几个主要穴位，称为重诱。如耳针麻醉进行阑尾手术，取患侧神门、肺、交感、阑尾四穴，普诱时将上述各穴轮流捻转1分钟，捻转四遍，共16分钟，然后再将神门和肺同时捻转4分钟为重诱，诱导期总共20分钟。

(5)留针和起针：在手术过程中某些手术刺激较轻的时候，可以停止手法运针或停止通电，而予以留针。一般在手术结束时，即可将所扎的针全部取出。

针麻手术，要求针麻和外科术者以及病员三者之间都须互相配合，发挥主观能动作用，这是针刺麻醉手术成功的关键。

(五)辅助用药

针刺麻醉一般辅助用药很少。有很多病例未用任何辅助药物，也获得了良好效果。

1.术前辅助用药：一般多在手术前15~30分钟应用杜冷丁50毫克。根据病人具体情况，也可同时给非那更25毫克。

2.术中辅助用药：手术中根据手术当时的具体情况，需要

时，可给予杜冷丁、非那更等镇痛、镇静剂，给以辅助。在某些情况下，可用局部麻醉药，如普鲁卡因等。在切、缝腹膜、剥骨膜、强烈牵拉内脏等之前，估计病人可能出现反应，可预先用药强化。

3. 术后填写和整理各种记录和表格，医护人员核对，以便日后查阅和总结经验。

(六) 针刺麻醉穴位处方举例

1. 拔牙手术：①体针麻醉配穴：合谷（双侧）。上颌前牙配人中、后牙配下关；下颌前牙配承浆，后牙配颊车、翳风，均患侧，得气留针或电针。②耳针麻醉配穴：神门。上牙配上颌，下牙配下颌，均患侧，手法运针或电针。

2. 眼科白内障晶体摘除术：①体针麻醉配穴：合谷、印堂透攒竹，阳白透鱼腰、太阳透颞髥，均患侧电针。②耳针麻醉配穴：肺、皮质下、眼、肝、均患侧，电针。

3. 胃大部切除术：①体针麻醉配穴：足三里、内庭、均双侧，手法运针或电针。②耳针麻醉配穴：神门、肺、交感、胃，均左侧，电针。

4. 下腹部手术：包括卵巢囊肿摘除术，子宫摘除术，腹股沟疝修补术，输卵管、输精管结扎手术等。

综合配穴：体针：三阴交、行间、双侧取穴；耳针：神门、肺、交感、外生殖器，左或右侧取穴，均电针。每个穴位普诱5分钟后，开始重诱，术中根据手术步骤和病人的具体情况，分别采用强刺激或弱刺激，直至手术结束。

第二章 手 法

针刺手法，十分重要，没有辨证配穴，抓不住病机，没有精练手法，也不能针到病除。内难二经关于针法早有理论指导，历代针灸大家都有发挥，但个人体会在初学时往往有明于书，未必明于心，明于心未必明于手的困难，必须坚持理论与实践相结合，精练手法。作为针灸医生，必须掌握理、法、方、穴、术五个要领。这个术，即手法。清朝李守先认为针灸之难，“难不在穴，在手法耳”。笔者在此想以先父毓琳公家传及多年来集理实践，诚尽描述能力，作一介绍，请同道参考，并望斧正。

第一节 练 针 法

毫针操作必须首先练针，由左手摸穴须辨别肌肉厚薄，穴位深浅，配合右手进针时还需有押按协调的持久力量。针体细软，右手持针需有一定的指力，在进针时才能随意的进行捻转、提插，两手密切配合是掌握针刺手法的关键。常练的方法有：

一、关节练习法

肩、肘、腕三个关节是上肢活动的枢纽，气是人的动力，经常锻炼，能强筋壮骨使肢体灵活。施针时左手推按，刚柔协调、揣穴准确，力量持久；右手进针迅速，操作准确，动作轻巧，得心应手。练习时采用站住，双膝略向前屈，两足分开与肩等宽。两臂自然下垂，同时口眼微合，意守丹田，然后由鼻缓慢的吸气，再挺胸放肩，引气由下返胸，缓慢的由嘴呼出，一呼一吸，息息

相随，反复的呼吸3～5分钟，调匀呼吸后，即开始肩、肘、腕关节的练习（图80）。

1.肩关节练习：首先内气贯两臂，然后上肢屈肘平肩，作由前往后或由后往前的旋转运动。两上肢交替或同时练习均可（图81）。

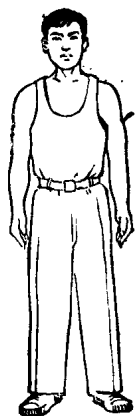


图80 预备动作

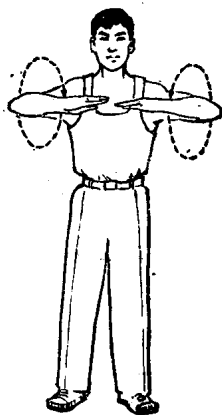


图81 肩关节练习法

2.肘关节练习：随肩关节练习之后，上肢屈与肩平，连续伸屈或上下转动肘关节。两肘交替或同时练习均可（图82）。

3.腕关节练习：随肘关节练习之后，垂臂曲肘，将两手半握拳，进行腕关节屈伸及旋转活动。两腕交替或同时练习均可（图83）。

二、左右手练习法

1.左手练习：左手五指排开按在桌上或书本上进行向前、下、左、右反复推压，以锻炼指力和腕力，以拇指或食指指腹在书本上向前、后、左、右推揉压按，以锻炼指力。

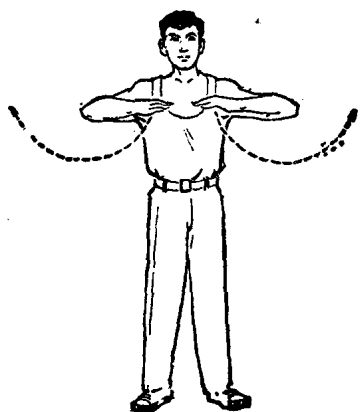


图82 肘关节练习法

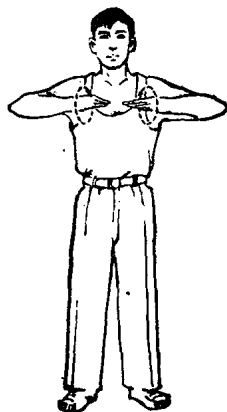


图83 腕关节练习法

2. 右手练习：右手拇食二指或拇食中三指持针柄，在空中向

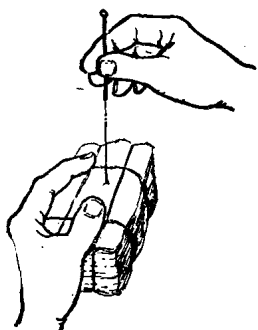


图84 练针

上下、左右、前后等方向横刺、斜刺、直刺反复进退，以练习持针向几个方向进针。达到手腕翻转灵活，进针迅速。右手持针柄，针尖放在书本上、棉枕上、厚麻纸上、软木上，拇指向前后反复的捻转，要求达到捻转角度均匀，针体不左右摆动，再进行反复的提插练习，要求达到针体垂直，进退深浅均匀，以锻炼捻转和提插的指力（图84）。

第二节 揣穴（定穴）法

在针前以手指在穴位处行揣、按、循、摸找出具有指感的准确穴位叫揣穴，或称定穴和摸穴。其目的是揣摸肌肉的厚薄，孔隙之

大小，指感的位置，分拨妨碍进针的肌腱、血管等。以确定进针的方向和深浅。《难经·七十八难》说：“知为针者信其左，不知为针者信其右，当刺之时，必先以左手压按所针之处”。由此可见，左手揣穴在临床上的重要。

一、指切法

以左手拇指指甲置于被针穴位上，用力掐之为指切。指切有宣散局部气血、避免疼痛、固定穴位和协助持针的右手躲避肌腱、血管的作用（图85）。

二、按压法

揣穴遇到肌肉丰盈疏松时，要用左手五指并拢或排开向下用力，将肌肉压平，以防移位，便于进针。如揣中脘穴，腹部肌肉疏松，中指按压中脘，其它四指排开将腹部压平，称为“五穴取一”，以备进针（图86）。

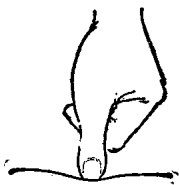


图85 指切法

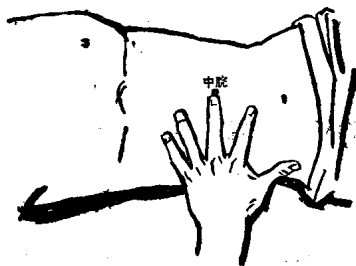


图86 压按法取中脘

三、分拨法

揣穴遇到肌腱、血管时，要用手指向前后或左右推拨，使其分开而按住穴位。如针内关穴，左手拇指紧按其穴，将两肌腱和血管拨开，同时要找到患者有痠、麻感觉的部位，以便进针（图87）。

四、旋转法

揣穴遇到骨骼、肌腱、血管覆盖的穴位时，令患者将有关的部位旋转，使其被覆盖的穴位充分显露，以指按穴。如揣养老穴，令患者屈肘，掌心朝面，小指侧向内旋转，尺骨小头桡侧显出的陷窝处，即为本穴（图88）。

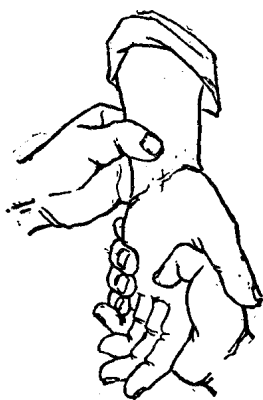


图87 分拨法（取内关）

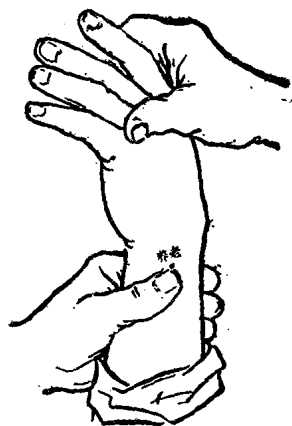


图88 旋转法（取养老）

五、滚摇法

揣穴遇到关节时，左手以拇指掐住穴位，右手牵拉患者肢体

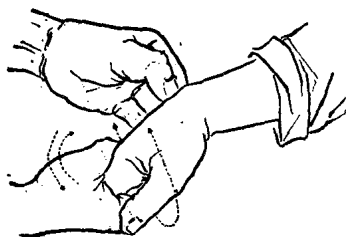


图89 滚摇法（取阳池）

远端，行左右或上下滚摇，使其关节松弛，指下便可揣清穴位。如取阳池穴时，以左手拇指紧掐其穴，右手握患者四指用微力牵拉并左右滚摇，使穴显于指下（图89）。

六、升降法

如遇伸屈关节才能较好显露穴位时，应采用升降法。如取解溪穴，以左手固定肢体，拇指紧掐其穴，右手握住足尖，上下摇动，以松动踝关节，便可揣清穴位（图90）。

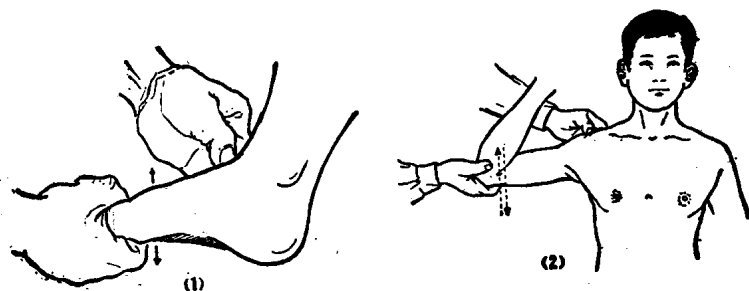


图90 升降法（取解溪、肩髃）

七、滚摇升降法

遇到屈伸关节，推拨肌腱才能显露穴位时，用手握住关节向左右滚摇、前后屈伸、推拨穴位周围组织，使穴显于指下。如取肩髃穴，左手拇指紧掐其穴，右手托握肘关节，上下抬举，左右滚摇活动，使穴位显于指下（图91）。

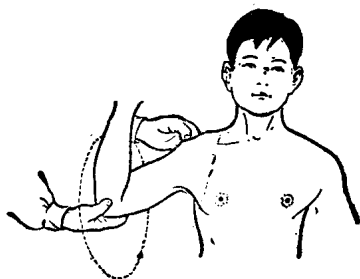


图91 滚摇升降法（取肩髃）

第三节 进 针 法

为了进针迅速，得气快，而不使患者疼痛和恐惧，在进针时常采用单指和双指两种押手法。单指压手法是用左手拇指或食指定穴后，用指尖压住被针的穴位，右手拇食二指（或中指辅助）持针置于穴上，小指或手腕自然地放在被针穴位旁的皮肤上，并和左手的指切，按压配合灵活，两手密切合作，再将针刺入穴内，进行提插，移动针的方向和确定针之深浅，才能有准。此法不但能协助右手进针和固定穴位，而且还能体会针下之气至冲动，控制针感之传导方向。双指押手法或称舒张押手法，是用左手拇食或食中二指放平，压在被针穴位的皮肤上向两侧张开，将皮肤撑紧再行针刺。此法可以避免皮肤、肌肉缠针引起疼痛，多用于长毫针深刺肌肉松软、肥厚之处。

一、指切速刺法

是左手拇指或食指指甲紧切按被针穴位的皮肤，右手持针柄，使针体贴着左手的指甲，不捻不转迅速刺入皮下。这种方法的优点是进针快，得气快而不痛，应用较广，但手法不熟练，进针易痛，也易弯针，应熟练后再用（图92）。

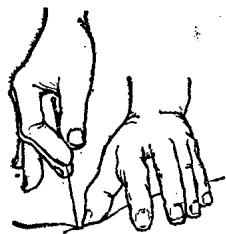


图92 指切速刺法

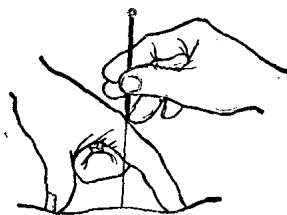


图93 缓慢捻进法

二、缓慢捻进法

是用左手单指或双指押手法，右手持针柄稍用压力，轻微、缓慢的用小于 45° 的角度，拇指向前后均匀捻转，边捻边进使针体垂直捻入皮下。进针时不要用力过猛，捻转角度不要过大，以免弯针和疼痛。这种方法容易掌握，应用最广（图93）。

三、刺入捻进法

是左手用舒张押手法，将穴位的皮肤撑紧，右手持消毒棉裹住的针体，以拇食二指捏紧，露出2~5分针尖，（视穴位的部位而定）迅速、准确的刺入皮下，然后左手拇食二指捏着消毒干棉球裹着的针体，右手持针柄，边捻边进将毫针刺入穴内。这种方法的优点是进针快而不痛，多用于长毫针深刺肌肉较厚的部位和精神紧张与怕针的患者（图94）。

四、管针打入法

是将针先插入用玻璃、塑料或金属制成的比针短三分左右的小针管内，放在被针穴位的皮肤上，左手压紧针管，右手食指对准针柄一击，使针尖迅速刺入皮下，然后将针管去掉，再将针刺入穴内。这种方法的优点是进针不痛，多用于儿童和精神紧张与怕针的患者（图95）。

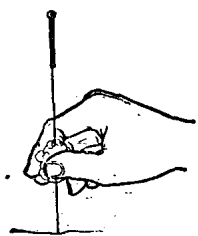


图94 刺入捻进法

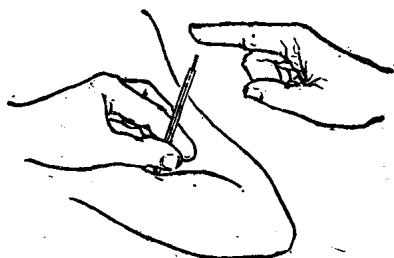


图95 管针打入法

五、指切压入法

是左手拇指或食指指甲紧切被针穴位的皮肤，右手持针不捻不转，只用指力缓慢的将针压入。这种方法的优点是进针不痛，感应不突然，应用最广。但不易掌握，必须久练才能将针压入，否则容易弯针。

六、压针缓进法

是右手持针，不捻不转缓慢将针压入穴内的方法。多用于内

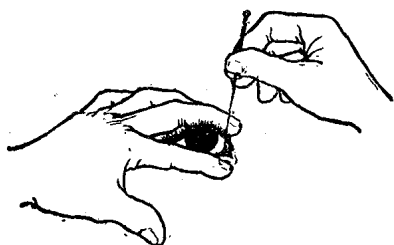


图96 压针缓进法

睛明穴。针_{睛明}的方法是：先用硼酸水将眼内洗净，以左手食中二指或拇食二指分开上下眼睑，右手持30~32号毫针，在眼球鼻侧红肉珠缝隙（泪阜边缘）缓慢将针压入1~1.5寸，留针后再

将针不捻不转的取出（图96）。

第四节 行针候气法

行针是针刺穴位后，利用搓捻提插等法，使之得气的操作方法。候气是医生采用各种方法候其经气（感应）之到来。并包括气不至时之催气、得气后的行气和守气。

气至亦即得气，这种感应医生和患者均可察知。患者在扎针部位感到的痠、困、麻、胀、热、凉、触电样等感觉。这些特殊的感觉得常从扎针的部位出现，似线状的向上、下传导或似片状的向周围扩散；医生进针后感到的是针下沉紧、冲动、针体转动有吸力和看到针穴处或针穴远处的肌肉跳动，都是得气的现象。

得气感传与疗效有密切关系；用毫针治病，须要候到感应，根据感应再使用手法，始能达到应有的效果，所以毫针治病的关键在于得气与否。《标幽赋》认为：“气至速而效速，气迟至而不治”。根据1964年3月在中医研究院针灸研究所针刺治疗视神经萎缩76例，患眼130只中，针刺风池感传到眼的44只中，有效率占77.3%；到额的41只中，有效率占68.3%；在局部的45只中，有效率占42.2%；并发现单眼患者针风池时，健侧感传多能到达眼区，患侧多为局部，双眼患者如感传不同时，则感传到达眼区的效果好，局部的效果差。但局部的感觉如逐渐传到了眼区，视力则随之好转。可以看出，针刺感应快、传导远、能到“病所”的疗效佳；感应迟、传导近或只限于局部的疗效差；如始终无感应则收效困难。

行气不要忽视病人痛苦，催气、行气都是为了使感应上下传导、通接到“病所”。《金针赋》说的：“通经接气之法，有定息寸数。手足三阳，上九而下十四，过经四寸；手足三阴，上六而下十一，过经一寸”。这是一息（一呼一吸）气循经脉运行6寸，手三阳经长5尺，操作9息，足三阳经长8尺，操作14息，超过经脉4寸；手三阴经长3.5尺，操作6息，足三阴经长6.5尺，操作11息，超过经脉1寸。指出每穴每次的手法操作时间、应在1分钟以内，使感应传到整体经脉或“病所”。如遇瘫痪、麻痹或感传近的患者，应在传到的部位接着针（接气），使感应继续向前传导，就能传到整个经脉或“病所”（通经）。如针肩髃，针感须传到手指。而只传到了曲池，就在曲池接着往下针，就能使感应传到手指。不要为了找感应或使感应传到“病所”，在一个穴位上操作时间过长而忽视病人痛苦。

按病位行气：要根据病位的深浅和表里决定针刺和行气的部位。如表症和皮肤疾患，病位浅，应在天部候到感应，并且使之放散、传导以通调腠理；病邪在肌肉、经络和半表半里之症，病

位居中，应在人部候到感应，并且使之放散、传导，以疏通经络；病邪在脏腑、骨髓之里症和疼痛症，病位深，应在地部候到感应，并且使之放散、传导，以调理脏腑和镇痛。《针灸大成》南丰李氏补泻说的：“除寒热病，宜于天部行气；经络病，宜于人部行气；麻痹、疼痛、宜于地部行气”。就是按病位行气的方法。

按病情行气：要根据病情之虚实，决定针之补泻。如久病、气短、便溏、脉弱无力的虚症或进针后针下空虚及出针时针下仍轻滑的，应用弹、捻、提、按等补法，促其针下稍涩，热感传导以补其虚；新病、胸满、腹痛、便结、脉大有力的实症或进针后紧涩及退针时针下仍过于沉紧的，应用搓、摇、循、摄等泻法，促其针下松滑，凉感放散以泻其实。《素问·针解篇》说的：“刺虚则实之者，针下热也，气实乃热也；满而泻之者，针下寒也，气虚乃寒也”。就是按病情行气的方法。

技术操作与得气、感传有密切关系：感觉性质（痠、困、麻、胀、热、凉等），传导远近以及循经与否和术者的手法、操作时间、取穴的正确和押手以及患者的病情等，均有密切关系。因此，将针进到一定深度后，如无得气现象或感传不明显或将感应失去时，应采用下列方法：

一、候气催气法

候气是在不得气时，将针停在原处，留3～5分钟，再进行提插捻转而使气至。叫候气法。催气的方法很多，常用的有：

1. 搜法：是针已进到所定深度尚不得气，即将针退到皮下，改变针刺方向，再行进针。如仍不得气，再向前、后或左、右有目的地直刺或斜刺反复的进退搜（探）索，以催其气至（图97）。

2. 循按：是针后气不至，用手指由针穴附近向上下、左右循按、爪摄或叩击，以引其气至。

3.弹震：弹是用手指弹动针柄，促其气至，使针下沉紧；震是右手以半握拳状将中指突出，敲震穴位周围，或用手指弹震，以震动内气或内部器官，促其经气内守（图98）。

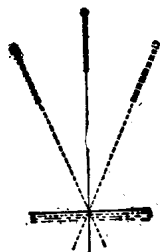


图97 搜法

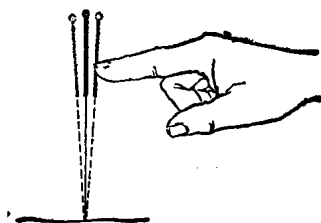


图98 弹法

4.移位：如因取穴不准，或针刺穴位过偏，则可重新移动针刺部位或调整针刺方向，再进行提插、捻转、一般即可得气。如因病人肢体麻痹或感应迟钝等，用上述方法催气，仍不得气，就不要强用手法，仍可留针候气。

二、行气法

是得气后，医生采用提插、搓捻、关闭等手法，以加大其感应或引导其感应向远处传导的方法。常用的有：

1.提插：提是向外退针，插（按）是向里进针。在得气的基础上，针尖在1分左右的范围内连续提插，使感觉传导，但因病情不同，提插也有轻重、急慢之不同（图99）。

2.搓捻：搓是捻力强而角度大，一般在 180° 以上；捻是捻力弱而角度小，一般在 45° 以内，都是捻针催气、行气和进行补泻的方法，在得气的基础上连续搓捻，以使感觉放散。但搓捻勿转太紧、太急、以防肌肉缠针，引起疼痛（图100）。

3.拨刮：拨是针下气至，以右手拇食二指扶针柄，向左右在 45° 角以内似钟摆式的、缓慢的拨动，使感觉放散，多用于拨散结节

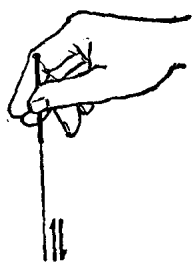


图99 提插

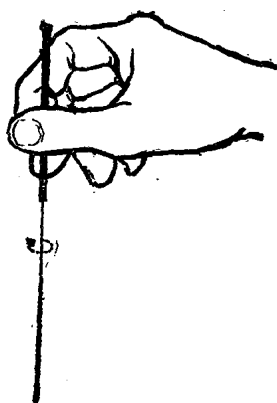


图100 搓捻

肿物，刮是针下气至，以右手指甲向上或向下连续刮动针柄，或用手指向上或向下摩擦针柄，以加大感应，但向下刮多用于补，向上刮多用于泻（图101~102）。

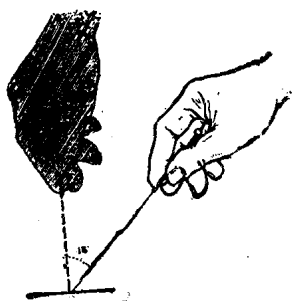


图101 拨法

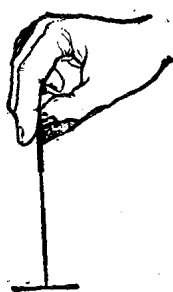


图102 刮法

4. 盘摇：盘是将针进到地部（穴的终点或筋骨之间），候气至，然后提至人部（穴的中层或肉内）或天部（皮下），将针撇倒，与皮肤呈45度角，似推磨式缓慢的旋转，一般不要超过三圈；摇是针下得气后，向左右似摇铃式的摇转，操作多在 180° ~

360°之间，一般不超过三遍，使针孔开大。二者的作用在于使感觉扩散，针下空虚，多用于泻法。但用盘摇二法，均勿过急、过快，以防肌肉缠针，引起肿痛，损伤正气（图103）。

5.关闭：是针下气至，左侧押手把不让感觉传导的方向闭住，把气至冲动的部位按住，主要是控制和引导感觉传导的方向。如使感觉向上传导，押手须放在针穴的下方，向上连续不断的用力，同时右手持针的针尖亦向上进，如使感觉向下传导，押手须放在针穴的上方，向下用力，同时针尖亦向下进，左右两手互相配合、同时努力，就能使感觉传导到预定的“病所”（图104）。

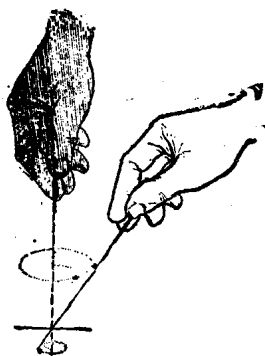


图103 盘法

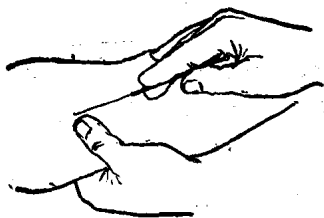


图104 关闭法

6.飞推：飞似捻法，但每捻一次，拇食二指要离开针柄一次，似展翅飞扬之状，一捻一离，针体不一定转动；推似捻法，但它是拇食二指持针向前弩推，针体同样不转；二法能使感觉向远处传导或延长感觉的持续时间。飞法常连续三飞，用于补泻，推法多用于守气（图105）。

三、守气法

是催气、得气、行气后，患者有舒适感觉时，医生采用推

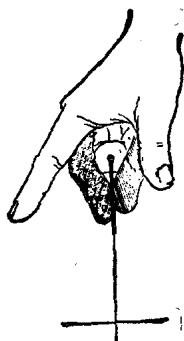


图105 飞法



图106 搬垫法

弩、搬垫等法，以保持感应之持久为守气法。《素问·宝命全形论篇》说的：“经气已至，慎守勿失”。就是守气的方法。因为候气、取气，都是为了得气，得气之后最好不要“失气”，所以古人把能守气的术者称为“上工”。故《灵枢·小针解》篇说：“上守机者，知守气也”。

1. 推弩：是针尖顶住有感觉的部位，推弩针柄或拇指向前或向后捻住针柄，不使针尖脱离感觉（不失气），稍待1～3分钟，以保持感觉时间延长。

2. 捻提：是针尖拉着有感觉的部位，拇指向后捻提针柄，使针尖不脱离感觉，稍待1～3分钟，以保持感觉时间延长。

3. 搬垫：搬是针下得气，患者有舒适感觉时，右手将针柄搬向一方，垫是将手指垫在针体与被针穴位皮肤之间，顶住有感觉的部位（拇指搬食指垫，食指搬拇指垫），以加大感应。有时也用于补泻，但用于补法针尖要往里按着，搬的角度小，泻法针尖往外提着，搬的角度大（图106）。

四、留针与出针

1.留针：是针下得气，将针留在穴内不动，以加强针法的持续作用。留针与否和留的时间长短，应根据病情而定。一般得气后，操作完毕即可出针。如遇剧烈疼痛、痉挛和寒症等，须镇痉止痛、温经除寒时，应留针30分钟左右，甚至可留数小时。

2.出针：操作完毕或留针后，左手持消毒棉球，轻按被针穴位的皮肤，或用手指按在针穴附近，右手持针柄轻捻、轻提，边捻边退将针拔出。如用于补法，则慢出针，急扞闭针穴，不令正气外泄或出血；用于泻法，则急出针，不扞闭针穴，使邪气外泄，但需保持针孔清洁，防止感染。

第五节 补泻手法

针刺治病，是根据不同病情，使用不同针刺手法；达到或补或泻的作用。因此掌握补泻手法是非常重要的。《难经·七十三难》说的：“补者不可以为泻，泻者不可以为补”。就是说用针治病，不可虚实不分，补泻乱施。

一、迎随补泻法

顺着十四经的循行方向进针，得气后将针推进半分左右为补，逆着十四经的循行方向进针，得气后将针提退半分左右为泻。是《灵枢·终始》篇说的：“泻者迎之，补者随之”；《难经·七十八难》说的：“得气，推而内之是谓补，动而伸之是谓泻”的迎随补泻法。

二、呼吸补泻法

是患者鼻子吸气，口中呼气，在呼气时进针，得气后在吸气

时将针拔出为补；鼻子出气，口中吸气，在吸气时进针，候其感应消失后，在呼气时将针拔出为泻。《素问·调经论篇》说的：

“气盛乃内针，针与气俱内，以开其门……针与气俱出……”曰泻；“候呼内针，气出针入……气入针出……”曰补。就是呼吸补泻法。

三、徐疾补泻法

《素问·针解篇》说的：“徐而疾则实者，徐出针而疾按之；疾而徐则虚者，疾出针而徐按之”。就是徐疾补泻法。但在徐疾补泻的方法上，历代均有发挥，现在常用的有：

1. 提插补泻：是进针得气后，针尖拉着有感应的部位，急（重）插慢（轻）提3～5次，出针后急按针穴为补；向有感应的部位，慢（轻）插急（重）提3～5次，出针后不按针穴为泻；在有感应的部位，缓慢的平提插，出针后揉按针穴为平补平泻（图107）。

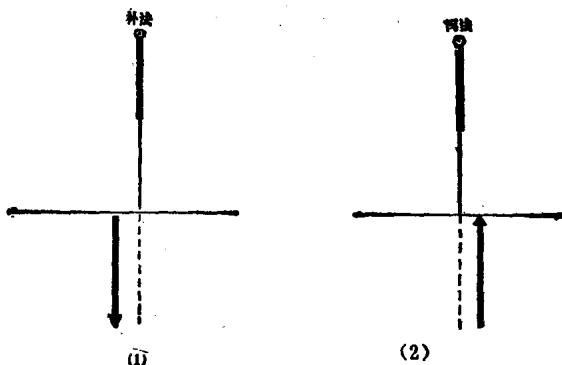


图107 提插补泻

2. 进退补泻：是将针进到天部，找到感觉，按天、人、地三部进针，一部一停的急（重）进三次，插至地部、然后一次将针缓慢拔出为补；一次将针缓慢进至地部，找到感应，然后按地、

人、天三部退针，一部一停的急（重）退三次，将针拔出为泻。亦即“三进一退”为补，“一进三退”为泻（图108）。

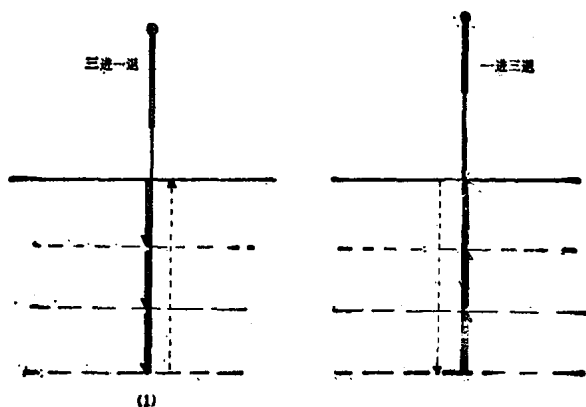


图108 进退补泻

四、捻转补泻法

1. 指飞补泻：是进针2～3分深得气后，拇指向前连续飞三次以加大感应，使针下沉紧，为“一进三飞”的补法；进针到一定深度，拇指向后连续飞三次加大感应后，再急提退1～2分，使针下空虚，为“三飞一退”的泻法。《神应经·补泻》说的：

“大指、食指持针，却用食指连搓三下，谓之飞，仍提针向左转，略退针半分许，谓之三飞一退；大指、食指持针，以大指连搓三下，谓之飞，将针深进一、二分，以针头向左边，谓之一进三飞”。就是指飞补泻法。

2. 九六补泻：是进针得气后，拇指向前连续捻（45°左右）九次或按天、人、地三部，每部捻九次或二十七次为补；向后连续搓（180°左右）六次或按地、人、天三部，每部连续搓六次或十八次为泻；拇指向前后（在90°左右）连续来回的平均捻转为平

补平泻（图109）。

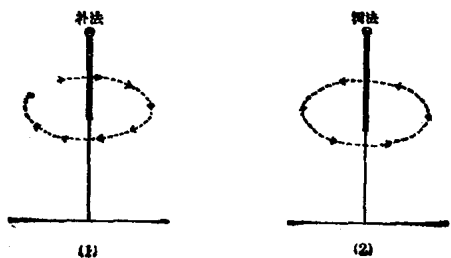


图109 九六补泻

五、荣卫补泻法

是先在天气部候气，如气不至，即行催气，气至后缓慢出针，急按其穴，不使气泻为之补；先在地部候气，候得气至，急（重）出针，不按针穴，或从血管点刺放血为之泻。《难经·七十六难》说的：“当补之时，从卫取气，当泻之时，从荣置气”。就是荣卫补泻法。

六、开合补泻法

是候针下气至（沉紧），缓慢将针拔出，急按其穴，使针孔闭合，真气内守为补；气至摇针，候针下气散（空虚），急速将针拔出，不按其穴，使针孔开大，邪气外散为泻。

七、虚实补泻法

是虚症用过补法后，针下仍松滑，采用弹、按、刮、捻等法，使针下沉紧，然后再将针缓慢拔出为补；实症用过泻法后，针下仍沉紧，采用循、摄、提、摇等法，使针下松滑，然后再将针急速拔出为泻。这种方法是根据《素问·宝命全形论篇》中“刺虚者须其实，刺实者须其虚”的原则发挥的。

第六节 混合补泻法

混合补泻法，是采用补泻法中的几种补泻，在一个穴位上综合运用方法。也是根据不同的病理虚实情况，采用不同的刺激量的补法或泻法。

一、烧山火（补法）

这种方法是采用三进一退、一进三飞、提插、九六、呼吸、迎随、开合等法中的补法组成的。以产生热感为目的。《金针赋》说的：“烧山火，治顽麻冷痹，先浅后深，用九阳而三进三退，慢提紧按”。《针灸大成》三衢杨氏补泻说的：“烧山火，能除寒，三进一退热涌涌……。指出按本法操作，可以产生热感，治疗寒症。

操作方法：令患者自然的鼻吸口呼，随其呼气，用单指押手法将针进至天部，右手拇指向前连续飞三次或九次，以催其气至（如针下沉紧，则轻提1～2分或轻微回转以解除滞针），即将针插至人部，操作方法与天部相同；然后即将针急插至地部，仍按天部的方法操作。飞毕候到针下气至沉紧时，用针尖拉着有感应部位，在一分上下的范围内急（重）插慢（轻）提三次，促其产生热感（如有热感则用推法守气，促其热感放散传导，如无热感则将针退至天部，另行操作）。手法用毕，随其吸气缓慢将针拔出，急扞针穴。此法如在天部或人部操作时，已见到患者皮肤发热或出汗或自觉针穴附近甚至全身有热感时，即不必继续操作。手法熟练时，不利用呼吸和九数操作也能产生热感。留针与否应根据病情而定（图110）。

应适症：中风脱症，瘫痪麻痹，风湿痹症，肢冷便溲，阳萎偏坠，腹痛腰痠等一切虚寒症。有时以发汗解表之目的，用于外

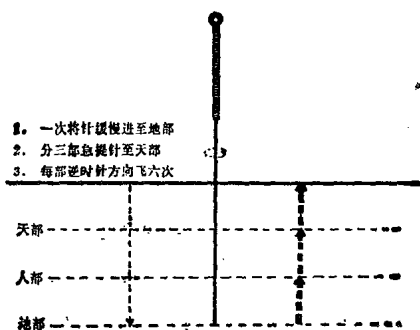


图110 烧山火法

感风寒。临床应用本法，针风池、合谷，可以发汗解表，治疗外感风寒；针梁丘、膝眼、足三里，可以温散寒湿，治疗风寒湿引起的膝关节炎等都有明显效果。

二、透天凉（泻法）

这种手法是采用一进三退、三飞一退、提插、九六、呼吸、迎随、开合等法中的泻法组成的。以产生凉感为目的。《金针赋》说的：“透天凉，治肌热骨蒸，先深后浅，用六阴而三出三入，紧提慢按”。《针灸大成》三衢杨氏补泻说的：“透天凉，能除热，三退一进冷冰冰……”。指出按本法操作，可以产生凉感，治疗热症。

操作方法：令患者自然的鼻呼口吸，随其吸气用舒张押手法，不捻不转缓慢的将针进至地部（俗名偷针刺法），右手拇指向后连续捻六次，候到针下气至沉紧时，然后将针急提至人部，再由人部向地部有感应的部位，连续的慢（轻）插急（重）提六次。促其产生凉感（如有凉感则用刮法守气，促其凉感放散传导，如发生滞针，则摇动针体或用指摄法以解除滞针），然后将针急提至天部，再由天部向人部有感应的部位连续慢插急提六次，使凉

感放散传导（如地、人、天三部均无感应则另行操作）。手法用毕，随其呼气急速将针拔出，不按针穴。此法操作时，不利用呼吸和六数操作也能产生凉感，留针与否应根据病情而定（图111）。

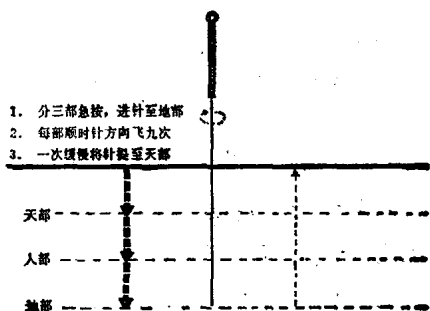


图111 透天凉法

应适症：中风闭症，暑热高烧，谵语，癫狂，鼻衄，龈肿，身

热便干等一切实热症。有时以清热解表之目的，用于外感风热。临床应用本法，针水道、中极、复溜可以泻热利尿，治疗膀胱实热的小便不通；针大椎、肺俞、合谷可以清热解表，治疗外感风热引起的发烧等都有明显效果。

三、阳中隐阴（先补后泻法）

这种手法是在同一穴位中，先在人部行烧山火，后在地部行透天凉的混合手法。《金针赋》说的：“阳中之阴，以九六之法，则先补后泻”。《针灸大成》三衢杨氏补泻说的，“阳中隐阴，能治先寒后热，浅而深”。指出按本法操作，可以治疗先寒后热的病。

操作方法：令患者自然的鼻吸口呼，随其呼气用单指押手法，将针进至天部，候其气至，即将针急插至人部，右手拇指向前连续飞九次，候到痠、胀等感觉时，用针尖拉着有感应部位，在1分上下的范围内急插慢提三次，患者如有热感，即将针稍停片刻，候热感消失，然后令患者改为口吸鼻呼的呼吸，医生改用舒张押手法，将针缓慢的插至地部，拇指向后连续捻六次，候到痠、麻等感觉时，即将针急提至人部，再由人部向地部有感应的部位，慢插急提三次，凉感产生，稍停片刻，即将针提至天

部，稍停片刻，将针拔出，缓慢揉按针穴。

适应症：疟疾之先寒后热者，以及内热表寒，内实外虚，虚实夹杂的疾病。

四、阴中隐阳（先泻后补法）

这种手法是在同一穴位中，先在地部行透天凉，后在人部行烧山火的混合手法。《金针赋》说的：“阴中之阳，以六九之方，则先泻后补”。《针灸大成》三衢杨氏补泻说的：“阴中隐阳，能治先热后寒，深而浅”。指出按本法操作，可以治疗先热后寒的病。

操作方法：令患者自然的口吸鼻呼，随其吸气，用舒张押手法，缓慢的将针进至地部，拇指向后连续捻六次，候到痠、麻等感觉时，即将针提至人部，再由人部向地部有感应部位，慢插急提三次，如有凉感，即将针稍停片刻，候凉感消失，然后令患者改为鼻吸口呼的呼吸，医生改为单指押手法，拇指将针向前飞九次，候到痠、胀等感觉时，针尖拉着有感应部位，在一分上下的范围内急插慢提三次，热感产生，稍停片刻，将针拔出，缓慢揉按针穴。

适应症：疟疾之先热后寒者，以及内热表寒，内实外虚、虚实夹杂的疾病。

五、苍龟探穴（平补平泻行气法）

这种手法是采用先深后浅，结合左右捻转组成的。由于拇食二指捻针，边捻边进、钻剔四方，有似苍龟入土之形象故名。《金针赋》说的：“苍龟探穴，如入土之象，一退三进，钻剔四方”。指出本法操作。

操作方法：先将针进至地部，复将针提至天部，变换针尖方向，再向下、向左、向右边捻边进，逐渐深入，如苍龟入土探

穴，向四方反复钻剔透刺，使针感连续出现、时间延长。留针后，缓慢将针拔出，揉按针穴。

适应症：顽麻冷痹，瘫痪萎软，肢体麻木，症瘕积聚等一切气血瘀滞症。

六、赤凤迎源（平补平泻、行气法）

这种手法是采用先深后浅，结合提插、捻转、指飞组成的。由于指飞一捻一离，有似赤凤展翅飞扬的形象故名。《金针赋》说的：“赤凤迎源，展翅之仪，入针至地，提针至天，候针自摇，复进其元，上下左右，四围飞旋”。指出本法操作。

操作方法：先将针进至地部，候到感应，复将针提至天部，候针下气至针体自行摆动，再将针插至人部，行提插、捻转，候得气至，再以拇食二指捏针柄，一捻一离，似展翅飞扬之状，左右飞旋，使针感放散传导。根据病情留针后，缓慢将针拔出，揉按针穴。

适应症：顽麻冷痹，瘫痪萎软，肢体麻木，症瘕积聚等一切气血瘀滞症。

七、进火补法

这种手法比烧山火刺激量轻，较为柔和，是采用三进一退、提插、呼吸、迎随、开合等法中的补法组成的。由于在操作时或起针后常产生热感故名。《针灸大成》三衢杨氏补泻说的：“进火补，初进针一分，……退三退，进三进，……自然热矣”。指出按此法操作，可以产生热感，治疗寒症。

操作方法：令患者口中呼气，随其呼气用指切速刺法，将针刺入一分，候到感应，则用针尖拉着有感应的部位，连续的急插慢提三次，每进针一分，则按上述方法连续操作三次，使热感放散传导。如无热感则令患者做鼻吸口呼的自然呼吸三次，或加刮

法使针尖颤动而催其气至。如有热感则缓慢将针拔出，急扞闭针穴。此法可以按天、人、地三部操作，有时不利用呼吸和提插三数也能产生热感。留针与否应根据病情而定（图112）。

适应症：中风脱症，瘫痪麻痹，顽麻冷痹，尿频便溏，肠鸣腹泻，腰痠阳萎等虚寒症及久病体弱的患者。临床应用本法，针肾俞、秩边、风市、阴市、血海、足三里、三阴交等穴，可以温通经络，治疗小儿麻痹后遗症等有明显效果。

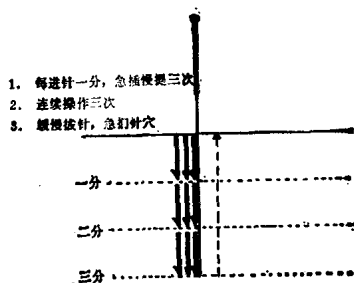


图112 进火补

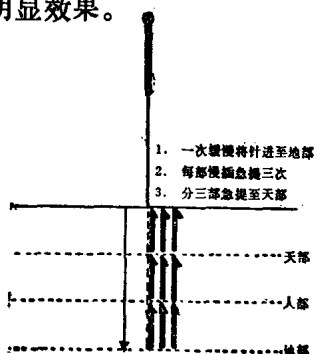


图113 进水泻

八、进水泻法

这种手法比透天凉刺激量轻，是采用一进三退、提插、呼吸、迎随、开合等法中的泻法组成的。由于在操作时或起针后常产生凉感故名。《针灸大成》三衢杨氏补泻说的：“进水泻，初进针一分，……进三进，退三退，……自然冷矣”。指出按此法操作可以产生凉感，治疗热症。

操作方法：令患者口中吸气，随其吸气，用舒张押手法，缓慢的不捻不转的将针进至地部，候到感应，将针提退一分，在一分上下的范围内连续的慢插急提三次，每提退一分则按上述方法连续操作三次，使凉感放散传导。如无凉感，则令患者做鼻呼口

吸的自然呼吸三次，或加摇法而催其气至；如有麻凉或触电样感觉，则将针急速拔出，不扞闭针穴。此法可以接地、人、天三部操作，有时不利用呼吸和提插三数，也能产生凉感。留针与否应根据病情而定（图113）。

适应症：中风闭症，暑热高烧，目赤唇烂，胸满便秘等一切实热症。临床应用本法，针大肠俞、天枢、足三里、丰隆等穴，可以泻热通便，治疗大便秘结，有明显效果。

九、苍龙摆尾（又名青龙摆尾，补法和温散法）

这种手法是采用拨散、呼吸、开合等法中的补法组成的。由于操作时的拨针，有似龙尾摆动的形象故名。《金针赋》说的：“青龙摆尾，如扶舡舵，不进不退，一左一右，慢慢拨动”。《针灸大成》三衢杨氏补泻说的：“苍龙摆尾手法，补”。指出按本法操作，可以起到补虚的作用。

操作方法：进针候到感应后，令患者自然的鼻吸口呼，随其呼吸医生扶针柄，向左右或前后（在 45° 角以内）似钟摆式的连续缓慢的拨动，往返拨针如“江中舡上舵”，使感觉放散。手法用毕缓慢将针拔出，急扞闭针穴。此法在操作时不利用呼吸也可（图114）。

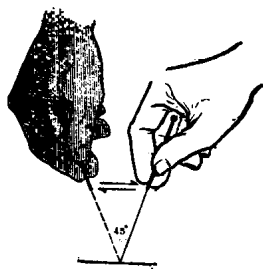


图114 苍龙摆尾

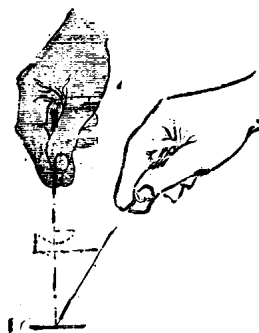
适应症：症瘕积聚、瘰癧、瘰气，关节肿痛等一切气血瘀滞症。临床应用本法，针中脘、天枢、关元、足三里、三阴交等穴，可以温通气血，治疗气滞血瘀所致的腹痛，有明显效果。

十、赤凤摇头（又名白虎摇头，泻法）

这种手法是采用盘摇、开合等泻法，配合关闭法组成的。由

于操作时的摇针，有似凤凰摇头的形象故名。《金针赋》说的：“白虎摇头，似手摇铃，退方进圆，兼之左右，摇而振之”。《针灸大成》三衢杨氏补泻说的：“赤凤摇头手法，泻”。指出按本法操作，可以起到泻实的作用。

操作方法：将针进至穴内，候到感应，如使感觉向上传导，



左侧押手则按在针穴的下方，如使感觉向下传导，则按在针穴的上方，在向前摇着转针时，针成半圆形，由右下方摇着进至左上方，成“⌒”形；在向后摇着转针时，针成半方形，由左上方退至右下方，成“⌞”形。反复的向左、右摇振，似“缸中之橹”，使感觉放散。手法用毕即将针拔出，缓慢揉按针穴（图115）。

图115 赤凤摇头

适应症：神昏谵语，烦躁疯狂，经络滞结，痉挛项强等一切实热症。临床应用本法，针合谷，人中，丰隆等穴，可以祛风化痰，通关开窍。治疗狂躁型精神病，有明显效果。

十一、热 补 法

这种手法比烧山火、进火补简便，刺激量介于两者之间，实践证明，它不但能使患者产生热感，而且能使皮肤温度升高。

操作方法：术者左手食指或拇指紧按针穴，右手将针刺入穴内，候其气至，左手加重压力，右手拇指向前连续捻按3～5次，候针下沉紧，针尖拉着有感应的部位，连续急（重）插慢（轻）提3～5次；拇指再向前连续捻按3～5次；针尖顶着产生感觉的部位守气，使针下继续沉紧，产生热感。根据病情留针后，缓慢将针拔出，急扞针穴（图116）。

适应症：中风脱症，瘫痪麻痹，风湿痹症，腹痛泄泻，阳萎遗精等一切虚寒症。临床应用本法，针中脘、天枢、气海、腰俞、会阳等穴，使之产生热感，治疗腹痛、腹泻等一切虚寒症，都有明显效果。

十二、凉 泻 法

这种手法比透天凉、进水泻简便，刺激量介于两者之间，实验证明，它不但能使患者产生凉感，而且能使皮肤温度下降。

操作方法：术者左手食指或拇指紧按针穴，右手将针刺入穴内，候其气至，左手减轻压力，右手拇指向后连续捻提3~5次，候针下沉紧，提退一分左右，针尖向有感应部位，连续慢（轻）插急（重）提3~5次；拇指向后再连续捻提3~5次，针尖拉着产生感应的部位守气，使针下松滑，产生凉感。根据病情留针后，急速将针拔出，不扞针穴（图117）。

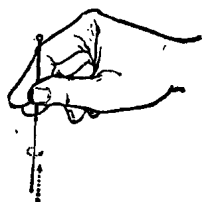


图116 热补法

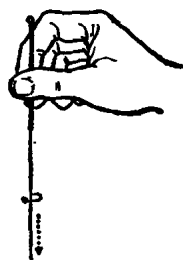


图117 凉泻法

适应症：中风闭症，暑热高烧，谵语癫狂，目赤龈肿，唇烂便秘等一切实热症。临床应用本法，针颊车、翳风、合谷等穴，使之产生凉感，可以清热消肿。治疗疟腮有明显效果。

十三、针刺热补（烧山火）凉泻（透天凉）

手法对皮肤温度影响的实验观察

针刺热补（烧山火）、凉泻（透天凉）手法，是祖国医学针刺

手法中的两种操作方法，能治虚实寒热不同类型的疾病。热补法能使针下产生热感，凉泻法能使针下产生凉感。为了观察热补和凉泻手法对皮肤温度的动态变化，我们从1964年9月10日至12月3日，进行了临床实验观察，兹小结如下：

（一）观察方法

1.观察对象：包括健康者和患者各16人。其中男性16人，女性16人，均等分布于健康者和患者两组内。年龄在17~50岁之间。

2.手法操作：系用32号1寸不锈钢毫针，针刺一侧合谷穴（左右两侧次数相等），进针至出针共操作65秒钟。

（1）热补（烧山火）手法：术者左手拇指或食指紧按针穴，右手将针进至五分深左右，候其气至，左手加重压力，右手拇指向前捻按5秒钟（5次左右），候针下沉紧，针尖拉着有感应的部位，连续急（重）插慢（轻）提10秒钟（10次左右），拇指再向前连续捻按45秒钟（45次左右），针尖顶着产生感应的部位守气，使针下持续沉紧，即刻出针。

（2）凉泻（透天凉）手法：术者左手拇指或食指紧按针穴，右手将针进至五分深左右，候其气至，左手减轻压力，右手拇指向后捻提5秒钟（5次左右），候针下沉紧，提退一分左右，针尖向产生感应的部位连续慢（轻）插急（重）提10秒钟（10次左右），拇指再向后连续捻提45秒钟（45次左右），针尖拉着产生感应的部位守气，使针下轻滑，即刻出针。

（3）平补平泻手法：术者左手食指或拇指紧按针穴，右手将针进至五分深左右，候其气至，右手拇指向前后捻转5秒钟（5次左右），然后均匀的提插10秒钟（10次左右），拇指再向前后均匀的捻转45秒钟（45次左右），即刻出针。

（4）对照组：用酒精棉球消毒后不作针刺。检查方法与针刺组相同。

实验采用自身对照法，在同一人身上进行热补、凉泻、平补平泻和对照四种操作各一次，隔日更换一种，其顺序随机安排，32人均完成四种方法。

3. 皮肤温度测量：受检者安静卧床30分钟左右，针前20分、10分用半导体点温度计测量皮肤温度（最小可测出 0.05°C ），候皮肤温度恒定后开始进行实验。于针前、针后即刻、针后2'、5'、10'、15'、20'、30'钟时测量同侧商阳穴的皮肤温度；针前、针后30秒、2'30"、5'30"、10'30"、15'30"、20'30"、30'30"钟时测量对侧商阳穴的皮肤温度；针前、针后1'、3'、6'、11'、16'、21'、31'钟时测量同侧少泽穴的皮肤温度。每次测量30秒钟。全部实验过程中室温为 $19.5\sim 27^{\circ}\text{C}$ ，湿度为69—89%，而每次实验时室温变化不超过 0.5°C ，湿度波动不明显。

手法操作和皮肤温度测量均由专人负责，在针刺过程中向半数受检者询问其主观感觉，而对另外半数受检者则避免任何暗示，于实验结束后再追问针刺感觉。

（二）实验结果

1. 同侧商阳穴皮肤温度的变化：热补和凉泻手法引起与对照组迥然不同的皮肤温度变化，热补手法使皮肤温度先下降后升高，凉泻手法使皮肤温度下降，平补平泻除针刺即时一度下降外和对照组同样基本稳定，经用方差分析法，进行统计学处理， $F=130.51$ ， $P<0.001$ ，不同手法之间有非常显著的差别。根据进一步分析结果，平补平泻组与对照组之间无显著差别。

凉泻组中下降最多者可达 5.75°C ；热补组中升高最多者可达 2.75°C 。实验结果如表8（图118）。

2. 对侧商阳穴皮肤温度的变化：实验结果表明，两侧商阳穴皮肤温度的变化基本相似，只是热补组和平补平泻组中对侧商阳穴皮肤温度的即刻下降不如同侧显著；凉泻组的回升显著延缓，30分钟以后仍低于针前水平 1°C 以上。经统计学处理， $F=172.41$ ，

表8 同侧商阳穴皮肤温度(平均值)的变化

针刺 经过时间		分组		对 照		热 补		凉 泻		平转平泻	
		手法		—		烧山火		透天凉		捻轻提插	
		人 数		32		32		32		32	
		项 目		皮温(平均值) (℃)	差数	皮温(平均值) (℃)	差数	皮温(平均值) (℃)	差数	皮温(平均值) (℃)	差数
术(针)前				32.56		32.35		32.43		32.34	
术(起针)后	0'			32.52	-0.04	31.34	-1.01	30.36	-2.07	31.30	-1.04
	2'			32.55	-0.01	32.39	0.04	31.13	-1.30	31.98	-0.35
	5'			32.69	0.13	32.90	0.55	31.19	-1.24	32.24	-0.10
	10'			32.61	0.05	33.14	0.79	31.58	-0.85	32.54	0.20
	15'			32.51	-0.05	33.43	1.08	31.90	-0.53	32.34	0.
	20'			32.63	0.07	33.29	0.94	31.78	-0.65	32.54	0.20
30'				32.52	-0.04	33.22	0.87	31.78	-0.65	32.35	0.01

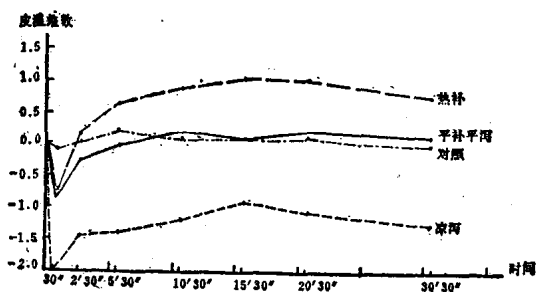


图118 同侧商阳穴皮肤温度(平均值)的变化

$P < 0.001$, 不同手法引起对侧商阳穴皮肤温度变化的差别同样非常显著。

凉泻组中皮肤温度下降最多者可达 7.25°C , 热补组中皮肤温度升高最多者可达 3.5°C 。实验结果如表9(图119)。

表9 对侧商阳穴皮肤温度(平均值)的变化

针 刺 经过时间		分 组	对 照		热 补		凉 泻		平补平泻	
		手 法	一		烧山火		透天凉		捻转提插	
		人 次	32		32		32		32	
		项 目	皮温 (平均值) (℃)	差数	皮温 (平均值) (℃)	差数	皮温 (平均值) (℃)	差数	皮温 (平均值) (℃)	差数
术 (针) 前			32.58		32.42		32.70		32.49	
术 (起 针) 后	30"	32.48	-0.10	31.66	-0.76	30.75	-1.95	31.65	-0.84	
	2'30"	32.61	0.03	32.55	0.13	31.23	-1.47	32.21	-0.28	
	5'30"	32.78	0.20	33.04	0.62	31.31	-1.39	32.45	-0.04	
	10'30"	32.69	0.11	33.28	0.82	31.53	-1.17	32.66	0.17	
	15'30"	32.65	0.07	33.46	1.04	31.81	-0.89	32.56	0.07	
	20'30"	32.73	0.15	33.43	1.01	31.64	-1.06	32.66	0.17	
30'30"	32.56	-0.02	33.19	0.77	31.45	-1.25	32.63	0.14		

3. 同侧少泽穴皮肤温度的变化: 同侧少泽穴皮肤温度的变化趋向, 与两侧商阳穴的变化基本符合, 但其即刻下降较同侧商阳穴的波动幅度明显减少, 热补组的峰值向后推迟。经统计学处理, $F = 99.2$, $P < 0.001$, 不同手法间的差别非常显著。

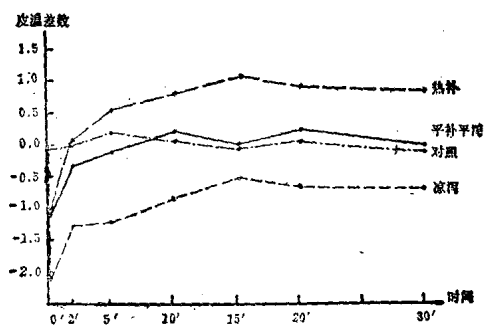


图119 对侧商阳皮肤温度(平均值)的变化

表10 同侧少泽穴皮肤温度(平均值)的变化

针刺 经过时间		分组		对 照		热 补		凉 泻		平补平泻	
		手法		—		烧山火		透天凉		捻转提插	
		人数		32		32		32		32	
		项目		皮温(平均值) (℃)	差数	皮温(平均值) (℃)	差数	皮温(平均值) (℃)	差数	皮温(平均值) (℃)	差数
术(针)前				31.98		32.35		32.46		32.25	
术(起针)后	1'			32.24	0.26	32.06	-0.29	31.09	-1.37	31.77	-0.48
	3'			32.38	0.40	32.71	0.36	31.51	-0.94	32.35	0.10
	6'			32.55	0.57	33.18	0.83	31.65	-0.81	32.46	0.21
	11'			32.55	0.57	33.33	0.98	31.83	-0.63	32.57	0.32
	16'			32.45	0.47	33.52	1.17	32.12	-0.34	32.56	0.31
	21'			32.62	0.64	33.66	1.31	32.11	-0.35	32.66	0.41
				32.51	0.53	33.31	0.96	32.06	-0.40	32.64	0.39

凉泻组中皮肤温度下降最多者可达 5.5°C ，热补组中皮肤温度升高最多者可达 3.5°C 。实验结果如表10（图120）。

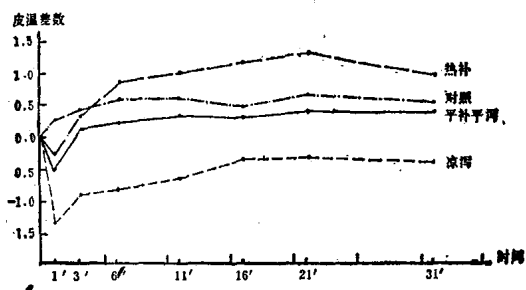


图120 同侧少泽穴皮肤温度（平均值）的变化

（三）讨论。

1. 在室温恒定的情况下，皮肤温度的波动范围，根据我们的观察，一般不超过 0.9°C ，用热补、凉泻手法针刺合谷穴后，同侧商阳穴的皮肤温度立即下降 1°C 以上，显然超过了自然变动范围。热补手法在引起比较明显的即刻下降后，皮肤温度迅速回升到原来水平上，15分钟时超出针前皮肤温度 1°C 以上；凉泻手法则在引起相当突出的即刻下降以后，皮肤温度逐渐回升，但在30分钟内一直未恢复到针前水平。根据统计学处理，证明两者之间以及它们与对照组之间的差别非常显著。由此可见，热补和凉泻手法确实对于皮肤温度能够引起完全不同的反应。热补、凉泻手法同时使对侧商阳穴的皮肤温度也发生类似变化。这说明针刺效应并非局限在所针穴位的一侧，并以同样方式和近似的强度，同时作用于两侧本经穴位。热补、凉泻二种针刺手法还使同侧少泽穴的皮肤温度发生类似变化。这说明针刺的效应绝非局限于针刺部位的附近，而能相当强烈的传导到远隔部位，乃至身体的对侧，从而证实了古人提出的经络有病，采用缪刺和巨刺的正确性。

2. 针刺在两性间引起相当不同的反应，女性反应较男性强而

持久，凉泻手法尤为突出，但由于观察例数不多，有待进一步观察研究。

3. 热补手法引起热感和凉泻手法引起凉感的阳性率，在言语诱导的情况下，可以高达75%和69%，超过无言诱导的将近一倍。因此不难看出，言语的启发诱导可以提高预期感觉的阳性率。这可能是由于言语的提示，通过受检者的高级神经活动起了作用。

4. 在实验方法上进行皮肤温度变化的动态观察，能够找出针刺后皮肤温度变动的趋向和最大峰值，以及峰值出现的时间，这样远较仅仅测量针刺后某一固定时间的皮温，更能全面而深入地反映皮肤温度的真正变动。自身对照法的实验方法，大为减少了个体差异性对实验的影响，在同一受检者身上进行对照、热补、凉泻和平补平泻四种测量，就使得观测数据具备了可比性，较之在不同受检者身上进行不同手法操作的方法更为可靠。

（四）结语

我们选择了17~50岁之间的健康者和患者各16人，共32人，其中男性16人、女性16人，用可以测出 0.05°C 差异的半导体点温度计（上海创造厂出品）测定皮肤温度的方法，对热补（烧山火）、凉泻（透天凉）手法的影响，进行了临床实验观察，同时并不与针刺和平补平泻作了对比。根据实验结果，针刺一侧合谷穴，测定两侧商阳穴和同侧少泽穴的皮肤温度，发现热补手法使皮肤温度先下降后上升，凉泻手法使皮肤温度下降。这说明热补、凉泻手法不仅可引起人体主观上有热和凉的感觉，同时也可反映在皮肤温度的客观变化上，为进一步探讨热补、凉泻手法的治疗机制，提供了初步的实验线索。

本实验是同吴希靖、金仁淇、俞福林大夫在中医研究院针灸研究所观察的，统计学处理是中国医学科学院统计室高润泉主任帮助完成的，协和医院中医科王台大夫协助总结的。

十四、对热补（烧山火）凉泻（透天凉）

针刺手法的实验观察

热补（烧山火）、凉泻（透天凉）是常用的补泻手法。由于热补、凉泻手法可使受试者分别产生热、凉的感觉，因此，我们以皮肤温度和血管容积波的变化为指标，进行了实验观察，结果如下。

（一）一般资料

本组41例中，男19例，女22例；最小17岁，最大62岁。其中健康者21例，患者20例。

（二）实验方法

在同一人身上，用30号一寸不锈钢毫针，针刺一侧合谷穴。进针至出针共1分钟。先用热补手法，隔日行凉泻手法。41例均完成了两种手法，以观察两种手法对针刺前后皮肤温度和血管容积波的影响。

1. 热补凉泻手法：①热补手法：术者左手拇指或食指紧按针穴，右手将针进至5分深左右，候其气至，左手加重压力，右手拇指向前连续捻按30次（约20秒），候觉针下沉紧，针尖似拉着有感觉的部位，再连续急（重）插慢（轻）提30次（约20秒），然后拇指向前推着守气20秒左右，使针下持续沉紧，立即出针。②凉泻手法：术者左手拇指或食指紧按针穴，右手将针进至5分深左右，候其气至，左手减轻压力，右手拇指向后连续捻提30次（约20秒），候针下沉紧，提退一分左右，针尖向产生感应的部位，连续慢（轻）插急（重）提30次（约20秒），拇指向后拉着守气20秒左右，使针下轻滑，立即出针。

2. 皮温测量及血管容积波描记：①皮肤温度测量：受试者在室内取坐位，安静休息约20分钟，在针刺合谷穴前15分钟，用国产626—4型半导体热敏电阻点温度计测量双侧商阳和同侧少商

穴的皮肤温度，候皮温恒定后开始实验。分别在针前、针后即刻、5、10、15、20、30分钟时测量上述3穴的皮肤温度，每次测量30秒钟。②血管容积波描记：采用国产HB3PLG型多导生理记录仪，将其描记头（光敏电阻法）接在被试者针刺对侧的无名指端，分别描记针刺前、后5、10、15、20、30分钟时的变化。

为了减少实验误差，各项操作均由专人负责，不给受试者任何暗示。实验过程中室温为20—27℃，每次实验室室温波动 $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$ ；湿度16~24℃。

（三）实验结果

1. 皮肤温度的变化：①同侧商阳穴皮肤温度的变化：热补组使皮肤温度先稍下降而后升高，凉泻组的皮肤温度迅速下降然后逐步回升。41例中热补组中升高 1°C 以上者36例，占87.7%，升高最多者可达 4.9°C ；凉泻组中下降 1°C 以上者36例，占87.8%，下降最多者可达 5°C 。经统计学处理。热补手法针后5分钟的皮温与针前比较差异不显著（ $P>0.05$ ），针后10分钟皮温升高 1.52°C （ $P<0.05$ ），15~30分钟皮温显著升高 $1.84\sim 1.99^\circ\text{C}$ （ $P<0.01$ ）。凉泻手法针后即刻的皮温与针前比较显著下降 1.75°C （ $P<0.01$ ），针后5~30分钟则差异不明显（ $P>0.05$ ），见表11。②对侧商阳穴皮肤温度的变化：41例中热补组中升高 1°C 以上的33例，占80%，升高最多者达 5.3°C ；凉泻组中下降 1°C 以上的35例，占85%，下降最多者达 5.5°C 。施热补手法后对侧商阳穴温度上升的较同侧慢，针后15分钟以前的皮温与针前比较，差异不明显（ $P>0.05$ ），而针后20~30分钟皮温明显升高 $1.62\sim 1.66^\circ\text{C}$ （ $P<0.05$ ）凉泻手法针后即刻皮温与针前比较，显著下降 1.63°C （ $P<0.01$ ），针后5~30分钟差异不明显（ $P>0.05$ ）详见表12。③同侧少商穴皮肤温度的变化：同侧少商穴皮肤温度的变化趋向，与双侧商阳穴的变化基本一致。41例

表11 41例受试者同侧商阳穴针刺前后皮肤温度变化 ($\bar{x} \pm S.E.$)

手 法	针前皮温 ($^{\circ}\text{C}$)	起 针 后 不 同 时 间 (分 钟) 皮 温($^{\circ}\text{C}$)					
		即 刻	5'	10'	15'	20'	30'
热补	28.83 ± 0.54	28.75 ± 0.51 -0.08 >0.05	29.71 ± 0.56 +0.88 >0.05	30.35 ± 0.47 +1.52 <0.05	30.71 ± 0.47 +1.88 <0.01	30.67 ± 0.49 +1.84 <0.01	30.82 ± 0.47 +1.99 <0.01
凉泻	30.36 ± 0.42	28.61 ± 0.39 -1.75 <0.01	29.72 ± 0.43 -0.64 >0.05	30.17 ± 0.41 -0.19 >0.05	30.36 ± 0.41 0 >0.05	30.28 ± 0.39 -0.08 >0.05	30.04 ± 0.40 -0.32 >0.05

表12 41例受试者对侧商阳穴针刺前后皮肤温度变化 ($\bar{x} \pm S.E.$)

手 法	针前皮温 ($^{\circ}\text{C}$)	起 针 后 不 同 时 间 皮 温 ($^{\circ}\text{C}$)					
		即 刻	5'	10'	15'	20'	30'
热补	29.34 ± 0.58	29.10 ± 0.59 -0.24 >0.05	29.97 ± 0.56 +0.63 >0.05	30.80 ± 0.51 +1.46 >0.05	30.76 ± 0.53 +1.42 >0.05	31.00 ± 0.57 +1.66 <0.05	30.96 ± 0.59 +1.62 <0.05
凉泻	30.73 ± 0.42	29.10 ± 0.43 -1.63 <0.01	29.99 ± 0.44 -0.74 >0.05	30.51 ± 0.44 -0.22 >0.05	30.54 ± 0.42 -0.19 >0.05	30.53 ± 0.42 -0.2 >0.05	30.15 ± 0.43 -0.58 >0.05

中热补组中升高 1°C 以上的33例，占80%，升高最多者达 5.1°C ；凉泻组中下降 1°C 以上的 33 例，占80%，下降最多者达 3.4°C 。经统计学处理，热补手法针后10分钟以前的皮温与针前比较，差异不显著 ($P>0.05$)。针后15~30分钟皮温明显升高 $1.64\sim 1.76^{\circ}\text{C}$ ($P<0.05$)，凉泻手法针后即刻皮温与针前比较明显下降 1.06°C ($P<0.001$)。而针后 5~30分钟差异不明显，($P>0.05$) 详见表13。

2. 血管容积波的变化：根据41例血管容积波描记结果分析，用热补手法血管容积波多数表现为上升。高峰出现在针后15分钟，占总数的73.2%，20分钟占65.9%，10分钟占63.4%，30分钟占56%，5分钟占53.6%；用凉泻手法后，多数人血管容积波下降，高峰出现针后30分钟，占总数的58.5%，20分钟占56%。详见表14。

从 X^2 测验结果来看，5分钟时，两种针刺方法差异不显著 ($P>0.05$)，而10~30分钟则差异有高度显著性 ($P<0.001$)。

(四) 体会

血管运动反应是机体对内外界环境各种刺激常见的应答性反应之一。不同的刺激可以引起不同的反应，而且由于机体的机能状态不同，对相同的刺激可以产生不同的反应。在实验中，我们观察到，女性比男性反应灵敏，老年比青年反应迟缓，阳虚者反应迟缓，阴虚者反应灵敏。但从对热补和凉泻两种不同针刺手法的反应结果来看，仍能是热补手法容积波上升者为多，凉泻手法下降者为多。这种变化因此临床上应根据患者的具体状态使用补泻手法，以免犯“虚虚实实”之戒，影响疗效甚至导致病情加重。

双侧的皮肤温度升降结果基本是一致的，说明针刺不仅有局部的作用，且对整体有调整作用。

本组受试者均先接受热补手法，隔日施行凉泻手法。总结时

表13 41例受试者同侧少商穴针刺前后皮肤温度变化 ($\bar{x} \pm S.E.$)

手 法	针前皮温 ($^{\circ}\text{C}$)	起 针 后 不 同 时 间 (分 钟) 皮 温 ($^{\circ}\text{C}$)					
		即 刻	5'	10'	15'	20'	30'
热补	29.78 $\pm$ 0.56	29.66 $\pm$ 0.53	30.50 $\pm$ 0.52	31.20 $\pm$ 0.45	31.42 $\pm$ 0.46	31.54 $\pm$ 0.46	31.47 $\pm$ 0.43
度与针 前温差 P 值		-0.12 >0.05	+0.72 >0.05	+1.42 >0.05	+1.64 <0.05	+1.76 <0.05	+1.69 <0.05
凉泻	32.96 $\pm$ 0.36	29.90 $\pm$ 0.39	30.71 $\pm$ 0.40	31.15 $\pm$ 0.36	31.18 $\pm$ 0.36	31.25 $\pm$ 0.36	30.99 $\pm$ 0.35
度与针 前温差 P 值		-1.06 <0.05	-0.25 >0.05	+0.19 >0.05	+0.22 >0.05	+0.29 >0.05	+0.03 >0.05

表14 热补与凉泻针刺手法在不同时间对血管容积变化的影响

时间(分钟)	5'		10'		15'		20'		30'	
针刺手法	热 补	凉 泻	热 补	凉 泻	热 补	凉 泻	热 补	凉 泻	热 补	凉 泻
升降变化	53.6	41.5	63.4	39.0	73.2	29.2	65.9	19.5	56.1	22.0
	39.0	48.7	29.3	41.5	17.0	48.8	24.4	56.1	31.7	58.5
	7.4	9.8	7.3	19.5	9.8	22.0	9.7	24.4	12.2	19.5
X^2	2.89		13.92		38.8		43.8		24.6	
P 值	>0.05		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	

发现施凉泻手法时针前皮肤温度较高，我们又另做了3例凉泻手法，以观察针前及起针24小时后的皮肤温度变化。结果表明，同侧商阳相差 -3.2°C ，对侧商阳相差 -1.8°C ，同侧少商相差 -2.7°C 。以上情况说明热补、凉泻手法的效应可持续较长时间。

本实验是1982年在甘肃中医学院同徐鸿达、杨廉德副主任医师观察的，1984年8月在全国针灸针麻学术讨论会上进行了大会宣读。

十五、对手法、补泻的探讨

针刺手法的关键，在于左手揣穴、右手辅助。左手拇指或食指押在穴位上似侦察兵，向前后、左右推拉、压按，摸到指感位置、揣准穴位；右手进针、左手候气。右手持针进针，要稳准坚实、全神贯注的将针迅速刺入皮下，避免刺痛，同时左侧押手要体会针下之气至冲动，并要观察患者的精神情绪和对针治的耐受力；针下得气、气至病所。左手一旦触到针下冲动，则按住针穴下方，右手持针向上推进、使气至病所，及时应用或补或泻的手法与守气，持续针感；根据患者的病情和体质强弱，给以不同的适当的刺激量，才能达到治愈疾病的目的。

（一）心手合一的持针进针：

在持针时，医生必须心神安静。先用左手固定进针部位，使其不要移动，然后循按经穴，揣准穴位，分拨妨碍进针的肌腱、血管等，以确定进针的方向和深浅；右手持针直下，不可偏左偏右，防止刺痛，进针要从容稳准，防止肌肉缠针产生疼痛；更要两手配合，稳重坚实。心神专一的操作，并要观察病人的精神活动和表情，这样不但能体会针下气至冲动的快慢、强弱和感传的远近，还可防止事故。

（二）针下气至的邪气与正气；

《灵枢·终始》篇说：“邪气来也，紧而疾，谷气来也，徐而和”。邪气在针下的表现“紧”，是来势紧迫而匆促；“疾”是动态急速而迅疾；即针下突然紧涩、肌肉缠针或感应一闪即无，这就是邪气。谷气包括营卫。“营气”即水谷之精气。营行脉中，徐和柔匀，即针下“指端搏动感”连续出现的现象。“卫气”即水谷之悍气。卫行脉外，慄悍滑利，疾而不紧，滑而不涩，如动脉之状，感应缓和，时间持久，这就是经气（正气）以上必须心手合一地在长期临床实践中细心体会。

（三）经气已至勿失良机：

《灵枢·邪气藏府病形》篇说：“中气穴，则针游于巷”。指出针刺的作用，关键在于刺中了经穴，尽快得气，并使感应沿着经脉循行线扩散传导。医生应根据病人的体质、营养、精神等来掌握病人的气血虚实、邪正盛衰等情况，其变动是离不开穴位空窍的。空窍中的气血、神气的活动，是至清至静而微妙的，当针下有了得气感，就要精细地注意气之往来，才不致错过用手法的时机。谨守气之往来，及时进行补泻，不能错过毫发之隙；不懂病机道理的，针下气已至，到了应补泻之时，而不能及时运用手法，等于箭已上弦，当射而不发。用针治病，必须知道针下气之往来盛衰，及时运用关闭法，使气至病所和进行补泻，才能手到病除。但人的气血、体质各不相同，所以针下的感应也不一致。或针刚刺入即有感应；或感应与针适时而至；或出针后始有感应；或经过数次针后，感应才逐渐产生。这是经常遇到的，要随机应变、灵活掌握。

根据病情需要，得气后施以补泻手法，才能达到“补虚泻实”的效果，同时在患者有舒适感应时“守气”勿失，并做到需要多长时间，就使气保持多长时间，这是针刺手法与取得疗效的关键。所以古人把能“守气”者，称为“上工”。

（四）补泻性质不同针感和治证各异：

补法是治疗虚证的，它能鼓舞人体的正气，使低下的功能得到恢复或旺盛起来；泻法是治疗实证的，它有消泻人体的邪气，使亢进的机能缓解或恢复正常。这是通过针刺某些穴位，激发经气来调节脏腑、经络的功能，促进阴阳平衡的。《素问·针解篇》说：“刺虚则实之者，针下热也，气实乃热也；满而泻之者，针下寒也，气虚乃寒也”。指出补和泻性质不同，产生的痠、麻、胀、热、凉等感觉也不同，因而各有各的适应证。补法治疗虚证，需要由针下虚滑转为沉紧、气实，产生热感；泻法治疗实证，需要由针下沉紧变为松滑、气虚，产生凉感。谢国荣氏1986年11月在全国针法灸法研究会上说：“针刺治疗是‘力’的物理效应，是利用力学原理来治病……运用手法千变万化，归其一点，即体现为针力。手持针柄操作，在针的远端——针尖，必然出现力的作用……如果手运针于针柄处，若认定为施力点，在皮肤的针身处为支点的话，则承受力的针尖应为着力点，当着力点集中在针尖时，作用于机体腧穴，将产生巨大的力量。……根据力的原理，针刺则必须借助于针力与力向……针力结合力向变化，将产生补泻两种不同质的效应”。

“提插补泻：反复插针，阳气隆至，针下热为补；反复提针，阴气隆至，针下寒为泻。其力的作用、有如船掌篙，针柄是施力点，针尖是着力点，以插为主，则针尖首当其冲，凭针力而产生针刺热效应，有人或谓这是摩擦生热，针身是存在滑动摩擦力，那么以提为主，亦是摩擦，却针下寒，这说明针体摩擦力在此不是起主要作用，而针尖之力在提、插针法中，均起主导作用，其中尤其是力向，针尖着力点向内为补，向外为泻，这是针刺补泻的基本效应”。也就是针尖着力点向内、针下实为补；向外、针下虚为泻的基本效应。

“捻转补泻：拇指向前，左捻为补，拇指向后，右捻为泻。我认为分左右捻针，这与补泻关系似乎不是主要的，问题是右手

持针，往往拇指向前下方倾斜，当拇指向前左捻，则拌以向下之力，拇指向后右捻，则拌上提之力，所以捻转之中，无形中配合了向上向下用力的力向，基于此点，有时把拇指向前捻转，改为食、中指向后向上捻转，临床上便出现了泻的针刺效应，故捻转不在左右，关键为是否兼有向上向下之针力”。也就是向上、向外提拉为泻；向下、向内插按为补的针力。

“刮、弹、摇、旋针法：此四种针法从力学认识，类属杠杆的形式，即以皮肤为支点，针柄为施力点，针尖为着力点”。

“刮针法：属辅助手法，向下刮动针柄为补，向上刮为泻。因向下刮则力向往下，向上刮则力向往上，故补泻分明”。

“弹针法：属辅助手法，轻弹为补，重弹为泻。因轻弹，针尖震动幅度小，震动波向下影响；重弹则针尖震动幅度大，且随针尖震弹摇摆，针力向两侧扩散，故两种针效有别”。

“摇针法：是持针柄向两侧摆动，或摇大针孔，属泻法。这更是由于针尖摇动幅度大，力向往两边扩散之故”。

“旋针法：即持针柄如推磨式旋转，属泻法，由于针尖盘旋幅度更大，针力向四周扩散，因此为泻法”。

刺激质和量不能截然分开，因为刺激量的大小、轻重，往往会引起质变。量合适可以治病；量不足治不好病；量太过反会给患者带来痛苦。比如补法适量，产生热感，能治疗虚寒证；加量即为烧山火，或为大补法，能温经散寒，治疗外感风寒，或风寒湿痹证；如量太过则汗多亡阳、伤阴，变为泻法。泻法适量，产生凉感，治疗实热证；减量能清热养阴，治疗阴虚内热证；加量即为透天凉，或为大泻法，能清热解表，治疗外感风热、暑热高烧、或热结胃肠、证实邪实等一切实热证；如量太过则亡阴、伤阳，使人虚脱。所以治病，要根据患者的病情和体质强弱的不同，要灵活掌握不同的补泻手法和不同的刺激量，这样才能获得预期的治疗效果。

第三章 灸 法

灸法是采用艾绒制成艾炷、艾条，在人体穴位或患处的皮肤表面，直接或间接的温烤，以温运气血，疏通经络，扶正祛邪，达到治疗或预防疾病的目的。

第一节 施灸的原料

施灸的种类繁多，所用的原料亦各有不同。历代文献记载有火簇灸、烟草灸、油捻灸、硫黄灸等，但应用最广泛的为艾灸，所以艾叶为施灸的主要原料。

艾系野生草本属菊科植物，性温芳香，我国各地皆产，但以蕲州产者为良，故有蕲艾之称。古人认为在旧历“端午节”（五月初五日）采者为佳。艾叶经过晒干后，加工捣春，筛去尘渣，取其柔软纤维则成艾绒。

新艾绒火力强，施灸时皮肤灼痛较剧，陈艾绒油质挥发殆尽，施灸时不但火力均匀不易熄灭，而且不易散裂。《孟子·离娄篇》中说：“七年之病，求三年之艾”。说明我国不但在几千年前艾灸治病就很盛行，而且古人也认识到了艾灸治病以陈艾为佳。因为需要陈艾绒，所以贮藏期间，必须常晒，防止潮湿、霉烂和虫蛀。

第二节 艾灸的常用方法

一、艾炷灸法

艾炷是艾绒制成的圆锥形的艾团。一般是将陈艾绒放在平板上，用拇、食、中三指捏成圆锥形大小不同的艾炷。艾炷小的如麦粒，中等的如半个枣核，大的如蚕豆，现在常用的多为艾炷器制成的艾炷，高约1公分，柱底直径为0.8公分，重约0.1克（一个艾炷相当于1公分艾条），可燃烧3～5分钟（图121～122）。

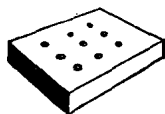


图121艾炷器



图122 艾炷

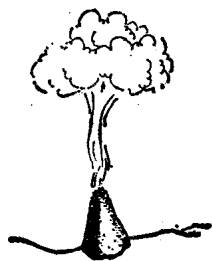


图123直接灸

（一）直接灸法

1. 无瘢痕灸：将中等艾炷放在穴位的皮肤上，点燃施灸，不等艾炷燃尽而患者感到灼痛时，立即更换艾炷再灸，不要使皮肤烧伤起泡。如用麦粒状小艾炷施灸，当患者感到灼痛时，医生立即用指甲将艾炷压灭，再更换艾炷继续施灸。多用于治疗腹痛、腹泻、腰痛、阳痿等一切虚寒性病症（图123）。

2. 瘢痕灸：施灸前点出准确穴位，选好舒适体位。在穴位上涂敷蒜汁，然后将艾炷粘上点燃施灸，等艾炷全部燃尽，除去灰烬，再涂蒜汁换艾炷再灸。将规定的壮数（一个艾炷为1壮）灸完为止。施灸时用双手在灸处周围轻轻拍击，可以缓解灼痛。施

灸前用2%普鲁卡因在施灸的局部注射，可以麻醉不痛。施灸完毕用棉球或纱布将灸处擦净。用清水膏（广丹4~6两，麻油1斤熬成的小膏药）紧贴灸处，以资保护。灸后一周左右化脓，六周左右结疤。化脓期间如脓液过多则每日换膏药1~2次，脓液少则隔日更换一次。如果不化脓则每日在灸处用艾条灸5~10分钟，连灸2~3天即可化脓。本法由于能引起烧伤、化脓、结疤，患者较痛苦，因此目前应用很少。但灸风门、肺俞、膏肓、膻中治疗哮喘；灸水分、关元、气海、足三里治疗胃和十二指肠溃疡、水肿等症效果良好。

（二）间接灸法

1. 隔姜或隔蒜灸：先将0.5~1分厚的鲜姜片或蒜片，用粗针刺几个孔，放在应灸穴位的皮肤上，然后再将艾炷放在姜片或蒜片上，点燃施灸，将艾炷燃尽，再换艾炷。将预定壮数灸完为止。一般施灸处出现湿润红热现象，患者有舒适感觉为宜。为了防止灼痛起泡，必要时在姜片或蒜片下面，再垫上一片也可。隔姜灸多用于治疗消化不良、腹痛、腹泻、遗精、早泄等虚寒症和风湿痹症等；隔蒜灸，古人认为有消肿解毒、定痛、散结的功能，多用于治疗慢性肿疡、蛇、蝎、毒虫所伤等症（图124）。

2. 隔盐灸：用干净的食盐将肚脐填平，再将艾炷或用艾条放在盐上点燃施灸，以患者感觉舒适为宜（严禁灼痛起泡）。古人认为隔盐连续施灸，有回阳固脱的作用，故多用于治疗腹痛、吐泻、虚脱等症（图125）。



图124 隔姜（蒜）灸

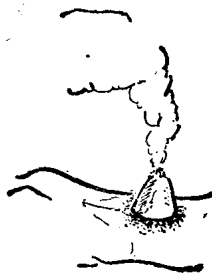


图125 隔盐灸

二、艾条灸法

艾条亦称艾卷，是我国古代雷火神针，太乙神针等药条灸简化而来的。

艾条是用细麻纸（或易燃薄纸）将艾绒卷紧后，用胶水或浆糊封住制成的。目前中医研究院中药研究所制的艾条长20厘米，直径1.2厘米，每支约重10克，可燃烧1小时。艾条不仅制作和操作简便，而且刺激量的强弱也容易掌握，所以目前应用最广泛。

艾条灸有两种手式，一种是以拇、食、中三指如持钢笔一样的持艾条，并用小指固定在被灸部位的附近，这样不仅能避免术者手腕动荡不稳，又能避免在长时间施灸的疲劳。另一种是以拇、食二指持艾条，用中指固定在被灸穴位的附近。

1. 温和灸：将艾条点燃的一端靠近穴位，距皮肤约二寸处。根据患者的热感反应，上下移动，调节温度。在患者施灸处有温热舒适感觉时固定施灸，灸到预定时间为止。一般可灸5~30分钟。本法由于灸火温热缓和，临床上最为常用（图126）

2. 雀啄灸：将艾条点燃的一端，距皮肤约二寸处，对准施灸穴位的皮肤，一起一落，象麻雀啄食样的施灸，一般可灸5~10分钟。本法由于灸火热度较小，多用于治疗小儿疾患和昏厥（图127）。

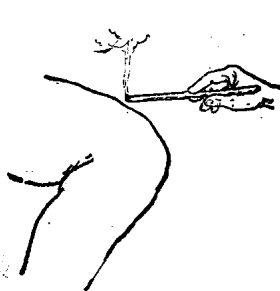


图126 温和灸

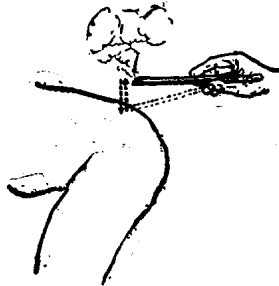


图127 雀啄灸

3. 熨热灸：将艾条点燃的一端，接近施灸部位，距皮肤约一寸处，象熨衣服样的往返移动，一般施灸20~30分钟。多用于治疗鹅掌风、皮炎、冻疮等（图128）。

4. 温针灸：亦称针柄灸。先将针刺入被针穴位，找到感应，然后将一寸左右的艾条插于针柄上或用艾绒裹在针柄上，由下面点燃施灸，借针体将艾火的热力传到穴内。多用于治疗风湿性关节痛和一切虚寒症（图129）。

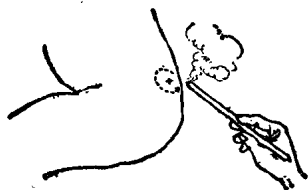


图128 温针灸



图129 熨热灸

第三节 施灸的作用与注意事项

施灸的作用很多，能治疗很多种病症，但用之不当，也会给患者造成痛苦，甚或发生事故，所以施灸时也应注意。

一、施灸的作用

《灵枢·经脉》篇说：“陷下则灸之”。《禁服》篇说：“陷下者，脉血结于中，中有著血，血寒，故宜灸之”。《针灸大成》千金灸法说：“若要安，三里常不干”。明朝《医学入门》说：“药之不及，针之不到，必须灸之”。说明在不同穴位上施灸，不但能治疗很多种病症，而且还有预防和保健作用。

1. 温散寒邪：艾绒性温，以火点燃熏烤或烧灼穴位，使火力

透过皮肤、肌肉、经络、患者局部感到温热舒适或沿着经络上下传导，有温散寒邪，治疗风、寒、湿痹和虚寒性腹痛、泄泻等症的作用。

2. 温通经络：凡属某一经络或部位气滞血凝，经络受阻引起的麻木、疼痛、肿胀等症，灸治一定的穴位，有温经止痛、调和气血的作用。

3. 益气养血：凡属中气下陷引起的腹泻、脱肛、子宫脱垂，或气血耗损，经络失养引起的肌肉萎缩、肢体麻痹等症，灸治一定穴位，有益气养血，补虚扶正的作用。

4. 回阳固脱：凡见四肢厥逆、气短脉微、手撒口开、目闭神昏、二便失禁的脱症，灸治一定的穴位，有回阳固脱的作用。

5. 预防保健：历代文献中常提到灸法的预防作用，《医说》中提到灸三里可以预防中风。目前临床上常灸大椎、风门等穴预防感冒；灸足三里能调整脾胃功能，促进身体健康。

二、施灸注意事项

灸法虽然容易掌握，但在具体操作时如果不注意，不但影响疗效，也会发生事故。

1. 选择体位：施灸前必须根据施灸的部位，选择舒适而固定的体位。

2. 施灸的壮数和时间：艾炷大小和壮数多少，应根据病人之年龄大小和体质强弱酌情增减。老人、小孩和身体弱的，施灸时艾炷应当小些，壮数应当少些，艾条灸的时间要短些；身体壮的，中年人艾炷应当大些，壮数应当多些，艾条灸的时间要长些。艾条灸1分钟，相当于艾炷灸1壮。可以灵活掌握。

3. 施灸的部位：头颈部和上腹部灸的壮数和时间应当少些，小腹部和腰背部灸的壮数和时间应当多些；在五官、面部、毛发处、生殖器官、大血管处、粘膜附近应避免施灸。

4. 作好思想工作：瘢痕灸因有灼痛、化脓和结疤，施灸前必须向患者解释清楚，使患者和医生合作。

5. 禁灸：咯血、吐血、中风闭症、大便秘结等实热症禁灸。《针灸大成》禁灸穴歌中提出的禁灸穴位：哑门、风府、天柱、承光、头临泣、头维、丝竹空、攒竹、睛明、素髻、禾髻、迎香、颧髻、下关、人迎、天牖、天府、周荣、渊液、乳中、鸠尾、腹哀、肩贞、阳池、中冲、少商、鱼际、经渠、地五会、阳关、脊中、隐白、漏谷、阴陵泉、条口、犊鼻、阴市、伏兔、髀关、申脉、委中、殷门、承扶、白环俞、心俞，共45穴。如在面部施化脓灸，遗留疤痕；人迎、委中均在大血管附近，应该禁灸。但有些禁灸穴，施灸很有疗效，如灸隐白治疗崩漏，灸犊鼻治疗膝关节痛等。应根据临床实践，不要泥于古说。

6. 避免烧伤和火灾：要防止艾绒或艾炷脱落，烧伤皮肤和衣被等。灸后将艾条的燃火一端剪掉，艾炷用镊子钳取，放入罐内，以免复燃发生火灾。

第三篇 临床治疗

第一章 临床治疗总论

针和灸是两种不同的治病方法。针是刺入体内，灸是熏灼皮肤，都是通过穴位、经络调节人体脏腑、营卫气血而达到扶正祛邪、预防和治疗疾病的目的。

第一节 针灸治病总则

针灸是通过经络穴位，从外治内的治病方法，但其治病原则和内服药物一样，仍然是虚证用补，实证用泻。急则治标，缓则治本。分清主次，采取各个击破，以达到扶正祛邪的治病目的。

一、补虚泻实

虚指的人体正气虚弱，实指的邪气偏盛。在具体运用上，实热证多采用浅刺出血方法，如局部青紫红肿，必要时用三棱针点刺放血；虚寒证应用补法留针或施灸。疼痛痉挛的多用泻法留针；麻痹不痛的多用补法和灸法。虚实夹杂的宜用平补平泻或补泻兼施。表症、皮肉病宜浅刺、里症、筋骨病宜深刺。

二、标本缓急

一般说，症状为标，病因为本。病邪为标，正气为本。本是

主要方面，所以有治病必求其本的原则。但在临床上要灵活掌握，故又有急则治其标，缓则治其本的原则。急性病表现症状为主的如剧痛、尿闭、昏迷等，应先治症，然后治因。慢性病没有剧烈症状，则应以治疗病因为主。如思虑太过，劳伤心脾，出现心悸、盗汗、多梦、易惊、失眠、食欲不振，疲乏无力等一派症状，而治疗时要审症求因，只要抓住调理心脾，使其功能恢复正常，症状就随之消除。气血虚弱易受外邪侵犯，所谓“邪之所凑，其气必虚”的，当以培补正气为主，就是“扶正祛邪”的法则。

三、主次先后

在治病当中如遇患者病情复杂，应当先抓主要病症治疗。如妇女闭经引起其它病症，要先治闭经，经血一调，其它病就好调治或不治自愈；但如见到另一种情况，一个人身上患有几种病，也可先治好治的，后治难治的。如既有风湿性关节炎，又有消化不良，可先治消化不良，后治关节炎，因为关节炎是一个慢性病，须较长时间治疗才能治好的病。这样就可以各个击破。

以上所举，只是说明医生在治病时，既要掌握治疗原则；又要有灵活性。既要根据病情变化抓主要矛盾和主要矛盾的主要方面；又不能孤立静止片面的去看待疾病的产生和发展变化。要突出祖国医学的整体观念和辨证施治的特点，才能收到良好的治疗效果。

第二节 特定穴的应用

特定穴，是根据其性能而给予特别称号的腧穴，对临床诊断和治疗都很重要，现分类将其功能及应用概述如下：

一、五腧穴

部位：五腧穴都在四肢肘膝以下，手不过肘，足不过膝。阴经各有五穴，阳经各有六穴，共六十六穴。按井、荣、俞、原、经、合的次序排列，阴经无原穴，而以俞穴代之（表15~16）。

表15 阴经五腧穴

阴经	五腧 意义 主治	井（木）	荣（火）	俞（土）	经（金）	合（水）
		所出	所溜	所注	所行	所入
		心下满	身热	体重节痛	喘咳寒热	逆气而泄
肺（金）		少商	鱼际	太渊	经渠	尺泽
脾（土）		隐白	大都	太白	商丘	阴陵泉
心（火）		少冲	少府	神门	灵道	少海
肾（水）		涌泉	然谷	太溪	复溜	阴谷
心包（相火）		中冲	劳宫	大陵	间使	曲泽
肝（木）		大敦	行间	太冲	中封	曲泉

功能：腧有输通的含意。《灵枢·九针十二原》篇说：“经脉十二，络脉十五，凡二十七气，以上下。所出为井，所溜为荣，所注为俞，所行为经，所入为合”。古人把井穴比作刚从地下涌出来的泉水；荣穴比作开始溜而不大的水流；俞穴比作能灌溉运输的水流；经穴比作畅行的水流；合穴比作汇入大河的水流。说明五腧穴有输通经络，运行气血，营养全身的作用。还有与五行配合的方法，即阴经的井属木，荣属火、俞属土，经属金，合属水。阳经的井属金，荣属水，俞属木，经属火，合属土。

应用：凡脏腑经络发生的病症，皆可取该经的五腧穴进行治疗，因此取穴的名称很多。

表16 阳经五腧穴

阳经	五腧 意义 主治	井(金)	荣(水)	俞(木)	原 (总刺)	经(火)	合(土)
		所出	所溜	所注	所过	所行	所入
		心下满	身热	体重节痛	脏腑病	喘咳寒热	逆气而泄
大肠 (金)		商阳	二间	三间	合谷	阳溪	曲池
胃 (土)		厉兑	内庭	陷谷	冲阳	解溪	足三里
小肠 (火)		少泽	前谷	后溪	腕骨	阳谷	小海
膀胱 (水)		至阴	通谷	束骨	京骨	昆仑	委中
三焦 (相火)		关冲	液门	中渚	阳池	支沟	天井
胆 (木)		窍阴	侠溪	临泣	丘墟	阳辅	阳陵泉

按症取穴：是根据五腧穴主治取穴的方法。《难经·六十八难》说的：“井主心下满，荣主身热，俞主体重节痛，经主喘咳寒热，合主逆气而泄”。即症见心慌，并有心下满闷的取心经井穴少冲；肺炎痰多，身热的取肺经荣穴鱼际；胃痛，并有逆气或下泄的取胃经合穴足三里；但井穴还用于发热、昏迷及急性病的治疗。

本经取穴：是脏腑经络有病取本经腧穴的方法。如咳嗽症是肺经病，就取肺经穴位。

子母取穴：是本经应用五腧穴“虚则补其母，实则泻其子”取穴的方法。如肝经（属木）实证泻行间（荣火），火为木之子；肝经虚症补曲泉（合水），水为木之母。

异经取穴：是异经应用“虚则补其母，实则泻其子”的法则取穴的方法。如肾经（属水）虚取肺经（属金）经渠穴补之（金为水之母）；肝经（属木）实取心经（属火）少府穴泻之（火为

木之子)。

四季取穴：是根据春夏阳气在外，人体之气行于浅表，宜浅刺肌肉浅薄的井穴、荣穴；秋冬阳气在里，人体之气潜伏于里，宜深刺肌肉深厚的经穴、合穴。如春天伤风咳嗽取井穴商阳、少商；冬天腹痛泄泻取合穴曲池、足三里。

子午取穴：见《子午流注与灵龟八法》一书。

五腧穴歌：

少商鱼际与太渊，经渠尺泽肺相连。

商阳二三间合谷，阳溪曲池大肠牵。

厉兑内庭陷谷胃，冲阳解溪三里随。

隐白大都太白脾，商丘阴陵泉要知。

少冲少府属于心，神门灵道少海寻。

少泽前谷后溪腕，阳谷小海小肠经。

至阴通谷束京骨，昆仑委中膀胱知。

涌泉然谷与太溪，复溜阴谷肾所宜。

中冲劳宫心包络，大陵间使传曲泽。

关冲液门中渚焦，阳池支沟天井索。

窍阴侠溪临泣胆，丘墟阳辅阳陵泉。

大敦行间太冲看，中封曲泉属于肝。

二、原络穴

部位：除任、督和脾之大络外，其它原络穴位皆在四肢肘膝以下（表17）。

功能：“原”即本源，有原气的含意。原气是生命活动的根本，起于脐下丹田，通过三焦，输布于五脏六腑和十二经脉。十二原穴是脏腑经络中原气驻留的部位，起着推动脏腑经络生理活动的作用。原穴都排列在五腧穴之间，所以也已归属于五腧穴范围。“络”有网络与联络的含意。十五个络穴，是十五络脉分出

表17 原穴与络穴

经脉	肺	大肠	胃	脾	心	小肠	膀胱	肾	心包	三焦	胆	肝	任脉	督脉	脾大络
原穴	太渊	合谷	冲阳	太白	神门	腕骨	京骨	太溪	大陵	阳池	丘墟	太冲			
络穴	列缺	偏历	丰隆	公孙	通里	支正	飞扬	大钟	内关	外关	光明	蠡沟	会阴	长强	大包

处的穴位，多在表里经之间，有协调经络、疏通气血的作用。

应用：《灵枢·九针十二原》篇说：“十二原者，主治五脏六腑之有疾者也”。说明原穴能治疗五脏六腑病。络穴在表里两经之间，所以能治疗表里两经的有关病症。如肺经络穴列缺，不仅能治肺经病，而且还能治大肠经病症。

原穴络穴可单独取用，亦可配合使用。原络配穴，亦称主客配穴。是先取发病本经的原穴为主。后取与其互为表里经的络穴为客。所以亦称表里配穴法。如心包络经病的胸满心跳，喜笑不休，取本经原穴大陵为主，再取三焦经络穴外关为客。

原络穴歌：

原穴歌：

心包大陵焦阳池，肝经太冲胆丘墟。

大肠合谷肺太渊，胃原冲阳太白脾。

小肠腕骨心神门，膀胱京骨肾太溪。

络穴歌：

膀胱飞扬肾大钟，脾经公孙胃丰隆。

大肠偏历肺列缺，小肠支正通里心。

心包内关焦外关，肝经蠡沟胆光明。

脾之大络名大包，督脉长强任会阴。

三、俞募穴

部位：俞穴皆位于背腰部脊柱两旁，募穴皆位于胸腹部，二者的穴位多数与脏腑所在部位相对，故以脏腑而命名（表18）。

表18 俞穴与募穴

脏腑	肺	大肠	胃	脾	心	小肠	膀胱	肾	心包	三焦	胆	肝
俞穴	肺俞	大肠俞	胃俞	脾俞	心俞	小肠俞	膀胱俞	肾俞	厥阴俞	三焦俞	胆俞	肝俞
募穴	中府	天枢	中脘	章门	巨阙	关元	中极	京门	膻中	石门	日月	期门

功能：“俞”有输转的含意，是各经脏腑之经气向背部输转散布的处所，也是风寒外邪由背部侵入、或脏腑功能失调在背部出现压痛等异常现象的部位；“募”与“幕”相通，有聚集的含意，是各经脏腑之经气在胸腹部聚集之处，也是脏腑功能失调在胸腹部出现压痛等异常现象的部位。因而俞穴、募穴均有疏调脏腑经气的作用。《素问·金匱真言论篇》说：“背为阳，腹为阴”。《难经·六十七难》说：“阴病行阳，阳病行阴，故令募在阴，俞在阳”。

应用：李东垣说：“阴病在阳者，当从阳引阴”，“故以治风寒之邪，治其各脏之俞”。“阳病在阴者，当从阴引阳”，“凡治腹之募，皆为原气不足，从阴引阳”。根据这一论述，笔者在临床上体会到：外感初期多取募穴，内伤久病多取募穴；邪气有余多取俞穴，正气不足多取俞穴，急性病多取俞穴，慢性病多取募穴；血分（阴）病多取募穴，气分（阳）病多取募穴；以上所举为俞、募穴应用常规。如风寒初起，病未及里，误取募穴，则有引邪入里之弊，但临床见证错综复杂，往往有虚实夹杂，表里俱病，又要俞募配合应用，称为俞募配穴法。总之要根

据病人的体质和病机反应，知常识变，灵活掌握。

俞募穴歌

俞穴歌：

胸三肺俞四厥阴，心五肝九胆十临。

十一脾俞十二胃，腰一三焦腰二肾。

腰四骶一大小肠，膀胱骶二椎外寻。

募穴歌：

心募巨阙肝期门，心包膻中肾京门。

肺募中府胃中脘，小肠关元焦石门。

膀胱中极胆日月，大肠天枢脾章门。

四、八会穴

部位：八会穴除头部外，分布全身各处（表19）。

表19 八会穴

八 会	腑会	脏会	筋会	髓会	血会	骨会	脉会	气 会
穴 位	中脘	章门	阳陵泉	绝骨	膈俞	大杼	太渊	膻 中

功能：“会”有会合与聚会的含意，八会穴是指人体脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓八者之气所聚会的部位。有调理脏腑、调和气血、疏筋益髓的作用。

应用：凡是属于脏、腑、筋、骨、髓、血、脉、气这八个方面的疾病，皆可取有关会穴进行治疗。如筋挛、筋缩、筋软取筋会阳陵泉；脘腹胀痛、便秘或泄泻取腑会中脘。

八会穴歌：

腑会中脘脏章门，髓会绝骨筋阳陵；

血会膈俞骨大杼，脉会太渊气膻中。

五、八脉交会穴

部位：八脉交会的八个穴位，皆位于四肢腕踝前后（表20）。

表20 八脉交会穴

经脉	肺	小肠	脾	胆	肾	膀胱	心包	三焦
穴位	列缺	后溪	公孙	临泣	照海	申脉	内关	外关
通脉	任脉	督脉	冲脉	带脉	阴跷脉	阳跷脉	阴维脉	阳维脉

功能：“交会”有交接会合的含意。八脉交会穴是十二经与奇经八脉交会相通的八个穴位，同样有调整脏腑、疏通经络的作用。

应用：八脉交会穴通常是两穴配合应用，亦可单独取用。如单取内关治胃病；内关、公孙配用治胃、心、胸部的病和疟疾；后溪、申脉配用治内眼角、颈、项、耳部病和发热恶寒的表证；外关、足临泣配用治外眼角、耳后、颊、颈、胁部病和往来寒热证；列缺、照海配用治咽喉、胸膈部病和阴虚内热证。

灵龟八法取穴：见《子午流注与灵龟八法》一书。

八脉交会穴歌：

内关相应是公孙，外关临泣总相同；
列缺交经通照海，后溪申脉亦相通。

六、郄 穴

部位：十六郄穴，多在四肢肘膝以下筋骨间隙中（表21）。

功能：“郄”有孔郄的含意，为经气深聚之处，也是脏腑经络功能失调在四肢出现明显压痛等异常现象的部位。有疏导经气、调整脏腑的作用。

表21 郄 穴

经脉	肺	大肠	胃	脾	心	小肠	膀胱	肾	心包	三焦	胆	肝	阴跷	阳跷	阴维	阳维
穴位	孔最	温溜	梁丘	地机	阴郄	养老	金门	水泉	郄门	会宗	外丘	中都	交信	跗阳	筑宾	阳交

应用：凡脏腑及所属经络的急性病痛，皆可取该经的郄穴进行治疗。如急性胆囊炎，取胆经郄穴外丘。外感风热、肺气不宜，发热口渴、咳嗽黄痰，取肺经郄穴孔最。均可取得良好效果。

郄穴歌：

孔最温溜肺大肠，水泉金门肾膀胱。

中都外丘肝与胆，阴郄养老心小肠。

郄门会宗心包焦，地机梁丘脾胃相。

交信跗阳阴阳跷，筑宾阳交维阴阳。

七、六腑下合穴

部位：六腑的六个下合穴，皆在下肢膝关节以下（表22）。

功能：“合”有会合的含意，六腑下合穴是脉气从足三阳经分出注入六腑的部位，有调整六腑、输导经气的作用。

表22 六腑下合穴

六 腑	大 肠	胃	小 肠	膀 胱	三 焦	胆
穴 位	上巨虚	足三里	下巨虚	委 中	委 阳	阳陵泉

应用：凡六腑的病症，皆可取该经的下合穴进行治疗。如阑

尾炎属大肠病取上巨虚；胆囊炎取阳陵泉。

下合穴歌：

大肠下合上巨虚，小肠下合下巨虚；
三焦委阳胆阳陵，膀胱委中胃三里。

八、四总穴

部位：四总穴皆在肘膝以下。

功能：四总穴是从原、络、合穴中选出的，有调整脏腑、疏通经络的作用。

应用：四总穴是治疗有关经络及所辖区域病症的要穴。如牙痛、面肿、口眼歪斜等症取合谷穴治疗。

四总穴歌：

肚腹三里留，腰背委中求；
头项寻列缺，面口合谷收。

九、回阳九针穴

部位：回阳九针穴，分布于项、腹及四肢。

功能：有培补元气、回阳救逆的作用。

应用：凡脏腑气血衰弱，或外邪侵袭引起元气大脱可取此类穴位，回阳救逆；阳不用事，功能低下，可取此类穴位，补阳益气、恢复功能。如寒中少阴、四肢厥逆、甚或神昏不语，取涌泉、足三里、哑门、合谷以回阳救逆、开窍醒神。瘫痪痿软取环跳、足三里、三阴交以疏筋活血，恢复功能。

回阳九针穴歌：

哑门劳宫三阴交，涌泉太溪加环跳；
中院三里合谷并，回阳救逆疗效高。

第三节 配 穴 法

配穴是针灸治病的处方，可单用一穴，也可用多穴配伍，与药物治疗的单方和复方一样，要根据病情的需要而定。

一、远隔配穴法

是在病症的远隔部位循经选穴治病的方法。适用于全身各种病症，对剧烈疼痛和痉挛效果好。

1. 循经配穴：是循病变本经穴位配穴的方法，全身各症都可使用。如心悸不安配神门、内关；咳嗽气喘配尺泽、太渊。

2. 异经配穴：是本经有病，取其互为表里或其它有关经穴位配用的方法。多用于复杂的病症。如肺热咳喘，口干咽痛配大肠经合谷、商阳；水不涵木，肝阳上亢配肾经阴谷、复溜。

3. 原络配穴：详见特定穴中原络穴一节。

4. 上病取下，下病取上配穴：是上面有病取下面，下面有病取上面穴位配穴的方法。如胃脘痛取足三里、内庭；牙痛取合谷；下肢瘫痪取肾俞、关元俞、秩边；手指无力取肩髃、曲池。

5. 左病取右，右病取左配穴法：通常称为健侧取穴。《内经》有巨刺和缪刺之称。多用于治疗急性疼痛。《素问·调经论篇》说：“身形有痛，九候莫病，则缪刺之；痛在于左而右脉病者，巨刺之”。《针灸大成》巨刺论说：“巨刺刺经脉，缪刺刺络脉，所以别也”。指出病侵络脉，邪浅症轻，需缪刺；病犯经脉，邪深症重，需巨刺。笔者根据这一理论，在临床上治疗落枕、颈项强痛，针悬钟或后溪，左病取右，右病取左，浅刺；肩关节周围炎针条口透承山，左病取右，右病取左，深刺。有明显效果。

二、局部配穴法

是在病症的局部或邻近部位选穴治病的方法。适用于全身各处病症。对麻痹无力、红肿热痛和脏腑功能失调效果好。

1. 前后配穴：是俞穴和募穴配用的方法。亦称俞募配穴法。详见特定穴中俞募穴一节。

2. 邻近配穴：是在病变附近配穴的方法。亦称局部配穴法。治疗麻痹无力、红肿热痛效果好。如手指麻木取后溪、合谷；目赤肿痛取攒竹、睛明。

3. 阿是穴、“天应”穴配穴法：是取病症周围的压痛点或“减痛点”（用手指押按疼痛消失或减轻的部位）治病的方法。如腰肌劳损，取压痛点或在结节肿物周围取穴；颈淋巴结核，在结核处围刺。

三、远近配穴法

是病症局部和远隔的穴位配合在一起治病的方法。适用于全身各种病症。

1. 上中下配穴：是局部和上下肢穴位配用的方法。如腹痛吐泻取中脘、天枢、内关、足三里。

2. 远近双侧配穴：是局部和远隔穴位配用的方法。全身病症都可使用。如失眠取百会、双神门；遗尿取关元、双三阴交。

3. 远近单侧配穴：是取局部和远隔患侧或健侧配穴的方法。取患侧多治疗瘫痪痿软，取健侧多治疗疼痛痉挛。如取左颊车、地仓、合谷治疗左侧面瘫；取右下关、地仓、颊车、合谷治疗左侧面神经牵。

4. 远近交叉配穴：是局部和远隔病侧与健侧穴位交叉配用的方法。全身病症都可使用。如取左风池、头维、太阳、右合谷治疗左偏头痛；取左支沟、右阳陵泉治疗胸胁痛。

第四节 治症总要（杨氏治症总要）

一论中风，但未中风时，一两月前，或三四个月前，不时足胫上发痠重麻，良久方解，此将中风之候也。便宜急灸三里、绝骨四处，各三壮，后用生葱、薄荷、桃柳叶，四味煎汤淋洗，灸令祛逐风气自疮口出。如春交夏时，夏交秋时，俱宜灸，常令二足有灸疮为妙。但人不信此法，饮食不节，酒色过度，卒忽中风，可于七处一齐俱灸各三壮，偏左灸右，偏右灸左、百会、耳前穴也。

1.阳症：中风不语，手足瘫痪者：合谷、肩髃、手三里、百会、肩井、风市、环跳、足三里、委中、阳陵泉（先针无病手足，后针有病手足）。

2.阴症：中风，半身不遂，拘急，手足拘挛，此是阴症也。亦依治之，但先补后泻。

3.中暑不省人事：人中、合谷、内庭、百会、中极、气海。

问曰：中暑当六、七月间有此症，八、九月，十月亦有此症，从何而得？

答曰：此症非一，医者不省，当以六、七月有之，如何八、九、十月亦有之？皆因先感暑气，流入脾胃之中，串入经络，灌溉相并，或因怒气触动，或因过饮、恣欲伤体，或外感风，至八、九月方发，乃难治也。六、七月受病浅，风疾未盛，气血未竭，体气未衰，此为易治。复刺后穴：中冲、行间、曲池、少泽。

4.中风不省人事：人中、中冲、合谷。

问曰：此病如何而来？已上穴法，针之不效，奈何？

答曰：针力不到，补泻不明，气血错乱，或去针速，故不效也。前穴未效，复刺后穴：哑门、大敦。

5. 中风口禁不开：颊车、人中、百会、承浆、合谷（俱宜泻）。

问曰：此症前穴不效，何也？

答曰：此皆风痰灌注，气血错乱，阴阳不升降，致有此病，复刺后穴：廉泉、人中

6. 半身不遂、中风：绝骨、昆仑、合谷、肩髃、曲池、手三里、足三里。

问曰：此症针后再发，何也？

答曰：针不知分寸，补泻不明，不分虚实，其症再发。再针前穴，复刺后穴：肩井、上廉、委中。

7. 口眼喎斜，中风：地仓、颊车、人中、合谷。

问曰：此症用前穴针效，一月或半月复发，何也？

答曰：必是不禁房劳，不节饮食，复刺后穴，无不效也。听会、承浆、翳风。

8. 中风，左瘫右痪：三里、阳溪、合谷、中渚、阳辅、昆仑、行间。

问曰：数穴针之不效，何也？

答曰：风痰灌注经络，血气相搏，再受风寒湿气入内，凝滞不散，故刺不效，复刺后穴。先针无病手足，后针有病手足。风市、丘墟、阳陵泉。

9. 正头大痛及脑顶痛：百会、合谷、上星。

问曰：此症针后，一日、二日再发，甚于前，何也？

答曰：诸阳聚会头上，合用先补后泻，宜补多泻少，其病再发，愈重如前，法宜泻之，无不效也。复针后穴，真头痛，旦发夕死，夕发旦死，医者当用心救治，如不然，则难治。神庭、太阳。

10. 偏正头风：风池、合谷、丝竹空。

问曰：以上穴法，刺如不效，何也？

答曰：亦有痰饮停滞胸膈，贼风串入脑户，偏正头风，发来连臂内痛，或手足沉冷，久而不治，变为瘫痪，亦分阴阳针之。或针力不到，未效，可刺中脘，以疏其下疾，次针三里，泻去其风，复针前穴。中脘、三里、解溪。

11. 头风目眩：解溪、丰隆。

问曰：此症刺效复发，何也？

答曰：此乃房事过多，醉饱不避风寒而卧，贼风串入经络，冷症再发，复针后穴：风池、上星、三里。

12. 头风顶痛：百会、后顶、合谷。

问曰：头顶痛针入不效者，再有何穴可治？

答曰：头顶痛，乃阴阳不分，风邪串入脑户，刺故不效也。先取其痰，次取其风，自然有效。中脘、三里、风池、合谷。

13. 醉头风：攒竹、印堂、三里。

问曰：此症前穴针之不效，何也？

答曰：此症有痰饮停于胃脘，口吐清涎，眩晕，或三日、五日，不省人事，不进饮食，名曰醉头风。先去其气，化痰调胃进食，然后去其风痛也。中脘、膻中、三里、风门。

14. 目生翳膜：睛明、合谷、四白。

问曰：以上穴法，刺之不效，何也？

答曰：此症受病既深，未可一时便愈，须是二、三次针之，方可有效。复刺后穴：太阳、光明、大骨空、小骨空。

15. 迎风冷泪：攒竹、大骨空、小骨空。

问曰：此症缘何而得？

答曰：醉酒当风，或暴赤，或痛，不忌房事，恣意好食，烧煎肉物；妇人多因产后不识回避，当风坐视，贼风串入眼目中，或经事交感，秽气冲上头目，亦成此症。复刺后穴、小骨空（治男妇醉后当风）三阴交（治妇人交感症）、泪孔上（米大艾灸七壮效）、中指半指尖（米大艾灸三壮）。

16.目生内障：瞳子瞤、合谷、临泣、睛明。

问曰：此症从何而得？此数穴针之不效，何也？

答曰：怒气伤肝，血不就舍，肾水枯竭，气血耗散，临患之时，不能节约，恣意房事，用心过多，故得此症，亦难治疗。复刺后穴：光明、天府、风池。

17.目患外障：小骨空、太阳、睛明、合谷。

问曰：此症缘何而得？

答曰：头风灌注瞳人，血气涌溢，上盛下虚，故有此病。刺前不效，复刺后穴二三次方愈。临泣、攒竹、三里、内眦尖（灸五壮，即眼头尖上）。

18.风沿眼红涩烂：睛明、四白、合谷、临泣、二间。

问曰：针之不效，何也？

答曰：醉饱行房，血气凝滞，痒而不散，用手揩摸，贼风乘时串入，故得此症。刺前不效，复刺后穴：三里、光明。

19.眼赤暴痛：合谷、三里、太阳、睛明。

问曰：此症从何而得？

答曰：时气所作，血气壅滞，当风睡卧，饥饱劳役，故得此症。复刺后穴：大阳、攒竹、丝竹空。

20.眼红肿痛：睛明、合谷、四白、临泣。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因肾水受亏，心火上炎，肝不能制，心肝二血不能归元，血气上壅，灌注瞳人，赤脉贯睛，故不散。复刺后穴：太溪、肾俞、行间、劳宫。

21.胥肉侵睛：风池、睛明、合谷、太阳。

问曰：此症从何而得？

答曰：或因伤寒未解，却有房室之事，上盛下虚，气血上壅；或头风不早治，血贯瞳人；或暴下赤痛；或因气伤肝，心火炎上，故不散也。及妇人产后，怒气所伤，产后未满，房事触动

心肝二经，饮食不节，饥饱醉劳，皆有此症，非一时便可治疗，渐而为之，无不效也。复针后穴：风池、期门、行间、太阳。

22.怕日羞明：小骨空、合谷、攒竹、二间。

问曰：此症缘何而得？

答曰：皆因暴痛未愈，在路迎风，串入眼中，血不就舍，肝不藏血，风毒贯入，睹灯光冷泪自出，见日影干涩疼痛。复针后穴：睛明、行间、光明。

23.鼻塞不闻香臭：迎香、上星、五处、禾髻。

问曰：此症缘何而得？针数穴皆不效。

答曰：皆因伤寒不解，毒气冲脑，或生鼻痔，脑中大热，故得此症。复刺后穴：水沟、风府、百劳、太渊。

24.鼻流清涕：上星、人中、风府。

问曰：此症缘何而得？

答曰：此因伤风不解，食肉饮酒太早，表里不解，咳嗽痰涎，及脑寒疼痛，故得此症。复针后穴：百会、风池、风门、百劳。

25.脑寒泻臭：上星、曲差、合谷。

问曰：此症缘何而得？

答曰：皆因鼻衄不止，用药吹入脑户，毒气攻上脑顶，故流鼻臭也。复刺后穴：水沟、迎香。

26.鼻渊鼻痔：上星、风府。

问曰：针此穴未效，复刺何穴？

答曰：更刺后穴：禾髻、风池、人中、百会、百劳、风门。

27.鼻衄不止：合谷、上星、百劳、风府。

问曰：此症缘何而得？出血不止。

答曰：血气上壅，阴阳不能升降，血不宿肝，肝主藏血，血热妄行，故血气不顺也。针前不效，复刺后穴：迎香、人中、印堂、京骨。

28.口内生疮：海泉、人中、承浆、合谷。

问曰：此症缘何而得？

答曰：上盛下虚，心火上炎，脾胃俱败，故成此症。复刺后穴：金津、玉液、长强。

29.口眼喎斜：颊车、合谷、地仓、人中。

问曰：此症从何而得？

答曰：醉后卧睡当风，贼风串入经络，痰饮流注，或因怒气伤肝，房事不节，故得此症。复刺后穴：承浆、百会、地仓、瞳子髎。

30.两颊红肿生疮（一名枯曹风，猪腮风）：合谷、列缺、地仓、颊车。

问曰：此症从何而得？

答曰：热气上壅，痰滞三焦，肿而不散，两腮红肿生疮，名曰枯曹风。复刺后穴：承浆三里、金津、玉液。

31.舌肿难语：廉泉、金津、玉液。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因酒痰滞于舌根，宿热相搏，不能言语，故令舌肿难言。复刺后穴：天突、少商。

32.牙齿肿痛：吕细、颊车、龙玄、合谷。

33.上片牙疼：吕细、太渊、人中。

34.下片牙疼：合谷、龙玄、承浆、颊车。

问曰：牙疼之症，缘何而得？

答曰：皆因肾经虚败，上盛下虚，阴阳不升降，故得此症。复刺后穴：肾俞、三间、二间。

35.耳内虚鸣：肾俞、三里、合谷。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因房事不节，肾经虚败，气血耗散，故得此症。复刺后穴：太溪、听会、三里。

36.耳红肿痛：听会、合谷、颊车。

问曰：此症肿痛，何也？

答曰：皆因热气上壅，或因缴耳触伤，热气不散，伤寒不解，故有此症。不可一例针灸，须辨问端的，针之，无不效也。

复刺后穴：三里、合谷、翳风。

37.聾耳生疮，出脓水：翳风、合谷、耳门。

问曰：聾耳生疮，出脓水，尝闻小儿有此症。

答曰：洗浴水归耳内，故有。大人或因剔耳触动，耳黄有水误入耳内，故如此。复刺后穴：听会、三里。

38.耳聋气闭：听宫、听会、翳风。

问曰：此症从何而得？

答曰：伤寒大热，汗闭，气不舒，故有此症。前针不效，复刺后穴：三里、合谷。

39.手臂麻木不仁：肩髃、曲池、合谷。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因寒湿相搏，气血凝滞，故麻木不仁也。复刺后穴：肩井、列缺。

40.手臂冷风痠痛：肩井、曲池、手三里、下廉。

问曰：此症从何而得？

答曰：寒邪之气，流入经络，夜卧凉枕、竹簟、漆凳冷处睡觉，不知风湿，流入经络，故得此症。复刺后穴：手五里、经渠、上廉。

41.手臂红肿疼痛：五里、曲池、通里、中渚。

问曰：此症缘何而得？

答曰：气血壅滞，流而不散，闭塞经脉不通，故得此症。复刺后穴：合谷、尺泽。

42.手臂红肿及疽：中渚、液门、曲池、合谷。

问曰：此症从何而得？

答曰：血气壅滞，皮肤瘙痒，用热汤泡洗，而伤红肿，故得此症；久而不治，变成手背疔。复刺后穴：上都、阳池。

43.手臂拘挛，两手筋紧不开；阳池、合谷、尺泽、曲池、中渚。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因湿气处卧，暑月夜行，风湿相搏，或酒醉行房之后，露天而眠，故得此症。复针后穴：肩髃、中渚、少商、手三里。

44.肩背少红疼痛；肩髃、风门、中渚、大杼。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因腠理不密，风邪串入皮肤，寒邪相搏，血气凝滞。复刺后穴：膏肓、肺俞、肩髃。

45.心胸疼痛；大陵、内关、曲泽。

问曰：心胸痛从何而得？

答曰：皆因停积，或因食冷，胃脘冷积作楚。心痛有九种，有虫，食痛者，有心痹冷痛者，有阴阳不升降者，有怒气冲心者，此症非一，推详其症治之。中脘、上脘、三里。

46.胁肋疼痛；支沟、章门、外关。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因怒气伤肝，血不归元，触动肝经，肝藏血，怒气甚，肝血不归元，故得是症。亦有伤寒后胁痛者，有挫闪而痛者，不可一例治也，宜推详治之。复刺后穴：行间（泻肝经，治怒气）、中封、期门（治伤寒后胁痛）、阳陵泉。

47.腹内疼痛；内关、三里、中脘。

问曰：腹内疼痛，如何治疗？

答曰：失肌伤饱，血气相争，荣卫不调，五脏不安，寒湿中得此。或冒风被雨，饱醉行房，饮食不化，亦有此症，必急治疗，为肾虚败，毒气冲归脐腹，故得此症。如不愈，复刺后

穴：关元、水分、天枢（寒湿饥饱）。

48.小腹胀满：内庭、三里、三阴交。

问曰：此症针入穴法不效，何也？

答曰：皆因停饮不化，腹胀。此症非一，有膀胱疝气，冷筑疼痛；小便不利，胀满疼痛；大便虚结，胀满疼痛，推详治之。再刺后穴：照海、大敦、中脘（先补后泻）、气海（专治妇人血块攻筑疼痛，小便不利，妇人诸般气痛）。

49.两足麻木：阳辅、阳交、绝骨、行间。

问曰：此症因何而得？

答曰：皆因湿气相搏，流入经络不散，或因酒后房事过多，寒暑失盖，致有此症。复针后穴：昆仑、绝骨、丘墟。

50.两膝红肿疼痛：膝关、委中。

问曰：此症从何而来？

答曰：皆因脾家受湿，痰饮流注，此疾非一，或因病后寒邪入于经络。复刺后穴：阳陵泉、中脘、丰隆。

51.足不能行：丘墟、行间、昆仑、太冲。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因醉后行房，肾经受亏，以致足弱无力，遂致不能行步。前治不效，复刺后穴：三里、阳辅、三阴交、复溜。

52.脚弱无力：公孙、三里、绝骨、申脉。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因湿气流入经络，血气相搏，或因行房过损精力，或因行路有损筋骨，致成此疾。复针后穴：昆仑、阳辅。

53.红肿脚气生疮：照海、昆仑、京骨、委中。

问曰：此症前穴不愈，何也？

答曰：气血凝而不散，寒热久而不治，变成其疾。再针后穴：三里、三阴交。

54.脚背红肿痛：太冲、临泣、行间、内庭。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因劳役过多，热汤泡洗，血气不散，以致红肿疼痛，宜针不宜灸。丘墟、昆仑。

55.穿跟草鞋风：照海、丘墟、商丘、昆仑。

问曰：此症缘何而得？

答曰：皆因劳役过度，湿气流滞而冷，或因大热行路，冷水浸洗，而成此症。复刺后穴：太冲、解溪。

56.风痛不能转侧，举步艰难：环跳、风市、昆仑、居髎、三里，阳陵泉。

问曰：此症缘何而得？

答曰：皆因房事过多，寒湿地上睡卧，流注经络，挫闪后腰疼痛，动止艰难。前穴不效，复刺后穴：五枢、阳辅、支沟。

57.腰脚疼痛：委中、人中。

58.肾虚腰痛：肾俞、委中、太溪，白环俞。

59.腰脊强痛：人中、委中。

60.挫闪腰胁痛：尺泽、委中、人中。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因房事过多，劳损肾经，精血枯竭，肾虚腰痛，负重远行，血气错乱，冒热血不归元，则腰痛。或因他事所关，气攻两胁疼痛，故有此症。复刺后穴：昆仑、束骨、支沟、阳陵泉。

61.浑身浮肿生疮：曲池、合谷、三里、三阴交、行间、内庭。

问曰：此症从何而感？

答曰：伤饥失饱，房事过度，或食生冷。

62.四肢浮肿：中都、合谷、曲池、中渚、液门。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因饥寒，邪入经络，饮水过多，流入四肢。或饮酒

过多，不避风寒，致有此症。复针后穴：行间、内庭，三阴交、阴陵泉。

63.单蛊胀：气海、行间、三里、内庭、水分、食关。

64.双蛊胀：支沟、合谷、曲池、水分。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因酒色过多，内伤脏腑，血气不通，遂成蛊胀。饮食不化，痰积停滞，浑身浮肿生水，小便不利，血气不行，则四肢浮肿，胃气不足，酒色不节，则单蛊胀也。肾水俱败，水火不相济，故令双蛊。此症本难疗治，医者当详细推之。三里、三阴交、行间、内庭。

65.小便不通：阴陵泉、气海、三阴交。

问曰：此症缘何得之？

答曰：皆因膀胱邪气，热气不散。或劳役过度，怒气伤胞，则气闭入窍中；或妇人转胞，皆有此症。复刺后穴：阴谷、大陵。

66.小便滑数：中极、肾俞、阴陵泉。

问曰：此症为何？

答曰：此膀胱受寒，肾经滑数，小便冷痛，频频淋漓。复针后穴：三阴交、气海。

67.大便秘结，不通：章门、太白、照海。

问曰：此症从何而得？

答曰：此症非一，有热结，有冷结，宜先补后泻。

68.大便泄泻不止：中脘、天枢、中极。

69.赤白痢疾，如赤：内庭、天枢、隐白、气海、照海、内关。如白，里急后重，大痛者：外关、中脘、隐白、天枢、申脉。

70.脏毒下血：承山、脾俞、精宫、长强。

71.脱肛久痔：二白、百会、精宫、长强。

72.脾寒发疟：后溪、间使、大椎、身柱、三里、绝骨、合谷、膏肓。

73.疟，先寒后热：绝骨、百会、膏肓、合谷。

74.疟，先热后寒：曲池（先补后泻）、绝骨（先泻后补）、膏肓、百劳。

75.热多寒少：后溪、间使、百劳、曲池。

76.寒多热少：后溪、百劳、曲池。

问曰：此症从何感来？

答曰：皆因脾胃虚弱，夏伤于暑，秋必成疟，有热多寒少，单寒单热，气盛则热多、痰盛则寒多，是皆痰饮停滞，气血耗散，脾胃虚败，房事不节所致。有一日一发，间日一发，或三日一发者，久而不治，变成大患。疟后有浮肿，有虚劳，有大便利，有腹肿蛊胀者，或饮水多，腹内有疟母者，须用调脾进食化痰饮。穴法依前治之。

77.翻胃吐食：中脘、脾俞、中魁、三里。

78.饮水不能进，为之五噎：劳宫、中魁、中脘、三里、大陵、支沟、上脘。

问曰：翻胃之症，从何而得？针法所能疗否？

答曰：此症有可治，有不可治者。病初来时，皆因酒色过度，房事不节，胃家受寒，呕吐酸水。或食物即时吐出，或饮食后一日方吐者，二、三日方吐者。随时吐者可疗，三两日吐者，乃脾绝胃枯，不能克化水谷。故有五噎者：气噎、水噎、食噎、劳噎、思噎、宜推详治之。复刺后穴：脾俞、胃俞（以上补多泻少）、膻中、太白、下脘、食关。

79.哮喘嗽喘：俞府、天突、膻中、肺俞、三里、中脘。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因好饮热酸鱼腥之物，及有风邪痰饮之类，串入肺中，怒气伤肝，乘此怒气，食物不化，醉酒行房，不能节约。此

亦非一也，有水哮，饮水则发；有气哮，怒气所感，寒邪相搏，痰饮壅满则发；咸哮，则食咸物发；或食炙煖之物则发，医当用意推详。小儿此症尤多。复刺后穴：膏肓、气海、关元、乳根。

80.咳嗽红痰：百劳、肺俞、中脘。三里。

问曰：此症缘何感得？

答曰：皆因色欲过多，脾肾俱败，怒气伤肝，血不归元，作成痰饮，串入肺经，久而不治，变成癆瘵。复刺后穴：膏肓、肾俞、肺俞、乳根。

81.吐血等症：膻中、中脘、气海、三里、乳根、支沟。

问曰：此症缘何而得？何法可治？

答曰：皆因忧愁思虑，七情所感，内动于心，即伤于神，外劳于形，即伤于精。古人言：心生血，肝纳血。心肝二经受克，心火上炎，气血上壅，肾水枯竭不交济，故有此症。须分虚实，不可槩治。肺俞、肾俞、肝俞、膏肓、关元。

82.肺壅咳嗽：肺俞、膻中、支沟、大陵。

问曰：此症从何而得？

答曰：因而伤风，表里未解，咳嗽不止，吐脓血，是肺癰也。复刺后穴：风门、三里、支沟。

83.久嗽不愈：肺俞、三里、膻中、乳根、风门、缺盆。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因食咸物伤肺，酒色不节，或伤风不解，痰流经络，咳嗽不已。可刺前穴。

84.传尸癆瘵：鸠尾、肺俞、中极、四花（先灸）。

问曰：此症从何而来？

答曰：皆因饱后行房，气血耗散，癆瘵传尸，以致灭门绝户者有之。复刺后穴：膻中、涌泉、百会、膏肓、三里、中脘。

85.消渴：金津、玉液、承浆。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆为肾水枯竭，水火不济，脾胃俱败，久而不治，变成背疽，难治矣。复刺后穴：海泉、人中、廉泉、气海、肾俞。

86.遗精白浊：心俞、肾俞、关元、三阴交。

问曰：此症从何而得？

答曰：因房事失宜，惊动于心，内不纳精，外伤于肾，忧愁思虑，七情所感，心肾不济，人渐羸瘦，血气耗散，故得此症。

复刺后穴：命门、白环俞。

87.阴茎虚痛：中极、太溪、复溜、三阴交。

问曰：此症因何而得？

答曰：皆因少年之时，妄用金石他药，有伤茎孔，使令阴阳交感，不能发泄，故生此症。复刺后穴：血郄、中极、海底、内关、阴陵泉。

88.阴汗偏坠：关元、三阴交。

89.木肾不痛，肿如升：归来、大敦、三阴交。

90.奔豚乳弦：关门、关元、水道、三阴交。

问曰：此三症因何而得？

答曰：皆为酒色过度，肾水枯竭，房事不节，精气无力，阴事不举，强而为之，精气不能泄外，流入胞中。此症非一，或肿如升，或偏坠疼痛，如鸡子之状，按上腹中则作声，此为乳弦疝气也。宜针后穴：海底、归来、关元、三阴交。

91.妇女赤白带下：气海、中极、白环俞、肾俞。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因不惜身体，恣意房事，伤精血。或经行与男子交感，内不纳精，遗下白水，变成赤白带下。宜刺后穴：气海、三阴交、阳交（补多泻少）。

92.妇女无子：子宫、中极。

93.妇女多子：石门、三阴交。

94.经事不调：中极、肾俞、气海、三阴交。

95. 妇女难产：独阴、合谷、三阴交。

96. 血崩漏下：中极、子宫。

97. 产后血块痛：气海，三阴交。

98. 胎衣不下：中极、三阴交。

99. 心烦热，头目昏沉：合谷、百劳、中泉、心俞、劳宫、涌泉。

问曰：此症因何而得？

答曰：皆因产后劳役，邪风串入经络。

或因辛勤太过而得，亦有室女得此症，何也？

答曰：或阴阳不和，气血壅满而得之者，或忧愁思虑而得之者。复刺后穴：少商、曲池、肩井、心俞。

100. 阴门忽然红肿疼：会阴、中极、三阴交。

101. 妇女血崩不止：丹田、中极、肾俞、子宫。

问曰：此症因何而得？

答曰：乃经行与男子交感而得，人渐羸瘦，外感寒邪，内伤于精，寒热往来，精血相搏，内不纳精，外不受血，毒气冲动子宫，风邪串入肺中，咳嗽痰涎，故得此症。如不明脉之虚实，作虚劳治之，非也。或有两情交感，百脉错乱，血不归元，以致如斯者。再刺后穴：百劳、风池、膏肓、曲池、绝骨、三阴交。

102. 妇人无乳：少泽、合谷、膻中。

103. 乳痛：针乳疼处、膻中、大陵、委中、少泽、俞府。

104. 月水断绝：中极、肾俞、合谷、三阴交。

问曰：妇人之症，如何不具后穴？

答曰：妇人之症，难以再具，止用此穴，法无不效。更宜辨脉虚实，调之可也。

105. 浑身生疮：曲池、合谷、三里、行间。

106. 发背痈疽：肩井、委中、天应、骑竹马。

或问：阴疽，满背无头，何法治之？

答曰：可用湿泥涂之，先干处，用蒜钱贴之，如法灸，可服五香连翘散数帖发出。

107.肾脏风疮：血郄、三阴交。

108.疔疮（以针挑，有血可治；无血不可治）：合谷、曲池、三里、委中。

109.夹黄（胁退毒也）：支沟、委中、肩井、阳陵泉。

110.伤寒头痛：合谷、攒竹、太阳（眉后紫脉上）。

111.伤寒胁痛：支沟、章门、阳陵泉、委中（出血）。

112.伤寒胸胁痛：大陵、期门、膻中、劳宫。

113.伤寒大热不退：曲池、绝骨、三里、大椎、涌泉、合谷（俱宜泻）。

114.伤寒热退后余热：风门、合谷、行间、绝骨。

115.发狂，不识尊卑：曲池、绝骨、百劳、涌泉。

116.伤寒发瘧，不省人事：曲池、合谷、人中、复溜。

117.伤寒无汗：内庭（泻）、合谷（补）、复溜（泻）、百劳。

118.伤寒汗多：内庭、合谷（泻）、复溜（补）、百劳。

119.大便不通：章门、照海、支沟、太白。

120.小便不通：阴谷、阴陵泉。

121.六脉俱无：合谷、复溜、中极（阴症多有此）。

122.伤寒发狂：期门、气海、曲池。

123.伤寒发黄：腕骨、申脉、外关、涌泉。

124.咽喉肿痛：少商、天突、合谷。

125.双乳蛾症：少商、金津、玉液。

126.单乳蛾症：少商、合谷、海泉。

127.小儿赤游风：百会、委中。

128.浑身发红丹：百会、曲池，三里、委中。

129.黄胆发虚浮：腕骨、百劳、三里、涌泉（治浑身黄）、

中脘、膏肓、丹田（治色黄）、阴陵泉（治酒黄）。

130. 肚中气块、痞块、积块：三里、块中、块尾。

131. 五疳等症：上星、鬼禄、鸠尾、涌泉、心俞、百会。

132. 马病：照海、鸠尾、心俞。

133. 风病：神庭、素髻、涌泉。

134. 食病：鸠尾、中脘、少商。

135. 猪病：涌泉、心俞、三里、鸠尾、中脘、少商、巨阙。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因寒痰结胃中，失志不定，遂成数症，医者推详治之，无不效也。

136. 失志痴呆：神门、鬼眼、百会、鸠尾。

137. 口臭难近：龈交、承浆。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因用心过度，劳役不已，或不漱牙，藏宿物，以致秽臭。复刺：金津、玉液。

138. 小儿脱肛：百会、长强、大肠俞。

139. 霍乱转筋：承山、中封。

140. 霍乱吐泻：中脘、天枢。

141. 咳逆发噎：膻中、中脘、大陵。

问曰：此症从何而得？

答曰：皆因怒气伤肝，胃气不足。亦有胃受风邪，痰饮停滞得者；亦有气逆不顺者，故不一也。刺前未效，复刺后穴：三里、肺俞、行间（泻肝经怒气）。

142. 健忘失记：列缺、心俞、神门、少海。

问曰：此症缘何而得？

答曰：忧愁思虑，内动于心，外感于情，或有痰涎灌心窍，七情所感，故有此症。复刺后穴：中脘、三里。

143. 小便淋沥：阴谷、关元、气海、三阴交、阴陵泉。

问曰：此症因何而得？

答曰：皆为酒色嗜欲不节，勉强为之，少年之过。或用金石热剂，或小便急行房，或交感之际，被人冲破，不能完事，精不得施泄，阴阳不能舒通。缘此症非一，有砂淋，有血淋，有热淋，有冷淋，有气淋，请审详治之。

144.重舌，腰痛：合谷、承浆、金津、玉液、海泉、人中。

145.便毒痈疽：昆仑、承浆、三阴交。

146.瘰疬结核：肩井、曲池、天井、三阳络、阴陵泉。

147.发痧等症：分水、百劳、大陵、委中。

148.牙关脱臼：颊车、百会、承浆、合谷。

149.舌强难言：金津、玉液、廉泉、风府。

150.口吐清涎：大陵、膻中、中脘、劳宫。

151.四肢麻木：肩髃、曲池、合谷、腕骨、风市、昆仑、行间、三里、绝骨、委中、通里、阳陵泉（此症宜补多泻少。如手足红肿，宜泻多补少）。

第五节 “八法”在针灸 治疗上的应用

八法在针灸治疗上的应用，是笔者根据内难二经有关针灸治病的理论指导，通过临床实践，应用八纲辨证、八法治病的原则写出来的，个人认识到针灸只要辨证清楚、配穴得要、手法精练，可以达到汗、吐、下、和、温、清、补、消的治病目的，故曾在1959年《中医杂志》第7号作过介绍。十多年来，又经过反复实践，反复认识，对原文作了某些修改和补充，现编入本书。

一、汗 法

《素问·阴阳应象大论篇》说的：“其在皮者，汗而发之”。

就是病邪在肌表的，应用汗法外解的治疗法则。《医学入门》说的：“汗，针合谷入二分，行九九数，搓数十次，男左搓、女右搓，得汗行泻法，汗止身温出针……”。就是针灸利用经穴，开泄腠理、发汗祛邪治疗表症的方法。

1. 发散风寒：取风池、大椎、身柱、风门、合谷、后溪，用烧山火法，使其产生热感发汗，主治感冒，头痛，恶寒，发热无汗，脉浮紧的表寒证。鼻塞流涕，配上迎香、迎香、列缺用平补平泻法，以祛风开窍。

2. 清透表热：取大椎、陶道、身柱、肺俞，用丛针扬刺法，刺之出血；列缺、合谷用透天凉法，使其产生凉感发汗，主治感冒发热，咳嗽痰喘，脉浮数有力的表热证。如目窠面青，神昏不安，痰涎壅盛，配百会、印堂、人中、少商、商阳、中冲用点刺法出血，以清热宣肺，祛痰开窍。

3. 注意事项：在大吐、大泻、大失血之后不可用汗法；气虚、阴虚患者，必要用汗法时，可先针足三里补气，或照海滋阴，然后再行发汗，以达到驱邪而不伤正的目的。

二、吐 法

《素问·阴阳应象大论篇》说的：“其高者，因而越之”。就是病邪在上，胸满脘胀的，应用吐法催吐急救的治疗法则。《医学入门》说的：“吐，针内关入三分，先补六次，泻三次，行子午捣臼法三次，提气上行，又推战一次，病人多呼几次，即吐……”就是针灸利用经穴催吐，引导有害物质吐出的方法。

1. 涌吐风痰：取天突或旁廉泉用导痰法（图130）。即以左手拇指或食指紧按天突穴，候至患者作呕时，速刺天突穴，欲使其激起内脏反射作用，上涌作呕，即可将顽痰涌出，如不能将顽痰涌出再以左手拇指和食指紧切左右廉泉穴，候至患者作呕时，用指

切速刺法针右旁廉泉速刺速出，再作呕时，再速刺左侧旁廉泉。欲使其激起内脏反射作用，上涌作呕，即可将顽痰涌出。如患者极力作呕，口吐粘液，而痰仍不能顺利涌出时，急将患者扶起，医者两手用力撑肋，拇指紧按两侧肾俞穴，就可以促其患者将顽痰涌出，主治中风闭症和小儿惊风，所致痰阻咽喉，不能吐出的险症。如中风不语，配风府用凉泻法，针时让患者喊一、二，金津、玉液用“金钩钓鱼”法（图131）（用速刺法进针2~5分，找到感觉后，拇指向前捻，用针尖拉着有感觉的部位抖提几次），能起到清热开窍，诱导说话的作用。

2.通结催吐：取中院、幽门用催吐法（图132）。即以左手中指紧按中脘穴，右手持针刺入八分，找到感觉用关闭法，是中

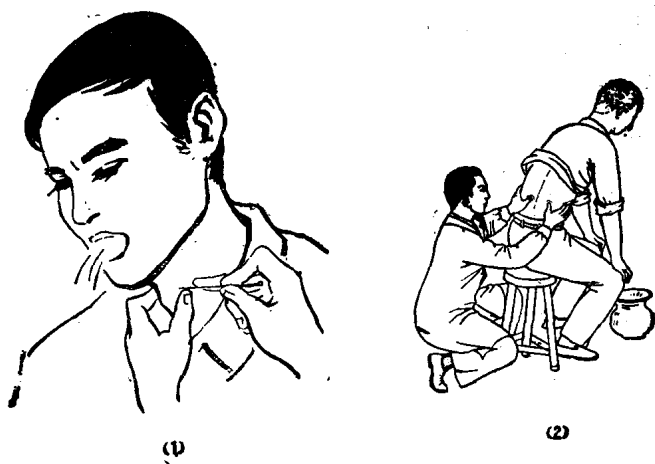


图130 导痰法（针旁廉泉）

指压在针的下方，其它四个手指压按在左右两侧（称为“五穴取一”）右手持针的针尖和左手压按的指力，随其出气向胸部努力推进一分，随其入气左手减轻压按将针尖提退一分，反复操作几次，使感觉向上传导，欲使其气向上攻，激起内脏反射作用，上

涌作呕，急速将针拔出。就可以将胃脘停留难以消化的食物呕吐而出。如患者仍不能呕吐时，急用左手食、中二指压按左右幽门穴，其它手指压按在左右两侧，候患者作呕时，速刺右侧幽门，再作呕时，再速刺左侧幽门，即可促其患者呕吐。主治食物中毒或宿食停滞、壅塞胃脘、欲吐不出的险症。如肝郁气滞，胸脘隐痛，两胁胀满，呃逆厌食，配期门、行间用凉泻法，中脘、足三里用平补平泻法，以舒肝理气。

3. 注意事项：年老体弱、慢性病、妊娠期、产后、大失血后、气虚、气短、哮喘患者都不能用吐法。



图131 金铃钓鱼法（针金津、玉液）

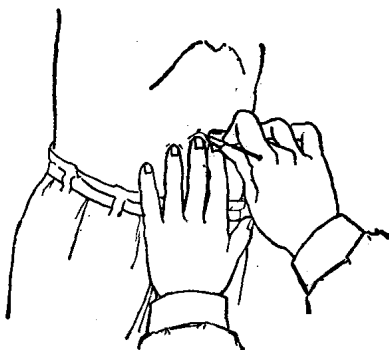


图132 催吐法（针中脘）

三、下 法

《素问·阴阳应象大论篇》说：“中满者，泻之于内”。《至真要大论篇》说的：“盛者泻之”。就是病邪在中焦，腹中胀满的，应用泻法攻下的治疗法则。《素问·针解篇》说：“满而泄之者，针下寒也，气虚乃寒也；……邪胜则虚之者，出针勿按；……刺实须其虚者，留针阴气隆至，乃去针也”。《医学入门》说的：“下，针三阴交入三分，男左女右，以针盘旋，右转六阴数毕，用口鼻闭气，吞鼓腹中，将泻插一下，其人即泻，鼻

吸手泻三十六遍，方开口鼻之气，插针即泻……”。就是针灸利用经穴，泻热导滞，排除肠胃积结，通便止痛，推陈致新的方法。

1.泻热通便：取大肠俞、天枢、丰隆、足三里用凉泻法，使其产生凉感下泻，主治胃肠积热，腹痛拒按，大便秘结，脉数有力的实热证。如年老体衰、气血亏耗、肠失润养的阴虚便秘，则取支沟透间使用泻法，次髎、三阴交、照海用补法，以清热养阴，润肠通便。

2.清肠导滞：取中脘、天枢、气海、曲池、足三里用凉泻法，使其产生凉感通便，主治湿热阻滞、腹痛便秘或下痢赤白、里急后重、脉滑数的湿热症。如小儿食积痞块，取上脘、中脘、建里用平补平泻法不留针，取三关穴用点刺法出血，以健脾助运，消积化滞。

3.注意事项：表邪未解、妇女妊娠、产后、大出血不能用下法。年老体衰以及虚弱患者应慎用，或攻补兼施。

四、和 法

《素问·至真要大论篇》说的：“谨察阴阳所在而调之，以平为期”。就是病邪在半表半里或阴阳偏盛偏衰的，应用和法和解与调整平衡的治疗法则。《灵枢·终始》篇说的：“阴盛而阳虚，先补其阳，后泻其阴而和之；阴虚而阳盛，先补其阴，后泻其阳而和之”。就是针灸利用经穴调和机体在生理、病理、机能上的偏盛偏衰、扶正祛邪的方法。

1.和解少阳：取大椎、陶道、身柱、液门、外关透内关、侠溪用阳中隐阴法，使其先热后凉，主治外感病，邪传半表半里，出现寒热往来，胸胁苦满，口苦咽干，心烦喜呕证候。如疟疾，在发作前1~2小时取大椎、陶道、身柱针后加灸10~20分钟，能起到扶正截疟的作用。

2.疏肝理气：取神封、上期门、膻中、膈俞、肝俞用平补平泻

法，支沟、阳陵泉留针10~20分钟，主治肝气郁结的胸胁胀痛。如肝阳上亢，头痛、眩晕、失眠，取百会、印堂、神门、三阴交用平补平泻法，留针20~30分钟，有平肝潜阳，养阴安神的作用。肝气下滞、出现疝气、偏坠、睾丸抽痛，配大敦针后加灸10~20分钟，照海、中都用平补平泻法，留针20~30分钟，有疏经活血，行气止痛的功能。

3.和血调经：取气海、关元、气穴、合谷、三阴交用平补平泻法，留针10~15分钟，使其产生胀感，主治妇女月经不调、经闭、痛经等症。如痛经、取关元、归来、三阴交用平补平泻法，留针20~30分钟，有舒肝理气，活血止痛的作用。

4.注意事项：表邪未解或邪热传里均不能用和法。和法用于病邪既不在表，又不在里，而在半表半里之间。此外和法还能调和气血、调和肝胃、调和阴阳，使机体达到平衡，是符合古人所谓“平则不病”的道理的。因此，和法在针灸的应用方面是最广泛的。

五、温 法

《素问·至真要大论篇》说：“寒者热之”和“清者温之”。《阴阳应象大论篇》说的：“形不足者，温之以气”。就是感受寒邪或形体虚寒的，应用温法温经散寒补气的治疗法则。《灵枢·经脉》篇说：“寒则留之”。《九针十二原》篇说：“刺寒清者，如人不欲行”（即急进，慢退）《针灸大全》说的：“有寒则温之”。就是针灸利用经穴消除沉寒阴冷、补益阳气的方法。

1.温中散寒：取上脘、中脘、建里、下脘、梁门、足三里或膈俞、肝俞、脾俞、胃俞，用热补法或留针加灸10~15分钟，使其产生热感，主治胃脘隐痛，得温则减，消化不良，脉沉缓的虚寒症。如胃脘剧痛，呕吐恶心，取内关、公孙留针20~30分钟，以疏调

肝脾，镇痛止呕。

2. 温肾壮阳：取肾俞、关元俞，次髎用热补法，使腰部产生热感，主治腰痛腿软，脉沉细无力的虚寒症。如腰背剧痛，不能转侧，配委中、秩边、人中用热补法，留针10~15分钟，以散寒镇痛。

3. 温通经络：上肢，取大椎、大杼、膏肓、肩髃、肩髃、曲池、外关、合谷、后溪；下肢，取肾俞、关元俞、次髎、秩边、环跳、风市、阴市、阳陵泉、足三里、绝骨、解溪、申脉；按顺序由上而下针刺（“通经接气法”），用热补法或针后加灸10~15分钟，使其产生热感，主治瘫痪、痿软、风湿痹症。如下肢瘫痪，取环跳、风市、阳陵泉、绝骨、用热补法，使热感传到足趾，以温经活血，恢复功能。肩痛不举取天宗、肩髃、肩髃、天髎透肩井、条口透承山，用热补法，俗称“穿髋热”（图133）。能祛寒镇痛，疏筋利节。

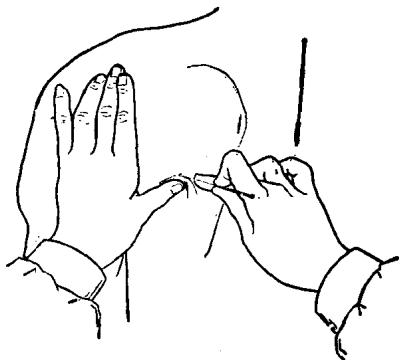


图133 穿髋热（针天宗）

4. 注意事项：实热症不可用温法。

六、清 法

《素问·至真要大论篇》说：“温者清之”。《针灸大全》说的：“有热则清之”。就是病邪化热，耗伤津液，应用清法清热养阴的治疗法则。《灵枢·经脉》篇说：“热则疾之”；《九针十二原》篇说的：“刺诸热者，如以手探汤”（即慢进、急退）。

就是针灸利用经穴，清热除烦，生津止渴的方法。

1. 清热开窍：取百会、人中、承浆、十宣用点刺法出血，主治中风窍闭，中暑昏迷，小儿惊厥，热极神昏，癲病，脏躁等症。如疯狂、脏躁，在痰迷心窍、精神失常、哭笑打骂、不识亲疏时，取内关、合谷用赤凤摇头法，人中、承浆、百会、巨阙、中脘、丰隆、太冲用凉泻法。留针20~30分钟，使其产生凉感，以熄风降痰，清热开窍。

2. 清热养阴：取尺泽、委中用三棱针点刺出血，排其血中毒热，主治霍乱腹痛，上吐下泻之急症。如呕吐不止，取内关用泻法，留针20~30分钟，能清热止吐，如吐泻之后，津液耗损，正气大亏，脉细无力的脱症，取气海、神阙灸20~30分钟，中脘、天枢、足三里用补法，以疏导气机，回阳救阴。

3. 清热解毒：取风池、大椎、颊车、翳风、合谷用凉泻法，使其产生凉感，留针20~30分钟，少商、商阳用点刺法出血，主治炸腮（腮腺炎）、咽喉肿痛、口唇生疮等温毒积热症。如项后发际疮疖（毛囊炎），取大椎、身柱、灵台、筋缩、脊中、命门、腰阳关、腰俞用丛针扬刺法，使之出血，是采取“釜底抽薪”。

4. 注意事项：体质虚弱、大便溏泻的虚寒证，不可用清法。

七、补 法

《灵枢·经脉》篇说：“虚则补之”。《素问·阴阳应象大论篇》说：“因其衰而彰之”。《针灸大全》说：“补则补其不足”。就是形体衰弱或气血不足的，应用补法益气养血的治疗方法。《素问·针解篇》说：“刺虚须其实者，阳气隆至，针下热，乃去针也”。《灵枢·官能》篇说的：“阴阳皆虚，火自当之”。就是针灸利用经穴扶正祛邪，补益人体的阴阳气血和脏腑虚损的方法。

1. 培元固本：取神封、幽门，中脘、列缺、太渊、足三里、

照海用热补法，大椎、百劳、肺俞、心俞、膏肓、肝俞、脾俞、肾俞、针后加灸10~20分钟，使其产生热感，主治喘咳气短、消化不良、自汗、盗汗等脏腑虚损症。如阳萎早泄，遗精，遗尿，取肾俞、关元俞、膀胱俞、关元、三阴交，用热补法或针后加灸，以补肾益精，固本壮阳。

2.补中益气：取中脘、关元、天枢、腰俞、会阳、长强，用热补法或针后加灸20~30分钟，使腹部和肛门温热，主治久泻不止，脱肛不收，腹痛喜温，苔薄白，舌质淡，脉迟无力的脾胃虚寒症。如五更泄泻，神衰厌食，配脾俞、胃俞、关元俞，用热补法或针后加灸，以温肾暖脾，涩肠固脱。

3.固崩止带：取大赫、中极、归来、三阴交，用热补法，留针10~15分钟，使其产生热感，主治经行不止、赤白带下、脉细无力、冲任不固的虚寒症。如血崩不止，神昏不语，面白脉微的脱症，取隐白、人中用补法，行间用平补平泻法；大敦针后加灸10~20分钟，以回阳固脱，补气摄血。

4.注意事项：邪气实不能用补法，邪气未尽不能早用补法，虚中夹实不能单用补法。针灸补法是调整人体生理功能，调动体内积极因素，抗御病邪的治疗方法，故在临床上应用最广泛。

八、消 法

《素问·至真要大论篇》说：“坚者削之”和“结者散之”。就是气血积聚或痰湿凝滞的，应用消法软坚磨积的治疗法则。《素问·阴阳应象大论篇》说：“其实者，散而泻之”；《灵枢·小针解》篇说的：“菀陈则除之”和“邪胜则虚之”。就是针灸利用经穴消积化滞、破瘀散结的方法。

1.破瘀活血：取风池、角孙、曲鬓、攒竹、太阳用热补法，使热感传到眼底，俗称“过眼热”（图134）。内睛明用压针缓进法，留针10~20分钟，使眼底有痒胀热感，能化散玻璃体内的瘀

血，并使瘀血吸收。主治视网膜出血，暴盲青盲，云雾移睛等眼

病。如身体虚弱、反复出血，配大椎、肝俞、肾俞用热补法，使其产生热感，以调肝补肾、益气养血、清头明目。

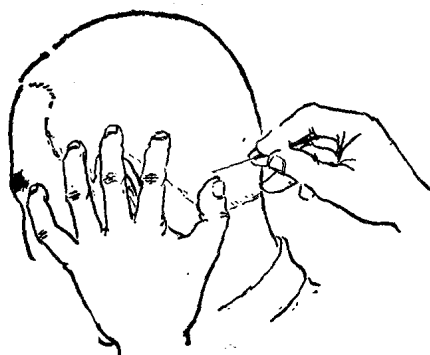


图134 过眼热（针风池）

2. 消肿止痛：取小节（腰部以上的取手小节，腰部以下的取足小节）用平补平泻法，留针20~30分钟，在留针期间，每5~6分钟操作一次，使感觉放散传导，同时让患者活动肿痛部位，

以缓解疼痛，主治创伤性疼痛。如红肿严重，局部用围刺法或施熨热灸20~30分钟，以活血散瘀。用局部灸法治疗冻疮也有显著效果。

3. 消坚散结：取阿是穴用三棱针点刺，挤出胶状粘液，主治腱鞘囊肿。局部用围刺提插法，主治瘰气。取扶突透天窗、天髻透肩井、曲池透臂臑，用平补平泻法，留针20~30分钟，主治瘰癧。如瘰癧坚硬，配阿是穴，但小似豆的，针向核中直刺，大如核桃的，用围刺法或针向核边斜刺，进至缝隙后用苍龙摆尾法，徐徐拨动，能活血散瘀，散结消肿。

4. 注意事项：消法是针灸常用法之一，虽然没有重要禁忌症，但对体质虚弱的患者应当慎用。

第二章 临床治疗各论

临床治疗各论，主要是自己多年来的经验总结，有辨证配穴，中西医结合治疗总结摘要和医案三个部分。有的过去曾在中医刊物上作过介绍，这次又经修改补充，编入本书。在论理方面，限于水平，难免有不妥之处，但辨证配穴，总结摘要和医案，确属临床实录，供同道参考。

第一节 脏腑经络证治

疾病的发生和发展，临床证候的表现虽然错综复杂，但究其原因，则不外乎脏腑、经络功能的失调。针灸治病，就是根据脏腑、经络学说，运用“四诊”、“八纲”的辨证方法，将临床上各种不同的证候加以归纳分析，以明确疾病的部位，是在经、在络、在脏、在腑、在表、在里；病症是属寒、属热、属虚、属实。在此基础上进行配穴处方，决定是针、是灸、是补、是泻、以通其经脉，调其气血，使脏腑功能平衡协调，而达到治愈病证的目的。

一、肺和大肠

（一）肺：肺在胸中，其主要功能是“主气”调节呼吸。

1. 风热犯肺，肺气失宣，引起发热，鼻流浊涕，咳喘气逆，鼻煽，喉痹、胸痛，取肺俞、大椎、尺泽、列缺，用透天凉法，留针20~30分钟，少商点刺出血，以清热宣肺，疏经止咳。

2. 风寒犯肺，引起发热恶寒、鼻塞流涕，咳吐稀痰，取风池、大椎、肺俞、列缺、合谷，用烧山火法，以祛风散寒，宣肺

止咳。

3. 肺气虚，咳喘无力，气短自汗，灸中府、膻中，补太渊，以补益肺气，平喘止咳。

4. 肺阴虚，阴液不能濡肺，咳痰带血，咽干，声音嘶哑，取中府、肺俞、太渊、列缺、照海，用补法，以滋阴润肺，化痰止咳。

5. 气血郁滞，肺经“下循膈内”的经络不利，上臂内侧前缘疼痛，取云门、天府、侠白、孔最，用平补平泻法，以理气活血，疏经止痛。

（二）大肠：大肠在腹腔，上接阑门，下接直肠和肛门，其主要功能是吸收水液，排泄糟粕。

1. 寒邪侵及大肠，吸收水液的功能失调，引起腹痛、泄泻、肠鸣，取天枢、曲池、上巨虚，用补法或灸10~20分钟，以温中助运，散寒止痛。

2. 热邪侵及大肠，导致大便秘结或里急后重，取大肠俞、天枢、曲池、上巨虚，用凉泻法，留针20~30分钟，以润肠通便，泻热止痛。

3. 久泻久痢之虚证，取中脘、天枢、气海、会阳、上巨虚，用补法，以补中益气，升提下陷。

4. 因邪热上冲，引起头痛、咽喉肿痛，口噤不开，牙痛颊肿，鼻衄、不闻香臭，取迎香、合谷、列缺，用凉泻法，留针20~30分钟，商阳点刺出血，以清热保津，消肿止痛。

5. 寒湿侵袭，大肠之经气不利，肩前、上臂痛和食指疼痛，麻木不用，取肩髃、曲池、手三里、合谷，用烧山火法，以散寒利湿，疏经止痛。

肺和大肠相表里，如肺失肃降，津液不能下达，引起的大便秘结，取太渊、偏历、尺泽，用补法，以补益肺气，养阴通便；大肠实热，大便不通，影响肺气肃降，也可引起胸膈满闷，气逆

而喘，取合谷、列缺、大肠俞、天枢、丰隆，用凉泻法，留针20~30分钟，以疏调大肠，通便降逆。

二、脾和胃

（一）脾：脾在腹中，其主要功能是“主运化”，为“气血生化之源”又主“统血”。

1.脾气受损，不能运化，导致呕逆，腹胀，便溏，四肢不温，取脾俞、章门、中脘、阴陵泉、太白，用补法，留针10~20分钟，以健脾益气，和中助运。

2.湿热内蕴，脾失健运，引起中焦痞满，腹胀恶心，肢体困重，取中脘、脾俞、天枢、足三里、商丘、内关，用凉泻法，留针20~30分钟，以清热利湿，通调脾胃。

3.脾虚不能统血，导致妇女月经过多或崩漏不止，取隐白、三阴交、行间、膈俞，用补法，以健脾益气，升阳摄血。

4.脾湿内困，身体沉重，取阴陵泉、公孙，用烧山火法，以健脾利湿、温阳助运。

5.寒湿阻经，股、膝内侧肿痛、厥冷，及大趾麻木不用，取血海、阴陵泉、三阴交、商丘、太白，用烧山火法，以利湿散寒，疏经止痛。

（二）胃：胃在膈下，上接食道，下通小肠，其主要功能是受纳、腐熟、消化水谷，为“后天之本”。

1.饮食不节，胃的和降功能失常，导致呃逆呕吐，脘腹胀痛，取中脘、足三里、内关、公孙，用平补平泻法，留针20~30分钟，以和中健胃，止呕镇痛。

2.热邪犯胃，可见消谷善饥，口渴引饮，取中脘、足三里、内关，用凉泻法，以清热养阴，和中益胃。

3.风寒伤及面部足阳明经之络，引起口眼歪斜或面肌拘急颤动，取风池、下关、地仓、颊车、合谷，用烧山火法，以祛风散

寒，舒筋活络。

4.胃火上炎，经脉气盛，发热，鼻衄、唇疹，咽喉、齿龈肿痛，取厉兑点刺出血，冲阳、内庭、下关、颊车、人迎，用泻法，以清热泻火，消肿止痛。

5.风寒外侵，经气不利，股、膝、胫前面，足背等处皆痛，中趾麻木不用，取髀关、伏兔、阴市、足三里、内庭，用烧山火法，以驱风散寒，疏经止痛。

脾胃相表里，胃气以降为和，脾气以升为顺，二者共同完成升清降浊的生理功能，如脾的运化失常，常见食后饱满，消化不良等胃纳不佳之证；如胃的功能失常也常见腹胀泄泻等脾失运化之证，所以都可以取中脘、足三里、公孙，用补法，留针10~30分钟，以健脾益胃，和中助运。

三、心和小肠

（一）心：心在胸中，其主要功能是“主血脉”和“藏神”。

1.心主血脉的功能不足，可见心悸气短，血脉空虚，面色苍白无华，脉细无力或结代不整，取心俞、巨阙、神门，用补法，留针10~20分钟，以补益气血，养心安神。

2.痰火上攻，扰动心神，导致狂躁不眠，神昏谵语，喜笑不休，取巨阙、内关、神门、丰隆，用凉泻法，留针20~30分钟，以祛痰降逆，清心安神。

3.心火上炎，引起烦躁不安，舌尖糜烂，咽喉肿痛，口渴欲饮，取天容、神门，用凉泻法，留针20~30分钟，少冲、少泽点刺出血，以清心泻火，消肿止痛。

4.心经蕴热，掌中热痛，取少海、神门，用泻法，少府点刺出血，以清热养阴，疏经止痛。

（二）小肠：小肠上接胃的幽门，下连大肠的阑门，其主要功能

是泌别清浊。

1. 热邪伤及小肠，泌别清浊的功能失常，引起小腹痛，尿血或小便短赤，取小肠俞、水分、关元、小海、下巨虚，用凉泻法，留针20~30分钟，以清热止痛，分别清浊。

2. 寒邪伤及小肠，泌别功能失常，导致肠鸣泄泻、小腹痛、疝气，取天枢、关元、水道、下巨虚，用热补法或灸20~30分钟，以温散寒湿，和肠止痛。

3. 热犯小肠，耗伤津液，耳聋、颊、颈、颌、咽喉肿痛，取小海、腕骨、后溪、天容，用泻法，以清热保津，消肿止痛。

4. 风寒侵袭，经气不利，颈、颌肿痛，不能回顾，肩、膈、肘、臂外侧后缘皆痛，取膈俞、天宗、小海、支正，用烧山火法，以驱风散寒，疏通经络。

心和小肠相表里，如心火过亢，可移热于小肠，引起小便短赤，灼痛、尿血，取少冲、少泽点刺出血，神门、支正、关元，用凉泻法，以清心泻热，利尿通便；如小肠有热，引起心火亢盛，出现心中烦热，口舌糜烂，取天容、腕骨、通里，用凉泻法，留针20~30分钟，少泽、少冲点刺出血，以清热降火，养阴除烦。

四、肾和膀胱

（一）肾：肾在腰部，其主要功能是“主水”和“藏精”。

1. 肾的气化功能失常，水液代谢障碍，导致小便不利，水肿，取肾俞、中极、阴谷、复溜，用热补法，留针20~30分钟，以培元益肾，温阳利尿。

2. 肾水不足，可见口热咽干，心烦咳血，取照海、然谷、神封，用补法，列缺用泻法，以清热保津，滋阴固肾。

3. 肾阳虚，藏精的功能失调，导致腰痛腿软，遗精阳痿，形寒肢冷，取肾俞、上髂、京门、关元、三阴交，用补法，以温肾

壮阳，培元固本。

(二)膀胱：膀胱在小腹，其主要功能是“藏津液”和排泄尿液。

1.热邪伤及膀胱，气化不利，引起小便癃闭不通，取中极、膀胱俞、秩边、委中，用凉泻法，至阴点刺出血，以清热利尿，疏调膀胱。

2.膀胱气化不足，失去约束能力，可见遗尿或尿频，取中极、阴谷，三阴交，至阴，用补或灸法，以培补肾气，约束膀胱。

3.太阳中风，发热恶寒，头痛鼻塞，目痛项痛，取天柱、风池、风门、申脉、京骨、后溪，用平补平泻法，以驱散表邪，疏经止痛。

4.寒湿偏胜，经络瘀阻，腰脊及下肢后面疼痛，屈伸不利，小趾麻木不用，取肾俞、关元俞、秩边、环跳、委中、承山、昆仑，用烧山火法，以驱寒利湿，理气通络。

肾和膀胱相表里，如肾气不足，不能固摄津液，可引起遗尿或尿失禁，取京门、太溪、飞扬，用补法，或灸法以温肾纳气，培元摄精。如湿热蕴结膀胱，气化不利，除尿频、尿急、尿痛外，也常见腰脊酸痛，滑精等肾关不固的病症，取中极、膀胱俞、京骨、大钟，用泻法，留针20~30分钟，以清热止痛、固肾利湿。

五、心包和三焦

(一)心包：心包在胸中，护于心脏之外，其主要功能是“代心行事”。

1.热邪内陷，痰蒙心包，引起意识模糊，神昏谵语，取曲泽、内关，用凉泻法，中冲点刺出血，以清热开窍，宁心安神。

2.老人心气虚，可见心悸胸闷，心痛气短，取膻中、厥阴俞、间使、大陵，用补法，以养心安神，理气止痛。

3.相火内动，烦心，心痛，心跳大动，喜笑不休，面赤，取内关、大陵、间使，用泻法，以清热泻火，宁心止痛。

4.热邪循经，经气不利，腋下肿痛，胸胁支满，臂肘挛急，手心热，取天池、天泉、尺泽、郄门、内关，用泻法，以清热祛邪、消肿止痛。

(二)三焦：三焦是上中下三焦的总称，其主要功能是“气化”和“通调水道”。

1.三焦气化功能失常，引起水道不利，水液潴留，肌肤肿胀，气逆腹满，小便不通，取三焦俞、石门、委阳、支沟，用凉泻法，以清热利尿，疏调三焦。

2.热邪上攻，引起暴聋，耳后及喉、颊肿痛，取液门、支沟、翳风、耳门，用凉泻法，以清热降逆，开窍聪耳。

3.风寒侵袭，经气不利，肩、臂、肘外皆痛，无名指麻木不用，取天髎、肩髎、天井、四渎、天宗、外关、中渚，用烧山火法，以驱风散寒，疏通经络。

心包和三焦相表里，如外感后期，热入心包，可引起神昏谵语，夜热不眠或昏睡不醒，取内关、中冲、大陵、厥阴俞、三焦俞，关冲，用凉泻法，以清心开窍，泻热养阴。如邪入心包，神志被蒙，影响到三焦气化失常，兼见小便失禁或尿闭，加配外关、委阳，用平补平泻法，留针10～30分钟，以清心醒神，通调水道。

六、肝和胆

(一)肝：肝在胁肋，其主要功能是“主筋”“藏血”和“主疏泄”。

1.肝藏血的功能虚衰，血不养肝而生风，引起眩晕，抽搐、

震颤、拘挛，取肝俞、三阴交、太冲、合谷、间使，用平补平泻法，以养血熄风，平肝安神。

2. 如肝气郁结不舒，引起胸胁胀闷，两胁下痛，呃逆干呕、善怒、善太息，精神不畅，喉中梗阻，取肝俞、期门、行间、阳溪，用平补平泻法，以理气活血，疏肝解郁。

3. 肝阳上亢，引起头痛、眩晕、目赤肿痛、烦躁易怒，取瞳子髎、风池、太冲、神门、大敦，用凉泻法，以清泻肝火，滋阴潜阳。

4. 风寒湿侵及肝经，引起少腹冷痛、疝气、睾丸偏坠胀痛，取四满、曲泉、行间，用热补法，大敦灸10~20分钟，以暖肝温经，散寒利湿。

（二）胆：胆附于肝，其主要功能是“贮藏与输出胆汁”。

1. 湿热伤及胆腑，排泄输出的功能失常，引起口苦、咽干、偏头痛、眩晕、胁肋胀满疼痛，取风池、瞳子髎、头维、颌厌、日月、足临泣，用凉泻法，以清热利湿，疏经泻胆。

2. 胆虚引起胆怯惊恐、虚烦失眠，取风池、百会、侠溪、丘墟、照海，用热补法，以温经壮胆，健脑安神。

3. 邪客少阳，寒热为疟，发冷、发热，头、颌、缺盆、胸胁痛不能转侧，口苦，好叹气，取大椎、风池、肩井、液门、足临泣，用平补平泻法，以扶正祛邪，疏调少阳。

4. 风寒侵袭，经气不利，髀、膝、胫外侧、外踝皆痛，四趾麻木不用，取环跳、风市、膝阳关、阳陵泉、悬钟、侠溪，用烧山火法，以驱风散寒，疏经止痛。

肝和胆相表里，如湿热伤肝，疏泄功能失常，常薰蒸胆汁外溢，可引起口苦、胁痛、黄疸；如胆汁郁滞不通，影响肝之疏泄时，也可出现上述症状，都可以取肝俞、胆俞、期门、日月、中脘、阳陵泉、丘墟、太冲、蠡沟，用凉泻法，留针20~30分钟，以清热利湿，疏调肝胆。

以上介绍了十二经、脏腑、经络病的配穴和针灸方法，但尚有二经和三经同病，临症时应四诊合参、仔细推敲，正确辨证，不能挂一漏万。如肾气不足，不能摄纳肺所吸之气，可引起气喘、气急、呼吸困难不得卧，取百劳、肺俞、膏肓、膻中、神封、列缺、照海，用补法，以培无益肾，肃肺平喘。肝的疏泄功能失常，影响脾胃的升降、运化，形成“肝胃不和”或“肝脾不和”，可引起气郁不舒、胸胁痞满，食欲不振、食后腹胀，取肝俞、脾俞、胃俞、中脘、期门、足三里、三阴交，用平补平泻法，以疏肝理气，健脾和胃。

第二节 辨证配穴

辨证配穴，就是辨证施治。临床病症虽然复杂，但总不离脏腑经络的病机反映。针灸治病，首先要辨清病在何经及内属脏腑，是经病及腑，还是腑病及经；是初病及经，还是经腑同病。然后再辨阴阳表里，寒热虚实，选取经络穴位，施以补泻凉热等手法，达到治疗目的。

一、昏迷不醒

昏迷不醒是一个症状，病因很多，治法各异。急先治症，缓则治因。

主穴：人中。

辨证配穴：

1.中暑昏迷：证见脉虚、身热、汗出、口渴，配承浆、十宣点刺出血，气海用平补平泻法，以清暑益气、泻热醒神。

2.：中风昏迷：突然昏倒，不醒人事，证见口眼歪斜，喉中痰鸣，舌苔黄腻，脉象洪滑，配十宣，点刺出血，承浆、合谷、丰隆用泻法，以降痰开窍，清热熄风。

3.晕针昏迷：因扎针发生晕针，突然昏迷，汗出脉微，配内关、中冲用补法，以补气固脱。

4.失血昏迷：因流血过多引起脱气（如妇女血崩），出现神志昏迷，脉微欲绝，四肢厥冷，配气海、三阴交、大敦、隐白用补法或灸法，以培元固本，补气救脱。

二、恶心呕吐

恶心呕吐，外感内伤皆可引起，常为好多病兼见之症，可随病施治。此处只谈胃失和降，其气上逆，恶心呕吐，药物饮食难以受纳的治疗。

主穴：内关、足三里。

辨证配穴：

1.饮食伤胃，消化不良：证见吐物酸臭、嗳气厌食，胃脘胀痛，舌苔厚腻，脉象弦滑，配公孙、中脘用泻法留针20~30分钟，以消食导滞、和胃降逆。

2.郁怒伤肝，肝气犯胃：证见恶心呕吐，吞酸反胃，胸胁胀满，口苦心烦，配膈俞、肝俞、期门、中脘、公孙用平补平泻法，以疏肝和胃，止呕降逆。

3.脾胃虚寒，痰饮内停：证见面色㿤白，身倦无力，口流清涎，胃纳不受，舌淡苔白，脉象沉迟，配中脘、梁门、脾俞、胃俞用补法或灸法，以健脾益胃，温中化痰。

4.胃阴不足，胃失濡养：多为热病伤津、耗伤胃阴，胃失濡养、气失和降，证见干呕烦热，舌红少津，脉象虚数，配胃俞、中脘用平补平泻法，留针10~20分钟，以和中健胃，清热生津。

三、便秘

便秘常见的有热秘、寒秘、气秘、血秘。

主穴：大肠俞、天枢。

辨证配穴：

1. 热秘：阳火偏旺，阴津不足，大肠失润，腑气不通，证见舌红、苔黄燥，脉沉数有力，配曲池、支沟、足三里用泻法，以泻热通便。

2. 寒秘：阴寒内结、阳气不运，证见面色清淡，四肢不温，小便清白，腹痛喜温，大便艰涩，舌淡苔白，脉象沉迟，配中脘、大横、足三里、丰隆用补法，以温中散寒，助运通便。

3. 气秘：肺气不足，大肠传送无力，证见面色㿔白，精神疲乏，大便费力，并不干结，舌淡嫩，脉虚弱，配次髎、尺泽、中脘、足三里用补法，以补中益气，助运通便。

4. 血秘：精血不足，肠道失濡，大便困难，证见面色无华，头晕心悸，舌燥少苔，脉象细涩，配支沟透间使，用泻法，次髎、三阴交、照海用补法，以补益精血，润肠通便。

四、脱 肛

脱肛多因湿热下注，或久泻不止，中气下陷所致。

主穴：会阳、腰俞。

辨证配穴：

1. 湿热下注，大肠迫滞不收：证见肛门灼热、痒痛，大便或干或稀，后重不畅，用力则肛门脱出，配大肠俞、天枢、承山用泻法，以清热导滞，调气收肛。红肿痒痛可用花椒艾叶水薰洗。

2. 久泻伤阳，中气下陷：证见身体虚弱，精神不振，肛门脱出不能上提，配百会、长强用补法，神阙、气海用灸法，以培补中气，升提下陷。

五、遗 尿

遗尿多因膀胱失约或肾气不固所致。

主穴：中极、三阴交。

辨证配穴：

1. 小儿遗尿：多因肾气未充，或先天不足，与精神刺激也有一定关系（如父母打骂），常在睡后梦中排尿或不自觉遗尿，配气海、百会用补法或灸10~15分钟，以培元益气，并嘱其注意饮食寒温，避免精神刺激。

2. 老年遗尿：多因肾气衰弱，一有尿意不及入厕，或咳嗽遗尿，配关元、复溜、肾俞、膀胱俞用补法加灸，以培补肾气。

六、尿 闭

尿闭是膀胱气化失司，多种疾病都可引起，急则治症，缓则治因，或症因同治。

主穴：中极、水道、涌泉。

辨证配穴：

1. 湿热下阻：证见小便淋漓涩痛，甚或点滴不通，小腹胀痛，口干，舌红苔黄，脉象洪数，配关元、秩边、三阴交用泻法，清热除湿，通调水道。

2. 肾气虚弱：证见气短无力，小腹胀痛，舌淡苔白，脉弱，配气海、肾俞、膀胱俞、阴陵泉、复溜用补法，以培元益气，振奋膀胱。

3. 跌仆损伤：瘀血停留，膀胱气化受阻，配肾俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、三阴交用平补平泻法，以活血逐瘀，通利膀胱。

七、遗 精

有梦遗和无梦之遗的区别。梦遗多因邪火妄动，无梦多因精关不固。

主穴：关元、三阴交。

辨证配穴：

1. 梦中遗精：为心阴暗耗，心火偏旺，火扰精室，证见梦中

遗精，头昏耳鸣，心悸多梦，舌红少苔，脉象细数，配神门、内关用泻法，留针10~20分钟，肾俞、关元俞、用补法以壮水制火，宁心固精。

2.无梦遗精：为肾气虚损，精关不固，证见滑精频作，面色胱白，精神疲倦，舌淡苔白，脉象沉弱，配气海、命门、肾俞、关元俞、上髎用补法加灸，以补肾培元，固摄精关。

八、疝 气

疝气类别很多，有的须经手术治疗，这里只介绍寒滞厥阴和湿热下注，阴囊肿痛的配穴。

主穴：关元、三阴交、大敦。

辨证配穴：

1.寒滞厥阴：证见睾丸冷痛牵引小腹，胀痛难忍，舌淡苔白，脉沉弦涩，配肾俞、气海、归来用补法加灸10~20分钟，以温经散寒，行气止痛。

2.湿热下阻：证见睾丸阴囊肿胀疼痛，舌红、苔黄腻，脉象弦数，配四满、气穴、阴陵泉、行间，用泻法留针20~30分钟，以清泄湿热，消肿止痛。

九、头 痛

头痛是病人自觉症状，内伤外感均可引起。

主穴：风池、太阳。

辨证配穴：

- 1.前额痛：属阳明经，配上星、头维、攒竹、合谷。
- 2.头顶痛：属厥阴经，配百会、上星、后顶、脑空、太冲。
- 3.脑后痛：属太阳经，配天柱、百会、后顶、后溪。
- 4.偏头痛：属少阳经，配头维、颌厌、悬颅、中渚。
- 5.眼眶痛：属阳明经，配攒竹、鱼腰、四白、合谷。

以上均为循经配穴，并可配阿是穴，用平补平泻法留针10~20分钟，以扶正祛邪，疏经止痛。

十、胸 痛

胸痛属古之胸痹，痹是闭塞之意，多因胸阳不振，阴寒内盛，气机不通，或瘀血停留，经络受阻所致。

主穴：膻中、阿是。

辨证配穴：

1.胸阳不振，阴寒内盛：证见胸痛彻背，喘息咳唾，舌淡苔白，脉象沉迟，配肺俞、膈俞、肝俞、内关用平补平泻法，留针10~20分钟，以理气降浊，宣痹通阳。

2.瘀血停留，经络受阻：证见胸痛如刺，定处不移，脉象弦涩，配心俞、厥阴俞、膈俞、支沟透间使，用平补平泻法，留针10~20分钟，以活血逐瘀，疏经止痛。

十一、胁 痛

两胁为肝胆经所布，故胁痛多因肝气郁结，或瘀血停留所致。

主穴：期门、肝俞

辨证配穴：

1.肝气郁结：证见情志易怒，胁下胀痛，食欲不振，胸闷不舒，舌苔白，脉弦，配内关透外关、阳陵泉、行间用平补平泻法，留针10~20分钟，以舒肝解郁，理气止痛。

2.瘀血停留：证见胁下刺痛，着重不移，舌质暗红，脉象弦涩，配膈俞、阿是、太冲用平补平泻法，留针10~20分钟，以活血逐瘀，行气止痛。

十二、胃 脘 痛

胃脘痛常见的多因肝气郁滞，食滞胃脘，或中焦虚寒所致。

主穴：中脘、足三里。

辨证配穴：

1.肝气郁滞：因肝气横逆，侵犯脾胃，证见胃脘胀痛，痛连两胁，口苦吞酸，呃气矢气较舒，情志不舒时加重，舌苔腻，脉弦，配肝俞、期门、梁丘、内关用平补平泻法，以舒肝理气，和胃止痛。

2.食滞胃脘：因暴食暴饮，宿食不消，证见胃脘胀痛，恶心呕吐，吐物酸臭，苔腻脉滑，配内关、梁门、梁丘用泻法，留针10～20分钟，以消食导滞，理气止痛。

3.中焦虚寒：脾失健运，饮食难消，形寒怕冷，身疲无力，时吐清水，舌淡、苔滑白，脉象沉迟，配下脘、天枢用补法或灸法，以温中散寒，行气止痛。

十三、腹 痛

腹痛可以出现在许多疾病中，多因寒温不适，内伤饮食，气血不和所致。

主穴：中脘、天枢、足三里。

辨证配穴：

1.寒痛：素本中气虚寒，复因外寒侵袭，或多食生冷，以致运化无权，证见腹痛绵绵，喜温喜按，大便溏泄，舌淡苔白，脉象沉紧，配建里、气海用补法或灸法，以温中助运，散寒止痛。

2.热痛：饮食不节，过食厚味，大量饮酒以致热结肠胃，证见腹痛拒按，恶食暖腐，大便干结、或泻而不畅，舌苔黄腻，脉象滑数，配大肠俞、丰隆用泻法，以清热导滞通肠止痛。

3.气痛：多因情志不舒，肝失条达，横逆脾胃，气机郁滞，证

见腹痛胀满，游走攻痛，矢气稍缓，时轻时重，苔腻脉弦，配肝俞、脾俞、三阴交用平补平泻法，以舒肝健脾，理气止痛。

4.血痛：为瘀血停留，气机不畅，证见腹痛拒按，或按之有形，痛有定处，多在少腹，口干不欲多饮，舌暗红，脉弦涩，配归来、阿是、血海、三阴交用平补平泻法，以活血逐瘀，疏经止痛。

十四、腰 痛

多因风湿、肾虚，闪挫所致。

主穴：肾俞、关元俞。

辨证配穴：

1.风湿腰痛：为风寒湿三气乘虚而入，证见腰痛痠楚，阴雨天加剧，舌苔白，脉象沉紧，配环跳、委中、昆仑用烧山火法，以驱风利湿，散寒止痛。

2.肾虚腰痛：因肾精亏损，证见腰痛而困，或遗精盗汗，头晕耳鸣，舌淡苔薄，脉濡，配命门、腰眼、上髂用补法，以补肾壮腰，滋阴养阳。

3.闪挫腰痛：因跌仆闪挫，损伤腰肌，证见腰痛不能转侧，起卧加剧，配志室、腰眼、阿是用烧山火法，不留针，手小节后用平补平泻法，留针20~30分钟，在留针时每3~5分钟，捻转一次，同时嘱患者活动腰部，以活血散瘀，疏经止痛。

十五、妇女月经病

月经不调：

主穴：关元、三阴交。

辨证配穴：

1.月经先期：量多或一月数次，色深红，面色潮红，小便色黄，舌干口燥，脉数，配归来、行间用泻法，以清热凉血，固冲

调经。

2. 月经后期：量少，色淡，身体瘦弱，面色萎黄，舌淡少苔，脉象细弱，配天枢、气海、用补法，以培补冲任，温经养血。

3. 月经先后无定期：经行不畅，或先或后，量少色紫，精神抑郁，乳房胀痛连及胸胁，舌紫少苔，脉弦，配膈俞、肝俞、乳根、归来、血海用平补平泻法，以疏肝理气，调经和血。

4. 倒经：经行不畅，伴有鼻衄，头痛，舌紫，脉滑数，配气海、归来、二间、合谷、血海、行间用平补平泻法，以平肝降逆，引血归经。

痛经：

主穴：关元、三阴交。

辨证配穴：

1. 经前或经期腹痛：经行不畅，胸胁胀满，色紫有块，口干不欲多饮，舌有紫点，苔黄，脉弦，配膈俞、膻中、气海、血海、阿是用平补平泻法，留针10~20分钟，以行气化滞，活血止痛。

2. 经后腹痛：绵绵不休，喜温喜按，月经色淡量少，面色萎黄，舌淡无苔，脉象细弱，配天枢、归来用补法，以补气养血，温经止痛。

崩漏：

主穴：血海、隐白。

辨证配穴：

1. 肝不藏血：月经过多，或突然崩漏不止，夹有血块，血色深红，烦热口渴，精神虚奋，舌红苔黄，脉数，配行间、大敦用泻法，留针20~30分钟，以清热凉肝，宁血止崩。

2. 气不摄血：下血过多，气血两脱，昏迷不醒，脉微欲绝，配人中、内关、中冲用补法，百会、大敦用灸法，以回阳救脱，

固气摄血。

3.冲任虚寒：经漏绵绵不止，色淡或暗，少腹寒凉，腰痛疲乏，舌淡苔白，脉沉细弱，配关元、归来、三阴交用补法，以培元固本，温补冲任。

十六、带 下

常见的有白带、黄带、赤白带。

主穴：带脉、三阴交。

辨证配穴：

1.白带：带下清稀色白，精神疲倦，四肢清冷，舌淡苔白，脉象缓弱，配关元、阴陵泉、隐白、上髁用补法，或灸10~20分钟，以健脾益气，利湿止带。

2.黄带：带下色黄粘稠，气味腥臭，心烦，口渴、不欲多饮，舌苔黄腻，脉濡数，配阴谷、隐白、大赫、气海用泻法，以健脾利湿，清热止带。

3.赤白带：带下赤白夹杂，淋漓不止，腰腿痠痛，舌红少苔，脉象细弱，配气海、关元、上髁用补法，以培补冲任，固精止带。

十七、乳汁不足

多因胃气不足，或肝气郁滞所致。

主穴：膻中、少泽。

辨证配穴：

1.胃气不足：证见乳房松软，身体瘦弱，营养不良，气血不足，乳汁缺乏，配膻中、乳根、中脘、足三里、三阴交用补法，以补脾益气，养血增乳。

2.肝气郁滞：证见胸胁胀满，乳房胀痛，闷闷不乐，口苦脉弦，配屋翳、膻中、乳根、肝俞、阿是用平补平泻法，以疏肝理

气，活络通乳。

十八、小儿抽风

多因外感风寒，入里化热，或乳食不节，损伤脾胃，肝木失养，引动肝风所致。

主穴：人中、合谷。

辨证配穴：

1. 六气化火，肝热生风：证见口噤唇青，面色青紫，角弓反张，配十宣、风府、大椎、陶道、身柱、大敦点刺出血，以清热凉肝，熄风镇惊。

2. 脾胃虚弱，肝失濡养：证见面黄肌瘦，大便溏泄，手足抽搐，配中脘、气海、内关、足三里、三阴交用补法加灸，以培补脾胃，养血柔肝。

十九、耳鸣、耳聋

多因胆火上扰，或肾精不足所致。

主穴：听宫、中渚。

辨证配穴：

1. 新病耳鸣、耳聋：为新感外邪，扰动胆火，循经上行，耳窍被蒙，证见头痛面赤，口苦咽干，心烦易怒，舌红苔黄，脉象弦数，配听会、率谷、翳风，侠溪用泻法，清泻胆火，开窍聪耳。

2. 久病耳鸣、耳聋：为肾精不足或病后精血未充所致。证见头晕目眩，腰痠遗精，舌质红，脉细弱，配耳门、百会、肾俞、照海用补法，补肾益精，升清聪耳。

二十、牙 痛

牙痛有实火、虚火、风火之分。

主穴：下关、翳风、合谷。

辨证配穴：

1.实火牙痛：热在阳明，证见口渴喜凉饮，大便热结，舌质红，苔黄燥，脉洪大，配巨髎、颊车、内庭用泻法，留针20~30分钟，以疏泻阳明，清热止痛。

2.虚火牙痛：多因肾水不足，虚火上炎，证见满口牙痛，并有松动感觉，口干舌燥，脉象细数，配太溪用补法，颧髎、颊车用泻法，留针10~20分钟，以滋阴降火，固齿止痛。

3.风火牙痛：多因素体阴亏，风邪化火，证见头昏目眩，牙痛扩散颜面，如蚁走窜，怕热喜凉，舌红少苔，脉象浮数，配风池、太阳、巨髎、颊车用泻法，留针20~30分钟，以清热驱风，疏经止痛。

二十一、冻 疮

主穴：阿是（冻伤局部）

冻疮在手上，配合谷、后溪、中渚；在脚上，配行间、内庭、足临泣、申脉用熨热灸20~30分钟，以温经散寒，行气活血。

二十二、鹅 掌 风

鹅掌风多因外感风寒，胃中火盛，血液枯燥所致。

主穴：针合谷透劳宫，用烧山火法，并用毛巾两条在开水中浸泡，交替乘热使用，将手包缠20~30分钟，使手出汗，以祛风散邪。

辨证配穴：

手掌痒痛，配中渚、后溪用烧山火法，留针20~30分钟，使手掌出汗，以疏风止痒。手掌剥皮，干裂出血或皮肤起泡流黄水，配八邪用烧山火法，阿是（患处）用熨热灸20~30分钟，以

疏风活血，除湿止痒。手掌干痒起硬皮，局部涂鲜蒜汁，用熨热灸20~30分钟，以活血润燥，驱风止痒。

二十三、聋 哑

聋哑，有先天与后天之分。后天多因肾气未壮，脾气未充，易感外邪，上扰神明，或因治不及时，用药不当，清窍闭蒙，致成本病。

主穴：听宫、哑门。

辨证配穴：

1. 全聋哑：以治聋为主。配耳门、翳风、外关、陵下；或听会、耳门、中渚；两组穴位交替使用。听力渐复后，再配上廉泉治疗哑症。

2. 半聋哑：聋、哑并治。配合谷、陵下；或耳门、翳风、上廉泉、中渚；两组交替使用，以通窍聪耳。

按：以上仅举常用配穴，在具体治疗时，要按少取勤换，远近配穴的原则，每次针2~3穴为宜。当听力有些恢复后，即同时治疗哑症，并配合语言训练。

第三节 临床治疗总结摘要

临床治疗总结摘要，是选择20年来中西医结合，采用西医诊断，祖国医学辨证施治，运用针灸和新医疗法治疗观察的结果。

一、感 冒

本病是由病毒引起的一种呼吸道传染病。属于祖国医学“伤寒”、“温病”范畴。多因体虚劳倦，外感风邪所致。

主症：

1. 风寒型：恶寒发热，头痛无汗，或有汗，四肢痠痛，鼻塞

流涕，打喷嚏，咽部干痒，咳吐清痰、舌苔薄白，脉浮紧或浮缓。

2. 风热型：发热恶风，头痛有汗，或无汗，咳吐黄痰，咽喉红肿、疼痛，口干欲饮，舌尖红，苔薄白，脉浮数。

治疗：

1. 风寒型：针风池、大椎、身柱、风门、合谷、后溪用烧山火法使其出汗，以发散风寒。

2. 风热型：针风池、大椎、陶道、身柱、合谷用透天凉法，少商点刺出血使其出汗，以发散风热。

咳嗽痰多配肺俞、列缺以清肺化痰。高烧神昏配百会、人中、十宣（或十二井）点刺出血，以清热开窍。鼻塞流涕配上迎香、迎香、曲池用速刺法，以驱风通窍。

1972年4月在成县医院总结的50例中，有效率为98%，平均1.1次见效。治愈率为84%，平均2.4次治愈。

病案举例：

王××，女，30岁，成县小学教员，因感冒发烧，1970年3月1日初诊。

患者于前一天开始头痛、打喷嚏、鼻流清涕，身上发冷，当日病情加剧，又出现发烧、咳嗽、吐痰，全身痠痛。检查：身热无汗、舌苔薄白，体温38.8℃，脉浮紧，90次/分，心、肺未见异常。中医辨证系体质素虚、外感风寒。采用扶正祛邪、驱风散寒之法治之。针风池、大椎、风门、合谷，用烧山火手法，不留针，针后汗出，头痛即止，40分钟后体温降至37℃。第二日针大椎、风门、肺俞、列缺，用平补平泻法。第三日症状完全消失，治愈停诊。

二、支气管炎

本病是由病毒、细菌等感染引起的一种常见的呼吸道疾病。

并与长期吸烟或吸入刺激性气体及尘埃有关。分急性和慢性两种。属于祖国医学“咳嗽”、“喘鸣”范畴。多因正气不足，外邪犯肺所致。

主症：

1.急性支气管炎：先有咽喉痒痛，鼻塞流涕，发热头痛，接着咳嗽胸痛，吐粘液或脓样痰，可伴有血丝，肺部听诊可听到粗糙呼吸音，或干湿罗音，x线检查显示肺纹理增粗。舌苔薄白，脉浮数。

2.慢性支气管炎：持久性咳嗽，吐大量粘液泡沫痰，气候改变或气味刺激咳喘加剧，甚则胸闷气促。肺部听诊可听到鼾声、湿性罗音和哮鸣音。舌苔黄，脉滑。

治疗：

1.急性支气管炎：针大椎、陶道、风门、定喘，合谷用泻法，以祛风散寒。

发热头痛，配风池、列缺、少商用泻法，以清热化痰。

2.慢性支气管炎：针百劳、身柱、喘息、肺俞、神封、膻中、列缺、太渊用补法或加灸，以理气化痰。

胸闷气短，配中脘、气海、内关、膏肓用平补平泻法，以宽胸理气。痰多，配丰隆，用平补平泻法，以祛痰降逆。

1972年6月在成县医院总结的50例中，有效率为96%，治愈率为40%。急性支气管炎疗效佳，老年慢性支气管炎疗效差。

病案举例：

王××，女，41岁，成县百货公司售货员，因咳喘痰多十二年，1970年2月15日初诊。

患者1958年开始咳嗽，冬季天冷加重，咳嗽以夜间为甚，吐白色粘液泡沫状痰，伴有心慌、怕冷、全身疲乏无力，胸闷、气短，不能平卧，经常感冒等症。检查：慢性病容，精神不振，眼睑浮肿，桶状胸，听诊呼吸音粗糙，胸透：两肺纹理增重；舌质

淡、苔白腻，脉滑细，78次/分。西医诊断为慢性支气管炎，中医辨证系正气不足、风寒犯肺，引动伏饮，痰阻气道。采用扶正祛邪、宣肺化痰之法治之。取百劳、定喘、身柱、肺俞、膻中、列缺，用热补法，留针20分钟，每日一次，针治五次，食欲增加，咳喘减轻，吐痰减少，精神好转。改为每周针三次，治疗至3月20日，针达十六次时，症状完全消失，停诊。同年7月15日随访未复发。

三、支气管哮喘

本病是呼吸道的过敏性疾病。属于祖国医学“哮”、“喘”、“痰饮”、“喘呼”范畴。多因肺肾气虚、失于降纳，风邪犯肺、引动伏饮，痰气交阻，气道闭塞，正虚邪实所致。临床有虚、实、寒、热之分。

主症：

呼吸困难、短促，喉中哮鸣、咳呛，咳白色粘液性痰，咳吐不利，胸膈胀闷，肺部可听到干性罗音及哮鸣音。

1.实喘：喘而气粗，胸满痰多，舌苔白腻，脉弦滑。

2.热喘：咳而口渴，面赤唇红，舌红苔黄，脉洪而滑。

3.虚喘：喘而气微，吐痰无力，精神不振，动则气促，面唇苍白，舌苔薄白，脉细无力。

4.寒喘：喘而怕冷，痰多而稀，口润而湿，鼻多清涕，舌苔薄白，脉细或迟。

治疗：

1.实喘：针大椎、定喘、肺俞、合谷、丰隆、天突用泻法，以清肺定喘。

2.热喘：用上穴加配少商、尺泽放血，以泻热祛痰。

3.虚喘：针百劳、大椎、陶道、肺俞、膏肓、膻中、中脘用补法或加灸，以温中化痰。

4.寒喘：用上穴加配风门、身柱用温和灸法，以祛寒散风，理气定喘。

1959年1月在中医研究院针灸研究所总结的58例中，有效率为98.3%，治愈率为48.3%。

病案举例：

李××，男，40岁，北京宣武区玻璃厂工人，因咳嗽气喘三十年，1957年8月11日初诊。

患者九岁时上学受凉后开始咳嗽，以后每年冬季咳嗽、气喘、痰多，逐年加剧，夜间不能平卧、仅能睡3—4小时。并伴有食欲减少，全身疲软无力、头昏头痛等症，曾多次到医院治疗，不能除根。检查：慢性病容，桶状胸，两肺呼吸音增强，可闻及哮鸣音，咳喘气微，动则气促，痰多，呈白色粘液状，吐痰无力，面色苍白，舌苔薄白，脉滑细，78次/分。西医诊断为慢性气管炎支气管哮喘；中医辨证系肺肾气虚、寒邪犯肺，引动伏饮、痰阻气道。采用补肾宣肺、化痰定喘之法治之。取百劳、大椎、肺俞、肾俞，用热补法，留针20分钟，每日一次，针治三次，咳喘减轻、痰亦减少，夜间能睡4—6小时，治疗至9月11日，针达二十次时，咳喘基本消失，精神好转，夜亦无痰；治疗至10月10日，针达三十二次时，气候改变无任何症状，即停诊。1958年2月15日随访未复发。

四、急性胃肠炎

本病是一种由于食用某种被污染的食物而引起的急性胃肠道疾病。属于祖国医学“吐泻”、“霍乱”范畴。多发于夏秋季节。常因饮食不洁，消化不良，或暴饮暴食，邪犯胃腑所致。

主症：

1.寒型：突然恶心呕吐，腹痛水泻，胸膈痞满，四肢冰冷，舌苔白腻，脉迟或细弱。

2.热型：腹痛心烦，发热口渴，吐腐臭物，便有粘液，舌苔黄腻，脉数。吐泻严重者，则口干舌燥，两眼凹陷，出现脱水现象。

治疗：

1.寒型：针中脘、天枢、气海、内关、足三里、公孙用热补法，或针后加灸10~20分钟，以温补脾胃，调中和胃。

2.热型：用三棱针点刺尺泽、委中放血，或针曲池、天枢、足三里用凉泻法，以清热利湿，调中和胃。

吐泻过久，两眼凹陷，出现津气两伤，则灸神阙、关元以回阳救阴，补气固脱。

1972年9月在成县医院总结的25例中，均有疗效，治愈15例。

病案举例：

张××，男，31岁，成县县委干部。因腹痛、吐泻五小时，1970年8月8日初诊入院。

患者入院前一天下午在街上吃甜瓜、桃子、凉面后，即感肚子不适，晚上开始腹痛，逐渐发展为上腹部及围脐绞痛，恶心呕吐，肠鸣腹泻，症状逐渐加剧，一夜腹泻、呕吐各十二次，吐出物为胃内容物，伴有绿色苦水；泻出物为黄色水样稀便，无脓血。头昏、全身疲困乏力，口渴、饮水即吐，在门诊注射阿托品、口服黄连素无效而入院。检查：体温37.5℃，舌苔黄，脉数，82次/分，血压120/80mmHg，发育正常，营养欠佳，神志清楚，急性病容，俯卧呻吟。心肺（-），左上腹及脐周有明显压痛，肠鸣音亢进，肝脾未触及。化验：大便稀黄，红细胞（+），未消化食物（++）。西医诊断为急性胃肠炎；中医辨证系饮食不洁、邪犯胃肠。采用清热利湿、调理胃肠之法治之。取尺泽、委中，用三棱针放血，中脘、天枢、足三里，用泻法，留针30分钟，针后腹痛、吐泻即止，至次日未见腹痛吐泻，下午

仅大便一次，黄色成形。治疗至8月11日，针达四次时，症状完全消失，检查、化验完全正常而出院。

五、胃及十二指肠溃疡

本病是胃肠道与胃液接触部分的慢性溃疡，其形成和发展可能与中枢神经系统功能紊乱和胃液中胃酸和胃蛋白酶的消化作用有关，故亦称消化性溃疡。属于祖国医学“胃脘痛”、“胃心痛”“心口痛”范畴。多因情志不舒，饮食失调，气滞血瘀，络脉受损所致。

主症：

胃溃疡多在进食后一小时疼痛，于上腹稍偏左；十二指肠溃疡多在空腹饥饿时或进食后3~4小时疼痛，于上腹稍偏右；有节律性，疼痛自觉有压迫感，膨胀感，以至钝痛、灼痛或剧痛，一般呈周期性发作。恶心呕吐，嗝气吞酸。胃脘和膈俞、肝俞处出现压痛。

1.脾胃虚寒型：胃痛喜按，得食稍安，嗝气吞酸，恶寒喜温，舌淡苔白，脉弱。

2.气血郁滞型：胃痛拒按，食后痛甚，吐血，便黑，舌色暗红、苔厚腻，脉弦。

治疗：

1.脾胃虚寒型：针巨阙、中脘、梁门、足三里、三阴交用补法，以温中健脾，活络止痛。

2.气血郁滞型：针上脘、下脘、足三里、内庭、膈俞、肝俞用平补平泻法，以舒肝理气，活血止痛。

呕吐，配内关、公孙用泻法，留针20~30分钟，以和中降逆。疼痛反复发作，配膈俞用皮下埋针或埋线，留针5~7天，加强疗效。大便色黑有热，配曲池、合谷、三阴交、内庭用泻法，以清热止血。便秘，配次髂、天枢、支沟用泻法，以润肠通

便。腹泻，配气海、脾俞、会阳用补法或灸法，以健脾止泻。

1956年12月在中医研究院针灸研究所总结的24例中有效率为95.8%，治愈率为37.5%。

病案举例：

例一、脾不摄血型

张××，女，28岁，东北农学院学员。因腹痛便血四年，1954年11月25日初诊。

患者1949年患肺浸润和胸骨结核，1950年5月患湿性肋膜炎以来，大便时干时稀，至1950年底形成每日黎明泻。仍是便秘和腹泻交替出现。1952年9月在瓦房店结核病休养所疗养中，突然腹泻不止，泻至7—8次时，开始便血，并混有粘液。经用止血剂注肠并禁食三日，一星期后便血方止。但自此以后即形成便秘，每星期灌肠一、二次。1952年12月到中国医大×医院受诊，诊断为“回盲部结核”，注射链霉素30g，症状稍减，继续治疗到1953年4月，又突然腹泻、便血，并带有脓液。同年8月—12月继续复发，症状逐次加剧，遂去哈尔滨医大诊治，经做直肠窥镜检查：在10厘米深处，见到点状出血灶；并做钡剂灌肠透视检查：发现在脾曲部有点状钡剂残余及压痛，下行结肠呈索状挛缩，诊断为溃疡性结肠炎，经过各种治疗，症状稍减，于1954年3月（出院后半月）又反复便血，难以制止，即使用各种止血剂和治疗方法，但最多不超过半月，仍继续便血。近来，患者上腹部及脐左侧疼痛较甚，腹部膨胀，下午尤甚，右季肋部和胃部发热，吞酸噁心，有时呕吐食物，大便时干时泻，并有黎明泻。无论腹泻与否均大量便血，每日2—8次，严重时达15次之多，每次血量10—30ml，严重时可达80ml，血色鲜红，有时混有少量紫色血块和粘液，便时腹内发热，里急后重，全身疲倦无力，食欲减退，因有盆腔炎，月经时多时少，有时咳嗽盗汗、失眠、头晕、心跳、腰腿痠痛，不能工作，而来我所诊治。检查：面色苍白，

皮肤干燥无光泽，营养不良，体重48kg，舌红少苔，脉细数，100次/分，血压90/60mmHg。左侧肋骨凸出，右侧肋骨凹陷，上腹部及脐左下方有压痛，背部两侧12椎下部有压痛，心肺未见异常。化验：大便黄褐色不成形，无脓，便外附有鲜血，无粘液，未见虫卵，大便培养无病原菌；出血时间3'30"，凝血时间14'，血红蛋白9.6g，白细胞总数3800/mm³，多核73%，酸性6%，杆状3%，淋巴18%。中医辨证系久病消耗、脾胃虚弱，脾不摄血，下元不固。采用健脾益胃、培元摄血之法治之。取中脘、天枢、气海、三阴交，用补法，留针20分钟，膈俞，会阳，用热补法，不留针，治疗四个月，针达五十二次时，一般症状减轻，便血仅犯2次（延续二十一天），但次数及量均减少。体力逐渐复原，腹痛、腹胀等症状明显减轻，经X线检查：幽门部有显著的痉挛现象，十二指肠球部有轻度的变形，且移动受牵制，并向胃小弯侧牵引。诊断为十二指肠溃疡，溃疡性结肠炎，盆腔炎。继续治疗到同年6月30日，共计八十八次，腹部已不经常疼痛，上腹部轻松，饮食增加，大便已转为正常，精神体力日见好转，月经已恢复正常，体重51kg，接近痊愈，为了继续观察，于7月开始隔日针灸一次，至7月30日，共计治疗七个月，观察一个月，针达一百零八次，即愈。停针时体重已增至53kg，半月后又经X线检查，证明痊愈，回籍。于同年9月、10月、11月，三次通信联络，情况良好。

附记：1981年开会相遇，患者病愈后，身体很好，改行学医，成了针灸医师。

例二、脾胃虚寒型

何××，女，50岁，北京人，市民。因胃痛呕吐反复发作三十余年，1954年4月9日初诊。

患者于十四岁患胃病，每年秋季和天冷时胃痛较重，暖气吞酸，逐渐加重。1953年病情更加恶化，曾经职工医院，北京×医

院诊断为胃下垂兼胃溃疡，经过治疗未见显著效果。现在患者胸中满闷、气短、胃痛腹胀、打嗝、呕吐食物，有时连续呕吐，后来口渴喜热饮，但水入即吐，喜服苏打片，自觉服后胃内比较舒适一些，腰背痠痛，全身无力，发冷、无汗，大便灰白色，而来我所诊治。检查：舌质淡，舌苔薄白，脉沉迟，60次/分，血压90/60mmHg，全腹部压痛，特别是右季肋部僵硬而明显压痛，其它无异常所见。中医辨证系脾胃虚寒、中气下陷。采用健脾养胃、温中散寒之法治之。取上脘、中脘、内关、足三里，用热补法，留针30分钟。治疗至4月10日，针治六次时，腹痛及呕吐基本消失，腹部压痛已减轻，治疗至2个月，针达二十一次时，症状即完全消失，恢复了家庭劳动，为了观察效果，每月来所针一次，观察至11月8日，又针六次，即完全恢复健康，于1955年联系，情况良好。

附记：何同志病愈后，为了感谢政府提倡中医且成立中医机构，把家传秘方90份左右，无代价地供献给了华北中医实验所。

例三、气血郁滞型

左××，女，35岁，河北省人。因胃痛恶心十一年，1955年9月8日初诊。

患者于1944年开始胃痛，每年秋初及天冷时胃痛较甚，恶心、吞酸，由1953年逐渐严重，曾服中药及西药，最初服苏打片后症状稍好，现服后则呕吐，毫无效果。近来，患者上腹部疼痛，尤以左上腹痛甚，恶心、吞酸、吐食、吐后则胃痛减轻，每日饭后2—3小时即开始疼痛，以前稍进饮食，则疼痛减轻，现在虽进饮食疼痛不减，疼痛有时放散到背部，腰部也有胀感，每当身体劳累或精神不愉快、生气时，即觉胃痛，经常头痛、头晕，下午发烧，大便褐色，而来我所诊治。检查：舌质暗红、舌苔白腻，脉弦细，74次/分，血压120/90mmHg，体重45kg，心肺未见异常，腹部平坦，肝脾未触及，保阿氏压痛点呈阳性反

应，其它未见异常。化验：血红蛋白10g，红细胞380万，白细胞6400/mm³，中性65%，淋巴35%，血沉4mm/小时，大便呈绿褐色软便，潜血反应（++），蛔虫卵（++）。胃液：（见表23）

表23

项 目	食 前	食 后
性 状	白色粘液（++）	多为食物残渣
量	20毫升	72毫升
镜 检	白 细 胞（+） 上皮细胞（+）	白细胞（+） 脂肪球（+）
总 酸 度	16单位	87单位
游离酸度	10单位	51单位

X线检查诊断为十二指肠球部溃疡。中医辨证系肝郁气滞，横逆犯胃。采用舒肝理气，健脾养胃之法治之。取肝俞、内关，用平补平泻法，上脘、中脘、下脘、足三里，用补法，留针30分钟。针治三次时，呕吐停止，上腹部疼痛减轻。针治六次时，上腹部疼痛消失，饮食增加；治疗至两个月，针达二十二次时，症状完全消失，即恢复了劳动。化验：血红蛋白12g，红细胞400万，白细胞7000/mm³，中性75%，酸性1%，淋巴24%，血沉1mm/小时，大便潜血反应（-）。胃液：（见表24）

为了继续观察，治疗至1955年12月6日，针达三十七次时，体重增加至48公斤，情况良好，X线检查，球部溃疡已不显著。停诊观察。1956年5月20日随访，未复发。

六、胃 下 垂

本病是由于胃支持韧带松弛，或因胃壁弛缓，致在直立时，

表24

项 目	食 前	食 后
性 状	乳白色，粘液多	白色微黄，多为食物残渣
镜 检	无 所 见	无 所 见
总 酸 度	26 单 位	86 单 位
游离酸度	8 单 位	28 单 位

胃小弯位于髂嵴联线下方1.5厘米或更下的位置。属于祖国医学“暖气”、“吞酸”、“胃痛”范畴。多因中气不足、胃中虚寒所致。

主症：

食后常感心窝部沉重、饱胀、暖气或呕吐。呕吐物常含陈旧的食物残渣，有时带发酵的酸味，便秘或溏泻，消瘦。X线检查：胃小弯位置在髂骨嵴联线下方1.5厘米以下，胃内常有较多的残余液体，排空时间显著迟缓。舌苔白腻，脉缓。

治疗：

胃小弯位置在髂骨嵴联线1.5厘米以下，取中脘向下斜刺透下脘，梁门向下斜刺透关门，足三里用补法，留针10—20分钟，以补中益气、促进运化，而使胃部提升。

胃小弯在4厘米以下，取中脘、天枢、向下斜刺透外陵，气海向下斜刺透关元，用补法，留针10—20分钟，以培元固本。

兼胃炎、胃痛、恶心呕吐，配上脘、内关，用平补平泻法，留针20—30分钟，以和中降逆。兼胃及十二指肠溃疡，配巨阙、内关、公孙、脾俞、胃俞，用补法，留针10—20分钟，以温中止痛。兼肝炎，配期门、膈俞、肝俞，用平补平泻法，留针20—30分钟，以舒肝理气、活血解郁。兼阳萎、早泄、肾虚，配肾俞、

关元，用热补法，留针20分钟，以补肾壮阳、温固下元。

1977年3月在成县医院和孟昭敏、郑俊明总结的40例中，治愈11例，占27.5%；显效11例，占27.5%；进步17例，占42.5%；无效1例，占2.5%；有效率为97.5%。1986年1月总结的91例中，痊愈25例，占27.5%；显效27例，占29.6%；进步37例，占40.7%；无效2例，占2.2%；有效率为97.8%。其中胃小弯在髂骨嵴联线以下1.5—3.5厘米的19例和50例中，治愈7例和15例，未见无效者；在4厘米以下的21例和41例中，治愈4例和10例，无效者1例和2例；可以看出胃下垂轻者疗效佳，重者疗效差。

病案举例：

例一：

邱××，女，21岁，因胃痛，腹胀半年，1974年5月20日来我院。

患者去年12月发现胃痛，腹胀，食欲逐渐减少，嗝气，现在每天食量不足半斤，身体逐渐虚弱，疲乏无力。经服药治疗效果不显。X线钡餐检查：胃小弯在髂骨嵴下4厘米，身体消瘦，腹部松软无压痛，面黄，舌苔薄白，脉沉缓无力。中医辨证系中气下陷，脾胃虚弱。采用补中益气，调整脾胃之法治之。取中脘透下脘、天枢透外陵、气海透关元、足三里，用热补法，留针10~20分钟。针治10次，胃痛、腹胀减轻。X线钡餐检查：胃小弯在髂骨嵴下2厘米，治疗到同年7月15日，针达30次时，症状完全消失，X线钡餐检查：胃小弯在髂骨嵴上1厘米，已愈停诊。经同年10月23日随访情况良好。

例二：兼十二指肠球部溃疡

1.王××，男，29岁，徽县泥阳丝绸厂职工。因胃痛、腹胀二年，1974年5月20日初诊。

患者1965年开始吞酸、嗝气，1972年2月开始胃痛，腹胀，

尤其是饭后上腹部饱胀、沉重，有向下坠的感觉，口干苦、吐酸水、食欲减退。X线钡餐检查：胃小弯在髂骨嵴联线下4厘米，十二指肠球部有 0.5×0.5 龛影。舌苔白腻，脉沉细而缓，腹部膨胀，上腹部压痛。中医辨证系中气不足、胃中虚寒。采用补中益气、温中散寒之法治之。取中脘向下斜刺透下脘，梁门向下斜刺透关门，天枢向下斜刺透外陵，气海、足三里、公孙、脾俞、胃俞，用补法，治疗至5月24日，针治四次时，胃即不痛，治疗至7月2日，针达三十次时，症状基本消失，饮食增加，X线钡餐检查，胃位置稍偏低，基本正常，胃和十二指肠球部溃疡病灶已消失，回籍恢复了工作。同年9月12日复查，胃位置正常。

2. 花××，女，32岁，成县182地质队家属。因胃痛、腹胀三年，1974年5月18日初诊。

患者1966年开始吞酸、暖气，1971年1月开始胃痛、腹胀、口苦、吐酸水、食欲减退。X线钡餐检查：胃小弯在髂骨嵴联线下4厘米，十二指肠球部有 0.5×0.5 龛影。舌苔白腻，脉沉细而缓，腹部膨胀，上腹部有压痛。中医辨证系中气不足、胃中虚寒。采用补中益气、温中散寒之法治之。取中脘、梁门、天枢、气海、足三里、公孙、内关、脾俞、胃俞，用热补法，治疗至5月23日，针治五次时，胃即不痛，治疗至6月30日，针达三十次时，症状基本消失，饮食增加，X线钡餐检查，胃小弯在髂骨嵴联线上2厘米，胃和十二指肠球部溃疡病灶已消失，治愈停诊。同年9月20日复查，胃位置正常。

例三：兼阳萎早泄

1. 王××，男，33岁，徽县某中学教员。因腹胀一年，1974年6月23日初诊。

患者九年前患阳萎早泄，去年夏季开始腹胀，饮食减少，现在食量每天不足半斤，食后饱满腹胀，暖气、上腹部坠痛，大便时干时稀，身体逐渐虚弱，疲乏无力，有时心慌。X线钡餐检

查，胃小弯在髂骨嵴联线下4厘米。心电图检查，窦性心律过缓及心律不齐，身体消瘦，面黄，脐周压痛，舌苔黄厚腻，脉迟无力，48次/分，左不及右。中医辨证系中气不足，肾气虚损。采用补中益气、培元固肾之法治之。取中脘向下斜刺透下脘，天枢向下斜刺透外陵，气海向下斜刺透关元，足三里、肾俞、用补法，治疗至7月5日，针达十次时，腹部即不胀，饮食增加，心慌和疲乏减轻，治疗至7月13日，针达十七次时，阳萎逐渐好转，精神体力增加。X线钡餐检查，胃小弯在髂骨嵴联线下0.5厘米。治疗至7月29日，针达二十七次时，每天食量增至1斤以上，脉缓有力，70次/分。X线钡餐检查，胃小弯在髂骨嵴联线上2厘米。治愈回原籍，恢复了工作。同年10月6日复查，情况良好。

2. 安××，男，31岁，成县县委干部。因胃、腹胀痛半年，1974年5月27日初诊。

患者三年前患阳萎早泄，饮食逐渐减少，继而胃脘作痛，噎气，大便稀，每日腹泻3—4次，走路时腹部坠痛，全身疲乏无力。X线钡餐检查，胃小弯在髂骨嵴联线下5厘米。身体羸弱，面色苍白，腹部柔软无压痛，舌苔薄白，脉沉缓无力。中医辨证系中气不足、肾气虚损。采用补中益气、培元固肾之法治之。取中脘、天枢、气海、足三里、肾俞，用热补法，针治两次时，胃、腹胀痛减轻；针治八次时腹泻停止；治疗至6月20日，针达17次时，症状完全消失，X线钡餐检查，胃小弯在髂骨嵴联线下0.5厘米；治疗观察至9月23日，针达三十次时，每日食量大增，脉缓有力，X线钡餐检查，胃小弯在髂骨嵴联线上1厘米，治愈停诊。同年12月23日复查，情况良好。

七、胆 囊 炎

本病多为胆石症或胆道蛔虫以及细菌感染引起的胆囊炎症。

属于祖国医学“胁痛”、“黄疸”范畴。多因寒热不适，饮食不节，肝气郁滞，胆失疏泄，湿热蕴于中清之腑所致。

主症：

右上腹部阵发性绞痛，伴有恶心呕吐，腹胀烦躁，发热，大便秘结，小便短赤，右上腹胆囊区有明显触痛及腹肌强直，有时可摸及肿大的胆囊，肝区有叩痛，右肩背部及肩胛下9~11肋骨区皮肤感觉过敏，脉弦，苔白。

治疗：

针期门、日月、阳陵泉用泻法留针30~40分钟，以清利肝胆。

恶心呕吐，配内关用泻法，以降逆止呕。发热，配曲池、丘墟，用泻法，以清热利胆。疼痛连及背部，配膈俞、肝俞、胆俞用泻法，以疏肝理气。腹痛便秘，配中脘、天枢、足三里用泻法，以通调胃肠。

1973年1月在成县医院总结的10例中，有2例治愈，7例显效，1例效果不明显。一般右上腹痛和呕吐针治1~3次，即可停止，胆囊区触痛10~15次方可消失。

病案举例：

王××，男，52岁，成县汪家巷11号农民。因右上腹部胀痛两个多月，1971年10月13日初诊。

患者今年6月右上腹部胀痛，不能吃东西，在成县县医院诊断为胆囊炎，住院十余天，治疗后有些好转。因不做手术而出院，服药物治疗，未见明显效果，近来病情加剧，右上腹部发硬、阵发性胀痛，不敢吃东西，有时反胃，恶心呕吐，大便秘。检查：痛苦病容，面色晦暗，舌质红，苔薄白，脉弦紧，80次/分。右上腹肋骨边缘有一肿物坚硬、压痛，侧卧时肿物可垂至腹部中线、下至梁门穴处。西医诊断为胆囊炎；中医辨证系饮食不节、肝气郁滞、湿热熏蒸、胆失疏泄。采用舒肝理气、清热利

湿、泻胆通腑之法治之。取日月、阳陵泉，用泻法；中脘、梁门、足三里用平补平泻法，留针30分钟。治疗至10月27日，针治十次时，上腹部胀痛减轻，大便即不干，肿物变软；治疗至11月15日，针达二十次时，上腹部胀痛消失，肿物渐小；治疗至12月6日，针达三十次时，肿物消失，治愈停诊。1972年3月10日随访未复发。

八、急性阑尾炎

本病是由阑尾腔梗阻或细菌感染引起的一种常见的急腹症。俗称盲肠炎。属于祖国医学肠痈范畴。多因寒温不适，饮食不节，劳倦过度，湿热、瘀血，郁积肠内所致。

主症：

转移性腹痛，先由腹部中线或脐周围或上腹部开始疼痛，数小时至1～2天后转于右下腹，呈持续性、阵发性加剧，恶心呕吐，发热口渴，尿黄，腹泻或便秘，右下腹有一范围局限的压痛点，侵及腹膜时有反跳痛。上巨虚附近有压痛，舌红、苔白厚或黄腻，脉弦紧或弦数。

治疗：

针足三里、上巨虚（或阑尾穴）、天枢、大巨用泻法，留针30～60分钟，每5～6分钟行针一次，5～8小时施针一次，疼痛缓解后12～24小时施针一次，以泻肠中积热。

疼痛剧烈，配公孙，内庭以镇痛。恶心呕吐，配内关以止吐。发热、配曲池、合谷以清热。局部压痛久不消失，配阿是穴以活血。便秘，配大肠俞、次髂以通便。

1972年2月在成县医院总结的20例中，均有疗效。治愈16例，平均2～6小时腹痛消失。1～2天体温和白血球恢复正常。压痛4～5天消失。

病案举例：

李××，女，38岁，成县文化馆职工。因转移性右下腹痛，伴有恶心两天，1971年12月12日入院。

患者两天前突然腹痛，逐渐转到右下腹部疼痛，两天来未见大便，恶心欲吐，不思饮食，全身不适而入院。检查：急性痛苦面容，心、肺（-），右下腹部肌肉紧张，麦氏点压痛阳性，反跳痛阳性，腰大肌试验阳性，阑尾穴（上巨虚上一寸）有压痛；化验：白细胞18,100，中性83%，淋巴17%，尿常规（-），体温37.8℃，舌质红，苔黄厚，脉弦，80次/分。西医诊断为急性阑尾炎；中医辨证系饮食不节、湿热郁积肠内。采用清热利湿、通便止痛之法治之。取天枢、阑尾穴，用泻法，留针40分钟，每5分钟，行针一次，腹痛即止；以后每6小时针治一次，至第二天大便一次，未再腹痛，腹部压痛减轻，改为每日针一次，14日腹部压痛消失，化验：白细胞7,100，中性72%，淋巴28%；12月16日治愈出院。1972年2月15日随访情况良好。

九、痢 疾

本病是由痢疾杆菌引起的一种肠道传染病。属于祖国医学肠癖、赤痢、白痢范畴。多发于夏秋季节。常因内伤生冷，饮食不洁，外感暑湿，湿热蕴结肠胃所致。

主症：

畏寒发热，腹痛，腹泻，每日数次至数十次，大便脓血，里急后重，常伴有恶心呕吐，小便赤，脐围有压痛，舌苔黄腻，脉滑数。粪便检查有大量脓细胞、红细胞。

治疗：

取中脘、天枢、气海、足三里用凉泻法，留针20~30分钟，以清热导滞，通调肠胃。久病气虚，配关元、腰俞、会阳用补法，以培元固脱。

1959年8月在中医研究院针灸研究所总经的30例中，均有疗

效；治愈率为50%，平均退热2.8天，腹痛消失2.3天。里急后重消失2.2天；大便恢复正常者3.8天。

病案举例：

陈××，男，16岁，北京宣武区粉房琉璃街32号，新七中学生。因腹痛、大便带脓血四天，1957年9月2日初诊入院。

患者1957年8月30日上午吃甜瓜，下午即感肚子不适，腹泻一次，8月31日大便十五次，便稀、带脓血，伴有发烧。在居民医院诊断为细菌性痢疾；经服中、西药，未见好，即转来我院。患者每4—5分钟泻肚一次，带有脓血，腹痛甚，有下坠感。检查：体温39℃，急性病容，有轻度脱水，精神不振，舌苔黄腻，脉滑数，82次/分，血压120/80mmHg，心肺未见异常，腹部平坦，脐周有压痛，以天枢穴处最明显，肝脾未触及，听诊：肠鸣音增强。化验：白细胞11,700，中性82%，淋巴17%，单核1%，红细胞400万，血红蛋白12g，尿常规呈酸性，蛋白及糖(-)，白细胞少，大便检查呈黄色，粘液及脓球(+)，红细胞少，大便细菌培养发现痢疾杆菌生长。西医诊断为急性细菌性痢疾；中医辨证系饮食不洁、热蕴胃肠；采用清热导滞，疏调胃肠之法治之。取中脘、天枢、气海、足三里，用凉泻法，留针30分钟，每日针治一次，针治二次时，腹痛、泻痢和发烧消失，治疗至9月9日，针达八次时，检查完全恢复正常，治愈出院。

十、疟 疾

本病是由疟原虫经过蚊子传播引起的一种传染病。多发于夏秋季节。祖国医学《素问·刺疟篇》中就有疟疾的记载：俗称“打摆子”。多因外邪入侵，蕴伏半表半里，形成阴阳纷争。

主症：

起病骤急，开始寒战，继以高热，头痛，面赤，四肢痠痛，

烦渴引饮，终则出汗，热退身凉，全身乏力，呈周期性发作。舌苔白，或黄腻，舌质红，脉弦。一日疟，每日发作一次；间日疟，二日发作一次；三日疟，三日发作一次；恶性疟，发作不规则，症状较剧。

治疗：

在发作前1~2小时针大椎、陶道、身柱用平补平泻法加灸10~20分钟，以扶正截疟。

寒重，配中脘、公孙、内关、足三里用平补平泻法，留针20~30分钟，以扶正祛邪。热重，配后溪、液门、疟门、申脉、足临泣用泻法，留针20~30分钟，以清热祛邪。高烧昏迷时，配人中、百会、疟门用平补平泻法，大椎、陶道、十宣点刺出血，以清热散邪，开窍醒神。

1971年10月在成县医院总结治疗的16例间日疟，全部有效；治愈14例。2次治愈者8人，3~5次治愈者各2人。

病案举例：

高××，女，38岁，成县抛沙农民。因“打摆子”四次，1970年9月11日初诊。

患者9月3日上午突然冷地发抖，后来接着发高烧，头痛、口渴、大量饮水，高烧昏迷不醒，昏睡半天，浑身出汗后症状消失，隔了一天又发病，发病时间及症状与前次相同，7日、9日又连续发病二次，时间、病情均与前两次相同，但身体日渐瘦弱，今日又开始发冷、高烧、口渴。检查：体温40℃，寒战高烧，面赤，舌红、苔黄腻，脉弦紧，100次/分，血常规：白细胞9,000，中性70%，淋巴30%，血片找到疟原虫。西医诊断为间日疟，中医辨证系外感时邪、蕴伏半表半里；采用扶正祛邪、调和阴阳之法治之。取内关、公孙、大椎、液门、足三里，用平补平泻法，留针30分钟，起针后体温降至38℃；9月13日在发病前1小时，取大椎、陶道，用平补平泻法，针后灸20分钟，未再发

病。同年10月1日随访未复发。

十一、神经衰弱

本病是大脑皮质兴奋和抑制平衡失调引起的一种功能性疾病。属于祖国医学郁症、心悸、不寐、“虚损”、“遗精”范畴。病因很多，病机复杂，多因思虑过度，劳伤心脾；房事不节，肾气亏损；情志不舒，肝气郁滞；心胆气虚，神志不宁；脏腑失调，阳不交阴所致。

主症：

1.肝郁气滞型：情志不畅，烦躁易怒，头痛，脑胀，眩晕不眠，胸胁胀满，逆气叹息，妇女月经不调，舌苔薄白，舌质红，脉弦。

2.肾虚型：阳萎遗精，精神不振，虚烦不眠，头晕耳鸣，腰痠腿软，舌苔薄白，脉沉细。

3.心血不足型：心悸，气短，胆怯，易惊，失眠多梦，四肢无力，舌淡少苔，脉细。

4.脾胃不和型：胃痛腹胀，呃逆厌食，大便失常，时秘时溏，忧思不眠，疲劳健忘，舌苔白腻，脉缓。

5.心肾不交型：头晕，耳鸣，失眠健忘，心悸怔忡，阳萎早泄，腰痛腿软，精神不振，舌尖红，舌苔薄白，脉细数。

治疗：

1.肝郁气滞型：针风池、百会、瞳子髎、合谷、通里、行间用平补平泻法，留针10~20分钟，以疏肝理气，养心安神。

2.肾虚型：针肾俞、关元俞用补法，不留针，百会、关元、复溜用补法，留针10~20分钟，以补肾培元，健脑安神。

3.心血不足型：针百会、印堂、神门用补法，留针10~20分钟，以养血宁心，安神定志。

4.脾胃不和型：针中脘、天枢、足三里、三阴交用平补平泻

法，留针10~20分钟，以调和脾胃，宁心安神。

5.心肾不交型：针百会、心俞、肾俞用平补平泻法，不留针，或针神门、内关、复溜用平补平泻法，留针10~20分钟，以交通心肾，清心安神。

1971年1月在成县医院总结的100例中，有效率为98%，平均2.2次见效。治愈率占22%，平均16.4次治愈。

病案举例：

例一：肝郁气滞型

蒲××，男，27岁，成县县委干部。因眩晕失眠二年，1970年7月20日初诊。

患者1968年2月开始眩晕失眠，逐渐加剧，经中西医治疗效果不显，现在整夜不能入睡，头重似戴钢盔，头痛发胀，有时麻木、眩晕，记忆力减退，烦躁易怒，不能看书、工作。检查：精神郁闷，善叹息，舌质红、苔薄白，脉弦。西医诊断为神经衰弱；中医辨证系肝郁气滞、肝阳上亢；采用疏肝解郁、理气安神之法治之。取风池、百会、瞳子髎、神门、太冲，用平补平泻法，留针20分钟，治疗至8月12日，针达十次时，头痛发胀和眩晕失眠减轻；治疗至9月10日，针达二十次时，症状基本消失，每夜能睡八小时，头脑清楚，记忆力明显增强；治疗至10月10日，针达三十四次时，症状完全消失，即恢复了工作。1971年3月随访，情况良好。

例二：肾虚型

巩××，男，25岁，四川省新都县××部队司令部战士。因阳痿和失眠一年多，1972年3月16日初诊。

患者1970年12月因工作紧张，出现腰痠腿软、遗精，在成都住院诊断为神经衰弱，治疗后，又出现精神过敏，最近又出现头痛、头晕、耳鸣、记忆力减退、视物模糊、失眠、精神紧张、阳痿遗精加剧，而来我院。检查：面色晦暗，精神不振，舌苔薄

白，脉沉细。中医辨证系房劳过度、肾元虚损，采用补肾培元、健脑安神之法治之。取风池、百会、印堂，用平补平泻法；肾俞、关元、三阴交，用补法，留针10分钟，治疗到3月30日，针达十次时，腰痠腿软和头痛失眠减轻；治疗到4月28日，头晕耳鸣、遗精阳萎等症基本消失。回籍恢复了工作。同年8月30日随访无复发。

例三：心肾不交型

雷××，男，32岁，武都军分区干部。因头晕失眠、阳萎早泄二年余，1970年5月19日来院治疗。

患者1967年11月开始遗精早泄，后又出现头痛、口渴、食欲减退，症状逐渐加剧，在当地医院诊断为神经衰弱，经过治疗有些好转。1968年6月身体逐渐消瘦，1969年1月又出现胸闷、心慌、失眠、健忘、耳鸣、阳萎、腰痠痛，下肢痿软无力。检查：精神不振，面黄干瘦，舌尖红、苔薄白，脉细稍数。中医辨证系肾气不足、不能上交于心，采用补肾培元、宁心安神之法治之。取风池、百会、肾俞、关元俞、神门、复溜，用补法，留针20分钟，针治五次时，头脑清楚，腰腿痿软减轻，则加中脘、天枢、关元、三阴交，用补法，和上穴交替使用，治疗至6月19日，针达二十次时，遗精阳萎、心慌、头痛、失眠健忘等症，基本消失，即回籍恢复了工作，1971年5月30日随访完全恢复了正常。

例四：心血不足型

贺××，男，22岁，康县林厂干部。因头痛失眠反复发作四年，1970年11月27日初诊。

患者1966年开始头痛、失眠、多梦、有时整夜不能入睡、记忆力减退。近来又出现心慌、气短、胆怯害怕、惊恐不安、经常感冒头晕、头脑闷胀、不清醒、四肢无力，症状逐渐加剧，不能工作。检查：痛苦面容，面色晦暗，无光泽，舌质淡、苔薄白，脉滑细，78次/分，血压140/70mmHg，心肺（-），腹软，肝脾未触及，胸部膻中穴处、腹部中脘穴处有明显压痛。西医诊断

为神经衰弱；中医辨证系思虑过度，心血不足，采用养血宁心、健脑安神之法治之。取风池、百会、印堂、神门，用补法，留针20分钟，每日针一次，针治三次时，头痛减轻，针治五次时，留针时间能入睡，头即不痛、心慌、气短减轻。治疗至12月12日，针达十二次时症状基本消失，患者每夜能睡6—8小时，头已不痛，饮食增加，精神恢复正常而停诊。回原籍工作。1971年4月20日患者来信说“上班后一直很好。”

十二、癔病

本病是常由明显精神因素引起的一种急性神经官能症。属于祖国医学郁症、脏躁范畴。多发于青年，且女性较多。常因怒气伤肝、或情志不遂所致。

主症：

1.精神方面：哭笑无常，乱说乱唱，乱跑乱骂，手舞足蹈，可持续数小时至数天，发作后如正常人，一般对发作情况尚有记忆，或情志抑郁，闷闷不乐，恐惧多疑，表情淡漠。

2.运动方面：常见的有失音不语，肢体痉挛性或弛缓性瘫痪，但无神经系统病理体征。

3.感觉方面：感觉消失，或减退或过敏，但不符合解剖学神经分布，或突然耳聋，失明。

治疗：

1.精神失常：针人中、神庭、百会、合谷、内关、中脘、巨阙、风池、丰隆用泻法，留针20~30分钟，以宁心醒神。妇女月经前后发病加针太冲、三阴交，以疏肝解郁。

2.肢体感觉异常或瘫痪：针曲池、合谷、外关、环跳、阳陵泉、足三里、人中用平补平泻法，以疏通气机。

3.失语：针百会、哑门、合谷用平补平泻法，以开窍解语。

4.耳聋：针百会、听宫用平补平泻法，以开窍聪耳。

5.失明：针风池、攒竹、太阳用平补平泻法，以开窍明目。

1972年10月在成县医院总结的50例中，有效率为98%，平均1.2次见效，治愈率为70%，平均9.8次治愈。情志兴奋的见效快而治愈率高；情志抑郁的疗效差而治愈率低。

病案举例：

例一：精神失常型

李××，女，29岁，北京万寿寺后身21号干部。因精神失常反复发作三年，1961年10月8日急诊。

其丈夫代诉：患者三年前因生气患过精神病，曾在清华园、青龙桥×医院诊断为“精神分裂症”，经治疗暂时有些效果，以后每当生气就发病。昨天晚上因生气，突然发病，先出现表情淡漠、闷闷不乐，后又语言增多、情绪激动，阵发性哭闹、憋气、全身抽搐、恶心、欲吐不出。检查：面色苍白、妄动不安，胡言乱语、哭闹、两目直视、脉沉弦，68次/分，两胸廓对称，颈部无强直，心肺（-），肝脾未触及。西医诊断为癔病；中医辨证系心气久郁、肝风内动；采用平肝熄风、宁心安神之法治之。取1、人中（使其流泪）、承浆、大陵、内关、行间、涌泉，在发作时用平补平泻法，不留针；2、巨阙、中脘、内关、三阴交，用平补平泻法，在神志清醒时留针20分钟。两组穴位交替轮换使用，每日针一次，第二日复诊时仍反复发作；针治二次后，症状逐渐减轻。治疗至10月14日，针达六次时，症状消失，状如常人而停诊。1962年3月3日随访未复发。

例二：血虚生风型

余××，女，37岁，徽县武装部干部家属。因哭笑无常反复发作十年，1970年6月25日初诊。

其丈夫代诉：患者1960年开始月经期小腹痛、月经量多、持续时间长，腹痛甚时患者常哭一阵、笑一阵，发病重时不明事理、随意离家出走，今年又出现头痛，头痛则发病。检查：面色

晦暗、无光泽，答非所问，语言支离，时哭时笑，两目直视、舌苔薄白，脉沉细稍弦，76次/分。颈部无强直，心肺（-），腹软，肝脾未触及。西医诊断为癔病；中医辨证系肝郁气滞、血虚生风；采用舒肝理气、养血熄风之法治之。取风池、百会、印堂、合谷、太冲，用平补平泻法，留针20分钟，每日针一次，针治三次时，精神好转，头痛减轻；治疗至6月30日，针达五次时，神志基本恢复，头痛消失。改针中脘、天枢、气海、三阴交，用平补平泻法，留针20分钟，治疗至7月3日，针达八次时，头痛、腹痛消失，精神恢复正常，治愈回籍。同年12月2日随访未复发。

例三：疯狂型

郑××，男，18岁，支旗北山农民。因精神失常半月，1971年11月10日初诊。

其父代诉：患者半月前，因有人逼迫要用患者的住房，想不开，一夜未入睡，自言自语，不知说些什么，第二天开始打人骂人，不视亲疏，街头乱跑，胡言乱语，力大，跑速很快，经常几个人才能将其捆绑回家；不知饮食，有时乱吃。检查：六人捆来，怒气面容，不视亲疏，暴跳、乱打人，胡言乱语，两眼发红、直视，不合作，不张口，未看舌苔，脉弦滑，余未查。西医诊断为癔病；中医辨证系怒气伤肝、风痰上扰神明；采用祛风降逆、豁痰醒神之法治之。取1、风池、风府、百会、神庭、合谷；2、人中（使其流泪）、内关、中脘、丰隆；用白虎摇头法，不留针，两组穴位交替轮换使用，每日针一次，治疗至11月15日，针达五次时，即不乱跑、乱说，精神好转。改为隔日针一次，治疗至12月14日，针达二十次时，面色、眼神及精神恢复正常，睡眠良好，舌苔薄白，脉缓，治愈停诊。1972年4月20日随访未复发。

例四：痰阻失语型

蒋××，女，31岁，北京东直门外西中街55号家属。因神昏不语两天，1954年5月6日急诊。

其丈夫代诉：患者于本月四日下午1时，气恼过甚，昏倒街道，牙关紧闭，口眼歪斜，不省人事，当即抬至×诊所注射强心剂无效，又送至北京×医院注射葡萄糖等仍无效，水米不下已三天。检查：患者两手扞胸，哆口，以手指喉，口流粘液尺许，两目直视，举手作欲语状，但不能出声，舌已缩至喉间，舌尖向下弯，仅看到一横指许，四肢厥冷、不能动转，全身知觉消失，喉中痰声如锯，不能下咽、亦不能吐出，两手脉搏皆无，面色青紫、眼球凸出，瞳孔散大，用强光直射，不能反应，反应完全消失。西医诊断为癔病，中医辨证系怒气伤肝、肝风内动、风痰上扰、阻塞清窍，采用涌吐顽痰、祛风开窍之法急救；先取傍廉泉，用导痰法（以拇指食指紧切左右两穴，候至患者作呕时，点刺右穴。欲使其激起内脏反射作用上涌作呕；经刺右廉泉穴后，患者作呕，但未吐出粘液，复刺左穴，患者呕力很大，但喉中堵塞，仍未吐出，让患者休息5分钟，再点刺天突穴，同时切紧左右廉泉；患者努力作呕，粘液流出很多，但仍不能大量吐出，急将患者猛力扶起，先以两手用力撑肋，复以右手拇指食指努力切紧肾俞穴，始吐出大量痰液。）再让患者休息10分钟，又点刺风池、哑门，针时让患者喊“一、二”，欲使其舌上翘发音。复泻合谷、少商，针后患者即张口想言，唯音哑喉干，不能出声，以手指喉作式，又指小腹，体会其意：喉间所堵之物已下降。此时患者瞳孔即恢复正常，向大夫点头欲笑，似表示谢意。急救脱险后，赵宪义感激涕零地说：“我是大车工人，患者是我爱人，营口人，她病后我的母亲也晕倒在床，两天水米不下，还有四岁的小孩，你们不独救了她的性命，而且救了我们一家人的性命。”5月7日复诊，又点刺风池、哑门、中脘、气海，患者当即说话，自述胸腹通畅，四肢运动自如，查其脉搏已转为正常，唯逆

气打嗝，有时气闭，饮食咽物发堵。5月8日三诊，又点刺肩井、照海而治愈。为了观察疗效，于5月10日、11日、15日又针治三次，情况良好，已恢复正常。1955年1月20日随访未复发。

例五：失明型

刘××，女，35岁，康县永太小学教员。因双目失明三天，1970年7月20日初诊。

其丈夫代诉：患者1961年开始头痛、头晕，1962年出现视物模糊，1969年月经不正常，1969年9月因晚上看到一个司机死亡，精神紧张，开始时哭时笑，语言支离，性情急躁，自言自语，“心里难受”、出家外跑、晚上不能入睡，发病四十多天，今年2月去天坛医院诊断为癔病，治疗两个多月有些好转。回单位工作一个多月，因又看见吊死了人，再次发病，病情逐渐加剧，经常离家外跑，有时昏倒，三天前突然双目失明，两手胡摸，胡言乱语，时哭时笑，不能入睡，而来院治疗。检查：面色晦暗，烦躁不安、悲啼欲哭，两目直视无光，舌质红、舌苔薄白，脉弦细。两胸对称，颈部无强直。心肺（-），腹软，肝脾未触及。眼科检查：视力，左、右均为眼前手动；眼底，未发现明显异常。西医诊断为癔病；中医辨证系肝郁气滞，惊恐伤神，精血不能上营于目。采用舒肝理气、宁心安神、活血明目之法治之。取风池，用平补平泻法，不留针；百会、人中、瞳子髎、内关、三阴交，用平补平泻法，留针20分钟；每日针一次，针治三次时，患者精神好转，夜晚已能入睡，针治五次时，不用人扶，患者同其丈夫能走来门诊，精神、情绪恢复正常，视力恢复到右0.5，左0.6，治疗至7月31日，针达十次时，患者自己能走来门诊，状如常人，视力恢复到右0.8，左1.0，治愈停诊。同年12月2日随访未复发。

例六：截瘫型

肖××，女，40岁，成县城关供销社干部。因时哭时笑反复

发作七年，下肢不能站立三天，1977年4月23日初诊。

其丈夫代诉：患者1970年5月出现生气后哭一阵笑一阵，不能入睡，经县医院注射镇静剂和服安眠药后2—3天即愈。但以后生气就发病，一年发病2—3次。今日早晨生气后发病，哭一阵笑一阵，一天没吃东西，撕毁自己的衣服，看见或听见别人说话就闹，烦躁不安，不吃不喝，一直卧床。检查：面色晦暗、无光泽，两眼直视、时哭时笑，烦躁不安，舌净无苔，舌质红，脉弦，80次/分，腹部膨胀如鼓，下肢僵直，不能站立、卧床不起。西医诊断为癔病性截瘫；中医辨证系肝风内动、上扰神明，气血郁滞、经络不畅。采用舒肝解郁、熄风安神、理气活血，通经活络之法治之；取肝俞、人中（使其流泪）、合谷，用平补平泻法，不留针，针后稍微清醒，即饮水两茶杯。第二天复诊，患者神志已清楚，自诉全身酸痛无力，而腿不能站立。改针1、关元俞、秩边、阳陵泉；2，肾俞、秩边、足三里；用平补平泻法，留针10分钟，两组穴位交替轮换使用。针治三次时，起针后患者能扶墙站立，但右腿无力，站立不稳；治疗至4月27日，针达五次时，起针后患者能扶杖步行；治疗至4月29日，针达七次时，症状完全消失，上下肢活动自如，生活能自理而停诊。同年8月3日随访完全恢复正常，早已上班。

例七：偏瘫型

刘××，女，18岁，成县园林局工人。因左半身动作困难，1970年5月18日初诊。

患者一年前因父母包办婚姻，生气后发现左上肢拘急不能伸开、不能活动，左下肢无力、走路困难，勉强走路也须扶杖跛行。检查：神志清楚、面色晦暗、舌质红、苔薄白，脉弦滑，80次/分，左上臂肌肉松弛、肩关节不能自主活动，肘、腕、指等关节拘急、呈铁钩状僵硬，不能搬开，不能伸展，肘关节以下至手指皮肤发紫、发僵、肌肉萎缩，下肢皮肤和肌肉尚佳，但走路

跛行。西医诊断为癔性偏瘫；中医辨证系肝郁生风、阻塞经络，采用平肝熄风、疏筋利节之法治之。取人中（使其流泪）、肩髃、曲池、外关、合谷、阳陵泉，用平补平泻法，留针20分钟，每日针一次，治疗至5月27日，针治九次时，肘、腕关节能伸直，手指能伸直且能稍微屈曲。改为隔日针一次，治疗至7月22日，针达二十次时，臂能抬与肩平，手能握物，走路跛行已不明显。治疗至8月15日针达三十次时，上下肢活动已恢复正常，即回单位工作。经同年10月1日、1971年10月1日、1973年1月3日多次随访，未复发，情况良好。

十三、癲 病

本病多由遗传，先天性脑畸形，脑病，脑外伤等引起的一种突发性短暂的大脑功能失调。属于祖国医学痫症范畴。多因情志抑郁，肝失条达；脾失健运，痰涎内结，风痰上逆，清窍被蒙，久则肾精不足，肝失濡养所致。

主症：

阵发性、间歇性神志昏迷，肢体抽搐或知觉异常或精神失常，多自幼年开始，有时大发作，有时小发作，发作时间不定，小发作每日可数十次，大发作可一日一次，或数月一次，发作时多跌倒在地，四肢强直，头眼偏向一侧，数秒钟后有阵挛性抽搐，面色发绀，两目上视，瞳孔散大，咬破舌唇，喉中痰鸣，口流白沫或血沫，大小便失禁，经数分钟后，抽搐渐渐缓解，呼吸恢复，神志模糊，骚动不安或精神失常，然后进入昏睡状态，约半小时逐渐清醒，醒后对发作毫无记忆。但多出现头痛、头晕及全身疲困等症状。

治疗：

发作时针人中、百会、合谷、行间用泻法，不留针，以熄风醒神。发作后针肝俞、心俞、巨厥、中脘、丰隆、涌泉用平补平

泻法，留针10~20分钟，以熄风化痰，柔肝益肾，防止复发。

1972年5月在成县医院总结的40例中，有效率为97.5%，治愈率为10%。

病案举例：

李××，女，20岁，成县文化馆职工。因经常昏倒抽搐三年，1970年5月15日初诊。

患者1967—1968年之间，因看到其父被打，惊倒跌伤，后常发病抽搐，一个月1—2次，有时大发作或小发作。大发作时，突然昏倒，全身抽搐，四肢肌肉僵直，阵发性抽搐，面色发绀，两目上视、喉中痰鸣、口吐白沫，小便失禁，3—8分钟后抽搐缓解，昏睡10—30分钟逐渐清醒，醒后头昏、全身不适、对发作情形毫无所知；小发作时则突然倒地、面色苍白，手足轻微抽动几次约1分钟即恢复正常。检查：面色苍白，舌质暗红，有瘀斑、苔白腻，脉滑。西医诊断为癫痫；中医辨证系惊恐伤肾、情志久郁、痰涎上逆、清窍被蒙；采用熄风化痰、柔肝益肾、开窍醒神之法治之。取百会、肝俞、腰俞透腰阳关、中脘、丰隆，用平补平泻法，留针20分钟，肾俞，用补法，留针20分钟；每周针治三次，治疗至6月15日，针达十二次时，无发病；治疗至8月20日，针达三十六次时，连续三个月未发病，停诊。经1972年4月15日随访，已上班工作二年，未复发。

十四、脑血管意外

本病包括脑出血、脑血栓形成、脑栓塞。属于祖国医学的中风、卒中、大厥、偏枯范畴。多因气血亏损、心、肝、肾三脏阴阳失调所致。常以情绪激动、饮食失节、饮酒、劳累为其诱因。

主症：

1. 阴虚阳亢型：多见于脑出血。症见突然昏倒，神志恍惚或不清，喉中痰鸣，偏瘫，血压升高，呼吸深而不规则，脉弦有

力，两侧瞳孔不等大或忽大忽小，对光反射迟钝或消失，脑脊液呈血性。昏迷前往往有头痛、呕吐等前驱症状，此症来势迅猛，死亡率颇高。

2. 气虚血瘀型：多见于脑血栓、脑栓塞。症见面黄唇白、头昏目眩，血压升高或不升高、无明显意识障碍或短暂意识障碍，亦可卒然昏倒，偏瘫或单肢瘫痪，偏身感觉障碍，失语，甚则昏迷。脉细涩或弦数，舌质紫、边有瘀斑。

3. 脾肾两虚型：多见于脑血管意外后遗症。症见瘫痪日久，脾肾受损，则患肢萎软发凉、肌肉消瘦，纳差便溏、头昏耳鸣、口角流涎、语言不清、时哭时笑，脉细弱或沉细。

治疗：

1. 阴虚阳亢型：针十二井，点刺放血、丰隆、三阴交，用泻法，留针30分钟，以平肝泻热、祛痰降逆。应全力以赴，予以抢救。

当急性期已过，血压渐趋稳定，遗留头痛、肢体瘫痪、语言失灵等证者，应及时治疗失语和肢体瘫痪。

2. 气虚血瘀型：针风府、风池、百会、上廉泉，用平补平泻法，不留针。十王，点刺出血、曲池、合谷、阳陵泉、足三里，用补法，留针10分钟，以补气活血、化瘀通络、熄风开窍。

3. 脾肾两虚型：针灸上肢先取大椎、大杼、风门，用热补法，不留针，以振奋阳气。再用“接气通经法”从上向下按顺序取穴，使针感传到手足末端，针肩髃、曲池、四渎、外关、合谷。下肢先取肾俞、关元俞、秩边，用热补法，不留针，以补肾培元。再用同样手法针环跳、风市、阳陵泉、足三里、绝骨、三阴交，留针10分钟，或做穴位埋线，以益肾健脾、活血通络。

肘关节拘急配天井、肘髎，手指拘急配三间，膝关节拘急配阳关、曲泉，用平补平泻法，留针20—30分钟，以疏筋利节。肌肉和关节痛，配痛处附近穴位，留针或加灸10—15分钟，以温通

经络。足内翻，配申脉；足外翻，配照海，用补法，以扶正补虚。口喎，配风池，颊车透地仓，用平补平泻法，留针10—20分钟，以散风活络。大便秘结，配天枢、丰隆，用凉泻法，留针10—20分钟，以祛痰通便。舌强不语，配风府、上廉泉，用泻法，不留针，金津、玉液，用速刺法出血，以散血凉血，清热开窍。口角流涎，配翳风、列缺、照海，用平补平泻法，以行气利湿。吞咽困难，配风府、风池，不留针；廉泉、天突、阳溪，用平补平泻法，留针10分钟，以祛风开窍。目闭鼻塞，配上迎香，用速刺法，以取嚏开窍。脉弦面赤，配内关、足三里，用泻法，以开胸降逆、平肝泻火。肩关节下垂，配天宗、肩髃、肩髃、臑会、臂臑，用补法，以升举阳气。手足麻木，配中脘、气海、后溪、申脉，针后加灸10—20分钟，以培本振阳。肌肉萎缩，配萎缩部位施灸10分钟，以温经活络。二便失禁，配气海、关元、腰俞、会阳，针后加灸10—20分钟，以温固下元。

心悸气短，配巨阙、内关，用补法，留针5—10分钟，以养心安神。

1980年5月在成县医院向孟昭敏、刘志安、郑俊朋总结的50例中，治愈者21例，占42%；显效者13例，占26%；进步者15例，占30%；无效者1例，占2%。有效率为98%。

病案举例：

例一：阴虚阳亢型

莫××，女，61岁，成县店村公社农民。因左半身不遂、失语八天，1978年10月16日初诊入院。

患者患高血压病二年余，八天前觉头痛、头晕，一天前在地里剥玉米，站起时即觉头晕而昏倒，不能说话，随即左侧上下肢不能活动，一直昏睡，在医疗站治疗无效而来住院。检查：嗜睡，神志恍惚，语言不清，面红，瞳孔左略大于右，左侧鼻唇沟较右侧浅，伸舌偏向左侧，两肺可闻及痰鸣音，呼吸深快，心尖

部可闻及Ⅱ级收缩期吹风样杂音，心律齐，心率60次/分，主动脉瓣第二音亢进，腹软，肝脾未触及，右侧上下肢能活动，但不灵活，左侧上下肢不能活动，膝腱反射右侧正常，左侧减弱。未引出病理反射，体温36.6℃，血压210/116mmHg，血常规：白细胞总数19,600/立方毫米，中性91%，淋巴9%；脑脊液呈血性。因患者口张不大，未看舌苔，脉弦有力。西医诊断为高血压脑溢血；中医辨证系肝风内动、气血上逆；采用镇肝清火、熄风潜阳之法治之。取太冲为主，配十二井放血、双三阴交、丰隆，用泻法，留针20分钟。西医给吸氧辅助。10月17日二诊，神志清楚，反应迟钝，能说话，但声音低微，能进少量饮食，头痛，左侧上下肢活动不自如，左手握力差，血压190/70mmHg，心率64次/分，舌质淡红，苔黄腻，脉弦。针刺取穴手法同前，加双风池、百会、上廉泉、左曲池、合谷、环跳。治疗至10月20日五诊时，头痛大减，说话清楚，能进饮食，伸舌仍偏向左，两侧瞳孔等大，左鼻唇沟较右侧浅，左侧上肢和下肢能抬起，左手握力仍差，血压150/60mmHg，苔脉同前，停止吸氧。针左肩髃、曲池、外关、合谷、环跳、风市、阳陵泉、足三里、悬钟，用平补平泻法，留针20分钟。治疗至11月6日，又针十二次时，患者头已不痛，精神好转，两侧瞳孔等大，两侧鼻唇沟无明显差异，饮食增加，左手握力增强，能握住别人三指，左手能抬高至头，能步行、但左腿力量较差，迈步时抬不高。血压160/80mmHg，因患者要求即出院。坚持到门诊针灸。配穴、手法同前，针灸十五次后，病情基本恢复、即停诊。12月20日随访，患者恢复健康，左手能抬高过头，握力好，步行端正，能承担家务劳动。

例二：气虚血瘀型

孔××，男，48岁，成县机关干部。因右侧偏瘫、失语两天，1979年4月19日入院。

患者患高血压病已二十年，最高180/120mmHg，1979年4

月17日行走中突然发病，右侧肢体无力，说话不清四次，返家后又频繁发作四次，始终神清，偶有恶心，但无呕吐，每次发作持续时间约几分钟至半小时（阵发性右侧抽动，随发作次数增加而间歇性缩短，持续期延长，病情继续发展至4月18日说话不清、右侧肢体完全不能活动而入院。检查：呼吸24次/分，脉搏84次/分，血压180/120mmHg，甲状腺不大，意识清楚，颈部抵抗（-），克氏征（-），布氏征（-），拉塞格氏征（-），心率80次/分，心律齐，腹软，肝脾未触及；脊柱无压痛畸形。神经系统检查：瞳孔等圆、等大（左右3mm）位置正中，光反射左右良好。眼球运动不受限，感觉正常，眼裂左右相等，鼻唇沟右侧浅，口角右低，发音不清，伸舌不能吐出、偏右，自主运动右侧丧失，肌张力右侧减弱，肌力右侧上下0°，左侧上下V°，指鼻试验（-），快复试验（-），昂白氏征（-），跟膝试验（-）右侧浅感觉减退，腹壁反射左右上（++）、中（++）、下（++），提睾反射左（++）、右（++）、肱二头肌左（++）、右（++）、肱三头肌左（++）、右（++），桡骨膜左（++）、右（++），膝反射左（++）、右（+），踝反射左（++）、右（++），霍夫曼氏征左（-）、右（-），巴彬斯基征左（-），右（+），却道克征左（+）、右（+），高登征左（-）、右（-），欧本海母征左（-）、右（-）。脑电图诊断：正常范围脑电图。血检查：胆固醇217mm/100ml，甘油三酯158mg/100mg， β -脂蛋白366/100mg；尿检：颜色淡黄，反应中性，糖定性阴性，蛋白定性（+ -），检查嗜酸性细胞计数22个/mm³。心电图：窦性心率，心电轴不偏，正常心电图，舌质紫、苔黄厚，脉弦数。西医诊断为脑血栓形成；中医辨证系气虚血瘀，经络受阻；采用活血化瘀、祛风开窍之法治之；取风府、双风池、上廉泉，不留针，右肩髃、曲池、手三里、外关、合谷、环跳、阳陵泉、足三里、悬钟，用平补平泻法，留针10分钟，起

针后右腿即能活动，下地能站。治疗至4月23日，针达三次时，两人架着能走，治疗至5月1日，针达十次时，右侧上下肢能屈伸，扶一人能在屋里走，能说话，手足指（趾）能活动，减肩髃、环跳，加右后溪、行间、丘墟，与前穴交替轮换使用，治疗至6月16日，针达四十次时，语言清楚，上肢能抬举过头，能握拳，走路基本正常，血压140/90mmHg，即求出院。又在门诊继续治疗至7月28日，针达六十次时，治愈停诊。同年10月10日和1980年10月5日两次随访，已恢复了工作。

附记：1986年12月随访，情况良好。

例三：脾肾两虚型

王××，男，54岁，天水地委干部。因右侧偏瘫，吞咽困难二十二天，1979年7月2日在水天×医院会诊抢救。

患者1956年患高血压病，1964年发生脑血管痉挛，1972年发生脑血栓形成，1975年复发，并出现假性球麻痹，于1979年4月9日入院。在治疗过程中，逐渐出现流涎增多，语言不清，口张，伸舌不灵活，吞咽时发呛，情绪易激动，有时无故哭笑，生活不能自理，右侧肢体虽能活动，但不能完成有意识的动作，伸舌偏右，咽后壁反射消失，双眼视网膜交替出血。因进水进食发呛，于6月5日下胃管鼻饲。请甘肃省、兰州市、天水等医院医师会诊，一致认为：患者病情的变化，是由于在脑动脉硬化的基础上，脑血管损害呈弥漫性改变的结果，出现9、10、12三对颅神经麻痹、运动性失语、假性球麻痹，目前尚无有效的西药治疗。检查：体温37.9℃，脉搏104次/分，呼吸24次/分，血压200/120mmHg。神清，发音不清，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，额纹对称，右侧鼻唇沟稍浅，伸舌居中，肺（-），心界向左下扩大，心率104次/分，节律不齐，心尖区可闻及Ⅰ级收缩期吹风样杂音，主动脉瓣区第二音大于肺动脉瓣区第二音，肝脾未触及，生理反射存在，病理反射未引出，四肢肌力尚可，桡动脉

硬化(+)，眼底视网膜血管硬化Ⅰ°—Ⅱ°。患者表情呆痴，有时似哭似笑，口半张，口流粘稠唾液，不能自行吐出。因不能进饮食，鼻中插一胃管已二十二天，右手腕轻度下垂，右臂肌肉轻度萎缩，右侧肢体可以屈伸，但不能做其它的动作；回答问话时只能发出“吁、呀”的声音；舌强挛缩，不能伸出齿外。舌质赤，苔黄厚腻，脉滑数。西医诊断为脑血管意外并发假性球麻痹；中医辨证系痰湿内停，经隧阻塞，清窍受蒙；采用祛痰利湿、疏经开窍之法治之；与主管医师商量后，拔出胃管。给患者喂水后，患者噙在口中，多时不咽，偶有下咽动作时则呛咳不止。先针照海、列缺，留针；后针上廉泉、廉泉、天突，用平补平泻法，不留针；风府、风池、通天、三阴交，用补法，留针10分钟；针时让患者试喝橘子汁，喝了两匙顺利，然后加橘瓣下咽时呛二次，加针右阳溪后，又喝两匙鸡汤炒面糊，均能咽下。下午继续观察患者吞咽情况，发现唾液粘腻而多，吐之不出，咽之不下；针左列缺、翳风，用平补平泻法，唾液稍清，吞咽亦稍好。1日喝稀面糊500ml。7月3日二诊，病情稍有好转，早晨进流食300ml，脉搏80次/分，体温37.℃。先针照海、右列缺、百会、通天、风池、上廉泉、阳溪，手法同前，一日共喝稀面糊1250ml。7月4日三诊，吞咽好转，先针临泣、外关；后针右曲池、合谷、环跳、足三里、悬钟以疏经活络治疗半身不遂，针后可吃面片及花卷（李核大小八块）。从7月5日以后，每日手法和配穴同前，治疗至23日，患者早晨能喝一碗牛奶，吃二个鸡蛋、二块桃酥，中午两碗豆角炒肉面，下午一碗稀饭，一个糖饼、一杯麦乳精，合主食半斤。25日患者早晨下地坐椅子不慎掉地，又出现舌挛缩、语言不清。加针金津、玉液后，舌能伸出唇外，并能上下、左右活动。治疗至7月28日，针达二十五次时，患者能自己端碗进食，每天平均半斤，有时能吃肉馅饺子，自己能到院外散步，血压140/100mmHg，苔薄白，脉滑。此后嘱患

者经常锻炼而停诊观察。同年9月9日和1980年10月20日两次随访，患者每日进食5—7两，右侧上下肢活动自如，能说3—4个字，出院后未复发。

附记：1986年6月15日随访，患者仍坚持锻炼，情况良好。

十五、脑血管意外后遗症

本病是由脑出血，脑血栓形成，脑栓塞与脑血管痉挛引起的一种瘫痪病。属于祖国医学中风、半身不遂、偏枯范畴。多因五志过极，饮食不节，精血亏损，脏腑失调，偶受外因，肝阳暴胀，气血痰火、一并于上，清窍受蒙，经隧不利所致。

主症：

语言蹇涩，口流涎液，嘴眼喎斜，半身不遂，舌苔白腻，脉弦滑，血压升高，划蹯试验阳性。

治疗：

1. 实证：拘急硬瘫，双侧取穴或先健侧取穴（巨刺）。针肩髃、曲池、合谷、环跳、风市、阳陵泉、足三里、绝骨用平补平泻法，留针20~30分钟，以祛风活络，疏筋利节。手指拘急，加配三间用平补平泻法，留针20~30分钟。肌肉和关节痛，加配痛处附近穴位，留针或针后加灸10~15分钟。足内翻，配申脉；足外翻，配照海；用补法，以扶正补虚。口眼歪斜，配风池、颊车用平补平泻法，留针10~20分钟，以散风活络。痰热中阻、大便秘结、减足三里，加天枢、丰隆用透天凉法，留针10~20分钟，以祛痰通便。身热不语，配风府、风池用透天凉法，不留针；

舌强不语，配金津、玉液用速刺法出血，以散血凉血，清热开窍。目闭鼻塞，配上迎香用速刺法，以取嚏开窍。脉弦硬面赤，配内关，足三里用透天凉法，留针20~30分钟，以开胸降逆，平肝泻火。

2. 虚症：弛缓软瘫，患侧取穴或分段取穴或少取穴。

上肢：先取大椎、大杼、风门用烧山火法，不留针，以振奋阳气，再用同样手法针肩髃、臂臑、曲池、外关、合谷。

下肢：先取肾俞、关元俞、秩边用烧山火法，不留针，以补肾培元，再用同样手法针环跳、风市、阳陵泉、足三里、绝骨、申脉以活血通络。

肩关节下垂或臂不能上举，配天宗、肩髃、臑会用同样手法。手足麻木，配后溪、申脉或气海、针后加灸10~20分钟，以培本振阳。肌肉萎缩，在萎缩部位加灸10~20分钟，以温经活络。二便失禁，配腰俞、会阳针后加灸10~20分钟，以温固下元。心悸脉弱，配内关留针5~10分钟，以养心安神。

1964年3月在中医研究院针灸研究所总结的20例中，治愈5例，有效14例，无效1例。见效在10次以内，治愈在21次以上。脑血管痉挛引起的偏瘫效果好；脑出血引起的偏瘫疗效差。

病案举例：

例一：脑血栓形成后遗右侧弛缓性偏瘫

刘××，男，70岁，1962年6月16日初诊。

患者有高血压症已10年。近一年来经常头昏，因3天前喂猪时觉头晕、右半身麻木发软，活动不灵而摔倒，继则语言不清，经当地医院转来我院。检查所见：神清合作，发育营养一般，能勉强起立，不能站立和行走，轻度失语，血压180/130毫米汞柱，双侧瞳孔等大、等圆，光反射佳，右侧眼裂较小，闭眼力量较差，露齿，口角稍向左牵，右侧肢体肌力明显降低，右上肢不能举达下颌，手腕活动迟钝，手指不能伸直，右下肢沉软，髋膝关节活动范围较小，踝以下不能活动，右侧腹壁及提睾反射消失，生理反射不亢进，病理反射除巴彬斯基氏征阳性可疑外，余皆阴性；眼底检查：呈动脉硬化性眼底改变。舌苔白腻，脉弦滑。中医辨证系脾湿多痰，劳累过度，肝阳上亢，痰阻隧道。采用抑肝扶脾，祛风化痰，疏通经络之法治之。取曲池、合谷、阳

陵泉、丰隆、曲泉，健侧用透天凉法，患侧用平补平泻法，留针20分钟，针治2次后，上肢能举至头顶，手指屈伸接近正常，下肢髋、膝关节活动范围扩大；针治4次后，能扶腋杖行走，步态尚稳；第5次针治加金津、玉液、丘墟、申脉、哑门，言语开始清楚，踝以下能活动，右腹壁及提睾反射逐渐出现，血压降至100/110毫米汞柱。为了巩固疗效，又配风府、关元俞、秩边、环跳为主，和前穴加减。治疗达24次时，症状消失，上下肢关节活动基本正常，仅肌力稍差，即出院。

例二：脑出血后遗左侧拘急性偏瘫

冯××，男，58岁，农民。因左侧瘫痪二年，1962年6月30日初诊入院。

患者二年前患脑出血昏迷，在本院治疗清醒后，自己觉得回家休养就会好，可是休息了两年多，没好，又来院治疗。检查：神清合作，发育营养一般，舌苔薄白，脉弦滑，血压220/120mmHg，左上肢拘急，肩关节下塌约一横指，手掌肌萎缩，瞳孔右大于左、光反射存在，面部左侧浅感觉弱于右侧，左侧闭眼力明显减弱，鼻唇沟变浅，露齿则口角明显右牵，伸舌明显左偏，左侧耸肩力量近于消失，左下肢肌力明显减低，左下肢能活动，但卧位时不能举达腹部，腕无自主活动，拇食二指稍能屈曲，余指难活动，不能站立和活动，左侧肢体浅感觉较右侧减退，左侧腹壁反射及提睾反射消失，左侧上下肢生理腱反射较右侧明显亢进，霍夫曼氏、纳久、巴彬斯基、罗索利模氏、戈登氏、恰道克氏等试验皆阳性，踝阵挛阳性；眼底检查：呈动脉硬化性眼底改变。中医辨证系素有痰湿、劳累后痰火内发、痰浊阴邪阻塞孔窍，气血瘀滞、经络不通、筋骨失养；采用祛风利湿、豁痰降逆、疏筋利节之法治之。取双侧内关、足三里，健侧曲池、阳陵泉、合谷，患侧三间，用平补平泻法，留针20分钟，每日针一次，治疗至7月4日，针治四次后，左上肢能举达剑突水平，下肢能扶腋杖及

推车锻炼行走,血压降至190/100mmHg;改针患侧天宗、肩髃、臑会、曲池、三间,健侧环跳、申脉,继续针治六次,患侧手指能完全伸直,膝关节能屈伸,血压降至170/100mmHg;再加肩髃、外关、中渚、阳陵泉、足三里等穴和前穴加减使用,隔日一次,治疗至8月9日,针达二十四次时,上肢能外展25°,上举能保持剑突水平,手指可以完全伸开,膝、踝、趾能屈伸活动,独立行走,血压降至150/98mmHg,显效出院。

十六、面神经麻痹

本病为身体虚弱,面部伤风受凉引起的一种周围性面神经麻痹。属于祖国医学口喎、口僻、口眼歪斜范畴。多因气血虚弱,营卫失调,风寒侵袭经络所致。

主症:

突然一侧眼睑闭合不紧,不能皱眉,一侧抬头纹消失,面肌松弛,鼻唇沟变浅,嘴角歪斜,鼓腮漏气,流口水等。

治疗:

初患四天之内取健侧地仓透颊车、迎香、下关、合谷用泻法,留针20~30分钟。四天以后取患侧针颊车透地仓、四白、太阳、攒竹、下关、合谷、人中、承浆用平补平泻法,留针5~10分钟,以扶正祛邪,疏风活络。

眼睑不能闭合,配风池、头维透颌厌、阳白透丝竹空、攒竹透鱼腰、四白透睛明、太阳、合谷用平补平泻法留针10~20分钟。久治不愈或体弱气虚,配会阳、长强、足三里,用补法或加灸10~20分钟,以益气振阳、养血祛风。接近治愈时,针足三里、内庭、太冲等远隔穴位,以防发生面神经痉挛。

1962年10月在中医研究院西苑医院总结的51例中,均有疗效,治愈率为74.5%,一般1~2次见效,15—20日即愈。

病案举例:

张××，男，22岁，北京大学工人。因口眼歪斜八天，1960年5月12日初诊。

患者5月4日早晨起床时自觉左侧面部发紧，下午发现左眼不能闭合、流泪，嘴角斜向右侧，左侧牙齿不能嚼食物，左侧口腔存留食物，需要用手指掏出，左嘴角闭不严，经常流口水和露出食物。在本单位医务室诊断为面神经麻痹，治疗效果不显，而来我院。检查：左眼上下眼睑不能闭合，露睛一公分，左侧面肌松弛下垂，不能皱眉，左侧抬头纹及鼻唇沟消失，嘴角向右侧歪斜，鼓腮左侧漏气，流口水，舌质淡，苔薄白，脉浮数，80次/分。中医辨证系风寒侵袭，经络瘀阻。采用祛风散寒、疏经活络之法治之。取风池、合谷，用烧山火法，使其出汗，不留针；地仓透颊车、四白透睛明、下关、阳白，用平补平泻法，留针10分钟，每日针一次，针治一次，眼睑能闭合；治疗至5月18日，针达七次时，口眼歪斜明显好转，则改针地仓透颊车、下关、巨髃、合谷，用平补平泻法，留针10分钟，治疗至5月24日，针达十一次时，症状消失，检查恢复正常而停诊。同年9月1日随访，情况良好。

十七、小儿麻痹及后遗症

本病是由病毒引起的一种脊髓前角损害以弛缓性瘫痪为特征的急性传染病。属于祖国医学“痿痹”范畴。多发于夏秋季节，以1~5岁小儿发病率最高，故名小儿麻痹。多因风湿温疫侵袭，五脏受热，津液消耗，肺热叶焦，肝肾亏损，或湿热侵淫，壅滞经脉，气血受阻所致。

主症：

1. 瘫痪期：受累肢体疼痛或发麻，皮肤感觉过敏，并有触痛，热退后肢体一侧或两侧出现松弛无力或瘫痪，腱反射迟钝或消失。
2. 瘫痪后期：肌肉萎缩，肢体发凉，变细，骨关节畸形，甚

至成为终身残废。

治疗：

1. 瘫痪期：

上肢瘫痪：取风门、肩髃、曲池、手三里、外关、合谷。

下肢瘫痪：取关元俞、秩边、环跳、四强、阳陵泉、足三里、三阴交、申脉、照海。

以上配穴按顺序由上而下的针刺“（通经接气法）”用热补法，使热感逐渐传到肢体末端，以温通经络。

2. 瘫痪后期：

下肢变细，发凉无力，足下垂，足外翻，膝反屈，走路困难，取环跳、四强、血海、纠正外翻、纠正下垂、三阴交。

下肢完全瘫痪，不能站，不能走，足内翻，取关元俞、秩边、风市、梁丘、足三里、悬钟、纠正内翻。

上肢细软无力，手腕下垂不能伸，取肩井、肩髃、手三里、外关。

上肢完全瘫痪，肌肉萎缩，取大杼、肩井、肩髃、曲池、四渎、外关、合谷。

腰部弯曲、臀肌萎缩，取肾俞、关元俞、秩边。

以上配穴用穴位埋线或强刺激结扎，以延长刺激时间，加强刺激强度，使经络疏通，气血调和，改善血管神经的营养状态，恢复经络的功能活动。

1973年4月在成县医院总结用针刺治疗瘫痪期的40例中，治愈15例，显效17例，进步8例，总结的用穴位埋线和强刺激结扎治疗瘫痪后期的73例中，有效率为98.6%，平均1.8次见效。治愈率为34.2%，平均7.8次治愈。

病案举例：

例一：瘫痪期。

姚××，女，5岁，成县北街杨家巷37号农民。因两腿不能站四天，1974年8月16日初诊。

患者十天前持续发烧五天后，发现患儿不能站立，不能行走，逐渐加剧。检查：扶着能站，不能抬腿、屈膝，不能迈步，两腿肌肉松软无力，以右侧明显，右膝内侧明显压痛，双膝反射未引出，面黄、苔薄白，脉细数，108次/分。中医辨证系五脏受热、津液消耗，经络失养。采用理气活血、疏通经络之法治之。取双秩边、环跳、四强、血海、足三里、三阴交，用热补法，不留针，针治三次时，腿即能站，压痛消失；治疗至8月28日，针达十次时，患儿走路恢复正常，膝腱反射恢复正常，治愈停诊。11月29日复查情况良好。

例二：瘫痪后期

王××，男，3岁，成县百货公司职工之子。因右腿不能站立一年半，1976年10月28日初诊。

患者1975年5月持续发烧三天后，发现右腿不能站立，不能行走，直至现在右下肢皮肤发凉、变细。检查：右腿不能站，皮肤发凉如冰，膝腱反射消失，右侧臀部和下肢肌肉松软萎缩，膝上梁丘穴处周径左20公分，右18公分，踝上三阴交穴处周径左14公分，右12公分，右膝向后反屈畸形，面黄、苔薄白、脉细缓，80次/分。中医辨证系五脏受热、津液耗损，经络筋肉失养。采用理气活血、温通经络之法治之。取右关元俞、秩边、环跳、阴市、血海、足三里、三阴交，用热补法，针治三次，皮肤温度好转；即取右秩边、四强、血海、足三里、三阴交、埋线。七—十天埋线一次，治疗至12月24日，埋线五次，针治十次时，右腿皮肤温度与健侧对比恢复正常，肌肉萎缩有好转，扶着能走；治疗至1977年4月25日，埋线达十五次，针达二十四次时，肌肉萎缩明显好转，走路恢复正常，膝腱反射恢复正常，治愈停诊。1977年10月29日复查，右腿能单独弹跳三十五次，右下肢萎缩已不明显（膝上梁丘穴处周径左22公分，右21.5公分，踝上三阴交穴处周径左16公分，右15.5公分）。

十八、传染性多发性神经炎

本病可能是由病毒或过敏反应所引起的一种疾病。青年和儿童发病者较高，死亡率也高，死亡原因多为呼吸肌麻痹。属于祖国医学痿痹、痿症范畴。多因肺热叶焦、脾胃湿热、阳虚、肝肾俱虚，津液不化，筋肉失养所致。

主症：

1. 肺热伤阴型：起病急，发烧，肢体瘫痪，呼吸困难，痰涎上涌，无力咯出，小便短赤，大便干，舌苔黄腻，脉细数。

2. 脾胃湿热型：胸脘满闷，肢体瘫痪，或下肢微肿麻木，小便赤涩，舌苔黄腻，脉濡。

3. 肝肾俱虚型：起病慢，腰痛、四肢痿软，肌肉萎缩，头昏目眩、舌红少苔，脉细数。

治疗：

1. 肺热伤阴型：病势危重，发展迅速，应密切观察病情变化，大力抢救，控制病情发展，患者必须卧床休息。取大椎、肺俞、列缺、用泻法；少商，用点刺法出血，一日可针1—4次，以清热养阴，宣通肺气。在治疗过程中要加强护理，保持呼吸道通畅，必要时吸入氧气，补充足够的水份和营养。

2. 脾胃湿热型：取曲池、手三里、足三里、三阴交、用泻法，或梁丘、血海、外关、合谷，用平补平泻法，以清热利湿、健脾助运。

3. 肝肾俱虚型：取肾俞、曲泉、三阴交，用热补法，或关元俞、血海、梁丘、足三里、臂臑、手三里、阿是穴，用穴位埋线，以补肾益肝，疏通经络。

以上三型可互相转化，大部分危重病例起病时表现为肺热伤阴，而经治疗病情稳定后，转为脾胃湿热或肝肾俱虚型；起病较缓的病例，大都表现为后两型，但当治疗失宜，病情加重时，则出现肺热伤阴的症状，所以治疗时应灵活掌握三型的变化。

1985年同孟昭敏、郑俊江、郑俊朋在成县医院治疗、在甘肃中医学院总结的24例中，经过针治2—50次，并经三个月后随访，治愈9例；显效6例，进步7例，死亡2例。

病案举例：

例一：肺热伤阴型

王××，男，18岁，成县立新公社孟坪大队农民。1974年10月16日因四肢瘫痪，咯脓痰十天而来住院。

患者十天前发烧、咳嗽，胸痛，继则口吐痰涎，四肢瘫痪，住某医院诊治，住院九天，诊断为传染性多发性神经炎，经用氢化可的松、青、链霉素、维生素B₁、B₁₂等药物及吸氧、输液各方面治疗，病情继续加重，即以病危而转来我院。检查：嗜睡，体温39℃，颈无抵抗，瞳孔等大，对光反射存在，喉中痰鸣、呼吸微弱，两肺满布中小水泡音和痰鸣音，心音较钝，律齐、心率快，110次/分，未闻及明显杂音，腹柔软，肝脾未触及，四肢瘫痪、不能活动、不能翻身，膝腱反射消失，病理反射未引出，四肢痛觉明显减退，脉细数，舌伸不出，脑脊液无色透明，蛋白阳性，糖1—5管阳性，细胞总数34个/mm³，白细胞4个/mm³，西医诊断为感染性多发性神经炎；中医辨证系肺热叶焦，津液消耗。采用清热养阴、宣通肺气之法治之。取大椎、肺俞、列缺、少商、照海，用点刺法出血，每日二次，治疗至10月17日，喉中痰鸣声消失，痰涎减少；治疗至10月20日，针达五次时，精神好转，无痰涎上涌，呼吸平稳，两肺湿啰音不明显，心音较前有力，律齐、每餐能吃半碗米粥，每日三餐，但自觉腰痛，四肢疲软不能动，头昏发晕，四肢肌肉萎缩，脉弱，舌红少苔，中医辨证为肝肾阴虚、筋骨失养。采用补肾益肝、疏通经络之法治之。取曲池、列缺、合谷、足三里、三阴交、照海，用补法，留针10分钟，每日一次；手三里、关元俞、秩边、血海，做穴位埋线，每7天一次，治疗至10月29日，又针治九次，埋线二

次，患者四肢稍能活动，下肢可屈伸，手能抬高至胸，握力仍差，扶起能坐半小时左右，饮食良好；治疗至11月15日，又针治十六次，埋线二次，患者能自己坐起，并能站立，自己能端碗吃饭，治疗至11月22日，针达三十六次，埋线五次时，患者能下床散步，走路端正，手能抬高过头，握力良好，症状完全消失，检查恢复正常而出院，3月1日随访，一切良好，已参加生产劳动。

例二：脾胃湿热型

易××，女，6岁，成县小川公社人。1979年4月29日因双上肢不能抬举，两下肢不能站立三天而住院。

患儿于4月27日早晨起床时突然跌倒，随后即不能站立，4月28日出现发烧、咳嗽、呼吸急促，手不能上举，在当地卫生院治疗无效，症状逐渐加剧而转我院。检查：患儿体温 39.5°C ，神志清楚，颈无抵抗，瞳孔等大，对光反射灵敏，呼吸表浅、急促，42次/分，两肺满布中小水泡音，心率齐、率快，120次/分，未闻及明显杂音，腹膨胀、软，肝脾未触及。两下肢不能屈伸，痛觉减退，不能翻身，不会坐立，上肢不能抬举，手不能握物，四肢肌力差，四肢远端皮肤温度低，反射明显减弱，巴彬斯基氏征阳性，脉细数，舌尖红，不能伸出口外，血常规：血红蛋白 10g ，白细胞 $146,00/\text{mm}^3$ ，中性76%，淋巴24%；脑脊液常规：无色、透明、蛋白阳性，细胞总数 $30\text{个}/\text{mm}^3$ ，白细胞 $4\text{个}/\text{mm}^3$ ，糖1—5管阳性。西医诊断为感染性多发性神经炎，中医辨证系肺热叶焦、津液消耗。采用清热养阴、宣通肺气之法治之。针大椎、肺俞、列缺、少商、照海，用点刺法出血，每日一次，配合吸氧。治疗至5月2日，患儿病情好转，呼吸平稳，两肺湿啰音明显减少，但四肢仍不能活动，脉濡，舌苔黄腻；中医辨证为脾胃湿热。采用清热利湿、健脾助运、疏通经络之法治之。取曲池、列缺、合谷、足三里、三阴交，照海，用泻法；治疗至5月4日，针治五次时，四肢稍能活动，痛觉明显好转，继

续针刺以上穴位，改用平补平泻法，治疗至5月18日，针达十四次时，上肢能抬高过头，握力良好，两下肢能站立，能自行上厕所，到锅炉去打水等，要求出院。经同年9月1日随访，再未进行任何治疗，上下肢活动自如，能跑、能跳。

例三：肝肾俱虚型

李××，女，12岁，因四肢软弱无力两天，1974年10月12日住院治疗。

患者10月9日白天劳动过累，晚饭时发现手不能拿筷，10日发现下肢疼痛，11日起床时发现坐不稳，腿不能站，手不能上举，握力差，在医疗站治疗无效，症状逐渐加剧而来我院。检查：患者神志清楚，体温37.2℃，颈部无抵抗，瞳孔等大，对光反射灵敏，心肺一般正常。腹部柔软，肝脾不大。感觉障碍和肢体疼痛不明显，手不能握物，上肢不能抬举，不能翻身，不能坐立，下肢不能屈伸，四肢肌力差，四肢远端皮肤温度低，腱反射明显减弱，未引出病理反射。入院当天脑脊液检查：无色透明，蛋白阳性，细胞总数24/立方毫米，白细胞2/立方毫米，糖1—5管阳性。面色苍白，舌尖红，不能伸舌，脉细弱。中医辨证系肺热叶焦、肾阴亏耗、肝失濡养、致成痿痹。采用清热养阴、保肺布津之法治之。取大椎、肺俞、列缺、少商，用点刺法出血。针治二次，病情稳定，则改取列缺、外关、命门、肾俞、关元俞、秩边、血海、足三里、三阴交用平补平泻手法，以保肺养阴，疏通经络。针治9次即能翻身，下肢能屈伸，腿能抬高三寸，即加八邪，针治12次，手即能握物。治疗到同年11月13日，针达22次时，不用手扶即能坐起，并能站1分钟，足趾能屈曲，即改取外关、阴市、足三里、三阴交、作穴位埋线。治疗到同年12月4日，埋线3次时，上肢即能抬举，手能提二斤重物，腿能抬举，并能走路。检查基本正常，即出院。因路途太远，往返不便，停诊3个月未进行治疗，于1975年3月15日来门

诊，检查发现：患者蹲下不能自起，两大腿肌肉明显萎缩变细。则取关元俞、秩边、血海、梁丘作穴位埋线，以补肾培元，调和气血，改善血管神经的营养状态，治疗到1975年9月10日，又埋线24次，症状完全消失，检查恢复正常，即停止治疗。经1975年12月8日及1976年3月10日二次随访，能跑、能跳、能走20里路，体力劳动完全恢复正常。

十九、风湿性关节炎

本病是一种反复发作的，全身性胶原组织变态反应性病变，一般认为与上呼吸道溶血性链球菌感染有关。若以关节受累为著，则称风湿性关节炎。属于祖国医学痹症、历节风范畴。多因身体虚弱，风寒湿侵袭所致。

主症：

关节痠痛呈游走性，或关节周围呈红肿热痛的炎症表现，但不化脓，常反复发作。

治疗：

- 1.肩关节炎：针肩井、肩髃、肩髃。曲池。
- 2.肘关节炎：针曲池、天井、手三里。
- 3.腕关节炎：针外关、阳池、阳溪、合谷。
- 4.指关节炎：针外关、中渚、八邪、后溪。
- 5.髌关节炎：针秩边、环跳、关元俞、风市。
- 6.膝关节炎：针梁丘、血海、膝眼、阳陵泉、足三里。
- 7.踝关节炎：针悬钟、昆仑、解溪、丘墟。
- 8.趾关节炎：针申脉、足临泣、公孙、八风。
- 9.四肢串痛：针曲池、合谷、阳陵泉、足三里。
- 10.全身串痛：针风池、大椎、肝俞、关元俞、申脉。

以上配穴可根据病情加减。膝窝痛、配委中。单一关节红肿、剧痛，配阿是穴用平补平泻法，留针20~30分钟，以疏散风

热。关节肿胀，积水剧痛，活动困难，配阿是穴，用烧山火法，以温阳利湿，活血止痛。

1962年在中医研究院西苑医院总结的318例中，有效率为92.1%，治愈率占25.8%，针刺感应快的和针灸并用的疗效好，针刺感应迟和不留针的疗效差。

病案举例：

例一：王××，男，54岁，中央党校干部。因全身关节串痛四年，1961年4月15日初诊。

患者居住房屋沿河潮湿，1957年开始发现左腕关节红肿痠痛，红肿消失后，继之左侧肩臂麻木痠痛，每遇风雨天气痠痛加重；1961年1—2月间左侧肢体之大关节有游走性疼痛，逐渐加剧，近十几天来，右膝关节疼痛严重，行走、上楼均感困难，经天津×医院诊断为风湿性关节炎，曾用中、西药物、电疗、理疗等治疗效果不显而来我院诊治。检查：膝关节无红肿，内外膝眼周围有较明显压痛，活动范围正常，但活动时疼痛明显，腰骶部左侧胞肓、秩边和肩部的天髎、肩髃等穴处有明显压痛，心、肺、肝、脾未见异常，膝腱反射存在，血常规正常，康克氏反应阴性，舌质红、苔薄白，脉沉弦。中医辨证系正气虚弱、风寒湿侵袭经络，留于关节，以风气偏胜。采用驱风散寒、疏通经络之法治之。取左胞肓、环跳、右风市、阳陵泉、足三里，针治六次，髌，膝关节疼痛基本消失，能上楼梯，并能骑自行车走5—6里；加取大椎、风门、膏肓、肩髃、与上述穴位轮换使用，治疗至6月1日，针达十次时，全身关节痛完全消失，回籍工作。

例二：仲××，男，39岁，住德外公德林13号。因腰膝痛反复发作十四年，1957年12月11日初诊。

患者十四年前在战争期间，掉到冷水中一次，期后左腿便开始疼痛，当时经打针吃药而缓解。1956年5月左腿疼痛复发，先是从胯部（当环跳穴附近）出现疼痛，继而向下内侧放散，直达

膝上部内侧，呈针刺样疼痛，当年经针灸治疗而疼痛消失。1957年12月7日，无任何诱因，左下肢疼痛又复发。此次是先由膝部开始疼痛，继而向上放散至大腿内侧及腰骶部，翻身、蹲坐、起立皆感困难。经×医院诊断为“腰骶神经根炎”、风湿性关节炎。因治疗效果不显而来我院诊治。检查：形盛气壮，面色润泽，舌苔薄白、脉弦紧。左下肢行路困难，血压146/100mmHg，其他无异常所见。中医辨证系风寒侵袭、气血滞结关节。采用驱除风寒、疏筋利节之法治之。取肾俞、关元俞、膀胱俞、中膂俞、胞育，用烧山火法，不留针；针治一次，即能由床上下地行走。12月12日复诊，取大肠俞、次髎、中髎、白环俞、秩边，与上述穴位轮换交替使用，用烧山火法，每日针一次，治疗至12月19日，针治八次时，血压降到120/70mmHg，左腿痛基本消失，仅晚上还感腰腿痛。则改取次髎、中髎、膀胱俞、承筋、委中，针达二十一次时，疼痛完全消失，患者做翻身、蹲坐、起立等活动时已无不舒感觉；为了巩固疗效，又针肝俞、肾俞、中髎等穴三次，治愈停诊。

例三：程××，男，37岁，第一机械工业部船舶局干部。因足，膝关节疼痛五年，1957年11月18日初诊。

患者1952年开始两脚掌发凉疼痛。疼痛与走路关系不大，走路和休息均感困难，且休息后尚感足底部疲乏，但用热水浸泡或走小石子道路时则疼痛减轻，故每日晚间常用热水浸泡两足。此外，在工作特别紧张之际（如听报告或作报告时）也常不觉疼痛。当年曾在大连×医院诊断为“神经性疼痛”。1954年两膝关节疼痛，每遇天凉或气候改变，皆感疼痛加剧，遇热则感有些减轻，但两足底部疼痛仍无改变，即来北京，经市×医院诊断为风湿性关节炎。因治疗效果不显，而来我院诊治。检查：舌苔白腻，脉沉紧，两膝部外形正常，无红、肿、胀、热等异常改变，但梁丘、血海等处扪之略感疼痛；两足部外形亦无异常改变，足

底与常人相同，非扁平足型，扪之不痛，且反略感舒适，其他无异常所见。中医辨证系肾气不足、风寒湿侵袭，以寒气偏盛，痹结于膝。采用驱风散寒，利湿止痛之法治之。取梁丘、犊鼻、足三里、阳陵泉、血海，用烧山火法，使痠、胀、热感达到膝关节和足部，留针20—30分钟；治疗至11月30日，针达十一次时，膝关节痛和足底凉痛基本消失，每晚已不用热水浸泡。停诊休息一周，12月9日复诊，因遇到天气变化、劳累又感膝部和腰部痠痛。又按上述穴位，加配肾俞、关元俞、胞育，用烧山火法，使腰部有温热感，治疗至1958年2月11日，针达三十六次时，治愈停诊。

二十、脊 椎 炎

本病是一种慢性进行性关节疾患。属于祖国医学腰痛范畴。多因正气不足，风、寒、湿三气乘虚而入所致。

主症：

脊椎和腰背部痠痛，肌肉萎缩、压痛、脊椎强直性畸形，运动障碍。

治疗：

1. 颈椎：针天柱、风池、大椎、大杼、风门。
2. 胸椎：针大椎、身柱、大杼、风门、心俞、至阳、膈俞、肝俞、脊中。
3. 腰椎：针命门、肾俞、关元俞。
4. 骶椎：针关元俞、腰阳关、膀胱俞、八髎、腰俞、秩边、环跳。

以上穴位用热补法，不留针，以补益肝肾、祛风散寒，通利关节，活血止痛。

1956年在中医研究院针灸研究所总结的33例中，有效率为93.9%，治愈率占42.4%。早期的疗效好，晚期脊柱强直的疗效

差。

病案举例：

例一：朱××，男，41岁，河北省人，司药。因腰腿痛二年，1953年10月16日初诊。

患者1951年5月开始腰痛和左腿痛，至1952年症状逐渐加重，1952年12月至1953年10月曾在协和医院脑系科和骨科检查，X线拍片六、七次，诊断为腰骶椎关节炎，坐骨神经痛。曾服用水杨酸钠、维他命，并作过组织疗法、烤电，电离子透入法，经过长时间用各种疗法治疗，仍感腰腿痠痛，不能弯腰，不能蹲坐，站着大便，已二年之久，特别是阴天变天，疼痛更加剧烈，而来我所诊治。检查：身体瘦弱、舌质淡、舌苔薄白、脉沉紧，72次/分，血压120/78mmHg，心、肺、肝、脾未见异常，第二腰椎至第二骶椎稍肿、不红、压痛，左臀部肌肉肥大，右臀部肌肉萎缩。中医辨证系肾气素虚、风寒湿侵袭。采用补肾强腰、祛风散寒、通利关节之法治之。取脊中、命门、肾俞、关元俞、膀胱俞、秩边，用进火补法，每日一次，针治五次时，疼痛减轻，即能蹲坐，解除了大便时的痛苦。治疗至两个月，针达四十次时，疼痛基本消失，能弯腰和蹲坐，开始上班工作。以后每周针一、二次，一方面治疗，一方面观察，共观察七个月，又针二十次，共针六十次，即恢复了健康。同时臀部肌肉逐渐恢复了正常。1955年12月3日X线拍片情况良好，未发现病变。

例二：张××，男，38岁，河南人，干部。因腰脊椎疼痛十年，1954年2月17日初诊。

患者1943年全身关节痛，尤以腰部脊椎部为甚，卧床一年多未起，疗养三年症状减轻，但时好时坏，已十年之久。1953年症状复发，比前加重，主要是腰部痠痛，两腿无力，有时自行摆动，经常心跳不匀、头痛失眠、疲乏无力，右侧腰部肌肉萎缩，经湖南湘雅医院诊断为风湿性关节炎，认为在潮湿地区无法治

愈，须转干燥地区长期疗养。于是来京住协和医院，各科大夫进行会诊，前后X线拍片近20张，诊断为腰骶部关节炎。曾经内服药和各种疗法，并去北戴河疗养，对头痛、心跳有效，腰骶部疼痛和腿痛等症状无明显改变。近来整个脊椎痠痛，尤以腰部为甚，痠困、疲劳；两腿痠痛无力，疲劳时两脚自行擅抖摆动，饮食减少，消化不良，而来我所诊治。检查：面色潮红，舌质淡、苔薄白，脉沉迟，68次/分，血压95/50mmHg，心、肺、肝、脾未见异常。腰骶椎弯曲不平，腰骶部肌肉萎缩，皮肤不润泽呈黄色，弯腰困难。中医辨证系肾气不足、风寒湿侵袭。采用补肾培元、祛风散寒、疏筋利节之法治之。取肝俞、肾俞、关元俞、命门、次髎，用进火补法，治疗二十天，针达十三次时，背部发现片片红点（充血点），皮肤发痒，腰痛即停止。继续治疗到两个月，针达三十九次时，周身疼痛完全消失，遇到天气变化时亦不发生不适感，即开始上班工作。唯因患病太久，身体衰弱过甚，若工作过久，用脑过多时，仍感疲乏腰痠，以后开始每星期针一次，观察至五月底，又针了三次，共计三个半月，共针四十二次，腰骶部肌肉萎缩情形好转，腰部弯转自如，精神体力增加，恢复了健康。为了继续观察，除经常联系外，1955年8月间曾X线拍片一次，未发现病变。据最近联系，仍照常工作，腰部肌肉恢复已接近正常。

二十一、坐骨神经痛

本病是一种症状诊断，分为继发性和原发性两类。绝大部分继发于腰椎间盘突出病变、腰椎关节和骶髂关节病变。属于祖国医学痹症范畴。多因肝肾不足，劳损和风寒湿侵袭所致。

主症：

疼痛自臀部和大腿后面向小腿外侧或后侧至足跟部，翻身、弯腰、蹲坐、走路均感困难。在臀点、委中、承山等穴处有压

痛，直腿抬高试验阳性。

治疗：

针秩边、阿是穴用烧山火法留针10~20分钟，或用腰椎穿刺针作“穴位埋线”，以疏通经络。

风寒湿所致的（天气变化加剧），配胞肓、风市、承山、飞扬用烧山火法，以祛风散寒。劳损所致的（有扭闪跌打损伤或肌肉萎缩、兼见疲劳遗精），配肾俞、关元俞、环跳、阳陵泉用热补法，以补益肝肾，疏筋活血。椎间盘脱出所致的配病变附近穴位，用烧山火法，以活血散瘀。

1964年3月在中医研究院西苑医院总结用烧山火法治疗的57例中，有效率为98.3%，治愈率为31.6%，平均见效为2.7次，治愈为13.3次。1973年2月在成县医院总结用“穴位埋线”治疗的71例中，有效率为98.6%，平均1.1次见效，治愈率为33.8%，平均4.1次治愈。风寒湿和劳损所致的疗效较高，椎间盘脱出所致的疗效较差。

病案举例：

例一：柯××，男，52岁，北京青龙桥六一幼儿园干部。因腰腿痛一月，1962年3月26日初诊。

患者一月前受寒后，右下肢感到发木发胀，休息不能缓解，近三—四天来，右胯部疼痛加剧，不能翻身，因不能弯腿而不能自行脱鞋。检查：腰前屈不足45°，右侧臀部疼痛，后伸和侧弯不受影响，右下肢行走稍跛，脊椎活动范围正常，腰、腹部无红肿，右臀点和居髂、环跳等处有明显压痛，并向大腿放散，拉塞格氏征和直腿上举试验阳性，膝腱反射及深浅感觉未见异常。舌苔淡黄，脉弦，右侧较细。中医辨证系风寒侵袭足太阳经。采用祛风散寒、疏通经络、温筋镇痛之法治之。取右侧秩边、居髂、环跳、风市、飞扬，用烧山火法，留针10—20分钟，隔日一次。针治一次，右胯、腿烧痛不能按，过半日则逐渐消失，针治三

次，压痛点基本消失，活动自如，拉塞格氏征和直腿上举试验阴性，为了巩固疗效，又针治二次，治愈停诊。经六个月后随访未复发。

例二：郑××，男，44岁，解放军装甲兵团干部，因腰腿痛五年，1962年7月6日初诊

患者在20岁时参军，行军作战比较劳累，一直精神体力很差。1957年7月受寒风后，出现左腿痛，经部队×医院诊断为坐骨神经痛，经用电疗、水疗和针灸治疗后即愈。1958年春天复发，又用上述方法治疗，疼痛虽有减轻，但以后左腿外侧知觉迟钝，腿逐渐变细，变软，行走困难，每逢寒冷病情较重，近一周来疼痛加剧，行走、蹲坐，腰腿皆痛。检查：脊椎无畸形，腰部无红肿压痛，腰前屈45°时，左侧臀部疼痛，后伸及侧弯不受影响，左腿肌肉萎缩比右腿明显变细，左侧坐骨大孔处有明显压痛，并向大腿后侧放散，直腿上举试验阳性，舌苔淡黄，脉弦细。中医辨证系肾气素虚，风寒外侵。采用补肾强腰、祛风散寒、疏通经络之法治之。取双肾俞、关元俞、左秩边、飞扬，用烧山火法，不留针；针治二次，疼痛减轻；针治三次时，蹲坐即不痛。则按上述穴位减肾俞，加环跳。阳陵泉，治疗至8月15日，针达十七次时，症状消失，腰腿活动自如，直腿上举试验阴性，仅肌肉萎缩无明显进步而停诊。三个月后随访未复发。

例三，杨××，男，34岁，农民。因左腿痛已一个多月，1972年11月11日来我院就诊。

患者同年10月初突然左臀部和左腿疼痛，不能走路、弯腰。在×卫生所注射青霉素及针灸治疗疼痛未能减轻，每遇阴天下雨病情加剧，不能翻身、蹲坐、迈步，咳嗽、打喷嚏时则引起剧痛。检查：腰不能前弯，抬腿上举试验，拉西格氏征阳性，左胞肓、秩边、委中、承筋、承山等穴处有明显压痛。中医辨证系风寒湿侵袭足太阳膀胱经。采用祛风散寒、疏通经络之法治之。取左侧

胞育、秩边、承筋、承山穴埋线，七天一次。埋线二次后，疼痛基本消失。以后又按上穴减去承筋，继续埋线两次，治愈停诊。12月28日复查恢复正常。1973年1月30日随访未复发。

二十二、腰肌劳损

本病多是急性外伤的后遗症。常见的是由于不适当的过度的软组织劳损，引起肌止点或筋膜、韧带、关节囊和软骨等组织的无菌性炎症而引起疼痛，属于祖国医学的伤筋、腰痛范畴。多因肾虚、劳损和风寒湿外邪侵袭所致。

主症：

1. 新伤型：腰部或臀部疼痛剧烈，活动受限，腰脊肌痉挛，有的放射到下肢，腰不能转侧，腰臀部软组织附近有质软如棉团状的条索状肿物，压痛明显。

2. 陈旧型：腰部或臀部疼痛，时轻时重，有的痠痛、胀痛、锥痛、钝痛、放射性痛，活动受限，脊柱可有侧弯畸形，腰背肌痉挛，腰臀部软组织附近可扪及不同程度的质地稍硬的结节状或条索状肿物，压痛明显。

治疗：

1. 新伤型：取关元俞、志室，用烧山火法，不留针，起针后针手小节，用平补平泻法，留针30分钟，在留针期间3—5分钟，行针一次，边操作边让患者活动腰部，尽量让患者站起来活动腰和下肢，以活血化瘀，疏经止痛。

2. 陈旧型：取志室、肾俞、秩边、阿是，用烧山火法，留针10—20分钟，以补肾培元、理气活血、疏筋利节。

腰肌有硬结、条索状肿物的，在结节、条索状肿物的边缘进针，用烧山火法，以消坚散结。

局部青紫有瘀血的，配膈俞、肝俞，用平补平泻法，以活血化瘀。放射到下肢痛、行动不便的，配秩边、环跳，用平补平泻法，

以疏经止痛。

病案举例：

例一：新伤型

鲁××，女，18岁，北京大学学生。因腰痛，不能转动三天，1962年4月23日住院。

患者三年前因下乡割庄稼二十余天，劳累过度后，即感腰部肌肉痛，伴有左侧膝关节和伸侧肌肉痛，当气候变化或冬季天冷时疼痛加剧，天热较轻，发病后，曾经×医院诊断为腰肌劳损，经中西药物内服、贴膏药和外敷药等长期治疗，疼痛减轻，三天前腰被跌伤，腰痛加剧，不能转动而来住院。检查：腰部左侧有6×5厘米大小的皮肤表面粗糙肿胀，发红有痂皮，左志室穴处皮下可扪及3×12厘米大小的质软如棉团的条索状肿物，压痛明显。第十胸椎至第二腰椎外形呈弓背状向左弯，腰向前弯和左右侧弯活动良好，后伸时感疼痛，1—3腰椎棘突有叩击痛，四肢活动自如。神经系统检查未见异常；X线拍片：胸12椎左侧肋骨较右侧明显变短，诸椎体及附件等未见明显异常。舌苔薄白，脉沉细。西医诊断为腰肌劳损；中医辨证系肾气素虚、劳累过度，损伤经筋。采用补肾振阳、活血化瘀、疏筋止痛之法治之。取肾俞、志室、关元俞，用烧山火法，不留针，起针后取手小节，用平补平泻法，5分钟行针一次，边操作边让患者活动腰部，针后腰痛减轻。隔日针一次，针治三次，腰痛明显减轻，即能活动。加针环跳、阳陵泉，针治九次，腰腿痛消失，腰部肿物渐小，压痛已不明显。则改取肾俞、关元俞、志室，治疗至6月11日，针达二十次时，腰痛和肿物完全消失，各种活动自如。停诊观察十天，6月26日治愈出院。同年9月份接患者来信说未复发。

例二：陈旧型

李××，男，32岁，中央党校工人。因腰痛反复发作十一年，1961年10月29日住院。

患者1950年7月下地干活扭伤腰部，当时腰腿痛不能活动，经过治疗两三个月，才逐渐恢复。但经常一干重活就腰痛。昨天下地采桑叶时，坐在地下休息后，站起来突然感觉腰部剧痛，不能走，当时被二人扶回单位，经医务室注射止痛药，服中西药效果不显，而来住院。检查：体温36℃，舌苔白腻，脉沉迟，60次/分，血压110/70mmHg，精神不振，心、肺（-），腹软，肝脾未触及，腰部活动受限，志室穴处可扪及质地稍硬的似核桃大小的结节状肿物，压痛明显，以左侧为剧。西医诊断为腰肌劳损；中医辨证系肾气素虚、劳累过度、感受寒湿、损伤经筋。采用补肾培元、散寒利湿，消坚散结、疏筋止痛之法治之。取志室、关元俞、阿是穴（结节状肿物的边缘进针至肿物中间），用烧山火法，留针10分钟，每日针一次，针治一次，腰痛减轻，针治三次，腰能活动，肿物渐小，治疗到11月8日，腰痛消失，活动自如，腰部肿物变软、渐小、治愈出院。1962年6月20日随访未复发。

二十三、肩关节周围炎

肩关节周围炎是关节囊和关节周围软组织的一种退行性、炎症性疾病。以50岁左右者为多见。常因扭伤，过劳，风寒湿侵袭所致。属于祖国医学痹症、肩凝症、漏肩风范畴。

主症：

肩部疼痛，日轻夜重，受压痛剧，稍事活动则疼痛减轻。日久粘连，活动受限，不能上举、内收，外展、扳腰。

治疗：

针肩髃、肩髃、天宗、肩贞用热补法或加灸10~20分钟，以活血止痛，通利关节。

肩肱连动，肩缝处有压痛，后伸困难，配肩缝、尺泽、阴陵泉。肩髃处有压痛，上举困难，配肩髃透极泉、曲池、巨骨、条口透承山。天宗处有压痛，内收困难，配肩贞、后溪、申脉。肩

髋处有压痛，外展困难，配臑俞、外关、阳陵泉透阴陵泉。

以上配穴，上肢的针起完后再针下肢穴，针下肢穴时边操作边嘱患者作上举、外展、内收等运动，以锻炼患肩的活动，而提高疗效。

1965年11月在中医研究院针灸研究所总结的81例中，有效率为97.5%，治愈率为24.7%，热补法或针上加灸法效果好，平补平泻法效果差。

病案举例：

例一：徐××，男，50岁，北京索家坟农民。因右胳膊疼痛两个月，1960年5月10日初诊。

患者两个月前在地里干活时，天气太冷，用镐翻土用力过猛，突然右臂疼痛，逐渐加剧，活动困难，夜里疼痛更剧，不能入睡，压着右臂睡觉，经常痛醒，不能提腰带，否则就引起剧痛，而来我院诊治。检查：右臂上举能摸及右耳，肩肱连动，外展不能平肩，内收能摸及胸部，后伸摸脊仅能摸及髂骨，不能弯腰，肩关节周围有压痛，以右肩髃、臂臑穴处压痛最明显。舌质红、苔薄白，脉弦紧。中医辨证系风寒侵袭、经络瘀阻、损伤经筋、瘀血停留。采用祛风散寒、活血通络、疏筋利节之法治之。取肩髃、臂臑、肩髃、曲池，用烧山火法，起针后用同样手法针右条口透承山，留针20分钟，在留针期间边操作边让患者活动患臂。每日针治一次，并嘱患者每日活动患臂。针治二次，右胳膊疼痛减轻，活动范围扩大。治疗至5月20日，针达十次时，疼痛基本消失，患者能下地干活。检查：右臂上举能摸及左耳，外展能平肩，内收能摸及左肩，后伸摸脊能摸脊能摸及第二腰椎，治疗至6月5日，针达二十次时，胳膊痛完全消失，活动恢复正常，后伸摸脊能摸及第9胸椎棘突。治愈停诊。同年10月29日随访，情况良好。

例二：李××，女，55岁，成县西街23号，农民。因左肩臂

痛一个月，1975年5月20日初诊。

患者一个月前因晒被子向上甩时引起左肩臂痛，以后逐渐加剧，经按摩无效。近来左肩臂痛、不能上举，不能向后背手，不能穿、脱衣服，不能梳头，昼轻夜重，不能压着左臂睡觉，否则即痛醒，有时手麻，而来我院诊治。检查：肩肱连动，左臂上举仅能摸及左耳垂，外展 45° 左右，内收能摸及前胸，后伸摸脊仅能摸及臀部，不能扭腰，肩髃、肩髃、臂臑穴处有明显压痛。舌质淡、苔薄白，脉弦。中医辨证系经筋受损、瘀血停留；采用活血化瘀、疏筋利节之法治之。取左肩髃、肩髃、臂臑、天宗穴埋线，5月25日针左巨骨、曲池，用烧山火法，留针10分钟，起针后用同样手法针左条口透承山，留针20分钟，在留针期间边操作边嘱患者活动患臂。埋线和针刺各一次后，肩臂痛减轻，肩关节活动范围扩大。嘱患者每日活动锻炼患臂。治疗至6月27日埋线五次，针治五次后，肩臂痛基本消失，患者能梳头、做饭和洗衣服。检查：左臂上举能摸及右耳，外展能平肩，内收能摸及右肩，后伸摸脊能摸及第十二胸椎棘突。治疗至7月20日埋线八次，针治八次后，肩臂痛完全消失，活动恢复正常而停诊。同年12月10日随访复查未复发。后伸摸脊能摸及第八胸椎棘突。

二十四、单纯性甲状腺肿

本病是由缺碘引起的甲状腺肿大。属于祖国医学瘰疬、瘰癧范畴。多与七情不遂，肝郁不达，脾失健运，气滞痰凝有关。

主症：

甲状腺弥漫性、结节性、混合型肿大，皮肉不变色，无压痛。颈前区逐渐增大，甚至压迫附近器官。

治疗：

取阿是穴用围刺，提插法，轻者不留针，重者留针10~20分钟，以消坚散结。

1972年8月在成县医院总结的60例中，有效率为96.7%，平均2.2次见效。治愈率为33.3%，平均11.4次治愈。病程短、肿物小、质地柔软的疗效好；病程长、肿物大、质地硬的疗效差。

病案举例：

例一：李××，女，32岁，成县百货公司售货员。因颈前部肿大四年，1970年2月15日初诊。

患者于1966年因和邻居生气后颈前部开始肿胀，逐渐增大，现在感到胸闷、有时心慌、心跳，烦躁失眠。检查：发育营养中等，形体较瘦，面色黄，心肺未见异常，甲状腺呈Ⅱ°肿大，有结节，舌苔薄白，脉弦滑，80次/分。西医诊断为地方性甲状腺肿；中医辨证系肝郁不达、气滞痰凝。采用消坚散结、舒肝理气之法之治。取阿是穴（甲状腺肿处），用围刺提插平补平泻法，留针20分钟，每日一次，针治二次时，自觉肿处轻松，见消。则改为每周针治三次，治疗至3月18日，针达十五次时，肿物和结节完全消失，治愈停诊。1972年1月15日随访，情况良好。

例二，田××，女，30岁，成县东街10号。因颈部肿大三年，1970年6月15日初诊。

患者1967年开始颈部起肿物，逐渐增大，经城关医院诊断为甲状腺肿，治疗效果不显，又无时间去医院诊治，现在颈部肿物增大，变硬，有时心慌。检查：甲状腺体呈Ⅱ°肿大，有结节，心情不好，生气时胸中满闷，舌苔薄白，脉弦滑，78次/分。西医诊断为甲状腺肿；中医辨证系肝郁气滞、痰湿凝结。采用舒肝解郁，消坚散结之法治之。取阿是穴用围刺（针在肿物周围向结节中间斜刺）提插平补平泻法，内关用平补平泻法，留针20分钟。每日一次，针治十次时，肿物渐消，结节变软，治疗至7月10日，针达二十次时，症状和肿物完全消失，治愈停诊。同年10月5日随访，情况良好。

二十五、腱鞘炎

本病是由长久的单一运动或过劳损伤引起的一种腱鞘损伤的疾病。多发于手腕部。属于祖国医学伤筋、筋痹范畴。多因劳伤经筋，气血运行不畅所致。

主症：

轻度肿胀、疼痛，皮肤微红，活动受限，影响劳动，若因损伤性炎症引起腱鞘增厚，则手腕部疼痛逐渐加剧，握拳外展时疼痛可向手部或前臂放散，拇指运动无力，在拇指活动时可有摩擦感，扭转运动时常发生啞叭声。

治疗：

在肿处用毫针围刺。

前臂挠侧，配曲池、偏历、列缺、阳溪、合谷。腕部，配外关、阳溪、阳池。

以上配穴用平补平泻法，留针10~20分钟，以疏经活血，消肿止痛。

1972年12月在成县医院总结的24例，均有效果。平均1.1次见效，治愈效为75%，平均4.1次治愈。

病案举例：

马××，女，41岁，成县城关农民。因右胳膊疼痛三天，1970年2月26日初诊。

患者三天前用手剥玉米粒，突然右手和手腕和胳膊疼痛，下午右手腕肿痛，无力拿东西，当时用毛巾热敷，晚上用酒敷，肿痛加剧，不能活动，右拇指发麻无力。检查：右手腕以上至四横指处红肿压痛，以偏历至列缺处红肿压痛最剧，活动受限，扭转活动右腕有明显的啞叭音，舌质胖嫩，舌苔白腻，脉弦滑。西医诊断为桡骨茎突腱鞘炎；中医辨证系劳伤经筋、气血瘀滞。采用疏经活血、消肿止痛之法治之。取曲池、偏历、列缺、阳溪、阿是

穴，用平补平泻法，留针20分钟，每日针一次；针治一次时，肿痛减轻，针治四次，肿痛消失。检查恢复正常，治愈停诊。同年5月1日随访，未复发。

二十六、腱鞘囊肿

腱鞘囊肿是由关节中的腱鞘囊向外膨出引起的一种硬韧的局限性小肿物。属于祖国医学伤筋、筋疣范畴。多因跌打扭挫、损伤经筋所致。

主症：

肿物主要生于关节处，多在手腕背侧，足踝骨前面和足背，状如杏核，大小不一，坚硬光滑，按之不移（有的可以移动），不痛或轻度痠痛，甚则影响劳动。

治疗

患处常规消毒，用三棱针在囊肿顶端刺破皮肤，勿刺透囊肿下层，然后迅速将针拔出，同时以掐持囊肿的手用力掐挤囊肿，挤净囊肿内胶性粘液，用胶布垫消毒棉贴盖针眼。如有复发，4—8天后再用毫针围刺法，在囊肿前后、左右沿皮向中间斜刺4针，留针10—20分钟。

1975年在成县医院同孟昭敏总结的90例中，经一——五次针刺治疗，三个月后随访，治愈78例，显效12例，平均针刺2.3次。

病案举例：

例一、张××，男，25岁，徽县泥阳公社农民。因右手腕背面起囊肿半年，1971年11月18日初诊。

患者两年前扭伤手腕，今年6月右手腕背面起一肿物，逐渐增大，劳动时胀痛，活动受限，不能干活。检查：右腕关节背侧阳池穴处，起一囊肿，杏核大小，坚硬圆滑，推之不移，有轻微压痛。西医诊断为腱鞘囊肿；中医辨证系扭伤经筋、结为筋疣。采用消坚散结，破瘀活血之法治之。用三棱针在肿物顶端刺破皮肤，

然后迅速将针拔出，同时以掐持囊肿的手掐持囊肿，挤出胶性粘液约 1 ml，囊肿即消，局部消毒，垫一消毒棉球，用胶布贴盖针眼。一次即愈。1972年 6 月 10 日随访未复发。

例二，乔××，女，36岁，成县永红小学教员。因右踝前起肿物半年，1970年 7 月 3 日初诊。

患者半年右外踝前起一肿物，逐渐肿大胀痛，走路困难。检查：右外踝前起囊肿，核桃大小，坚硬圆滑、推之不移。中医辨证系损伤经筋、内结痰气；采用破瘀活血、消坚散结之法治之。在囊肿局部常规消毒，用三棱针在囊肿顶端刺破皮肤，迅速将针拔出，同时以手用力掐挤囊肿，挤出胶性粘液约 3 ml，囊肿即消，局部消毒，垫一消毒棉球，用胶布贴盖针眼以防感染。7 月 8 日复诊在囊肿处用毫针前后、左右沿皮向中间斜刺 4 针。留针 20 分钟，针治四次，囊肿完全消失。1970年 10 月 20 日随访未复发。

二十七、创伤性肿痛（软组织损伤）

本病是肌肉、肌腱、韧带等软组织受伤引起的机械性炎症。属于祖国医学跌打损伤范畴。因跌扑闪挫、筋肉受伤，瘀血停留所致。

主症：

局部青紫，红肿，疼痛（无伤口，无骨折）。

治疗：

针阿是（局部）、小节（腰以上针手小节，腰以下的针足小节）。

颈项部：配风池、天柱。

胸胁部：配膻中、膈俞。

腰背部：配肝俞、肾俞。

肩臂部：配肩髃、曲池。

腕以下：配外关、合谷。

腿膝部：配血海、足三里。

踝以下：配悬钟、三阴交。

以上配穴，用平补平泻法，起针后，小节留针20~30分钟，每3~5分钟行针1次，并在行针时让患者活动肿痛部位，以疏经活血，消肿止痛。

1973年2月在成县医院总结的93例中，有效率为97.9%，平均1.1次见效。治愈率为53.8%，平均3.2次治愈。

病案举例：

例一，冯××，男，50岁，成县抛沙乡农民。因右腿摔伤不能动一天，1970年3月13日初诊。

患者3月12日在房上干活，不慎从房上跌下来，右膝盖至脚脖子处摔伤，肿胀疼痛不能活动。检查：右膝关节下方有一处 $6 \times 10 \text{ cm}^2$ ，内踝上方有一处 $3 \times 8 \text{ cm}^2$ 两处青紫、肿胀压痛，以足三里穴处青紫、肿胀压痛最剧，舌苔薄白，脉弦紧。西医诊断为软组织挫伤；中医辨证系跌伤筋肉、瘀血停留。采用疏筋活血、消肿止痛之法治之。针左手小节、双侧血海、足三里、三阴交，右侧点刺出血，左侧用平补平泻法，留针30分钟，留针3—5分钟行针一次，同时边行针、边让患者活动右腿，针后疼痛减轻，即能站立，第二日又针一次，肿痛渐消，即能走路。同年3月26日随访，已参加了劳动。

例二，田××，男，52岁，成县106地质队干部。因两下肢不能活动十四天，1981年1月19日初诊。

患者今年1月6日坐吉普车去天水，途中与大卡车相碰，患者坐在车前的座位上。右侧紧靠车上的一个备用轮胎，碰车时后面的人将患者碰下车座，由于车座变形离位，患者被挤在车座与轮胎之间。患者当时感觉两腿象粘在一起似的，患者就用双手按住两腿向外猛搬，想将两腿分开，移动一下，好站起来，但没能移动，也没站起。直到有人将患者拖下车，扶患者站立，仍不能迈步，只觉得臀部和两腿剧烈疼痛而送天水×医院。经过拍片和各

种检查，未发现骨折，但两下肢仍不能活动，翻身需2—3人帮助才能慢慢翻过，稍微快一点精神就紧张、抽筋、疼痛难忍。有时咳嗽也会引起抽筋，抽筋时疼痛难忍，因此，不敢活动。经过治疗，未见明显好转，而来我院。检查：痛苦病容，面色晦暗、无光泽、舌质红，舌苔薄白，脉象弦紧，大腿前面有两处瘀血斑，屈伸膝关节时可引起剧痛，腰部两侧关元俞穴处、胯部两侧肌腱、大腿前面和外侧肌肉青紫肿胀、僵硬压痛。西医诊断为软组织损伤，中医辨证系外伤经筋、瘀血停留。采用活血化瘀、疏筋利节之法治之。取关元俞、环跳、秩边、阴包、曲泉、阳陵泉，用平补平泻法，留针20分钟。每日针一次，针后疼痛抽筋减轻，即能下地走几步。治疗到1月24日，针达五次时，腰腿痛明显好转，自己能走路，肌肉青紫、肿胀、僵硬、压痛明显好转。治疗到2月2日，针达十二次时，症状完全消失，走路和检查恢复正常而停诊。同年5月4日随访情况良好。

二十八、颈淋巴结结核

本病是由结核杆菌侵入颈淋巴结引起的炎症。可原发或继发于其它结核病。属于祖国医学瘰癧、鼠瘻、痰核范畴。多因忧思郁怒，情志不畅，痰火凝结所致。

主症：

颈部一侧或两侧有一个或多个不同程度肿大的淋巴结，皮色正常，早期较硬，无压痛，孤立而不粘连，以后逐渐扩散，可使邻近的淋巴结融合成块，并与皮肤肌肉粘连，而不能滑动，有的自行破溃，流出稀薄淡黄色脓液，长期不愈。

治疗：

针阿是穴（在肿大的淋巴结周围），用围刺法。曲池沿皮透臂，用泻法留针10—20分钟，以疏经散结。如结核坚硬而大的用缝面肭衣针将粘有砒霜的药线，由结核外面的皮肤进针，穿过结核对

的皮肤将线取出，以攻毒散结。1960年3月在中医研究院针灸研究所总结的15例中，治愈4例，有效9例，效果不明显者2例。早期结核，能活动的疗效佳，晚期结核，融合成块推之不移的疗效差。

病案举例：

王××，女，15岁，北京四中学生。因左颈前肿块二年，1957年4月8日初诊。

患者两年前左颈前起一肿块，近一个月来逐渐增大，有时疼痛，在北京市×医院诊断为颈淋巴结结核，经服异菸肼等药未见好转。检查：左颈锁骨上窝部有2—3个肿块，小指头大小，质地稍硬，皮色正常，舌苔薄白，脉弦滑，76次/分。X线检查：发现第二肋间有片状阴影，印象为左上肺结核。血象检查：血红蛋白9.3g，红细胞346万，白细胞4300，中性72%，淋巴25%，嗜酸3%，血沉14mm/小时。西医诊断为颈淋巴结结核；中医辨证系情志不畅，湿痰凝结颈部。采用疏经活络、消坚散结之法治之；取阿是穴（在肿大的淋巴结周围）用围刺法，曲池沿皮透臂臑，用泻法，留针20分钟，每日一次，针治十次，疼痛减轻，肿块范围缩小为5.5×3.3×1立方厘米，改为每周针三次，治疗至1957年7月9日，针达四十三次时，肿块和疼痛消失，治愈停诊，1958年随访未复发。

二十九、急性淋巴管炎

本病是由化脓性细菌从破损皮肤或粘膜侵入淋巴管引起的急性炎症。属于祖国医学大疔、红丝疔范畴。多因手足疮疡或湿毒流注经脉所致。

主症：

手指或足趾皮肤有破损感染，出现红肿疼痛，继则淋巴管出现一条直行的不规则的红线，从伤口沿手足，很快向近心端蔓延，重者可有恶心呕吐，发热寒战，头痛，全身不适等症。

治疗:

用三棱针先针红丝疔之顶端刺破出血,然后再将红丝疔之起端和中间,点刺出血,俗称截头、断尾、斩中腰,以泻血中毒热。

1972年8月在成县医院治疗5例,均获治愈,平均3.4次。

病案举例:

苏××,男,30岁,成县文化馆干部。因手指肿痛,1970年6月19日初诊。

患者前两天左手拇指起一小白泡,麻木作痒,被雨淋后红肿疼痛,第二天肿痛加剧,痛如锥刺,恶寒发热,从拇指肿处起红线,向肘部走窜。检查:左拇指内侧指甲根处有一小伤口,红肿灼热,从伤口处上方出现一条直行的不规则红线,向上蔓延至肘窝处。精神疲倦,发热寒战,无汗,体温38℃,面晦无华,舌苔薄白,脉弦紧,84次/分。西医诊断为急性淋巴管炎;中医辨证系水邪内侵,湿毒郁结。采用清热利湿,消肿止痛之法治之。先取红丝疔之顶端(尺泽)放血,然后沿红丝疔从上向下孔最、列缺、鱼际和红线的起端,用三棱针点刺出血并点刺至阳、隐白出血。针治一次疼痛减轻,体温降至37℃,每日针治一次,针治三次红线消退,红肿渐消,针治五次,拇指疮面溃破,流出灰黑色毒水,肿痛完全消失,治愈停诊。同年7月1日随访复查,左手拇指脱了一层硬皮,未复发。

三十、腮腺炎(痄腮)

本病是由病毒感染引起的一种急性传染病。属于祖国医学时毒、发颐范畴。多发于冬春季节。常因胃经积热,外感时毒所致。

主症:

恶寒发热,头痛倦怠,腮部一侧或两侧肿胀疼痛灼热,咀嚼、吞咽时疼痛加剧,有的累及颌下腺,舌下腺。舌苔薄白或黄,舌质红,脉浮数。

治疗：

针翳风、颊车、合谷用凉泻法，留针20~30分钟，商阳，少商点刺出血，以疏风清热，消肿止痛。

高热配风池、大椎、曲池、外关用凉泻法，以驱风散邪。

呕吐配中脘、足三里、内关用泻法，以清热降逆。

1965年5月在中医研究院针灸研究所总结的9例中，全部治愈。一般针1次肿痛减轻，3~4次即愈。

病案举例：

樊××，女，17岁，顺义县衙门村农民。因两腮肿痛，1965年2月16日初诊。

患者前两天开始头痛发烧、发冷，昨天发现两腮肿痛，逐渐加剧，现在咀嚼不便、张口困难，不能进食。检查：体温38.9℃，舌红、苔薄白，脉浮数，90次/分，两侧腮腺红肿灼热、有压痛。血常规，白细胞11000，中性60%，淋巴40%。西医诊断为腮腺炎；中医辨证系胃经积热，外感时邪。采用疏风清热、消肿止痛之法治之。针翳风、下关、颊车、合谷，用凉泻法，少商点刺出血；第二日复诊，两腮肿痛减轻，体温降至37℃，按上述方法减去少商、又针治一次，治愈停诊。经同年3月30日和4月20日两次随访未复发。

三十一、闭 经

本病是指卵巢功能紊乱，周期三个月以上不见月经的一种妇女病。属于祖国医学月经不来、女子不月、经闭范畴。多因气血瘀滞，或血源枯竭所致。

主症：

1.虚症：月经逐渐减少而致经闭不通，头晕心悸，少气懒言，疲乏无力，面色苍白，肢冷脉微。

2.实症：胸肋痞满，精神抑郁，恶心嗳气，小腹胀痛，数月

不见月经，面唇发青，舌色暗红，脉弦或涩。

治疗：

针关元、气穴、三阴交。

1.虚症：消化不良，腹胀溏泻属于脾胃虚弱，配中脘、天枢、章门用热补法，以健脾养血。

腰痠腿软，肢冷无力属于肝肾不足，配肝俞、肾俞、关元俞、膀胱俞、气海用热补法，以补益肝肾。

2.实症：心烦急躁，胸胁胀满属于肝郁气滞，配肝俞、膈俞用平补平泻法，以理气活血。

一日一次。10次为一疗程，每疗程后休息3~5天。

1962年1月在中医研究院西苑医院总结的34例中，有效率为73.5%，一般3~8次月经来潮。观察3个月，治愈率为55.9%。在治疗期间并发现多数闭经患者三阴交、膀胱俞、气海、地机等穴处出现压痛点，也常伴着月经的来潮而消失。

病案举例：

例一，解××，女，25岁，未婚，北京工业学院学生。因六个月未来月经，1961年3月9日初诊。

患者15岁月经初潮，一向规律，28天一次，每次持续五天，量中等，色红有块，1959年冬开始不规则，20—45天一次，量少，超前或错后不定。1960年8月30日末次月经后，即未回潮，至今已六个多月，最近一个月来头晕、腰痠、疲倦无力，胸闷气短，有少量白带。一般检查：苔薄白，脉沉细涩，体温36—36.5℃，营养中等，体重87斤，血压140/118mmHg，其它未见异常。妇科检查：宫体后倾偏左，激情素中度低落，其它正常。化验：白细胞8000，中性70%，淋巴29%，单核1%，红细胞435万，血红蛋白12.5g。中医辨证系饮食失调，损及脾胃，冲任失养，无血以行；采用健脾益胃、培补冲任之法治之。取气海、关元、气穴、三阴交、关元俞，用热补法，留针20分钟，每日针治一次，

针治四次，患者感肠鸣腰痠、白带增多，又按上穴针治一次，月经于4月14日即回潮，因只来两天而量少，又按上穴继续针治五次，至4月23日，月经回潮即持续了五天，并且血量和颜色正常，舌苔薄白，脉缓稍细，因症状均已消失而停诊观察，经5—11月份复查、随访，月经正常，未发现症状。

例二：朱××，女，25岁，未婚，北京工业学院学生。因七个月未来月经，1961年3月9日初诊。

患者12岁来月经，有时冬季不来，无其他症状。于1960年8月月经来潮后，至今已七个月，始终未回潮，9月份出现全身疲困，近两个月来经常出汗，每夜盗汗，全身疲乏无力。检查：两颧红，发育良，营养中等，舌净无苔，舌尖稍红，唇干，爪甲枯，脉沉细无力，两侧地机和三阴交穴处有明显压痛，其他未见异常。妇科检查：子宫发育不良，后倾，激情素中度低落，其他正常。中医辨证系先天不足，饮食失调，脾肾两虚，血海空虚。采用健脾补肾、培源养血之法治之。取中脘、天枢、关元、三阴交、肾俞，用热补法，每日一次，针治四次，盗汗、疲乏等症减轻，即改用肾俞、关元俞、气海、关元、三阴交，治疗到十二次，出现了烦躁腹痛，治疗到4月15日，针达十四次时，月经回潮而停诊。经过5月复查和11月随访月经基本正常。

三十二、小儿营养不良症

本病是由营养不足引起的一种儿科疾病。属于祖国医学疳疾范畴。多因饮食不节、喂哺不当，脾失运化，水精不布，或先天不足所致。

主症：

食欲减退，精神不振，面黄发枯，肌肉消瘦，或肚大青筋，皮肤干燥、弹性差，睡眠不安，鼻孔赤痒（喜用指挖鼻），夜惊多哭，抵抗力差，易感染疾病。

治疗：

针中脘、天枢用点刺法，以通调肠胃。

腹泻脱肛，配建里、气海、腰俞、会阳用补法，以补中益气。完谷不化，配足三里用平补平泻法，以健脾调胃，消食导滞。虚热烦躁，配三关穴放血，以清热养阴。吐奶和吐食，配内关，用平补平泻法，以和中止吐。

以上治疗可同时配用捏脊法（三次），以通调肠胃。

1971年在成县医院总结的40例，均有效果，平均1次见效，治愈率为82%，平均6.4次治愈。

病案举例：

王××，男，5岁，成县抛沙乡人。1970年2月14日住院。

患者腹部膨胀、消瘦三年，坐着不欲动，贪食、常在地下拾东西吃，多吃、多泻、大便腥臭，经常盗汗，昨天突然发烧、水泻，1970年2月12日来我院内科住院。住院两天发烧好转，腹泻一直不止，而转来我科。患儿不思饮食，每日绿水样腹泻8—12次，呕吐3—5次，检查：精神萎靡，嗜睡，面色晦黄，两眼窝凹陷，骨瘦如柴，头发稀少，囟门凹陷，小腹膨胀，弹力差，肝在肋下一横指，三关纹紫色，舌苔薄白，脉细数，120次/分。血常规：红细胞278万，血红蛋白7.7克，白细胞5700，中性20%，淋巴79%，嗜酸1%。西医诊断为小儿营养不良；中医辨证系饮食不节、脾失运化。采用健脾益胃、消食导滞之法治之。取1、三关穴放血，中脘、天枢、三阴交，2、建里、气海、腰俞、会阳，用平补平泻法，两组穴位轮换使用，每日针二次；针治二次时，病情好转，一日只泻2次，呕吐一次，治疗至18日，针达十次时，饮食增加、呕吐、腹泻停止，精神好转，腹膨胀减轻，则改为每日针一次，因三关纹已不发紫，减去三关穴放血，治疗至3月14日，针达三十次时，饮食增加，消化良好，检查恢复正常，即出院。同年12月20日随访，患儿发育、营养和大便等一切

正常。

三十三、百 日 咳

本病是由嗜血性百日咳杆菌侵袭人体引起的一种儿童常见的传染病。多发于冬春季节。属于祖国医学疫咳、顿咳、痉咳范畴。多因疫疠之邪从口鼻入肺，肺失肃降，痰浊阻滞气道所致。

主症：

微热出汗，阵发性、痉挛性咳嗽，咳嗽连续不断，咳毕则有一次深长的吸气而发出的特殊回声。一周后逐渐加剧，夜间最明显，吐粘痰或呕吐食物。因咳嗽有时可引起颜面浮肿，结膜充血。病程可延至2~3个月。舌苔薄白，脉浮数。

治疗：

取大椎、陶道、身柱、定喘、肺俞、列缺用平补平泻法，留针10~20分钟，以疏风清肺，止咳化痰。

喉痒，配天突、傍廉泉以润喉降逆。痰多气短，配膻中、丰隆以理气化痰。

1971年4月在成县医院总结的10例中，治愈2例，有效6例，效果不明显者2例。

病案举例：

张×，女，8岁，成县西关小学学生。因阵发性痉咳、伴呕吐已十天，1970年3月15日初诊。

患者1970年3月5日开始咳嗽，晚上发烧，逐渐加剧，每日连续痉咳二十余次，夜间尤甚。痉咳时目赤、涕泪俱下，咳后有鸡鸣样回声，伴有呕吐，面色苍白。检查：颜面浮肿，两眼球结膜有片状出血，舌苔白腻，质红，体温38℃，脉浮滑，80次/分。化验：白细胞1200，中性70%，淋巴30%。西医诊断为百日咳；中医辨证系外感时邪，肺失肃降、痰浊阻滞。采用清肺祛邪、止咳化痰之法治之。取百劳、大椎、陶道、定喘、列缺，用平补平泻

法，留针20分钟，每日一次；针治三次时，发烧消退，咳嗽减轻，体温37℃，治疗至3月25日，针达十次时，治愈停诊。1970年6月1日随访，上学后未再发作。

三十四、急性结膜炎

本病是由细菌、病毒感染或过敏等因引起结膜急性充血，分泌物增多的一种眼科常见病。属于祖国医学目中赤痛、天行赤眼、火眼、红眼范畴。多因风热外侵，肝胆火盛、血热上冲所致。

主症：

眼睛突然红肿，热痛，眵多流泪，不能睁眼，有畏光和异物感，结膜充血、水肿，流脓样分泌物。

治疗：

针风池、太阳、合谷用泻法，上星、攒竹、鱼腰、少商点刺出血，内睛明用压针缓进法，留针10~20分钟，以清热散风，消肿止痛。

1965年5月在中医研究院针灸研究所总结的20例，均有效果。平均1次见效。治愈率为90%，平均2.6次治愈。

病案举例：

郑××，女，8岁，北京市四维小学学生。因右眼红肿疼痛一天，1954年5月3日初诊。

患者前两天上学写字时，右眼突然红肿热痛、眵多、流泪，畏光不能睁开而来我所诊治。检查：球结膜高度充血，流脓样眼眵，舌净质红，脉浮数。中医辨证系风、热相搏，热血上冲于目。采用驱风泻热、消肿止痛之法治之。取上星、攒竹、鱼腰，用点刺法出血，以清热消肿；合谷，用进水泻法，留针20分钟，以驱风泻热。第二日复诊时，症状基本消失，但仍畏光，又针瞳子髎、合谷，用平补平泻法，留针20分钟，第三日即愈。

三十五、近 视

本病是由用眼不当（光线过强或过弱的情况下用眼睛），和遗传引起的一种眼病。属于祖国医学目不能远视、能近怯远症范畴。多因肝肾不足，视物过劳所致。

主症：

只能看清近物，不能看清远物，并易引起眼球疲劳，眼睛痒，眼痛和头痛。戴眼镜矫正后始能看清远物。

治疗：

针风池、攒竹、鱼腰、太阳、承泣透睛明用补法，以益气明目。

体弱血虚，配肝俞、肾俞、光明用补法，以补益肝肾，养阴明目。

每日针一次，10次一个疗程，每疗程后休息3～5天。梅花针叩打后颈、骶部、眼区以活血明目。每日一次，14次为一疗程。

1965年11月在广安门医院总结用针刺治疗的86例，166只眼中，有效率为89.2%，平均2.4次见效。治愈率为10.2%，平均18.9次治愈。刺激神经疗法研究室总结用梅花针治疗的780例，1533只眼中，有效率为82.7%，治愈率为9.3%。

病案举例：

田××，女，15岁，顺义县衙门村农民。因视物模糊不清，1965年1月13日初诊。

患者从8岁开始近视，不能看清远方的东西，近年来，看书时常常要鼻子贴在书本上，看书时间长了眼球胀痛、疲劳、头痛，医院配了三百度近视眼镜，戴上就能看清楚远方的东西，但时间长了就感头晕。检查：矫正前视力左、右均为0.5，矫正后视力左、右均为1.5，舌苔薄白，脉弦细，82次/分。西医诊断为屈光

不正，中医辨证系气血不足、视物过劳。采用益气养血、疏肝明目之法治之。针风池、攒竹、太阳、肝俞，每日一次，针治二次眼即不疲劳，针治十次症状消失，即取掉了三百度的眼镜，治疗至2月12日，针达二十次时，完全恢复正常，治愈停诊。5月15日随访未再戴近视眼镜，视力正常。

三十六、视网膜出血

本病是由外伤、结核病、高血压、贫血、视网膜血行障碍，视网膜静脉周围炎引起的一种眼病。属于祖国医学血灌瞳人、云雾移睛症、暴盲症范畴。多因怒气伤肝，或外伤及其它慢性疾病引起络脉受损，血溢血瘀，睛目被蒙，久则气血障碍，精血不能上荣于目所致。

主症：

一眼或双眼，视物模糊，自觉眼前有黑点、飞蚊、蜘蛛、网样物，甚则失明。眼底静脉周围有程度不等的白色鞘膜和大小不等的点状或片状出血区或因反复出血而结缔组织增生，形成增殖性视网膜炎；如出血较多，且瘀积于网膜前玻璃体内，形成玻璃体混浊，则光线难以透入，眼底无法看见。

治疗：

针风池、曲鬓、角孙用热补法，使热感传到眼底，内睛明用压针缓进法，太阳、鱼腰、攒竹、阳白、四白用平补平泻法，留针10~20分钟，以活血化瘀，清头明目。

玻璃体混浊有陈旧性积血，配瞳子髎透太阳，阳白透丝竹空，以通络活血，祛瘀生新。眼底静脉曲张、有出血先兆时，配上迎香点刺，脑空、合谷、三阴交用平补平泻法，以清热散瘀、防止出血。肝肾不足（或见血小板降低），配大椎、身柱、膏肓、肝俞、肾俞用热补法或加灸，以补益肝肾，养血明目。预防复发。

每日一次，10次一个疗程，每疗程后休息3～5天。

1957年6月在中医研究院针灸研究所总结的41例，56只眼中，有效率为90.2%，治愈率为29.2%，视网膜出血疗效佳，增殖性视网膜炎疗效差。根据临床统计，针治10～20次的效果差，针灸需要半年以上疗效才能巩固。

病案举例：

例一、张××，男，30岁，已婚，干部。因眼底反复出血、视力减退二年，1953年11月18日初诊。

患者1951年11月初，赛球被球打中左面部当时流泪发晕，1952年3月初左眼突然出血，经×医院眼科用结核菌素及链霉素等治疗，症状加剧，至9月间，共出血十次，10月到×医院诊断为青年反复性视网膜出血，增殖性视网膜炎，用氯化钙及食盐水注射，1953年4月又出血二次，视力大减，玻璃体混浊程度加重，又经×中医师用中药100余剂，但视力仍无好转，至今左眼出血共十三次，已形成增殖性视网膜炎，而来我所诊治。主要症状：两眼视物不清，下午眼胀，经常头痛，感冒引起眼底出血，失眠、腰痛、周身无力，并有腹胀、黎明泻。检查：眼底，左眼玻璃体轻度混浊，有陈旧性出血及结缔组织增殖，右眼玻璃体亦轻度混浊，能看到乳头和血管。视力：右眼0.8，左眼0.02，舌质红有紫斑，舌苔薄白，脉微弱，56次/分，血压110/78mmHg，血小板7.3万。中医辨证系络脉受损，瘀血停留，睛目被蒙。采用活血化瘀，清头明目之法治之。取风池、大椎、颅息、角孙，用“烧山火”手法，内睛明，用“压针缓进手法。治疗至1954年4月29日计五个月，针达七十次时，自觉症状基本消失。检查：眼底，左眼玻璃体混浊已减轻，陈旧性出血大部分已吸收，血管安静，炎症消失，结缔组织冲开两裂口，右眼玻璃体混浊减轻，乳头和血管大致正常。视力：右眼1.5，左眼0.08，血小板16.5万。为继续观察，每星期针一、二次，至1955年4月2日，共观察11个

月，共针113次，即恢复了工作。经常联系情况良好。

附记：1978年11月—12月患者在中央党校学习时见面，谈话后未再复发。

例二、尚××，男，34岁，已婚，干部。因双眼反复出血，视力减退，1955年6月30日初诊。

患者1949年春，左眼出血，1950年因鼻大出血不止，住×医院4个月，输血七磅，1951年右眼出血失明，住×医院一星期，诊断为双眼视网膜出血，经过各种治疗，但仍继续出血，至今右眼出血三次，左眼出血四次，血未吸收，两眼玻璃体混浊、视物不清而来我所治疗。主要症状：视物模糊，眼痛，永有条状黑物呈现目前影响视力，不能看书，精神不振，全身困倦无力。检查：舌质紫、舌苔薄白，脉弦滑，80次/分，血压110/80mmHg，颈淋巴腺肿压痛，视力：右眼0.4，左眼0.2；眼底：玻璃体高度混浊，眼底看不清。血常规：红细胞427万，血红蛋白11.3g，白细胞7154，中性79%，淋巴18%，单核3%，血小板20.5万，出血时间1分30秒，凝血时间1分钟。中医辨证系体质素虚、瘀血停留、目睛被蒙。采用活血化瘀、清头明目之法治之。取风池、颅息、角孙，用烧山火法，内睛明用压针缓进法，太阳、攒竹，用平补平泻法，治疗至一个月，针达十三次时眼即不干，疼痛已消，能看书报；治疗至9月30日，计三个月，针达三十六次时，症状消失。检查：视力，右眼0.6，左眼0.6；眼底，玻璃体混浊减轻，乳头和血管已能清楚看见。血小板21.5万。即恢复了工作。经最近联系情况良好。

例三，张××，男，27岁，已婚，干部。因左眼底出血视物不清一年，1954年14日初诊。

患者1953年夏左眼出血，1954年6月和8月连续出血，至今左眼共出血五次。曾在北京×医院诊断为视网膜出血，经过各种治疗，未见显著效果而来我所诊治。主要症状：头昏头重，视物

不清，自觉眼前有黑物动荡，久视则不能分析物体，并有遗精阳痿、腰痠腿软，全身无力。检查：舌质淡、苔薄白，脉弦细，72次/分。视力：左眼0.5。中医辨证系怒气伤肝、气滞血瘀、肾气不足，精血不能上营于目。采用平肝补肾、活血化瘀，养血明目之法治之。取1、膈俞、肝俞、太阳、阳白，用平补平泻法，肾俞，用补法；2、风池、角孙，用烧山火法，内睛明，用压针缓进法；两组穴位轮换交替使用。治疗至10月28日，计半个月，针达十三次时，视力恢复到0.9，症状消失，要求回籍工作，因治疗次数太少，经1955年通信联系，因工作劳累又出血一次。

例四、杨××，女，25岁，已婚，工人。因两眼底出血，视力减退一年，1955年9月10日初诊。

患者1954年7月左眼出血，1955年8月右眼出血，至今左眼出血二次，右眼出血一次，经北京×医院诊断为双眼增殖性视网膜炎，右眼视网膜出血，经过各种治疗，未见显著效果而来我所诊治。主要症状：两眼出血后经常疼痛，视物模糊、头胀痛、不思食、大便干燥。检查：发育良好，营养中等。心、肺、肝、脾未见异常。视力，右眼光觉，左眼0.9；眼底，右眼玻璃体内有大量积血，视网膜血管出血所遮不能看清；左眼底结缔组织增生，乳头和血管大致正常。血常规：红细胞370万，血小板20万，白细胞6000，中性80%，淋巴19%，酸性1%，血红蛋白10.4g。中医辨证系怒气伤肝、气滞血瘀、睛目被蒙。采用活血化瘀、清头明目之法治之。取风池、角孙，用烧山火法，内睛明用压针缓进法，太阳、合谷，用平补平泻法，治疗到一个月，针达二十一次时，两眼视力增到0.9。治疗到两个月，针达三十八次时，症状消失，两眼视力增加。检查：两眼视力均为1.0。眼底：右眼停止出血，视神经乳头大致正常，视网膜血管除颞上较周边静脉周围有白线相伴外，大致正常，鼻上方较周边部，有比较陈旧之出血斑。血常规：红细胞420万，血小板21.6万，白细胞5400，中

性74%，淋巴24%，酸性2%，血红蛋白11.3g。因症状消失，视力恢复，即在工作中进行观察治疗。于12月底（在停诊期间）因同爱人性交，第二日右眼又出血而失明。又治疗二十天，针达十次，视力又恢复到1.0。而停诊休息。由此可见，本病在出血停止，视力增加而治疗的时间短，疗效尚未巩固时，应尽量避免性交，以防再度出血。

三十七、视神经萎缩

本病是由视神经炎或其它原因引起的视神经退行性病变。属于祖国医学青盲、视瞻有色范畴。多因失血过多，外感风邪，饮食劳倦，忧思郁结，气血不能上荣于目所致。

主症：

眼睛不痛不痒，无红肿，视力逐渐减退，视野缩小，有中心暗点，不能视物，甚则失明。眼底视神经乳头色苍白，视网膜血管变细。舌苔薄白，脉细弱。

治疗：

针风池用热补法不留针，使热感传到眼底，内睛明用压针缓进法，瞳子髎、攒竹、球后用平补平泻法，留针10~20分钟，以通络明目。

头晕烦躁，配丝竹空、鱼腰、曲鬓、肝俞、合谷、光明用平补平泻法，以镇静安神。遗精阳痿，疲乏无力，配脑空、大椎、肝俞、肾俞用热补法，以培补肝肾，益精明目。

每日一次，12次为一疗程，每疗程后休息3~5天。

1960年1月在中医研究院针灸研究所和协和医院眼科总结的24例、40只眼睛中，有效率为62.5%，病程短乳头苍白轻的疗效好，病程长乳头苍白重的疗效差。

病案举例：

例一、风邪阻络型

张××，男，40岁，北京市大经厂24号，会计。因视力逐渐减退十年，1958年3月16日初诊。

患者十年前视力逐渐减退，1951年在北京市×医院检查诊断为视神经炎，半年前，因感冒发烧后，视力大减，只能勉强看到报纸上的一号大字，但看字呈黄色，且眼易疲乏，看3—4分钟即出现头痛，眼睁不开而想睡，又去×医院检查，诊断为视神经萎缩，遂来本组治疗。检查：视力，右0.3，左0.4；眼底，双视乳头颞侧淡黄，边缘清楚，生理凹陷及视网膜血管正常。视野，双侧中心有绝对性暗点约3°。面色黄而不润泽，舌苔白根腻，脉缓尺弱，68次/分，西医诊断为视神经萎缩；中医辨证系风邪久郁，阻塞经络之“视瞻昏眇”。采用祛风活络、活血明目之法治之。取风池，用烧山火法，使热感传到眼底出汗，曲鬓、瞳子髎、攒竹，用平补平泻法，留针20分钟；并配大椎、肝俞、肾俞，用平补平泻法，不留针。两组穴位交替使用，每日针一次，针治十四次，视力恢复至右0.6，左0.5。针治二十五次时，视力恢复到右0.8，左0.7。治疗至6月15日，针达五十六次时，症状基本消失。检查视力：右0.9，左0.8。眼底：双乳头大小正常，边缘整齐，右颜色正常，左颜色略浅，血管无特殊。舌质淡，苔薄白，脉弦细，72次/分。即停诊观察。1959年3月26日随访情况良好。

例二、肝肾阴虚型

王××，女，32岁，北京市甘家口118号市民。因左眼失明半月，1958年11月3日初诊。

患者半月前左眼突然失明，并伴有头痛、腰痠、全身疲乏无力。检查：视力，右1.2，左眼前手动。左眼瞳孔对光反射迟钝。眼底，右眼正常，左眼视乳头水肿，黄斑正常。舌苔薄白，脉浮稍数，82次/分。西医诊断为左眼视乳头水肿、视神经萎缩。中医辨证系肝肾阴虚、精血不能上营于目之“青盲”。采用补肾益

肝、养血明目之法治之。取风池，用热补法，使热感传到眼底，肝俞、肾俞，用热补法，不留针，内睛明，用压针缓进法，留针10分钟；并配球后、攒竹、鱼腰、太阳，用平补平泻法，留针20分钟。两组穴位交替轮换使用。每日针一次，针治三十二次后，头痛、腰痠消失，全身有力，亦不疲乏。眼科检查：视力，右1.2，左0.1。眼底，左眼视乳头水肿消退，颜色稍浅，边缘清楚，动静脉迂曲，黄斑中心凹可见，光反射消失，周边未见异常。诊断为视神经萎缩。又用前法治疗到1959年1月23日，针达六十六次时，视力：左0.7，眼底：左眼视乳头边缘清楚，颜色淡黄，视网膜动脉轻度狭窄，静脉正常。视野：左中心视野生理盲点扩大，2/1000白，绝对性环状暗点1/1000白。治疗到1959年2月25日，针达九十次时，左眼视力恢复到1.0，即停诊。同年6月15日随访情况良好。

三十八、内耳眩晕症

本病是由内耳迷路水肿，半规管平衡功能失调引起的。属于祖国医学耳鸣掉眩、耳鸣目眩、眩晕范畴。多因正气不足，痰饮上泛所致。

主症：

发作突然，症状剧烈，呈旋转性眩晕，不能站立，多伴有耳鸣、耳聋、恶心、呕吐、出汗及面色苍白，脉弦细，舌红，苔白，严重者可有神志昏迷。一般在数小时至数日反复发作。

治疗：

针风池、百会、神庭、听宫、内关、合谷、丰隆用平补平泻法，以温阳化湿，升清降浊。

心慌不能入睡，配印堂、神门以安神定志。神志昏迷，配人中以开窍醒神。耳聋、耳鸣，配耳门、听会以清泻肝胆，利窍聪耳。头胀痛、眼球震颤，配太阳、攒竹以祛风止痛。恶心呕吐，

厌食，配中脘、三阴交以平肝和胃。

1972年12月在成县医院总结的11例中，经过2~10次治疗，均有效果。治愈者5例。

病案举例：

例一、王××，女，37岁，成县小学教员。因眩晕头痛呕吐三天，1970年10月13日初诊。

患者三天前作恶梦，出冷汗，感觉头晕，不能站立，视物模糊，呕吐苦水，耳鸣，听力减退，烦躁气急，不能入睡，不想吃东西，月经过多。经×医院诊断为“美尼尔氏综合症”及神经官能症。今天病情加剧，而来我院。检查：舌苔白腻，脉弦细。中医辨证系肝阴不足，血虚生风，上扰清窍。采用平肝熄风、养血安神之法治之。取风池、百会、听宫、神庭、合谷、内关，用平补平泻法，留针10—20分钟。针治一次，头晕呕吐基本消失。复诊减去内关，加印堂、神门，每日一次，又针治三次，睡眠好转，共针治八次而痊愈。1971年12月20日随访未复发。

例二、张××，女，46岁，成县医药公司嫖姆。因眩晕呕吐反复发作四年，1970年6月6日初诊。

其女代诉：患者近四、五年来经常头痛、头晕、耳鸣，昨天生气后，半夜里突然眩晕，觉得天翻地覆，旋转，当即呕吐不止，昏迷不醒。出诊检查：患者卧床昏睡，床下呕吐食物满地，面色苍白，舌苔薄白，脉细数。中医辨证系肝郁气滞、风痰上犯清窍。采用舒肝解郁、祛痰利湿、醒神开窍之法治之。取人中、内关、风池、听宫、神庭、合谷，用平补平泻法，留针15分钟。针后患者苏醒，呕吐停止，眩晕减轻。复诊减去人中，加印堂，每日一次，又针治三次即愈。1971年8月10日随访未复发。

三十九、链霉素中毒性耳聋

链霉素中毒所致耳聋，是比较难治的一种五官科病症，属于

祖国医学耳鸣、耳聋范畴。多因风寒上扰、湿浊内停，肝胆火盛，蒙闭耳窍所致。

主症：

1. 风寒上扰、湿浊内停型：耳聋的发病初期，耳内闷响，鼻塞不通，舌苔白腻，脉浮有力。

2. 肝胆火盛、蒙闭清窍型：突然耳聋耳鸣，烦躁不安，舌苔黄腻，脉弦滑。

3. 经络失养、耳窍不聪型：耳聋日久，多数兼有哑症，但无证候，苔脉正常。

治疗：

1. 风寒上扰、寒湿内停型：取风池、合谷用烧山火法、听会、上迎香，用平补平泻法，以驱风散寒，利湿开窍。

2. 肝胆火盛、蒙闭清窍型：取风池、支沟、百会、听宫、翳风，用凉泻法，以疏泻肝胆、开窍聪耳。

3. 经络失养、耳窍不聪型：取耳门、听宫、听会、翳风、百会、风池、哑门、支沟、液门、合谷，用平补平泻法，以疏经活络，开窍聪耳。

在甘肃中医学院同孟昭敏总结的14例（28只）患者中，治愈6例（12只），显效4例（8只），进步3例（6只），无效1例（2只）。并观察到病程长、针治次数少疗效差，病程短、针治次数多疗效佳。

病案举例：

例一、风寒上扰、痰湿内停型。

付××，男，58岁，兰州，中国市政工程西北设计院院长兼总工程师。因听力突然减退42天，1983年3月19日初诊。

患者83年1月上旬开始感冒，中旬去西安参加会议，因室内无取暖设备，自觉全身发冷恶寒，感冒加重，注射青、链霉素，下旬返回兰州，在本院医务室继续注射青、链霉素，并口服土霉

素，2月5日早晨去华林山参加追悼会，因心情沉重，天气又冷，受凉后一身冷汗，自觉全身痠痛，支持不住，回单位后，鼻塞严重，呼吸困难，下午突然听力减退。2月7日经×医院内科治疗，效果不显，2月12日去陆军×医院五官科就医，经口服土霉素、黄连上清丸、麻黄硷滴鼻、注射大青叶注射液后，舌干口渴异常，17日转入兰州×医院，诊断为神经性耳咽管阻塞，经注射青霉素、输液十天未见好转。3月11日曾用导管疏通右耳咽管，当时通气，但取出导管仍不通气，并且鼻孔流血，病情加重，耳内闷响，听不到任何外界声音，体温下降至 $34.8-35.6^{\circ}\text{C}$ （平时 $36.5-37^{\circ}\text{C}$ ），于3月19日转来我院，五官科检查：鼻粘膜充血、肿胀、通气不畅，两耳鼓膜内陷，听力减退，两耳气、骨导均减低，双侧重度耳聋。其它检查：胸部拍片，肺纹理较重。心电图、超声波、鼻部拍片、血常规、二便、血小板、生化、肝功等均正常。中医检查：听不到对面说话声音，鼻塞不通、张口呼吸，呼吸音粗，面色红润，舌质淡，苔白腻，脉浮有力，（74次/分）。中医辨证系风寒上扰，湿浊内停、阻闭少阳、壅遏清窍。采用驱风散寒、利湿疏胆、开窍聪耳之法治之。取合谷、风池，用烧山火法，使热感传到前额而使全身出汗，上迎香点刺，上星、听会，用平补平泻法，留针30分钟。3月21日第三次按上述方法针后，患者捏住鼻子鼓气时，自觉耳内响了一声，似鼓膜鼓起来的样子，即能听见室内说话。3月23日鼻子通气，听力增加，则减去上迎香、上星、加翳风，手法和留针同前。治疗到4月25日，针达三十一小时，听力和身体恢复正常，治愈停诊。经同年7月30日、84年1月20日和86年10月2日随访复查，情况良好。

例二、肝胆火盛、蒙闭清窍型

魏××，男，44岁，甘肃省百货公司司机。因听力突然减退十一天，1983年8月13日初诊。

患者1983年8月1日去武威出差，右耳突然疼痛，在武威×医院诊为急性卡他性中耳炎，经注射青、链霉素两天，病情加重，出现耳鸣、听力减退。8月4日回兰州，在×医院检查，又发现鼻中隔穿孔。继续注射青、链霉素8天，作耳咽管通气术五次，右耳即不痛，但耳鸣、耳聋加剧。8月11日去省×医院，因无特效方法，于13日转来我院。五官科检查：右外耳道内有少量油剂，鼓膜充血，鲜红色水肿，光锥消失，活动好，轻度内陷，未见明显穿孔。音叉试验：右耳感受性听力下降，左耳气导略差；电测听检查：右耳骨导1500—300赫兹（HE）时，给左耳加噪音50分贝（db），左侧轻度耳聋，右侧重度耳聋。鼻粘膜充血，中隔大穿孔。中医检查：两耳聋，听不见对面说话，自觉耳内嗡嗡作响，听不到外界任何声音，舌质红、苔黄腻，脉弦滑，80次/分。中医辨证系风热外侵，胆火上扰，蒙闭清窍。采用驱风清热、疏泻肝胆、开窍聪耳之法治之。取支沟、风池，用凉泻法，使凉感传到前额，百会、听宫、翳风，使头部、耳内有凉感，留针30分钟。按上述方法治疗到8月23日，针达十次时，听力逐渐好转，已能听到近距离的说话声和电视机的响声。以后则改为每周针治三次，治疗到10月30日，共针治三十五次，听力恢复正常。经1984年12月18日和1986年12月15日随访复查，情况良好。

例三、经络失养、耳窍不聪型

白××，男，7岁，成县北关农民。因听不见、不会说话五年，1979年11月8日初诊。

其父代诉：患儿两岁时，春天发高烧，注射青、链霉素，病好以后，一直听不见，也不会说话已五年，而来我院诊治。五官科检查：两耳鼓膜正常，听力减退，两耳气、骨导都减低，双侧耳聋。中医检查：两耳聋，听不见对面说话，表情痴呆，舌苔薄白，脉缓。中医辨证系经络失养，耳窍不聪。采用疏通经络、开

窍聪耳之法治之。取听官、听会、哑门、上廉泉、合谷，用平补平泻法，留针20分钟，治疗到11月15日，针治五次时，能听见大声说话，能说单字语如能叫爸、妈、爷。治疗到11月18日，针达八次时，能听见说话，能说双字语，如能说吃饭、喝水。因外出探亲未归，作为进步（有效）停诊。

四十、鼻 炎

本病是由细菌侵入鼻粘膜引起的一种炎症。属于祖国医学鼻渊、鼻渊范畴。多因外感风寒，或积久化热所致。

主症：

1. 风寒型：鼻塞流清涕或白粘涕，伴有咳嗽，喷嚏，头痛，鼻粘膜较白，舌苔白腻，脉浮缓。

2. 湿热型：鼻塞流黄脓涕，伴有头痛眩晕，鼻粘膜充血，舌尖红，舌苔黄，脉滑数。

治疗：

1. 风寒型：针风池、攒竹、迎香、合谷用烧山火法，以驱风散寒。

2. 湿热型：针上星、上迎香、迎香、合谷用泻法，以清热化浊。

头痛，眩晕，配百会、头维用泻法留针20~30分钟，以镇痛安神。咳嗽，喷嚏，配风门、肺俞、上迎香用平补平泻法，以疏风润肺。

1971年6月在成县医院总结的81例中，有效率88%，平均1.4次见效。治愈率33%，平均10.2次治愈。

病案举例：

李×，男，10岁，成县106地质队，学生。因鼻子不通气三年，1970年2月15日初诊。

患者三年来一直鼻子不通气，流鼻涕，容易感冒，头痛，前

两个月发现鼻发堵发胀、咽喉发干，经职工医院诊断为慢性鼻炎，封闭两个月未见明显效果。检查：双下鼻甲肥大，粘膜增厚，表面粗糙不平，鼻道无脓性分泌物，麻黄素可收缩。舌苔薄白，脉滑数，88次/分。西医诊断为慢性鼻炎；中医辨证系湿热久郁、阻塞鼻窍。采用清热利湿、解郁开窍之法治之。针攒竹、上迎香，点刺出血，风池、迎香、合谷，用泻法，每日一次，针治一次，鼻即通气，头亦不痛，针治十次鼻涕减少，则改为每周针三次，治疗至4月15日，针达三十次时，症状完全消失，检查恢复正常，治愈停诊。同年11月15日随访未复发。

四十一、急性扁桃体炎

本病是由细菌侵入扁桃体而引起的一种常见疾病。属于祖国医学喉痹、乳蛾范畴。多因肺胃积热，感受风邪，或阴虚咽燥所致。

主症：

起病急，畏寒发热，体温可高达 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，咽痛、吞咽时加剧，兼见小便赤，大便干，扁桃体肿大充血，有散在黄白色点状渗出物，易于拭去不出血，常有颌下淋巴结肿大。舌红，苔黄，脉浮数。

治疗：

取翳风、扶突、合谷、足三里用泻法留针10~20分钟，少商、商阳点刺出血，以疏风解热。

发热怕冷，配风池、大椎用泻法，以疏散风寒。咽喉肿痛，吞咽困难，配颊车、十宣用泻法，以清热利咽。肺燥阴虚，配列缺、照海用平补平泻法，以滋阴润肺。

1971年11月在成县医院总结的52例中，均有疗效，平均1.1次见效，治愈率为89.2%，平均3.2次治愈。

病案举例：

例一、钟××，男，42岁，中央组织部招待所干部。因嗓子痛两天，1957年12月14日初诊。

患者三天前感冒发烧，身热恶寒，逐渐发觉嗓子疼痛，咽东西困难。检查：体温38.9℃，脉搏88次/分，身体稍虚弱，面色尚润泽，左侧扁桃体显著肿大、红赤、并有多数散在之白点；化验：白细胞10500。西医诊断为急性扁桃体炎。舌苔薄白，舌质红，脉数有力。中医辨证系风热外侵、肺胃积热。采用祛风泻热、养阴生津之法治之。取少商，点刺出血，合谷，用凉泻法，使麻或凉的感觉传到手指。翳风，用泻法，使麻或凉的感觉传到颊部或口腔，不留针，针后20分钟，患者即感疼痛有所减轻。12月15日复诊，自述嗓子疼痛减轻，咽东西已不感疼痛，左侧扁桃体已缩小，其上面之白点已全部消失。治疗至12月16日，针达三次时，经检查，原肿大之扁桃体已恢复正常，白细胞降至7150。治愈停诊。

例二、张××，男，40岁，成县百货公司职工，因嗓子痛两天，1970年3月4日初诊。

患者前天开始发冷、发烧，经城关医院给A、P、C、未见效果，昨日又觉头痛、嗓子痛，咽吐沫亦痛，全身乏力。检查：体温39℃，咽部红，两侧扁桃体Ⅱ度肿大充血，表面有脓苔附着，颌下淋巴结肿大如栗子大小，化验：白细胞16000，中性87%，淋巴13%，舌红，苔黄，脉浮数，90次/分。西医诊断为急性扁桃体炎；中医辨证系外感风邪、肺胃积热。采用疏风解热、消肿止痛之法治之。取风池、大椎、颊车、合谷，用凉泻法，商阳、少商点刺出血。针治一次，头和嗓子痛减轻，能咽食物，体温降至38℃。每日一次，治疗至3月7日，针达四次时，症状完全消失，检查恢复正常，治愈停诊。同年5月20日随访，未再复发。

第四节 医 案

医案是选择20多年来中西医结合，采用西医诊断，祖国医学辨证施治，单用针灸和新医疗法治愈的典型病历。

一、上呼吸道感染

谷××，男，54岁，北京宣武区食品厂工人。因发热咽喉肿痛两天，1964年12月30日初诊。

患者前天受凉后，昨天出现发热恶寒，不出汗，鼻塞流涕、咳嗽痰多，咽喉肿痛，咳嗽时腰背震痛，头晕、音哑，胸闷。检查：体温38℃，舌质淡，舌苔薄白，扁桃体窝和咽部充血，皮肤干燥，脉浮而有力，82次/分，右大于左。血常规：白细胞7400，中性70%，淋巴25%，单核2%，嗜酸3%。西医诊断为上呼吸道感染；中医辨证系风寒束表、肺气不宣。采用驱风散寒、解表宣肺之法治之。取风池、大椎、风门、肺俞，用烧山火法，不留针，列缺、合谷，用烧山火法，留针20分钟，针时使患者全身出汗，起针后，患者感到身体轻松。每日针一次，第二日复诊时，已不发热恶寒、咳嗽吐痰减少，咽喉肿痛、鼻塞、音哑等症减轻，皮肤已不干燥，检查：体温36.6℃，脉搏72次/分。治疗到1965年1月3日，针达四次时，症状完全消失，检查：扁桃体窝和咽部充血消失，脉搏70次/分，脉沉细。治愈停诊。

二、支气管哮喘合并肺炎

胡××，男，4岁半，成县182地质队家属。因间歇性哮喘一年余，1976年7月3日住院。

患者1975年7月5日突然发烧气喘，咳嗽痰多，全身出现荨麻疹，经县医院儿科诊断为支气管哮喘合并肺炎。经注射青、链

霉素、口服氨茶硷、朴尔敏等药一周后治愈，但荨麻疹经用强地松后方收效。此后每不到一个月就犯病一次。1975年7月至1976年7月共发病14次，每次发病十天左右，每次发病用药同前，不能根治，一年来患儿面黄肌瘦，发育迟缓。本次发病而来住院。检查：发育中等、神清、动作自如，体温38℃，精神萎靡呈哮喘状态，面色青灰，喉间有哮鸣音，呼气延长，低头不语，胸廓对称，三凹症（+），听诊两肺满布大中水泡声及哮鸣音，肝大剑突下3 cm，余（-）。舌苔白腻，脉滑数，92次/分。1975年8月28日化验：血色素11g，白细胞8950，中性51%，淋巴30%，单核1%，嗜酸18%。1975年10月4日化验：血色素10.5g，白细胞11400，中性41%，淋巴27%，单核1%，嗜酸31%。参考1975年以来血常规，嗜酸细胞一直上升，最高达31%，西医诊断为支气管哮喘合并肺炎；中医辨证系肺气素虚、再感风邪，肺气失宣。采用扶正祛邪、宣肺益气之法治之。取膻中、定喘、肺俞，用补法，留针20分钟，每日针一次，针治二次时，体温降至37℃，病情好转稳定，7月5日出院时按以上穴位埋线一次。以后每月按以上穴位作穴位埋线一次，继续观察。同年7—12月，仅10月份发病一次，持续3~4天，临床症状明显减轻，发病时，患儿照常玩耍，仅在跑步时出现呼吸困难，未出现荨麻疹。1976年10月13日化验：血色素10.8g，白细胞11800，中性53%，淋巴31%，单核1%，嗜酸15%。1977年1—6月发病两天，症状很轻，患儿仍照常玩耍，犯病期间仍未出现荨麻疹。1977年3月30日化验：血色素12g，白细胞8000，中性53%，淋巴36%，嗜酸11%，酸性细胞计数726/mm³。6月30日化验：嗜酸性细胞计数654/mm³。停诊观察。1978年8月18日随访，一年未复发。

三、流行性胸痛

毛××，男，11岁，因间歇性胸痛八年余，1982年12月12日初诊。

其父代诉：患儿两岁时，常觉腹痛，经甘肃省×医院检查，认为是肠虫症，曾驱虫治疗三次无效。患儿3岁时发现腹痛集中于剑突处，为隐痛、一年发作3—4次，每次持续1—2天，可自行缓解。以后发作频繁，持续时间延长，引起重视。每次发作均较突然，疼痛时在剑突处有黄豆大小痛点、拒按，如针刺样锐痛，不向他处放射，除弯腰以图缓解外，不伴随任何症状，亦无规律性。但每次发作前相当于左太阳穴附近出现一枚黄豆大小丘疹，疼痛、奇痒。丘疹痛痒越重，剑突处疼痛越剧；当丘疹或该丘疹处痛痒消失，剑突处疼痛也随之消失，而胸痛好转。为此曾赴兰州市各大医院，北京儿童医院和北京各大医院等求治，接受数十名、名老中医及西医胸科、骨科诊疗，众说纷云，诊断不一。经过钡餐透视4次，胸骨拍片8张，脑电图、心电图、超声波等检查，均无异常发现；每次发病化验血常规：白细胞6000—8000，中性50—80%，淋巴20—50%范围。口服中西药及局部封闭、理疗等治疗，均无疗效，而来我院诊治。检查：左太阳穴处有一黄豆大小象蚊虫叮后的丘疹，明显压痛，胸部中庭穴斜上方与左步廊穴之间，有一黄豆大小之痛点，周围无红肿，局部无结节，明显压痛，拒按，尤其是中庭穴处，手指刚接近皮肤，患者则疼痛难忍，而及时坐起。舌质淡红，舌苔薄白，脉沉迟而弦，65次/分。诊断为流行性胸痛；中医辨证系风湿侵袭、气血久瘀，经络不畅。采用祛风利湿、活血化瘀、疏通经络之法治之。取风池，用烧山火法，不留针，使热感传到前额出汗，膻中、中庭、内关，用平补平泻法，留针20分钟，每日针一次，针治二次后，疼痛减轻，太阳穴处丘疹和剑突处痛点渐消，患儿即恢复上学。

则减风池，改为隔日针一次，治疗至12月28日，针达九次时，患儿因为参加考试，精神紧张，又出现剑突处隐痛一天，但不剧烈、能忍住，而参加完了考试。而且左太阳穴处起了丘疹，也不痒痛。治疗到1983年1月12日，针达十三次时，疼痛症状消失，一直未再痛，痛点完全消失，治愈停诊。同年3月30日其父送信患儿情况良好，未再发病。1983年12月、1984年10月、1985年10月、1986年12月15日多次随访，上学情况良好，一直未复发。

四、风湿热（关节型）

祖××，男，14岁。因两膝关节剧痛两天，1976年2月3日来我院。

患者二年来天气变化时发现腿痛，去年春节前发现两膝关节痛，昨天两膝关节剧痛，不能站，不能走，全身关节串痛，并有发烧。检查：体温38.4℃，听诊：心尖部可听到Ⅱ级吹风样杂音。血常规：红血球288万，白血球27,300，中性80%，淋巴18%，嗜酸2%；血沉：71毫米/第1小时；尿常规：蛋白微量，尿酸盐结晶（+++），心电图可疑，心率86次（分），双膝关节红肿压痛，苔白腻，脉滑数。中医辨证系风寒湿邪、郁久化热，经络受阻，阳气闭郁。采用发散风邪，除湿利节之法治之。取梁丘、血海、膝眼、足三里用烧山火手法，使局部和全身产生热感出汗。针后即能下床走两步。针治5次，疼痛基本消失，即能走路。治疗到2月13日，针达10次时，关节肿痛消失，活动自如，已如常人。检查：心电图正常，心率71次（分）；尿常规：蛋白阴性，尿酸盐结晶（-）。2月16日因两踝关节和两足红肿疼痛，复诊，针加三阴交、公孙、行间，治疗到2月28日，又针治10次，两足和踝关节肿痛消失。血常规：白血球8,400，中性54%，淋巴40%，单核1%，嗜酸5%；血沉：5毫米/1小时。治愈停诊。1976年3月13日随访，情况良好。

五、风湿性心脏病

吕××，男，48岁，北京第一机械部干部。因胸闷、心悸、全身无力三年，1972年11月18日住院。

患者1962年膝关节以下肿痛、头晕，经服中药治愈。1969年1—2月因劳动较多，发现胸部闷痛、气短、心慌、失眠、疲乏无力，经常晕倒，在北京阜外医院检查诊断为风湿性心脏病、二尖瓣狭窄合并闭锁不全。经过治疗效果不显，1970年3月转至杭州、浙江医学院治疗有些好转。1971年9月7日因发烧不能平卧而住临潼417医院，除上述病症外，又发现心界扩大、心率不齐，心房纤维震颤，治疗一个多月，病情有些好转。今年5—7月犯病又住该病，检查病情加重，心脏扩大比去年严重，经服中西药物效果不显而来我院。检查：精神不振，呼吸气粗，心率119次/分，并有Ⅱ级吹风样杂音和舒张期杂音，心律不齐。面色、口唇青紫、不润泽，耳轮干枯，舌质紫，苔黄厚而腻，脉结代，68次/分。西医结合心电图诊断为风湿性心脏病，二尖瓣狭窄合并闭锁不全，心界向左扩大，心房纤颤，心功能代偿期。中医辨证系血瘀痹阻、胸阳不振、气血涩滞、心脉不畅。采用健脾益心、利湿振阳、温通经络之法治之。取心俞、膈俞、膻中、天池、巨阙、内关、三阴交，用热补法，留针20分钟，每日一次，治疗到11月30日，针达十二次时，胸闷有好转，走路较前有力，面色和口唇变红，耳轮较前润泽，舌苔白腻，心律减至82次/分，脉搏69次/分，仍为结代象。治疗到1973年1月22日，针达五十二次时，胸部闷痛，气短、心慌等症明显好转，每夜能睡5—6小时，饮食平均每日8—9两，精神体力好转。心率减至78次/分，脉搏68次/分，结代现象好转。病情稳定即出院。1973年3月1日到门诊针治，取穴厥阴俞、心俞、膻中、巨阙、内关、三阴交，用热补法，留针20分钟，隔日一次，治疗到1973年12月10日，针达一百

四十次时，精神好转，体力增强，一次能走13里路。心率81次/分，脉搏73次/分。为了观察远期疗效，嘱其每月来院复查针灸一次。1974年11月5日复查，精神体力一直很好，能参加一般的体力劳动和学习，走路已不心慌，心率76次/分，脉搏67次/分，心房纤颤和结代现象已不明显。即停诊。1978年11月29日随访，已恢复工作，情况一直很好。

六、膈肌痉挛（呃逆）

肖××，女，42岁，成县食品公司干部。因呃逆频繁两月，1979年8月2日初诊。

患者素有神经官能症，经常失眠已二年。两月前因事不遂心，突然呃呃不止，约两小时自行缓解，初不介意，近来病情加剧，连续发作不止，“呃呃”连声，每次发作约两小时左右，每天发作4—5次，难受不堪，发作后精神疲倦。白天工作紧张时呃呃声小，有时暂停，晚上加剧，呃呃不断，不能入睡。检查：心、肺、肝、脾均正常，腹部平软，无压痛。呃呃连声不止，呃声响亮，膈俞穴处有明显压痛。舌质红，舌苔黄，脉弦细，76次/分。西医诊断为膈肌痉挛，中医辨证系肝郁不舒，胃气上逆。采用舒肝解郁、和胃降逆之法治之。取膈俞，肝俞，用平补平泻法，不留针，期门、中脘、天枢、足三里、内庭，用平补平泻法，留针30分钟，呃逆暂停。每日针一次，针治五次时，每天只发作呃逆一次，且呃呃声较前小，夜晚已能入睡5—6小时，针治十二次时，呃逆连续两天未发作，停诊观察。同年12月23日随访，停诊后未再复发。

七、慢性萎缩性胃炎

蔡××，女，46岁，成县物资局干部。因胃痛反复发作三年，1976年11月8日初诊。

患者三年前开始上腹部胀痛，逐渐加剧，近年来又出现胸闷、嗳气，饮食减少，不思饮食，身体消瘦，疲乏无力。检查：体瘦，面黄，色晦暗、无光泽，舌质暗红、苔黄腻，脉弦稍缓，70次/分。上腹部有压痛，以上、中脘穴处最明显。1976年10月10日在兰州×医院胃镜检查，发现胃窦部粘膜色泽红白相间，有大片白色区，胃粘膜明显变薄，粘膜下小血管显露，取活组织检查，诊断为慢性萎缩性胃炎（中度）；中医辨证系肝郁气滞、脾胃失运。采用舒肝解郁、健胃止痛之法治之。取期门、肝俞，用平补平泻法，上、中脘、梁门、天枢、足三里，用补法，留针20分钟，每日一次，十次为一疗程，每一疗程完了休息3—5天，再继续治疗。治疗一个疗程，患者胃痛消失，饮食增加，病情好转。治疗四个疗程，症状完全消失而停诊观察。1977年2月1日在兰州×医院胃镜检查，胃粘膜色泽仍为红白相间，但以红色为主，白色范围较前缩小；病理报告：胃粘膜萎缩由中度转变为轻度。因患者无症状，身体、精神恢复正常，即上班工作。1978年3月8日随访，未复发。

八、贲门癌

赵××，男，40岁，青水县黄门乡干部。因胃痛吃东西发噎半年，1980年4月12日住院。

患者1979年12月14日出现上腹部疼痛、吃东西发噎、咽东西困难，在清水县医院诊断为贲门癌，12月20日转天水地区医院造影检查，诊断未变，病情逐渐恶化，现在上腹部疼痛、吃饭恶心、嗳气、发噎、咽不下，胸膈胀满，转来我院针灸治疗。吞钡食道检查：钡剂通过食道，显示食道下段狭窄，粘膜皱襞中断、消失，钡流贲门胃底部呈分流状改变，狭窄以上的食道显示扩张。舌质胖嫩，苔黄厚腻稍干，脉左沉细无力、右缓，70次/分，耳轮皮肤粗糙发干，腹部膨胀，上腹部有明显压痛。西医诊断为

贲门癌，中医辨证系忧思悲恚、伤及脾胃，气血亏损，采用健脾益胃、理气养血之法治之。取膻中、巨阙、中脘、阳溪、足三里，用平补平泻法，留针30分钟，每日一次，针治二次时，腹痛和咽东西好转，治疗至18日，针达六次时，上腹部胀痛和咽东西明显好转，一天能食一斤二两粮。改针紫宫、玉堂、膻中、灵墟、神封、巨阙、中脘、内关、足三里，用平补平泻法，留针30分钟。治疗至5月14日，针达二十四次时，吃饭发噎和上腹部疼痛的症状基本消失，精神好转，出院回籍。

九、糖 尿 病

陆××，男，50岁，成县物资局干部。因多食、多饮、多尿八个月，1976年9月7日初诊。

患者今年1月出现饿得快、能吃、口干能喝水、尿亦多，身体虚弱，腰腿痠软，疲乏无力，无精神，体重由130斤降至110斤，9月2日在甘肃省×医院检查，空腹尿糖（+++），血糖260毫升克%，胆固醇246毫克%，诊断为糖尿病。经过治疗效果不显，来院治疗。检查：舌质红、苔薄黄，脉弦细，74次/分。中医辨证系肝脾阴虚、郁热内生。采用健脾益胃、解郁清热之法治之。取肝俞、脾俞、胃俞，用平补平泻法，不留针；中脘、梁门、天枢、气海、足三里、三阴交，用补法，留针20分钟；每日针一次，两组穴位交替、轮换使用。十次为一疗程，休息了3—5天，再继续针治。针治一个疗程后，症状减轻，精神好转，针治二个疗程后，口干多饮，能吃、尿多等症明显好转，空腹尿糖（+），血糖200毫克%。舌质微红，苔稍黄，脉稍细，72次/分。治疗四个疗程后，症状完全消失，病情稳定，停诊观察。1976年12月1日检查：空腹尿糖（-），血糖150毫克%，胆固醇205毫克%，体重增至120斤。1978年5月2日随访，未复发。

十、肠 麻 痹

张××，女，5岁，因手术后腹胀6天，1976年12月8日会诊。

患者12月2日在我院作阑尾手术后，伤口良好。但术后6天一直腹胀，无排便排气，昨日给以灌肠，今早又灌肠一次，仅排出很少量粪便，腹部仍胀，肠鸣音极弱，给以胃肠减压，开始吸出黄绿液体约300毫升左右，以后吸出清液体少量，但腹部仍胀。经X线透视：上腹部有液平面数个。面色苍白，苔薄白，舌质淡，脉细数无力。中医辨证系经络有伤，气化未复，大肠传导失司，采用疏经活络，补气助运之法治之。取中脘、天枢、气海、足三里用热补法，不留针。针后即出现肠鸣音，3个小时后放屁1次，23小时大便1次，大便干硬。12月9日又针治1次，即能喝少量米汤，12月10日，针达3次时，又大便1次，能吃牛奶和水果。12月11日检查：面色红润，舌苔薄白，脉细有力，腹部柔软不胀，完全恢复正常出院。同年12月31日随访情况良好。

十一、慢性肠炎

王××，男，31岁，1961年10月31日初诊。

患者近两个多月来一直腹泻，开始时每日3～6次，伴有便前后腹痛，曾在某医院诊断为慢性肠炎，经用黄连素、合霉素、四神丸等腹泻暂时停止，但以后仍反复发作，大便溏泻，每日2～3次，并伴有肠鸣、腹痛。曾作大便培养无病菌。检查所见：腹软无压痛，舌净无苔，脉缓无力。中医辨证系脾肾阳虚，寒湿下注。采用温补脾肾，固肠止泻之法治之。取中脘、关元、会阳、长强用热补法，针后加灸20分钟。隔日一次，针灸1次后，大便即成形，每日1次，腹痛亦减轻，针灸5次后，溏泻基本停止，腹痛消失，大便每日1次且有规律，为了巩固疗效，又针灸4

次，观察11天，治愈停诊。

十二、结肠炎伴肠痉挛

梅××，女，41岁，甘肃人民出版社编辑，因左下腹部疼痛半年多，1983年6月27日初诊。

患者1973年患慢性阑尾炎，在甘肃省人民医院治愈。1982年12月患腹痛，今年3月转至左下腹部疼痛，经医院治疗效果不显。1983年6月20日在甘肃省地方病防治研究所检查：心电图可疑；心动图正常；肝功正常；胃肠拍片：上消化道未见明显器质性病变，1小时半胃内残留钡剂40%，2小时半胃内残留钡剂10%，钡头达4组小肠，4小时后钡头达升结肠，6组小肠有部分钡剂潴留，9小时后钡头达乙状结肠，可见降结肠上部外侧 2×2 Cm圆形切迹，降、乙状结肠呈条状改变，结肠带消失，经注射阿托品一支，15分钟后，可见乙状结肠带形态如常，降结肠未见钡剂充盈，未见连续性，余未见明显异常。诊断为①降、乙状结肠炎，②肠痉挛。因腹痛加剧，食欲减退、夜晚失眠，1983年6月27日来我院诊治。检查：面色苍白、消瘦，舌质紫有瘀斑，舌苔薄白，脉沉缓，66次/分，血压100/60mmHg，腹部中脘，下脘穴处有明显压痛，左天枢至大巨穴处，可扪及 4×2 cm大小的肿块，质地稍硬、压痛明显，肠鸣音亢进。中医辨证系胃肠瘀积、腑气不通。采用活血化瘀、消积导滞、通调胃肠之法治之。取中脘、下脘、天枢、气海、上巨虚，用平补平泻法，留针20分钟，每日针一次，十次为一疗程，休息3—7天，再继续治疗。针治四次后，剧痛基本消失，因月经来潮，暂停针治。治疗至7月16日，第二疗程针治三次后，腹痛有间断，自觉腹部有气窜，舌质瘀斑好转颜色变红。因仍失眠，加针百会，又针五次后，腹痛和失眠基本消失。7月30日—8月10日，针治三个疗程后，腹痛消失，睡眠恢复正常，腹部硬结和压痛消失，胃肠拍片，完全恢

复正常而停诊。1984年8月20日和1986年12月20日两次随访未复发。

十三、五 更 泻

李××，男，50岁，成县支旗乡农民。因大便溏泻三年，1971年12月20日初诊。

患者三年前常感腹胀，受凉后即腹痛泻肚，有时腹泻便血，带有脓液，经县医院诊断为肠结核。经过中西药物治疗即愈。但以后每逢受凉或天气变冷即腹泻，并常在黎明时泻肚，今年10月间病情加剧，每天黎明时腹痛，腹泻1—3次，腹胀，不思食，心悸气短，腰痠腿软，日渐消瘦。而来我院。检查：面色苍白，营养欠佳，舌质淡红、苔白腻，脉沉细而缓，70次/分。腹部平坦而软，无压痛，心、肺（一），肿脾未触及，肠鸣音活跃，大便镜检无特殊。中医辨证系脾肾两虚、命门火衰。采用健脾补肾、温固下元之法治之。取中脘、天枢、气海、命门、腰俞、会阳，用热补法，留针20分钟，每日针一次，针治三次后，腹痛、腹泻和黎明泻减轻；治疗至12月31日，针达十次时，症状基本消失，大便转为正常；即改为每周针治二次，观察远期疗效；治疗至1972年1月20日，针达十六次时，症状完全消失而停诊。1972年12月15日随访未复发。

十四、消化不良

李××，女，3岁，成县支旗乡农民。因间歇性泻肚一年伴发烧九天，1979年6月18日住院。

患儿一年前患泻肚，水样便，夹有未消化食物和粘液，严重时每月犯3—4次，每次5—6天左右，以后每日二次左右。二十多天前患儿感冒流清涕，食欲不振，但未发烧，于6月10日开始高烧，一般于中午11时一下午一晚上半夜左右，每次持续发烧2小时左右，一般用退烧药后，热度很快下降，同时伴有呕吐，

精神不振、面色晦暗，无咳嗽，发烧时有汗，曾给磺胺药、氯霉素、合霉素、卡那霉素、安乃近等，住我院内科九天仍高烧38—40.2℃，病情未见好转而于6月28日转来我科。既往无盗汗，患过痢疾。检查：神志清楚、热性病容，巩膜无黄染，体温39.3℃，颈部两侧有数个黄豆大淋巴结，无压痛、活动。肺（-），舌苔薄白，脉弦滑，130次/分。腹软，肝肋下刚触及，脾肋下能触及1cm、质软，尿常规正常，血常规：血红蛋白12g，白细胞7900，中性63%，淋巴36%，嗜酸1%。大便：外观黄色软便带粘液，镜检：脂肪球少量，蛔虫卵0—1。胸透未见异常。肝功：转氨酶245单位，余正常。西医诊断为消化不良；中医辨证系久病伤阴、脾肾两虚，运化失常。采用清热养阴、益肾培元、健脾助运之法治之。取大椎、陶道、身柱、至阳、命门、肾俞，用平补平泻法，不留针。针治二次后，吐泻减轻，体温降至37.6℃。改针中脘、天枢、气海、内关、足三里，用平补平泻法，不留针，每日针一次，治疗至7月8日，针达十次时，腹泻等症状完全消失，检查恢复正常，治愈出院。同年10月1日随访，未复发。

十五、急性肾炎

朱××，女，34岁，于1961年2月4日初诊。

患者5、6天前感觉全身疲乏无力，胃口不佳，继之畏寒发热，头胀不适，体温39.6℃，在×门诊部注射和口服退烧药物，最近三天来不思饮食，昨日仅吃了一碗面汤，吃后即吐，以后逢吃即吐，喝水也吐，有时吐黄绿色苦水，并感左侧腰部痠痛，向左腹股沟放散，大便干，小便深黄，量少滴痛，次数频繁每天20余次，易出汗。检查所见：体温38℃，血象：白血球19.700，中性88%，淋巴9%，单核3%。尿常规：色黄，透明度：清，反应：酸，比重：不足，蛋白（卅），糖定性（-），红血球5～

8，上皮细胞10~20，白血球10~15。面色苍白，眼睑微有浮肿，舌淡红，苔白，咽红，扁桃体红肿，脉数。中医辨证系邪从上焦已传中下二焦，中焦受邪，脾失健运，胃纳不受；下焦热阻，肾失开合，膀胱气化失司。采用调和脾胃，泻热养阴之法治之。取中脘、关元、内关、公孙用泻法，留针30分钟。每日1次，针治1次，呕吐停止，体温降至37℃，则改取中脘、关元、足三里、复溜，留针15分钟，针治5次，尿痛，尿频等症完全消失，于2月13日复查：白血球9.800，中性58%，淋巴37%，单核3%，酸性2%。尿常规：色黄，透明度：清，反应：中性，比重：低，蛋白（-），糖定性（-），上皮细胞2~8，白血球3~5。治愈停诊。

十六、急性膀胱炎

李××，女，34岁，成县抛沙乡干部。因小腹胀痛，1972年10月12日住院。

患者小腹胀痛，尿频、尿急，尿时灼痛，逐渐加剧，现在尿色黄而发混，一日20多次，排尿时自肚脐往下疼痛至尿道。检查：腹软，下腹部有明显压痛，肾区无扣击痛。尿检：色黄、混浊，蛋白少量，白细胞（++），红细胞（++）。舌质红、苔黄，脉滑数88次/分。西医诊断为急性膀胱炎；中医辨证系湿热郁结，膀胱气化功能失调之热淋。采用清热利湿、通淋止痛之法治之。取关元、中极、复溜、束骨、膀胱俞、次髎，用凉泻法，留针30分钟，针后小腹胀痛减轻。每日针一次，针治三次时，尿时灼痛已不明显，排尿次数减少，为一日10次左右，小腹疼痛消失。尿检：色黄，质清，蛋白（-），白细胞少许，红细胞（-）。治疗至10月17日，针达五次时，症状完全消失，尿检等均正常，治愈出院。1973年3月1日随访，未复发。

十七、慢性前列腺炎

郭××，男，29岁，成县县委干部。因睾丸坠痛四个月，1979年4月30日初诊。

患者去年冬天下农村，被雪浸透衣服感冒后，出现阴茎发胀发堵，睾丸坠痛，有时尿痛、尿急，有尿不净的感觉，大便后尿道口常有白色分泌物，并有阳痿、早泄、头昏、失眠。检查：指诊检查，前列腺肥大，硬度中等，有轻度压痛。前列腺液化验：白细胞15—20个/高倍视野，卵磷脂小体60%。精神不振，面色无华；舌苔薄白，脉沉细，74次/分，肾俞、关元穴处有明显压痛。西医诊断为慢性前列腺炎；中医辨证系房劳过度、下元虚损。采用固肾培元之法治之。取1.肾俞、上髂、会阳，2.气海、关元、三阴交，每日针一次，两组穴位轮换交替使用，针治十次时，自觉症状好转，检查无变化。治疗至6月6日，针达三十次时，自觉症状完全消失，精神恢复正常，指诊检查：前列腺正常。前列腺液化验：白细胞2—4个/高倍视野，卵磷脂小体80%。即停诊。1980年7月1日随访复查，未再复发。

十八、偏头痛并低血压症

高××，男，50岁，成县农业局干部。因左侧偏头痛二十三年，1979年3月26日初诊。

患者从1957年因失眠引起左侧偏头痛，每日上午10点一下午3点疼痛较剧，3点以后逐渐好转或不痛，经服“天王补心丹”无效，服“黄连上清丸”有效，参加体力劳动时不犯病，看文件、坐办公室、开会就头痛。开始服“苯巴比妥”能入睡，但醒后仍头痛，后来再服则无效。现在左侧头痛、咳嗽、痰多，头重脚轻，两腿无力，走路时身体向右边倾倒，食欲减退，有时耳鸣，心慌左右摆动。检查：右侧鼻唇沟变浅，口向左歪，舌苔薄

白根厚腻，舌有芒刺，脉滑，血压80/40mmHg。西医诊断为1. 偏头痛、2. 低血压症。中医辨证系失眠伤阴、肝风内动、上扰清窍。采用平肝熄风、养阴止痛之法治之。取双风池、太阳、百会、左头维、颌厌、合谷，用平补平泻法，留针20分钟，治疗至3月29日，针治三次后头痛减轻，饮食增加，一天能吃12两，睡眠恢复正常，血压106/72mmHg，改针风池、百会、内关、中脘、足三里，用平补平泻法，留针20分钟，治疗至4月25日，针达十三次时，症状完全消失，血压128/70mmHg，治愈停诊。同年8月15日随访，已参加工作，情况良好。

十九、病毒感染性头痛

王××，男，18岁，成县支旗供销社干部家属。因剧烈头痛十一天，1977年5月8日住院。

患者十一天前开始头痛，第八天出现恶心、呕吐三次，而在我院内科住院。化验血常规：白细胞4200，中性83%，淋巴14%，单核3%。5月11日因发热，头痛加剧，检查：体温38.4℃，脉搏90次/分，血压130/90mmHg。血常规：白细胞5600，中性85%，淋巴14%，嗜酸2%。曾服VB₁、利眠宁、安痛定，注射青霉素等治疗无效，要求会诊而转来我科。检查：痛苦病容，两手抱头呻吟，舌苔薄白，脉弦数。西医诊断为病毒感染性头痛；中医辨证系外感时邪，阻塞清窍。采用祛邪扶正、开窍止痛之法治之。取风池，用烧山火法，不留针，百会、大椎、太阳、合谷，用平补平泻法，留针30分钟，每日针一次；针治一次，头剧痛转为慢痛。治疗至5月14日，针达四次时，头痛停止，体温降至37℃。治疗观察至5月16日，针达五次时，症状完全消失，体温降至36.8℃，而出院。1977年9月1日随访未复发。

二十、乙型脑炎后遗症

李××，男，32岁，因精神失常两个月，1971年10月18日来我院。

患者于同年8月16日患乙型脑炎，在我院住院5天，因病情危急，转某解放军医院进行抢救。10月上旬脱险出院后，一直生活不能自理，不知大小便，意识不清，痴呆不语，有时胡言乱语，吃饭不知饥饱。检查发现：精神失常，二目直视，不识亲疏，答非所问，乱说乱动，自言自语，时哭时笑，面色干黄，舌苔黄厚，脉滑。中医辨证系风邪犯脑，津液灼伤，气血耗损，神明不清。采用清热养阴，开窍醒神之法治之。取风池、风府、百会、神庭、印堂、人中、合谷用平补平泻法，内关用补法，每日针1次，治疗到一个月，患者能识亲疏，能说话，但说过就忘，以前的事一点也想不起来。吃饭能知饥饱。又治疗一个月，大小便能够自理，记忆力有所好转，但患者经常头痛眩晕，烦躁不安。取穴减人中、风府加太阳、巨阙、神门隔日一次，又针治两个月，精神和记忆力已基本正常，即恢复了工作。1972年8月随访一切良好。

二十一、脑震荡

陈××，男，51岁。因头部被木棒击伤一小时，1973年11月26日来住院。

患者一小时前盖房时不慎被木棒击伤头部，当即昏倒约10分钟左右，醒后头昏，头痛不止，呕吐两次，经当地卫生所注射安痛定一支，但仍头痛、头昏、烦躁、不能坐立。检查：体温37.5℃，头部右枕区约有3×4厘米肿胀压痛，后项部约有1×0.3厘米皮肤擦伤，血常规：白血球14,500，中性90%，淋巴6%，单核4%。脉搏130次/分，血压150/110毫米汞柱，舌苔黄厚腻，脉

弦滑。中医辨证系髓海受伤，瘀血停留，经络受阻，元神不宁。采用疏经活血，清脑安神之法治之。取风池、百会、神庭、后顶、通天、合谷用平补平泻法，留针20分钟，针治2次头痛减轻，痛仅限于前额部，头脑感觉清凉，则减通天、后顶，加太阳，治疗到12月8日，针达10次时，头痛头昏等症消失。检查完全恢复正常，即出院。74年3月3日随访情况良好。

二十二、腰麻后遗头痛

薛××，女，18岁。因在本院手术后头痛4天，1973年12月10日会诊。

患者12月6日作阑尾摘除术，腰麻后出现头痛，以头顶和前额部最剧烈，并有头晕，不能坐，不能下床。检查发现：面色苍白，舌苔薄白，脉弦细。西医诊断：腰麻后遗头痛。中医辨证系素体虚弱，脑髓失清，经络受阻，引动肝风。采用清头散风，疏经止痛之法治之。取风池、百会、头维、太阳、神庭、合谷用凉泻法，留针20分钟。针治1次，头痛减轻，即能坐起，并能下地。针治2次，头即不痛不晕，能走路。检查恢复正常而停诊。

二十三、多发性神经根炎

宋××，女，3岁，因两下肢瘫痪三天，于1973年10月27日住院。

患者发病前曾有低烧3~4天，近两天来两下肢发软，不能翻身，不能站立，症状逐渐加剧。检查：体温38℃，双上肢活动尚好，不能翻身，不能坐，不能爬，不能站，双下肢不能活动，肌力差，双膝腱反射未引出。血常规：白血球8,400，中性54%，淋巴40%，单核1%，酸性5%。脑脊液：蛋白（-），细胞总数12/立方毫米，白细胞6/立方毫米，糖1~5管阳性。舌红，苔薄白，脉数。中医辨证系五脏受热、耗伤津液，肝肾两虚、气血亏损，筋肉失养。采用清热养阴，益气生津，疏通经络之法治

之。取血海、足三里、隐白用点刺法出血，针治2次体温降至37℃，病情好转后则采用补肾益肝、温通经络之法治之。取肝俞、关元俞、秩边、梁丘、血海、足三里、三阴交由上而下的针刺（“通经接气法”），用热补法，针治4次，左腿能活动，针治12次，两腿能屈伸，治疗到同年11月26日，针达20次时扶着能站立，拉着能走，则改取秩边、血海、三阴交作穴位埋线。治疗到74年3月2日埋线13次时，经检查已完全恢复正常出院。74年9月30日和75年4月15日两次随访，跑、跳活动和健儿一样。

二十四、三叉神经痛

张××，女，50岁，1961年5月12日转诊。

患者于1960年3月开始牙痛，遇冷遇热均痛，有时连及右侧鼻翼、面部、项区，疼痛为持续性，能持续数十分钟不停，痛时喜冷风，因痛不能饮食和睡眠，并伴有头晕、面赤、面热和胁痛，在×医院诊断为三叉神经痛，曾拔去牙齿，服中药等效果不显，现在又出现额部及两太阳穴处疼痛，头皮紧，痛时恶心发热，胸闷气短，心烦口苦，睡眠不佳，大便干燥，以早晨和疲劳后症状加剧。检查所见：血压120/80毫米汞柱，苔白根腻，舌有裂痕，脉弦。中医辨证系肝阳乘胃，风热上扰。采用驱风清热，调和肝胃之法治之。取风池、头维、太阳、百会、合谷用凉泻法，留针10~20分钟，隔日一次，针治3次，头痛眩晕减轻，则改取头维、中脘、天枢、足三里用平补平泻法，针治10次，症状完全消失而停诊。经7月15日随访未复发。

二十五、眶上神经痛

张××，男，29岁，1962年1月19日初诊。

患者于1956年右眉骨处痛，初似针刺，后如刀割，重时伴有呕吐，右眼发胀或跳痛，视力无障碍，每次犯病持续1~2个月，

上午重，下午轻，不犯病时无任何不适，但有时腰痠两下肢无力，病前无外伤及发烧病史。检查所见：右眉骨近中 $1/3$ 处有压痛，颅神经一般正常，其它无异常发现、舌苔薄白，脉弦，左尺较弱。中医辨证系肾虚肝旺，风热上扰。采用祛风止痛，补肾调肝之法治之。取双风池、右攒竹、四白、合谷，用平补平泻法，留针20分钟，隔日一次，针治一次，眉骨痛减轻。第二次配肾俞、关元俞用热补法，不留针，针治3次，眉骨痛消失，腰痛减轻，下肢感觉有力，则减风池、四白、又治疗3次症状完全消失。为了观察疗效，每周复查2次，观察了两周未复发。

二十六、尺神经麻痹

单××，男，7岁，因右手无名指和小指运动和感觉障碍两个月，于1964年7月21日来院治疗。

患者于同年5月18日患中毒性痢疾，神志昏迷，住北京×医院，经用冬眠疗法等措施进行抢救，连续输液3天，病情好转，但发现右手无名指和小指运动失灵，感觉迟钝，皮肤温度较低，经理疗约两个月，无明显效果。检查发现：右手无名指及小指中、末节呈外展屈曲位，曲、伸、内收、外展均乏力，右手拇指内收、屈曲力亦弱，不能持筷。大小鱼际肌肉明显萎缩。小指及无名指尺侧痛觉、触觉和温度觉消失。右侧小指皮肤温度较左侧低 4.25°C ，无名指较左侧低 1°C ，其余3指基本相同，舌苔薄白，脉细。中医辨证系外伤经络，气血不运，筋肉失其营养所致。采用理气活血，温通经络之法治之。取同侧膈会、小海、曲池、外关、腕骨、后溪、中渚、神门、液门、合谷按顺序由上而下针刺（“通经接气法”）用热补法，使温热感觉传导到手指。隔日针灸1次。经过6次针刺治疗后，右手运动及感觉障碍逐渐恢复，肌肉萎缩情况逐渐好转。经过10次针刺治疗后，右手无名指及小指活动幅度增大，伸直尤为明显，感觉消失范围明显缩小，治疗一个

月后，右手无名指及小指活动范围进一步增大，握力明显进步，已能持筷进食，大小鱼际肌肉萎缩情况已有好转，痛觉消失范围进一步缩小，而触觉几乎完全恢复，针刺或触右手小指时均引起相当尖锐的麻感。治疗两个月后，右手运动基本恢复正常，仅右小指稍屈曲，肌肉萎缩情况基本恢复，与健侧无明显差别，痛觉也基本恢复，但较正常部位稍迟钝。自10月中旬以后，改为每周针刺一次，以巩固疗效。至11月中旬停止治疗时，仅右小指末节痛觉稍迟钝，其余均恢复正常。经1965年1月27日复查，情况良好。皮肤温度恢复较慢，且不稳定，开始治疗阶段，正值夏季，气温较高，而右小指皮肤温度大多较健侧明显降低。治疗的后期气温较低，而室内温度保持在20℃左右，患者初入诊室时，两侧皮肤温度相差较多，但经过一段休息后，两侧皮肤温度逐渐接近，说明皮肤温度的调节功能也有进步。

二十七，正中神经麻痹

郭××，男，30岁，1961年8月23日初诊。

患者于40天前，左手背第二掌骨处被机器碰伤。伤口长约一厘米多，失血过多，当即在左腕部上止血带，后又于左上臂根部加止血带，历约两个多小时（中间未松懈过），血方止，去止血带一天后左臂始能上举，但呈腕垂状，不能背曲。经当地医院和北京某医院诊断为臂丛神经损伤和外伤性正中神经麻痹。后转我院时，左前臂肌肉萎缩，左手麻木无力，不能持火柴盒，亦不能握拳，有时手肿。检查所见：左前臂肌肉及大小鱼际肌肉萎缩，左手皮色暗紫，肌张力低，左肘关节可伸直，不能屈曲，左腕可以活动，左手握拳及对掌运动不能，左二头肌腱反射未引出，霍夫曼反射（一）；舌红、苔黄腻，脉沉细稍弦。中医辨证系外伤经络，气血不运，筋肉失养所致。采用理气活血，温通经络之法治之。取左大杼、膈俞、膈会、消泺、曲池、外关、后溪、由背向

下，按肩、肘、手顺序取穴，用烧山火法，使感觉逐渐由肩传导到手，并且曲池、外关、后溪针后用艾条灸15~20分钟，使肌肤温热。第一次针刺时，大杼的感觉可以传导到上臂，臑俞、臑会可以传到肘，曲池仅能传到温溜，外关和后溪的感觉迟钝未见传导。针灸6次，外关和后溪的感觉较前有进步。左手拇指和食中二指对掌运动出现；针灸26次，左手握力增加，能提起小椅子。于10月26日神经科检查：左上肢、肩、肘、腕、指各关节活动范围正常，但腕指关节运动尚欠灵活，左手拇指与各指均可作对掌运动，但与小指仅刚能接触，左上肢力量比右侧仍明显减低，肌张力也差，左上臂及左前臂之周径与对侧之周径相比约小一厘米左右，左手大小鱼际肌及骨间肌仍有萎缩，未见有肌纤维震颤，左上肢之前臂及上臂痛觉稍过敏，以前臂为明显，腕上二厘米以下及手痛觉则迟钝，触觉及冷觉仅腕上二厘米以下及手部减退，运动位置觉无改变。肱二头肌反射右（+）、左（-），肱三头肌反射右（+），左偶尔可叩出，桡反射右（+），左（-），尺反射右（-），左（-），霍夫曼反射右（-），左（-），其余神经系统无明显改变。肌电检查：肱桡肌、肱二头肌、肱三头肌波幅较前高，取穴则改为左侧肩髃、消泺、曲池、外关、中渚、合谷仍用烧山火法，治疗到11月30日，针达40次时，症状基本消失。除肌萎缩无明显改变外，左手皮色，左臂各关节活动范围及对掌运动均恢复正常，左手肌力增加，可持30斤重物；痛觉、触觉冷觉基本恢复；肌电检查有明显进步；治愈回籍。经1962年1月15日随访，患者恢复工作后，照常劳动，左手肌萎缩现象，经过劳动锻炼，恢复正常，与健手无异，亦无其它不舒适感觉。

二十八、巴比妥中毒后遗症

高×，男，21岁。间歇性四肢抽搐，声嘶、步态不稳二年余，1982年5月30日初诊。

其父代诉：患者1980年3月25日上午9时许，误服戊巴比妥28片，5小时后因昏迷、不省人事，呼吸微弱，被家属发现，急送医院抢救，抢救7小时后自主呼吸恢复。二天后并发高烧、肺炎，呼吸困难，而行气管切开术。一周后，拔除气管套管，出现面部抽搐。三周后发现四肢无力，伴有间歇性抽搐，活动受限。一月后出现声嘶，可以下床活动，但步态不稳，仍予以支持疗法。于6月20日再次出现呼吸窘迫，而立即行气管切开术，呼吸困难改善。但后来四肢时有抽搐，步态不稳，上肢呈僵直状态，持续不能改善。在治疗期间作脑电图、脑超声波及脑脊液检查，均无异常发现；五官科检查：双声带不能外展，以左侧为重，声带间三角裂隙仅3 mm。诊断为巴比妥中毒性震颤；双侧声带外展麻痹。仍服安坦及维生素B₆、谷维素等治疗，停药即犯病，并出现食欲和记忆力减退，对往事不能回忆。因此1981年8月去北京各医院求治，效果不显而来我院诊治。检查：神志清楚，表情淡漠，动作迟缓，反应迟钝，颈前气管套管周围稍红，有少许分泌物。声音嘶哑，发音微弱、不清，上下肢肌肉轻度萎缩伴有震颤，站立不稳。舌质紫、苔薄白，脉弦滑。中医辨证系痰湿内停、引动肝风、上扰清窍。采用祛痰利湿、平肝熄风、健脑安神之法治之。取风府、风池，用烧山火法，不留针，神庭、合谷、足三里、三阴交，用平补平泻法，留针30分钟，隔日针一次，十次为一疗程，休息3~5天，再继续治疗。治疗至6月18日，第一疗程结束时，震颤、记忆力好转，食欲增加，手在早晨只震颤20分钟左右，其它时间震颤已不明显，体力有进步，能骑自行车来门诊。安坦由每日三次减二次。治疗至7月19日，第二疗程结束时，拔除气管套管，病情继续好转，食量每日增至1斤，震颤已不明显，说话发音清楚。7月25日，第三疗程开始则改针百会、内关、郄门、足三里、三阴交。安坦每日减为一次。治疗至8月16日，第三疗程结束时，下肢有力、走路稳。9月12日第四疗程开始，停服安

坦等药，改取郄门、足三里、三阴交，穴位埋线，十天一次，治疗至10月20日，埋线三次，症状完全消失，停诊观察。1983年5月6日随访，未复发。

二十九、植物神经功能紊乱

芦××，男，37岁，天水军分区干部。因头晕腹胀一年，1979年11月10日初诊。

患者自述1978年12月31日误服“合霉素粉”两次，共7g，当日下午即觉头晕，晚上觉得鼻子里响了一声后，即觉全身冰冷，浑身往一起抽，即往133医院，血化验发现：白细胞内有中毒性颗粒，经治疗好转，但以后经常全身不舒适，尤其是晚上鼻子里一响，即觉整个腹部胀满、头晕，到天水精神病院诊断为中毒性神经功能紊乱，治疗未见好转，到兰州总院住院，作心电图、脑电图等检查基本正常，诊断为植物神经功能失调，治疗亦未见明显好转，现在觉得小腹内有一股气从小腹往上冲，腹部膨胀，胃部有热气，口鼻发干，舌发硬，胀过后肠鸣，肠鸣后全身收缩或抽动，发作多在夜里1—5点钟左右，有时一夜发作四次，每次发作10分钟左右，痛苦难忍，不能入睡，而来我院。检查：血压96/64mmHg，脉搏80次/分，神清，精神尚可，两侧瞳孔等大，心肺（-），腹部平软，肝脾未触及；生理反射存在，病理反射未引出，舌苔薄白，脉弦细。西医诊断为植物神经功能紊乱；中医辨证系七情郁结、引动肝风、逆气上冲、侵犯神明。采用舒肝解郁、祛风安神之法治之。取1.风池、百会、神庭、合谷、神门；2.中脘、育俞、气海、气冲、公孙；用平补平泻法，留针30分钟，两组穴位交替轮换使用，每日针一次。针治二次时，睡眠好转；治疗到12月20日，针达十次时，小腹内气往上冲、腹胀肠鸣、全身收缩抽动的感觉已两天未发作，食欲增加、精神好转，停诊观察。1980年9月12日随访，停诊上班后一直未复发。

三十、两手震颤

谈××，男，21岁，1961年3月2日初诊。

患者由十岁开始在精神紧张及作精细手工时，即两手震颤，当精神和注意力集中时则震颤加剧，能持续数分钟或数小时不等。以前在站队、集合紧张时，两侧小腿亦有同样的现象发生，近两年来未发作，但两手震颤不断发作已十年之久。曾在北京×医院诊断为麻痹性震颤。经常大便带血，鼻衄血，有时头晕，烦躁起急。检查所见：血压106/64毫米汞柱，患者伸直前臂两手明显震颤，脉沉细无力，苔薄白，中医辨证系气血虚弱，肝木失养，虚风内动，神不自主。采用调胃健脾，补气养血，柔肝熄风，安神定志之法治之。取中脘、足三里、合谷用平补平泻法，留针10分钟，每星期针2次，针治4次手颤减轻，但鼻仍衄血，大便仍带血。则配大肠俞、二间、神门用平补平泻法，又针治2次，大便带血和鼻衄血即停止，治疗到4月30日，针达16次时，手颤已不明显，便血和衄血未复发而停诊。

三十一、功能性震颤

魏××，女，43岁，成县县委干部。因双手颤抖两年，1978年6月8日初诊。

患者两年前曾患失眠症，后来出现两手伸直或写字时发抖，逐渐加剧，现在写字困难，拿东西也发抖，曾服用安定、利眠宁等治疗无效。检查：甲状腺不大，心、肺（-），肝脾未触及，脑血流图结果正常。舌质红稍干、无苔，脉弦细，76次/分，两手震颤不停。西医诊断为功能性震颤；中医辨证系肝阴不足、血虚生风。采用镇肝育阴、养血熄风之法治之。取郄门、内关、大陵，三阴交，用补法，留针20分钟。每日针一次，针治四次，两手震颤好转。治疗到7月28日，针达三十次时，两手震颤停止，治愈。

停诊。同年12月20日随访，未再复发。

三十二、一氧化碳中毒

罗××，女，67岁，因昏迷不醒一个半小时，于1961年1月13日下午6时抢救。

患者平素体弱，其女代诉，发病当日上午自觉头晕，视物不清，烦热多汗，全身乏力，但仍坚持厨房劳动，下午五时左右自觉头晕身软欲倒，即呼其女，前往时见已倒地，随抬至床上问不作答，手脚发凉且发硬，当即注射强心剂，吸氧进行抢救，一小时后仍昏迷不醒。检查所见：仰卧在床，面色苍白，口噤不开，四肢厥冷，问不作答，呼吸平稳，一分钟24次，脉数有歇止100次/分，腹肌稍硬，目闭不睁，指拨眼睑有抵抗感，伴有震颤，瞳孔不等，左>右，右光反射消失，左存在，两眼球不自主的转动。针刺各处均无反应。不能作自主运动，双上下肢均伸直，肌张力强，未见偏瘫现象，生理反射存在，颈项强直。经西医诊断为一氧化碳中毒，采取各种措施急救，效果不佳，邀我会诊，辨证为年老体衰，邪毒乘中，心窍蒙闭，神志不清，阳气闭郁，四肢厥冷，经脉受阻，全身强直，属于祖国医学中闭症、厥症、风症之类。采用通关开窍，清热熄风，调气活血，疏通经络之法治之。取十王用点刺法出血，合谷、足三里、涌泉用速刺法，针后用纸烟喷鼻孔，仍无反应，仍给吸氧，并针素髎、人中用速刺法、上迎香用搜法，针后打喷嚏后，眼睑、手指和口即有微动，又针内关后出现谵语，复又针人中、后溪，问其喝水？患者开始点头，当即给水二匙，神志逐渐恢复，至夜间12点即复如常人。

三十三、椎间盘脱出

吴××，男，12岁，成县沙坝乡农民。因双腿活动受限三个月，1977年11月21日住院。

患者三个月前走路时被人推倒跌伤，当时腰痛难忍，不能行走。自此以后两腿不能活动，小便不能控制，在当地卫生院治疗效果不显而来住院。检查：脉搏104次/分，呼吸24次/分，慢性病容，神志清楚，体查合作，皮肤、巩膜无异常，瞳孔等大，对光反射存在，扁桃体、咽部无异常，心肺（-），腹部平软，腰部两侧不对称，右侧突出高起，不能俯卧，腰椎3、4、5压痛明显，两侧脊背肌压痛，以右侧为重，双下肢屈曲受限，可伸展，感觉存在，膝腱反射减弱，余（-）。尿检正常，血常规：血红蛋白11g，白细胞5800，中性77%，淋巴22%，单核1%，血沉3mm/小时；腰椎正侧位片：正位1—3腰椎向右侧弯，其他椎体及间隙均未见异常，胸椎1—12椎体骨质完整。舌苔薄白，脉细数。西医诊断为椎间盘脱出；中医辨证系经筋受损、瘀血停留。采用活血化瘀、疏筋利节之法治之。取胆俞、脾俞、胃俞、肾俞、关元俞，用烧山火法，不留针；气海、血海、阳陵泉、三阴交，用平补平泻法，留针20分钟，两组穴位轮换交替使用，每日针二次，治疗至12月12日，针达三十六次时，腰腿痛减轻，即能俯卧和能走几步。治疗至12月16日，腰腿痛消失，小便能控制，能站立小便，并能走一里路，即出院。1978年3月15日随访，完全恢复正常。

三十四、骶椎腰化伴坐骨神经痛

杨××，男，23岁，武都地区交通局司机，因腰腿痛三个月，1977年9月28日住院。

患者1976年7月开始腰腿痛，逐渐加剧，去武都地区医院拍片诊断为第一骶椎腰化，坐骨神经痛。治疗后未见明显好转，并出现肌肉萎缩，不能走路，站立不能持久而转来住院治疗。检查：体温37℃，心率79次/分，血压80/42mmHg，痛苦病容，舌苔黄腻，脉弦滑，站立不稳，走路困难，第一腰椎棘突明显压痛，两志室穴处有块状硬结，有明显压痛，左侧臀部和下肢肌肉

明显萎缩，并有压痛，两下肢周径膝上10公分处左44公分、右47公分，膝下20公分处左29公分、右32公分。西医诊断为①坐骨神经痛，②骶椎腰化。中医辨证系腰肾素虚、筋肉失养。采用补肾培元、疏经止痛之法治之。取①志室、环跳、殷门、承筋，②关元俞、秩边、承山、飞扬；两组穴位交替轮换使用，用热补法，留针20分钟，每日针一次，十天作穴位埋线一次。治疗至10月8日，针达十次、埋线一次时，腿痛减轻，治疗至10月20日，针达二十次，埋线二次时，下肢能站立，并能走路。治疗至11月2日，针达三十次，埋线三次时，腰腿痛等症基本消失，两下肢周径：膝上10公分处左45公分、右47公分，膝下10公分处左30公分、右32公分。血压100/50Hg。治疗至11月28日，症状完全消失而出院。同年12月29日复查两下肢周径：膝上10公分处：左47公分、右47公分，膝下10公分处：左32公分、右32公分。1978年11月25日随访，早已恢复工作，一直很好。

三十五、荐肠关节结核（骶髂关节结核）

郭××，女，28岁。1953年11月14日初诊。

患者于1950年11月开始腰背部肿痛和腿痛，逐渐加剧，于1951年5月在北京×医院作子宫肌瘤摘除手术，住院28日，于52年4月16日和5月5日在北京某医院前后在腰荐部抽脓两次，又照X线像7片，最后症状恶化，腰荐部肿痛引起背部及下肢肿，手腕和膝脚关节疼痛，脊柱不能侧弯，不能坐、不能站、不能翻身，卧床不能动已18个月之久。月经24天1次，白带多。1951年5月19日X线第一次照片结果：两侧荐肠关节下部骨质稀疏散乱，关节腔扩张，有骨质破坏，右侧较重，上部骨盆腔至第四腰椎下缘，有圆形较致密之阴影，似有一肿瘤或长大之子宫，下部腹腔及骨盆腔有钙化阴影。1952年4月10日X线第二片前后位，右侧荐肠关节腔明显扩大，关节骨质破坏显著，在肠骨上有一锐

利之边缘，骨盆腔中阴影已消失，两侧髋骨关节正常及第五腰椎亦未发现骨质破坏现象。右侧荐肠关节结核性病灶，较前破坏显著，左侧似亦不健全。1953年5月23日腰荐椎第3～4片正侧位，腰椎未见骨质破坏及增生现象，椎间隙不狭窄，腰大肌影象清晰，未见膨隆，右侧荐肠关节结核与52年4月10日比较无明显改变。检查所见：右侧荐肠关节部有抽脓遗留之针痕，腰荐部至胸背部软组织隆起，触之坚硬有压痛，腰荐不能屈曲，两腿外侧肿，右腿尤甚，红线状血管丛生，有淋巴血循环瘀滞现象，不能翻身，不能坐，动转困难，颜面潮红，舌苔薄白，脉细，脉搏82次/分。中医辨证系正虚邪实，精血败伤，痰浊流注、结于腰胯。采用扶正祛邪，化痰散结，舒经活血之法治之。取风门、大椎、膀胱俞、腰阳关用平补平泻法，肾俞用进火补法，不留针，每星期针2次。1954年2月4日腰荐椎第5～6正侧位，右侧荐肠关节结核抽脓2次后所见，与一年前照片所见同，腰椎1～5未见病变。针至54年3月14日，针达30次时，肿痛见消，患者即能翻身起坐，又继续治疗两个月（针16次），腰背部及下肢肿痛基本消失，亦无明显压痛，但在荐肠关节部尚有纤维硬结（可能是脓疡吸收后的瘢痕），此时患者即能扶杖步行。又继续治疗两个月（针15次），不扶杖自己能上下电车，随便走路，为了继续观察病理变化和结果，每1～2星期复查和针治1次，至1955年3月20日症状一直减轻，背部之肿胀压痛完全消失，右荐肠关节部之结节特别减小，亦无压痛，并能弯腰，做些轻微工作。1955年3月14日荐肠关节像第7片正位，右侧荐肠关节结核抽脓二次后所见：关节腔增宽，关节腔边缘骨质尚清晰锐利，左侧荐肠关节清晰。1955年8月11日复查情况良好。X线照片荐肠关节前后位，两侧结核性荐肠关节炎强直型，全愈状态而停诊。又经过一年随访未复发。

三十六、大骨节病

杨××，男，17岁。因四肢关节肿痛5年，1970年10月9日来我院。

患者12岁发现下肢和两手关节痛，手指和踝关节逐渐肿大疼痛，后来又发展到腕、肘、膝关节肿大变形，活动困难，不能走路。检查发现：身体矮小，身高1.48米，体重91斤，肘、腕、指、膝、踝关节肿大变形。肘不能伸直，指呈梭形，不能握拳，踝关节活动困难。面色黑紫，舌苔薄白，脉缓。中医辨证系肝肾不足，风邪乘中，著于筋骨，关节变形。采用补肾益肝，驱风化湿，疏筋利节之法治之。取曲池、外关、阳池、合谷、鹤顶、膝眼、足三里、三阴交、丘墟用热补法，留针15分钟，针治10次，膝关节肿见消，疼痛减轻。则改取曲池、天井、阳池、八邪、三阴交、解溪、商丘，针治25次时，肘、指、膝、踝关节肿痛明显好转，肘能伸直，腿能走路。治疗到1971年5月11日，针达140次时，各关节肿痛基本消失。继续治疗观察情况良好。75年8月29日随访，已参加工作。

三十七、腰椎压缩性粉碎性骨折

赵××，男，39岁。因腰部跌伤12天，1975年3月7日住院。

患者今年2月23日坐拖拉机翻车，跌伤腰部，当即腰腿疼痛不能活动，坐、立均感困难，但受伤后下肢活动良好，小便正常。经在207医院X线照片发现腰₁压缩性骨折，并有脊突粉碎骨折。检查：神志清楚，心、肺正常，腹胀但无压痛，肝、脾未触及，四肢活动如常。痛觉存在，患者取俯卧位后，在胸₁₂~腰₁软组织肿胀，稍微后突，并有明显压痛，两下肢承山穴处有压痛以右侧为著。苔薄白，脉弦。中医辨证系筋骨受损，瘀血停留。采用活血散瘀，疏通经络，培补肝肾之法治之。取阿是穴围刺，肾俞、关元俞、秩边、承山用热补法，不留针，针治10次，胸₁₂~腰₁后突处肿痛明显减轻，臀部和下肢已不痛，则减秩边、承山，

仍按前法治疗。治疗到3月30日，针达20次时，腰背部疼痛明显减轻，胸₁₂~腰₁软组织肿胀及后突已不明显，亦无压痛。患者已能坐起，下肢活动自如。治疗到4月10日，针达30次时，患者能扶床下地走动。治疗到4月23日，针达40次时，不扶东西能走路，治疗到5月15日，针达60次时，腰和下肢活动自如，基本恢复正常，能走5里路而出院，恢复了工作。同年9月22日和11月29日两次随访情况良好。

三十八、下肢静脉曲张并发血栓性静脉炎

贾××，男，48岁。因右小腿起疙瘩胀痛4个月，1974年8月3日来我院。

患者1950年右下肢感染后皮肤发黑，68年发现右小腿静脉曲张，今年4月30日在水市医院确诊为右下肢静脉曲张并发血栓性静脉炎，经服中西药物治疗有所好转，但小腿之肿块胀痛不减轻，并且下午肿痛加剧。检查发现：右小腿至足背皮肤黑色，静脉曲张，由膝窝至内踝有结节硬块，连成一片，压之胀木。舌紫，苔薄白，脉弦细。中医辨证系瘀血凝滞，经络不通。采用活血化瘀，温通经络之法治之。取血海、足三里、阴陵泉、承山、三阴交、太冲用热补法，留针10分钟，起针后用梅花针沿着静脉曲张和结节肿块的部位由下而上的、由轻而重的，作中等度叩打5分钟。治疗10次，小腿肿见消，每次针后自觉下肢有蚁走感，一直保持一天，胀痛减轻，并发现皮肤黑色变浅，静脉曲张好转，结节硬块变软，变小（由连成一片，变成9块），休息10天，8月23日减足三里，仍用前法治疗到9月5日，针达20次时，病情逐渐好转，治疗到同年10月15日，针达30次时，小腿已不胀痛，下午小腿已不肿，结节硬块基本消失，静脉曲张基本恢复正常而停诊。1975年1月26日随访，右下肢皮肤颜色由黑变灰，病已全愈。

三十九、面肌痉挛

陈××，男，20岁，武都地区师范学校学生。因左侧面部跳动两天，1981年1月30日初诊。

患者前两天晚上睡时被风吹了左侧头面部，第二天感觉左上眼睑跳动，逐渐发展到下眼睑和嘴角抽动、麻木。检查：左上、下眼睑和口角阵发性痉挛，左面部皱纹减少，皱眉时特别明显，左鼻唇沟变浅，闭口时口角向右歪斜，舌质紫，苔薄白，脉浮滑，82次/分，右大于左。西医诊断为面肌痉挛，中医辨证系风寒侵袭，头面部经络郁阻。采用祛风散寒、疏经活络之法治之。取双风池，用烧山火法，不留针，使之出汗；右地仓透颊车、合谷，用平补平泻法，留针30分钟，每日针一次，治疗至2月3日，针治四次时，面部抽搐停止，左眼能闭，口角有些露气。治疗至2月20日，针达十五次时，完全恢复正常，治愈停诊。同年8月20日随访，未复发。

四十、腓肠肌痉挛

李××，男，30岁，成县支旗乡农民。因小腿肚经常转筋，1971年1月20日初诊。

患者三年前因过河涉水后出现右小腿肚转筋，以后遇到寒冷天气或受凉就犯病，近一个月来两侧交替转筋，疼痛难忍，频繁时每日发作1—3次，曾服用钙剂、镇痛剂未见明显效果。检查：痛苦病容，右腓肠肌挛急、僵硬、压痛、不得屈曲，不红肿，其它未见阳性体征，舌苔薄白，脉弦紧，82次/分。西医诊断为腓肠肌痉挛，中医辨证系风寒侵袭、阻塞经络。采用驱风散寒、疏经活络之法治之。取承山、三阴交、用烧山火法，留针30分钟，在留针期间5—10分钟操作一次，使其产生热感出汗，留针20分钟时痉挛和疼痛缓解；第二日来门诊时未发作。为了巩固

疗效，又按上法针治一次停诊观察。同年4月2日随访，未再复发。

四十一、进行性肌营养不良症

苏××，男，15岁，成县一中学生。因两下肢走路困难十天，1973年1月29日初诊。

患者1972年11月发现两下肢痠痛，逐渐加剧，经服止痛药疼痛好转后，自觉两下肢麻木无力，又经城关医院治疗，两下肢麻木减轻，逐渐发展为小腿肌肉萎缩，走路困难，经常跌倒。检查：身体消瘦，血压120/80mmHg，心、肺、肝、脾（-），两下肢小腿肌萎缩，鸭行步态。颈软，两上肢肌力、肌张力对称；两下肢肌力Ⅱ—Ⅲ级，肌张力减退。两膝反射、跟腱反射消失，病理反射未引出。全身痛、触觉正常。面色苍白，舌质淡，苔薄白，脉沉细，78次/分。西医诊断为进行性肌营养不良；中医辨证系气血不足、筋肉失养。采用补气益血、舒筋活络之法治之。取关元俞、秩边、足三里、三阴交，用热补法，留针20分钟，每日针一次，十次为一疗程，每疗程休息十天，在休息期取足三里、三阴交，作穴位埋线。治疗一个疗程后，患者感觉走路有力，已不跌倒；治疗两个疗程，病情继续好转，鸭行步态已不明显，行步基本平稳；治疗三个疗程后，两下肢走路有力，能步行五里路，检查肌力、肌张力、肌萎缩等基本恢复，即停诊。1975年2月1日随访，未复发。

四十二、慢性盆腔炎

姜××，女，22岁。1954年10月12日初诊。

患者由14岁月经初潮，经期一直错后，阴道经常有茶色分泌物，且痛经剧烈，有时因腹痛而失去知觉，结婚五年无生育。由1953年出现腰痛，饮食减少，精神不振。在天津某医院诊断为盆

腔炎，曾作烤电、组织疗法和药物治疗五个月。检查所见：小腹
部有似鸭蛋大小硬块压痛，按之不散不移，腰部和臀部有压痛，
以关元俞处最明显，苔薄白，脉弦细。中医辨证系气血虚弱，寒
滞血凝。采用温经散寒，补气益血之法治之。取肾俞、关元俞、
腰阳关、上髂用热补法，不留针，隔日一次，针治7次，腰腿痛
基本消失，则配中脘、气海、关元、足三里、三阴交用热补法，
使腹部和小腿有热感，留针10分钟；和上述穴位交替轮换使用，
治疗到3个月，针达25次时，痛经病已愈，其它诸症基本消失，
则改为每月经期针治2次，观察到1955年5月7日即愈。1956年
8月来信，病愈后身体健康，并生一女孩，寄来像片留念。

四十三、功能性子宫出血

贺××，女，37岁，成县县委家属。因子宫流血反复发作三
年，1970年5月18日初诊。

患者1967年4月在武都地区医院生小孩三天后做绝育手术，
术后出血过多，自此以后每二十来天见月经一次，大量流血4—
6天，有时停两天再来，1969年10月病情加剧，每月行经两次，
每次6—9天，量特多，往下流，每日流4—6痰盂，全身无
力，无气力说话，吃饭都得休息几次，消化不良，不能吃，腹
痛、早晨泻肚，头晕、失眠，经常整夜不能入睡，有时腿不会活
动，不能下床已6个月。检查：精神不振，面色苍白，浮肿、两
腿有凹陷性水肿，声音低怯，舌质淡、苔薄白，唇淡白，脉沉细
无力，血红蛋白5g。西医诊断为功能性子宫出血；中医辨证系
失血过多，气血两脱。采用回阳救脱、固气摄血之法治之。取隐
白、三阴交、人中，用补法，留针20分钟，每日针一次。针治三
次时，出血停止，改针1.中脘、天枢、气穴、三阴交；2.风池、肾
俞、关元俞、血海，用补法，留针20分钟，交替轮换使用，隔
日针一次，治疗至10月1日，针达五十二次时，症状基本消失，月

经每月一次，每次3—6天，基本正常，但仍是月经来三天，隔两天再稍见些月经。治疗至10月23日，针达六十次，症状完全消失，饮食睡眠恢复正常，能参加家务劳动而停诊。1971年12月12日随访，未复发。化验：血红蛋白11g。

四十四、产后感染

张××，女，27岁，成县副食品厂工人。因产后半月发烧发冷四天，1979年6月22日住院。

患者怀孕二次，生产二次，皆是男孩。1979年6月6日最后一次分娩，是由旧法接生娩出，产后出血较多，胎儿娩出后10分钟胎盘娩出，胎盘是否残留不清楚，至今阴道还是少量流血，恶露不多，但淋漓不尽，自述会阴裂未缝，轻度疼痛，近四天来伴有发冷发烧而住院。月经史：16岁月经初潮，25天一次，持续5天，量不多，平常白带多。婚史：24岁结婚，26岁第一胎，爱人身体健。检查：体温39.9—40.04℃，脉细数，116次/分，血压114/70mmHg，面色苍白，体瘦、营养差，言语清楚，肺(-)，心率快，心尖部可闻及Ⅱ级收缩期杂音，腹软，肝脾未触及，腹部无压痛，肠鸣音不亢进，宫底触不到，会阴裂伤Ⅰ度，余未查。血常规：血红蛋白6.5g，白细胞15500，中性88%，淋巴11%，嗜酸1%。西医诊断为产后感染，中医辨证系产后血虚、感受风寒。采用驱风散寒、补肾培元之法治之。取风池、大椎、陶道、身柱、至阳、命门、肾俞，用烧山火法，不留针，每日针一次。针治一次，体温降至39℃，针治二次，体温降至38℃；针治四次，体温降至37℃；治疗至6月27日，针达五次时，没再发烧；改针：命门、肾俞、血海、三阴交，用热补法，以培元养血，治疗至6月30日，针达八次时，症状完全消失，治愈出院。同年10月28日随访，早已上班工作，情况良好。

四十五、产后无乳

贾××，女，24岁，兰州友谊饭店干部家属。因产后无乳十三天，1982年12月23日初诊。

患者怀孕期间食欲特好，身体健康，生下女孩后的第二天开始，只觉得肚子里饿，但看见平时爱吃的东西，无论什么东西都不想吃，每天只能喝点水或米汤，一天不足三两，小孩生下后一直没奶。检查：乳房不饱满，无压痛，腹部中脘、下脘、左天枢穴处有明显压痛，舌苔白厚腻，脉弦细而数，90次/分。西医诊断为产后无乳；中医辨证系肝郁气滞、中气不足。采用舒肝解郁、补中益气之法治之。取中脘、下脘、天枢，用补法，期门，用平补平泻法，留针20分钟。12月25日复诊，针后第二天患者饮食增加，乳房有胀感，乳头有清水。检查：中脘、下脘穴处压痛消失。改针膻中、中脘、天枢、少泽，用平补平泻法，留针20分钟。12月27日三诊，患者自述上次针后1—2小时乳汁即下。1983年1月13日随访，患者自述针过两次后乳汁很多，一直很好。

四十六、慢性毛囊炎

崔××，男，45岁，1957年4月23日初诊。

患者项部发际长疮疖，随起随落，缠绵不断已20年，疖肿消退后常遗留硬核，数年不能消失，经常痒痛流水。检查所见：项部发际片片红疤多处，新起如黄豆大之疖肿四个，并有红尖，左天柱和右风池穴处各有似枣大之硬核一个。舌苔薄白、脉弦滑。中医辨证系热毒上冲，流于项部血络。采用清热解毒，疏经活血之法治之。取风池用凉泻法，不留针，大椎、身柱、灵台、筋缩、脊中、命门，腰阳关、腰俞用丛针扬刺法出血。并用赤小豆粉调鸡蛋清成膏，放在布上贴患处。每星期二次，针后7天新起小疖肿消失，硬核见软，第三次针后硬核渐消，痒痛消失，疖肿亦未

起，经过半年后随访未见复发。

四十七、酒皰鼻

萧××，男，29岁。1961年8月15日初诊。

患者鼻尖红，皮脂腺分泌多，常自毛孔挤出油脂样物，并长脓疱已两月。近一个月来又出现胃痛。检查所见：鼻尖红，毛细血管可见，皮脂腺分泌较多，腹软剑突下有压痛，无反跳痛，其它无异常发现，舌净，脉弦。中医辨证系热郁肺胃，风热上攻，瘀血停留。采用清热散风，活血化瘀之法治之。取素髻用点刺法出血，双迎香、合谷用凉泻法，留针15分钟。胃痛时加中脘、足三里用平补平泻法，留针15分钟。隔日一次。针治3次，鼻尖红减轻，油质分泌物减少，胃痛已减轻；治疗到9月8日，针达12次，鼻尖基本不红，分泌物已不显，胃痛亦消失。又针治4次，观察到10月4日，治愈停诊。

四十八、带状疱疹

沈××，女，59岁，1960年4月20日初诊。

患者背部左侧出红点，逐渐扩大，肿痛异常，夜间疼痛较剧，痛时烦躁不能入睡已一月。有时头晕，手抽，腿痛，食欲不振。检查所见：面色红润，左背部至左侧胸部有颗粒状小疮疖，尖部有脓，底部红赤、成线状及片状排列，连接到后背的督脉，前至胸部的任脉，以膻中穴处最明显，右侧的心俞穴处也有一片，但尚未连接。舌红、无苔，声音嘶哑，脉沉细稍弦。中医辨证系肝火久郁，湿热内蕴。采用清肝泻火之法治之。取膻中、玉堂、大椎、陶道、身柱、神道、双心俞、肝俞用丛针扬刺法出血，不留针，先刺病的开始部位，最后再刺病的尾端，俗称“截断头尾”。然后取双神门、内关用凉泻法，留针15分钟，每日一次，针治二次，疼痛停止，红点减少，肿疖尖部之脓点消失，颜

色变紫，针治5次，肿痛消失，病愈停诊。

四十九、顽固性荨麻疹

王××，女，40岁，成县百货公司售货员。因全身间歇起疹、瘙痒难忍十年，1970年9月9日初诊。

患者1960年开始全身起疹，形如米粒，逐渐发展成云片状，微突出皮肤，瘙痒难忍，阴雨天加剧，夜不能入睡，影响工作和休息，曾用中西医药物治疗未见好转而来我院。检查：全身多处出现风团样的皮疹，高出皮肤表面，边缘清楚、色淡，周围有抓痕及血痂，舌苔薄白，脉弦滑，78次/分。西医诊断为顽固性荨麻疹；中医辨证系体表素虚、风湿外侵。采用祛风利湿、活血固表之法治之。取曲池、合谷、风市、血海、足三里、三阴交，用平补平泻法，留针20分钟，每日一次；针治三次时，皮疹渐消，瘙痒减轻。治疗至9月20日，针达十次时，症状完全消失，治愈停诊。同年12月12日随访，未再复发。

五十、过敏性紫癜

陈××，女，12岁。因两下肢出现紫斑点半个月，1975年12月8日来我院。

患者半月前两下肢突然出现密集的斑点，大者呈片状，以伸面分布较多，并有两腿痛，两膝关节尤为严重，阴天下雨疼痛加剧，服药治疗效果不显。检查：神志清楚，心肺正常，两下肢由大腿根往下至脚腕全部呈弥漫性紫红色斑出血点，略高出皮面，指压不退色，两膝关节不红肿，血常规：血色素10.5克，白血球 7^{100} ，中性60%，淋巴37%，单核1%，嗜酸2%，血小板16.5万，血沉3毫米/第一小时，舌苔白腻，脉弦滑。中医辨证系寒滞经脉，瘀血停留。采用温通经络，祛寒利湿，活血化瘀之法治之。取风市、阴市、血海、足三里、三阴交用烧山火法，留针20

分钟，治疗到12月16日，针达8次时，紫斑出血点完全消失，仍有痕迹，触之扎手，即停诊。同年12月30日复查、完全恢复正常。

五十一、翼状胬肉

杨××，女，38岁，成县182地质队工人。因左眼大眼角长鱼肉一年余，1979年2月14日初诊。

患者1977年底发现左眼内眼角长出一条粉红色的鱼肉，不痛不胀，1979年2月长势很快，现已遮盖半个瞳孔，影响看东西。追其发病原因，患者每日多食辣椒。检查：左眼内眼角粉红色翼状胬肉已侵入半个瞳孔，并有血管丛生，舌质胖、苔白，脉缓而稍弦，70次/分。西医诊断为翼状胬肉；中医辨证系恣食辛热、肺实肠燥、经络瘀滞。采用清肺润燥、泻肠导滞、疏经活络之法治之。取攒竹、少商，点刺出血；内睛明，用压针缓进法，留针10分钟；合谷，用泻法，留针20分钟，每日针一次；治疗至17日，针达三次时，翼状胬肉渐消，已露出瞳孔。治疗至3月14日，针达十二次时，翼状胬肉消失，治愈停诊。同年7月1日随访，未复发。

五十二、青 光 眼

郑××，男，63岁。1958年6月20日初诊。

患者左眼球发胀，视物模糊，头晕痛，眼压高已一年。近三个月来，有时恶心呕吐，曾在北京×医院诊断为青光眼。检查：视力右 1.2^{-2} ，左 0.8^{+3} 。眼压：右32毫米汞柱，左40毫米汞柱。视野：左眼鼻侧显著缩小。舌苔薄白，脉弦滑。中医辨证系肾阴不足，肝阳上亢，睛目失养。采用养阴平肝，疏经活络，清头明目之法治之。在视物模糊时取风池、丝竹空、攒竹用平补平泻法，内睛明用压针缓进法，以清头明目。呕吐恶心时配中脘、内关、足三里用平补平泻法，留针20~30分钟，以降逆和胃；头昏

痛或眼压高时，配合谷、光明、三阴交用平补平泻法，留针20~30分钟，以养阴平肝，疏经活络。隔日一次，针治10次，左右眼压均降至25毫米汞柱。针治48次，视力右：1.2，左：1.5。眼压右：22毫米汞柱，左：25毫米汞柱。又治疗22次，观察了两个月，未复发即停止治疗。

五十三、视网膜脉络膜炎

姜××，男，48岁。1956年5月29日初诊。

患者左眼视力减退，视物动荡，视野缩小，有时左眼胀痛已三年。曾经北京×医院诊断为陈旧性视网膜脉络膜炎。检查：视力左0.3，眼底左屈光间质模糊，乳头稍发赤，周围有灰白色渗出环绕，外上有色素块，乳头外上约 $\frac{1}{2}$ 乳头直径距离处，有约二个乳头直径大小之陈旧病灶，色素暗灰，并杂有许多色素点，下方可透见脉络膜血管。视野：盲点较大，乳头下方有实性暗点，舌苔薄白，脉弦。中医辨证系肝肾不足，瘀血停留，络脉受阻，血不荣目。采用培补肝肾，活血化瘀，益精明目之法治之。取风池用烧山火法，不留针，攒竹、瞳子髎、肝俞、肾俞用平补平泻法，内睛明用压针缓进法，留针20~30分钟。针治49次，症状完全消失。检查视力左：0.8，视野盲点比前缩小。眼底无显著变化。即恢复了工作。

五十四、电光性眼炎

梁××，男，20岁，成县面粉厂工人。因两眼肿痛两天，1980年7月20日初诊。

患者昨天下午6点钟电焊时没有做好防护工作，电焊后1小时开始双眼疼痛，夜间疼痛加重，灼烧怕光，流泪及异物感。第二天来院诊治。检查：眼眶周围红晕，眼睑水肿、痉挛，球结膜

中度充血，角膜肉内眼检查透明，虹膜肉纹理清晰，前房正常，瞳孔等大，光反应良好。舌质红、苔薄白，脉滑数，84次/分。视力：右，远0.6、近1.2；左，远0.7、近1.2；西医诊断为电光性眼炎；中医辨证系火光侵袭、热蕴睛明。采用清热泻火、养阴明目之法治之。取太阳、四白透睛明、合谷，用泻法，攒竹、少商，点刺出血，每日针一次，针治一次肿痛减轻；治疗至7月25日，针治四次时，肿痛完全消失，视力：右，远1.2、近1.2、左，远1.2、近1.2。视力恢复正常而停诊。同年8月10日复查，完全恢复正常已上班。

五十五、麻痹性外斜视

冯××，女，14岁，成县抛沙乡农民。因视物不清楚六天，1970年6月28日初诊。

患者今年6月23日被木棍砸伤头部后，自觉看东西时，常看成两个（一个真的物体，一个影像），但有时分不出真假；有时头晕、头痛。检查：经角膜光反射法进行斜视角检查，其右眼向外偏斜约32度，体质营养中等，面色、精神正常，舌苔薄白，脉弦，74次/分。西医诊断为麻痹性外斜视；中医辨证系击伤经络、瘀血滞留。采用活血化瘀、疏通经络之法治之。针双风池、合谷、右攒竹、上睛明，用平补平泻法，留针5分钟，每日针一次；针治二次，头痛、头昏，复视减轻；治疗至7月10日，针达十次时，症状完全消失，治愈停诊。同年10月1日随访，未复发。

五十六、麻痹性内斜视

马××，男，16岁，成县阵院乡农民。因看东西不清楚半年，1971年6月15日初诊。

患者半年前不慎跌倒碰伤头部，伤愈后觉得看东西模糊，有时看一成二，有时头痛。检查：双外眼正常，瞳孔等大，平视时右

眼内斜视45度，右眼球外展受限，视力0.2，有时复视；左眼正常，视力1.2。舌苔薄白，脉弦，80次/分。西医诊断为右眼麻痹性内斜视；中医辨证系外伤经络，瘀血停留。采用活血化瘀、疏经活络之法治之。取双风池、合谷、右瞳子髕、丝竹空，用平补平泻法，留针5分钟，每日针一次；针治二次，头痛、复视好转，针治十次后，症状完全消失。检查：双眼平视时，眼球正位，右眼外展超过中线15度，两眼视力均为1.2。同年10月2日随访，未复发。

五十七、鼻 衄

孙××，女，16岁，成县一中学生。因鼻子反复出血三年，1972年3月28日初诊。

患者三年前跑步时突然鼻子出血，以后经常发作，近三个月来病情加剧，4—5天鼻子出血一次，每次流血100—150毫升，发作时必须用明胶海绵止血，曾到城关医院，县医院多次检查未见异常，服中西药物也未见明显效果，现在头晕、疲乏、有时口干、恶心、鼻干、大便干、小便黄。检查：舌质红、苔薄白，脉细数，84次/分，血红蛋白10g，红细胞380万/mm³，血小板20万/mm³。中医辨证系阴虚火盛、上灼肺金、肠腑燥结、血热气逆发为鼻衄。采用养阴清肺、润肠止血之法治之。取少商、商阳，点刺出血，合谷、三阴交，用平补平泻法，留针30分钟，针后鼻衄即止，每日针一次；针治六次，未复发，停诊观察。5月1日随访，患者停诊后，症状完全消失，大小便正常，一直很好。1973年1月20日随访，未再复发。

五十八、慢性上颌窦炎

梁××，男，18岁，于1961年8月24日转诊。

患者鼻涕多，冬季为脓性涕，夏季为清涕，鼻塞不通已三

年，有时头昏、头痛，不能坚持读书，但身体较健。检查所见：两耳鼓膜内陷，外耳道和咽部未见异常，鼻粘膜暗红色，轻度水肿，其他未见异常。X线照片：双侧上颌窦普遍透明度减低，沿窦壁内缘并可见一层致密阴影，以右侧上颌窦下外方为主。两侧筛窦观察不够满意。脉弦滑，苔薄白根腻。中医辨证系风热久郁，清阳不升，湿浊上泛，阻塞肺窍，祖国医学称为鼻渊。采用疏风清热，化浊开窍之法治之。取上迎香用点刺法，针后打喷嚏，并由鼻孔内流出几滴血，当即通气，再针风池、合谷用平补平泻法，留针15~20分钟，隔日一次。针治一次头昏减轻，脓性涕减少，鼻已通气。则改取迎香、风池、合谷。治疗到9月14日共针治9次，症状完全消失。经1962年5月16日随访未见复发。

五十九、化脓性中耳炎

张××，男，23岁，成县城关农民。因两耳疼痛流脓三天，1976年3月2日初诊。

患者六天前发烧，从发烧第三天，两耳剧烈疼痛，在城关医院给滴耳油等治疗效果不显而转来我院。检查：双耳道有大量脓性分泌物流出，外耳道及鼓膜充血，鼓膜紧张部穿孔，舌质红、苔黄，脉数，86次/分。西医诊断为急性化脓性中耳炎；中医辨证系肝胆湿热、上蒸耳窍。采用清胆化湿、通利耳窍之法治之。取风池、听会、耳门、翳风、足临泣，用泻法，留针30分钟，每日针一次；针治一次后，耳痛减轻，脓液减少；针治三次，耳痛、脓性分泌物消失，为了巩固疗效，又针治二次，症状完全消失。3月9日检查：双耳道干燥清洁，外耳道及鼓膜充血消失，治愈停诊。

六十、慢性唇炎

张××，男，48岁，经济学院工人。因口唇溃烂间歇性发作三年，1965年12月27日初诊。

患者1962年冬天出现下嘴唇起疱、发痒，初起时不在意，后来时起时消，反复发作，逐渐加剧，红肿糜烂、渗流黄水、灼热疼痛，不能入睡，大便干燥，近三天来症状更甚。曾服用核黄素、外敷药物等效果不显，而来针灸科试治。检查：口角及上下唇起颗粒状丘疹、大小不一，大者如绿豆、小者如米粒，红肿痒痛，下唇及两侧口角有三个绿豆大小溃烂面，表面有渗出液。舌质红、苔白腻，脉滑数，86次/分。西医诊断为慢性唇炎；中医辨证系风湿热毒、上犯阳明。采用祛风解毒、清热利湿、消肿止痛之法治之。取商阳、少商，厉兑，点刺出血，合谷、内庭，用泻法，留针20分钟，每日针治一次；针治二次，口唇红肿灼痛减轻；针治四次，唇疹和溃烂面渐消；治疗至12月31日，针达五次时，症状基本消失，唇疹和溃烂面结痂，停诊观察。1966年12月2日随访，未复发。

六十一、口腔溃疡

马××，男，49岁，北京丰台区蔬菜门市部工人。因口腔溃疡间歇性发作六年，1981年6月1日初诊。

患者1975年开始舌边起白泡、溃烂，时起时消，反复发作，逐渐加剧，有时口唇边起白疱、溃烂，每处溃烂需15天左右始能消退，但消退后另一处又起。发作时疼痛难忍，不能入睡，不能嗽口，只能喝凉粥，还得用筷子送进咽喉部咽下，食物不能在口腔内停留，不能咀嚼，否则就象刀割样的剧痛难忍。这六年当中没有完全好过几天，不能吃有酸、辣味的蔬菜，有时面部、颈部、肛门起红疱，肿痛难忍，时起时消。检查：发育营养中等，

口腔粘膜水肿，舌中心裂口多处，舌边缘充血，有溃疡多处，并有齿痕，舌尖左侧有一个榆钱大小之溃疡，口腔内侧左颊部有一个黄豆大小溃疡面，表面有脓苔，面部下颌右侧有一个黄豆大疖肿，舌苔干黄，脉沉细无力，80次/分。西医诊断为口腔溃疡；中医辨证系内热久郁、耗伤肾阴、脾胃湿热、熏蒸舌本。采用清热养阴、健脾利湿之法治之。取翳风、列缺，用泻法，照海，用补法，留针20分钟；下关、颊车、地仓、三阴交，用平补平泻法，留针20分钟。二组穴位交替轮换使用，每日针一次；针治三次，疼痛减轻，夜里能入睡6—8小时，舌中裂口消失，口腔内溃疡渐消。治疗至6月29日，针达二十四次时，口腔溃疡和疼痛完全消失，检查恢复正常，停诊观察。1982年6月2日随访，治愈后未复发。

六十二、急性牙周炎

杨××，男，30岁，成县阵院乡农民。因牙痛，1973年6月12日初诊。

患者6月2日开始左侧上牙痛，曾在当地卫生所服止痛药无效，逐渐加剧，前天出现牙床子红肿疼痛，口干口渴、想喝水，口有臭味，大便干燥，两天无大便。检查：左上颊侧齿龈充血红肿，触之易出血，牙周袋探有少量脓性分泌物，舌质红、苔黄厚，脉数，88次/分。西医诊断为急性牙周炎；中医辨证系饮食不节、胃火炽盛、上薰口齿。采用清胃泻火、消肿止痛之法治之。取下关、颊车、合谷，用凉泻法，留针30分钟，厉兑，点刺出血，针后当天即见大便，肿痛减轻，每日针一次，连续针治三次，牙痛消失，齿龈充血红肿基本消失，触之无明显出血，牙周袋亦无脓性分泌物，为了巩固疗效，又针治二次，症状完全消失，治愈停诊。同年12月23日随访，未复发。

六十三、急性喉头炎

孙××，女，14岁，1965年8月12日住院。

患者咽痛，身热已七天，经北京×医院诊断为“感冒”，“急性喉头炎”，口服合霉素、金霉素，解热止痛片，注射退烧针等，上午体温低，午后增高，一般在 $37.6\sim 39.3^{\circ}\text{C}$ ，身热、汗出，咽干喉痛，吞咽困难，饮食无味。检查所见：营养欠佳，颜面潮红，精神不振，体倦，咽部充血，扁桃体Ⅰ度肿大，有脓性物，关节活动自如，声息正常。心率98次/分，苔白、舌尖红。脉数。血象：白血球5250，中性65%、淋巴34%、酸性1%，血色素14.1克，红血球415万，血沉32毫米/第一小时；胸透无异常；咽拭培养，有金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌。中医辨证属素体阴虚，风邪外袭，入里化热，上结咽喉所致。采用养阴清热，解毒利咽之法治之。取少商、商阳点刺出血，颊车、风池、大椎、翳风用凉泻法，留针30分钟，午后体温即降至 37.8° 咽痛减轻；次日体温正常，咽痛显减，饮食有味，脉搏76次/分。改取翳风、颊车、合谷用凉泻法，照海用平补平泻法，留针30分钟，每日一次，连针三日，症状消失，体温 36.2°C ，血沉12毫米/第一小时，咽部和扁桃体恢复正常，病愈出院。

六十四、下颌关节炎

杨××，男，57岁。1962年2月17日初诊。

患者右侧面痛已半月，张口时下颌关节痛，咀嚼困难，并牵及颞部痛，牙不痛，病前无发烧。检查所见：下颌关节紧，有压痛，外观无红肿，舌苔薄白，脉弦。中医辨证系风邪阻络，关节不利。采用驱风散邪，利节止痛之法治之。取下关、颊车、翳风、合谷用平补平泻法，留针10分钟，隔日一次。针治1次，疼痛减轻，咀嚼即不困难，针治3次疼痛消失，下颌关节活动自如而停诊。

[General Information]

书名=针灸集锦 （修订本）

作者=郑魁山编著

页数=503

SS号=10297781

DX号=

出版日期=1988年12月第1版

出版社=甘肃科学技术出版社

书名

前言

目录

第一篇 经络腧穴

第一章 经络腧穴总论

第一节 经络

一、经络系统的结构

二、经络的作用

第二节 腧穴

一、腧穴的分类

二、腧穴的作用

三、取穴法

第二章 经络腧穴各论

第一节 手太阴肺经

中府

云门

天府

侠白

尺泽

孔最

列缺

经渠

太渊

鱼际

少商

第二节 手阳明大肠经

商阳

二间

三间

合谷

阳溪

偏历

温溜
下廉
上廉
手三里
曲池
肘髎
五里
臂臑
肩髃
巨骨
天鼎
扶突
禾髎
迎香

第三节 足阳明胃经

承泣
四白
巨髎
地仓
大迎
颊车
下关
头维
人迎
水突
气舍
缺盆
气户
库房
屋翳
膺窗
乳中

乳根
不容
承满
梁门
关门
太乙
滑肉门
天枢
外陵
大巨
水道
归来
气冲
髀关
伏兔
阴市
梁丘
犊鼻
足三里
上巨虚
条口
下巨虚
丰隆
解溪
冲阳
陷谷
内庭
厉兑

第四节 足太阴脾经

隐白
大都
太白

公孙
商丘
三阴交
漏谷
地机
阴陵泉
血海
箕门
冲门
府舍
腹结
大横
腹哀
食窦
天溪
胸乡
周荣
大包

第五节 手少阴心经

极泉
青灵
少海
灵道
通里
阴郄
神门
少府
少冲

第六节 手太阳小肠经

少泽
前谷
后溪

腕骨
阳谷
养老
支正
小海
肩贞
臑俞
天宗
秉风
曲垣
肩外俞
肩中俞
天窗
天容
颧髎
听宫

第七节 足太阳膀胱经

睛明
攒竹
眉冲
曲差
五处
承光
通天
络却
玉枕
天柱
大杼
风门
肺俞
厥阴俞
心俞

督俞
膈俞
肝俞
胆俞
脾俞
胃俞
三焦俞
肾俞
气海俞
大肠俞
关元俞
小肠俞
膀胱俞
中膂俞
白环俞
上髎
次髎
中髎
下髎
会阳
附分
魄户
膏肓
神堂
諝諝
膈关
魂门
阳纲
意舍
胃仓
盲门
志室

胞肓
秩边
承扶
殷门
浮郤
委阳
委中
合阳
承筋
承山
飞扬
跗阳
昆仑
仆参
申脉
金门
京骨
束骨
足通谷
至阴

第八节 足少阴肾经

涌泉
然谷
太溪
大钟
水泉
照海
复溜
交信
筑宾
阴谷
横骨

大赫
气穴
四满
中注
盲俞
商曲
石关
阴都
通谷
幽门
步廊
神封
灵墟
神藏
彘中
俞府

第九节 手厥阴心包络经

天池
天泉
曲泽
郄门
间使
内关
大陵
劳宫
中冲

第十节 手少阳三焦经

关冲
液门
中渚
阳池
外关

支沟
会宗
三阳络
四渎
天井
清冷渊
消泺
臑会
肩髃
天髃
天牖
翳风
瘈脉
颊息
角孙
耳门
和髃
丝竹空

第十一节 足少阳胆经

瞳子髃
听会
上关
颌厌
悬颅
悬厘
曲鬓
率谷
天冲
浮白
头窍阴
完骨
本神

阳白
头临泣
目窗
正营
承灵
脑空
风池
肩井
渊液
辄筋
日月
京门
带脉
五枢
维道
居髃
环跳
风市
中渎
膝阳关
阳陵泉
阳交
外丘
光明
阳辅
悬钟
丘墟
足临泣
地五会
侠溪
足窍阴

第十二节 足厥阴肝经

大敦
行间
太冲
中封
蠡沟
中都
膝关
曲泉
阴包
足五里

阴廉
急脉
章门
期门

第十三节 任脉

会阴
曲骨
中极
关元
石门
气海
阴交
神阙
水分
下脘
建里
中脘
上脘
巨阙
鸠尾
中庭
膻中

玉堂
紫宫
华盖
璇玑
天突
廉泉
承浆

第十四节 督脉

长强
腰俞
腰阳关
命门
悬枢
脊中
中枢
筋缩
至阳
灵台
神道
身柱
陶道
大椎
哑门
风府
脑户
强间
后顶
百会
前顶
囟会
上星
神庭

素膠

人中

兑端

齟交

第十五节 其它经脉

冲脉

带脉

阴跷脉

阳跷脉

阴维脉

阳维脉

第十六节 经外奇穴

邱堂

鱼腰

太阳

球后

上迎香

金津

玉液

旁廉泉

上廉泉

百劳

喘息

定喘

腰眼

华佗夹脊

提托

子宫

肩缝

抬肩

疟门

手小节

落枕
八邪
十王
三关
四缝
十宣
四强
鹤顶
上阳关
膝眼
陵下
阑尾
纠下垂
纠内翻
纠外翻
八风
足小节

第十七节 经络的分布与临床应用

- 一、根结标本与气街
- 二、四海
- 三、三阳三阴与关、阖、枢

第二篇 针灸方法

第一章 针法

第一节 古代九针简介

- 一、毫针的规格
- 二、选针与藏针

第二节 内经刺法

- 一、属于不同浅深的刺法
- 二、属于取穴原则的刺法
- 三、其它刺法

第三节 针治的作用及注意事项

- 一、针治的作用

二、针治注意事项

第四节 禁针与异常现象的处理

一、禁针

二、针刺异常现象及处理

第五节 其它针及疗法

一、三棱针

二、挑治

三、火针

四、皮下埋针

五、丛针

六、拔罐与捏脊

第六节 新医疗法与针刺麻醉

一、穴位注射

二、强刺激结扎

三、穴位埋线

四、耳针

五、针刺麻醉

第二章 手法

第一节 练针法

一、关节练习法

二、左右手练习法

第二节 揣穴(定穴)法

一、指切法

二、按压法

三、分拨法

四、旋转法

五、滚摇法

六、升降法

七、滚摇升降法

第三节 进针法

一、指切速刺法

二、缓慢捻进法

三、刺入捻进法

四、管针打入法

五、指切压入法

六、压针缓进法

第四节 行针候气法

一、候气催气法

二、行气法

三、守气法

四、留针与出针

第五节 补泻手法

一、迎随补泻法

二、呼吸补泻法

三、徐疾补泻法

四、捻转补泻法

五、荣卫补泻法

六、开合补泻法

七、虚实补泻法

第六节 混合补泻法

一、烧山火(补法)

二、透天凉(泻法)

三、阳中隐阴(先补后泻法)

四、阴中隐阳(先泻后补法)

五、苍龟探穴(平补平泻、行气法)

六、赤凤迎源(平补平泻、行气法)

七、进火补法

八、进水泻法

九、苍龙摆尾

十、赤凤摇头

十一、热补法

十二、凉泻法

十三、针刺热补(烧山火)凉泻(透天凉)手法对皮肤

温度影响的实验观察

十四、对热补(烧山火)凉泻(透天凉)针刺手法的实
验观察

十五、对手法、补泻的探讨

第三章 灸法

第一节 施灸的原料

第二节 艾灸的常用方法

一、艾炷灸法

二、艾条灸法

第三节 施灸的作用与注意事项

一、施灸的作用

二、施灸注意事项

第三篇 临床治疗

第一章 临床治疗总论

第一节 针灸治病总则

一、补虚泻实

二、标本缓急

三、主次先后

第二节 特定穴的应用

一、五腧穴

二、原络穴

三、腧募穴

四、八会穴

五、八脉交会穴

六、郄穴

七、六腑下合穴

八、四总穴

九、回阳九针穴

第三节 配穴法

一、远隔配穴法

二、局部配穴法

三、远近配穴法

第四节 治症总要(杨氏治症总要)

第五节 “八法”在针灸治疗上的应用

- 一、汗法
- 二、吐法
- 三、下法
- 四、和法
- 五、温法
- 六、清法
- 七、补法
- 八、消法

第二章 临床治疗各论

第一节 脏腑经络证治

- 一、肺和大肠
- 二、脾和胃
- 三、心和小肠
- 四、肾和膀胱
- 五、心包和三焦
- 六、肝和胆

第二节 辨证配穴

- 一、昏迷不醒
- 二、恶心呕吐
- 三、便秘
- 四、脱肛
- 五、遗尿
- 六、尿闭
- 七、遗精
- 八、疝气
- 九、头痛
- 十、胸痛
- 十一、胁痛
- 十二、胃脘痛
- 十三、腹痛
- 十四、腰痛

十五、妇女月经病

十六、带下

十七、乳汁不足

十八、小儿抽风

十九、耳鸣、耳聋

二十、牙痛

二十一、冻疮

二十二、鹅掌风

二十三、聋哑

第三节 临床治疗总结摘要

一、感冒

二、支气管炎

三、支气管哮喘

四、急性胃肠炎

五、胃及十二指肠溃疡

六、胃下垂

七、胆囊炎

八、急性阑尾炎

九、痢疾

十、疟疾

十一、神经衰弱

十二、瘧病

十三、癲癇

十四、脑血管意外

十五、脑血管意外后遗偏瘫

十六、面神经麻痹

十七、小儿麻痹及后遗症

十八、传染性多发性神经炎

十九、风湿性关节炎

二十、脊椎炎

二十一、坐骨神经痛

二十二、腰肌劳损

- 二十三、肩关节周围炎
- 二十四、单纯性甲状腺肿
- 二十五、腱鞘炎
- 二十六、腱鞘囊肿
- 二十七、创伤性肿痛(软组织损伤)
- 二十八、颈淋巴结结核
- 二十九、急性淋巴管炎
- 三十、腮腺炎(痄腮)
- 三十一、闭经
- 三十二、小儿营养不良症
- 三十三、百日咳
- 三十四、急性结膜炎
- 三十五、近视
- 三十六、视网膜出血
- 三十七、视神经萎缩
- 三十八、内耳眩晕症
- 三十九、链霉素中毒性耳聋
- 四十、鼻炎
- 四十一、急性扁桃体炎

第四节 医案

- 一、上呼吸道感染
- 二、支气管哮喘合并肺炎
- 三、流行性胸痛
- 四、风湿热(关节型)
- 五、风湿性心脏病
- 六、膈肌痉挛(呃逆)
- 七、慢性萎缩性胃炎
- 八、贲门癌
- 九、糖尿病
- 十、肠麻痹
- 十一、慢性肠炎
- 十二、结肠炎伴肠痉挛

- 十三、五更泻
- 十四、消化不良
- 十五、急性肾炎
- 十六、急性膀胱炎
- 十七、慢性前列腺炎
- 十八、偏头痛并低血压症
- 十九、病毒感染性头痛
- 二十、乙型脑炎后遗症
- 二十一、脑震荡
- 二十二、腰麻后遗头痛
- 二十三、多发性神经根炎
- 二十四、三叉神经痛
- 二十五、眶上神经痛
- 二十六、尺神经麻痹
- 二十七、正中神经麻痹
- 二十八、巴比妥中毒后遗症
- 二十九、植物神经功能紊乱
- 三十、两手震颤
- 三十一、功能性震颤
- 三十二、一氧化碳中毒
- 三十三、椎间盘脱出
- 三十四、骶椎腰化伴坐骨神经痛
- 三十五、荐肠关节结核(骶髂关节结核)
- 三十六、大骨节病
- 三十七、腰椎压缩性粉碎性骨折
- 三十八、下肢静脉曲张并发血栓性静脉炎
- 三十九、面肌痉挛
- 四十、腓肠肌痉挛
- 四十一、进行性肌营养不良症
- 四十二、慢性盆腔炎
- 四十三、功能性子宫出血
- 四十四、产后感染

四十五、产后无乳
四十六、慢性毛囊炎
四十七、酒皰鼻
四十八、带状疱疹
四十九、顽固性荨麻疹
五十、过敏性紫癜
五十一、翼状胬肉
五十二、青光眼
五十三、视网膜脉络膜炎
五十四、电光性眼炎
五十五、麻痹性外斜视
五十六、麻痹性内斜视
五十七、鼻衄
五十八、慢性上颌窦炎
五十九、化脓性中耳炎
六十、慢性唇炎
六十一、口腔溃疡
六十二、急性牙周炎
六十三、急性喉头炎
六十四、下颌关节炎